

مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان

دکتر محمد خدایاری فرد دکتر یاسمین عابدینی

دانشیار دانشگاه تهران استادیار دانشگاه اصفهان

۱۳۸۶

فهرست مطالب

عنوان.....	صفحه.....
پیشگفتار.....	۱.....
فصل اول: مقدمه کلی.....	۴.....
تعریف‌های سلامتی.....	۶.....
احساس مسئولیت در مقابل سلامت خود.....	۷.....
الگوی زیستی، اجتماعی و روانی.....	۸.....
مفاهیم سلامت و بیماری در میان کودکان و نوجوانان.....	۱۰.....
رشد و توسعهٔ باورهای سلامت.....	۱۰.....
مطالعات تحولی- شناختی.....	۱۱.....
موضوعات مرتبط با مفهوم‌سازی از سلامت و بیماری.....	۱۱.....
منبع باورهای سلامتی.....	۱۴.....
نگرانی‌های سلامتی نوجوانان.....	۱۷.....
نوجوانی: دوره‌ای خطرناک برای سلامتی.....	۱۹.....
عوامل تاریخچهٔ اجتماعی.....	۲۰.....
عوامل روان‌شناختی اجتماعی.....	۲۰.....
نقش مذهب در سلامتی.....	۲۰.....
ادراک خطر در نوجوانان.....	۲۳.....
شیوه‌های حل مسئله و سلامت روان‌شناختی.....	۲۵.....
شادی.....	۲۸.....
پیامدهای شادی.....	۲۹.....
راهبردهایی برای زندگی شادتر.....	۲۹.....
خطرهایی که سلامت نوجوانان بی‌خانمان را تهدید می‌کند.....	۳۲.....
خطرهایی که سلامت نوجوانان محلات فقیرنشین را تهدید می‌کند.....	۳۳.....
خلاصه.....	۳۵.....
پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن.....	۳۵.....
فصل دوم: تنیدگی و روش‌های مقابله با آن.....	۳۶.....
تنیدگی‌های دورهٔ نوجوانی.....	۳۷.....

۳۹	انواع رویدادهای تنش‌زا
۴۱	علل و همبسته‌های تنیدگی در نوجوانان
۴۱	تفاوت‌های سنی در هیجانات منفی
۴۲	تنش‌زاهای خانوادگی
۴۳	تفاوت‌ها و تأثیرات جنسیتی
۴۵	مقابله با تنیدگی
۴۷	روندهای تحولی در مقابله با تنیدگی
۴۷	تأثیر روابط نزدیک
۴۸	روابط خانوادگی
۵۰	روابط همسالان
۵۰	قابلیت کنترل ادراک شده
۵۱	نقش مذهب در مقابله با عوامل تنش‌زا
۵۵	خلاصه
۵۶	پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن
۵۷	فصل سوم: اختلالات خوردن
۵۸	پر خوری عصبی
۶۰	عوامل روان‌شناختی و اجتماعی مرتبط با پر خوری عصبی
۶۰	طراحی معیارهای بسیار سخت
۶۱	نقش شخصیت و جو خانوادگی
۶۲	بی‌اشتهایی عصبی
۶۴	عوامل مرتبط با مشکلات عمومی خوردن
۶۵	نقش طبقه اجتماعی
۶۵	نقش فرهنگ
۶۵	درمان اختلالات خوردن
۶۸	خلاصه
۶۸	پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن
۶۹	فصل چهارم: مشکلات و مسائل جنسی
۷۱	تحول جنسی

۷۵.....	کنترل میل جنسی.....
۷۶.....	هویت همجنس خواه.....
۷۷.....	جوانان همجنس خواه و ایدز.....
۷۸.....	نگرش نوجوانان به عمل جنسی.....
۷۸.....	اولین رابطه و عمل جنسی.....
۷۹.....	رفتار جنسی و کاندوم.....
۷۹.....	نقش کاندوم در پیشگیری از HIV در رفتار جنسی.....
۸۱.....	فواید و مضرات کاندوم.....
۸۲.....	استدلال در مورد خطر و عدم آسیب پذیری.....
۸۳.....	تشخیص و درمان ایدز.....
۸۵.....	سلامت جنسی.....
۸۷.....	خلاصه.....
۸۸.....	پرسش هایی برای تفکر و اندیشیدن.....
۸۹.....	فصل پنجم: حاملگی در نوجوانان.....
۹۲.....	همه گیرشناسی.....
۹۲.....	روند حاملگی در نوجوانان.....
۹۲.....	فعالیت جنسی و استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی.....
۹۳.....	ویژگی های جمعیت شناختی و اجتماعی مادران نوجوان.....
۹۳.....	همبسته های رفتارهای جنسی بسیار خطرناک و حاملگی.....
۹۳.....	تأثیرات تحولی.....
۹۴.....	تأثیرات اجتماعی جنسی.....
۹۴.....	تأثیرات اجتماعی.....
۹۵.....	تأثیرات هیجانی.....
۹۶.....	دلایل عدم استفاده نوجوانان از وسایل جلوگیری.....
۹۶.....	پیشگیری اولیه از حاملگی نوجوانان.....
۹۹.....	پیشگیری ثانویه از حاملگی نوجوانان.....
۹۹.....	تشخیص حاملگی.....
۱۰۰.....	تدارک مراقبت های لازم قبل از زایمان.....

- ۱۰۱ شیوه برخورد با حاملگی نوجوانان
- ۱۰۲ روابط دختر و پسر در ایران
- ۱۰۳ خلاصه
- ۱۰۴ پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن
- ۱۰۵ فصل ششم: مصرف مواد مخدر
- ۱۰۷ الگوهای مصرف مواد مخدر
- ۱۰۹ مصرف الکل
- ۱۱۰ تفاوت‌های بین فرهنگی
- ۱۱۲ مصرف سیگار
- ۱۱۴ تفاوت‌های بین فرهنگی
- ۱۱۴ مصرف سایر مواد مخدر و داروها
- ۱۱۵ شیشه (متامفتامین)
- ۱۱۵ آثار کوتاه مدت مصرف متامفتامین چیست؟
- ۱۱۶ آثار بلندمدت مصرف متامفتامین چیست؟
- ۱۱۷ عوارض جسمی ناشی از مصرف متامفتامین چیست؟
- ۱۱۸ ارتباط مصرف متامفتامین و هپاتیت B و C
- ۱۱۸ هروئین فشرده (کریستال یا کراک)
- ۱۱۹ آثار بلندمدت مصرف کریستال
- ۱۱۹ قرص‌های ریتالین
- ۱۲۰ آثار مصرف ریتالین
- ۱۲۰ عوارض مصرف مقادیر زیاد ریتالین
- ۱۲۱ آثار منفی سوء مصرف حشیش
- ۱۲۲ آثار منفی سوء مصرف اکستاسی (X)
- ۱۲۳ قضاوت‌های اجتماعی در مورد مصرف مواد
- ۱۲۳ نشانه رفتار مشکل آفرین
- ۱۲۵ چارچوب‌ها و دیدگاه‌های نظری
- ۱۲۵ شروع مصرف دارو و مواد
- ۱۲۵ زمینه‌های ژنتیکی

۱۲۶	پیش‌بینی‌کننده‌های روانی اجتماعی
۱۳۰	نظام همسالان
۱۳۲	عوامل زیست‌شناختی و شخصیتی
۱۳۳	ادامه‌یافتن مصرف مواد
۱۳۳	تأثیر مواد مخدر و داروهای روان‌گردان
۱۳۴	عوامل روانی اجتماعی
۱۳۵	درمان اعتیاد به مواد و الکل
۱۳۵	برنامه‌های کمک‌رسانی به دانش‌آموزان
۱۳۶	کلینیک‌ها یا مراکز مشاوره مدارس
۱۳۷	برنامه‌های خانوادگی
۱۳۸	برنامه‌های دوازده‌مرحله‌ای
۱۳۹	درمان شبانه‌روزی
۱۴۰	چگونه از مصرف مواد جلوگیری کنیم؟
۱۴۱	چگونه باید مصرف دارو را ترک کرد؟
۱۴۳	خلاصه
۱۴۴	پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن
۱۴۵	فصل هفتم: بزهکاری
۱۴۶	خطرهای بزهکاری
۱۴۷	شیوع و میزان بروز بزهکاری
۱۴۸	بزهکاری و ویژگی‌های جمعیت‌شناسی اجتماعی
۱۴۸	سن
۱۴۸	جنسیت
۱۴۹	سکونت در شهرهای بزرگ و صنعتی
۱۵۰	روندهای زمانی
۱۵۰	پیشگیری
۱۵۱	عوامل زمینه‌ساز بزهکاری
۱۵۱	عزت نفس پایین
۱۵۳	عملکردهای خانوادگی

عملکردهای تحصیلی و نگرش به مدرسه.....	۱۵۷
ارتباط با همسالان بزهکار.....	۱۵۷
محدودیت‌ها و قیدوبندهای محیطی.....	۱۵۸
درمان.....	۱۵۹
شیوه‌های درمانی.....	۱۶۲
کارایی رویکردهای مختلف درمانی.....	۱۶۲
درمان روان‌پویشی.....	۱۶۲
رویکردهای شناختی - رفتاری.....	۱۶۳
برنامه‌های تحصیلی، شغلی و مهارت‌های زندگی.....	۱۶۴
خلاصه.....	۱۶۵
پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن.....	۱۶۷
فصل هشتم: خشونت در نوجوانان.....	۱۶۸
همه‌گیرشناسی خشونت.....	۱۷۱
تشخیص عوامل خطرآفرین.....	۱۷۳
نژاد و جایگاه اجتماعی - اقتصادی.....	۱۷۳
اجتماع.....	۱۷۴
خانواده.....	۱۷۴
دسترسی به اسلحه.....	۱۷۵
عوامل خطرآفرین.....	۱۷۶
نظریه‌های عوامل خطرآفرین.....	۱۷۸
پیشگیری.....	۱۷۹
بخش تشکیلات قضایی کیفری و جنایی.....	۱۸۱
بخش سلامتی.....	۱۸۲
بخش آموزشی.....	۱۸۲
بخش اجتماعی.....	۱۸۴
درمان.....	۱۸۵
مداخله در سطح جامعه.....	۱۸۷
نحوه برخورد با نوجوانانی که شاهد مرگ ناشی از خشونت یکی از نزدیکان خود بوده‌اند.....	۱۸۹

۱۹۱	پیشگیری در سطح شخصی.....
۱۹۲	پیشگیری در سطح اجتماعی.....
۱۹۳	پس‌مداخله.....
۱۹۴	خلاصه.....
۱۹۵	پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن.....
۱۹۶	فصل نهم: نوجوانان فراری و بی‌خانمان.....
۱۹۸	همه‌گیرشناسی بی‌خانمانی.....
۱۹۸	برآوردهای انجام‌شده از تعداد نوجوانان بی‌خانمان.....
۱۹۹	تعریف بی‌خانمانی.....
۱۹۹	ویژگی‌های نوجوانان بی‌خانمان.....
۲۰۱	عواملی که موجب بی‌خانمانی نوجوانان می‌شوند.....
۲۰۴	عوامل و رفتارهای خطرآفرین نوجوانان بی‌خانمان.....
۲۰۸	پژوهش‌های موردی انجام‌شده در مورد نوجوانان بی‌خانمان.....
۲۰۹	از دست دادن والدین در اثر مرگ یا طلاق.....
۲۱۰	نوجوانان همجنس‌خواه.....
۲۱۱	نوجوانان دارای مشکلات روانی حاد و مزمن.....
۲۱۲	بی‌خانمانی ناشی از بی‌برنامه بودن خانواده.....
۲۱۳	آزار و اذیت جنسی.....
۲۱۴	سوءمصرف مواد.....
۲۱۶	خدمات اجتماعی به نوجوانان بی‌خانمان.....
۲۱۶	نیاز به خدمات اجتماعی.....
۲۲۰	خلاصه.....
۲۲۲	پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن.....
۲۲۳	فصل دهم: مشکلات تحصیلی.....
۲۲۵	چرا کودکان مدرسه را طرد یا ترک می‌کنند.....
۲۲۶	درگیری تحصیلی.....
۲۳۱	تعریف پیشرفت تحصیلی ضعیف و ترک تحصیل.....
۲۳۳	تفاوت‌های جنسیتی و قومی.....

۲۳۷	پیشگیری.....
۲۳۸	پیشگیری ثانویه.....
۲۳۸	مقابله با مشکلات مرتبط با عدم پیشرفت تحصیلی.....
۲۳۹	خلاصه.....
۲۴۰	پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن.....
۲۴۱	فصل یازدهم: اختلالات روانی.....
۲۴۲	ترس و اضطراب.....
۲۴۳	روندهای تحولی.....
۲۴۵	علائم و نشانه‌های بالینی ترس و اضطراب.....
۲۴۶	انواع اساسی و اصلی اختلالات اضطرابی.....
۲۴۷	وسواس.....
۲۵۰	اختلال وحشت‌زدگی.....
۲۵۱	درمان اختلالات اضطرابی نوجوانان.....
۲۵۲	مشکلات حاد روانی.....
۲۵۲	اسکیزوفرنیا.....
۲۵۳	نشانه‌های بالینی.....
۲۵۳	اسکیزوفرنیا و خودکشی.....
۲۵۴	پیشایندها و علل اسکیزوفرنیا.....
۲۵۵	افسردگی.....
۲۵۵	ماهیت افسردگی.....
۲۵۶	عوامل مرتبط با افسردگی.....
۲۶۰	خودکشی.....
۲۶۰	میزان بروز خودکشی و افکار خودکشی.....
۲۶۱	اقدام به خودکشی.....
۲۶۲	عوامل مرتبط با خودکشی.....
۲۶۵	پیشگیری از خودکشی.....
۲۶۵	مداخله‌های درمانی.....
۲۶۵	برنامه‌های آموزشی.....

خلاصه.....	۲۶۶
پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن.....	۲۶۷
فصل دوازدهم: آموزش سلامتی.....	۲۶۸
بیماری‌ها و آسیب‌های نوجوانی: نیاز به آموزش.....	۲۶۹
راهنماهای آموزش سلامتی.....	۲۷۰
پیام‌های برانگیزاننده ترس.....	۲۷۰
ارائه اطلاعات.....	۲۷۱
سبک‌های اسنادی.....	۲۷۴
خلاصه.....	۲۷۵
پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن.....	۲۷۵
فصل سیزدهم: بحث پایانی و پیشنهادها کاربردی.....	۲۷۷
توصیه‌های کلی برای سلامت کودکان و نوجوانان.....	۲۷۹
پیشنهادها کاربردی.....	۲۸۰
سازگار شدن با نوجوانان در حال تغییر.....	۲۸۰
غلبه بر مشکلات ارتباطی.....	۲۸۳
شکستن سدها.....	۲۸۴
شناسایی اضطراب‌ها.....	۲۸۵
ایجاد بیشترین رابطه.....	۲۸۷
چند نکته دیگر برای کمک بیشتر.....	۲۸۹
وقتی نوجوان به نظم و انضباط نیاز دارد.....	۲۹۱
ایجاد مقدار کمی محدودیت.....	۲۹۲
وقتی نوجوان قوانین را نقض می‌کند.....	۲۹۶
وقتی اوضاع از کنترل خارج می‌شود.....	۲۹۷
منابع و مآخذ.....	۳۰۱
منابع فارسی.....	۳۰۱
منابع لاتین.....	۳۰۶
فهرست اعلام.....	۳۲۶
فهرست موضوعی.....	۳۳۵

۳۴۴واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

پیشگفتار

نوجوانی، یکی از چالش‌انگیزترین، تنش‌زاترین، جذاب‌ترین و در عین حال مشکل‌سازترین دوران زندگی هم برای نوجوانان و هم برای والدین، معلمان و متخصصان سلامت جامعه است. در عین حال، نوجوانی، دوره‌ای با بهترین خوشی‌ها، تفریحات، تهییج‌ها، آرمان‌گرایی‌ها و خوش‌بینی‌هایی است که طی آن نوجوان لذت خودپیروی، استقلال، صمیمیت و برنامه‌ریزی برای آینده را می‌چشد و به اوج تحول جسمانی، عاطفی و ذهنی دست می‌یابد. موضوع این کتاب، مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان و به عبارت دیگر، عوامل مرتبط با سلامت آنان است که بازتابی از تأثیر متقابل چالش‌ها و مشکلات نوجوانان و فرصت‌ها و پیشرفت‌های تحولی جدید آنهاست. موضوع سلامت نوجوانان را می‌توان به‌صورت حوزه‌های خطرناک تحولی مدنظر قرار داد. نوجوانان امروز برخلاف کودکان دیروز، باید با مجموعه‌ای از خطرهای سلامتی جدید دست و پنجه نرم کنند. این خطرها شامل مواد مخدر و اختلالات قابل انتقال جنسی تا اختلالات خوردن، خودکشی و افسردگی می‌شود. خطرهایی از این نوع، ضرورت و فوریت درک سلامت نوجوانان را خاطرنشان می‌سازد، همچنین بینش‌ها و نگرش‌های جدیدی نیز نسبت به ابعاد و جنبه‌های مثبت رفتار سالم و توأم با سلامت که نسل نوجوان را از نسل کودکان و بزرگسالان متمایز می‌سازد، ایجاد می‌کند.

امروزه بسیاری از نوجوانان، درکی پیچیده از سلامتی به‌عنوان آمیزه‌ای چندبعدی از عوامل فیزیکی و روان‌شناختی دارند. بسیاری از آنان در مقایسه با نوجوانان نسل قبل، مسئولیت شخصی بیشتری را نسبت به سلامت شخصی خود در حال حاضر و آینده می‌پذیرند و با انگیزه قوی‌تری به دنبال حفظ تناسب و دستیابی به بهزیستی هیجانی در سطح بهینه آنند.

رویکرد این کتاب، درک سلامت نوجوانان مبتنی بر دیدگاه تفاوت‌های فردی آنان است. این کتاب با ارائه مجموعه‌ای از یافته‌های پژوهشی انتخاب شده و طرح موارد و مثال‌های واضح، خواننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا جاذبه، گیرایی و کششی به رفتارهای سالم موجود بین دختران و پسران پیدا کند. این رفتارهای سالم تابعی از سابقه خانوادگی، شخصیتی، زندگی، فقر، بی‌خانمانی و فرهنگ نوجوانان است. پیام اصلی این کتاب این است که روان‌شناسی سلامت نوجوانان را نمی‌توان به‌طور

کامل درک کرد و شناخت، مگر اینکه فقط ویژگی‌های هر یک از آنها را به عنوان موجود انسانی درک کرد. یکی از قوت‌های این کتاب، پوشش دادن به پیچیدگی این پیام به صورت عملی است. این کتاب با تحلیل دقیق و منطقی معنای سلامت برای نوجوانان و خطرهای خاص سلامتی که در طول این دوره از زندگی افزایش می‌یابند، شروع می‌شود، سپس طی فصولی به تفصیل مشکلات مختلف سلامتی را که امروزه نوجوانان با آن درگیرند، نظیر نیاز به آموزش سلامتی، تنیدگی و راه‌های مقابله با آن، مشکلات خوردن، مشکلات جنسی، مصرف مواد مخدر و نوشیدن مشروبات الکلی، بزهکاری، خشونت، فرار و بی‌خانمانی، مشکلات روانی و تحصیلی را همراه با تحقیقات انجام‌شده در هر زمینه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

فصل اول، زمینه را برای بحث‌های زیر فراهم می‌سازد؛ در این فصل تعریف‌هایی از سلامت و اینکه چگونه مفاهیم سلامت و بیماری در نوجوانان شکل می‌گیرند، ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که سال‌های نوجوانی، مصادف با زمانی است که نوجوانان در معرض خطرهای مختلف سلامتی قرار دارند. در فصل دوم، نیاز و اهمیت آموزش سلامت مورد بحث قرار گرفته است. همچنین راهبردهای آموزش سلامتی که در دسترس ما قرار دارند، مطرح شده‌اند. بخشی از این فصل، به الگوهای رفتار سالم اختصاص دارد و به بررسی الگوهای روان‌شناختی موجود برای تبیین این موضوع که چرا افراد در رفتارهای مرتبط با سلامتی درگیر می‌شوند، پرداخته است.

سایر فصل‌ها، با رفتارهای خاص و خطرهایی که این رفتارها برای سلامتی دارند، از جمله عوامل روان‌شناختی که این رفتارها را ایجاد می‌کنند، مرتبط‌اند. این فصل‌ها شامل تنیدگی و راه‌های مقابله با آن، اختلالات خوردن از جمله پرخوری و بی‌اشتهایی عصبی، مشکلات جنسی و خطر ابتلا به ایدز، حاملگی نوجوانان، مصرف مواد، مشروب‌خواری، بزهکاری، خشونت و جرم‌آفرینی، فرار از خانه و بی‌خانمانی، مشکلات تحصیلی و شخصیتی و روانی‌اند. در هر یک از این فصل‌ها، نخست اختلال موردنظر تعریف و میزان شیوع آن مطرح، سپس نظریه‌های مربوط به سبب‌شناسی این اختلالات بررسی شده است. همچنین رویکردها و روش‌های درمانی مختلف برای آن اختلالات همراه با نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه مطرح شده‌اند. در انتهای هر فصل، خلاصه‌ای از مطالب هر فصل ارائه شده است.

به‌طور خلاصه، این کتاب منبعی ضروری برای کلیه افرادی است که به نحوی با سلامت و توسعه آن در نوجوانان امروزی ارتباط دارند. در این کتاب، علاوه بر ارائه چارچوب‌ها و دیدگاه‌های نظری موجود درباره اختلالات و مشکلات خاصی که نوجوانان معاصر با آن مواجه‌اند، بر جنبه کاربردی این نظریه‌ها و دیدگاه‌ها تأکید شده است. از این رو کتاب حاضر، کتابی کاربردی و حاوی ایده‌ها و تفکرات

مفید برای مربیان و متخصصان سلامت، معلمان، مشاوران مدارس و مراکز سلامت و بهداشت روانی، روان‌پزشکان، روان‌درمانگران و متخصصان بالینی و استادانی است که به تدریس موضوعات مرتبط با سلامت نوجوانان مشغول می‌باشند. همچنین نوجوانان و والدین آنها می‌توانند استفاده مفیدی از مطالب کتاب در راستای رشد و توسعه سلامت فیزیکی، روانی و فردیت انسانی در جامعه پیچیده و در حال تغییر امروزین داشته باشند.

از کلیه صاحب‌نظران درخواست می‌شود که کاستی‌های مطالب را به مؤلفان یادآور شوند تا در چاپ‌های بعد مورد توجه قرار گیرند.

در پایان از آقای مهرداد نوایی که با ارائه نظرهای علمی خود بر غنای محتوای کتاب افزودند، تشکر می‌شود.

دکتر یاسمین عابدینی
استادیار دانشگاه اصفهان

دکتر محمد خدایاری فرد
دانشیار دانشگاه تهران

فصل اول

مقدمه کلی

دیر زمانی است که دوران نوجوانی و جوانی به عنوان سال‌های تعیین‌کننده تحول هیجانی بعدی افراد شناخته شده است. چاپ و تکثیر کتاب‌ها و مجلاتی که درباره این مرحله از زندگی نوشته شده، بیانگر این موضوع است. با این حال، فقط در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران علوم اجتماعی، انسانی و پزشکی به سلامت نوجوانان جلب شده است.

دلایل زیادی برای افزایش علاقه‌مندی به سلامت نوجوانان وجود دارد که به طور خلاصه به دو مورد از آنها اشاره می‌شود؛ یکی شیوع عفونت و ویروس HIV یا ایدز. واضح است که نوجوانان به طور فزاینده‌ای در معرض خطر ابتلا به عفونت HIV قرار دارند. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که اگرچه نوجوانان از خطرهای بالقوه اعمال جنسی ناسالم آگاهند، اما این آگاهی همراه با رفتار پیشگیرانه مناسب نیست (مور و روزنتال^۱، ۱۹۹۳؛ کرافورد، تارتل و کیپاکس^۲، ۱۹۹۰). بنابراین درک تمام ابعاد جنسیت و رفتارهای جنسی در نوجوانان، درک آنها از رفتارهای خطرناک و کارایی برنامه‌های تغییر رفتار، بسیار تعیین‌کننده است. دلیل دیگر اینکه برخی رفتارها نظیر سیگار کشیدن، اولین بار در سنین نوجوانی شروع می‌شوند (هیل^۳ و همکاران، ۱۹۹۰). رابطه بین سیگار کشیدن و ابتلا به اختلالات ریوی و قلبی - عروقی در مراحل بعدی زندگی، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است که چرا بعضی نوجوانان در معرض خطرهای ناشی از سیگار کشیدن قرار دارند.

مفهوم نهفته در علاقه‌مندی به سلامت نوجوانان، این است که دوره نوجوانی، دوره تغییر و انتقال است. در طول این سال‌ها جوانان فعالیت‌های تازه‌ای را تجربه می‌کنند. جسون^۴ (۱۹۸۴)، خاطرنشان می‌کند بسیاری از رفتارهای مرتبط با سلامت نظیر سیگار کشیدن و اعمال جنسی، اولین بار در این دوره صورت می‌گیرند. از این رو، درک کلیه ابعاد سلامت در نوجوانان بسیار مهم است.

^۱ . Moore & Rosenthal

^۲ . Crawford, Turtle & Kippax

^۳ . Hill

^۴ . Jessor

تعریف‌های سلامتی

سلامت، دقیقاً به چه معناست؟ سلامت را می‌توان به روش‌های مختلفی تعریف کرد. تعاریفی که از سلامت می‌شود، در طول زمان دچار تغییر می‌شوند. در قرن نوزدهم، بر ابعاد جسمانی و فیزیکی تأکید می‌شد (میلستین و لیت،^۱ ۱۹۹۰). تعاریف بعدی به سادگی به سلامت به‌عنوان فقدان هر نوع بیماری نظر افکندند، درحالی‌که تعاریفی نیز، سلامت را از نظر بدنی، ذهنی و اجتماعی مدنظر قرار می‌دهند (تیلور،^۲ ۱۹۹۱). از این رو، امروزه بسیاری از نویسندگان نه تنها آن را تابع شرایط و وضعیت جسمانی فرد، بلکه تابع نگرش‌های او به سلامتی، تصورات او از خطر، رژیم غذایی و محیط می‌دانند. برای مثال، نوجوانی که اعتقاد دارد هرگز به ایدز مبتلا نخواهد شد، به‌احتمال زیاد در رفتارهای خطرناکی چون برقراری روابط جنسی ناسالم یا استفاده از تزریق مواد، درگیر می‌شود. بنابراین موقعیت سلامت این نوجوان تا حدودی توسط عوامل شناختی و همچنین عوامل رفتاری تعیین می‌شود.

بر اساس نظر گوشمن^۳ (۱۹۸۸)، تعریف سلامت باید از سه دیدگاه مدنظر قرار گیرد. این تعریف نخست باید بر بُعد زیست‌شناختی سلامت تأکید کند و در درجه اول با عواملی نظیر عملکرد نادرست فیزیولوژیکی و نظریه جنینی سر و کار داشته باشد. البته می‌توان از جمله مسائل مرتبط با سلامت به نشانگان آشکار خاصی از بیماری اشاره کرد.

دیدگاه دوم با نقش‌های اجتماعی که انتظار می‌رود افراد ایفا کنند، سر و کار دارد. بنابراین آن دسته از نوجوانانی که به ایفای نقشی که از آنها انتظار می‌رود نمی‌پردازند، احتمالاً به‌عنوان منحرف^۴ برچسب می‌خورند. سومین دیدگاه، رویکرد روان‌شناختی است. تعجبی ندارد که این دیدگاه بر ادراکات، تصورات و نگرش‌های افراد تأکید دارد. بنابراین، افرادی که احساس می‌کنند حالشان خوب است، احتمالاً فکر می‌کنند که سالم‌اند. براساس این دیدگاه، تجارب شخصی و همچنین عوامل شناختی، سلامت یا عدم سلامت یک فرد را پیش‌بینی می‌کنند.

این دیدگاه‌ها در مورد سلامتی دو موضوع مهم را پیش می‌آورند که مستلزم توجه دقیق‌تر است؛ اول اینکه فرد در مقابل سلامت خود مسئول است یا می‌تواند بر سلامت خود نظارت داشته باشد؛ دوم اینکه سلامت دارای ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی است. در زیر هر کدام از این موضوعات به اختصار بررسی می‌شوند.

^۱ . Millstein & Litt

^۲ . Taylor

^۳ . Gochman

^۴ . deviant

احساس مسئولیت در مقابل سلامت خود

همان‌طور که اشاره شد، سلامت هر فردی ممکن است تاحدودی از طریق عوامل رفتاری و شناختی تعیین شود. نوجوانانی که معتقدند امکان دارد ابتلا به عفونت ایدز ناشی از اعمال جنسی ناسالم باشد، به احتمال زیاد تمایل بیشتری به روابط جنسی سالم دارند. این مسئله نشان می‌دهد بسیاری از رفتارهایی که بر سلامت تأثیر می‌گذارند، توسط افراد قابل کنترل‌اند. به عبارت دیگر، فرد می‌تواند زندگی همراه با سلامت را انتخاب کند یا نکند. بنابر این نظر، بسیاری از اختلالات و بیماری‌ها، منعکس‌کننده سبک زندگی و انتخاب‌های شخصی افراد است.

مفهوم مکان کنترل که تأثیر زیادی بر درک روان‌شناسان از انگیزش انسان دارد و به درستی کنترل درونی^۱ نام‌گذاری شده است (زیرا انرژی خود را از وقایع زندگی می‌گیرد)، تأثیر زیادی بر سلامت افراد دارد. افراد دارای مکان کنترل درونی اعتقاد دارند که خودشان مسئول وقایعی‌اند که برایشان رخ می‌دهد و می‌توانند بر این وقایع کنترل داشته باشند. در مقابل، آنهایی که به‌صورت بیرونی کنترل می‌شوند، معتقدند وقایعی که برای آنها اتفاق می‌افتد، تا حد زیادی به احتمال و تصادف بستگی دارد. پیشینه پژوهشی گسترده‌ای در مورد بررسی مکان کنترل و ارتباط آن با نگرش‌ها و رفتارهای سالم وجود دارد. به‌طور خلاصه، افرادی که نوعی حس کنترل شخصی دارند، به احتمال زیاد به رفتارهای سالم گرایش دارند (لو،^۲ ۱۹۸۸).

مفهوم مرتبط دیگر، سبک اسنادی^۳ است که مبتنی بر الگوی تجدیدنظرشده درماندگی آموخته‌شده در افسردگی است. یک سبک اسنادی منفی یا غیرکارآمد مرتبط با ویژگی‌های شخصیتی نظیر انزوا، عزت نفس پایین و همچنین پیامدهای سلامتی ضعیف است (پیترسون، سلگمن و وایلانت،^۴ ۱۹۸۸). مکان کنترل و سبک اسنادی، کاربردهای فراوانی در سلامت افراد دارند که به تفصیل در فصل بعد بررسی می‌شوند.

^۱ . internal

^۲ . Lau

^۳ . attributional style

^۴ .Peterson, Seligman & Vaillant

الگوی زیستی، اجتماعی و روانی

این اعتقاد که عوامل جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و فیزیکی نقش مهمی در تعیین وضعیت سلامت فرد دارند، به الگوی زیستی، اجتماعی و روانی مربوط می‌شود (انگل^۱، ۱۹۷۷). براساس نظر انگل، الگوی پزشکی^۲ که بر علل زیست‌شناختی بیماری تأکید دارد، نمی‌تواند به‌طور کلی تمام جنبه‌های سلامت و بیماری را توضیح دهد و تبیین کند، زیرا الگوی پزشکی از بررسی عوامل اجتماعی و روان‌شناختی عاجز است و تأکید دارد هر چیزی که مطابق با هنجارهای زیست‌شناختی نباشد بیماری یا اختلال است. دانشجویان پزشکی نیز وسوسه می‌شوند تا این طبقه‌بندی کاهش‌گرا را برای تمام بیماری‌ها به‌کار گیرند و به‌دنبال علت‌های دیگری غیر از علل زیست‌شناختی برای وضعیت انحراف از سلامت نباشند.

براساس الگوی پزشکی، روان و ذهن، جدا از جسم و بدن است. به بیان دیگر، این رویکرد یک الگوی تک‌عاملی از بیماری و متمرکز بر دامنه محدودی از علل بیماری است (اغلب فقط علل زیست‌شناختی) و عوامل و مؤلفه‌های علی احتمالی دیگر را نادیده می‌گیرد؛ عناصری نظیر عوامل روانی، اجتماعی و شناختی. با این حال، برخی معتقدند به هنگام مطالعه سلامت فرد، علاوه بر عوامل زیست‌شناختی، باید به بررسی علل اجتماعی و روانی نیز پرداخت.

الگوی زیستی، روانی و اجتماعی، اعتقاد دارد که مرز بین سلامت و بیماری به‌طورکامل مشخص نیست، بنابراین الگوی پزشکی همیشه معیار مفیدی برای مشخص کردن و توصیف سلامت و عدم سلامت نیست. برخلاف الگوی پزشکی، الگوی زیستی، روانی و اجتماعی، هم بیمار و هم بیماری را در نظر می‌گیرد. همان‌گونه که انگل (۱۹۷۷) اظهار می‌کند، با ارزیابی تمام عوامل سهیم در بیماری و بیمار بودن، به‌جای اینکه در ابتدا فقط بر عوامل زیست‌شناختی تأکید کنیم، الگوی زیستی، روانی و اجتماعی این امکان را فراهم می‌سازد که به تبیین این موضوع بپردازیم که چرا برخی افراد برخلاف بعضی دیگر که فقط شرایط را به‌صورت مشکلات زندگی تجربه می‌کنند، شرایط را بیمارگونه تجربه می‌کنند و واکنش‌های هیجانی به شرایط زندگی دارند و نشانگان جسمانی از خود نشان می‌دهند.

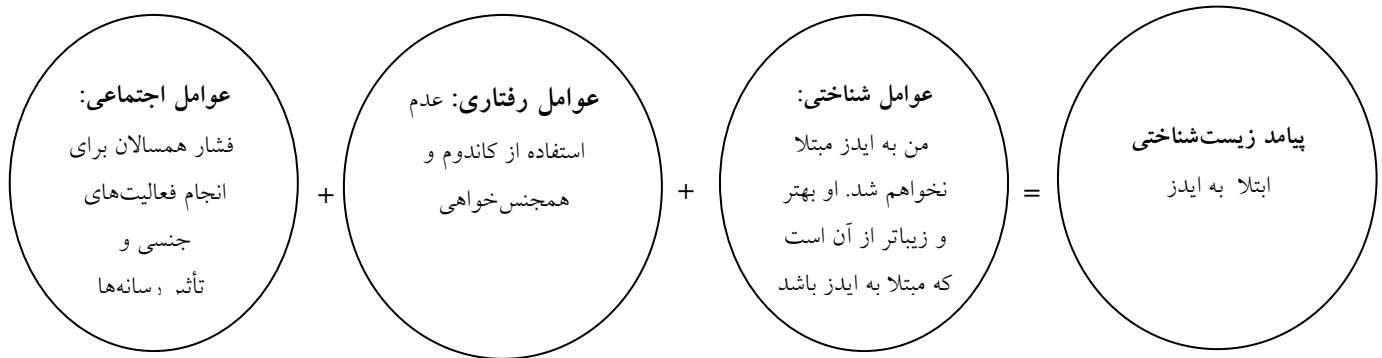
براساس نتایج مطالعات ابروین و اور^۳ (۱۹۹۱)، از دیرباز بین رشته‌های علمی مختلف رابطه وجود داشته است. این محققان دریافته‌اند که سلامت نوجوانان، بهزیستی و بیماری آنها ماهیتاً چندبعدی بوده و فقط متشکل از بدن و ذهن نیست، بلکه شامل مؤلفه‌های حقوقی، قانونی و محیطی نیز است. الگوی زیستی، روانی و اجتماعی، از سلامت و بیماری هنگام تشخیص و درمان یک

^۱ . Engel

^۲ . medical

^۳ . Irwin & Orr

بیماری دچار چالش می‌شود و تمایل دارد که تمام عملکردهای فردی را در نظر بگیرد و به حساب بیاورد. بنابراین افراد تشویق می‌شوند تا دریابند که سلامت و بیماری توسط علل چندگانه‌ای که با یکدیگر در حال تعامل‌اند، تعیین می‌شود و فقط زمانی تشخیص کامل و کارآمد وجود خواهد داشت که کلیه عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و زیست‌شناختی ارزشیابی شوند. بر این اساس، دانشجویان پزشکی برانگیخته می‌شوند تا به تمام ابعاد بیمار (با برقراری ارتباط با بیمار) علاقه نشان دهند، توجه بیشتری به شرایط زندگی بیمار کنند و به مشکلات شخصی وی حساس‌تر باشند. از این‌رو، برای چالش با دانشجویان پزشکی باید رویکردی نظام‌دار طرح‌ریزی کرد که شامل شناسایی این نکته باشد که ابعاد و جوانب زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی افراد متعلق به نظام واحدی است و آنها به اتفاق و هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند تا یک فرد سالم باشد (نمودار ۱-۱). به بیان دیگر، اعتقاد بر این است که تغییر در یک مؤلفه از این سیستم آثار بالقوه‌ای بر دیگر مؤلفه‌های این سیستم دارد. برای مثال نوجوانی را در نظر بگیرید که از طرف همسالان خود در مدرسه طرد شده است. همکلاسی‌های او تا حد امکان از تماس با او اجتناب می‌کنند. او بندرت در فعالیتهای کلاسی به آنها می‌پیوندد و حتی در اجتماعات شرکت نمی‌کند. به‌عنوان یک پیامد، او دچار انزوا و تنهایی شده و نمی‌تواند خوب غذا بخورد و این بی‌اشتهایی وزن او را بشدت کاهش داده است. دکتر خانوادگی او بدون آگاهی از شرایط او در مدرسه به درمان نشانگان جسمانی او بدون توجه به منشأهای اجتماعی آن می‌پردازد و تعجبی ندارد که بیماری او مدت‌ها ادامه می‌یابد و درمان نمی‌شود.



نمودار ۱-۱. رویکرد زیستی، روانی و اجتماعی به عفونت ایدز در میان نوجوانان (به نقل از هیون^۱، ۱۹۹۶)

الگوی زیستی، روانی و اجتماعی، پایه و اساس تعریف ما از سلامت است و به‌طور خلاصه عبارت است از اینکه فرایندهای روان‌شناختی و زیست‌شناختی نقش مهمی در بروز سلامت یا بیماری دارند. برای بررسی و آزمایش سلامت نوجوانان، نخست باید به متغیرهای مختلف فردی و روان‌شناختی مرتبط با آنها توجه کرد.

مفاهیم سلامت و بیماری در میان کودکان و نوجوانان

در این بخش، به مطالعه دیدگاه‌های نوجوانان در مورد بیماری و سلامت پرداخته می‌شود. این کار را با بررسی چگونگی شکل‌گیری و رشد باورهای سلامت در میان نوجوانان شروع می‌کنیم.

رشد و توسعه باورهای سلامت

مطالعات زیادی باورهای نوجوانان در مورد سلامت و بیماری را بررسی کرده‌اند (کمپبل^۲، ۱۹۷۵؛ دیلمن^۳ و همکاران، ۱۹۸۰؛ گوشمن، ۱۹۷۱). شواهد موجود نشان می‌دهند که شکل‌گیری و رشد باورهای سلامت هم همانند سایر ارزش‌ها و باورها، سیر تحولی دارد و تحول این باورها ارتباط نزدیکی با تحول شناختی افراد دارد.

^۱. Heaven

^۲. Campbell

^۳. Dielman

مطالعات تحولی - شناختی

بورباش و پیترسون^۱ (۱۹۸۶) به بررسی چندین پروژه تحقیقاتی پرداخته‌اند. در این پروژه‌ها سعی شده مراحل تحولی مفهوم بیماری مشخص شود. این مطالعات نشان داده‌اند کودکانی که از نظر شناختی به بلوغ لازم رسیده‌اند، به احتمال بیشتر دارای احساس کنترل بر فرایند سلامت و بیماری خود می‌باشند. کودکان کوچک‌تر ممکن است بیشتر اوقات بیماری را پیامد و نتیجه رفتار بد و نادرست خود بدانند و فکر کنند که بیماری شکلی از مجازات است. کودکان بزرگ‌تر درباره بیماری‌ها و نشانگان بیماری به‌طور مشخص‌تر و خاص‌تری آگاهی دارند. آنها می‌توانند ماهیت بیماری را به‌طور واضح‌تری توصیف کنند. در مقابل، کودکان کوچک‌تر بیماری خود را به روش‌هایی که وضوح کمتری دارد و کمتر مشخص است، توصیف می‌کنند (برای مثال من احساس درد می‌کنم).

یافته‌های پژوهشی نیز نشان داده‌اند که کودکان بزرگ‌تر نسبت به کودکان کوچک‌تر، از روابط بین ابعاد عاطفی، روان‌شناختی و اجتماعی بیماری‌ها آگاهی بیشتری دارند (بورباش و پیترسون، ۱۹۸۶). به‌نظر می‌رسد کودکان بزرگ‌تر این توانایی را دارند که هنگام تعیین وضعیت سلامت خود از نشانه‌های درونی استفاده کنند. از سوی دیگر، کودکان کوچک‌تر بیشتر بر نشانه‌های بیرونی (نظیر خون آمدن از انگشت) یا بر نظارت بیرونی (نظیر رأی و نظر پزشک خانوادگی) تأکید می‌کنند. بنابراین به موازات اینکه کودکان از لحاظ شناختی رشد پیدا می‌کنند و می‌توانند به‌صورت منطقی‌تری فکر کنند، مفهوم‌سازی‌های آنها از سلامت و بیماری تغییر می‌کند. تفاوت‌های ظریف و در عین حال مهمی در زمینه ادراک کودکان در مراحل تحول وجود دارد. کودکان بزرگ‌تر، بخصوص آنهایی که در مرحله عملیات صوری قرار دارند، نسبت به آنهایی که در مرحله عملیات عینی قرار دارند (سانتروک^۲، ۱۹۹۰)، هنگام مفهوم‌سازی از بیماری، از استدلال‌ها و توجیه‌های انتزاعی استفاده می‌کنند. کودکان بزرگ‌تر قادرند بیماری را به‌عنوان شرایطی که دارای علل چندگانه‌ای است مدنظر قرار دهند، درحالی‌که کودکان کوچک‌تر، مفاهیم ساده‌تر و با پیچیدگی کمتری را از بیماری و سلامت ارائه می‌دهند (میلستین، ۱۹۹۱).

موضوعات مرتبط با مفهوم‌سازی از سلامت و بیماری

وقتی از کودکان خواسته می‌شود معنای بیماری یا سلامت را شرح دهند، از نظر مطالبی که برای توصیف و تشریح منظورشان استفاده می‌کنند، تفاوت‌هایی دارند. برای مثال، در مطالعه‌ای که بر روی

^۱ . Burbach & Peterson

^۲ . Santrock

کودکان ۶-۱۳ ساله و مادران آنها انجام شد، بین کودکان کوچکتر و بزرگتر تفاوت‌هایی در زمینه مفهوم‌سازی از بیماری مشاهده شد. کودکان مورد مطالعه در بیمارستان بستری و در حال بهبودی بودند و در این حال از آنها سؤال شده بود که: ما نمی‌دانیم شما چگونه می‌فهمید مریض‌اید و وقتی می‌گویید مریض‌اید منظورتان چیست؟ شما می‌دانید که یک روز حالتان خوب است و یک روز دیگر مریض‌اید، بسیار خوب به ما بگویید که تفاوت آنها در چیست؟ (کمپبل، ۱۹۷۵).

طی این تحقیق موضوعات بسیاری در مورد بیماری آشکار شد (جدول ۱-۱). کمپبل (۱۹۷۵) دریافت که کودکان بزرگتر و کوچکتر در زمینه موضوعات مهم یا برجسته تا حدودی اتفاق نظر^۱ دارند. برای مثال، مشاهده شد که در هر دو گروه حالات احساسی غیرمشخص و مبهمی در زمینه تعریف‌های رایجی که از بیماری صورت می‌گرفت وجود داشت، درحالی‌که در مورد سؤالاتی که مرتبط با خلق و خو یا نقش بود، این‌طور نبود. همچنین باید توجه داشت که کودکان بزرگتر نسبت به کودکان کوچکتر، به احتمال زیاد در تعاریف خودشان به بیماری‌های مشخص یا تشخیص‌های خاصی اشاره می‌کنند یا نقش‌های تعدیل‌یافته و اصلاح‌شده را مدنظر قرار می‌دهند.

برخلاف اینکه برخی شباهت‌های بین‌نسلی^۲ بین مادران و کودکان بزرگتر وجود داشت، تعاریف مادران پیچیده‌تر بود، این موضوع نشان می‌دهد که آنها به لحاظ روانی اجتماعی جهت‌یافته‌تر، دقیق‌تر و همچنین ظریف‌ترند.

نتایج پژوهش کمپبل (۱۹۷۵) نشان می‌دهد که حتی کودکان شش ساله در دیدگاه خود نسبت به ماهیت بیماری تا حدودی اتفاق نظر دارند. همچنین دیده شده به موازات اینکه کودکان از لحاظ شناختی رشدیافته و بالغ‌تر می‌شوند و در یادگیری مهارت‌های زبانی پیشرفت بیشتری پیدا می‌کنند، تعاریف آنها از بیماری پیچیده‌تر و پالایش‌یافته‌تر می‌شود.

^۱ . consensus

^۲ . intergenerational

جدول ۱-۱. مفهوم‌های کودکان از بیماری

موضوعات	مثال‌ها
۱- حالت‌های احساسی غیرمشخص و فاقد مکان ^۱	احساس بد بودن، خوب نبودن
۲- حالات احساسی مشخص ولی فاقد مکان	بیماری یا درد فاقد مکان
۳- احساسات جسمانی مشخص و دارای مکان	درد معده
۴- علامت‌های قابل مشاهده بیرونی	ظاهر شدن دانه‌های قرمز رنگ روی پوست
۵- مفهوم بیماری یا تشخیص خاص	آپاندیس، آبله مرغان
۶- حالات خلقی، انگیزشی و نگرشی	تحریک‌ناپذیر، ناراحت
۷- افزایش میزان رفتارهای نقش بیمار	دراز کشیدن، به تختخواب رفتن، گفتن به مادر که من مریض‌ام
۸- نقش‌های متعارف را تغییر دادن	به مدرسه نرفتن
۹- رفتار یا تمایلات و مقاصد دیگران	مادر به من دارو بده
۱۰- محدودیت آشکار در مفهوم بیماری	اگر فقط سرماخوردگی داشته باشم که مریض نیستم

منبع: کمپیل، ۱۹۷۵

زمانی که از نوجوانان خواسته می‌شود تا سالم بودن را از نظر خودشان توضیح دهند، به موارد زیر اشاره می‌کنند (میلشتین و لیت^۲، ۱۹۹۰):

- در حد توان خود زندگی کردن؛
- توانایی انجام اعمال جسمانی، روانی و اجتماعی؛
- تجربه کردن حالات هیجانی مثبت.

در مطالعه‌ای مفاهیم بیماری و سلامت در نوجوانان ۱۸-۱۱ ساله بررسی شد. با این نوجوانان دانش‌آموز درباره درکی که از معنای سلامت یا بیماری دارند، به‌طور انفرادی مصاحبه شد. پاسخ‌دهندگان از موضوعات مختلفی برای تعریف مفاهیم استفاده کردند. همان‌گونه که در جدول ۱-۲ نیز مشاهده می‌شود، یکی از یافته‌های مهم این مطالعه این بود که موضوعات معینی با بیماری مرتبط بود. همان‌طور که جدول ۱-۲ نشان می‌دهد، تعاریف سلامت بیشتر بر وضعیت عملکرد کلی، رفتارهای پیشگیری‌کننده - حفاظت‌کننده (نظیر رژیم غذایی خوب و مناسب)، و ظرفیت‌های محدود متمرکز است (نظیر نداشتن بیماری‌های زیاد) (میلشتین و ایروین، ۱۹۸۷). علاوه بر این تفاوت‌های دیگری نیز ملاحظه شد، برای مثال، محققان دریافتند نوجوانان کم‌سن‌تر بیشتر از بزرگ‌ترها بر «بیمار

^۱ .non - localised^۲ . Litt

نبودن» تأکید می‌کنند. بین گروه‌های سنی نیز تفاوت‌هایی در زمینه موضوعات استفاده شده برای تعریف سلامت و بیماری وجود داشت.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که تعاریف نوجوانان از بیماری متفاوت‌تر و متنوع‌تر از تعاریفی است که از سلامت دارند، این موضوع نشان می‌دهد که برای این نوجوانان مفهوم بیماری خیلی برجسته‌تر و بارزتر است. همچنین مشاهده شد که مفهوم‌های سلامت و بیماری برای نوجوانان کاملاً متمایز و جدا از هم نیست و یکی را می‌توان به جای دیگری بکار برد. بنابراین تعریف‌های نوجوانان از سلامتی و بیماری تا حدودی دارای همپوشی است. از این رو، ممکن است برنامه‌های آموزش و ترویج سلامت که فقط بر عدم بیماری متمرکزند، تا حدودی موفق باشند.

جدول ۱-۲. بخشی از موضوعات مورد استفاده در تعریف سلامت و بیماری توسط نوجوانان

موضوعات تعریفی	درصد معنای سلامت	درصد معنای بیماری
حالات احساسی جسمانی	۳۳/۲	۵۸/۹
نشانه‌های سلامت و بیماری	۱۳/۵	۲۱/۳
نشانه‌های عینی	۱۲/۰	۱۶/۵
مشخصه‌ها	۱/۵	۴/۸
توانایی عملکردی	۱۶/۴	۷/۱
عملکرد کلی	۱۳/۹	۲/۰
عملکرد نقش	۲/۴	۷/۷
حالات عاطفی	۶/۵	۸/۰
ارزیابی دیگران	۰/۰	۰/۹
رفتارهای پیشگیرانه - حفاظت‌کننده	۱۷/۹	۰/۳
محدودیت - کمی کردن	۵/۱	۰/۲

منبع: ملیشتین و ایروین، ۱۹۸۷

منبع باورهای سلامتی

برخی نویسندگان (لو، کوادرل و هارتمن^۱، ۱۹۹۰) اعتقاد دارند که باورهای سلامتی از طریق دو الگو آموخته می‌شوند؛ این دو الگو شامل جامعه‌پذیری خانوادگی دیرپا (طولانی‌مدت) و دریچه‌های آسیب‌پذیری^۲ است. اولین روش برای یادگیری، مجموعه‌ای از باورهای سلامتی از طریق یادگیری

^۱ . Lau, Quadrel & Hartman

^۲ . windows of vulnerability

اجتماعی است که عبارت است از تقلید باورها و رفتارهای سلامت از اعضای دیگر خانواده. همان‌گونه که لو، کوادرل وهارتمن (۱۹۹۰) شرح داده‌اند، والدین رژیم غذایی خانواده را تعیین می‌کنند، مواد اولیه غذایی را تهیه کرده و پخت می‌کنند تا کودکانشان بخورند، آنها به فعالیت‌های جسمانی مشغول‌اند، ممکن است خیلی افراطی مشروب بنوشند یا سیگار بکشند، مواد مخدر تهیه می‌کنند و به خانه می‌آورند، و تصمیم می‌گیرند که چه موقع کودک باید به دکتر مراجعه کند.

لو و همکاران (۱۹۹۰) این الگو را در یک مطالعه طولی بررسی کردند. آنها به مطالعه این موضوع پرداختند که والدین و همسالان به چه میزان باورها و رفتارهای سلامت نوجوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. گروهی از نوجوانان که هنوز با خانواده‌های خود زندگی می‌کردند، پرسشنامه‌ای را در مورد اینکه این رفتارها چقدر کارآمد و مؤثرند، پر کردند. از والدین نیز خواسته شد تا سؤالاتی را درباره میزان تلاش خود برای آموزش به فرزندانشان برای عمل به این رفتارها، پاسخ دهند. آزمودنی‌ها طی یک دوره سه ساله مورد مصاحبه قرار گرفتند.

لو و همکاران (۱۹۹۰) دریافتند که والدین نقش مهمی در جامعه‌پذیری نوجوانان و در نتیجه شکل‌گیری باورهای سلامت آنان دارند، اگرچه قدرت تأثیر آنها به اندازه اولین مسائلی که اعتقادهای نوجوانان را تشکیل می‌دهند نیست. همچنین، دیده شد که همسالان تا حدودی بر نوجوانان تأثیر می‌گذارند، بویژه وقتی آنها وارد دانشگاه می‌شوند. با این حال، این تأثیر محدود است. بنابراین محققان مدل دومی را با عنوان دریچه‌های آسیب‌پذیری پیشنهاد کردند.

این محققان معتقدند که والدین همیشه نقش مهمی در رفتارها و باورهای سلامت کودکانشان دارند، به‌استثنای دوره‌های مهم یا دوره‌های آسیب‌پذیری. این دوره‌های مهم در طول دوران نوجوانی اتفاق می‌افتند و مصادف با زمانی‌اند که نوجوانان خانه را ترک و محیط زندگی خود را انتخاب می‌کنند. در دورانی که نوجوانان در جست‌وجوی هویت شخصی‌اند (اریکسون، ۱۹۶۸)، آزمایش و تجربه رفتارها و نقش‌های مختلف شایع است و دوره مهمی برای نوجوان محسوب می‌شود و زمانی است که تأثیر گروه همسالان کاملاً قدرتمند است. به این دوره‌های حساس دریچه‌های آسیب‌پذیری می‌گویند. به‌طور خلاصه، این الگو به‌صورت زیر است:

بررسی و پیش‌بینی تأثیر دیرپای والدین درحالی‌که نوجوان در معرض یک دوره آسیب‌پذیری نسبت به سازمان‌های مهم اجتماعی قرار گرفته است، نشان می‌دهد که عقاید، باورها و رفتار او از والدین متفاوت است. در این مورد، باورها و رفتارها باید تغییر کنند و بیشتر با همان سازمان‌های اجتماعی و جامعه‌پذیری همگون و متجانس شوند.

گاهی نوجوانان و جوانان در برخورد با والدین از احساس امنیت برخوردار نیستند و احساس نوعی نیاز روانی به محبت را از جانب والدین می‌کنند. توجه به نوع نیازمندی‌های نوجوانان و تأمین آنها، می‌تواند موجب امنیت و جلب اعتماد آنان شود. در پژوهشی که توسط انجمن اولیا و مربیان (۱۳۵۴، به نقل از احمدی، ۱۳۸۲) صورت گرفته، انواع نیازهای نوجوانان و جوانان تا حدودی روشن شده است.

جدول ۱-۳. درصد نیازهای نوجوانان و جوانان

درصد	نوع نیاز
۲۷	تقویت روانی
۲۱	داشتن آزادی
۱۷	محیط مناسب برای فعالیت و دوستی
۱۳	پرورش و رشد شخصیت
۱۱	تشکیل انجمن‌های مختلف
۷	امکان برقراری ارتباط اجتماعی
۴	داشتن هدف در زندگی

همان گونه که در جدول ۱-۳ مشاهده می‌شود، نوجوانان و جوانان نیاز به تقویت روانی و محیط مناسب برای فعالیت و امکان ارتباط اجتماعی دارند و نباید آزادی عمل را در مواردی که اشکال ندارد محدود کرد.

بحث بالا نشان می‌دهد که نوجوانی دوره‌ای توأم با انتقال^۱ است. بویژه، بسیار واضح است که باورها و مفهوم‌سازی‌ها درباره سلامت، بیماری و رفتارهای پیشگیری‌کننده در حالت انتقالی قرار دارند. نتایج پژوهش‌ها به‌طور همگونی نشان‌دهنده وجود تفاوت‌های سنی و جنسی در دامنه‌ای از رفتارهایی است که تأثیر مستقیمی بر وضعیت سلامت دارند. این رفتارها شامل سیگار کشیدن، ورزش کردن، کم غذا خوردن و تند غذا خوردن است (کوهن، براونل و فلیکس^۲، ۱۹۹۰). در فصل بعد این موضوعات به‌طور مفصل بررسی می‌شوند.

^۱ . transition

^۲ . Cohen, Brownell & Felix

نگرانی‌های سلامتی نوجوانان

همان‌گونه‌که نوجوانان می‌توانند سلامت و بیماری را مفهوم‌سازی کنند، قادرند نگرانی‌های خاصی درباره سلامتی داشته باشند. یک مطالعه طولی در استرالیا (دپارتمان استخدام، آموزش و کارآموزی، ۱۹۹۱) باورهای سلامتی ۵۰۰ نوجوان ۱۹-۱۶ ساله را بررسی کرد. نزدیک به ۲۰ درصد آزمودنی‌ها فکر می‌کردند که سلامتی آنها در طول سال‌های گذشته افزایش یافته است. کمتر از ۱۰ درصد آنها فکر می‌کردند که سلامتی آنها کمتر شده، درحالی‌که در حدود ۷۰ درصد آنها معتقد بودند سلامتی‌شان تغییری نکرده است.

سوبال^۱ (۱۹۸۷) با ۲۷۸ نوجوان آمریکایی درباره نگرانی‌های سلامتی‌شان مصاحبه کرد. بیشتر پاسخ‌دهندگان سفیدپوست و از طبقه کارگر بودند. ۳۴ درصد پاسخ‌دهندگان اظهار کردند سلامتی آنها عالی است. ۵۰ درصد اظهار کردند که سلامتی آنها خوب است. ۱۶ درصد بیان داشتند که از سلامتی خوبی برخوردار نیستند. ۱۶ درصد اظهار کردند که همیشه به سلامتی‌شان می‌اندیشند و ۵۵ درصد اظهار کردند فقط گاهی به سلامت خود فکر می‌کنند و ۲۹ درصدشان بیان کردند که هیچ‌گاه به سلامتی خود فکر نمی‌کنند. همچنین از این نوجوانان خواسته شد درباره موضوعاتی که بیشتر آنها را در مورد سلامتی‌شان نگران می‌کند، صحبت کنند. آنها به موارد زیر اشاره کردند:

- مشکلات مربوط به دهان و دندان؛
- در کنار دوستان بودن؛
- تغذیه؛
- مسائل جنسی؛
- با بزرگسالان بودن؛
- جوش صورت؛
- آسیب‌های ورزشی؛
- خوابیدن؛
- سردرد.

نوجوانان کم سن و سال‌تر نسبت به نوجوانان بزرگ‌تر، نگرانی بیشتری در مورد موضوعاتی نظیر دوستان، کمبود ویتامین، سردرد، کودک‌آزاری، تصادف با اتومبیل، ترس‌ها، دستیابی به خدمات و سازمان‌های سلامتی، عصبی بودن، مشروب‌خواری، رژیم غذایی، سرفه‌های ممتد، خودکشی، مواد مخدر و کنترل زاد و ولد، جوش صورت، چاقی و اضافه وزن داشتند. پسران بیشتر درباره صدمات

^۱ . Sobal

ورزشی و روابط جنسی نگران بودند. آن دسته از نوجوانانی که فکر می‌کردند به اندازه همسالان خود سالم نیستند، بیشتر دربارهٔ افسردگی، تصادف با اتومبیل، مشروب‌خواری و کودک‌آزاری نگران بودند. مطالعهٔ مشابهی نیز با گروه بزرگی از نوجوانان کانادایی (۷۰۰ نوجوان) با میانگین سنی ۱۲ تا ۲۰ سال صورت گرفت (هاجسون^۱ و همکاران، ۲۰۰۳). جدول ۱-۴ نشان‌دهندهٔ درصد پاسخ‌دهندگان است که با دکتر یا پرستار دربارهٔ مشکل خود صحبت کردند و تمایل داشتند دربارهٔ مشکل خود با کسی مشورت کنند. اطلاعات جدول نشان می‌دهد که این گروه از نوجوانان بیشتر دربارهٔ موضوعاتی نظیر جوش‌های مربوط به مشکلات قاعدگی (فقط دختران)، مشکلات هیجانی و عصبی و نگرانی در مورد دندان، ناراحت بودند. برخی از این موضوعات با نتایج به‌دست آمده از پژوهش سوبال (۱۹۸۷) همخوانی دارد.

جدول ۱-۴. نگرانی‌های سلامتی نوجوانان کانادایی

نوع مشکل	درصدی که بیشتر اوقات یا گاهی اوقات او را نگران می‌کند	مشورت با پزشک	تمایل به مشورت با پزشک
جوش صورت	۴۷/۴	۳۹/۹	۲۵/۲
قاعدگی	۳۱/۵	۴۳/۴	۴۰/۰
هیجانی - عصبی	۲۶/۳	۵۴/۲	۳۸/۶
دهان و دندان	۲۵/۹	۲۷/۳	۳۹/۷
اضافه وزن	۲۱/۶	۶۵/۱	۳۱/۷
چشم و بینایی	۱۹/۷	۱۸/۰	۳۷/۸
صدمات ورزشی	۱۹/۰	۳۵/۶	۲۵/۰
دردهای معده	۹/۲	۲۶/۲	۴۴/۰
کنترل و جلوگیری از بارداری	۸/۸	۱۹/۰	۶۵/۶
کم بودن قد نسبت به سن	۶/۸	۳۱/۱	۴۰/۰
کم‌وزنی	۵/۱	۷۱/۰	۳۱/۹
مشکلات مزمن سلامتی	۲/۶	۱۶/۷	۲۴/۸
بلند بودن قد نسبت به سن	۱/۶	۲۰/۰	۱۹/۴
داروهای روان‌گردان	۱/۲	۱۴/۳	۴۲/۹
الکل و مشروبات الکلی	۱/۱	۲۰/۰	۶۰/۰

منبع: هاجسون و همکاران، ۲۰۰۳

^۱. Hodgson

هر دو مطالعه نشان داد نوجوانان درباره موضوعات جنسی نظیر جلوگیری از بارداری و بیماری‌های آمیزشی نگران‌اند. مطالعه کانادایی نشان داد اگرچه فقط ۲۲ درصد کل پاسخ‌دهندگان درباره روابط جنسی نگران بودند، در حدود ۹ درصد آنها از موضوع جلوگیری از بارداری و بچه‌دار شدن ناراحت بودند. دختران بیشتر نگران این موضوع بودند تا پسران. به‌علاوه، دختران ۱۶ ساله و بزرگ‌تر که روابط جنسی را تجربه کرده بودند، بیشتر درباره جلوگیری از بارداری ناراحت و نگران بودند تا پسران در تمام سنین. کنترل بارداری و روابط جنسی سالم، از موضوعات بسیار مهم برای نوجوانان است و کاربردهای مهمی در سلامت افراد دارد. این موضوعات به تفصیل در فصل‌های بعد بررسی می‌شوند.

نگرانی‌های سلامتی در نوجوانان مورد بحث نشان می‌دهد که آنها موضوعات غیرپزشکی و همچنین روابط بین شخصی را بیان می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که نتایج مطالعات دیگر نیز از این موضوع حمایت کنند. مطالعات دیگر نشان داده‌اند نوجوانان کوچک‌تر بیشتر درباره موضوعاتی نظیر سیگار کشیدن و استفاده از مشروبات و مواد مخدر نگران‌اند، درحالی‌که نگرانی نوجوانان بزرگ‌تر بیشتر درباره مسائل تحصیلی و شغلی است (میلشتین و لیت، ۱۹۹۰).

عوامل اقتصادی-اجتماعی و قومی نیز نقش مهمی در ادراک سلامتی در نوجوانان دارد. یکی از این عوامل مذهب است. در قسمت‌های بعد به تفصیل در این مورد بحث خواهد شد.

نوجوانی: دوره‌ای خطرناک برای سلامتی

نوجوانی، دوره‌ای است که طی آن افراد تلاش می‌کنند به هویت شخصی خود دست یابند. همچنین در این دوره نوجوانان رفتارهای مختلف را به آزمایش می‌گذارند و تجربه می‌کنند. برخی صاحب‌نظران به سال‌های نوجوانی به‌عنوان دوره توفانی، تنش‌زا، استقلال و عدم وابستگی می‌نگرند. بعضی هم این دوره را به سادگی دوره‌ای خطرناک قلمداد می‌کنند (مکانیک^۱، ۱۹۹۱). رفتارهای خطرناک، رفتارهایی با پیامدهای مبهم‌اند. چنین رفتارهایی ممکن است آسیب‌زا باشند یا نباشند (ایروین و میلشتین، ۱۹۹۱).

جسور^۲ و همکارانش (۱۹۹۱) نظریه‌ای درباره خطرهای روانی اجتماعی پیشنهاد کرده‌اند. آنها به دامنه‌ای از عواملی که ممکن است برخی از نوجوانان را برای درگیر شدن در مشکلات و رفتارهای

^۱ . Mechanic

^۲ . Jessor

مشکل آفرین مستعد سازد، اشاره کرده‌اند. برخی از این عوامل ممکن است تأثیرات مستقیمی بر وضعیت سلامتی داشته باشند. این عوامل عبارتند از:

عوامل تاریخچه اجتماعی

این عوامل شامل سطح تحصیلات، شبکه و ترکیب خانوادگی، مذهب و وقایع مثبت و منفی زندگی و غیره می‌شود.

عوامل روان‌شناختی اجتماعی

- شخصیت (ارزش‌ها، باورها و کنترل شخصی)؛
- محیط ادراک شده (برای مثال کنترل والدین، نقش الگوهای اجتماعی و ارزیابی همسالان)؛
- نظام رفتاری؛
- رفتار مشکل‌آفرین (مواد مخدر، سیگار کشیدن و انحرافات عمومی)؛
- رفتار متعارف.

براساس این الگو، عوامل مختلف شخصی و محیطی رابطه تنگاتنگ و متقابلی در مستعد کردن نوجوانان برای درگیری در رفتارهای مشکل‌آفرین خاص دارند. عوامل محافظتی نیز در هر حوزه وجود دارد. برای مثال، خانواده‌ای که در آن روابط نزدیکی بین والدین و نوجوان وجود دارد و والدین، سبک والدینی قاطعانه^۱ را بر خانواده حاکم کرده‌اند، به احتمال زیاد خطر اقدام به رفتارهای خطرآفرین در نوجوان کاهش می‌یابد. همچنین درحالی‌که برخی صفات شخصیتی نظیر عزت نفس پایین با رفتارهای خطرناک نوجوانان مرتبط‌اند، صفات دیگری نظیر عزت نفس بالا یا مذهبی بودن ممکن است به‌عنوان عوامل محافظت‌کننده عمل کنند (جسور، ۱۹۹۳).

نقش مذهب در سلامتی

یافته‌های بیشتر پژوهش‌هایی که در زمینه رابطه مذهب و جنبه‌های گوناگون سلامت جسمانی انجام گرفته است، رابطه مثبتی را بین مذهب و سلامت جسمانی در سنین مختلف نشان داده‌اند (بیکر و گورساج^۲، ۱۹۸۲؛ لو و هاندال^۳، ۱۹۹۵؛ به نقل از فقیهی، ۱۳۸۴). آکلین، براون و منیوگر^۴ (۱۹۸۳)

^۱. authoritative

^۲. Bacher & Gorsuch

^۳. Low & Handal

^۴. Acklin, Brown & Manuger

رابطه مذهب و قدرت مقابله با سرطان را در نوجوانان و بزرگسالان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که نگرش مذهبی موجب می‌شود، افراد مبتلا به سرطان نگرش مثبتی به زندگی داشته باشند، بیشتر در جمع حضور پیدا کنند و از انزوای اجتناب ورزند. کولیپ^۱ (۱۹۶۹) نیز در پژوهشی که بر روی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان انجام داد، نشان داد که عبادت می‌تواند عمر این کودکان و نوجوانان را افزایش دهد.

در زمینه بهداشت روانی و سازگاری، بیشتر پژوهش‌های انجام شده نشان داده‌اند که مذهب اثر مثبتی در سازگاری و بهداشت روانی افراد دارد (خدایاری‌فرد، رحیمی‌نژاد و عابدینی، ۱۳۸۵؛ بهرامی، ۱۳۷۳؛ اسلامی، ۱۳۷۶؛ محفوظی و جان بزرگی، ۱۳۷۷).

خدایاری‌فرد، رحیمی‌نژاد و عابدینی (۱۳۸۵)، رابطه باورهای دینی و سازگاری اجتماعی را در دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه‌های شهر تهران مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. آنان دریافتند که بین کلیه ابعاد باورهای دینی (شناخت دینی، عواطف دینی، باورهای دینی و وظایف دینی) با ابعاد مختلف سازگاری اجتماعی در دانشجویان فرزندان شهدای جنگی و عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این حال این رابطه در دانشجویان دختر شاهد و عادی قوی‌تر از دانشجویان پسر شاهد و عادی و در دانشجویان دختر و پسر فرزندان شهدای جنگی قوی‌تر از دانشجویان دختر و پسر عادی بود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان شاهد به دلیل داشتن نگرش دینی قوی‌تر سازگاری بیشتری از دانشجویان عادی دارند.

بهرامی (۱۳۸۳) با به کارگیری پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا^۲ (MMPI) و آزمون عبادت‌سنج در نوجوانان دبیرستانی دریافت که رابطه‌ای منفی و معنادار بین میزان عبادت و نشانگان افسردگی و اضطراب وجود دارد.

اسلامی (۱۳۷۶) با مطالعه نوجوانان ایرانی دریافت که بین نگرش مذهبی و میزان افسردگی آنان رابطه‌ای منفی وجود دارد. بنابراین دین واجد مؤلفه‌های مهمی برای سازش‌یافتگی انسان است. کسانی که ارزش‌های دینی را بر دیگر ارزش‌ها ترجیح می‌دهند، از سازگاری بیشتر و سلامت جسمانی و روانی افزون‌تری برخوردارند (محفوظی و جان بزرگی، ۱۳۷۷).

الگوی خطرهای روانی- اجتماعی بین عوامل مؤثر مجاور و عوامل مؤثر با فاصله در به خطر افتادن سلامت نوجوانان تمایز قائل می‌شود. عوامل مجاور، روابط نزدیکی با رفتار مشکل‌آفرین دارد (برای مثال، تأثیر الگوگیری از دوستان)، درحالی‌که عوامل دور (نظیر عزت نفس ضعیف) تأثیر غیرمستقیمی بر رفتارهای خطرناک دارد. حمایت‌های تجربی زیادی برای الگوی روانی اجتماعی از

^۱ . Collip

^۲ . Minnesota Multiphasic Personality Inventory

خطر وجود دارد. جسور (۱۹۸۴) در مطالعه‌ای توانست به پیش‌بینی زمان برقراری اولین رابطه جنسی (خطر سلامتی) در گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی بپردازد. او یک الگوی روانی - اجتماعی را قبل از برقراری اولین رابطه جنسی تعریف و مشخص کرده است. بنابر نظر او، نوجوانانی که در فعالیت جنسی درگیر می‌شوند، ارزش زیادی به استقلال و ارزش کمتری به عملکرد تحصیلی می‌دهند. نوجوانان دارای اشکال مختلف رفتارهای انحرافی بودند، کمتر مذهبی بودند و تمایل کمتری به رفتن به کلیسا داشتند و از جامعه بیشتر انتقاد می‌کردند. آنها در سایر رفتارهای مشکل‌آفرین درگیر شدند و به‌نظر می‌رسید که بیشتر به ارزش‌های گروه همسالان پایبند باشند تا به ارزش‌های والدین خود. به‌طور کلی، می‌توان پنج گروه از نوجوانانی را که بیشتر در معرض خطر حاملگی، اقدام به جرم و مصرف مواد مخدر قرار دارند نام برد؛ این پنج گروه عبارتند از:

- آنهایی که شکست‌های تحصیلی پی در پی را تجربه کرده‌اند؛
- افرادی که به محیط‌های خانوادگی آزاردهنده و دارای بحث و مجادله تعلق دارند؛
- نوجوانانی که نسبت به ارزش‌های همسالان و تحریک و ترغیب آنان آسیب‌پذیرند؛
- نوجوانانی که می‌خواهند اثبات کنند ترسی از خطر ندارند؛
- آنهایی که متعلق به خانواده‌هایی هستند که حاملگی، استفاده از مواد مخدر و دزدی را رفتارهای قابل قبولی می‌دانند.

به‌نظر می‌رسد، رفتارهای مشکل‌آفرین با یکدیگر روابط متقابلی دارند. در واقع، بسیاری از رفتارهای خطرناک توسط افرادی رخ می‌دهند که در گذشته به رفتارهای خطرناک دیگری دست زده‌اند. برای مثال، الکلیسم در نوجوانان مرتبط با استفاده از داروهای دیگر است، استفاده از داروها نیز مرتبط با درگیر شدن در رفتارهای خطرناک دیگری نظیر برقراری روابط جنسی است. اگرچه برخی از این اعمال و فعالیت‌ها خطرهای کاملاً آشکاری برای سلامتی دارند، اما تأثیر برخی از اعمال دیگر نظیر خواب ناکافی، ورزش نکردن و رژیم غذایی نامناسب، زیاد آشکار نیست و به آنها کمتر اشاره شده است.

خطرهای سلامتی در دوره نوجوانی را می‌توان از دیدگاه‌های مختلفی مدنظر قرار داد و تعریف کرد. برای مثال ممکن است رفتارهایی را که تقریباً پیامدهای فوری و خطرناکی برای سلامتی دارند، مدنظر قرار داد (مانند رانندگی پس از خوردن مشروبات الکلی)، یا رفتارهایی را که آثار بلندمدت‌تری دارند، موردنظر قرار داد (رفتارهایی نظیر رژیم غذایی بسیار چاق‌کننده). از این‌رو می‌توان به بررسی رفتارهایی پرداخت که هم تأثیرات بلندمدت و هم کوتاه‌مدتی بر سلامتی دارند (رفتارهایی نظیر حاملگی). دیدگاه‌های مختلف درباره خطرهای سلامتی در جدول ۱-۵ خلاصه شده‌اند.

جدول ۱-۵. دیدگاه‌هایی در مورد خطرهای سلامتی در نوجوانان

نوع خطر	مثال
فوری و کنونی - در نوجوانی	نوشیدن مشروب - رانندگی کردن
دوره بعد از نوجوانی	رژیم‌های غذایی بسیار چاق‌کننده
فوری و کنونی و بعد از نوجوانی	حامله شدن
خطرهای ناشی از رفتار	سیگار کشیدن
خطرهای ناشی از شخصیت	مکان کنترل
خطرهای ناشی از محیط	فشار همسالان و رسانه‌ها
خطرهای مرتبط با جنسیت	مصرف الکل در دوران حاملگی

منبع: برگرفته از جسور، ۱۹۸۴

ادراک خطر در نوجوانان

توانایی نوجوانان برای ادراک خطر، حوزه بسیار مهمی برای مطالعه است. این حوزه به بررسی این موضوع می‌پردازد که نوجوانان تا چه حد خطرهایی را که سلامتی‌شان را تهدید می‌کنند، ادراک می‌کنند و اینکه آیا ادراک نوجوانان در این زمینه با بزرگسالان تفاوتی دارد؟

به نظر می‌رسد نوعی تفکر قالبی عمومی مبنی بر اینکه نوجوانان نسبت به بزرگسالان کمتر احساس خطر می‌کنند، وجود داشته باشد. برای تبیین این نگرش نیاز به تعیین تعداد نوجوانانی داریم که به جای توجه به خطرهای بعضی از رفتارها، بر فواید آنها متمرکزند.

همچنین باید به خودمیان‌بینی‌های^۱ نوجوانان که از طریق تصورات و خیالبافی‌های شخصی آنها آشکار می‌شود، توجه کرد (الکایند^۲، ۱۹۶۷). به نظر می‌رسد نوجوانان خود را مرکز و محور توجه می‌دانند، از این رو ممکن است ساعت‌های طولانی را صرف این موضوع کنند. نوجوانان همچنین دارای خیالبافی‌های شخصی‌اند. آنها در مورد خودشان به عنوان افراد کاملاً خاصی که وقایع را به روشی جدید و خاص تجربه می‌کنند، فکر می‌کنند. آنها اعتقاد دارند که فرد دیگری نمی‌تواند آن‌طور که آنها برخی از مسائل را احساس می‌کنند، احساس کنند.

پیامد این باورها، این است که نوجوانان خودشان را افراد منحصربه‌فردی می‌دانند که در مقابل خطرهای آسیب‌ناپذیرند. البته نتایج پژوهش‌ها (بیت - ماروم^۳ و همکاران، ۱۹۹۳)، از این اعتقاد که نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان، خودشان را افرادی کمتر آسیب‌پذیر می‌دانند، حمایت می‌کند.

^۱ . egocentrism

^۲ . Elkind

^۳ . Beyth - Marom

کوادرل^۱ و همکاران (۱۹۹۳) در مطالعه‌ای برای آزمایش فرضیه عدم آسیب‌پذیری نوجوانان گروه نمونه، از میان نوجوانانی که در معرض خطر کمتری^۲ قرار داشتند، والدین آنها و نوجوانانی که در معرض خطر زیادی^۳ قرار داشتند (نوجوانان متعلق به مراکز اصلاح نوجوانان) انتخاب کردند. در این تحقیق از هر آزمودنی خواسته شد تا میزان خطرناک بودن ۸ واقعه فرضی مختلف را ارزیابی کند. ۴ واقعه در سطح بالایی به صورت قابل کنترل (مانند حاملگی ناخواسته) و ۴ واقعه به عنوان کمتر قابل کنترل ادراک شده بود (برای مثال در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفتن).

هر واقعه توسط گروه‌های هدف نظیر دوست و آشنا نیز ارزیابی شد. به علاوه، والدین فرزندان نوجوان خود را ارزیابی و به طور متقابل نوجوانان نیز والدین خود را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که گروه بزرگسالان بیشتر از گروه نوجوانان، خود را به عنوان افرادی کاملاً برابر از نظر آسیب‌پذیری با گروه هدف مقایسه کرده بودند. به نظر می‌رسد این موضوع از مفهوم آسیب‌ناپذیری نوجوانان حمایت می‌کند. در هر حال، وقتی از آزمودنی‌ها خواسته شد تا بین آسیب‌پذیری زیاد و آسیب‌پذیری کم تمایز قائل شوند، به طور متوسط بزرگسالان در مقایسه با نوجوانان در معرض خطر زیاد و نوجوانان در معرض خطر کم خود را کمتر آسیب‌پذیر ادراک کردند (۳۴/۵ درصد، ۴۱/۵ درصد و ۳۵/۹ درصد). همچنین مقایسه ادراک‌های والدین و نوجوانان نشان داد، والدین روند بالاتری را نسبت به ادراک آسیب‌ناپذیری نشان دادند.

با بررسی ۸ واقعه مذکور مشخص شد، نوجوانان در معرض خطر کم با احتمال بیشتری یک آشنا را کمتر در معرض خطر ابتلا به الکلیسم می‌بینند، در حالی که نوجوانان در معرض خطر زیاد آشنایان را افرادی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به الکلیسم و حاملگی ناخواسته قرار دارند، ادراک کردند. بزرگسالان تمایل داشتند به آشنایان خود به عنوان افرادی که در معرض خطر ابتلا به الکلیسم قرار دارند، بنگرند. تمام مقایسه‌های دیگر نشان‌دهنده آسیب‌ناپذیری به نسبت ضعیف بود، در نتیجه، کوادرل و همکاران (۱۹۹۳) حمایت محدودی را برای فرضیه آسیب‌ناپذیری نوجوانان پیدا کردند.

در مطالعه دیگری (بنتین، اسلوویک و سورسون^۴، ۱۹۹۳)، از نمونه‌ای از نوجوانان ۱۵ ساله که در ایالت متحده آمریکا زندگی می‌کردند، خواسته شد تا به نمره‌گذاری و درجه‌بندی میزان خطر ۱۳ رفتار مختلف پردازند که برخی از آنها می‌توانستند به صورت رفتارهای مشکل‌آفرین (نظیر داشتن روابط جنسی یا مصرف کوکائین)، بعضی دیگر نیز به عنوان رفتارهایی که از نظر اجتماعی خطرناک ارزیابی می‌شوند، بررسی شوند (نظیر پریدن از بالای تپه).

^۱ . Quadrel

^۲ . Low – risk

^۳ . high - risk

^۴ . Benthin, Slovic & Severson

نتایج نشان داد برخی رفتارها (نظیر مصرف کوکائین) به عنوان کاملاً خطرناک مدنظر قرار گرفتند، درحالی که برخی دیگر خیلی مفید و کم خطر ارزیابی شدند (نظیر دوچرخه سواری). نوجوانان داشتن روابط جنسی را رفتاری خطرناک، ولی خطر آن را قابل کنترل و همانند خطر مرتبط با انجام بازی های ورزشی می دانستند. آزمودنی ها همچنین از خطرهای ارتباطات جنسی آگاه تر از خطرهای بیماری ها بودند، اما از خطرهای بیماری ها بیشتر از خطرهای جنسی نظیر حاملگی می ترسیدند. جالب اینکه، آزمودنی ها فکر می کردند دوستان آنان بیشتر از خود آنان در معرض خطر رفتارهای جنسی قرار دارند.

یک روش مناسب برای درک این موضوع که چرا نوجوانان به رفتارهای ناسازگار با سلامتی روی می آورند، ارزیابی و امتحان چگونگی ادراک مضرات و فواید آن رفتارهاست. در مطالعه ای مضرات و فوایدی که نوجوانان برای استفاده از الکل و رفتار جنسی قائل بودند، بررسی شد (اسمال، سیلوربرگ و کرنز^۱، ۱۹۹۳). محققان دریافتند مضرات ادراک شده از انجام یک رفتار است که احتمالاً نوجوان غیرفعال از لحاظ جنسی را از نوجوانان فعال از نظر جنسی و نوجوانانی را که مشروب می خورند از افرادی که مشروب نمی خورند، جدا می کند. به احتمال زیاد زنان نسبت به مردان برقراری روابط جنسی و نوشیدن مشروب را زیان آورتر می دانند. مضرات ادراک شده برای گروه غیرفعال از نظر جنسی با افزایش سن کاهش می یابد. نوجوانان بزرگ تر در مدرسه مضرات کمتری را برای وابستگی به الکل ادراک می کردند تا نوجوانان کوچک تر.

به طور متوسط، نوجوانانی که از مشروبات الکلی استفاده نمی کنند، به احتمال زیاد مضرات مشروب خوردن را بیشتر ادراک می کنند تا آنهایی که از الکل استفاده می کنند. این یافته ها کاربردهای مهمی برای تغییر رفتارهای ناسازگار با سلامت نوجوانان دارد. نتیجه اصلی و مهمی که می توان گرفت این است که مراکز آموزش سلامت باید تمرکز و تأکید بیشتری بر مضرات این رفتارها داشته باشند.

شیوه های حل مسئله و سلامت روان شناختی

سلامتی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی^۲ عبارت است از: حالت بهزیستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی. در تعریف دیگری دان^۳ (۱۹۷۶)؛ به نقل از ادلین، گولانتی و براون، (۱۹۹۹) سلامتی را یک روش کنش وری وحدت یافته ای می داند که هدفش به حداکثر

^۱ . Small, Silverberg & Kerns

^۲ . world Health Organization(WHO)

^۳ . Dunn

رساندن توان فرد است. به نظر وی سلامتی مستلزم این است که فرد طیف تعادل و مسیر هدفمند را با محیط، یعنی جایی که کنش‌وری خود را در آن آشکار می‌سازد، نگه دارد.

برخی مؤلفان مفهوم سلامتی را مترادف با کیفیت زندگی^۱ آورده‌اند. به نظر این مؤلفان کیفیت زندگی دربر گیرنده‌ی مجموعه شرایطی است که افراد در زندگی خود دارند. برای مفهوم کیفیت زندگی دو معنی در نظر گرفته شده است: الف) وجود شرایط لازم برای یک زندگی خوب، ب) تمرین برای خوب زندگی کردن. این دو معنی ممکن است در یک راستا نباشند و حتی با هم تلاقی^۲ داشته باشند، از این رو فرد می‌تواند غنی، نیرومند و مشهور باشد، اما پریشان، آزرده خاطر و مأیوس باشد یا برعکس فردی که فقیر، ضعیف و منزوی است ممکن است از نظر روانی و جسمانی شاداب و کامیاب باشد. در این دیدگاه نقش ادراک فرد از موقعیت‌ها و تفسیرهای ذهنی وی کاملاً نمایان است (اراسموس^۳، ۱۹۷۷).

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، الگوی کلی‌نگر^۴ سلامتی را بر حسب کلیت شخصیت و نه براساس بخش بیماری از بدن، تعریف می‌کند. الگوی کلی‌نگر جنبه‌های فیزیولوژیکی، روانی، هیجانی، اجتماعی، معنوی و محیطی افراد و جوامع را شامل می‌شود و بر سلامت بهینه، پیشگیری از بیماری و حالت‌های روانی و هیجانی مثبت متمرکز است (هرمن، هزلر^۵، ۱۹۹۹). استقرار این الگو نوید ظهور قلمرو بین‌رشته‌ای جدیدی را به میان می‌آورد که با پذیرش یک رویکرد کلی و به کار بستن این راهبرد در روش‌شناسی پژوهشی در پی پاسخگویی به معماهای حل‌نشده دیدگاه‌های تک‌بعدی درباره سلامت و بیماری است (آزاد فلاح و همکاران، ۱۳۷۸).

رواج الگوی کلی‌نگر و افزایش پیروان این دیدگاه موجب شده که به مفهوم سلامت از منظری متفاوت نگریسته شود و به همین منظور ابعاد مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. برشمردن ابعادی مانند جسمانی، اجتماعی، هیجانی، عقلانی، معنوی و روان‌شناختی از ره‌آوردهای این دیدگاه است. هر کدام از این ابعاد دارای معنا و مفهوم متناسب با سازه‌های نظری مربوط به خود می‌باشند؛ سازه‌هایی که دیدگاه کلی‌نگر آنها را معرفی کرده است. سلامت روان‌شناختی نیز همانند مفهوم کلی سلامت دارای تعاریف متعددی است که این تنوع در تعاریف ممکن است ناشی از تفاوت روی آوردهای مختلف در روان‌شناسی و اعتقاد متفاوت مؤلفان نسبت به مؤلفه‌های مختلفی که در ارتباط با

^۱ . quality of life

^۲ . coinside

^۳ . Erasmus

^۴ . holistic

^۵ . Hermon & Hazler

سلامت روان‌شناختی وجود دارد یا در برخی مواقع به واسطه نتایجی که از پاره‌ای بررسی‌ها به دست می‌آید، باشد.

برخی مؤلفان معتقدند که سلامت روان‌شناختی یعنی "ادراک مثبت فرد از رویدادها و شرایط زندگی". این تعریف به یک منبع روانی^۱ یا خوش‌بینی ارثی^۲ اشاره می‌کند، به طوری که فرد خوش‌بین عقیده دارد هر موقعیت و وضعیتی سرانجام نتیجه مثبتی خواهد داشت (سویتمن^۳ و همکاران، ۱۹۹۳؛ به نقل از بزکز، اشتین هارت^۴، ۱۹۹۷).

رایف^۵ و همکاران (۱۹۹۷؛ به نقل از ویسینگ و فوری، ۲۰۰۰) یک الگوی چندبعدی از سلامت روان‌شناختی را مفهوم‌سازی و عملیاتی کرده‌اند. در این الگو سلامت روان‌شناختی ماهیت مثبت عملکردی دارد و متشکل از عناصر مختلفی است از جمله:

- پذیرش خود^۶: نگرش مثبت به خود، شناخت جنبه‌های مختلف خود که می‌تواند مثبت یا منفی باشد، احساس مثبت درباره گذشته خود؛
- رابطه مثبت با دیگران^۷: داشتن رابطه گرم، رضایت‌بخش و توأم با اعتماد به دیگران، توجه به سلامتی و خشنودی دیگران، احساس همدردی قوی با سایر افراد؛
- خودپرویی^۸: مستقل^۹ و خودمختار بودن^{۱۰}، توانایی مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی، توانایی تنظیم رفتار از درون و ارزیابی خود به وسیله معیارهای شخصی؛
- غلبه بر محیط^{۱۱}: داشتن حس غلبه و برتری بر محیط، مهار کردن آرایه پیچیده‌ای^{۱۲} از فعالیت‌های بیرونی، استفاده مؤثر از فرصت‌های به‌عمل آمده، توانایی انتخاب یا ایجاد زمینه‌های مناسب برای نیازها و ارزش‌های شخصی؛
- هدفمندی در زندگی^{۱۳}: داشتن هدف و جهت در زندگی، معنا دادن به زندگی در حال و گذشته، داشتن عقیده و باوری که به زندگی هدف می‌دهد؛

^۱ . psychic resource

^۲ . dispositional optimism

^۳ . Sweetman

^۴ . Bezner & Steinhardt

^۵ . Ryff

^۶ . self- acceptance

^۷ . positive relations with others

^۸ . autonomy

^۹ . independent

^{۱۰} . self- determined

^{۱۱} . environmental mastery

^{۱۲} . complex array

^{۱۳} . purpose in life

- رشد شخصی^۱: احساس رشد ممتد داشتن، خود را در حال رشد و تحول دیدن، گشاده‌رو بودن برای تجارب جدید، داشتن حس تشخیص برای توان بالقوه خود.
- سرانجام اینکه برخی مؤلفان (برای مثال کوزما، استونز^۲ و استونز، ۲۰۰۰) سلامت روان‌شناختی را مترادف با شادی و خشنودی از زندگی در نظر گرفته‌اند. به نظر این افراد سلامت روان‌شناختی یعنی تعادل بین هیجان مثبت و منفی.

شادی

پاسخ‌های هیجانی بخش بسیار مهمی از تعاملات فیزیولوژیک انسان است که توانایی وی را برای بقا، حفظ و سلامت با بیماری‌های مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. شادی^۳، یکی از این هیجان‌هاست که دامنه وسیعی از واکنش‌های عاطفی از احساس آرامش گرفته تا احساس لذت و خلسه را شامل می‌شود. شاد بودن آرزوی قلبی بسیاری از افراد بشر است. ما انسان‌ها همواره از طریق گرایش به مذهب، فلسفه، روان‌شناسی، پزشکی و حتی سیاست، شادی و آرامش را جست‌وجو می‌کنیم. یکی از موضوعاتی که به تازگی مورد توجه روان‌شناسان قرار گرفته، "روان‌شناسی مثبت‌گراست". سال‌های طولانی روان‌شناسان بر موضوعاتی نظیر افسردگی و اضطراب متمرکز بوده‌اند، اما در حال حاضر "دانش شاد بودن" مورد توجه این متخصصان قرار گرفته است.

انسان‌ها به‌طور ذاتی برای شاد بودن برنامه‌ریزی شده‌اند. محققان معتقدند که حدود ۵۰ درصد شادی و خوشبختی ما توسط ژن‌ها تعیین می‌شود. ژن‌ها تعیین‌کننده شادی، محتوای شخصیت، آمادگی برای تجربه اضطراب و افسردگی و توانایی مقابله با استرس‌اند. با این حال، فقط ۵۰ درصد شادی را ژن‌ها تعیین می‌کنند و ۵۰ درصد بقیه ناشی از نگرش‌ها، رفتار و ارزش‌های فرد است. شیوه تفکر ما درباره رویدادها، امور و اشیا و افراد بر هیجانات ما مؤثر است. آیا نیمه خالی لیوان را می‌بینید یا نیمه پر آن را؟ آیا آفتاب زیبا و درخشنده است یا قادر به تحمل گرمای شدید آن نیستید؟ آیا پس از چند روز بارندگی از آن لذت می‌برید؟ چگونگی درک شما از محیط، کلید هیجاناتی است که تجربه می‌کنید. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شادی همواره در روح آدمی وجود دارد، اما افکار، خواسته‌ها و نگرانی‌ها آن را می‌پوشانند. فقط در صورتی که این افکار، تمایلات و اضطراب‌ها کنار بروند، احساس شادی که ویژگی ذاتی روح انسان است، ظاهر خواهد شد.

^۱ . personal growth

^۲ . Kozma, Stones

^۳ . happiness

پیامدهای شادی

نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که:

- افرادی که در مقیاس‌های روان‌شناختی ارزیابی میزان شادی، نمره‌های بهتری کسب می‌کنند، در مقابل واکسن آنفولانزا ۵۰ درصد بیشتر از دیگران پادتن ترشح می‌کنند؛
- افرادی که در فعالیت‌های شادی‌بخش شرکت می‌کنند، پرنرژی و سالم‌اند و درد و خستگی کمتری را تجربه می‌کنند؛
- در افراد خوش‌بین، در مدت ۹ سال پیگیری، ۵۰ درصد مرگ و میر کمتر از افراد دیگر دیده شده است.

خنده و شوخی موجب سلامت و تندرستی فرد می‌شود، زیرا:

- استرس را کاهش می‌دهد؛
- سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند؛
- فشار خون را کاهش می‌دهد؛
- عملکرد فرد را بهبود می‌بخشد (پیام مشاور، ۱۳۸۵).

راهنمایی برای زندگی شادتر

توصیه‌های زیر به داشتن زندگی شادتر کمک می‌کنند:

۱. همواره به آنچه انجام داده‌اید، بیندیشید. گاهی برخی از امور مربوط به برنامه روزانه خود را ناتمام و ناقص رها می‌کنیم. تفکر درباره این امور به ناامیدی و دلسردی فرد می‌انجامد. درباره خود منصف باشید و هرگز بر کارهایی که انجام نداده‌اید، بیش از حد متمرکز نشوید.
۲. نوع نگرش خود را تغییر دهید. همواره به جنبه مثبت امور نگاه کنید. ممکن است ذهنتان شما را به توجه به نکات منفی و مشکلات ترغیب کند. در هر شرایطی به دنبال نکات مثبت بگردید.
۳. همواره به راه‌حل‌ها بیندیشید نه به مشکلات. فقط علت‌شناسی مشکل کافی نیست، بنابراین راه‌حل مشکل را جست‌وجو کنید.
۴. زمانی که اوضاع بر وفق مراد و در کنترل شما نیست، به خود فرصت دهید و با کمال خونسردی و با کنترل احساسات رفتار کنید. کناره‌گیری به معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکه موجب آرامش درونی و در نتیجه احساس شادی می‌شود.

۵. هر روز برای شاد کردن خود کاری انجام دهید. این کار می‌تواند شامل موارد کوچکی مثل خرید کتاب مورد علاقه، خوردن غذای مورد علاقه، تماشای برنامه تلویزیونی مورد علاقه، رفتن به سینما یا قدم زدن در فضایی مطبوع باشد.
۶. هر روز حداقل یک نفر را خوشحال کنید. کلمه‌ای محبت‌آمیز بگویید، اتومبیل خود را برای عابران پیاده متوقف کنید، جای خود را در اتوبوس به فرد دیگری بدهید، هدیه کوچکی برای فرد مورد علاقه خود بخرید و از این قبیل. شاد کردن دیگران موجب شادی شما خواهد شد.
۷. همیشه به دنبال پیدا کردن شادی باشید. از شادی دیگران شاد شوید. شادی، مسری است. با مردم شاد همنشین شوید تا شادی کردن را از آنان بیاموزید.
۸. افکار خود را ارزیابی کنید. اگر افکار منفی ذهن شما را اشغال کرده‌اند، آنها را متوقف کرده و به مسائل خوشایند فکر کنید.
۹. بسیاری از مردم شاد، تمرین‌های معنوی انجام می‌دهند تا قلب و روح خود را سیراب کنند. چه مواردی موجب آرامش روح شما می‌شوند؟ چه کارهایی قلب شما را سرشار از عشق و رضایتمندی می‌کنند؟ معنویت پایه و اساس زندگی ماست.
۱۰. نوع دوستی هیجانات منفی را خنثی می‌کند و مانع تاثیر آنها بر عملکرد سیستم ایمنی، غدد دور ریز و قلب می‌شود. نوع دوستی حالت فیزیولوژیکی ویژه‌ای در بدن ایجاد می‌کند که به احساس نیرومندی و مقاومت در برابر اثر زیان‌بخش اضطراب منجر می‌شود.
۱۱. افراد شاد می‌دانند که گذشت و عفو موجب آزادی روح می‌شود. با رها کردن پیشداوری، خشم و رنجش، قلب خود را سرشار از شادی کنید.
۱۲. لبخند بزنید. زمانی که لبخند می‌زنید، ترشح سروتونین و اندروفین‌ها افزایش می‌یابد. ترشح این هورمون‌ها به احساس شادی می‌انجامد.
۱۳. تا حد امکان بخندید. خنده موجب افزایش ترشح اندروفین‌ها و هورمون‌های ضد درد بدن می‌شود. خنده فشار خود را پایین می‌آورد و موجب کاهش هورمون استرس و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن می‌شود.
۱۴. هر روز زمانی را به خواندن کتاب و مطالب شاد و مهیج اختصاص دهید.
۱۵. خاطرات خوب و احساسات و هیجان‌های مربوط به آنها را در دفترچه خاطرات خود یادداشت کنید.
۱۶. بدن خود را سالم و تندرست نگه‌دارید. با مراقبت از بدن خود احتمال شادی و خشنودی را افزایش می‌دهید.

مشخص شده است که عوامل متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به طور مثبت یا منفی بر سلامت روان شناختی اثر می گذارند. از بین این عوامل تأثیرگذار می توان به شیوه های حل مسئله^۱ اشاره کرد که تأثیر مهمی بر فعالیت های مختلف و در نهایت سلامت افراد می گذارد.

حل مسئله یک مهارت حیاتی برای زندگی در عصر حاضر است. امروزه در تمامی فعالیت ها، صاحبان امر به سوی مهارت های تفکر سطح بالا و حل مسئله، چه در حیطه عمومی و چه در حیطه های فناوری، خواه در فعالیت های طبیعی و خواه در فعالیت های مسئله دار فراخوانده می شوند و در بیشتر جوامع هم بر این عقیده اند که باید بر افزایش مهارت های حل مسئله تأکید کرد (وو^۲ و همکاران، ۱۹۹۶).

به طور کلی حل مسئله به فرایند شناختی - رفتاری ابتکاری فرد اطلاق می شود که به کمک آن فرد می خواهد راهبردهای مؤثر و سازش یافته مقابله ای برای مشکلات روزمره را تعیین، کشف یا ابداع کند. به عبارت دیگر، حل مسئله راهبرد مقابله ای مهمی است که توانایی و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزایش و تنیدگی و نشانه شناسی روانی را کاهش می دهد (دزوریلا و شیدی^۳، ۱۹۹۲).

حل مسئله مستلزم راهبردهای ویژه و هدفمندی است که فرد به وسیله آن مشکلات را تعریف می کند، تصمیم به اتخاذ راه حل می گیرد، راهبردهای حل مسئله را انجام می دهد و بر آن نظارت می کند (الیوت^۴ و همکاران، ۱۹۹۹).

دزوریلا و نزو^۵ (۱۹۹۰، به نقل از دزوریلا و شیدی، ۱۹۹۲) الگوی تبدیلی از حل مسئله ارائه داده اند که نظریه های مربوط به تنیدگی، شیوه های مقابله ای و حل مسئله را یکپارچه می سازد. فرض عمده این الگو این است که حل مسئله راهبرد مقابله ای مهمی است که فرد را قادر می سازد موقعیت های مشکل آفرین زندگی روزمره و تأثیر هیجانی آنها را به خوبی مهار کند و از این راه تنیدگی روان شناختی را کاهش دهد، به حداقل برساند یا از بروز آن پیشگیری نماید. اگر این الگو صحیح باشد، پس توانایی حل مسئله و استفاده از شیوه های حل مسئله کارآمد و سازنده به طور معنی داری با میزان تنیدگی روان شناختی ارتباط دارد. بدین صورت که میزان توانایی حل مسئله بالا، پیش بینی کننده سطح تنیدگی پایین یا مقابله مؤثر با آن و در نتیجه میزان سلامتی بالاست.

در پژوهشی باباپور خیرالدین و همکاران (۱۳۸۲) رابطه بین شیوه های حل مسئله و سلامت روان شناختی را در بین ۴۲۰ دختر و پسر بررسی کردند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل

^۱ . problem solving styles

^۲ . Wu

^۳ . D'zurilla & Sheedy

^۴ . Elliot

^۵ . Nezu

مقیاس شیوه‌های حل مسئله و مقیاس رضایت خاطر بود. مقیاس شیوه‌های حل مسئله متشکل از ۲۴ سوال بود که شش عامل درماندگی، مهارگری حل مسئله، سبک خلاقیت، اعتماد در حل مسئله، سبک اجتنابی و سبک روی‌آوردی را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که دختران هنگام مواجهه با مشکلات بیشتر از پسران از شیوه حل مسئله اجتنابی استفاده می‌کنند. همچنین مشاهده شد که تمام خرده‌مقیاس‌های حل مسئله به غیر از شیوه اجتنابی با سلامت روان‌شناختی رابطه‌ای معنادار داشتند، به‌طوری‌که رابطه خرده‌مقیاس‌های درماندگی و مهارگری حل مسئله با سلامت روان‌شناختی منفی و رابطه خرده‌مقیاس‌های خلاقیت، اعتماد در حل مسئله و سبک روی‌آوردی مثبت بود. از میان این خرده‌مقیاس‌ها، اعتماد در حل مسئله بیشترین و قدرتمندترین ارتباط را با سلامت روان‌شناختی داشت.

خطرهایی که سلامت نوجوانان بی‌خانمان را تهدید می‌کنند

نوجوانان بی‌سرپناه، در مقابل دامنه‌ای از رفتارهای مشکل‌آفرین بسیار آسیب‌پذیرند و کاملاً مستعد ابتلا به بیماری‌ها و عفونت‌ها می‌باشند، زیرا بسیاری از آنان مجبورند با فروش مواد مخدر یا تن دادن به فحشا امور خود را بگذرانند. به‌علاوه زنان نوجوان با خشونت‌های جنسی و جسمی در خیابان‌ها بیشتر مواجه می‌شوند. برآورد شده که در کل جهان ۱۰۰ میلیون جوان خیابانی وجود دارد (لونا^۱، ۱۹۹۱). به‌نظر می‌رسد خشونت‌های خانوادگی، افزایش سطح بیکاری، فقر و کاهش سطوح همکاری‌های نزدیک اجتماعی، برخی از عوامل علی باشند که به نوجوانان فشار می‌آورند تا در خیابان‌ها زندگی کنند. برای نوجوانانی که خانه‌های پر از درگیری و خشونت را ترک می‌کنند، زندگی در خیابان، فوایدی نظیر رهایی از درگیری، دوستی و دریافت حمایت از نوجوانان دیگر را دارد (نولر و کالان^۲، ۱۹۹۱).

بی‌خانمانی برای بسیاری از نوجوانان خطرهای جدی از نظر سلامتی در بردارد. مطالعه‌ای که در مورد جوانان و نوجوان بی‌پناه انجام گرفت، نشان‌دهنده وجود مشکلاتی نظیر آنفلوآنزا، برونشیت، افسردگی و اعتیاد به الکل در آنها بود (راپرس و بایر^۳، ۱۹۸۷). اینکه جوانان خیابانی در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف قرار دارند، در سایر مطالعات مورد حمایت قرار گرفته است. در کلینیکی در آمریکا که فقط مخصوص جوانان خیابانی بود، در حدود ۵۰۰ نوع علائم تشخیصی در طول یک دوره پنج ساله پیدا شد. در حدود نیمی از این جوانان دارای تمایلات همجنس‌خواهانه، حاملگی و

^۱ . Luna

^۲ . Noller & Callan

^۳ . Ropers & Boyer

اختلال تغییر جنسیت بودند. اختلالات و مشکلات پوستی نظیر جوش صورت، خال‌های پوستی و غیره در بین آنها شایع بود. بیشتر این نوجوانان افسرده یا مضطرب بودند، یا تمایل به خودکشی (حدود یک سوم از آنها) و مشکلات مرتبط با مشروب‌خواری و استفاده از موادمخدر داشتند (در حدود ۲۰ درصد) (دیشر و راجرز^۱، ۱۹۹۱).

نوجوانان و جوانان خیابانی، در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های جنسی نظیر روابط با همجنسان و HIV و غیره قرار دارند. پژوهشگران توجه خود را به افزایش روند عفونت ایدز در نوجوانان و جوانان معطوف کرده‌اند. برای مثال، در حدود ۱۱ درصد جوانان خیابانی که در یکی از کلینیک‌های شهر نیویورک آزمایش شدند، مبتلا به ایدز بودند، درحالی‌که مطالعه‌ای که در ریودوژانیرو انجام شد، نشان داد در حدود ۶۹ درصد پسران ۱۱ تا ۲۳ ساله‌ای که برای به‌دست آوردن پول به رابطه جنسی تن می‌دهند، دارای HIV هستند (لونا، ۱۹۹۱). احمد خانی‌ها، ترکمن‌نژاد و حسینی مقدم (۱۳۸۱) در مطالعه‌ای میزان همه‌گیرشناسی افسردگی و سوءاستفاده جنسی را در کودکان خیابانی بررسی کردند، گروه نمونه این مطالعه شامل ۷۸ کودک خیابانی در منطقه ۱۲ شهر تهران با میانگین سن ۱۱ سال و ۶ ماه بود و ۶۴ درصد آنان پسر بودند. ۸۶/۷ درصد دختران و ۴۸/۲ درصد پسران مورد مطالعه افسرده تشخیص داده شدند؛ همچنین ۲۱ درصد این کودکان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته بودند. فرد سوءاستفاده‌کننده در ۵۶ درصد موارد، غریبه بود. نتایج این پژوهش نشان داد که افسردگی در این کودکان با سابقه زندان رفتن پدر، بیکاری پدر و تأمین درآمد خانواده توسط فردی غیر از پدر ارتباط معناداری دارد. ابتلا به ایدز نیز یکی از عوامل تنش‌زای اضافی برای جوانانی است که از جامعه کناره گرفته و با آن بیگانه‌اند. برای آنها، ایدز، خطر ابتلا به افسردگی، خودکشی، افزایش در معرض خطر قرار گرفتن یا خطر کردن را بیشتر می‌کند. در فصل‌های بعد به‌طور مفصل به این مسئله پرداخته می‌شود.

خطرهایی که سلامت نوجوانان محلات فقیرنشین را تهدید می‌کند

خطرهایی زیادی سلامت نوجوانانی را که در نواحی فقیرنشین و بسیار قدیمی زندگی می‌کنند، تهدید می‌کند. براساس برخی گزارش‌ها در ایالت متحده آمریکا، قتل و آدم‌کشی، علت مرگ و میر مردان ۱۴ تا ۴۴ ساله ساکن این محلات بوده است (شابینر، اسکات و تزلیس^۲، ۲۰۰۴).

^۱. Deisher & Rogers

^۲. Schubiner, Scott & Tzelepis

شابینر و همکاران (۲۰۰۴)، این موضوع را به طور مفصل در میان ۲۴۶ نفر از نوجوانان محلات فقیرنشین که بیشتر آنان سیاه‌پوست بودند، بررسی کردند. پژوهشگران، به مشاهده اعمال خشونت‌آمیز توسط نوجوانان علاقه‌مند بودند. ۵۷ درصد آزمودنی‌ها زن، ۱۲۸ نفر آنان ۱۴ تا ۱۸ ساله و ۱۱۸ نفر این افراد ۱۹ تا ۲۳ ساله بودند. بیشتر نوجوانان از خانواده‌های فقیر بودند. ۴۲ درصد آزمودنی‌ها در طول زندگی خود یک بار چاقو خورده بودند. ۲۲ درصد آنها شاهد قتل یک فرد و ۹ درصد شاهد قتل بیش از یک نفر بودند. جدول ۶-۱، مواجهه آزمودنی‌ها با اشکال مختلف دیگر خشونت را در دوره سه‌ماهه نشان می‌دهد.

نواحی شهری قدیمی و فقیرنشین، از طریق فرهنگ بیگانه‌ساز^۱ و توأم با خشونت مشخص می‌شوند. به نظر می‌رسد بیشتر نوجوانان این نواحی از فقر، نابرابری، تمایز، بی‌عدالتی، تبعیض و دسترسی به مواد مخدر و اسلحه رنج می‌برند. جدول ۶-۱، نشان می‌دهد که به دست آوردن اسلحه در این محلات بسیار ساده است (بویژه در جوامعی نظیر آمریکا)، بنابراین به خطر انداختن زندگی دیگران هم بسیار آسان است.

جدول ۶-۱. درصد آزمودنی‌هایی که در مدت سه ماه با اشکال مختلف خشونت مواجه شده بودند

نوع خشونت	درصد
شاهد درگیری‌های شدید بودن	۸۱
شاهد درگیری فیزیکی بودن	۵۸
شاهد شلیک اسلحه توسط یک نفر بودن	۳۴
شاهد قتل حداقل یک نفر بودن	۱۹
درگیری در بحث‌های شدید لفظی	۷۳
درگیری در دعواها و درگیری‌های فیزیکی	۳۲
حمل چاقو	۳۰
حمل اسلحه	۸۰

منبع: شابینر و همکاران، ۲۰۰۴

^۱. alienation

خلاصه

پژوهشگران علاقه زیادی به آگاهی از اهمیت تحقیق در مورد سلامت نوجوانان دارند. بسیاری از رفتارهایی که سلامت افراد را تهدید می‌کنند، ریشه در دوران نوجوانی دارند. همان‌طور که مشاهده شد، تعریف سلامت را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف زیستی، روانی، اجتماعی و زیستی پزشکی مدنظر قرار داد. اگرچه طی سالیان درازی تفکر قالب در مورد سلامت و بیماری ناشی از الگوی زیستی پزشکی بوده است، اما بازشناسی فرایندهای روانی اجتماعی نقش مهمی در وضعیت سلامت افراد دارد. در این فصل به بررسی سؤالات تحولی در مورد باورهای بیماری و سلامت، نگرانی‌های سلامتی نوجوانان و جوانان در معرض خطر پرداخته شد. در انتهای فصل نیز خطرهایی که سلامت نوجوانان شهرهای بزرگ و بی‌خانمان را تهدید می‌کند، مطرح شد.

پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

- ۱) همسالان چگونه در دوره‌های آسیب‌پذیری، سلامت نوجوانان را به خطر می‌اندازند؟
- ۲) مذهب از چه راه‌هایی بر سلامت جسمانی و روانی و سازگاری نوجوانان تأثیر می‌گذارد؟

فصل دوم

تنیدگی و روش‌های مقابله با آن

تندگی های دوره نوجوانی

دوره نوجوانی، زمان تغییر و انتقال است. امروزه همگان قبول دارند که نوجوانان هنگام تجربه کردن تغییرات جسمانی، شناختی و اجتماعی، با چالش های تحولی چندگانه ای مواجه می شوند. رفتن به دبیرستان یکی از تغییرات اجتماعی است. برای برخی نوجوانان این دوره بسیار مهم است، زیرا محیط آشنا و امن دوران ابتدایی تغییر می یابد و به دوستی های جدید و محیط نامشخص در دبیرستان تبدیل می شود. تغییرات شناختی به این واقعیت اشاره دارد که نوجوانان به توانایی تفکر انتزاعی دست پیدا می کنند که یک تغییر تحولی مهم برای نوجوانی است که به ناشناخته ها می اندیشد و تأثیرات طولانی مدت وقایع را مدنظر قرار می دهد. تغییرات جسمانی شامل تغییرات هورمونی و زیست شناختی اند که در بدن رخ می دهند. نوجوان باید با این تغییرات بدنی سازگار شود و برای بعضی نوجوانان این تغییرات سریع تر (یا کندتر) از برخی دیگر رخ می دهد. بنابراین، موقع بلوغ وقتی که یک انتقال بهنجار با تندگی همراه شود، ابعاد نابهنجاری به خود می گیرد.

بعضی از تغییرات بیانگر ترکیبی از وقایع اند. شکی وجود ندارد که بیدار شدن علاقه و تمایل به جنس مخالف نشان دهنده تغییرات توأم اجتماعی و زیست شناختی است. بسیار مهم و قابل توجه است بدانیم وقایع تحولی منفردی نظیر علاقه به جنس مخالف به طور طبیعی و بهنجار، منجر به بروز تندگی در نوجوانان نمی شوند، بلکه ترکیبی از وقایع بهنجار و نابهنجار است که در برخی نوجوانان تندگی ایجاد می کنند.

در دیدگاه سنتی، به نوجوانی به عنوان دوره توفان و تندگی نگریسته می شود. در این باره، روان تحلیل گران به نوجوانی به عنوان دوره آشفتگی هیجانی و اغتشاش می نگرند. برای مثال، آنافروید بر اهمیت احساسات ادیپی در نوجوانی تأکید کرده است و آن را با اضطراب و رفتارهای معینی نظیر فرار از خانه یا گذراندن اوقات طولانی در تخت خواب مرتبط می داند. براساس نظریه روان تحلیل گری، ویژگی قابل توجه سال های نوجوانی، وجود کشاننده ها و غرایز و انگیزه هایی است که می توانند در طول سال های نوجوانی تنش را و مشکل ساز شوند، برای مثال نیازهای جنسی تحول و توسعه می یابند تا بخشی از ساختار کلی شخصیت و اهداف او در زندگی باشند (کلمن^۱، ۱۹۹۲).

^۱. Coleman

به تازگی برخی نظریه پردازان این اعتقاد را که نوجوانی دوره توفانی و تنش زایی است، مورد سؤال قرار داده اند. مشاهده شده که افراد در این مرحله از زندگی با تکالیف تحولی مهم و منحصر به فردی روبه رو می شوند. این تنیدگی ها در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله ممکن است شامل سازگاری با تغییر یافتن تصور بدنی، پذیرش هیجانات لطیف و ملایم و نوسانات موجود در خلق و خو، پیوستن به گروه های همسالان و غیره باشد. در نوجوانان بزرگ تر باید استقلال از والدین تحول و توسعه یابد، هویت یابی و نقش های جنسیتی و انتخاب های شغلی نیز صورت گیرد.

گاهی واکنش نوجوانان در مقابل استرس ها و فشارها از حد عکس العمل ها و واکنش های دفاعی تجاوز کرده و به صورت حالات هیجانی نظیر نگرانی و ترس بروز می کند. در تحقیقی که توسط انجمن اولیا و مربیان صورت گرفته، مشاهده شده است که نوجوانان بیشتر نگران زندگی آینده، تحصیل و شغل خود هستند. نتایج این پژوهش را در جدول ۱-۲ مشاهده می کنید.

جدول ۱-۲. درصد انواع نگرانی ها در دانش آموزان

درصد	نوع نگرانی
۲۴	ترس از عدم موفقیت در امتحان و ادامه تحصیل
۲۳	ناراحتی های مبهم
۱۶	ترس از بیکاری و سرنوشت نامعلوم
۶/۵	ناراحتی های مالی
۶	ناراحتی های خانوادگی

منبع: انجمن اولیا و مربیان، ۱۳۵۱

در هر حال، دیده شده که بیشتر نوجوانان این تغییرات را با موفقیت پشت سر می گذارند. این مسئله منجر به بروز این دیدگاه شده که نوجوانی، دوره توفانی نیست و فقط تعداد کمی از نوجوانان در معرض تنیدگی و ناسازگاری قرار دارند.

چالش بزرگی که تمام نوجوانان باید با آن روبه رو شوند، شکل گیری هویت شخصی و احساس بهزیستی روانی است. براساس نظریه اریکسون (۱۹۶۸)، نوجوانی بین کودکی و بزرگسالی قرار دارد. گاهی نوجوان با کشف هویت های جسمانی، عاطفی - اجتماعی و تظاهرات جنسی بیدار شده خود مواجه است. نوجوانان در این فرایند، با تقاضاهای متعارض همسالان و والدین سروکار دارند و هر کدام از این تقاضاها مستلزم گروه بندی های مختلفی از نظر رفتارهای قابل قبول هستند. تمام اینها در

شکل‌دهی هویت فردی نقشی حیاتی دارند. شکل‌گیری احساس ارزشمندی به عنوان فردی متمایز از دیگران نیز عامل تنیدگی در بین برخی از نوجوانان است.

انواع رویدادهای تنش‌زا

در مطالعه‌ای که نیوکامب^۱ و همکاران (۱۹۸۶) طی مطالعه‌ای روی ۱۰/۰۰۰ نوجوان، از آنها خواستند تا مطلوب‌ترین و بدترین رویدادهای زندگی خود را طبقه‌بندی کنند. مطلوب‌ترین وقایع برای این نوجوانان، شامل رانندگی با موتورسیکلت یا ماشین یا دارا بودن تلویزیون یا ضبط صوت شخصی بود. وقایع مطلوب اغلب با خودمختاری و استقلال نوجوانان مرتبط بودند. این یافته‌ها از این اعتقاد که بیشتر نوجوانان خواهان استقلال یافتن از والدینشان هستند، حمایت می‌کند. جدول ۲-۲ نشان می‌دهد که تجربه‌های بد و نامطلوب بیشتر مربوط به موضوعات جنسیتی و خانوادگی است. تفاوت‌های جنسی بسیار ضعیفی بین طبقه‌بندی دختران و پسران مشاهده شد.

جدول ۲-۲. مطلوب‌ترین و بدترین رویدادهای زندگی برای نوجوانان

مطلوب‌ترین (خواستنی‌ترین)	بدترین (کمتر خواستنی)
۱- شروع به رانندگی کردن	۱- ابتلا به عفونت HIV یا ایدز
۲- گرفتن تلویزیون یا ضبط صوت شخصی	۲- مرگ یکی از اعضای خانواده
۳- به دست آوردن پول توسط خود فرد	۳- بیماری یا تصادف شدید خود فرد
۴- عاشق شدن	۴- بیماری یا تصادف یکی از اعضای خانواده
۵- تنظیم وقت و زمان توسط خود فرد	۵- داشتن تجربه جنسی با همجنس
۶- دیدن معلمی که خیلی دوستش داشته‌اند	۶- درگیری با قانون
۷- تفریح و گذراندن تعطیلات بدون والدین	۷- ابتلای والدین به الکل
۸- پیوستن به یک گروه یا کلوپ	۸- بحث و درگیری شدید والدین
۹- تصمیم‌گیری برای ورود به دانشگاه	۹- داشتن افکار خودکشی
۱۰- مذهبی بودن	۱۰- مشکلات مالی و پولی خانواده

منبع: نیوکامب و همکاران، ۱۹۸۶

در صفحات قبل به این واقعیت اشاره شد که عوامل تنش‌زای مختلفی برای نوجوانان وجود دارد. صاحب‌نظران این حوزه بین عوامل تنش‌زای هنجاری، غیرهنجاری و مشاجره‌های روزانه تمایز قائل شده‌اند. تنش‌زاهای هنجار، وقایعی‌اند که تمام نوجوانان با آن مواجه می‌شوند. این عوامل تنش‌زا

^۱. Newcomb

به عنوان تنش‌زاهای نوعی نیز مطرح‌اند و شامل تغییرات جسمانی، رفتن به دبیرستان و بیدارشدن، علایق جنسی به جنس مخالف می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد، این تنیدگی‌ها همراه با وقایع دیگر، تقویت و تشدید می‌شوند. بنابراین، انتقال به مدرسه جدید وقتی با تغییرات بیولوژیکی و فیزیکی یا طلاق و جدایی والدین توأم می‌شود، شدت تنش افزایش می‌یابد.

تنش‌زاهای هنجاری دیگر، شامل تأثیرات مهم و متفاوت گروه همسالان است. همسالان، رفتارهایی از خود نشان می‌دهند تا مورد قبول یکدیگر قرار گیرند. این موضوع به شکل‌گیری هنجارهایی که رفتارها می‌توانند در قالب آن رخ دهند، کمک می‌کند. تنش‌زاهای غیرهنجاری به وقایعی اشاره دارد که می‌توانند در هر زمانی رخ دهند. از جمله این موارد، می‌توان به طلاق والدین، مرگ فرد دوست‌داشتنی، گرفتن نمره بد در مدرسه و غیره اشاره کرد. این تنیدگی‌ها اغلب تأثیر تجربه انتقال را تشدید و گسترده‌تر می‌کنند. البته این بدان معنا نیست تمام نوجوانانی که طلاق والدین را تجربه می‌کنند، حتماً از تنیدگی، کج‌سازگاری و ناسازگاری رنج می‌برند. در هر حال، شواهد پژوهشی نشان می‌دهند نوجوانانی که والدینشان با یکدیگر درگیرند، یا تنش‌های خانوادگی زیادی دارند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات و مشکلات رفتاری نظیر افسردگی، عصبانیت، پرخاشگری، برقراری رابطه جنسی نامتعارف و مشکلات ارتباطی قرار دارند (هاسر و بولدز^۱، ۱۹۹۰).

تنش‌زاهای غیرهنجاری دیگری وجود دارند که تلویحات مهمی برای آسیب‌شناسی روانی والدین، سبک‌های والدینی و سلامت روانی و رفتار نوجوانان دارند. برای مثال، مشاهده شده نوجوانانی که در خانواده‌های آزاداندیش بزرگ می‌شوند، مهارت و سازگاری بیشتر و مشکلات رفتاری کمتری دارند. در مقابل، نوجوانانی که در خانواده‌های مستبد، ستیزه‌جو و دارای بحث و درگیری بزرگ می‌شوند، در معرض خطر ابتلا به رفتارهای خطرآفرین و مشکل‌زا و اختلالات روانی قرار دارند.

یکی دیگر از رویدادهای تنش‌زا، مشاجره‌ها و درگیری‌ها روزانه است. این عوامل تنش‌زا وقایع روزمره‌ای هستند که تأثیرات انباشتی و تجمعی آنها منجر به تنیدگی افراد می‌شود. اعتقاد بر این است که تنش‌زاهای هنجاری و غیرهنجاری، میزان مشاجرات روزانه‌ای را که نوجوانان با آن مواجه می‌شوند، افزایش می‌دهند. به عبارت دیگر، یک عامل تنش‌زا (نظیر طلاق والدین)، پیامدهای زیادی دارد (نظیر احساس گناه در نوجوانان، سازگاری با شرایط جدید خانوادگی، فشارهای مالی و مسائل جانبی دیگر)، که زندگی نوجوانان را پیچیده می‌سازد و ممکن است رفتار و سلامت آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. برخی معتقدند بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های نشانگان روان‌شناختی در طول دوره

^۱ . Hauscr & Bowllds

نوجوانی، ترکیبی از مشاجرات روزانه و تنش‌زاهای شدید (که اغلب غیرهنجاری‌اند) می‌باشند. برخی از تنیدگی‌های حاد و شدید (ناگهانی و کوتاه‌مدت)، می‌توانند کاملاً آسیب‌رسان و صدمه‌زننده باشند و پیامدهای منفی داشته باشند. وقایع و حوادث غیرهنجاری می‌توانند مزمن باشند؛ وقایعی نظیر زندگی در خانواده‌ای فقیر و پر از درگیری. این وقایع تأثیرات جدی و شدیدی بر میزان تنیدگی افراد دارند. در بعضی موارد، وقایع و حوادث بزرگ، نمی‌توانند میزان تنیدگی را پیش‌بینی‌کنند، اما به کمک مشاجرات روزانه می‌توان میزان تنش را پیش‌بینی کرد. در واقع، این مشاجرات روزمره‌اند که پیش‌بینی‌کننده‌های دقیق‌تری از تنیدگی‌اند نه وقایع بزرگ.

علل و همبسته‌های تنیدگی در نوجوانان

در قسمت‌های قبل گفتیم که نوجوانان با تنیدگی‌های هنجاری، غیرهنجاری و مشاجرات روزانه مواجه می‌شوند. در این بخش، به بررسی علل و همبسته‌های تنیدگی نوجوانان پرداخته می‌شود.

تفاوت‌های سنی در هیجانات منفی

شواهد موجود نشان می‌دهند تفاوت‌های زیادی در تجربه هیجانات منفی توسط نوجوانان و افرادی که در دوره قبل از نوجوانی به سر می‌برند، وجود دارد. هیجانات منفی ناشی از تفاوتی است که بین آنچه نوجوانان انتظار دارند اتفاق بیفتد و آنچه در عمل رخ می‌دهد، وجود دارد. به‌طور معمول هیجان‌های منفی با تنیدگی مرتبط‌اند، اگرچه جهت‌گیری علی آن هنوز کاملاً واضح نیست. لارسن و آسموسن^۱ (۱۹۹۱) نشان دادند که حوزه‌های خاصی از زندگی، هیجانات منفی را در نوجوانان برمی‌انگیزند. این پژوهشگران در مطالعه خود از نوجوانان خواستند که حالات هیجانی خود را در مورد حوزه‌های مختلف زندگی توصیف کنند. این حوزه‌ها عبارت بودند از: خود، خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه‌ها. برای مثال، نوجوانان بزرگ‌تر هیجانات منفی کمتری را در حوزه‌هایی نظیر فعالیت‌های غیرتحصیلی تجربه کرده بودند، اگرچه هیجانات منفی در ارتباط با حوزه‌های «دیگران» و «فعالیت‌های غیرتحصیلی» برای کلیه پسران بیشتر بود (شامل شغل، زمان و موضوعات محیطی). هم دختران و هم پسران به هیجانات منفی در حوزه دوستان اشاره کردند. تحلیل بیشتر آشکار کرد که این هیجانات منفی در مورد دوستان جنس مخالف است. وقایع زندگی می‌توانند در حوزه‌های مختلفی

^۱ . Larson & Asmussen

طبقه‌بندی و مقوله‌بندی شوند که برخی از آنها شامل تنیدگی‌های هنجاری و بعضی دیگر شامل تنیدگی‌های غیرهنجاری می‌شوند.

تنش‌زاهای خانوادگی

اگرچه رابطه نوجوان - والدین تحت تأثیر "شکاف نسل‌ها" قرار می‌گیرد، اما بیشتر خانواده‌ها عدم توافق‌ها و مشاجرات روزانه‌ای را تجربه می‌کنند که تأثیر تجمعی آنها می‌تواند هم نوجوانان و هم والدین را دچار تنیدگی کند.

به‌طور معمول والدین و فرزندان، نگرش‌ها، دیدگاه‌ها و انتظارات کاملاً متفاوتی درباره قواعد خانوادگی، قدرت و اقتدار و روابط بین‌فردی دارند. گاهی نگرش‌های والدین و کودکان غیرواقع‌گرایانه یا غیرمنطقی است و منجر به بروز تعارضات خانوادگی می‌شود. بعضی از افراد خانواده سخت به باورهایشان پایبندند و با هیجان زیادی از باورها و عقایدشان دفاع می‌کنند و این مسئله، هیجان خشم را در سایر اعضای خانواده برمی‌انگیزد.

اغلب نوجوانان و والدین در این مورد توافق دارند که ریشه درگیری‌های آنان در درون خانه است. بیشتر درگیری‌ها در مورد کارهای روزمره، روابط بین‌فردی، تنظیم فعالیت‌های نوجوانان، ویژگی‌های شخصیتی، کارهای منزل، زمان خواب و استراحت، تنظیم روابط اجتماعی و وضع ظاهری رخ می‌دهند.

نوجوانان دلایل زیر را منشأ تعارضات خود با والدین می‌دانند:

تباه کردن: نوجوانان اعتقاد دارند که نظم و مقررات والدین سال‌های نوجوانی آنها را تباه می‌کند؛

بی‌انصافی: به نظر نوجوانان والدینشان با آنها با بی‌انصافی رفتار می‌کنند؛

خودمختاری: نوجوانان معتقدند که آنها باید کاملاً آزاد باشند؛

تأیید: به نظر نوجوانان والدین باید آنها را تأیید کنند.

ماهیت تعارضات فرزند - والد بسته به سن کودک فرق می‌کند. اغلب تعارض والدین با کودکان قبل از نوجوانی حول مسائل و موضوعاتی نظیر حاکمیت مقرراتی نظیر خاموش کردن تلویزیون، دور می‌زند، درحالی‌که تعارض والدین با نوجوانان مربوط به تنظیم روابط بین‌فردی آنان است و منجر به بروز تنیدگی می‌شود. والدین و نوجوانان از نظر معنایی که به این موضوعات می‌دهند و از نظر روش‌هایی که درباره این موضوعات تعارض‌انگیز استدلال می‌کنند، تفاوت دارند. به‌طور دقیق روشن نیست که تا چه حد این تفاوت در ادراکات و تصورات با میزان تنیدگی رابطه دارد. والدین تمایل

دارند که به تعارضات خانوادگی از دیدگاه و نظر اخلاقی و عرفی نگاه کنند، اما نوجوانان به عدم توافق‌ها و تعارضات خانوادگی به صورت قدرت شخصی خودشان یا از حوزه قضایی و قانونی می‌نگرند. به بیان دیگر، آنها معتقدند که می‌توانند بدون دخالت والدینشان تصمیم‌گیری کنند.

برخی پژوهشگران چارچوب اجتماعی بوم‌شناختی را برای مطالعه تنیدگی در نوجوانان مطرح کرده‌اند. آنها معتقدند فرایندهای رفتاری، تحت تأثیر محیط کنونی و بدون فاصله فرد و از جمله اعضای خانواده قرار می‌گیرند. اعضای خانواده در تعیین سلامت روانی نوجوانان نقش مهم و حیاتی دارند. تحقیقات تجربی از این نظریه حمایت کرده‌اند، برای مثال مشاهده شده که افسردگی بالینی والدین با اختلالات اجتماعی در کودکان رابطه دارد و سبک‌های والدینی مرتبط با سازگاری نوجوانان و سبک‌های رفتاری آنهاست (کیتنر و میلر^۱، ۱۹۹۰).

تفاوت‌ها و تأثیرات جنسیتی

بعضی صاحب‌نظران اشاره کرده‌اند که پسران و دختران نوجوان در تجربه تنیدگی با یکدیگر متفاوت‌اند. یکی از علل این موضوع، مربوط به تفاوت‌های دختران و پسران از نظر زمان جهش‌های رشدی است. به طور متوسط دختران زودتر از پسران با جهش‌های رشدی مواجه می‌شوند و این موضوع احتمالاً منجر به سطوح بالاتر تنیدگی در دختران می‌شود. به علاوه، دخترانی که از لحاظ جسمانی زودتر بالغ می‌شوند، به احتمال بیشتری از تصویر بدنی منفی‌تر رنج می‌برند و بیشتر به مشکلات خوردن مبتلا می‌شوند تا دخترانی که به موقع یا دیرتر بالغ می‌شوند. برعکس، پسرانی که زودتر بالغ می‌شوند، از تصویر بدنی منفی کمتر رنج می‌برند تا پسرانی که دیرتر بالغ می‌شوند.

تجربه نخستین قاعدگی در تمام دختران بدون تنیدگی نیست. گزارش شده دخترانی که در حال بالغ شدن هستند، اما با مادران خود در مورد تغییرات بلوغ صحبت نمی‌کنند، به احتمال بیشتری به نخستین قاعدگی خود به طور منفی نگاه می‌کنند. احتمالاً این دختران، نخستین قاعدگی خود را نمی‌توانند با پدر خود در میان بگذارند.

پسران و دختران نوجوان از نظر تجربه تنیدگی‌های مرتبط با خانواده و تنیدگی‌های بین‌فردی، با یکدیگر متفاوت‌اند. مروری بر ادبیات پژوهش نشان داد که دختران برای گزارش وقایع منفی بزرگی که مرتبط با همسالان، خانواده و مسائل جنسی آنان است، مستعدترند. این موضوع شاهی برای صداقت بیشتر برخی از دختران است. در هر صورت، به نظر می‌رسد دختران نسبت به تنیدگی‌های مربوط به ایجاد تغییرات در دوستی‌ها و شبکه‌های بین‌فردی، حساس‌تر از پسران باشند. همچنین آنچه

^۱. Keitner & Miller

در دوستی‌ها و الگوهای دوستی پسران حاکم است، موضوعات خودمختاری و جدایی است، درحالی‌که الگوهای دوستی در دختران می‌تواند به صورت روابط بین فردی توصیف شود. برای مثال، به احتمال زیاد دختران نسبت به پسران از حمایت اجتماعی و حالات هیجانی‌تر بیشتر استفاده می‌کنند (فرایدنبرگ و لوئیس^۱، ۱۹۹۳). بنابراین، ابعادی از دوستی که در تنیدگی و راهبردهای مقابله‌ای نقش دارند، در دختران و پسران متفاوت است.

پاک‌نژاد (۱۳۷۳) با هدف هنجاریابی پرسشنامه سبک‌های مقابله با تنیدگی در نوجوانان و جوانان دریافت که سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری با یکدیگر دارد، به‌طوری‌که پسران بیشتر از مقابله‌های عقلانی و انفصالی و دختران بیشتر از مقابله‌های هیجانی و اجتنابی در مواجهه با موقعیت‌های تنش‌زا استفاده می‌کنند.

در پژوهشی خدایاری‌فرد، غباری بناب و شکوهی یکتا (۱۳۸۰) رابطه عوامل تنش‌زا، نشانگان تنیدگی و راه‌های مقابله با تنیدگی را در بین ۱۳۲۰ دانشجوی دختر و پسر (۵۵ درصد پسر و ۴۵ درصد دختر) مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های تهران با میانگین سن ۲۰ سال مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که دانشجویان دختر و پسر از نظر طبقه‌بندی عوامل تنش‌زا تفاوت معناداری با یکدیگر دارند، به‌طوری‌که دانشجویان دختر بیشتر درمورد مرگ والدین یا بیماری اعضای خانواده، نداشتن دوست صمیمی، ازدواج و اختلاف سلیقه با والدین نگران بودند، درحالی‌که دانشجویان پسر بیشتر نگران مسائل شغلی و پیدا کردن شغل در آینده و عدم موفقیت در ازدواج یا نامزدی بودند. همچنین مشاهده شد که میانگین نمره‌های دختران در نشانگان تنیدگی شناختی، عاطفی و جسمانی بالاتر از میانگین نمره‌های پسران در این شاخص‌ها بود، درحالی‌که در شاخص نشانگان تنیدگی رفتاری میانگین نمره‌های پسران از دختران بیشتر بود. درمورد راه‌های مقابله با تنیدگی یافته‌ها نشان داد که دختران بیشتر از پسران از مقابله‌های مسئله‌مدار و دریافت حمایت اجتماعی و پسران بیشتر از دختران از مهارت مقابله‌ای تفریح‌های جسمانی استفاده می‌کنند. هر دو جنس به یک میزان از مقابله‌های دریافت حمایت‌های معنوی و مثبت‌نگری استفاده می‌کنند.

ظهره‌وند (۱۳۷۵) رابطه ملاک‌ها و کیفیت دوستی با روش‌های مقابله با فشار روانی را در سه گروه از دانش‌آموزان دختر دبستانی، راهنمایی و دبیرستانی بررسی کرد و دریافت آزمودنی‌هایی که در اوایل نوجوانی دارای دوستی‌های تقابلی و دوطرفه بودند، در مواجهه با تنیدگی بیشتر از مقابله‌های مسئله‌مدار استفاده می‌کردند.

^۱ . Frydenberg & Lewis

توکلی خمینی (۱۳۷۶)، به نقل از خدایاری فرد، غباری بناب و شکوهی یکتا، (۱۳۸۰) در پژوهش بر روی ۱۲۱ نوجوان دبیرستانی، دریافت بین شیوه‌های شناختی مقابله با تنیدگی و نشانگان آسیب‌شناختی رابطه منفی و بین شیوه‌های مقابله‌ای هیجان‌مدار و نشانگان آسیب‌شناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

تفاوت جنسیتی دیگری که بین دختران و پسران از نظر تنیدگی وجود دارد، مربوط به شیوع بیشتر افسردگی در میان دختران است. دلیلی که برای این موضوع مطرح شده، مربوط به تفاوت‌هایی است که در تغییرات هورمونی در حین بلوغ وجود دارد. اعتقاد بر این است که این تغییرات هورمونی نقش پایدارتری را در حالات عاطفی دختران بازی می‌کنند تا در حالات عاطفی پسران. افزایش هورمون استروئید، نقش مهمی در تبیین میزان بیشتر نشانگان افسردگی در دختران دارد. در هر حال، باید توجه داشت اگرچه تحلیل‌های آماری نشان‌دهنده تأثیر زیاد هورمون‌هاست، اما اهمیت این هورمون‌ها به اندازه اهمیت تأثیر وقایع بزرگ و منفی زندگی نیست.

مقابله با تنیدگی

نوجوانان با تجارب چالش‌انگیز زیادی مواجه می‌شوند و نیاز دارند که سازوکارهای مقابله‌ای مؤثر را بیاموزند. اینکه نوجوانان و جوانان چگونه با وقایع بزرگ و انتقال‌های مهم زندگی خود مقابله کنند، نقش مهمی در تعیین سازگاری عاطفی آنان دارد.

مقابله را می‌توان به روش‌های مختلفی تعریف کرد. برای مثال، بعضی مقابله را، تمام پاسخ‌هایی که فرد در مواجهه با یک انتقال یا واقعه از خود بروز می‌دهد، تعریف می‌کنند. کمپاس^۱ (۱۹۸۷) معتقد است چنین نگرشی زیاد مفید نیست و باید مقابله را به شیوه‌ای که در زیر توضیح داده شده، تعریف کرد. پاسخ‌های توأم با تلاش در مقابل پاسخ‌های فاقد تلاش، که شامل تلاش‌هایی می‌شود که برای به حداقل رساندن اثر تنیدگی انجام می‌گیرد یا تلاش‌های دیگری که برای تسلط بر محیط صورت می‌گیرد. به گفته دیگر، افراد رفتار یا راهبردهای شناختی خودشان را در تلاش برای رویارویی با چالش‌های محیطی تنظیم می‌کنند و به کار می‌گیرند. به نظر می‌رسد که این بُعد از مقابله با موردی که باند و ویسز^۲ (۱۹۸۸) با عنوان مقابله اولیه - ثانویه مطرح کرده‌اند، مرتبط باشد. مقابله اولیه بیشتر با تلاش برای تأثیرگذاری بر شرایط یا واقعه تنش‌زا مربوط است، درحالی‌که مقابله ثانویه مربوط به راهبردهای انعطاف‌پذیری شناختی و شکل کامل‌تری از مقابله‌اند.

^۱ . Compas

^۲ . Band & Weisz

فرایندبرگ و لوئیس^۱ (۱۹۹۳) در مطالعه‌ای به بررسی توانایی نوجوانان برای استفاده از یکی از راهبردهای زیر پرداختند؛ حل مسئله، رجوع به دیگران و مقابله غیرکارآمد. اولین نوع به تلاش برای حل مشکل اشاره دارد، درحالی‌که دومین نوع به دنبال استفاده از منابع پیشنهادشده توسط افراد دیگر است؛ سومین راهبرد نیز ضرورتاً به حل مشکل نمی‌انجامد، اما به کاهش میزان تنیدگی کمک می‌کند.

عملکردهای مقابله: مقابله را می‌توان به مقابله هیجان‌مدار و مسئله‌مدار تقسیم کرد. عملکرد این دو روش می‌تواند از نظر رابطه بین عامل تنش‌زا و فرد متفاوت باشد. برای مثال، در مقابله مسئله‌مدار، فرد تلاش می‌کند تا منبع تنیدگی را تغییر دهد، درحالی‌که در مقابله هیجان‌مدار، فرد حالت هیجانی ایجادشده توسط عامل تنش‌زا را تغییر می‌دهد.

منابع، سبک‌ها و پاسخ‌های مقابله‌ای خاص: این موضوع به تفاوت‌های فردی و متغیرهای محیطی گسترده‌ای که به مقابله کمک می‌کنند، اشاره دارد و شامل عواملی نظیر سبک‌های حمایت اجتماعی، مهارت‌های حل مسئله، مهارت‌های بین فردی و عزت نفس می‌شود.

راث و کوهن^۲ (۱۹۸۶)، بین سبک‌های مقابله‌ای اجتنابی و رویکردی تمایز قائل شده‌اند. به نظر آنها، بعضی از سازوکارهای مقابله‌ای نسبت به عامل تنش‌زا جهت‌گیری می‌شوند، درحالی‌که برخی دیگر از عامل تنش‌زا روی برمی‌گردانند. فرد با روی‌گردانی کامل از عامل تنش‌زا می‌تواند تنیدگی را کاهش دهد. با این حال، ممکن است این روش مقابله‌ای منجر به بروز رفتارهای آسیب‌رسان و صدمه‌زننده شود (برای مثال به مدرسه نرفتن برای اجتناب از معلم). راهبرد مقابله‌ای رویکردی به فرد اجازه می‌دهد که با مسائل و مشکلات رویارو شود و با هیجانات مرتبط با واقعه کنار بیاید. بنابر نظر این محققان، این راهبرد شرایطی را ایجاد می‌کند که واقعه تنش‌زا در آن با خودآگاهی کامل‌تری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نوجوانانی که در برخی راهبردهای مقابله‌ای نقص و کمبود دارند، در معرض خطر روی آوردن به رفتارهای سازش‌نایافته‌ای چون مصرف مواد و الکل هستند. برای مثال، نوجوانانی که بیشتر از مقابله‌های هیجان‌مدار و مقابله‌های اجتنابی استفاده می‌کنند، بیشتر از نوجوانان دیگر به مصرف سیگار یا الکل روی می‌آورند (فرومه و رایوت^۳، ۱۹۹۴).

بین سبک‌های مقابله‌ای و پیشرفت تحصیلی نوجوانان نیز ارتباط وجود دارد. در پژوهشی عابدینی (۱۳۸۲) رابطه راه‌های مقابله با تنیدگی و پیشرفت تحصیلی را در نوجوانان دختر بررسی کرد. آزمودنی‌های این پژوهش را ۳۲۸ دانش‌آموز دختر پایه سوم راهنمایی تشکیل می‌دادند که به‌طور

^۱ . Frydenberg & Lewis

^۲ . Roth & Cohen

^۳ . Fromme & Rivet

تصادفی از جنوب، مرکز و شمال شهر تهران انتخاب شده بودند. نتایج این پژوهش تفاوت معناداری را بین شیوه‌های مقابله‌ای دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا نشان داد. به‌طوری‌که دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا نسبت به دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، بیشتر از مقابله‌های مسئله‌مدار استفاده می‌کردند. در ادامه بعضی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری و انتخاب راه‌های مقابله‌ای فردی بررسی می‌شود.

روندهای تحولی در مقابله با تنیدگی

کودکان سنین مختلف از نظر راهبردهای مقابله‌ای مورد استفاده با یکدیگر متفاوت‌اند. همان‌گونه‌که انتظار می‌رود، کودکان بزرگ‌تر بیشتر در سازوکارهای مقابله‌ای ثانوی درگیر می‌شوند و کودکان کوچک‌تر تمایل به استفاده از راهبردهای مقابله‌ای اولیه دارند. استفاده از این راهبردهای کلی تا حد زیادی به ماهیت موقعیت تنش‌زا وابسته است، با این حال عوامل مرتبط با مدرسه پاسخ‌های مقابله‌ای اولیه را در میان نوجوانان و کودکان بزرگ‌تر ایجاد می‌کند (داشتن رفتار بهتر با معلم). شرایط بیماری و دارویی نظیر تزریق آمپول، پاسخ‌های مقابله‌ای ثانویه را (فکر اینکه در روز تعطیل به شما آمپول تزریق کنند) در کودکان بزرگ‌تر و پاسخ‌های مقابله‌ای اولیه را در کودکان کوچک‌تر ایجاد می‌کنند.

آلتشولر و رابل^۱ (۱۹۸۹) دریافتند وقتی کودکان ۵ تا ۱۲ ساله با موقعیت‌های غیرقابل‌کنترلی مواجه می‌شوند، موقعیت‌هایی نظیر انتظار برای وقوع یک حادثه ناخوشایند و نامطلوب، تمایل دارند که از راهبردهای مقابله‌ای اجتنابی استفاده کنند. در واقع، این کودکان اغلب آشکالی از حواس‌پرتی‌های رفتاری را، نظیر شمارش اعداد یا استفاده از تصورات ذهنی هدایت‌شده، از خود بروز می‌دهند. همچنین دیده شده که کودکان بزرگ‌تر از حواس‌پرتی‌های شناختی نظیر سعی برای کنترل هیجانات خود، به دفعات بیشتری نسبت به کودکان کوچک‌تر استفاده می‌کنند.

تأثیر روابط نزدیک

دارا بودن شبکه حمایت اجتماعی برای کمک به افراد به‌منظور مقابله با تنیدگی، بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین، داشتن گروهی از دوستان نزدیک یا دارا بودن روابط گرم و صمیمانه، اضطراب را تعدیل می‌کند و نشانه‌های تنیدگی را کاهش می‌دهد و از بین می‌برد و به فرد کمک می‌کند تا با

^۱ . Altshuler & Ruble

موقعیت‌های تنش‌زا سازش پیدا کند. بحث در این مورد را نخست با بررسی نقش خانواده شروع می‌کنیم و پس از آن با طرح نقش دوستان و گروه همسالان ادامه می‌دهیم.

روابط خانوادگی

شبکه خانوادگی حمایت‌کننده، عامل مهمی در کاهش تأثیر تنیدگی‌هاست. همچنین سبک‌های والدینی با داشتن مهارت اجتماعی در میان نوجوانان همسن و سال رابطه دارد. شولمن^۱ (۱۹۹۳) با مطالعه نوجوانان و مادران استرالیایی، مشاهده کرد که نوجوانان به والدین حمایتگری اشاره کرده‌اند که نظرهای خود را هرگز تحمیل نمی‌کنند و با این کار مهارت‌های اجتماعی زیادی را در فرزندان خود پرورش می‌دهند. سبک‌های پرورش کودک با استفاده از تحمیل و اجبار که با فقدان حمایت همراه باشد، منجر به ایجاد مشکلات رفتاری در میان نوجوانان می‌شود.

سبک‌های والدینی سنتی، مستبدانه و تحمیل‌کننده، نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارها و سازگاری نوجوانان دارد. در واقع، پویایی‌های خانوادگی با مقابله نوجوانان در ارتباط است. روابط خانوادگی، نقش حیاتی و مهمی در هدایت مسیرهای تحولی نوجوانان دارد. مسیرهای تحولی متفاوت با سبک‌های مقابله‌ای متفاوتی مرتبط‌اند که در نهایت منجر به بروز پیامدهای رفتاری متفاوتی در نوجوانان می‌شوند.

انواع مختلف روابط خانوادگی به‌طور مستقیم با راهبردهای مقابله‌ای مورد استفاده نوجوانان رابطه دارد. پژوهش شولمن نشان‌دهنده چهار نوع مختلف از جو خانوادگی است (جدول ۲-۳). نویسنده اشاره می‌کند که هر نوع جو خانوادگی دربردارنده رفتارهای مقابله‌ای منحصر به فرد و خاص خودش است. نوع جو خانوادگی تعارض‌مدار فاقد ساختار اغلب منجر به پرورش نوجوانانی می‌شود که فاقد الگوهای کارآمد و رضایت‌بخش مقابله‌ای هستند. درحالی‌که خانواده‌هایی که روابط گرم، صمیمانه و عاطفی با فرزندان خود دارند و حمایت‌کننده‌اند (جهت‌گیری مستقل و فاقد ساختار)، عزت نفس نوجوانان را افزایش می‌دهند و منجر به پرورش نوجوانانی می‌شوند که هنگام رویارویی با تنیدگی، دچار سردرگمی و ندانم‌کاری نمی‌شوند. خانواده‌های قدرت‌طلب و مستبد^۲ (کنترل‌مدار) که در آنها قواعد و مقررات واضح‌اند، اما جو عاطفی گرمی وجود ندارد، منجر به پرورش نوجوانانی منفعل می‌شوند که هنگام تصمیم‌گیری بیشتر به خانواده خود متکی‌اند. تعداد زیادی از نوجوانان در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که والدین از یکدیگر جدا شده یا طلاق گرفته‌اند؛ این مسئله برای

^۱ . Shulman

^۲ . authoritarian

بسیاری از نوجوانان اضطراب‌آور و تنش‌زاست و ممکن است آنها با خشم، پرخاشگری یا افسردگی به آن واکنش نشان دهند. هم والدین و هم متخصصان برنامه‌هایی دارند که به نوجوانان کمک می‌کند تا با این شرایط کنار آیند و مقابله کنند. در این مورد ممکن است در این دوره سخت گروه‌های حمایت‌کننده (نظیر دوستان یا اعضای جامعه) به کمک نوجوان بشتابند. برای بعضی نوجوانان، جدایی والدین از یکدیگر برابر با پایان و خاتمه‌یافتن دوره‌ای طولانی از بحث و درگیری‌های بین والدین و تعارضات آنها با یکدیگر است و فرصت جدیدی است تا بتوانند زندگی بدون بحث و درگیری را تجربه کنند. این شرایط برای این نوجوانان احتمال رشد و تحول شخصی را افزایش می‌دهد.

جدول ۲-۳. رابطه بین جو خانوادگی و رفتارهای مقابله‌ای

جو خانوادگی	رفتارهای مقابله‌ای
۱- تعارض‌مدار فاقد ساختار ویژگی این جو خانوادگی وجود تعاملات زیاد تعارض‌انگیز، فقدان حمایت درون خانواده و عدم حمایت از رشد شخصی است ۲- کنترل‌مدار ویژگی این جو خانوادگی، وجود فعالیت‌های خانوادگی سازمان‌یافته، قواعد خانوادگی صریح و آشکار، تأکید بر پیشرفت، خانواده حمایت‌کننده، اما بدون بیانات و کلمات عاطفی ۳- جهت‌گیری بیانگر، مستقل^۱ و فاقد ساختار برای مثال به هم‌پیوستگی و اتحاد، احساسات زبانی و بیانی، حمایت از استقلال فردی، عدم فشار برای پیشرفت ۴- جهت‌گیری بیانگر و منطقی دارای ساختار برای مثال تأکید بر روابط خانوادگی، تقویت استقلال، قواعد صریح و روشن	میزان بالایی از مقابله غیرکارآمد که با انزوای طلبی و منفعل بودن مشخص می‌شود متکی به تصمیم‌های خانواده، تمایل به منفعل بودن روی آوردن به دیگران برای دریافت راهنمایی و مشورت و برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از اعمال توسط نوجوان روی آوردن به دیگران برای دریافت اطلاعات، راهنمایی و مشورت، طرح‌ریزی گروهی از اعمال توسط نوجوان

منبع: شولمن، ۱۹۹۳

^۱ - expressive – independence oriented

روابط همسالان

دوستان نزدیک و گروه همسالان نیز نقش مهمی در حمایت اجتماعی در موقعیت‌های تنش‌زا دارند. پذیرفته شدن در گروه همسالان، عزت نفس را افزایش می‌دهد، به اجتناب از تنهایی کمک کرده و دوستی‌ها و حمایت‌های باارزشی را فراهم می‌کند. در نتیجه، دوستی‌های نزدیک، صمیمیت هیجانی، همراهی و همدلی ایجاد می‌کند. دوستان، باورها، ارزش‌ها و اطلاعاتی را در نوجوان شکل می‌دهند، بنابراین نقش ضربه‌گیر و کاهش‌دهنده تنیدگی دارند.

رابطه میان دلبستگی به والدین و دوستان و مقابله با تنیدگی، در دختران و پسران متفاوت است، به‌طوری‌که پسران تمایل دارند والدینشان را به‌عنوان منبع حمایتی هنگام مقابله فعال انتخاب کنند (نظیر جست‌وجو برای کسب اطلاعات)، اما دختران از دوستان و والدین خود به‌عنوان منابع حمایتی استفاده می‌کنند. بنابر نظر شولمن (۱۹۹۳)، این تفاوت‌های جنسیتی انعکاسی از عملکردهای مختلفی است که دوستان و دوستی‌ها برای دختران و پسران دارد. برای مثال دیده شده که دوستی‌های پسران کمتر توأم با صمیمیت و بیشتر محافظت‌کننده است تا دوستی‌های دختران. دختران در دوستی‌هایشان بیشتر به خودفاش‌سازی و درد دل کردن روی می‌آورند، آنها اغلب دوست‌هایشان را به‌عنوان افرادی که با آنها صمیمیت دارند، معرفی می‌کنند، درحالی‌که پسران کمتر بر عاطفی بودن تأکید دارند. این الگوهای دوستی منعکس‌کننده راهبردهای مقابله‌ای مختلفی برای پسران و دختران است. از این‌رو رابطه با والدین و دوستان در رفتارهای مقابله‌ای دختران بسیار بااهمیت است.

به‌طور کلی، برخی از وقایع تنش‌زا هنجاری و بعضی دیگر غیرهنجاری‌اند. تغییرات فیزیکی در سنین نوجوانی از جمله تنش‌زاهای هنجاری به‌شمار می‌روند و وقایع غیرهنجاری، شامل مرگ یک فرد دوست‌داشتنی یا مرگ والدین است. برخی صاحب‌نظران معتقدند بهترین پیش‌بینی‌کننده تنیدگی نشانگان روان‌شناختی در سنین نوجوانی، ترکیبی از رویدادهای روزمره زندگی است. همچنین می‌توان علل مهم و همبسته‌های تنیدگی در نوجوانان را شامل تغییر در تجارب دارای عواطف منفی در طول سال‌های نوجوانی، تنیدگی‌های خانوادگی، تفاوت‌های قومی در ادراک وقایع و نقش مهم تفاوت‌های جنسیتی دانست. مقابله با تنیدگی نیز در نوجوانی اهمیت زیادی دارد. عوامل مهم مرتبط با راه‌های مقابله با تنیدگی شامل تغییرات مرتبط با سن در مقابله و تأثیر روابط نزدیک بر مقابله است.

قابلیت کنترل ادراک شده

نوجوانانی که معتقدند بر زندگی خود کنترل دارند، از نظر مقابله و کنار آمدن با تنیدگی، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند تا آنهایی که معتقدند آنچه در زندگی آنان رخ می‌دهد، از قبل تعیین شده

و فقط ناشی از بدشانسی آنان است. تحقیقات روان‌شناختی انجام‌شده در مورد مفهوم مکان کنترل، بیش از حدی نسبت به وجود رابطه بین باورهای کنترل از یک سو و نگرش‌ها و رفتارها از سوی دیگر ایجاد کرده است.

همان‌طور که می‌دانیم، انتظارات ما در مورد وقوع حوادث، توسط پاداش‌ها، تشویق‌ها و تقویت‌کننده‌ها شکل می‌گیرند، به‌طوری که اگر فردی برای رفتاری انتظار تقویت داشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که آن رفتار را انجام دهد. افرادی که معتقدند، پاداش‌ها به رفتار خودشان وابسته‌اند، دارای مکان کنترل درونی و افرادی که معتقدند پاداش‌ها مرتبط با نیروهای هستند که در خارج از خودشان قرار دارند، دارای مکان کنترل بیرونی‌اند.

بسیاری از مطالعات به بررسی رابطه بین مکان کنترل و مقابله با تنیدگی پرداخته و مشاهده کرده‌اند که مکان کنترل درونی به‌طور معناداری با سازگاری هیجانی و کارهایی که تنیدگی را کاهش می‌دهند، رابطه دارد. برای مثال، مطالعه‌ای که در مورد تنیدگی‌های زندگی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی صورت گرفت، نشان داد نوجوانانی که دارای مکان کنترل درونی بودند، از نظر میزان اضطراب، وضعیت تحصیلی، فیزیکی و کلی، در شرایط بهتری قرار داشتند تا آنهایی که دارای مکان کنترل بیرونی بودند (کاس، هانان و سارجینت^۱، ۱۹۹۲؛ به نقل از هیون، ۱۹۹۶). از این رو احساس کنترل درونی به‌عنوان یک عامل ضربه‌گیر در مقابله با تجارب تنش‌زا عمل می‌کند. این کار با کاهش اضطراب و کمک به فرد برای حفظ سطح بهینه‌ای از کارایی و صلاحیت انجام می‌گیرد.

نقش مذهب در مقابله با عوامل تنش‌زا

پارگامنت (۱۹۸۶، به نقل از فقیهی، ۱۳۸۴) یکی از پژوهشگرانی است که نظریه جامع‌ی در زمینه نقش مذهب در مقابله با عوامل تنش‌زا مطرح کرده است. او سه شیوه تأثیرگذاری مذهب را در جریان مقابله با فشارهای گوناگون روانی و محیطی مطرح کرده است:

نخست آنکه مذهب می‌تواند بخشی از فرایند مقابله تلقی شود و بر نحوه ارزیابی فرد از عامل تهدیدکننده و شدت آن تأثیر گذارد، به عبارت دیگر، مذهب ممکن است متغیرهای میانجی مانند محدودیت‌های شخصی و اجتماعی فرد و نیز چگونگی ادراک از منابع و رویدادهای فشارزا را تحت تأثیر قرار دهد؛ دوم آنکه مذهب می‌تواند در فرایند مقابله مداخله کند، بدین معنا که در تعریف مجدد از مشکل و مسئله به گونه‌ای که قابل حل باشد، کمک کند. از این رو مذهب به افراد کمک می‌کند تا از نظر هیجانی خود را حفظ کرده و در برخورد با آن موقعیت از طریق معناجویی و امیدواری تلاش

^۱ . Cause, Hannan & Sargeant

کنند؛ سوم آنکه مذهب می‌تواند بر نتایج و پیامدهای حاصل از عوامل فشارزا تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر، چگونگی تفسیر افراد از نتایج و عواقب مربوط به رویدادها و حوادث زندگی، تحت تأثیر باورها و اعتقادهای مذهبی قرار می‌گیرد.

پژوهش‌های گوناگون، نقش مذهب را برای مقابله با مشکلات روانی نشان می‌دهند. ماتلین و همکاران (۱۹۹۰؛ به نقل از فقیهی، ۱۳۸۴) نشان دادند که مقابله‌های مذهبی، آثار قوی و مطلوبی در کاهش سطح اضطراب و افسردگی در زمینه وقایع مربوط به فقدان و اساساً داغیدگی‌ها دارند. اما در زمینه انواع دیگر وقایع تنش‌زای حاد و مزمن اثر چندانی ندارند.

شاید دلیل اینکه مذهب در کاهش تنیدگی‌های مربوط به عوامل و وقایع خاص زندگی مؤثر واقع می‌شود، این است که در این وقایع، امکان تغییر شرایط وجود ندارد، بنابراین مقابله‌های مذهبی با کمک به فرد برای پذیرش واقعیت یکی از مؤثرترین مقابله‌ها به حساب می‌آیند. علاوه بر این مذهب به تنظیم و تفسیر وقایع زندگی، حالتی عبادت‌گونه می‌بخشد. شواهد و تحقیقات نشان می‌دهند افرادی که از احساس وابستگی و ارتباط متعالی برخوردارند و از اطاعت خداوند در زندگی‌شان لذت می‌برند، سلامت جسمانی و روانی بیشتری دارند (برگین^۱، ۱۹۹۱).

مدارکی در دست است که نشان می‌دهد، وقایع خاص زندگی و شرایط تنش‌زای مزمن در نوجوانان و افراد بزرگسال به احتمال زیاد پاسخ‌های مقابله‌ای مذهبی را برمی‌انگیزد. از این میان می‌توان به ناتوانی‌ها و بیماری‌های سخت جسمانی، دردهای مزمن، داغیدگی و حوادث سخت (لو و هاندال، ۱۹۹۵) اشاره کرد. در نهایت می‌توان به عنوان یک شیوه مقابله‌ای به بقای ادراک افراد در زمینه اجرای عدالت در جهان اشاره کرد (اعتقاد به جهان آخرت)، که طی آن افراد خوب و بد براساس اعمالی که انجام داده‌اند، متمایز می‌شوند و به سزای اعمالشان می‌رسند.

به‌طور کلی کنش مهم فعالیت‌های مذهبی این است که فرد را در برابر عوامل تنش‌زا توانمند می‌کنند. در ایفای نقش‌گیری مذهبی^۲، فرایند اتخاذ نقش مذهبی را به عنوان یک شیوه مقابله‌ای نمی‌توان نادیده گرفت. در واقع ایفای نقش مذهبی با فراهم ساختن امکان ارزیابی برای فرد به او کمک می‌کند تا جنبه‌های نظم‌دهی عاطفی و مقابله‌ای خود را شکل دهد. به‌طور خلاصه ایفای نقش مذهبی سبب می‌شود که فرد خود را با چهره‌های کمال‌یافته مذهبی همسان کند. در این شرایط افراد خود را برحسب چهره‌های والای مذهبی ارزیابی می‌کنند و از منظری برتر و متعالی‌تر (نقش خداوند) به مسائل خود می‌نگرند. این وضع سبب می‌شود آنان موقعیت‌های تنش‌زا را به آسانی اداره کنند.

^۱ . Bergin

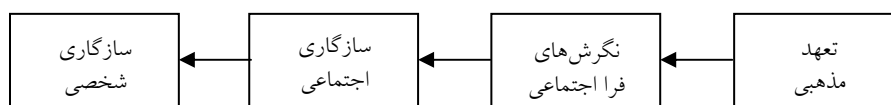
^۲ . religious role taking

اعتقاد بر این است که اسنادها^۱ یکی از جنبه‌های مهم ارزیابی عوامل تنش‌زا بوده و عبارتند از نسبت دادن مسئولیت و مهار این عوامل به شرایط یا حوادث ایجادکننده آنها. برخی از پژوهش‌ها در زمینه افراد مذهبی نشان می‌دهد که برخلاف ذهنیت روان‌شناختی موجود، این افراد نگرانی و حوزه سرزنش خود را تقلیل می‌دهند و بدین ترتیب سلامت خود را بهبود می‌بخشند. آنها مشکلات خاص خود را با نسبت دادن شرایط حل‌نشده به خداوند مهار می‌کنند (ونتیس، ۱۹۹۵). یافته‌ها نشان می‌دهند افراد مذهبی وقایع را مثبت‌تر ارزیابی می‌کنند تا افراد غیرمذهبی.

توماس و کروور^۲ (۱۹۹۰؛ به نقل از خدایاری فرد و رحیمی‌نژاد، ۱۳۸۵) معتقدند که باورها و اعمال مذهبی در زندگی نوجوانان و جوانان دو کارکرد مهم دارند: ۱) کنترل اجتماعی، به این معنا که دینداری و اعمال مذهبی رفتارهای ضداجتماعی را کاهش می‌دهند و ۲) تسهیل اجتماعی، به این معنا که مذهب و دینداری روابط اجتماعی رضایت‌بخش را ترویج می‌دهد و تسهیل می‌کند.

دوناهو و بنسون^۳ (۱۹۹۵) با مروری بر ادبیات پژوهش دریافتند که دینداری به نحو مثبتی با رفتارها و ارزش‌های فرا اجتماعی نوجوانان رابطه دارد و این مسئله به‌طور بالقوه‌ای از درگیر شدن نوجوانان در رفتارهای منفی و سازش‌نایافته‌ای چون بزهکاری، مصرف مواد و الکل و برقراری روابط نامشروع جنسی پیشگیری کرده و بدین ترتیب سازگاری اجتماعی آنان را تسهیل می‌کند.

شلودرمن و شلودرمن (۲۰۰۰) مدلی را ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد: ۱) تعهد مذهبی نگرش‌های فرا اجتماعی را در نوجوانان توسعه می‌دهد، ۲) نگرش‌های فرا اجتماعی نیز سازگاری اجتماعی نوجوانان را توسعه می‌بخشد (از طریق تأثیر بر نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، مدرسه و محل کار) و ۳) سازگاری اجتماعی نیز منجر به سازگاری شخصی می‌شود (از طریق تأثیر بر عزت نفس و رضایت از زندگی). این محققان با استفاده از داده‌هایی که از نوجوانان دبیرستانی کاتولیک به دست آوردند و نیز به کمک مدل معادلات ساختاری، به بررسی روابط علی بین دینداری، سازگاری اجتماعی و سازگاری شخصی در نوجوانان پرداختند. یافته‌های آنها از الگوی تسهیل اجتماعی مذهب ارائه شده توسط آنان حمایت کرد. به‌طوری‌که مشاهده شد: ۱) تعهد مذهبی بالا در نوجوانان همبستگی بسیار زیادی با نگرش‌های فرا اجتماعی و همبستگی ضعیفی با سازگاری شخصی داشت، ۲) نگرش‌های فرا اجتماعی همبستگی زیادی با سازگاری اجتماعی نوجوانان داشت و ۳) سازگاری اجتماعی همبستگی بسیار زیادی با سازگاری شخصی نوجوانان داشت (شکل زیر).



^۱ . attributions

^۲ . Thomas & Craver

^۳ . Donuhue & Benson

وایوگن و روش^۱ (۲۰۰۳) رابطه بین مقابله‌های مذهبی، دینداری، سلامت جسمانی و روانی را در گروهی از نوجوانان متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین بررسی کردند. آنها دریافتند که تفسیرهای مجدد مثبت، دریافت حمایت اجتماعی از هم‌کیشان، مقابله‌های مذهبی و دینداری رابطه مثبت و معناداری با سازگاری شخصی و اجتماعی و سلامت جسمانی این نوجوانان داشت.

بواله‌ری، احسان‌منش و کریمی کیسمی (۱۳۷۹) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه میان عوامل تنش‌زا، میزان توکل به خدا و نشانگان تنیدگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و تهران، ۴۰۸ دانشجو (۲۳۴ پسر و ۱۳۴ دختر) را به شیوه تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار دادند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شاخص میزان توکل، پرسشنامه عوامل تنش‌زا و پرسشنامه نشانگان تنیدگی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که ۴۴/۱ درصد دانشجویان دارای تنیدگی کم، ۳۱/۱ درصد دارای تنیدگی متوسط و ۲۴/۸ درصد دارای تنیدگی زیاد بودند. از میان عوامل تنش‌زا، ترس از مردود شدن در امتحان‌ها، مرگ یکی از بستگان نزدیک و مشاجره با والدین، به ترتیب درصد بیشتری از دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین مشاهده شد به موازات بالاتر رفتن نمره‌های دانشجویان در پرسشنامه توکل، نمره‌های آنان در پرسشنامه نشانگان تنیدگی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، دانشجویانی که هنگام مواجهه با عوامل تنش‌زا از راهبردهای مقابله‌ای مذهبی نظیر توکل به خدا استفاده می‌کردند، از سلامت بیشتری برخوردار بودند.

هومن (۱۳۷۶) با هدف بررسی سطوح و انواع تنیدگی و راهبردهای مقابله با آن در جوانان، ۵۰۴ دانشجو را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که مهم‌ترین موقعیت‌هایی که برای این دانشجویان ایجاد تنیدگی می‌کنند، به ترتیب عبارتند از: امکانات رفاهی و بهداشتی کم، بالا بودن هزینه‌ها، نگرانی درمورد انتخاب شغل و درآمد ناکافی. همچنین مشاهده شد که مهم‌ترین شیوه‌های مقابله‌ای دانشجویان به ترتیب عبارتند از: توکل به خداوند متعال و یاری گرفتن از او، عبادت، دعا خواندن، کمک گرفتن از تجربیات قبلی برای حل مشکل، استفاده از روش‌های نظام‌دار برای حل مشکل و عدم تعجیل.

^۱ . Vaughn & Roesch

خلاصه

از آنجا که نوجوانان تجارب مختلفی را به‌عنوان تجارب تهدیدکننده تصور می‌کنند که مستلزم پاسخ‌های تازه‌ای هستند، پس آن وقایع می‌توانند به‌عنوان وقایع تنش‌زا مدنظر قرار گیرند. برخی وقایع تنش‌زا جنبهٔ هنجاری دارند. این وقایع شامل تغییرات جسمانی در سال‌های نوجوانی، انتقال به دبیرستان و غیره می‌شود. برخی از وقایع غیرهنجاری‌اند، نظیر مرگ یکی از والدین یا از دست دادن یک دوست صمیمی. برخی محققان معتقدند که بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های نشانگان روان‌شناختی در سال‌های نوجوانی مشاجرات، بحث‌ها و درگیری‌ها هستند. براساس این دیدگاه، این مشاجرات پیش‌بینی‌کننده‌های دقیق‌تری برای تنیدگی و فشار روانی‌اند تا وقایع مهمی که فقط یک بار در زندگی نوجوان رخ می‌دهند.

در این فصل چندین علت مهم تنیدگی نوجوانان و همبسته‌های آنها مورد بحث قرار گرفت. این علل شامل تغییر در تجارب منفی هیجانی در طول سال‌های نوجوانی، تنش‌زاهای خانوادگی، تفاوت‌های قومی در ادراک وقایع و نقش تفاوت‌های جنسیتی‌اند. بنابراین، والدین گاهی از نظر رعایت قواعد و قوانین خانوادگی و انتظاراتشان از فرزندان نوجوان خود بسیار متفاوت‌اند. چنین تفاوت‌هایی برای بعضی افراد می‌تواند منبع تنیدگی باشد.

صاحب‌نظران اشاره کرده‌اند که تفاوت‌های جنسیتی در تجربهٔ تنیدگی نقش دارند. اگرچه به‌طور کامل روشن نیست که چرا چنین تفاوت‌های جنسیتی وجود دارند، اما اعتقاد بر این است که در این مورد عوامل فیزیکی - زیست‌شناختی می‌توانند مهم باشند. ممکن است تأثیر هورمون‌های خاص و رشد جهشی در این مسئله که دختران و پسران چگونه تنیدگی را تجربه کنند و به آن واکنش نشان دهند، مطرح باشد.

اهمیت راهبردهای مقابله‌ای در نوجوانان نیز در این فصل بررسی شد. چند عامل مهم شامل تغییرات مرتبط با سن، تأثیر روابط نزدیک (با خانواده و دوستان) و نوع مکان کنترل مطرح شد. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که تمام این عوامل با سازگاری رابطه دارند، از این‌رو باید به‌عنوان عواملی که در مواجهه با تنیدگی نقش ضربه‌گیر دارند، مدنظر قرار گیرند.

در مورد نتیجهٔ مقابله‌های غیرکارآمد، ناکافی و ناقص، اشاره شد که چند نتیجهٔ احتمالی وجود دارد که دامنه‌ای از مصرف مواد تا افسردگی، اختلالات خوردن و خودکشی دارند. این نتایج کاربردها و تلویحات مهمی را در وضعیت سلامت نوجوانان دارند که در فصل‌های دیگر به تفصیل بررسی می‌شوند.

پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

۱) به نظر شما علت اصلی تفاوت‌های جنسیتی در نوع، میزان تنیدگی و سبک‌های مقابله‌ای مورد

استفاده در نوجوانان و جوانان چیست؟

۲) قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه از جمله عوامل تنش‌زای هنجاری است یا غیرهنجاری؟

چرا؟

فصل سوم

اختلالات خوردن

دو رفتار مشهور در مورد خوردن که یکی از علل نگرانی افراد متخصص و عام است، عبارتند از پرخوری عصبی^۱ و بی‌اشتهایی عصبی^۲. در متون علمی، به هر دو این اختلالات به‌عنوان اختلالات خوردن اشاره شده و به‌عنوان مشکلات جدی سلامت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مطالعاتی که در مورد همه‌گیرشناسی این اختلال صورت گرفته، نشان می‌دهد که شیوع این دو اختلال در میان نوجوانان روبه افزایش است (بویژه در جوامع صنعتی) و پیامدهای رفتاری و دارویی جدی و شدیدی را در پی دارد.

پرخوری عصبی

کلمهٔ پرخوری یا جوع، ریشهٔ لاتین دارد و به معنای گرسنگی است. بنابراین پُرخوری به درستی نام‌گذاری شده، زیرا فرد پُرخور که بیشتر این افراد را زنان تشکیل می‌دهند، دچار پُرخوری مفرط شده است. فرد مبتلا به پرخوری، با خوردن افراطی دوره‌ای و نامحدود مشخص می‌شود که طی آن فرد حدود ۲ ساعت غذا می‌خورد و اغلب این کار را پنهانی انجام می‌دهد. فرد در طول این دورهٔ زمانی می‌تواند در حدود ۱۰/۰۰۰ کالری مصرف کند، قبل از اینکه بالا بیاورد و استفراغ کند. تعداد کمی از افراد جامعه به پُرخوری مبتلا می‌شوند، در حدود ۱ تا ۳ درصد دختران نوجوان به این اختلال دچار می‌شوند. در میان پسران، شیوع این اختلال خیلی کمتر است (DSM-IV-TR، ۲۰۰۰).^۳

افراد پرخور بیشتر در دامنهٔ وزنی بهنجار قرار دارند، ولی اغلب در مورد وزن خود حساس و ناراضی‌اند. بنابراین، هر دورهٔ پرخوری، یک دورهٔ تنقیه را توسط خود فرد برای کنترل وزن به دنبال دارد. کنترل وزن توسط روش‌های مختلفی نظیر بالا آوردن، مصرف داروهای ضد یبوست، روزه گرفتن شدید و افراطی، ورزش‌های سخت و استفاده از داروهای کاهش‌دهندهٔ وزن صورت می‌گیرد. انجمن روان‌پزشکان آمریکا (۲۰۰۰) مجموعه‌ای از ملاک‌های تشخیصی را برای پرخوری عصبی مطرح کرده است (جدول ۳-۱). مؤلفه‌های مهم این ملاک‌ها عبارتند از اینکه رفتار پرخوری باید در حدود دوبار در هفته و طی دورهٔ سه ماهه رخ دهد تا به‌عنوان پرخوری مشخص و طبقه‌بندی شود.

^۱ . bulimia nervosa

^۲ . anorexia nervosa

^۳ . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Forth Edition, Text Revision

دو نوع پرخوری مشخص شده است، یکی خوردن افراطی یا پرخوری و دیگری عدم پرخوری. نوع اول، با رفتارهای جبرانی نظیر تحریک خود برای بالا آوردن و استفراغ کردن یا استفاده از داروهای ضد یبوست، اماله کردن و غیره همراه است؛ در نوع دوم، افراد ممکن است از روزه گرفتن یا ورزش‌های سخت و افراطی به منظور کنترل وزن خود استفاده کنند.

در حدود ۳ درصد دختران نوجوان از پرخوری عصبی رنج می‌برند و اغلب سن شروع پرخوری عصبی در نوجوانی، ۱۶ تا ۱۸ سالگی است. دوره‌های پرخوری همراه با احساس از دست دادن کنترل و احساس گناه است. نوجوانان مبتلا به این اختلال اغلب وزن خود را بیش از حد برآورد می‌کنند. نتایج پژوهش‌های اخیر بیانگر افزایش تعداد نوجوانان مبتلا به پرخوری عصبی است، به‌طوری‌که مشاهده شده حدود ۱۰ تا ۵۰ درصد دختران و پسران نوجوان، به‌طور مکرر رفتار پرخوری دارند (فایر بورن^۱ و همکاران، ۲۰۰۳؛ گرانج^۲ و همکاران، ۲۰۰۴؛ جونز^۳ و همکاران، ۲۰۰۱).

به‌طور معمول خوردن افراطی به دنبال یک واقعه بیرونی نظیر تنیدگی‌های بین فردی رخ می‌دهد، اما ممکن است نتیجه گرسنگی شدید به علت رژیم غذایی نیز باشد. اگرچه اختلال خوردن ممکن است به عنوان یک شیوه مقابله با دامنه‌ای از وقایع عمل کند، اما افراد مبتلا به پرخوری پس از این کار دچار افسردگی و انتقاد شدید از خود می‌شوند.

موس^۴ (۱۹۸۶) با افراد پرخور مصاحبه کرده و تجارب آنها را ثبت کرده است. یکی از این تجارب به شرح زیر است:

اولین دوره پرخوری من مربوط به پنج سال قبل است. من پرخوری‌های برنامه‌ریزی شده و بدون برنامه و تحریک خودم برای بالا آوردن را ۴ مرتبه در روز داشتم. روزانه سه وعده غذا می‌خوردم، به اضافه ۳ یا ۴ عدد همبرگر در بعدازظهر، ۴ تا ۵ کاسه بزرگ بستنی، مقدار زیادی شیرینی (۱۲ عدد)، یک پاکت سیب‌زمینی سرخ شده، پنیر سویسی، حداقل ۳ شیرکاکائو، چند عدد سیب، موز و ۲ شیشه شیر برای اینکه بتوانم این میوه‌ها را پایین بفرستم. سپس از رختخواب بیرون می‌آمدم و به دستشویی می‌رفتم تا خود را خالی کنم، گاهی غذا به راحتی بیرون نمی‌آمد و به سرعتی که من می‌خواستم بالا نمی‌آوردم، به همین دلیل با ترس انگشت سبابه‌ام را در حلقم فرو می‌کردم، به‌طوری‌که گاهی ناخن‌هایم گلویم را خراش می‌دادند.

^۱ . Fairburn

^۲ . Grange

^۳ . Jones

^۴ . Muuss

جدول ۱-۳. ملاک‌های تشخیصی برای پرخوری عصبی

۱. دوره‌های مکرر و متوالی پرخوری که از طریق موارد زیر مشخص می‌شود: (الف) خوردن غذای زیاد (بیشتر از آنچه همه افراد می‌خورند) اغلب در یک دوره ۲ ساعته. (ب) احساس از دست دادن کنترل در طول دوره پرخوری.
۲. رفتار جبرانی نامتناسب به صورت مکرر. هدف اصلی، کاهش وزن است. روش‌ها ممکن است شامل تحریک خود برای استفراغ کردن، استفاده از داروهای ضد یبوست، اماله، روزه‌گرفتن و ورزش شدید باشد.
۳. پرخوری و رفتار جبرانی در حدود ۲ بار در هفته در طول ۳ ماه رخ می‌دهد.
۴. شکل بدنی و وزن در ارزیابی از خود بسیار مهم است.
۵. این تجربه نمی‌تواند فقط در طول یک دوره پرخوری عصبی رخ دهد.

منبع: انجمن روان‌پزشکان آمریکا (۲۰۰۰)

عوامل روان‌شناختی و اجتماعی مرتبط با پرخوری عصبی

عوامل بسیار زیادی با پرخوری مرتبط‌اند که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌شود.

طراحی معیارهای بسیار سخت

افراد مبتلا به پرخوری معیارهای بسیار سختی را برای خود طرح می‌کنند. به‌تازگی در برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای، در مورد شکل بدنی ایده‌آل و متناسب صحبت‌های بسیاری می‌شود. از این رو بسیاری از افراد رهنمودهای خود را از برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای می‌گیرند و رفتار مطلوب و معیارهای قابل قبول را براساس این برنامه‌ها تشخیص می‌دهند.

امروزه جذابیت فیزیکی برای زنان در بسیاری از فرهنگ‌ها برابر با لاغری است. به‌طور کلی، زنان تمایل بیشتری دارند که خوش‌اندام باشند. زنان بیشتر از مردان در مورد وزن و شکل بدنی‌شان نگران و ناراضی‌اند، زیرا وزن زیاد مضرات و نگرانی‌هایی را در پی دارد. بیشتر زنان برای حفظ رژیم غذایی خود تحت فشارند، بویژه افراد مبتلا به پرخوری از شکل بدن خود ناراضی‌اند و میل شدیدتری برای لاغر شدن دارند. به‌همین دلیل احتمال دارد آنها از مشکلات مرتبط با خوردن بیشتر رنج ببرند. ترس از چاقی محور چرخه پرخوری آنان است. آتیه و بروکس^۱ (۱۹۸۹)، به ارزیابی نقش تصور بدنی در رشد و شکل‌گیری مشکلات خوردن در آینده پرداختند. آنها در مطالعه طولی نخست با ۲۰۰ دختر ۱۳

^۱. Attie & Brooks

ساله مصاحبه کردند و دو سال بعد آنها را مورد پیگیری قرار دادند. این پژوهشگران دریافتند که تصور بدنی منفی در طول سال‌های بلوغ بهترین پیش‌بینی‌کننده مشکلات خوردن در طول زمان است. اعتقاد بر این است که چاقی و اضافه وزن در زنان به‌طور معناداری در طول دوران بلوغ افزایش می‌یابد و این ممکن است با تصور بدنی مرتبط باشد.

گارسیا - گرو^۱ (۲۰۰۴) نیز به بررسی عوامل زمینه‌ساز اختلالات خوردن در بین ۷۸۵ دختر و پسر نوجوان پرداختند. ایشان دریافتند که سرزنش خود یا به عبارت دیگر سرزنش افراطی خود هنگام مواجهه با مشکلات، یکی از راهبردهای مقابله‌ای ناکارامدی است که رابطه‌ی زیادی با ابتلا به اختلالات خوردن دارد. همچنین مشاهده شد که تمایل به لاغری در دختران نوجوان از جمله عوامل دیگری است که زمینه را برای ابتلا به اختلالات خوردن فراهم می‌کند.

نقش شخصیت و جو خانوادگی

عملکردهای خانوادگی، یکی از عواملی است که با پرخوری رابطه دارد. به‌علاوه، جوهای خانوادگی‌ای که در آنها وابستگی وجود ندارد، سازماندهی و حالت‌های عاطفی و بیانی کم است، پیش‌بینی‌کننده معناداری برای ابتلا به اختلالات خوردن در آینده‌اند.

مروری بر پژوهش‌های مختلف انجام‌شده در این حوزه، نشان می‌دهد که پویایی‌های خانوادگی در مشکلات خوردن نقش دارند. سخت‌گیری‌های خانواده و اقتدار و تحکم آنها در دوران کودکی، زمینه‌ساز الگوهای نابهنجار خوردن هستند. کودکانی که در این خانواده‌ها پرورش می‌یابند، در تلاش برای اجتناب از تنش‌های خانوادگی و کاهش احساسات قلبی درونی خود، شکست می‌خورند و تعارض‌های خانوادگی آنها اغلب حل‌نشده یا حتی کاملاً پنهان می‌مانند. در بسیاری از موارد، این نوجوانان دستیابی به هویت را برای خود مشکل می‌یابند و ممکن است از اختلالات خوردن به‌عنوان روشی برای باور کردن استقلال خود استفاده کنند. کنترل وزن برای این نوجوانان، علامت کنترل شخصی و کارآمد بودن آنان است. به‌طور معمول افراد مبتلا به پرخوری یا جوع، متعلق به خانواده‌های سخت‌گیر و مقتدری هستند که تعارضات و درگیری‌های خانوادگی نیز دارند. این خانواده‌ها خودبستگی، تکیه بر خود و اعتماد به نفس و جرأت‌ورزی را در اعضای خود تشویق نمی‌کنند (جانسون و فلچ^۲، ۱۹۸۵). پژوهشگران به چنین پویایی‌هایی به‌عنوان عواملی می‌نگرند که

^۱ . Garcia - Garau

^۲ . Johnson & Flach

منجر به مشکلات خوردن، افسردگی، احساس درماندگی و عدم کارایی، عزت نفس پایین، کمال‌گرایی و مشکلات مربوط به احساس تنش و تنیدگی می‌شوند.

شاو^۱ (۲۰۰۴) به بررسی نقش فرهنگ قومی در اختلالات خوردن پرداخت. وی الگوی فرهنگی اجتماعی را در زمینه سبب‌شناسی اختلالات خوردن، اساس کار خود قرار داد. براساس این الگو، گروه‌های اقلیت قومی کمتر به اختلالات خوردن مبتلا می‌شوند تا سفیدپوست‌ها. شاو، به بررسی تفاوت‌های قومیتی از نظر نشانگان اختلال خوردن در نوجوانان دختر و پسر پرداخت. یافته‌های او نشان داد که نوجوانان متعلق به اقلیت‌های قومی از نظر نشانگان اختلالات خوردن تفاوتی با نوجوانان سفیدپوست ندارند.

مروری بر ادبیات پژوهش دربارهٔ پرخوری نیز نشان داد که عزت نفس پایین، عامل مهمی در درک این رفتار است. از آنجا که جامعه به‌طور اعم و زنان به‌طور اخص شرطی شده‌اند که به چاقی با دیدی منفی بنگرند، ادراک فرد از خودش به‌عنوان فردی چاق اغلب با داشتن عزت‌نفس پایین مرتبط است. افراد مبتلا به پرخوری، عزت‌نفس پایین و تصور بدنی ضعیف و انتظارات زیادی از خود دارند و به تأیید دیگران نیازمندند و تمایلات بیشتری به رژیم‌های غذایی سخت دارند. نتایج یکی از مطالعات نشان داد که دامنه‌ای از عوامل خانوادگی و اجتماعی، آثار منفی بر عزت‌نفس و خودکارآمدی دارند. این دو عامل پیش‌بینی‌کننده‌های بسیار خوبی برای مشکلات خوردن به شمار می‌روند (استروبر و هامفری^۲، ۱۹۸۷).

عوامل شخصیتی مرتبط با پرخوری عبارتند از حالت افسردگی، اضطراب و آشفتگی‌های هیجانی. افرادی که به اختلال پرخوری دچارند، نمره‌های بهتری از میزان بهنجار در افسردگی دارند (هیشرتون و بایومیستر^۳، ۱۹۹۱).

بی‌اشتهایی عصبی

اگرچه بیشتر افراد مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی را زنان تشکیل می‌دهند، اما گروه زیادی از مردان نیز به این اختلال مبتلا می‌باشند. به‌علاوه ممکن است شیوع این اختلال در میان مردان خیلی بیشتر باشد، اما از آنجا که بیشتر متخصصانی که مبتلایان به این اختلال را درمان می‌کنند، انتظار دارند که مبتلایان به این اختلال زنان باشند، از این رو ممکن است میزان شیوع در مردان کمتر گزارش شده باشد.

^۱ . Shaw

^۲ . Strober & Humphrey

^۳ . Heatherton & Baumeister

انجمن روان‌پزشکان آمریکا، ملاک‌هایی را برای تشخیص اختلال بی‌اشتهایی عصبی مشخص کرده است (جدول ۲-۳).

جدول ۲-۳. ملاک‌های تشخیصی برای بی‌اشتهایی عصبی

۱. ناتوانی در حفظ وزن بهنجار بدن. وزن بدنی کمتر از ۸۵ درصد وزنی است که برای سن و وزن مورد انتظار است.
۲. ترس و وحشت شدید از چاقی و به‌دست آوردن اضافه وزن.
۳. اختلال در ادراکات و تصورات شکل بدنی و وزن بدنی. تصور بدنی مرتبط با عزت نفس است.
۴. فقدان حداقل سه چرخه قاعدگی متواتر بهنجار بدون استفاده از دارو.

منبع: انجمن روان‌پزشکان آمریکا (۲۰۰۰)

همانند اختلال پرخوری، افرادی که از بی‌اشتهایی عصبی رنج می‌برند نیز تصور بدنی نادرستی از خود دارند و اندازه بدن خود را بیشتر از آنچه واقعیت دارد ادراک می‌کنند. این افراد از اضافه وزن خود بشدت می‌ترسند و نمی‌توانند وزن خود را در دامنه بهنجاری حفظ کنند. در واقع، حتی وقتی که وزن آنان کاهش می‌یابد، باز هم ترس از اضافه وزن همچنان ادامه دارد.

عزت نفس با تصور بدنی و ناتوانی در از دست دادن وزن ارتباط دارد. این ناتوانی در از دست دادن وزن همراه با لاغری نشانه‌ای از فقدان کنترل بر خود است.

افراد مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی، پیوسته نگران شکل و اندازه بدن خود هستند و این نگرانی ذهن آنها را بشدت مشغول می‌سازد، به‌طوری‌که پیوسته به فکر رعایت رژیم غذایی برای حفظ تناسب اندام خود هستند. برخی از این افراد برای از دست دادن وزن به ورزش‌های سخت می‌پردازند، اما همین که وزنشان کاهش یافت، ضعیف، نحیف و خسته می‌شوند. به‌طور معمول، بی‌اشتهایی عصبی منجر به بروز پیچیدگی‌های دارویی زیادی می‌شود.

به‌نظر می‌رسد بی‌اشتهایی عصبی در ۱۴ تا ۱۸ سالگی رخ می‌دهد و در حدود نیم تا ۱ درصد افراد جامعه به آن مبتلا می‌شوند. بیش از ۹۰ درصد افراد مبتلا به این اختلال را زنان تشکیل می‌دهند. این اختلال بندرت در میانسالی یا قبل از بلوغ در دختران رخ می‌دهد. در بیشتر موارد، اختلال ناشی از زندگی سرشار از تنیدگی و وقایع تنش‌زاست و احتمال دارد مستلزم بستری شدن در بیمارستان به‌دلیل از دست دادن زیاد وزن یا بی‌نظمی و اختلال در ترکیبات مورد نیاز بدن باشد. برآورد شده که میزان مرگ و میر ناشی از این اختلال در حدود ۱۰ درصد است و بیشتر افرادی که مرده‌اند، علت مرگشان خودکشی یا عدم تعادل در ترکیبات بدن و گرسنگی بوده است (انجمن روان‌پزشکان آمریکا، ۲۰۰۰). افراد مبتلا به بی‌اشتهایی، به‌طور کلی به افکار وسواسی درباره غذا و اینکه وزن بدنشان تحت

کنترل باشد، دچارند. افراد مبتلا به این اختلال حتی ۱ یا ۲ کیلوگرم افزایش وزن را، از دست دادن کنترل بر وزن بدن خود تفسیر می‌کنند. این افراد به شکل بدن خود اعتماد ندارند و ممکن است در واقع از بدشکل شدن بدن خود بترسند و در هراس باشند.

افرادی که از این اختلال رنج می‌برند، بیشتر به انجام کارها، تکالیف و امور روزانه خود نظیر تکالیف تحصیلی ادامه می‌دهند و ممکن است حتی پیشرفت تحصیلی زیادی داشته باشند. اما یکی از نشانه‌های این بیماری، عدم ارتباط و تماس با دوستان است. رژیم غذایی موجب می‌شود تا فرد احساس بهتری درباره خود داشته باشد و بیشتر با دیگران ارتباط برقرار کند، اما این کار نه تنها منجر به اصلاح و بهبود روابط نمی‌شود، بلکه سبب انزوا و تنهایی او می‌شود (گارفینکل و گارنر، ۱۹۸۲). اوبسیتی، فیتنس و ولنس ویک^۱ (۲۰۰۴)، توصیه‌هایی را برای پیشگیری و درمان اختلالات خوردن در نوجوانان مطرح کرده‌اند که عبارتند از:

۱) ارزیابی دقیق و مؤثر افراد مبتلا به اختلالات خوردن. این کار مستلزم همکاری مراکز بهداشتی و درمانی، فعالیت و درگیری خود بیمار یا اطرافیان او، فراهم کردن اطلاعات مفید درباره این اختلال، حمایت اخلاقی و کمک‌رسانی اولیه است؛

۲) همکاری اعضای خانواده از جمله خواهرها و برادرهای فرد بیمار در فرایند درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات خوردن؛

۳) استفاده از مداخله‌های درمانی نظیر رفتاردرمانی همراه با تسهیل برقراری ارتباط با دیگران، شناخت درمانی و شناخت - رفتاردرمانی، استفاده از برنامه‌های خودیاری و دارودرمانی از جمله به‌کارگیری داروهای ضدافسردگی. آنچه باید در نظر داشت، این است که مداخله‌های شناختی - رفتاری باید مطابق و متناسب با سطح تحول و جو خانوادگی نوجوانان باشد.

عوامل مرتبط با مشکلات عمومی خوردن

تا اینجا در مورد چند عامل مرتبط با پرخوری عصبی و بی‌اشتهایی عصبی بحث شد. در این بخش، عواملی که با مشکلات عمومی خوردن مرتبط‌اند، بررسی می‌شوند.

^۱ . Obesity, Fitness & Wellness week

نقش طبقه اجتماعی

بعضی صاحب نظران معتقدند که مبتلایان به اختلالات خوردن نظیر بی‌اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی، متعلق به طبقات خاصی از اجتماع‌اند. اغلب بی‌اشتهایی عصبی در میان نوجوانان متعلق به جایگاه اجتماعی متوسط تا بالا، و پرخوری عصبی در میان دختران طبقه پایین شیوع بیشتری دارد. مطالعه‌ای به بررسی نگرش ۱۱/۰۰۰ نوجوان ۱۳ تا ۲۰ ساله پرداخت. اگرچه در این مطالعه مشکلات خوردن مورد ارزیابی قرار گرفت نه اختلالات خوردن، اما مشاهده شد که رابطه خیلی ضعیفی بین طبقه اجتماعی و مشکلات خوردن وجود دارد. به عبارت دیگر، مشکلات خوردن در بین نوجوانان متعلق به طبقات اجتماعی بالاتر، بیشتر بود (هیون، ۱۹۹۶).

نقش فرهنگ

نوجوانان مهاجر بیشتر به مشکلات عمومی خوردن دچار می‌شوند. ویچستروم^۱ و همکاران (۱۹۹۴؛ به نقل از هیون، ۱۹۹۶)، مشاهده کردند که بین نوجوانان مهاجر آسیایی و بریتانیایی، از این نظر تفاوت وجود دارد و نوجوانان مهاجر نمره‌های بهتری را در پرسشنامه‌های مرتبط با مشکلات خوردن به دست می‌آورند. برای این روند دو تبیین احتمالی وجود دارد؛ اولاً، نوجوانان مهاجر ممکن است با ایده‌های غربی نظیر داشتن تصورات بدنی سرعت انطباق یابند و در نتیجه آن را قاطعانه و مصمم دنبال کنند؛ ثانیاً خانواده‌های مهاجر، بویژه آنهایی که متعلق به فرهنگ‌های خاصی‌اند، ممکن است تلاش زیادی برای به حداقل رساندن تعارضات خانوادگی کنند. چنین خانواده‌هایی که تعارضات پنهان دارند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به مشکلات خوردن قرار دارند تا خانواده‌هایی که در آنها تعارضات آزادانه مطرح و حل می‌شوند.

درمان اختلالات خوردن

اگرچه روش‌های مختلفی برای درمان افراد مبتلا به بی‌اشتهایی و پرخوری عصبی وجود دارد، اما به دلایل زیر، کوشش‌های درمانی کنترل‌شده‌ای در مورد این روش‌های درمانی صورت نگرفته است: اولاً، روان‌درمانگری اختلالات خوردن بسیار مشکل است، زیرا افراد مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی، اغلب هیچ انگیزه‌ای برای درمان ندارند، از این رو درمان ناکارآمد و غیرمؤثر خواهد بود؛ ثانیاً، عوامل دیگری نظیر تأثیر دارودرمانی و اعضای خانواده ممکن است اثر درمانی را از بین ببرد.

^۱. Wichstrom

اختلالاتی نظیر بی‌اشتهایی عصبی را می‌توان از دیدگاه بدکارکردی‌های موجود در روابط خانوادگی تبیین کرد. از این‌رو راهبردهای درمانی که تمام اعضای خانواده را به‌عنوان یک کل در فرایند درمان درگیر می‌کنند، می‌توانند مؤثر واقع شوند.

اعضای خانواده باید بدانند که هر یک از افراد خانواده، ظرفیت‌ها، مهارت‌ها، نیروها و شایستگی‌های منحصر به فرد و خاصی دارند. برای درمان اختلالات افراد خانواده، باید درگیری‌ها را در چنین خانواده‌هایی از میان برد. عدم انسجام و هماهنگی و وابستگی، علت اصلی تعارضات و عدم توافقی است که در این خانواده‌ها وجود دارد. اعضای خانواده‌ها باید یاد بگیرند که چگونه با تعارضات برخورد کنند، به جای آنکه این تعارضات را پنهان کنند؛ خانواده‌ها باید بحث و گفت‌وگوهایی در جو گرم، صمیمانه، باز و صادقانه داشته باشند. افرادی که چنین راهبردی را به‌کار می‌گیرند، در ۸۶ درصد موارد طی یک تا ۷ سال می‌توانند به وزن طبیعی دست یابند.

یک راهبرد درمانی برای درمان افراد مبتلا به پرخوری و بی‌اشتهایی عصبی، برنامه‌های اصلاح رفتار است. در مورد افراد مبتلا به بی‌اشتهایی، درمان شامل راهبردهای کنترل‌شده برای اضافه وزن است که در طول اولین بخش از برنامه درمانی که بسیار حیاتی است فرد اضافه وزن داشته باشد، بسیار مفید است. از تقویت‌کننده‌ها نیز می‌توان استفاده کرد، این تقویت‌کننده‌ها می‌توانند شامل امتیازهای کم یا فرصت‌های اجتماعی باشند. مثال زیر این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد.

دختری که مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی بود، به‌منظور به‌دست آوردن امتیازهای خاصی، حداقل در حدود نیم کیلو در روز اضافه وزن داشت. در ابتدا این امتیازها شامل مدت زمانی بود که این دختر می‌توانست خارج از اتاقش باشد. در واقع، ماندن در اتاق هیچ نتیجه و سودی به غیر از خواب و استراحت در رختخواب برای او نداشت. این دختر هر روز صبح وزن می‌شد. اگر نتوانسته بود به وزن موردنظر و لازم برای آن روز برسد، در اتاقش تنها می‌ماند و در اتاق بسته می‌شد، ولی اگر می‌توانست صبح روز بعد به وزن لازم و ضروری برای آن روز دست یابد، به او اجازه داده می‌شد از اتاق خارج شود.

یکی از راهبردهای درمانی برای پرخوری عصبی، استفاده از فرایند شناختی - رفتاری برای کمک به فرد است تا بتواند رفتار و تفکر خود را درباره بیماری‌اش تغییر دهد. برای مثال، چندین مرحله یا چندین تمرین طراحی می‌شوند که بسیار شبیه به برنامه خود - یاری عمل می‌کند. این راهبرد شامل موارد زیر است:

- تعمق، تأمل یا تفکر درباره تغییر یافتن؛

• تأکید بر این موضوع که فرد آگاهانه و حساب شده و توأم با تعمق و تأمل برای تغییر تصمیم بگیرد؛

• این فکر که همه چیز تغییر خواهد کرد؛

• اطمینان از اینکه از هرگونه تغییری حمایت می شود.

یکی از مؤلفه های موجود در چنین برنامه ای، نظارت و بازبینی بر پرخوری و یادداشت افکار، احساسات و هیجانات فرد در حین پرخوری است. مؤلفه و جزء مهم دیگر این برنامه، «کنترل ذهن»^۱ است. از این رو، این راهبرد شامل کمک و یاری به افراد برای درک این موضوع است که چگونه احساس عدم کنترل کرده اند، همچنین کمک به آنها برای به دست آوردن مجدد کنترل. در این راهبرد، به افراد کمک می شود تا دریابند تفکرات و هیجان های آنان درباره یک واقعه خاص که در زندگی شان رخ داده و منجر به تنیدگی و پرخوری شده، چه بوده است. اغلب این کار را می توان در جلسات گروه درمانی که یک سری بحث و گفت و گوهایی بین افراد مبتلا به پرخوری عصبی صورت می گیرد، انجام داد و به نتیجه خوبی دست یافت.

در مروری بر ادبیات که توسط میتچل و اکرت^۲ (۱۹۸۷) صورت گرفت، مشاهده شد که بسیاری از روان درمانگران سعی می کنند شناخت - رفتار درمانی را برای درمان پرخوری عصبی به کار گیرند. البته اگرچه روان درمانگران شناختی - رفتاری از نظر شیوه های مورد استفاده و راهبردهای به کار گرفته شده تفاوت دارند، اما همه آنها بر موضوعات زیر تأکید می کنند:

• مشاوره غذایی با تأکید بر ایجاد الگوهای نرمال و بهنجار خوردن؛

• آموزش جرأت ورزی و تنش زدایی^۳؛

• راهبردهای کنترل محرک، تأخیر در پاسخ دهی و حل مسئله؛

• خودبازبینی و خودکنترلی.

درمان افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی، با دارو نیز امکان پذیر است، اگرچه نتایج در این مورد دویپهلوست و ابهام دارد. داروهای ذکر شده در زیر، از جمله داروهایی هستند که به کار برده شده و به نتایج متفاوتی منجر شده اند، داروهای ضد روان پریشی و ضد افسردگی از جمله لیتیوم. با این حال، لیتیوم باید برای افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی که دچار بی نظمی هایی در ترکیبات درونی بدنشان شده اند و مشکلات قلبی دارند، با احتیاط تجویز شود. بعضی موفقیت ها نیز برای درمان پرخوری عصبی با ضد افسردگی ها گزارش شده است (هیون، ۱۹۹۶).

^۱ . mind control

^۲ . Mitchel & Eckert

^۳ . relaxation

خلاصه

به طور کلی، به نظر می‌رسد هنجارهای نیرومند فرهنگی - اجتماعی برای تعریف جذابیت فیزیکی در مردان و زنان وجود داشته باشد. زنان علاقه بیشتری به زیبایی، خوش اندام و جذاب بودن دارند. مردان نیز دوست دارند عضلات قوی و شانه‌های پهن داشته باشند. اگرچه هنجارها برای هر دو جنس در نظر گرفته می‌شوند، اما تحقیقات نشان داده‌اند که زنان خیلی بیشتر از مردان نسبت به این ایده‌آل‌ها برای جذابیت و زیبایی جسمانی حساس‌اند. بی‌گمان این موردی است که در نوجوانی تظاهر شدیدتری پیدا می‌کند. می‌دانیم که سال‌های نوجوانی، با تغییرات و دگرگونی‌های فیزیکی و هیجانی همراه است. در این زمان، نوجوانان فشاری را برای همسان شدن با این ایده‌آل‌ها در مورد جذابیت و داشتن ظاهری زیبا، هم از طرف همسالان و هم از طرف خود تحمل می‌کنند. بنابراین عجیب نیست که نوجوانان و جوانان از وزن و شکل بدن خود ناراضی‌اند.

دوره بلوغ و تغییرات فیزیکی مرتبط با آن، به عنوان یک عامل اساسی راه‌انداز نگرانی درباره تصور بدنی است. هر چند تفاوت‌هایی در ادراک تصور بدنی از نظر جنسی وجود دارد، اما دختران بیشتر نگران لاغری و جذابیت خود و پسران بیشتر نگران قدرت بدنی و جسمانی خود می‌باشند.

این تفاوت در ادراکات، تأثیر مهمی بر رفتارهای خوردن دارد و موجب می‌شود دختران بیش از پسران تلاش کنند که وزن خود را با رعایت رژیم و سایر وسایل، کنترل کنند. از این رو، شاخص اختلالات خوردن در دختران بیشتر از پسران است و اوج آن در نوجوانی و سال‌های اولیه بزرگسالی است. اختلالات خوردن، خطرهایی را برای سلامت جسمانی و روانی نوجوانان در پی دارد، به علاوه بی‌اشتهایی عصبی میزان مرگ و میر زیادی در حدود ۱۰ درصد به همراه دارد. به همین دلیل، نگرانی و مشکل بسیاری از نوجوانان، ایجاد توازن و تعادل بین تقاضاهای فرهنگی برای جذابیت و سلامت جسمانی خودشان است.

پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

- (۱) چگونه ممکن است اختلالات خوردن با سبک‌های مقابله‌ای در ارتباط باشند؟
- (۲) به نظر شما اختلالات خوردن بیشتر ناشی از عوامل فطری و ژنتیکی‌اند یا ناشی از عوامل روانی - اجتماعی؟

فصل چهارم

مشکلات و مسائل جنسی

سال‌های نوجوانی، با بیداری و تظاهرات جنسی و هویت‌یابی جنسیتی همراه است. هویت‌یابی جنسیتی، فرایندی بسیار پیچیده است و رابطه‌ی نزدیکی با هویت شخصی دارد. در طول این دوره، نوجوانان درمی‌یابند که کیستند و پرسش‌هایی برای آنها درباره‌ی شکل‌گیری هویت جنسی، مطرح می‌شود. بیداری و تظاهرات جنسی، اغلب رویه‌های مختلفی از تمایلات جنسی را آشکار می‌کند. نوجوان از یک طرف از لحاظ فیزیکی تحول می‌یابد، از سوی دیگر با چالش‌های روان‌شناختی و اغلب علاقه‌ی جنسی به جنس مخالف یا به همجنس خود، کشاننده‌های جنسی و آمادگی جنسی روبه‌رو می‌شود (میلر و دیک^۱، ۱۹۹۳).

این بیداری جنسی برای بسیاری از نوجوانان ممکن است اضطراب‌آور و آشفته‌ساز باشد، اگرچه احتمال دارد نوجوان از لحاظ فیزیکی آماده‌ی انجام فعالیت جنسی باشد، اما ممکن است از لحاظ هیجانی آماده‌ی پذیرش پیامدها و مسئولیت‌های مرتبط با چنین رفتاری نباشد. از طرفی، عده‌ای از نوجوانان در این دوره مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند.

در پژوهشی اوگن و بلک استون^۲ (۲۰۰۴)، به بررسی آزار و اذیت جنسی در کارگران نوجوان پرداختند. آنها طی مطالعه‌ی میدانی کوچک و با مصاحبه‌های طولانی با ۷۰۰ دختر و پسر نوجوان کارگر، دریافتند که نه تنها دختران نوجوان در معرض آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند و از این نظر آسیب‌پذیرند، بلکه پسران نوجوانی که فاقد کلیشه‌های جنسیتی مردانه‌اند نیز آسیب‌پذیرند. آنان دریافتند پسران نوجوانی که تمایلی به شنیدن شوخی‌ها و لطیفه‌های جنسی نشان ندهند، از نظر مالی مشکلاتی داشته باشند یا در خانه بیشتر در امور خانه‌داری و منزل مشارکت کنند، هدف آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. آنان نتیجه گرفتند که آزار و اذیت جنسی می‌تواند از طرف یک همجنس یا از طرف مردان نسبت به زنان صورت گیرد. اگرچه پسران نوجوانی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند، هرگز در مورد این موضوع با کسی صحبتی نمی‌کنند، اما ۱۳ دختر نوجوان و ۱۷ پسر نوجوان مورد مطالعه، گزارش کرده بودند که مورد آزار و اذیت جنسی واقع شده‌اند.

^۱ . Miller & Dyk

^۲ . Uggan & Blackstone

این گزارش‌ها و خطر ابتلا به اختلالات مقاربتی قابل انتقال نظیر ایدز، نیاز به افزایش آگاهی‌های عمومی و اجتماعی را دربارهٔ تمایلات جنسی در دورهٔ نوجوانی افزایش می‌دهد. امروزه فعالیت جنسی در دورهٔ نوجوانی و تلویحات مهمی که برای حالات سلامت نوجوانان بویژه از نظر ابتلا به HIV در بردارد، در کانون توجه قرار گرفته است. شواهد نشان می‌دهند احتمال افزایش عفونت ایدز در میان نوجوانان، زیاد است، مگر اینکه آموزش اعمال جنسی سالم به‌صورت دائم انجام گیرد. با توجه به اهمیت مشکلات جنسی در نوجوانان، در این فصل به بررسی تمایلات جنسی در دورهٔ نوجوانی و ارتباط آن با بیماری مسری ایدز می‌پردازیم. در مورد سوگیری‌های جنسی نوجوانان، تحول جنسی آنان و همچنین نگرش‌هایی که در مورد استفاده از کاندوم وجود دارد، به بحث خواهیم پرداخت. این بحث را از تحول جنسی شروع می‌کنیم.

تحول جنسی

آگاهی نوجوان از هویت جنسی خود یک مفهوم درهم‌تنیده با تحول جنسی است. احتمالاً ترجیحات و رجحان‌های جنسی بیشتر دختران و پسران، در دورهٔ نوجوانی و هنگام بلوغ تعیین می‌شود. تعداد بسیار کمی از نوجوانان دارای تمایلات همجنس‌خواهانه و بیشتر آنها دارای تمایلات دگرجنس‌خواهانه‌اند. تلاش برای به‌دست آوردن هویت شخصی نیز فرایندی تأثیرگذار بر هویت‌یابی جنسی است (اریکسون، ۱۹۶۸). دست‌یابی نوجوانان به هویت شخصی، اهمیت زیادی دارد و به معنای تحقق یافتن این است که آنها چه کسانی هستند، و بسیار مهم‌تر اینکه نوجوانان خود را به‌عنوان یک فرد واحد، یگانه و ارزشمند بپذیرند. این مسئله در تحول هیجانی آنها در آینده نقشی حیاتی دارد.

تظاهرات جنسی یا فرایند بیداری جنسی توسط سارل و سارل^۱ (۱۹۸۱) به‌صورت زیر شرح داده شده است:

- افراد (بویژه نوجوانان)، باید حقایق را دربارهٔ اندام‌های تناسلی خود بیاموزند و تغییرات بدنی و فیزیکی‌ای را که در درون آنها رخ می‌دهد، درک کنند و بفهمند؛
- نوجوانان نیاز دارند که بر احساس گناه، شرمساری و ترس دربارهٔ افکار جنسی، رؤیاها و خیال‌پردازی‌ها و رفتارهای جنسی خود غلبه کنند. آنها باید به سطحی برسند که دربارهٔ این موضوعات احساس امنیت، راحتی و پذیرش داشته باشند؛

^۱ . Sarrel & Sarrel

- نوجوانان باید یاد بگیرند بین مسائلی که به لحاظ جنسی مطلوب و نامطلوب است، تمایز قائل شوند. لازم است این نگرش‌ها به همسالان آنها منتقل شود؛
- نوجوانان باید در شرایطی قرار بگیرند که تعارضات و آشفتگی‌های خود را دربارهٔ سوگیری‌های جنسی‌شان حل کنند؛
- نوجوانان باید برای زندگی جنسی رضایت‌بخش که رها از هرگونه انحراف باشد، تلاش کنند؛
- بسیار مهم است که نوجوان در مورد خود به‌عنوان شخصی دارای جنسیت آگاهی داشته باشد، همچنین از ارزش زندگی جنسی افراد به‌طور کلی آگاه باشد. فرد باید از گزینه‌های جنسی مختلف نظیر تأهل و مجرد نیز آگاه باشد.
- فرایند آشکار شدن و بیداری تظاهرات جنسی، با آگاهی از تغییرات بدنی و فیزیکی در اوایل نوجوانی شروع می‌شود و بعدها با آگاهی از خود به‌عنوان یک موجود جنسی خاتمه می‌یابد، این وضعیت در بهترین حالت، یک الگوی نظری از تظاهرات جنسی است.
- روشن نیست تا چه حد نوجوانان ۱۸ و ۱۹ ساله به خودشان به‌عنوان موجود جنسی می‌نگرند و چقدر برای دستیابی به زندگی جنسی رضایت‌بخش تلاش می‌کنند.
- برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که پسران و دختران در ۱۱ تا ۱۳ سالگی دست به عمل استمناء می‌زنند. رفتار اجتماعی جنسی، مراحل و درجات مختلفی دارد که شامل ارتباط جنسی، اعمال جنسی و نوازش جنسی با جنس مخالف است. بنابراین، این مراحل از اشکال کمتر صمیمانهٔ جنسیتی به طرف اشکال صمیمانه‌تر گسترش می‌یابند. استمناء نیز ممکن است به صورت شبانه و رسیدن به لذت جنسی باشد.
- نوجوانان در سطوح مختلفی از بلوغ شناختی قرار دارند و بعضی از آنها ممکن است حتی تا سال‌ها بعد به مرحلهٔ نهایی ارائه‌شده در این الگو نرسند. همچنین تمام نوجوانان فرصت‌ها و انگیزه‌های یکسان و مشابهی برای فعال شدن از لحاظ جنسی به صورتی که این الگو پیشنهاد می‌کند، ندارند. در نهایت اینکه افراد حتی در سال‌های بزرگسالی هم با شکل‌گیری هویت جنسی دست و پنجه نرم می‌کنند و یا سوگیری‌های جنسی متفاوتی پیدا می‌کنند.
- به‌نظر می‌رسد نوجوانان در سال‌های اول نوجوانی به آزمایش مسائل جنسی می‌پردازند. این دیدگاه با توجه به نتایج پژوهش‌های بین‌فرهنگی شکل گرفته است. مطالعه‌ای که در سال ۱۹۷۱ در آمریکا بر روی نوجوانان صورت گرفت، نشان داد که در حدود ۳۰ درصد نوجوانان دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله که هنوز ازدواج نکرده بودند، تجربهٔ رابطهٔ جنسی و عمل جنسی داشتند و در سال ۱۹۷۹ این

تعداد به ۵۰ درصد رسیده بود (بیکر، ثالبرگ و موریسون^۱، ۱۹۸۸). در یک مطالعه استرالیایی که توسط زابریک^۲ و همکاران (۱۹۹۵) انجام شد، ۲۱ درصد نوجوانان گزارش کردند که در ۱۳ سالگی رابطه جنسی را تجربه کردند و ۴۳ درصد اظهار داشتند بین ۱۵ تا ۱۶ سالگی تجربه عمل جنسی داشته‌اند.

در ایالت متحده آمریکا، میانگین سن برای اولین تجربه جنسی در یک نمونه ناهمگون کالیفرنایی، برای پسران ۱۳/۵ سالگی و برای دختران ۱۴ سالگی بود. بیش از پنجاه درصد این نمونه که نوجوانان دبیرستانی بودند، اشاره کردند که روابط جنسی داشتند (لی لاند و بارث^۳، ۱۹۹۲). محققان برزیلی نیز دریافتند که میانگین سن اولین تجربه عمل جنسی برای پسران و دختران بین ۱۳ سال و ۷ ماهگی تا ۱۵ سالگی بود (اوسوالد و پفور^۴، ۱۹۹۲). در یک مطالعه فرانسوی که بر روی ۴۰۰۰ نوجوان انجام شد نیز مشاهده شد ۱۶ درصد دختران و پسران نوجوان که سنشان کمتر از ۱۳ سال بود، گزارش کردند دارای روابط جنسی‌اند. این ارقام برای نوجوانان بالاتر از ۱۸ سال پسر ۷۰ درصد و در مورد دختران ۴۴ درصد گزارش شد (چوکویت و مانفردی^۵، ۱۹۹۲). به نظر می‌رسد بخش به نسبت بزرگی از نوجوانان در روابط جنسی نامشروع درگیر می‌شوند.

متأسفانه به دلایل و محدودیت‌های فرهنگی - اجتماعی در کشور ما هیچ‌گونه آمار و ارقام دقیقی در مورد سن و تعداد نوجوانان و جوانانی که رابطه جنسی را تجربه کرده‌اند، وجود ندارد.

هنجارهای مربوط به رفتار جنسی بسیار متفاوت و تغییرپذیرند و فرهنگ‌های مختلف نسبت به رفتار جنسی نگرش‌های متنوعی دارند. رفتار جنسی یک بعد مهم تعامل اجتماعی و فعالیت جنسی جزء آشکار هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. با گسترش ارتباطات، صنعتی شدن و شهرگرایی، روابط جنسی هر چه بیشتر شکل می‌گیرد و به موازات آن نابهنجاری‌های رفتار جنسی نیز گسترش می‌یابد، بخصوص در میان نوجوانان و جوانان هر جامعه‌ای.

علمی (۱۳۸۵) انحرافات جنسی نوجوانان و ارتباط آن را با محیط خانواده مورد بررسی قرار داد. این محقق طی یک مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد ۶۰ نوجوان مجرم جنسی که در کانون اصلاح و تربیت شهر تبریز ساکن بودند را با استفاده از مصاحبه بالینی مورد مطالعه قرار داد. نتایج پژوهش او نشان داد که عمده‌ترین انگیزه این نوجوانان برای دست زدن به عمل جنسی انحرافی عبارت بودند از: کسب لذت جنسی، فرو نشانیدن میل جنسی، ارضای حس کنجکاوی و تفریح و ابراز قدرت جهت

^۱ . Baker, Thalberg & Morrison

^۲ . Zubrick

^۳ . Leland & Barth

^۴ . Oswald & Pforr

^۵ . Choquet & Manfredi

تحمیل عقاید. عمده‌ترین عوامل مؤثر در انجام این عمل نیز شامل موارد زیر بود: عدم نظارت والدین، داشتن دوستان ناباب، ضعف اعتقادات دینی و اخلاقی، نداشتن آگاهی‌های لازم در مورد مسایل جنسی و در دسترس بودن امکان انجام اعمال انحرافی. همچنین مشاهده شد که بین شیوه جامعه‌پذیری در خانواده و دست زدن به رفتار جنسی انحرافی رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان برخورداری از آگاهی‌های جنسی و ارتکاب رفتارهای جنسی نیز رابطه معناداری مشاهده شد.

انحرافات جنسی در نوجوانان و جوانان به صورت کامجویی‌های بدلی (استمناء، همجنس‌بازی، نظربازی، بچه‌بازی و خودفروشی) بروز می‌کند. کامجویی‌های بدلی که انحراف از مسیر صحیح ارضای جنسی است و به انحراف جنسی تعبیر می‌شود، آمار رسمی و دقیقی ندارد و در جوامع مختلف متفاوت است. آمار رسمی انحرافات مربوط به مسائل جنسی که در مراجع قضایی در سال ۱۳۶۱ در کشورمان رخ داده، در سه مورد گزارش شده است (مرکز آمار ایران، ۱۳۶۱). این آمار را در جدول ۴-۱ مشاهده می‌کنید.

جدول ۴-۱. آمار انحرافات جنسی در نوجوانان و جوانان در سال ۱۳۶۱

درصد	نوع انحرافات
۲۷/۳	جرایم نسبت به اطفال یا آزار و اذیت جنسی کودکان
۱۱	دایر کردن اماکن فساد
۱۲/۹	ایجاد مزاحمت برای بانوان

کامجویی‌های بدلی معلول علل زیر است:

(۱) انحراف جنسی در اثر اختلال شخصیتی. گاه انحرافات جنسی نوجوانان ناشی از اختلالات شخصیتی آنان است. در این‌باره فرخ (۱۳۵۱) در تحقیق درمورد ۳۰۰ مجرم جنسی دریافت که ۱۴ درصد آنان از نظر روانی عادی بوده، ۲۹ درصد به بیماری‌های خفیف نورویتیک، ۳۵ درصد به بیماری‌های شدید نورویتیک، ۸ درصد به سایکوز، ۱۲ درصد به بیماری روانی، ۵ درصد مبتلا به آسیب مغزی، ۳ درصد مبتلا به شخصیت ضداجتماعی و ۴ درصد به نقص عقلی و ذهنی مبتلا بودند.

(۲) نقص در تربیت اولیه جنسی، که در دوران طفولیت تمرین شده و به صورت عادت در آمده است.

(۳) ناکامی‌های محیطی و اجتماعی.

بدون توجه به عواقب اجتماعی، اخلاقی و سلامتی برقراری عمل جنسی در نوجوانان، این روابط برای نوجوانان، واقعه روان‌شناختی مهم و خطیری به حساب می‌آید. همچنین، این روابط منجر به بروز دامنه‌ای از هیجانات کاملاً متفاوت در آنان می‌شود، که اغلب شامل احساس اضطراب، لذت، کنجکاوی و گناه است.

کنترل میل جنسی

تمام نوجوانان در روابط جنسی درگیر نمی‌شوند. لی‌لاند و بارث (۱۹۹۲) به مطالعه ۱۰۰۰ دانش‌آموز دبیرستانی پرداختند. در این پژوهش از آزمودنی‌ها خواسته شده بود دلایلی را برای امتناع و خودداری از برقراری عمل جنسی ایراد کنند، این دلایل در جدول زیر خلاصه شده است.

جدول ۴-۲. دلایلی برای نداشتن روابط و عمل جنسی

دلیل	پسران (به درصد)	دختران (به درصد)
ترس از ابتلا به ایدز و دیگر بیماری‌های مقاربتی	۳۰/۷	۴۰/۱
عدم آمادگی	۴۰/۳	۷۱/۴
نداشتن دوست دختر یا دوست پسر یا هر کس دیگری	۳۸/۲	۳۱
ارزش‌ها - مذهب	۱۳/۷	۳۱/۶
خواسته‌های والدین	۱۱/۶	۳۷/۷
دلایل دیگر	۱۵	۲۹/۳

منبع: برگرفته از لی‌لاند و بارث، ۱۹۹۲

بیشتر آزمودنی‌ها از ابتلا به بیماری‌های مقاربتی انتقالی نظیر ایدز ترس داشتند، البته دختران نگرانی بیشتری در این زمینه نشان دادند تا پسران. به‌طور کلی، دختران در مقایسه با پسران، بیشتر به دلایل و ارزش‌های شخصی و مذهبی، همچنین به دلیل پیروی از خواسته‌های والدین و عدم آمادگی برای عمل جنسی، بیشتر از پسران از عمل جنسی خودداری می‌کردند.

مک کران مک کی^۱ و همکاران (۲۰۰۴)، به ارزیابی تأثیر برنامه‌های اردوگاهی خانوادگی در کاهش خطر ابتلا به ویروس HIV در نوجوانان پرداختند. نتایج نشان داد که برنامه‌های مداخله‌ای

^۱. McKernan - McKey

خانوادگی در کاهش مدت زمانی که نوجوانان صرف فعالیت جنسی می‌کنند و در به تأخیر انداختن شروع فعالیت جنسی توسط آنان نقش زیادی دارد. شایان ذکر است که نوجوانان شرکت‌کننده در این مطالعه، در روستایی در مجاورت محدوده‌ای زندگی می‌کردند که اردوگاهی برای نگهداری از افراد مبتلا به ویروس HIV دایر شده بود.

هویت همجنس‌خواه

بسیاری از کودکان در بازی‌های جنسی با اعضای همجنس خود درگیر می‌شوند. همان‌گونه‌که کاتچادورین^۱ (۱۹۹۰) خاطر نشان ساخته، چنین رفتاری ماهیتی اکتشافی دارد و بسیار گذراست. بیشتر بزرگسالان همجنس‌خواه منشأ و شروع هویت جنسی خود را مربوط به فعالیت جنسی سال‌های نوجوانی خود اعلام کردند. به‌علاوه، احتمال کمی وجود دارد که مردان همجنس‌خواه در دوره نوجوانی خود عمل جنسی با جنس مخالف را تجربه کرده باشند تا مردان دگرجنس‌خواه. بنابراین، دوره نوجوانی زمان مهمی برای شکل‌گیری هویت همجنس‌خواه در بزرگسالی است. گوردون و گیلگان^۲ (۱۹۸۷)، اعتقاد دارند که هویت همجنس‌خواه در بزرگسالی تداوم هویتی است که در نوجوانی و در بعضی موارد در دوران کودکی شکل گرفته است.

چهار نظریه بیولوژیکی در زمینه تبیین سوگیری همجنس‌خواهانه وجود دارد. این نظریه‌ها اغلب بر سازوکارهای هورمونی، ساختار مغزی، عملکردهای عصب - روان‌شناختی و عوامل ژنتیکی تأکید می‌کنند. به‌نظر بانکرافت^۳ (۱۹۹۴)، حمایت تجربی از سه دیدگاه اول تا حدودی ضعیف است. او درباره نقش عوامل ژنتیکی، شواهدی را مبتنی بر مطالعه دوقلوها مطرح می‌کند که نشان می‌دهد نشانه‌های کروموزوم‌ها علت این مسئله است. چون ماهیت واقعی ژنوتیپ مشخص نیست، اعتقاد بر این است که عوامل روانی - اجتماعی نیز نقش برجسته‌ای در تحول جهت‌گیری جنسی دارند.

در نوجوانانی که از نظر جنسی به افراد همجنس خود جذب می‌شوند، این دوره از زندگی می‌تواند بسیار آشفته‌کننده و بحران‌زا باشد. این نوجوانان در دنیایی زندگی می‌کنند که بیشتر افراد دگرجنس‌خواه‌اند و از آنها انتظار می‌رود که به شیوه‌های دگرجنس‌خواهانه رفتار کنند. ازاین‌رو به‌زودی در می‌یابند که با دیگران متفاوت‌اند و با انتظارات دیگران تناسبی ندارند. این نوجوانان گاهی امیال عجیب و حتی ناخوشایندی دارند. این نوجوانان همجنس‌خواه خیلی زود یاد می‌گیرند که امیال

^۱ . Katchadourian

^۲ . Gordon & Gilligan

^۳ . Bancroft

خود را پنهان کنند و بر احساسات واقعی خود سرپوش بگذارند و دچار انزوا و جدایی از دوستان نزدیک خود شده و نسبت به گروه همسالان خود بیگانه می‌شوند.

گارنتس و کیمنل^۱ (۱۹۹۱)، چند مرحله را به‌عنوان مراحل تحولی شکل‌گیری هویت همجنس‌خواهانه تهیه و تدوین کرده‌اند:

- آگاهی اولیه از احساسات شهوانی - عاطفی همجنس‌خواهانه؛

- تجارب جنسی اولیه همجنس‌خواهانه؛

- مشخص کردن خود به عنوان زن یا مرد همجنس‌خواه؛

- هویت مثبت زن یا مرد همجنس‌خواه.

این نویسندگان معتقدند آگاهی اولیه نوجوانان در مورد اینکه از لحاظ جنسی مجذوب اعضای همجنس خود می‌شوند، در سال‌های اولیه نوجوانی رخ می‌دهد، برای بعضی در ۱۲ سالگی و برای برخی دیگر در سنین بالاتر. بعضی پسرها در حدود ۱۶ سالگی این تمایلات را تجربه می‌کنند. مشخص کردن خود به عنوان یک فرد همجنس‌خواه قبل از شکل‌گیری هویت مثبت یعنی بین ۳ تا ۶ سالگی قرار می‌گیرد. در مورد برخی افراد، این هویت ممکن است فقط طی سال‌های بزرگسالی رخ دهد و شکل بگیرد.

جوانان همجنس‌خواه و ایدز

بسیاری از جوانان همجنس‌خواه، نه تنها در سنین ذکر شده به دلیل احساس بیگانگی از جامعه کناره‌گیری می‌کنند، بلکه از جامعه همجنس‌خواهان نیز کنار گذاشته می‌شوند. این مسئله ممکن است اثری جدی روی شناخت و دانش آنها درباره ویروس HIV و اعمال سالم جنسی بگذارد (میلان و راس^۲، ۱۹۸۷).

جوانان همجنس‌خواه نسبت به مردان بزرگسال همجنس‌خواه از نظر منابع کسب اطلاعات درباره ایدز متفاوت‌اند. جوان‌ترها اطلاعات خود را از تلویزیون، رادیو، دوستان، زنان همجنس‌خواه، جزوه‌ها و متون به‌دست می‌آورند، درحالی‌که مردان مسن‌تر و بزرگ‌تر برای کسب اطلاع از ایدز، بیشتر به روزنامه‌ها رجوع می‌کنند. جوانان همجنس‌خواه در مقایسه با مردان بزرگسال همجنس‌خواه، برخلاف داشتن منابع گسترده‌تر کسب اطلاعات، به‌احتمال بیشتر گزارش می‌کنند که درباره ایدز اطلاعات کافی

^۱ . Garnets & Kimnel

^۲ . Millan & Ross

ندارند. این از جمله مهم‌ترین و جدی‌ترین نگرانی‌های سازمان‌های آموزشی و تخصصی حفظ سلامتی است.

میلان و راس (۱۹۸۷) در پژوهشی درمورد افراد همجنس‌خواه استرالیایی، مشاهده کردند جوانان همجنس‌خواه سبک زندگی یا عادات جنسی خود را برای مقابله با شیوع ویروس HIV کمتر تغییر می‌دهند. به نظر می‌رسد که مهیا کردن اطلاعات کافی درباره عفونت HIV و راهبردهای جنسی سالم، اولین گام برای مقابله با این بیماری باشد. در عمل، مشکلات زیاده‌تری بر سر راه تغییر رفتارهای جنسی وجود دارد.

مویندا^۱ (۲۰۰۴) معتقد است پرورش مشاوران زن برای ارائه اطلاعات جنسی سالم به دختران نوجوان، یکی از راهبردهای مؤثر برای پیشگیری از ابتلا به ویروس HIV در آنهاست. او در مطالعه خود ۱۴ مشاور زن را آموزش داد و به دهکده‌های اوگاندا فرستاد. نتایج پژوهش او نشان داد که در طول یک سال ۳۴۷ دختر نوجوان، ۴۰۳ مرتبه به این مشاوران رجوع کرده و از توصیه‌های بهداشتی و آموزش‌های آنان استفاده کردند. او نتیجه گرفت که این راهبرد پیشگیرانه با وجود مخالفت‌های اولیه دست‌اندرکاران جامعه با آن، به عنوان مداخله مؤثر شناخته شد که پلی بین روش‌های سنتی و روش‌های جدید برقرار کرده است.

نگرش نوجوانان به عمل جنسی

اولین رابطه و عمل جنسی

به نظر می‌رسد که واکنش‌های نوجوانان به اولین عمل جنسی‌شان تا حدودی نامشخص باشد. شایان ذکر است که پسران اولین عمل جنسی خود را مطلوب‌تر گزارش کرده‌اند. نتایج گزارشی نشان داد که ۱۱ درصد دختران از کاری که انجام داده‌اند، متأسف و ناراحت و ۲۳ درصد از کار خود راضی‌اند.

از میان نوجوانانی که تجربه جنسی مکرر داشته‌اند، ۳۰ درصد دختران گزارش کرده‌اند که از عمل جنسی لذت زیادی نبرده‌اند (کاتچادوریان، ۱۹۹۰). پژوهشی که بر روی جوانان و نوجوانان بزرگ‌تر انجام شد، نشان داد که پسران بیشتر از دختران گزارش کرده‌اند که در حین انجام اولین عمل جنسی، رضایت فیزیولوژیکی و روان‌شناختی داشته‌اند. همچنین احتمال اینکه دختران نسبت به پسران بیشتر اوقات از برقراری رابطه جنسی احساس گناه داشته باشند، بیشتر است.

^۱ . Muyinda

رفتار جنسی و کاندوم

بسیاری از نوجوانان، از سال‌های اولیه نوجوانی در فعالیت‌های جنسی درگیر می‌شوند. به‌نظر می‌رسد که تجارب جنسی این نوجوانان کاملاً پیچیده است و اعمال جنسی مختلفی را تجربه می‌کنند. این کار تأثیر زیادی بر سلامت نوجوانان می‌گذارد. بیشتر نوجوانان به‌صورت اتفاقی در فعالیت‌های جنسی درگیر می‌شوند و در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی جنسی قرار می‌گیرند. استفاده از کاندوم هنگام مقاربت جنسی، خطر ابتلا به عفونت‌هایی نظیر عفونت HIV را کاهش می‌دهد. بنابراین، بسیار مهم است که ما نگرش نوجوانان را در مورد استفاده از کاندوم بدانیم و شرایطی را که احتمال انجام این رفتار را کاهش یا افزایش می‌دهد، شناسایی کنیم. البته استفاده از کاندوم نباید فقط به عنوان عاملی برای کاهش خطر ابتلا به ایدز مدنظر قرار گیرد، یکی از جنبه‌های بااهمیت استفاده از کاندوم، جلوگیری از خطر حاملگی زودرس در دختران است. تعدادی از نوجوانان دختر، به سوزاک، سفلیس، عفونت‌های رحمی و مثانه‌ای مبتلا دارند. این اختلالات و بیماری‌ها نه تنها در اثر فعالیت جنسی اولیه عود می‌کنند و تشدید می‌شوند، بلکه در اثر استفاده دائمی از کاندوم نیز تشدید می‌شوند (بروکس گان و فورستنبرگ^۱، ۱۹۸۹).

به‌نظر کیاپوا^۲ (۲۰۰۴)، کارکنان مراکز سلامتی نیاز به آموزش بیشتری برای کمک به نوجوانان در زمینه موضوعات و مسائل سالم جنسی دارند. از آنجا که کارکنان مراکز سلامتی اطلاعات مهمی را در مورد مسائل جنسی به نوجوانان ارائه می‌دهند و نوجوانان اطلاعات کمی در مورد بیماری‌های مقاربتی جنسی و راه‌های پیشگیری از ابتلا به این بیماری‌ها دارند، از این‌رو لازم است که کارکنان آموزش داده شوند تا اولاً هنگام ارائه اطلاعات جنسی به نوجوانان محافظه‌کار نباشند، ثانیاً راه‌های برقراری رابطه جنسی سالم را به آنان معرفی کنند.

نقش کاندوم در پیشگیری از HIV در رفتار جنسی

شواهد نشان می‌دهند رفتار سالم جنسی همیشه ناشی از شناخت فرد درباره خطرهای ابتلا به عفونت‌ها و ویروس‌ها نیست.

پژوهشی که در استرالیا بر روی دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شد، نشان داد که ۸۳ درصد آزمودنی‌ها با اینکه اعتقاد داشتند کاندوم به پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی جنسی کمک می‌کند، ۳۸ درصد اظهار کردند زیاد در مورد ایدز فکر نمی‌کنند و این مسئله ذهن آنها را زیاد به خود

^۱ . Brooks - Gunn & Furstenherg

^۲ . Kiapiawa

مشغول نمی‌کند (بارلینگ و موره^۱، ۱۹۹۰). پس به نظر می‌رسد برخی نوجوانان میزان خطر ابتلا به ایدز را کم برآورد می‌کنند و ترجیح می‌دهند زیاد ذهن خود را با این فکر مشغول نکنند.

این شکاف بین نگرش‌ها و رفتارهای جنسی بین نوجوانان بزرگ‌تر نیز مشاهده شده است. یک گروه پژوهشی در مطالعه باورها و رفتارهای جنسی بیش از ۶۰۰ دانشجو، دریافت که بیش از نیمی از آنها به عمل جنسی و مقاربت دست می‌زنند. از این تعداد، ۲۵ درصد دارای روابط جنسی اتفاقی بودند و بیش از ۹۰ درصد آنها تصور می‌کردند که احتمال بسیار کم و ناچیزی وجود دارد که به ایدز مبتلا شوند. تعجب‌انگیز نیست که مشاهده شد چنین تصویری در مورد کم‌خطر بودن ابتلا به ایدز درباره رفتارهای خطرآفرین نیز وجود داشت. برای مثال، اگرچه همه آنها اعتقاد داشتند که رابطه جنسی نامشروع و غیرمحافظت‌شده با شریک جنسی، خطر ابتلا به عفونت و ویروس HIV را به دنبال دارد، اما فقط ۲۶ درصد آنها هنگام مقاربت جنسی با جنس مخالف و شریک جنسی خود از کاندوم استفاده می‌کردند. بنابراین شناخت اعمال جنسی سالم برای اینکه افراد به رفتارهای محافظت‌کننده و پیشگیرانه دست بزنند، به خودی خود و به تنهایی غیرکارآمد است.

تارتل^۲ و همکاران (۱۹۸۹) چندین دلیل برای تضاد بین شناخت و رفتار جنسی مطرح کردند. از یک سو، احتمال دارد نوجوانان تصور کنند که استفاده از کاندوم لذت جنسی را کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد، بنابراین، هنگامی که تصمیم می‌گیرند از کاندوم استفاده کنند یا نه، فواید و مضرات خاصی بر تصمیم‌گیری آنها اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، احتمال دارد که استفاده از کاندوم تحت تأثیر عوامل دیگری نظیر باورهای درباره مطلوبیت استفاده از آنها یا هنجارهای ذهنی درباره استفاده از کاندوم قرار داشته باشد. عوامل دیگر شامل تصورات نوجوانان از سازه‌های اجتماعی و عدم آسیب‌زایی و آسیب‌پذیری نسبت به خطر ابتلا به عفونت ایدز است.

شکاف بین شناخت فرد از ایدز و رفتار متناسب جنسی، به این دلیل است که نوجوانان تصور نمی‌کنند آنها هم در مقابل ابتلا به ایدز آسیب‌پذیر باشند. در مطالعه‌ای که زایمت^۳ و همکاران، (۱۹۹۲) بر روی جوانان سیاه‌پوست در مرکز شهری در آمریکا انجام دادند، تأکید بر این بود که عوامل زیر تا چه حد می‌توانند رفتارهای سالم را از نظر جنسی پیش‌بینی کنند: شناخت ایدز، باورها و اضطراب‌های اجتماعی درباره ایدز و تصور از خطر ابتلا به ویروس HIV.

محققان دریافتند که تغییر رفتار با این عوامل به صورت زیر ارتباط داشت: پسرانی که از میزان فراوانی فعالیت جنسی خود کم کرده بودند، نسبت به پسران دیگر، شناخت بیشتری در مورد ایدز

^۱ . Barling & Moore

^۲ . Turtle

^۳ . Zimet

داشتند. دخترانی که تعداد شریک‌های جنسی‌شان را کاهش داده بودند، در مقایسه با سایر دختران، شناخت بیشتری دربارهٔ ایدز داشتند. به‌طور مشابه، پسرانی که گزارش کرده بودند از میزان روابط جنسی خود کاسته‌اند، در مقایسه با آنهایی که این کار را نکرده بودند، باورهای اجتماعی دقیق‌تری در مورد ایدز داشتند. اگرچه در مورد دختران کاملاً عکس این مطلب صادق بود و محققان نتوانستند آن را تبیین کنند.

ویکلی^۱ (۲۰۰۴) نیز طرحی را با عنوان طرح ABC برای پیشگیری از ابتلای نوجوانان به ویروس HIV پیشنهاد کرده است. این طرح شامل سه مؤلفه است: A) توصیهٔ اکید به نوجوانان در این مورد که از برقراری رابطهٔ جنسی در طول سال‌های آسیب‌پذیری نوجوانی خودداری کنند؛ B) آگاه‌کردن نوجوانان از این موضوع که افرادی که ازدواج می‌کنند، از نظر جنسی کمتر بی‌بندوبارند و خطر ابتلا به ایدز به موازات افزایش و تعدد در انتخاب شریک جنسی، افزایش می‌یابد؛ C) آگاه‌کردن نوجوانان از این موضوع که استفاده از کاندوم، نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به ایدز دارد و استفادهٔ صحیح و دائمی از کاندوم خطر ابتلا به ایدز را کاهش می‌دهد، اگرچه خطر کاملاً رفع نمی‌شود.

فواید و مضرات کاندوم

نوجوانانی که به هنگام مقاربت و عمل جنسی از کاندوم استفاده می‌کنند، معتقدند این کار به کاهش ابتلا به بیماری‌های ویروسی جنسی کمک می‌کند. در عین حال، تعداد زیادی از نوجوانان تصور می‌کنند که استفاده از کاندوم لذت جنسی را از بین می‌برد و کاهش می‌دهد. اما پرسش این است که میزان کدام یک بیشتر است، احتمال اینکه نوجوانانی که تجربهٔ جنسی داشته‌اند، نگرش منفی در مورد استفاده از کاندوم داشته باشند یا احتمال اینکه نوجوانانی که فاقد چنین تجربیاتی هستند، نگرش منفی به استفاده از کاندوم داشته باشند.

به‌نظر پلک^۲ و همکاران (۱۹۹۱)، استدلال نوجوانان دربارهٔ استفاده از کاندوم، مبتنی بر تصویری است که از فواید و مضرات آن دارند. اگر از نظر نوجوانان مضرات استفاده از کاندوم بیشتر باشد، میزان اعمال جنسی سالم در آنان کاهش می‌یابد. براساس مطالعه‌ای که این محققان در آمریکا بر روی بیش از ۲۰۰۰ پسر انجام دادند، فواید و مضرات زیر در ارتباط با استفاده از کاندوم وجود دارد:

^۱ . Weekly

^۲ . Pleck

پیشگیری از حاملگی: فواید و مضرات شخصی، برای مثال نگرانی از حاملگی منجر به افزایش استفاده از کاندوم می‌شود. باور به اینکه یک دختر با استفاده از قرص‌های ضد حاملگی می‌تواند خطر حاملگی را کاهش دهد، استفاده از کاندوم را کاهش خواهد داد. مسئولیت برای جلوگیری از حاملگی: باور هنجاری، برای مثال اعتقاد به اینکه پسرها هم در مقابل کاهش حاملگی مسئول‌اند، میزان استفاده از کاندوم را افزایش می‌دهد. اجتناب از ایدز: باور به اینکه اجتناب از ابتلا به ایدز مهم است، استفاده از کاندوم را افزایش می‌دهد.

انتظارات شریک جنسی: خواسته‌ها و اصرار دختران موجب افزایش استفاده از کاندوم می‌شود. از بین رفتن یا کاهش لذت جنسی: تصور اینکه کاندوم لذت جنسی را از بین می‌برد، موجب کاهش استفاده از آن می‌شود.

برخی نوجوانان از ۱۲ سالگی به رفتارها و اعمال جنسی دست می‌زنند و این مسئله سبب می‌شود که این نوجوانان در معرض خطر ابتلا به ویروس ایدز قرار گیرند. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگرچه بسیاری از نوجوانان از خطر ابتلا به ایدز در اثر انجام عمل جنسی آگاهند، اما تعداد کمی از آنها به رفتارهای جنسی سالم از جمله استفاده از کاندوم هنگام مقاربت جنسی اقدام می‌کنند.

استدلال در مورد خطر و عدم آسیب‌پذیری

بعضی نویسندگان معتقدند نوجوانان استدلال رضایت‌بخشی درباره خطر ابتلا به ایدز و تصادفات دارند. گوردون^۱ (۱۹۹۰) از این موضوع به عنوان کمبودها و کاستی‌های کارکردهای شناختی یا «تأخیر عمومی تحولی» یاد می‌کند. به نظر می‌رسد این نوجوانان نمی‌توانند پیامدهای رفتار خود را به درستی ارزشیابی کنند، بلکه ترجیح می‌دهند این‌طور استدلال کنند که فقط یک‌بار برقراری رابطه جنسی بدون محافظ منجر به حاملگی یا بیماری‌ها و اختلالات انتقالی جنسی نمی‌شود. اگرچه ممکن است چنین نگرشی در میان عده خاصی از نوجوانان رایج باشد، اما به نظر می‌رسد که دیدگاهی عمومی باشد.

بعضی نوجوانان متعلق به گروه‌های اقلیت در آمریکا، در مقایسه با سایر گروه‌های قومی و نژادی، خود را کمتر در معرض خطر ابتلا به عفونت ایدز تصور می‌کنند. یک تبیین احتمالی برای این موضوع این است که احتمال دارد بعضی نوجوانان سیاه‌پوست به ایدز به منزله اختلالی نگاه کنند که خاص افراد همجنس‌خواه سفیدپوست است. چنین تصویری تأثیرات جدی و شدیدی بر اعمال سالم جنسی در آنان دارد. پس از آن، الکایند (۱۹۶۷؛ به نقل از گوردون، ۱۹۹۰)، مفهوم «افسانه شخصی» را

^۱ . Gordon

مطرح کرد. برخی صاحب نظران معتقدند نوجوانان در استدلال‌های خود درباره خطر، از خودمحوری شناختی استفاده می‌کنند. از این دیدگاه حمایت‌های تجربی نیز شده است. به‌طوری‌که محققان به بررسی رفتار واقعی نوجوانان و تصورات آنها از خطر پرداخته‌اند. نتایج نشان داده اگرچه بیشتر پاسخ‌دهندگان درباره اعمال جنسی سالم و ایدز دانش کافی دارند، اما این دانش همیشه در رفتار آنها منعکس نمی‌شود. شواهدی موجودند که نشان می‌دهند به احتمال زیاد نوجوانانی که رفتارهای جنسی خطرناک دارند، نمره‌های کمتری را در توانایی کنترل و کاهش ابتلا به ایدز دریافت می‌کنند. اگرچه کاملاً روشن شده که عفونت ایدز، اختلال خاص افراد مذکر همجنس‌خواه نیست و زنان دگرجنس‌خواه هم تا حد زیادی در معرض خطر ابتلا به آن قرار دارند، با این حال، محققان دریافتند زنان معتقدند که در مقایسه با مردان، کمتر در معرض ابتلا به ایدز قرار دارند (مور و روزنتال^۱، ۱۹۹۱؛ به نقل از هیون، ۱۹۹۶).

تشخیص و درمان ایدز

گفتیم نوجوانانی که از نظر جنسی فعال‌اند، در معرض خطر ابتلا به ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی قابل انتقال قرار دارند. نوجوانانی که رفتارهای بسیار خطرناک از نظر جنسی را شناسایی کرده‌اند، کمتر به عفونت ایدز مبتلا می‌شوند. با این حال، بیشتر نوجوانان ناقل و حامل ویروس، یا تجارب انتقالی داشته‌اند که در بیشتر زمینه‌یابی‌های انجام‌شده در مورد عفونت HIV در نوجوانان مدنظر قرار نگرفته یا تاریخچه دقیقی از رفتارهای خطرناک خود ارائه نکرده‌اند (استیفمن و ایرلز^۲، ۱۹۹۰؛ به نقل از دیکلمنت، هانسن و پانتون^۳، ۱۹۹۶).

به‌دلیل فاصله زمانی طولانی که بین عفونی شدن و ظهور علائم و نشانه‌های ابتلا به عفونت مزمن HIV وجود دارد، بیشتر نوجوانان مبتلا به ایدز، از بیمار بودن خود آگاهی ندارند. در حال حاضر، اطلاعات کافی در مورد تاریخچه طبیعی عفونت HIV در نوجوانان در مقایسه با کودکان و بزرگسالان وجود ندارد.

به‌نظر می‌رسد عفونت‌های قابل انتقال جنسی و سایر عفونت‌های مقاربتی، خطر ابتلا به عفونت HIV را افزایش می‌دهند، سایر عوامل خطرآفرین شامل تعدد شریک‌های جنسی، ماهیت اعمال جنسی و استفاده از داروهای تزریقی و آمپول‌هاست.

^۱ . Moore & Rozenenthal

^۲ . Stiffman & Earls

^۳ . Diclemente, Hansen & Ponton

تشخیص ایدز. از آنجا که بیشتر نوجوانان مبتلا به عفونت HIV بدون علامت و نشانه‌اند، تشخیص این عفونت بیشتر اوقات براساس وجود پادتن‌هایی در خون فردی که رفتارهای خطرآفرین داشته است، صورت می‌گیرد. از آنجا که ممکن است این پادتن‌ها شش ماه بعد از ابتلا به عفونت HIV به وجود آیند، انجام آزمایش‌های مکرر اغلب ضرورت دارد، بویژه اگر نوجوان در رفتارهای خطرآفرین درگیر باشد. روش تشخیص، شامل فرایند دومارحله‌ای است که در مرحله اول، خود فرد از نظر وجود پادتن خاصی مورد آزمایش قرار می‌گیرد، سپس نمونه‌های مثبت از طریق تجزیه شیمیایی الکتروفروریتیکی تأیید می‌شوند.

اگرچه هر نوجوانی که دارای فعالیت جنسی است، در معرض خطر ابتلا به عفونت HIV قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که افراد زیر باید از نظر ابتلا به عفونت HIV آزمایش شوند: نوجوانانی که با سایر مردها یا پسرها رابطه جنسی دارند؛ زنان یا مردانی که از داروهای تزریقی استفاده می‌کنند؛ زنان یا مردانی که با مصرف‌کنندگان داروهای تزریقی رابطه جنسی دارند؛ افرادی که با زنان یا مردانی که سابقه ابتلا به سایر بیماری‌های انتقالی جنسی دارند، رابطه جنسی دارند (بویژه بیماری‌های مربوط به زخم‌های آلت تناسلی)؛ زنانی که برای به دست آوردن مواد مخدر، پول، سرپناه یا اموال، تن به روابط جنسی می‌دهند؛ زنان یا مردانی که از خون یا فراورده‌های خونی استفاده می‌کنند؛ زنان یا مردانی که سابقه همخوابی و ارتباط جنسی با چهار نفر یا بیشتر را داشته‌اند یا شریک‌های جنسی متعددی دارند. بیشتر سازمان‌های مراقبتی نوجوانان توصیه می‌کنند که نوجوانان برای محرمانه ماندن نتایج آزمایش‌های مربوط به عفونت HIV، از آزمایش‌های بدون نام استفاده کنند.

افرادی که دارای عفونت‌های فرصت طلب همایند یا بازداری ایمنی شدید و عمیق‌اند (مقدار لیمپوسیت^۱ CD4 کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر مکعب در سلول‌های آنها)، اغلب به عنوان افراد مبتلا به ایدز تشخیص داده می‌شوند.

درمان ایدز. امروز درمان ایدز با داروهای آنتی‌ریتروویرال^۲ یا داروهایی که در مقابل عفونت‌های فرصت طلب محافظت ایجاد می‌کنند، براساس سطح بازداری ایمنی صورت می‌گیرد (سطح بازداری ایمنی با کمی کردن تعداد مطلق لیمپوسیت‌های دارای علائم سطحی CD4 تعیین می‌شود). در حال حاضر، توصیه می‌شود افرادی که مقدار CD4 آنها کمتر از ۵۰۰ میلی‌متر مکعب در هر سلول است، هر ۸ ساعت یکبار از قرص‌های زیدوودین^۳ دویست میلی‌گرمی استفاده کنند (مقدار طبیعی CD4 برابر با ۱۲۰۰ یا ۱۴۰۰ میلی‌متر مکعب در هر سلول است). بیمارانی که CD4 آنها کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر

^۱ . Lymphocyte

^۲ . antiretroviral

^۳ . Zidovudin

مکعب در سلول‌هاست، برای مبارزه با انگلی که عامل بیماری‌زاست^۱ و در همه جای بدن حضور دارد، باید از پروپیلاکسیس^۲ استفاده کنند (دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶). درمان خاص عفونت‌های همایند که همزمان در مبتلایان به عفونت HIV مشاهده می‌شود، از طریق ماهیت عامل بیماری‌زای تشخیص داده شده تعیین می‌شود. مراقبت‌های حمایتی روانی - اجتماعی و تغذیه‌ای در شرایط زندگی افراد مبتلا به HIV بسیار مهم است.

پیگیری. بیماران مبتلا به عفونت HIV، باید به‌طور منظم معاینه شوند. افرادی که CD4 آنها بیشتر از ۶۰۰ میلی‌متر مکعب در هر سلول است، باید هر شش ماه یک‌بار، افرادی که میزان CD4 آنها کمتر از ۶۰۰ میلی‌متر مکعب و بیشتر از ۲۰۰ میلی‌متر مکعب است، باید هر سه ماه یک‌بار و افرادی که CD4 آنها کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر مکعب است، باید هر ماه یک‌بار معاینه شوند.

به تمام افراد مبتلا به عفونت HIV، توصیه می‌شود که وضعیت HIV خود را حتماً به شریک جنسی خود یا افرادی که به‌صورت شریکی با آنها به تزیق می‌پردازند، اطلاع دهند تا آنها نیز آزمایش و معاینه شوند. به بیماران مبتلا به HIV که از نظر جنسی فعالیت خود را حفظ می‌کنند و ادامه می‌دهند، باید اخطار داده شود که رفتارهای جنسی کم‌خطر یا بی‌خطری داشته باشند تا بیماری خود را به دیگران انتقال ندهند. اگرچه استفاده از کاندوم کمک‌کننده است، اما کاندوم نمی‌تواند جانشینی برای تغییر رفتارهای جنسی یا پرهیز از برقراری روابط جنسی باشد.

در پژوهش سمندری (۱۳۸۳) نظر دانشجویان در مورد ابعاد اخلاقی - خانوادگی بیماری ایدز و نقش آن در پیشگیری از این بیماری مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه او توصیفی بود و گروه نمونه شامل ۳۷۴ دانشجوی مقطع کارشناسی در دانشگاه شهیدبهشتی بود. نتایج نشان داد ۱۲/۳ درصد آزمودنی‌ها اعتقاد داشتند انجام آزمایش HIV برای تشخیص ایدز قبل از ازدواج فرد را بدنام می‌کند، ۲/۱۳ درصد آنان اظهار کردند در صورت ابتلا به عفونت ایدز، همسر خود را در جریان نمی‌گذارند و ۲/۱۳ درصد آنان اظهار کردند حتی در صورت امکان ابتلا به ایدز حاضر به کنترل خود برای این که مبتلا نشوند، نیستند.

سلامت جنسی

یکی از جنبه‌های تربیت، تربیت جنسی است، به‌طوری‌که کودک در نوجوانی و بزرگسالی دچار انحراف جنسی و بی‌بندوباری نشود. دانشمندان مختلف برای سلامت جنسی تعاریف مختلفی ارائه

^۱ . pneumocystis carinii

^۲ . Prophylaxis

کرده‌اند و سلامت جنسی و شیوه برطرف کردن نیاز جنسی در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. باتوجه به منابع معتبر غربی و منابع اسلامی، فردی از نظر جنسی سالم است که اصول زیر درمورد او صدق کند (فلاحتی خشکناز، ۱۳۷۷):

- ۱) از جنسیت خود راضی باشد، پسر از پسر بودن و دختر از دختر بودن خود راضی باشد و در غیراین صورت دچار اشکال در هویت جنسی است؛
 - ۲) نیاز جنسی خود را از طریق جنس مخالف برطرف سازد، در غیراین صورت بیمار تلقی می‌شود و از دیدگاه اسلام انحراف جنسی حرام است؛
 - ۳) از رابطه جنسی لذت ببرد و در کمال آرامش و بدون بی‌قراری و اضطراب این نیاز طبیعی خود را برطرف سازد؛
 - ۴) نیاز جنسی باید از طریق طبیعی، یعنی از ناحیه ژنیتال (تناسلی) برطرف شود، بدیهی است در غیراین صورت انحراف جنسی تلقی می‌شود؛
 - ۵) نیاز جنسی باید باتوجه به فرهنگ و از راه مشروع ارضا شود (مانند هر نیاز دیگر) و از نظر اسلام تنها راه مشروع برطرف کردن این نیاز، ازدواج است.
- از نظر مکاتب مختلف روان‌پزشکی، اختلالات جنسی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ۱) اختلال در هویت‌یابی جنسیتی (مثل تغییر جنسیت‌طلبی و همجنس‌گرایی)، ۲) انحرافات جنسیتی (مانند یادگارپرستی) و ۳) اختلالات کنشی جنسی (مانند سردمزاجی و ناتوانی جنسی).
- باتوجه به مفاهیم انحرافات جنسی از نظر مکاتب غربی و باتوجه به مفاهیم اسلامی، به بحث درباره راه‌هایی که والدین باید به کار ببندند تا در آینده فرزندان آنها، بخصوص نوجوانان دچار انحراف جنسی نشوند، خواهیم پرداخت.
- ۱) از آنجا که کودکان نقش خود را از والدین می‌آموزند، والدین موظف‌اند رعایت شرم و حیا را در منزل بنمایند و بخصوص نواحی تناسلی خود را از کودکان بپوشانند، زیرا در غیر صورت این مسئله منجر به آگاهی زودتر از معمول کودکان و احیاناً انحرافات در آینده خواهد شد.
 - ۲) آموزش محارم به کودکان و تشویق آنان به رعایت آن. این مسئله باید از طرف والدین نیز رعایت شود، زیرا کودکان رفتار والدین را تقلید می‌کنند.
 - ۳) رعایت حجاب در نزد کودکان و نوجوانان برای پیشگیری از تحریک جنسی در آنان.
 - ۴) جدا کردن اتاق خواب کودک از اتاق و محل خواب والدین.
 - ۵) انتخاب لباس‌های متناسب با جنسیت کودک.

۶) اگر کودکان بویژه در سنین پیش دبستانی پرسش‌هایی درمورد جنسیت خود و دیگران و تفاوت‌های جنسی و چگونگی تولد فرزند دارند، این پرسش‌ها را باید حمل بر کنجکاوی کودکان کرد، زیرا کودکان در این سن شروع به هویت‌یابی جنسیتی خود می‌کنند. از این‌رو بهتر است این پرسش‌ها را سرکوب نکنید یا پاسخ دروغ و اشتباه به آنها ندهید و سعی کنید پاسخی به زبان کودکانه با نشان دادن تصاویری از جنین و مراحل بزرگ شدن آن به آنها بدهید.

۷) بهتر است همبازی‌های کودک از جنس خود او باشند، این کار به همانندسازی جنسی صحیح او کمک زیادی می‌کند.

۸) در سنین بلوغ مسائل مختلفی چون قاعدگی برای دختران و احتلام برای پسران پیش می‌آید که باید به زبان ساده برای کودک یا نوجوان توضیح داده شود تا دچار ترس و وحشت نگردد، همچنین مسائل بهداشتی و احکام دینی مربوط به این مسائل باید به آنها آموزش داده شود.

۹) با کودک و نوجوان خود علاوه بر پدر و مادر بودن، دوست باشید. فقط پدر و مادر بودن کافی نیست. بسیاری از کودکان و نوجوانان مشکلات خود را با دوستان خود در میان می‌گذارند، دوستانی که خود بیش از آنها نمی‌دانند و چه بسا راهنمایی‌ها و آموزش‌های نادرستی در این بین انجام گیرد و بدآموزی‌ها و انحرافات صورت بگیرد. در صورتی که اگر والدین با فرزند خود دوست باشند و رابطه‌ای صمیمی داشته باشند، کودک مشکلات و مسائل خود را با والدین در میان خواهند گذاشت و از بسیاری از نابسامانی‌های جنسی پیشگیری خواهد شد (فلاحی خشک‌ناب، ۱۳۷۷).

خلاصه

این فصل با مطرح کردن این موضوع که نوجوانی دوره تحول جنسی است، شروع شد و گفتیم اگرچه فرایند هویت‌یابی جنسیتی برای بعضی نوجوانان خیلی سریع رخ می‌دهد، ولی برای برخی دیگر یک رخداد معمولی است. بعضی نوجوانان از ۱۲ سالگی در روابط جنسی درگیر می‌شوند، درحالی‌که بیشتر آنان در اواخر دهه دوم زندگی خود اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند. بعضی از آنان با افراد خودفروش رابطه جنسی دارند و بسیاری از آنها با افراد زیادی ارتباط جنسی برقرار می‌کنند و اعتقادی به تک‌همسری ندارند، از این‌رو بیشتر در معرض خطر ابتلا به عفونت HIV و سایر بیماری‌های مقاربتی و اختلالات انتقالی جنسی قرار دارند.

ادبیات تحقیق نشان داده است که بیشتر نوجوانان دربارهٔ خطرهای ناشی از درگیری در روابط جنسی بدون محافظت آگاهی دارند. با این حال، به نظر می‌رسد که تعداد کمی از آنان دست به اعمال جنسی سالم بزنند. بهترین تبیین برای این مسئله این است که آنها خود را در مقابل ابتلا به عفونت HIV آسیب‌پذیر نمی‌دانند. از این رو یکی از وظایف مهم سازمان‌های بهداشتی و پزشکی، آگاه کردن جوانان از رفتارهای سالم جنسی از جمله استفاده از کاندوم هنگام مقاربت است.

به‌طور کلی، نوجوانان در مقایسه با سایر اقشار جامعه، بیشتر در معرض خطر ابتلا به ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی قرار دارند و دلایل این موضوع مربوط به ترکیب عوامل پیچیده زیست‌شناختی، رفتاری و روانی اجتماعی است. آثار نامطلوبی که این عفونت‌ها بر سلامت نوجوانان دارند، همیشه از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، اما در مورد عفونت HIV، باید نوجوانان را آگاه کرد تا بتوانند نگرش‌ها و رفتارهای خود را برای اجتناب از پیامدهای مخرب، مصیبت‌بار و زیان‌آور بالقوهٔ آن تغییر دهند.

در انتهای فصل نیز به تعریف سلامت جنسی پرداختیم و گفتیم که در فرهنگ‌های مختلف تعاریف مختلفی از سلامت جنسی می‌شود. در ادامه راهکارهایی را برای تربیت صحیح جنسی کودکان به والدین توصیه شد.

پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

- (۱) به نظر شما نحوهٔ پوشش و لباس تا چه حد می‌تواند از اختلالات و کجروی‌های جنسی پیشگیری کند؟
- (۲) آیا صحیح است که برنامه‌های آموزش جنسی را در برنامه‌های درسی دورهٔ دبیرستان بگنجانیم؟

فصل پنجم

حاملگی در نوجوانان

یکی از عوامل نگران‌کننده از نظر اجتماعی و اقتصادی در چند دهه اخیر، حاملگی نوجوانان در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته است. به دنیا آوردن کودک در نوجوانی، عواقب وخیمی از نظر اجتماعی و سلامت جسمانی و روانی برای بیشتر مادران نوجوان و کودکان آنان به دنبال دارد. نتایج تحقیقات گسترده‌ای که در کشورهای غربی طی ۳۰ سال گذشته در این مورد صورت گرفته، نشان داده است که حاملگی، پیشرفت تحصیلی و فرصت‌های شغلی نوجوانان دختر را بسیار محدود می‌سازد و کاهش می‌دهد. به علاوه، این مشکل نقش مهمی در فقر، که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های محرومیت اجتماعی - اقتصادی در جوامع مختلف است، دارد و به افزایش فقر در جوامع منجر می‌شود. انجمن تحقیقات ملی آمریکا پس از مطالعه عمیق و گسترده ادبیات، به این نتیجه رسید زنانی که در نوجوانی مادر می‌شوند، نسبت به زنانی که پس از بیست‌سالگی مادر می‌شوند، بیشتر در معرض خطر تجربه کردن محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند. آنها شانس کمی برای ادامه تحصیل دارند، نمی‌توانند کاری داشته باشند، درآمدی ندارند و احتمال کمی وجود دارد که ازدواج موفق و شادی داشته باشند و به احتمال زیاد خانواده‌های پرجمعیتی دارند و از رفاه و آسایش کمی برخوردارند. شکست تحصیلی و وابستگی مالی - اقتصادی، دو مورد از مهم‌ترین، جدی‌ترین و فراوان‌ترین پیامدهای طولانی‌مدت به دنیا آوردن بچه توسط نوجوانان دختر است. یافته‌های اخیر نشان داده نوجوانانی که در نوجوانی مادر می‌شوند، به احتمال زیاد از دبیرستان اخراج می‌شوند، ترک تحصیل می‌کنند یا مردود می‌شوند و احتمال بازگشت آنان به دبیرستان بسیار کم است (میلر^۱، ۲۰۰۳).

در پژوهشی زمان رخداد سه واقعه بزرگ یعنی تولد اولین فرزند، فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان و ترک تحصیل در گروهی از نوجوانان ۱۴ ساله مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حدود ۵ درصد دختران نوجوان در بدو ورود به دبیرستان حامله می‌شوند، از این تعداد ۲۹ درصد ترک تحصیل می‌کنند و فقط ۳۰ درصد آنان دوباره به مدرسه بازمی‌گردند و فارغ‌التحصیل می‌شوند، درحالی‌که فقط ۱۹ درصد دختران نوجوانی که حامله نمی‌شوند، ترک تحصیل می‌کنند (در مقایسه با ۳۹ درصد آنان که حامله بودند) و از این تعداد، ۸۵ درصدشان دوباره به مدرسه برمی‌گردند و

^۱ . Miller

فارغ التحصیل می‌شوند، در مقایسه با ۳۰ درصد نوجوانان دختری که پس از حاملگی فارغ التحصیل می‌شوند (میلر، ۲۰۰۳).

علاوه بر تحصیلات کمتر مرتبط با حاملگی در نوجوانان، فشار اقتصادی‌ای که نوجوانان حامله بر جامعه تحمیل می‌کنند، بسیار سنگین و زیاد است. دولت‌ها ناچار هستند از نظر مالی به این مادران کمک کنند، از نظر درمانی، تغذیه و هزینه زایمان نیز مسئولان جامعه فشار زیادی را متحمل می‌شوند. علاوه بر این، هزینه‌های خدمات اجتماعی، محافظتی و آموزش خاص و آموزش‌های مرتبط با شغل نیز برای این مادران نوجوان، مشکلات زیادی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند. به این هزینه‌ها، باید هزینه‌های فرصت‌های مرتبط با نیروهای مولد کاری را نیز اضافه کرد.

وجود مشکلات پزشکی، دارویی و اجتماعی در میان نوزادان مادران نوجوان نیز یکی دیگر از نتایج حاملگی در نوجوانی است. مرگ و میر، این کودکان را در ماه اول تولد تهدید می‌کند، زیرا بیشتر این نوزادان کم‌وزن و نارس‌اند و شانس زیادی برای زنده ماندن ندارند. حتی با کنترل وزن هنگام تولد، این نوزادان در معرض مشکلات پزشکی و اجتماعی زیادی قرار دارند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد احتمال مرگ نوزادان مادران نوجوان بسیار زیاد است. این نوزادان نسبت به سایر نوزادان، بیشتر در معرض خطر آسیب‌های تصادفی و غیرتصادفی، مشکلات رفتاری و کم‌هوشی قرار دارند (استیونز-سیمون و ریچرت^۱، ۱۹۹۴).

اگرچه حاملگی نوجوانان منحصر به کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا نیست، با این حال، آمریکا بیشترین میزان حاملگی، به دنیا آوردن نوزاد و سقط جنین انتخابی را در میان نوجوانان خود داراست. یکی از دلایل این مسئله، عدم استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی در نوجوانان است. اگرچه ۱۸ درصد نوجوانان آمریکایی قبل از ۱۵ سالگی و ۶۶ درصد آنان در ۱۹ سالگی از نظر جنسی فعال می‌شوند، فقط یک سوم آنها از وسایل جلوگیری استفاده می‌کنند. در بخش‌های بعد، همه‌گیرشناسی حاملگی در نوجوانان، پیامدهای آن، راهبردهای پیشگیرانه و راه‌های درمانی آن توضیح داده می‌شود.

همه‌گیرشناسی

در آمریکا در هر ۳۱ دقیقه، یک نوجوان دختر حامله می‌شود و در هر ۲ دقیقه، یک نوجوان دختر مادر می‌شود و نوزادی را به دنیا می‌آورد و هر سال در حدود ۱ میلیون دختر زیر ۲۰ سال حامله

^۱ . Stevens – Simon & Reichert

می‌شوند، که سن نیمی از آنان کمتر از ۱۸ سال است. از این مادران ۴۰ درصد دست به سقط جنین می‌زنند و ۵۰ درصدشان فرزند خود را به دنیا می‌آورند و ۱۰ درصد بقیه به‌طور خودبه‌خودی جنین‌شان سقط می‌شود (دیکلمنت، هانسن و پانتون؛ ۱۹۹۶).

روند حاملگی در نوجوانان

تجزیه و تحلیل و تفسیر به دنیا آوردن نوزاد در نوجوانان بسیار مشکل است. نرخ کلی زایمان نوجوانان در آمریکا تا سال ۱۹۷۰ افت داشته و در سال ۱۹۸۰ تقریباً متوقف شده است. اما میزان این زایمان‌ها از سال ۱۹۸۸ به بعد افزایش چشمگیری داشته است (هاردی و زابین^۱، ۱۹۹۱؛ به نقل از دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶).

قضاوت براساس نرخ کلی ممکن است تا حدودی گمراه‌کننده باشد. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴، تعداد نوجوانان دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله حامله برابر با ۱۱/۴ درصد بوده است. بنابراین، تطابق نرخ زایمان نوجوانان آمریکایی براساس نرخ حاملگی نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله که تعداد آنان از ۱۰۹/۰۰۰ در سال ۱۹۷۲ به ۹۴۱/۰۰۰ در سال ۱۹۸۴ رسیده، نشان‌دهنده افزایش حاملگی در این سال‌هاست. با این حال، به‌طور کلی استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی می‌تواند یکی از راه‌های اصلی کاهش حاملگی در نوجوانان باشد.

فعالیت جنسی و استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی

از چند دهه قبل، درصد نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله‌ای که دارای روابط جنسی‌اند، افزایش چشمگیری داشته است. در سال ۱۹۷۰، فقط ۲۶/۶ درصد نوجوانان گزارش کرده‌اند که روابط جنسی دارند، در سال ۱۹۷۵ این مقدار به ۳۶/۴ درصد و در سال ۱۹۸۰ به ۴۲ درصد رسیده است، در سال ۱۹۸۵ به ۴۴/۱ درصد و در سال ۱۹۹۰ به ۵۱/۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین درصد روابط جنسی در دختران نوجوان مربوط به ۱۵ سالگی است. درحالی‌که میزان استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی در دهه قبل افزایش یافته، اما این افزایش به حد مورد انتظار نبوده است. در سال ۱۹۹۰، ۸۷/۸ درصد دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله گزارش کرده‌اند که از یکی از روش‌های جلوگیری استفاده می‌کرده‌اند، این مقدار در سال ۱۹۸۲ برابر با ۷۱ درصد بوده است (هاردی، ۱۹۹۱).

^۱ . Hardy & Zabin

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اجتماعی مادران نوجوان

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اجتماعی نوجوانانی که مادر می‌شوند، در طول زمان به‌طور چشمگیری تغییر می‌کند. از این‌رو تعداد زایمان‌های نوجوانان بدون اینکه ازدواج کنند، طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ افزایش زیادی یافته است (از ۴۹ درصد به ۶۶ درصد). بیش از ۹۰ درصد زایمان‌های نوجوانان سیاه‌پوست و در حدود ۵۰ درصد زایمان‌های نوجوانان سفیدپوست، خارج از چارچوب ازدواج است. از طرفی، تعداد مادران نوجوانی که خارج از چارچوب ازدواج بچه‌دار می‌شوند، بیشتر از تعداد پدران نوجوان است و نشان می‌دهد که سن پدران در مقایسه با مادران بیشتر است (هاردی^۱، ۱۹۹۱).

همبسته‌های رفتارهای جنسی بسیار خطرناک و حاملگی

عوامل تحولی، اجتماعی، رفتاری، هیجانی و روان‌شناختی زیادی وجود دارند که با حاملگی و رفتارهای جنسی بسیار خطرناک همبستگی دارند. عواملی مانند داشتن دوست‌پسری که بزرگ‌تر از فرد است، شکست تحصیلی و ترک تحصیل، دارا بودن سابقه آزار و اذیت جسمی و جنسی، درگیری در سایر رفتارهای پرخطر نظیر مصرف مواد و الکل، داشتن دوستان، مادر، خواهر یا بستگانی که در نوجوانی مادر شده‌اند، از جمله عواملی‌اند که فرد را در معرض خطر حامله شدن قرار می‌دهند. بلوغ و رشد فیزیکی و جسمانی، یکی دیگر از عوامل مهم مرتبط با حاملگی است. نوجوانان دختری که تا حدودی رشد یافته‌تر از همسالان خود به‌نظر می‌رسند، بیشتر در معرض خطر برقراری رابطه جنسی و حاملگی قرار دارند. همچنین ممکن است این نوجوانان فعالیت جنسی را قبل از اینکه به رشد شناختی لازم و کافی برسند و بتوانند درباره پیآمدهای رفتار خود فکر کنند، شروع کنند.

تأثیرات تحولی

تبیین‌های احتمالی زیادی برای خطر روزافزون حاملگی در میان دختران نوجوان وجود دارد. برای مثال، مطالعات اخیر نشان داده‌اند که ترشح غدد درون‌ریز مربوط به رشد توانایی اعضای تناسلی در بزرگسالی و وقایع روانی اجتماعی مرتبط با رشد هویت جنسی در یک بزرگسال، به‌طور مستقیم احتمال حاملگی در دوران نوجوانی را با افزایش برانگیختگی جنسی و باروری تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عوامل همچنین به‌طور غیرمستقیم و از طریق رشد معیارها و استانداردهای جدید برای

^۱ . Hardy

رفتارهای دگرجنس خواهانه قابل قبول از نظر اجتماعی و با پرکردن شکاف بین رشد فیزیولوژیکی و بلوغ روانی اجتماعی در نوجوانان، میزان حاملگی را تحت تأثیر قرار می دهند. عدم هماهنگی بین بلوغ روانی اجتماعی و توانایی و ظرفیت تولیدمثل بسیار مشکل آفرین است، بخصوص برای جوانانی که از نظر فیزیکی خیلی سریع تر از همسالان خود رشد پیدا کرده اند (گروس و دوک^۱، ۱۹۸۰).

از آنجا که سازوکارهای مستقیم به تنهایی نمی توانند تغییرات فرهنگی فاحشی را که از نظر زمان اولین حاملگی وجود دارد تبیین کنند، به نظر محتمل می رسد که در گروه اجتماعی خاص، وضعیت ظاهری و جسمانی رشدیافته نوجوانان، انتظارات بزرگسالان را برای رفتار آنان تحت تأثیر قرار می دهد و موجب می شود که آنها در روابط اجتماعی ای که هنوز از نظر شناختی و روان شناختی برای آن آمادگی ندارند، درگیر شوند.

تأثیرات اجتماعی جنسی

صاحب نظران معتقدند افرادی که در دوران کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند، بیشتر در معرض خطر حاملگی در دوران نوجوانی قرار دارند، شاید به این دلیل که شرایط شخصی و اجتماعی این نوجوانان طوری است که آنان را برای مورد آزار و اذیت قرار گرفتن در دوره کودکی و حاملگی در نوجوانی مستعد می کند (برای مثال خانواده هایی که دارای بدکارکردی و مصرف مواد هستند و والدین روابط بسیار ضعیفی با فرزندان دارند و افراد این خانواده ها نیازهای هیجانی برآورد نشده زیادی دارند)، شاید هم به این دلیل که تجربه مورد آزار و اذیت جنسی واقع شدن، نگرانی هایی را درباره توانایی تولیدمثل در فردی که مورد آزار و اذیت جنسی واقع شده است، به وجود می آورد و میل به باروری و حاملگی را در او افزایش می دهد (میلر، ۲۰۰۳).

تأثیرات اجتماعی

دختران نوجوانی که ترک تحصیل می کنند، متعلق به خانواده ها و محلات محروم اند و دوستان و بستگان زیادی دارند که در نوجوانی و سنین کم حامله شده اند. نوجوانانی که در سنین کم حامله شده اند، احتمال بیشتری وجود دارد که دوباره حامله شوند. فقدان فرصت برای پیشرفت های شخصی ممکن است منجر به فقدان انگیزش برای اجتناب از حاملگی شود. به دنیا آوردن نوزاد برای این نوجوانان نه یک اقدام طغیان گرانه در مقابل قدرت والدین است و نه نوعی رفتار اعتراضی از نظر

^۱ . Gross & Duke

اجتماعی، بلکه، حاملگی و به دنیا آوردن نوزاد، ریشه در تار و پود و بافت زندگی و فعالیت‌های هشیارانه یا ناهشیارانه اعضای خانواده یا دوستان آنها دارد، زیرا حامله و مادر شدن آنها را قادر می‌سازد تا با دختران نوجوان دیگری که مادر شده‌اند و با آنها همدردند، روابط نزدیک و عاطفی برقرار کنند.

در بیشتر مواقع، حامله شدن یک دختر نوجوان نوعی تشریفات برای پشت سر گذاشتن دوره کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی و در واقع بخشی از فرایند بزرگ شدن اوست. به نظر می‌رسد این احساس بویژه در میان نوجوانان دختری که در مدرسه عملکرد ضعیفی دارند یا در محیط‌های اجتماعی فقیری زندگی می‌کنند که حامله شدن نوجوانان در آنجا بسیار شایع است، به‌وفور یافت می‌شود (کلی^۱ و همکاران، ۱۹۹۴).

تأثیرات هیجانی

تصور می‌شود همان‌گونه که برقراری روابط جنسی در طول زمان افزایش می‌یابد و روابط عاشقانه عمیق‌تر می‌شود، احساس فعالیت جنسی نیز هویدا می‌شود و نوجوانان می‌توانند از نظر شناختی درباره رفتار جنسی خود فکر کنند و انتخاب آگاهانه‌ای درباره فعالیت جنسی و جلوگیری از حاملگی داشته باشند.

در پژوهشی مشاهده شد که با طولانی شدن روابط عاشقانه، احساس صمیمیت و نزدیک‌تر شدن به یکدیگر، میل نهفته در وجود افراد برای به دنیا آوردن نوزاد را برمی‌انگیزد یا اینکه نگرانی‌هایی را درباره حامله شدن به وجود می‌آورد که به جای افزایش استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی، این کار را بازدار می‌کند (راینی و همکاران، ۱۹۹۳؛ به نقل از دیکلمنت و همکاران، ۱۹۹۶). در واقع، بسیاری از نوجوانان به دلیل اینکه می‌خواهند چیزی یا کسی را دوست بدارند و می‌دانند که از این طریق فردی به وجود خواهد آمد که همیشه آنها را دوست خواهد داشت، تمایل به حامله شدن پیدا می‌کنند.

دلایل عدم استفاده نوجوانان از وسایل جلوگیری

دلایل نوجوانان برای عدم جلوگیری از حاملگی بسیار زیاد است. وقتی محققان برای اولین بار از نوجوانان می‌پرسند که چرا در جلوگیری از حامله شدن تعلل می‌کنید؟ رایج‌ترین پاسخ آنان این است که «به وسایل جلوگیری دسترسی نداشتم»، دومین پاسخی که نوجوانان به این پرسش می‌دهند، شامل

^۱ . Kelly

ترس از عوارض جانبی این وسایل، ترس از اینکه والدین بفهمند آنها درگیر روابط جنسی‌اند و ترس از آزمایش‌های جسمی و فیزیکی است و سومین پاسخ آنان عدم تمایل برای تصمیم‌گیری آگاهانه دربارهٔ فعالیت جنسی است (برای مثال می‌گویند "من فقط انتظار داشتم روابط نزدیک‌تری با دوست پسرم داشته باشم" یا "من برنامه‌ریزی داشتم که رابطهٔ جنسی نداشته باشم"). سایر دلایل نشان‌دهندهٔ عدم آگاهی آنها دربارهٔ نیاز به استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی است. برای مثال "من فکر می‌کردم برای حامله شدن خیلی کوچک‌ام" یا عدم آگاهی از چگونگی به‌دست آوردن و مورد استفاده قرار دادن وسایل جلوگیری از حاملگی است (برای مثال "من از خریدن قرص‌های ضد حاملگی احساس شرم و خجالت می‌کردم").

به‌طور کلی، به‌نظر می‌رسد که عدم آگاهی و عدم دسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی در مقایسه با اعتقادات، باورها و تصورات نوجوانان، نقش کمتری در عدم جلوگیری از حاملگی دارد. از این‌رو لازم است طی برنامه‌های آموزشی خاصی که در مراکز بهزیستی ارائه می‌شود، این باورهای نادرست با آموزش صحیح و علمی، اصلاح شوند و آگاهی‌های لازم به آنان داده شود.

پیشگیری اولیه از حاملگی نوجوانان

در این بخش به بررسی ضعف‌ها و قوت‌های راهبردهای مختلف جلوگیری از حاملگی نوجوانان با توجه به این نکته می‌پردازیم که استفادهٔ منظم از وسایل جلوگیری ممکن است در حداقل خود باشد که در جدول ۵-۱ فهرست شده است، می‌پردازیم.

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، برنامه‌های پیشگیری از حاملگی نوجوانان در درجهٔ اول متمرکز بر شرایط حداقل اولیه بود. اعتقاد بر این بود که افزایش دانش نوجوانان در مورد عواقب فعالیت جنسی بدون محافظ و راه‌های جلوگیری از حاملگی برای این کار کافی است. سیاست‌گذاران، برنامه‌های آموزش جنسی را در مدرسه ترویج و توسعه دادند. این برنامه‌ها شامل ارائهٔ اطلاعاتی دربارهٔ اختلالات انتقالی جنسی، جلوگیری از حاملگی و مشکلات و پیامدهای حاملگی بود. البته این برنامه‌های آموزشی مدرسه‌مدار تا حد زیادی مؤثر بودند و درک و فهم دانش‌آموزان را از فیزیولوژی تولیدمثل، روابط جنسی و جلوگیری از حاملگی رشد می‌داد، اما رفتار جنسی، جلوگیری از حاملگی در نوجوانان یا میزان حاملگی آنان را تحت تأثیر قرار نمی‌داد (میلر، ۲۰۰۳).

جدول ۵-۱. شرایط حداقل برای استفاده منظم از وسایل جلوگیری از حاملگی در میان نوجوانان دارای فعالیت

جنسی

- اعتقاد به اینکه امکان حاملگی وجود دارد و باور به اینکه وسایل جلوگیری به سلامتی آسیب نمی‌رسانند و فقط روش جلوگیری از حاملگی اند.
- دسترسی به مراکز توزیع وسایل جلوگیری از حاملگی.
- مفهوم خود مثبت جنسی که فرد را قادر می‌سازد تا درباره رفتار جنسی و جلوگیری از حاملگی و داشتن رابطه با شریک جنسی مذکر و به دنیا آوردن نوزاد تصمیم‌گیری آگاهانه‌ای داشته باشد.
- میل به تعویق انداختن به دنیا آوردن نوزاد

منبع: برگرفته از دیکلمنت و همکاران، ۱۹۹۶

با شکست برنامه‌های مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی در جلوگیری از حامله شدن نوجوانان، توجه اذهان عمومی و متخصصان به چهار شرط حداقل برای استفاده از وسایل جلوگیری به‌طور منظم که در جدول ۵-۱ به آن اشاره شد، جلب شده است. از این‌رو هدف برنامه‌های جلوگیری از حاملگی در نوجوانان، مبتنی بر مؤلفه‌های «انتخاب‌های زندگی» است. این برنامه‌ها، بر توجه به انگیزه‌های ناشی از نیاز نوجوانان و فراهم کردن فرصت‌هایی برای ارضای این نیازها بویژه ارزش‌های مبتنی بر نیاز خویش‌داری و اجتناب و ارائه خدمات رایگان برای جلوگیری از حاملگی به نوجوانان تأکید می‌کنند. رفتارهای خطرآفرینی چون برقراری ارتباط جنسی بدون محافظ به‌عنوان رفتارهای تصادفی و اینکه نوجوانان از روی هوا و هوس در آنها درگیر شده‌اند، مدنظر قرار نمی‌گیرند، بلکه با این رفتارها به‌صورت رفتارها و فعالیت‌های هدفداری برخورد می‌شود که پیامدهای مثبت و منفی‌ای برای تحول نوجوانان به‌دنبال دارند. به‌همین دلیل، برنامه‌ریزان این برنامه‌ها تلاش دارند تا به نوجوانان گزینه‌ها و انتخاب‌های شغلی‌ای بدهند که جذاب‌تر از مادر و پدر شدن است.

یکی از رویکردهای ابتکاری برای کاهش حاملگی در نوجوانان، طراحی برنامه‌های مبتنی بر اجتماع است. در این برنامه‌ها، یک‌سری پیام‌های مداخله‌ای برای والدین، معلمان، روحانیان، رهبران جامعه و کودکانی که در نظام آموزش عمومی ثبت‌نام کرده‌اند، ارسال می‌شود. پیام‌ها بر توسعه و رشد تصمیم‌گیری و مهارت‌های برقراری ارتباط، بهبود و افزایش عزت نفس و درک و فهم آناتومی تولید مثل و تناسل در نوع بشر، دانش درباره فیزیولوژی رفتار جنسی و جلوگیری از حاملگی تأکید دارند. گزارش شده که این برنامه‌ها منجر به کاهش حاملگی در نوجوانان دختر ۱۴ تا ۱۷ ساله در کالیفرنیا شده است (وین سنت^۱ و همکاران، ۱۹۸۷).

^۱. Vincent

به‌طور کلی، نتایج تحقیقات نشان داده‌اند که برنامه‌های پیشگیری از حاملگی نوجوانان تأثیر و کارایی کمی دارند. از این رو لازم است که والدین نیز به‌منظور آموزش فرزندان خود آگاهی به‌دست آورند و مجهز به دانش جنسی و چگونگی انتقال این دانش به فرزندان خود شوند.

بحث و گفت‌وگو درباره‌ی این موضوع باید در سال‌های دوره‌ی راهنمایی شروع شود و تا دبیرستان ادامه یابد؛ باید برنامه‌های آموزش جنسی جامع و فراگیری طراحی شوند که کلاس درس را با خانواده‌ها مرتبط کنند؛ برنامه‌ریزی‌های شغلی باید صورت گیرد که در دوره‌ی راهنمایی قابل دسترس باشند. اگر چنین اقدام‌هایی صورت بگیرد، نوجوانانی که وارد دبیرستان می‌شوند، احساس روشنی دارند که آینده‌ی آنان مملو از فرصت‌هایی است که بسیار جذاب‌تر از پدر و مادر شدن است و در نتیجه، ذهن آنها سرشار از دانشی می‌شود که آنها را قادر می‌سازد از روی اختیار، به‌دنیا آوردن نوزاد و مادر شدن خود را عقب بیندازند و آن را به موقع و زمان مناسب موکول کنند. به‌طور کلی، به‌نظر می‌رسد که برنامه‌های مدرسه‌ای - اجتماعی تأثیر زیادی در جلوگیری از حامله شدن نوجوانان داشته باشد.

پیشگیری ثانویه از حاملگی نوجوانان

تشخیص حاملگی

پیشگیری ثانویه، به شناسایی و تشخیص اولیه و مداخله برای بازگشت، متوقف کردن یا حداقل به‌تأخیر انداختن روند پیشرفت شرایط یا وضعیت اشاره دارد. پیشگیری ثالثیه به معنای به حداقل رساندن تأثیر یک شرط یا وضعیت است. حاملگی به خودی خود بیماری نیست، از این رو به‌طور دقیق با اصطلاح پیشگیری ثانویه یا ثالثیه تناسب ندارد. با این حال، در این فصل پیشگیری ثانویه را در مورد حاملگی نوجوانان مدنظر قرار می‌دهیم. تشخیص اولیه‌ی حاملگی بسیار مهم است، از این رو نوجوانان می‌توانند ابتدا به مرکز مامایی رجوع کنند. از جمله علائم حاملگی می‌توان به خستگی، حالت تهوع در صبحگاه، ناراحتی‌های شکمی، سردرد، گیج بودن، سرگیجه و ضعف اشاره کرد. اما بهترین راه، آزمایش حاملگی است. اغلب نتیجه‌ی آزمایش ۷ تا ۱۰ روز بعد از حاملگی مثبت نشان داده می‌شود. اگر نتیجه‌ی آزمایش مثبت نبود، انجام آزمایش دیگری در هفته بعد ضرورت دارد.

بلافاصله پس از تشخیص حاملگی، باید در مورد ادامه‌ی حاملگی بین نوجوان حامله و پزشک متخصص بحث صورت گیرد. در کشورهای غربی نوجوان حامله سه گزینه را می‌تواند انتخاب کند:

۱. ادامه‌ی حاملگی و نگهداشتن نوزاد؛

۲. ادامه‌ی حاملگی و برنامه‌ریزی برای دادن نوزاد برای فرزندخواندگی؛

۳. سقط جنین.

اما در کشور ما، با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم خاص، سومین راه برای نوجوان حامله عملی نیست، ولی به صورت غیرقانونی این عمل صورت می‌گیرد که خطرهایی را نیز برای دختر نوجوان دارد.

تدارک مراقبت‌های لازم قبل از زایمان

اگر نوجوانی تصمیم بگیرد حاملگی را ادامه دهد، بلافاصله باید مراقبت‌های قبل از زایمان را برای او تدارک و تهیه دید. تحقیقات نشان داده‌اند که می‌توان از فواید مراقبت‌های کامل قبل از زایمان استفاده برد و این کار را به چند روش انجام داد. برای مثال، توجه خاص به تشخیص و درمان عفونت‌های رحمی و دهانه رحم که منجر به کاهش احتمال رخداد پارگی پیش از موعد کیسه جنینی می‌شود. همچنین بهبود وضعیت تغذیه‌ای مادر و در نتیجه اضافه شدن وزن او که منجر به کاهش احتمال رخداد مشکلات پزشکی نظیر کم‌خونی می‌شود، در نهایت توجه بیشتر به تشخیص و درمان مشکلات روان‌شناختی نامرتبط با آبستنی نظیر مصرف مواد مخدر، تنیدگی‌ها و فشارهای روانی مادر و افسردگی او که می‌تواند زایمان زودرس، کم‌وزنی نوزاد و غیره را کاهش دهد. مراقبت‌های کامل قبل از زایمان هم شامل مراقبت‌های پزشکی در دوران حاملگی و هم ارائه خدمات روانی اجتماعی به مادران حامله می‌شود (هینز^۱ و همکاران، ۲۰۰۴).

^۱. Heins

جدول ۵-۲. مشکلات روانی اجتماعی رایج در میان مادران نوجوان و نوزادان آنها

پزشکی	روانی اجتماعی
مادر	
سایز کوچک، کم‌وزنی، چاقی، اضافه وزن زیاد، حاملگی توأم با فشار روانی و تنیدگی زیاد، اختلالات انتقالی جنسی، بی‌نظمی‌های هورمونی و حاملگی مکرر	تحصیلات کم، شکست تحصیلی، فرصت‌های شغلی کم و فقر طلاق و جدایی انزوای اجتماعی تنیدگی، فشار روانی و افسردگی مصرف مواد حاملگی مکرر
کودک	
وزن کم به هنگام تولد نارس بودن سندرم مرگ ناگهانی نوزاد عفونت‌های حاد و جزئی حوادث مرگ در دوران جنینی و نوزادی	تأخیرهای تحولی - رشدی پرخاشگری مشکلات رفتاری / مصرف مواد شکست تحصیلی و عقب‌ماندگی ذهنی و تحصیلی بیکاری و فقر حاملگی بدون برنامه

منبع: برگرفته از استیونز - سیمون و همکاران، ۱۹۹۵

شیوه برخورد با حاملگی نوجوانان

برنامه‌هایی که برای پیشگیری از حاملگی تدوین شده‌اند، بر برنامه‌ریزی‌های خانوادگی و شغلی برای نوجوانان تأکید دارند. این برنامه‌ها بر این موضوع تأکید دارند که والدین نوجوان و فقیر برای به تأخیر انداختن زایمان‌های بعدی خود و درگیر شدن در فعالیت‌های توسعه‌دهنده تحول و رشد، نیاز به تشویق و حمایت اضافی دارند. در بیشتر موارد، پدر، مادر و نوزاد، یک‌جا ویزیت می‌شوند تا پیچیدگی حاصل از مراقبت‌ها و خدمات مراقبتی بهداشتی پیشگیری‌کننده کاهش یابد و استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی به حداکثر برسد. مشاهده شده برنامه‌هایی که دارای مؤلفه‌های خاص خانوادگی برنامه‌ریزی‌شده‌ای نیستند، تأثیر و کارایی کمی در پیشگیری از اقدام به جرم و ترک تحصیل و وابستگی‌های مالی و رفاهی این نوجوانان دارند (پولیت^۱، ۱۹۸۹).

^۱. Polit

علاوه بر فراهم ساختن مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان که با برنامه‌های آموزش شغلی و تحصیلی جامعه‌مدار مرتبط‌اند، کار امدادگرانی که بیماران را در خانه‌ها معاینه می‌کنند، روشی کارآمد و باارزش است که شکاف بین خانواده‌های جوان و منزوی از نظر اجتماعی و سیستم‌های خدماتی اجتماعی و پزشکی را پر می‌کند. به‌طور کلی، حاملگی را می‌توان با سقط جنین خاتمه داد. تعداد سقط جنین‌های عمدی و انتخابی از سال ۱۹۷۰ تاکنون افزایش چشمگیری داشته است. البته مراقبت‌ها و خدمات دقیق پیشگیری برای نوجوانانی که سقط جنین کرده‌اند، ضروری و لازم است. البته ممکن است لازم باشد که شریک جنسی این نوجوانان هم مورد مشاوره قرار گیرند (هنشاو^۱، ۱۹۹۲). فرزندخواندگی، یکی دیگر از راه‌های برخورد با حاملگی نوجوانان است. با این حال، فقط ۳۰ درصد والدین نوجوان حاضر می‌شوند که کودک خود را به‌عنوان فرزندخوانده به خانواده‌های دیگر بدهند، البته به سختی می‌توان تعیین کرد که تأثیر بلندمدت این راه‌حل بر به‌دنیا آوردن نوزاد در نوجوانان چگونه است.

روابط دختر و پسر در ایران

باتوجه به فرهنگ خاص کشور ما و تأکیدی که خانواده‌ها بر آموزش تعلیم مذهبی و اخلاقی برگرفته از دین مبین اسلام به کودکان خود از همان بدو تولد دارند، برقراری ارتباط بین نوجوانان دختر و پسر تاحدودی با کشورهای غربی و سایر ممالک جهان متفاوت است. اولاً تاچندی قبل خانواده‌ها نسبت به این نوع ارتباطات برخوردهای شدید و گاه مخرب و خطرناکی داشتند و به هیچ‌وجه روابط دختر و پسر برایشان قابل قبول نبود، با این حال اخیراً نحوه برخورد خانواده‌ها با این موضوع تا حدودی تفاوت کرده و شاید بهتر است بگوییم متعادل‌تر شده است. اما این مسئله به معنای این نیست که خانواده‌ها و جامعه برقراری این‌گونه روابط را کاملاً پذیرفته و تأیید می‌کنند. بلکه به نظر می‌رسد با صنعتی‌تر شدن جامعه و با توجه به این که به دختران نسبت به چند دهه قبل حق بیشتری برای انتخاب و شرکت در انجام فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی داده شده است، تا حدودی روابط دختر و پسر جنبه پیچیده‌تری به خود گرفته است و شاید بتوان گفت غیرقابل اجتناب شده است. زیرا اکنون در کشور ما مثل اکثر کشورهای دیگر، زنان و دختران بخش عظیمی از نیروی تحصیل‌کرده، متخصص و گرداننده چرخ‌های اقتصادی کشور را تسکین می‌دهند. ثانیاً، به دلیل این که اکثر نوجوانان دختر و پسر برای ورود به آموزش عالی و ادامه تحصیل ناچار به مهاجرت به شهرهای دیگر، بخصوص شهرهای بزرگ هستند، خانواده‌ها و جامعه با دیدی بازتر و روشنفکرانه‌تر به این

^۱ . Henshaw

پدیده می‌نگرند و این در حالی است که نوجوانانی که در شهرهای کوچک و خانواده‌هایی با فرهنگ بسته و کاملاً متفاوت با شهرهای بزرگی چون تهران پرورش یافته و بزرگ شده‌اند، وقتی در شهرهای بزرگ ساکن می‌شوند و مستقل از خانواده و نظارت والدین به زندگی در این شهرها ادامه می‌دهند، نسبت به برقراری رابطه با جنس مخالف چه به طور سنجیده و عاقلانه و چه به صورت کاملاً سنجیده و غیرمعقول، آسیب‌پذیرتر می‌گردند.

گاهی برقراری این روابط منجر به آسیب‌های جدی برای آنان چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌گردد. خصوصاً که بعضی از این نوجوانان و جوانان با فیزیولوژی جنسی هیچ آشنایی علمی ندارند و از پیامدهای خطرناک جسمانی، عاطفی، روانی و اجتماعی برقراری ارتباط با جنس مخالف به صورت زودرس آگاهی ندارند. چه بسا که بعضی از این نوجوانان فریب خورده، دچار حاملگی در نوجوانی شوند و برای همیشه شانس تجربه یک زندگی زناشویی سالم و موفق را از دست بدهند. ثالثاً به دلیل این که حاملگی نوجوانان و جوانان دختر واقعه‌ای است که برای هیچ یک از خانواده‌های ایرانی قابل قبول نیست، این نوجوانان ممکن است پس از این واقعه به سقط جنین‌های غیرقانونی که در شرایطی کاملاً غیربهداشتی و غیرعلمی انجام می‌گیرند و در اکثر موارد منجر به مرگ یا ابتلا به بیماری‌های عفونی و مهلک می‌گردند روی می‌آورند و سلامتی و زندگی خود را شدیداً به مخاطره بیندازند. بعضی از این نوجوانان نیز ترجیح می‌دهند برای مقابله با این مشکل از خانه فرار کرده و به شهرهای دیگر مهاجرت کنند و نهایتاً درگیر روابط نامشروع، مصرف و حمل موادمخدر، ابتلا به ایدز، هپاتیت و سایر بیماری‌های مقاربتی گردند و توسط باندهای تبه‌کار مورد هرگونه سوءاستفاده‌ای قرار گیرند. لذا به نظر می‌رسد که تحقیق در این زمینه و دادن اطلاعات و آگاهی‌های لازم درمورد آسیب‌شناسی روابط دختر و پسر به نوجوانان و خانواده‌ها از جمله مسائلی باشد که متخصصان جامعه باید آن را در اولویت قرار دهند.

خلاصه

در بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در مورد حاملگی نوجوانان، از روش مشاهده‌ای استفاده شده است. اگرچه چنین مطالعاتی منجر به ایجاد داده‌های همبستگی ارزشمندی شده‌اند، اما مانع استنتاج درباره علل این مشکل شده‌اند. در این فصل، برخی از خلأهای مهم در دانش لازم برای نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت حاملگی در نوجوانان مطرح شد. در ادامه، معماها و پرسش‌های تحقیقی که هنوز درباره موضوعات مهم بدون پاسخ مانده‌اند، مطرح شدند.

از آنجا که مداخله مؤثر مستلزم درک سازوکارهای علی است، باید کارهای زیر صورت گیرد:

۱. طراحی مطالعات بعدی در مورد حاملگی نوجوانان برای آزمایش فرضیه‌های قابل آزمون؛
 ۲. محاسبات دقیق در مورد حجم نمونه تا نتایج حاصل قابل تعمیم باشند و محدودیت حجم نمونه نداشته باشند؛
 ۳. استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل چندمتغیری برای تعیین و بررسی نقش عوامل چندگانه‌ای که روی یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
- حاملگی نوجوانان، مشکل بسیار پیچیده‌ای است، پاسخ‌های ساده و راه‌حل‌های آسانی برای آن وجود ندارد، مگر اینکه راهبردهای تحقیقی قدرتمندی طراحی شوند. امید کمی وجود دارد که میزان حاملگی نوجوانان کاهش یابد و در نتیجه، چرخه مرتبط با فقر که توسط این مشکل ایجاد می‌شود، متوقف گردد.
- در حال حاضر، نیاز به بررسی دقیق پیش‌فرض‌هایی داریم که برنامه‌ریزی‌های خانوادگی، آموزش جنسی و برنامه‌های پیشگیری از حاملگی نوجوانان بر آنها مبتنی‌اند. برای مثال، درحالی که به‌نظر غیرممکن می‌رسد آموزش دادن به نوجوانان درباره تولیدمثل و جلوگیری از آن موجب افزایش فعالیت جنسی پیش از ازدواج شود، مطالعه و تحقیقات بیشتری لازم است تا تعیین شود که این کار چگونه حاملگی و جلوگیری از آن را تشویق می‌کند. درمان مؤثر بیماری‌های مرتبط با تولد نوزاد در نوجوانان (برای مثال پیشگیری از پیامدهای کوتاه‌مدت که در جدول ۶-۲ فهرست شده است)، مستلزم این است که درباره سازوکارهای سبب‌شناختی تأثیرگذار بر خطرهای پزشکی مرتبط با به‌دنيا آوردن نوزاد در نوجوانی بیشتر بدانیم و آگاهی بیشتری داشته باشیم. برای مثال، سوءتغذیه در مادران نوجوان منجر به بروز آسیب‌های جدی برای رشد خود و جنینی که در شکم دارند می‌شود.
- به‌طور کلی، حامله شدن در نوجوانی تأثیرات منفی بر سلامت مادر و نوزاد دارد و مراقبت‌های بهداشتی به تنهایی تأثیر معناداری روی مشکلات مرتبط با به‌دنيا آوردن نوزاد در این سن ندارد. تغییرات اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذارند، تغییراتی نظیر آموزش، تحصیلات، فرصت‌های شغلی بیشتر و فقرزدایی بسیار اهمیت دارند.

پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

- (۱) اگر شما مشاور دبیرستان دخترانه باشید و یکی از دانش‌آموزان به شما رجوع کند و بگوید که حامله شده است، چگونه به او کمک می‌کنید تا مشکل خود را حل کند؟
- (۲) به نظر شما آیا باتوجه به فرهنگ کشور ما، جای دادن آموزش جنسی در محتوی کتب درسی دوره راهنمایی یا دبیرستانی کار درستی است؟

فصل ششم

مصرف مواد مخدر

در این فصل به بررسی عوامل روان‌شناختی و اجتماعی مرتبط با مصرف افراطی و مشکل‌آفرین مواد مخدر پرداخته می‌شود. بحث ما متمرکز بر سیگار کشیدن، مصرف مواد و نوشیدن الکل در میان نوجوانان خواهد بود. امروزه برخی صاحب‌نظران معتقدند استفاده از مواد مخدر، الکل یا سیگار در کشورهای غربی جزئی از زندگی نوجوانان شده است (رایس^۱، ۱۹۹۲). مصرف این مواد نه تنها تأثیر سویی بر سلامت افراد دارد، بلکه نقش مؤثری در رفتارهای ضداجتماعی و خطرآفرینی نظیر خشونت، جرم و جنایت، بزهکاری و تجاوز جنسی دارد. از این رو، سوء مصرف مواد توسط نوجوانان اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

بسیاری از نوجوانان برای رسیدن به حس هویت شخصی، در دوره نوجوانی به مصرف موادی چون الکل یا سیگار روی می‌آورند. بخشی از فرایند رسیدن به هویت شخصی شامل تجربه ایده‌ها و رفتارهای جدید است. از طرفی، نوجوان می‌خواهد کاری را تجربه کند که بزرگسالان تجربه نکرده‌اند و کاری را انجام دهد که آنها انجام نداده‌اند و می‌خواهد دست به خلاقیت بزند و برای اینکه کاری مهم انجام داده باشد، به استعمال مواد مخدر روی می‌آورد. هر چند نوجوان در ابتدا فکر می‌کند هر وقت اراده کند می‌تواند از مصرف این مواد خودداری کند، اما آن‌قدر مواد مخدر مصرف می‌کند که وابستگی جسمی و روانی به آن پیدا کرده و به مرحله‌ای می‌رسد که اگر مواد مخدر مصرف نکند، شاهد علائم و عوارضی در رفتارهایش خواهد بود، از این رو برای جلوگیری از بروز این علائم، حالت‌ها و رفتارها، به طرف مصرف مواد کشیده می‌شود (خدایاری فرد، ۱۳۸۵).

به‌طور کلی در بین نوجوانان و جوانان اعتیاد به هرئین بیشتر از اعتیاد به حشیش، تریاک، مورفین و کدئین است. بیشتر این نوجوانان در اثر ویژگی‌های روانی «بحران هویت» و «حالت حساسیت زیاد» به طرف مواد کشیده شده‌اند. از آنجا که والدین نتوانسته‌اند الگوهای خوبی برای فرزندان خود باشند، نوجوان با روی آوردن به اعتیاد به دنبال هویت گم‌شده و تازه‌ای می‌گردد. از طرفی، با کناره‌گیری یا در حاشیه قرار دادن خود از جامعه، به مقابله با ارزش‌های بزرگسالان می‌پردازد و بدین ترتیب می‌خواهد به خویشتن هویت ببخشد و از سوی دیگر، با انتقاد کردن و پوچ شمردن ارزش‌های اجتماع، به هویت معتاد خود اعتبار و استحکام می‌بخشد.

^۱ . Rice

نوجوان در جریان معتاد شدن، دستخوش عدم امنیت و حساسیت زیاد شده، پرخاشگر و گذشت‌ناپذیر می‌شود، یک خنده یا مختصر بی‌توجهی از طرف اطرافیان را بد تعبیر می‌کند و سخت رنجیده خاطر می‌گردد، واقعیت‌ها را با توهمات و تصورات واهی در می‌آمیزد و گاهی چنان است که گویی هذیان می‌گوید و همه این موارد جنبه اغراق‌آمیز حساسیت او هستند. در چنین حالی، مواد اعتیادآور می‌تواند از دلهره‌ها و تعارضات وی بکاهد و نقش وی را کم‌رنگ و ضعیف سازد، طغیان درونی او را کاهش دهد و نوجوان معتاد را از انزوا و حالت عدم اطمینان بیرون آورد. علاوه بر حساسیت زیاد و بحران هویت، میل به حادثه‌جویی، تلاش برای اثبات وجود خود، و نشان دادن استقلال می‌تواند زمینه‌ساز روانی اعتیاد در نوجوانان باشد. البته منشأ تمام این مسائل، کانون خانواده و روابط خانوادگی است. عدم انسجام، فوت والدین، کمبود محبت، شدت عمل، فقر، جابه‌جایی و سرگردانی، کار و برنامه‌های بی‌رویه اعضای خانواده، جو پرتعارض و مبهمی ایجاد می‌کنند که هم می‌تواند نشانه‌ای از بیماری باشد و هم عامل ایجادکننده بیماری.

عدم ثبات و پایداری اجتماعی جامعه نیز مشکلات نوجوانان را افزایش می‌دهد و آنها را به انجام رفتارهای ناسازگارانه می‌کشاند. وقتی در جامعه شرایطی غیرعادی چون شورش، انقلاب، جنگ و فقر بیش از حد وجود داشته باشد، نوجوان و جوان ممکن است احساس عدم امنیت کند که این احساس خود عامل پیدایش اضطراب، پرخاشگری و احساس گناه می‌شود. در این فصل به بررسی فرایندهای روان‌شناختی و اجتماعی می‌پردازیم که موجب می‌شوند برخی نوجوانان از مواد شناخته‌شده و مشهوری نظیر سیگار، الکل، هروئین، حشیش و داروهای تحریک‌کننده استفاده نادرستی کنند.

الگوهای مصرف مواد مخدر

مصرف و سوء مصرف مواد در نوجوانان مراحل دارد، این مراحل را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

- سیگار، آبجو، یا هر دو؛
- حشیش یا نوشابه‌های الکلی سخت؛
- ماری‌جوانا؛
- سایر داروهای تحریک‌کننده.

تعداد بسیار کمی از نوجوانان با ماری‌جوانا یا سایر داروهای تحریک‌کننده شروع می‌کنند، آنها اولین بار مواد قانونی نظیر سیگار را تجربه می‌کنند. تعداد خیلی کمی از نوجوانان تا مراحل نهایی

مصرف مواد پیش می‌روند. بیشتر نوجوانانی که با آبحو شروع می‌کنند، به طرف مصرف مواد قاچاق هم پیش می‌روند. هیچ نوجوانی در اولین مرحله داروهای تحریک‌کننده مصرف نمی‌کند، مگر اینکه سیگار کشیدن و مصرف داروها و مواد قاچاق را تجربه کرده باشد. مصرف ماری‌جوانا، پیش‌بینی‌کننده‌ای قوی برای مصرف داروهای تحریک‌کننده است. کندل^۱ (۱۹۷۵) معتقد است که فقط ۲ تا ۳ درصد مصرف‌کنندگان داروهای قانونی تا مرحله مصرف داروهای تحریک‌کننده پیش می‌روند، بدون اینکه قبلاً تجربه استفاده از ماری‌جوانا را داشته باشند. کندل، یاماگوشی و چن^۲ (۱۹۹۲)، ادعا کرده‌اند مصرف موادی نظیر هروئین بعد از تجربه کردن ماری‌جوانا شروع می‌شود. به‌علاوه، تفاوت‌های مهم جنسیتی در رشد و پیشرفت مصرف مواد و داروهایی که ذکر شد، وجود دارد. دیده شده که در دختران مصرف سیگار قبل از مصرف ماری‌جوانا و در پسران مصرف الکل قبل از مصرف ماری‌جوانا صورت می‌گیرد. در مورد پسران دیده شده که کشیدن سیگار مسیر مهمی برای مصرف مواد تحریک‌کننده است.

اوبسیتی، فیتنس و ولنس ویک^۳ (۲۰۰۴)، با مطالعه ۹۴۱ پسر و ۲۶۲ دختر نوجوان آمریکایی که در برنامه‌های ترک اعتیاد شرکت کرده بودند، میزان اعتیاد به مواد مخدر را در دختران و پسران نوجوان مقایسه کردند. این مقایسه در ابتدای درمان ۳، ۶، ۱۲ و ۳۰ ماه پس از درمان و ترک اعتیاد صورت گرفت. سپس دختران و پسران نوجوان از نظر شدت اعتیاد، میزان سلامت روانی و درگیری در جرایم غیرقانونی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نوجوانان دختر نسبت به نوجوانان پسر به‌طور معنادار مشکلات کمتری را از نظر مشکلات مرتبط با مصرف مواد داشتند و از سلامت روانی بیشتری برخوردار بودند. اما ترک اعتیاد در پسران بیشتر طول کشید و طولانی‌تر از ترک اعتیاد در دختران بود. همچنین مشاهده شد پس از درمان دختران نسبت به پسران تغییرات مثبت‌تری را از نظر مصرف مواد، سلامت روانی و وضعیت رهایی از اعتیاد داشتند.

بسیار جالب توجه است که بدانیم الگوهای مصرف الکل و کشیدن سیگار در میان نوجوانان، انعکاسی از جامعه بزرگسالان و مشابه آنهاست. نوجوانان نیز همانند بزرگسالان، اغلب به نوشیدن مشروب تمایل دارند تا کشیدن سیگار. به‌علاوه، تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از این مواد مشابه با این تفاوت‌ها در میان بزرگسالان است؛ درصد بیشتری از دختران نسبت به پسران سیگار می‌کشند، اگرچه مصرف سیگار پسران بیشتر است. در مقایسه با دختران، تعداد بیشتری از پسران مشروب

^۱ . Kandel

^۲ . Yamaguchi & Chen

^۳ . Obesity, Fitness & Wellnessweek

می‌خورند، در عین حال مقدار مشروبی که دختران می‌خورند، کمتر از پسران است (هیل و همکاران، ۱۹۸۷).

در جامعه ما آمار دقیقی درباره مصرف مواد مخدر و الکل در بین نوجوانان وجود ندارد، ولی به نظر می‌رسد که از نظر جنسیتی تفاوت‌هایی با جوامع غربی داشته باشد. به تازگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن آغاز مصرف مواد مخدر را بین ۱۲ و ۱۵ سالگی اعلام کرده است. تحقیقات متعدد در این زمینه نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر اغلب پس از مصرف سیگار و در کشورهای خارجی با استفاده از الکل آغاز می‌شود. در گام دیگر در کشورهای خارجی به‌طور معمول سوء مصرف با ماری‌جوانا ادامه می‌یابد و در ایران استفاده از حشیش و تریاک مرسوم‌تر است. در تداوم مصرف این مواد در نهایت انواع مواد مخدر غیرقانونی که جنبه‌های تحریک‌کننده^۱، مخدر^۲، توهم‌زا^۳ دارند، مصرف می‌شوند. اغلب چگونگی استفاده از این مواد و تقدم یا تأخیر مصرف آن وابسته به میزان در دسترس بودن این گونه مواد است، بدین ترتیب برای تحول وابستگی به مواد می‌توان بر نقش عوامل اجتماعی که تعیین‌کننده میزان دسترسی به مواد است، تأکید کرد. اغلب از سیگار، الکل و ماری‌جوانا به عنوان دروازه‌های سوء مصرف مواد یاد می‌شود (بهرامی احسان، ۱۳۸۳).

مصرف الکل

الکل، ماده ترجیحی بیشتر نوجوانان و جوانان است. برخی کودکان برای اولین بار در ۱۰ سالگی شروع به نوشیدن الکل می‌کنند. براساس گزارش استرالیایی، میانگین سن شروع استفاده از الکل در مورد افراد ۱۶ ساله‌ای که مشروب می‌خوردند، در پسران ۱۰ سال و ۶ ماه و در دختران ۱۲ سال و یک ماه است (ویلکز و کالان^۴، ۱۹۹۰). در پژوهشی عادات نوشیدن حدود ۲۰/۰۰۰ نوجوان استرالیایی بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان مصرف الکل همراه با سن افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که حدود ۹۰ درصد نوجوانان ۱۷ ساله گزارش کردند که در گذشته الکل مصرف کرده‌اند و نزدیک به ۵۰ درصد نوجوانان ۱۶ ساله گزارش کردند که الکل را به‌صورت منظم مصرف کرده‌اند. زیتلین و سوادی^۵ (۱۹۹۱) دریافتند که حدود ۶۰ تا ۹۰ درصد نوجوانان بریتانیایی، به‌طور منظم و ۱۰ درصد آنها بیشتر از حد متوسط الکل مصرف می‌کنند، اگرچه محققان اشاره نکرده‌اند که منظور

^۱. stimulants

^۲. opiates

^۳. hallucinogens

^۴. Wilks & Callan

^۵. Zeitlin & Swadi

آنها از «به طور متوسط» چیست؟ همچنین معلوم نیست که کدام گروه سنی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بیشتر جوانان، اولین بار نوشیدن الکل را در خانه تجربه کرده‌اند، از این رو تمایل دارند بدون دخالت بزرگسالان در خانه الکل بنوشند. بعضی از این جوانان هم به دلیل اینکه والدین یا بستگانشان به آنها نوشیدن الکل را پیشنهاد کرده‌اند، تمایل به نوشیدن الکل در خانه دارند. بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نوجوانان گزارش کرده‌اند اولین بار به پیشنهاد یکی از اعضای خانواده‌شان الکل مصرف کرده‌اند. در حدود ۴ درصد آنها هم گزارش کرده‌اند که دوستانشان برای اولین بار به آنها نوشیدن مشروب را پیشنهاد کرده‌اند. بیشتر افراد جوان ترجیح می‌دهند الکل را در میان دوستان خود مصرف کنند (۵۶ تا ۶۴ درصد)، در غیر این صورت همراه با بستگانشان مشروب می‌خورند (۳۳ تا ۴۳ درصد). تعداد خیلی کمی از نوجوانان به تنهایی مشروب می‌خورند (در حدود ۲ درصد). مصرف الکل برای نوجوانان در دانشگاه یا در دوران پیش‌دانشگاهی مشکلاتی را به وجود می‌آورد. برآورد شده که در ایالات متحده آمریکا، ۹۰ تا ۹۲ درصد دانشجویان دانشگاه الکل مصرف می‌کنند، فقط ۷ درصد این افراد مصرف الکل را به طور روزانه گزارش کرده‌اند. مصرف الکل به صورت روزانه مرتبط با صدمات شخصی، عملکرد تحصیلی ضعیف، حاملگی ناخواسته و غیره است (ورنر و گرین^۱، ۱۹۹۲).

اسکات^۲ و همکاران (۲۰۰۴) با مطالعه ۴۰۰ نوجوان ۱۳ تا ۱۸ ساله که به مصرف مواد اعتیاد داشتند، دریافتند که استفاده از الکل به همراه سایر داروهای برانگیزاننده و محرک، مشکلات قانونی و روانی و احتمال رجوع به مراکز درمانی برای ترک اعتیاد را افزایش می‌دهد. درحالی که استفاده همزمان الکل و ماری‌جوانا، احتمال رجوع برای ترک اعتیاد را کاهش می‌دهد. در این مطالعه هیچ تفاوت جنسیتی در زمینه‌های مذکور مشاهده نشد.

تفاوت‌های بین فرهنگی

ویلکز و همکاران (۱۹۸۵) به بعضی روندهای بین فرهنگی در الگوی نوشیدن مشروب توسط نوجوانان اشاره کردند. آنها در مطالعه‌ای نگرش‌های نوجوانان را در استرالیا، آمریکا و گینه‌نو مورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد که مصرف الکل سطح خوشحالی، لذت، قابلیت اجتماعی و آرامش را در این نوجوانان افزایش می‌داد. تعداد بسیار کمی از این نوجوانان گزارش کردند که به دلیل دوست داشتن مزه مشروب یا به دلیل پیدا کردن دوستان جدید مشروب می‌خورند (جدول ۶-۱). نوجوانان

^۱ . Werner & Greene

^۲ . Scott

متعلق به گینه‌نو، بیشتر از نوجوانان آمریکایی و استرالیایی به مضرات مالی، اقتصادی و مشکلات خانوادگی که در اثر مشروب‌خواری پیش می‌آید، اشاره کردند. آنها اعتقاد داشتند که استفاده از الکل و مشروب منجر به ایجاد دردسر، درگیری و دعوا می‌شود. اما نوجوانان استرالیایی و آمریکایی بیشتر به آثار جانبی فیزیکی مشروب‌خواری نظیر اعتیاد، تهوع و استفراغ و کلافه بودن اشاره کردند و بیشتر نگران خطرهای ناشی از تصادفات با ماشین و موتور به دلیل مشروب‌خواری بودند.

به نظر می‌رسد که نوجوانان آثار جانبی مصرف الکل را کم برآورد می‌کنند. مطالعه‌ای که بر روی نوجوانان استرالیایی صورت گرفت، نشان داد که این نوجوانان پس از نوشیدن مشروب تمایل زیادی به رانندگی دارند. آنها اظهار کردند که اگر به اندازه ظرفیت خود الکل مصرف کنند، می‌توانند با امنیت خاطر رانندگی کنند. به طور کلی، مشاهده شده است که گروه‌های فرهنگی مختلف خطرهای متفاوتی را برای مصرف مشروب و الکل برمی‌شمارند (سیلبری زین، نوک و شانپفلاک^۱، ۱۹۹۴).

سواهن^۲ و همکاران (۲۰۰۴) رابطه بین مصرف الکل با درگیری‌های فیزیکی، صدمه رساندن به دیگران و صدمه دیدن هنگام درگیری را بررسی کردند. آنان ۸۸۵ نوجوان ۱۳ تا ۲۰ ساله را که سابقه مشروب‌خواری داشتند انتخاب کردند و مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد نوجوانانی که مشروب می‌خوردند و دوستان مشروب‌خوار داشتند، در درگیری‌های فیزیکی بیشتر مشارکت می‌کردند و هنگام درگیری به دیگران بیشتر صدمه می‌رساندند و صدمه می‌دیدند تا نوجوانانی که فقط به صورت تفریحی مشروب می‌نوشیدند.

^۱ . Slibereisen, Noak & Schonpflug

^۲ . Swahn

جدول ۶-۱. نگرش گروه‌های فرهنگی مختلف در مورد مصرف الکل

فواید	درصد در آمریکا	درصد در استرالیا	درصد در گینه‌نو
خوشحالی و لذت	۲۹/۵	۲۸/۵	۴۳
اجتماعی بودن	۲۲	۱۹/۵	۴۳
آرامش یافتن	۳/۵	۲۶/۵	۴۵/۵
فرار یا فراموشی از مشکلات	۱۴/۵	۴۳	۲۹/۵
پیدا کردن دوستان جدید	۱۴/۵	۵	۵
کاهش ممنوعات	۱۲	۸	۶
مزه خوب	۴	۱۴	۱
اضافه شدن وزن	۹/۵	۰/۵	۰
مضرات	درصد در آمریکا	درصد در استرالیا	درصد در گینه‌نو
هزینه‌های مالی و اقتصادی	۳۶/۵	۴	۱۴
مشکلات خانوادگی	۳۲	۷/۵	۹/۵
ابتلا به بیماری‌های کلی در طول زمان	۱۲	۱۴	۲۰
تصادف با ماشین	۱۲/۵	۹/۵	۲۵/۵
علت پیش آمدن مشکلات کلی	۱۶/۵	۹/۵	۹/۵
بحث، درگیری و قتل	۱۸/۵	۴/۵	۵
مشکلات روحی - روانی	۹/۵	۶	۵/۵
کلافه بودن	۰/۵	۸	۱۵
اعتیاد	۰/۵	۱۴	۱۵
استفراغ و تهوع	۴	۱۵/۵	۱۱
از دست دادن کنترل روحی	۱۵	۱۲/۵	۷/۵

منبع: برگرفته از ویلکز و کالان، ۱۹۹۰

مصرف سیگار

بعضی صاحب‌نظران معتقدند الگوهای مصرف سیگار توسط بزرگسالان به‌طور منطقی در حدود ۱۵ سالگی تغییر می‌کند. در حالی که در حدود ۸۳ درصد پسران ۹ ساله، فکر می‌کنند که نباید سیگار بکشند، اما فقط ۶۲ درصد از پسران ۱۵ ساله دارای این طرز فکر هستند. این درصدها در مورد دختران نوجوان به ترتیب برابر با ۸۹ و ۵۵ درصد است. در حدود ۱۴ درصد نوجوانان ۱۴ تا ۱۹ ساله فکر می‌کنند دانستن اینکه فرد بداند چگونه سیگار بکشد، بسیار مهم است. در حدود ۱۵ درصد آنها

نیز فکر می‌کنند که سیگار کشیدن کار خطرناکی نیست. در حدود ۱۰ درصد آنها اعتقاد دارند که سیگار کشیدن خیلی خطرناک است (گزارش مرکز سلامت استرالیا، ۱۹۹۰).

نوجوانان مضرات و فواید مختلفی را برای سیگار کشیدن برمی‌شمارند. مضرات مصرف سیگار بیشتر مربوط به سلامتی است، درحالی‌که فواید آن اغلب ماهیت اجتماعی دارد (جدول ۶-۲). در بسیاری از نوجوانان، کشیدن سیگار به آنها کمک می‌کند تا به گروه همسالان خود احساس تعلق داشته باشند یا اینکه سبب کاهش ناراحتی و عصبانیت در آنان می‌گردد. سیگار کشیدن همچنین موجب می‌شود که نوجوانان احساس کنند بزرگ شده‌اند.

هورن^۱ و همکاران (۲۰۰۴)، رابطه سلامت روان و ترک سیگار را در نوجوانان روستایی مورد بررسی قرار دادند. آنان بدین منظور ۱۱۳ پسر و ۱۴۵ دختر نوجوان ۱۴ تا ۱۹ ساله روستایی را انتخاب کرده و برای آنها برنامه ۱۰ هفته‌ای ترک سیگار طراحی کردند. این نوجوانان از نظر وضعیت سیگار کشیدن در خط پایه و بعد از شرکت در برنامه ترک سیگار مورد سنجش قرار گرفتند (مانند ترک کامل، کاهش میزان مصرف سیگار و غیره). همچنین وابستگی به نیکوتین، سابقه سیگار کشیدن، افسردگی و اضطراب آنان ارزیابی شد. نتایج نشان داد کلیه آزمودنی‌هایی که در برنامه ترک سیگار شرکت کرده بودند، به‌طورکامل سیگار را ترک کرده بودند یا میزان مصرف سیگار آنان کاهش پیدا کرده بود. همچنین مشاهده شد که میزان افسردگی و اضطراب نوجوانان پس از شرکت در برنامه ترک سیگار کاهش معناداری پیدا کرده بود.

جدول ۶-۲. مضرات و فواید ادراک شده برای مصرف سیگار توسط نوجوانان

مضرات	فواید
خلاف قانون بودن	دختران، پسرانی را که سیگار می‌کشند دوست دارند
دوستان این کار را دوست ندارند	احساس تعلق به گروه
سرطان‌زا بودن	عصبانی کردن والدین
خلاف مذهب بودن	کاری که هنگام عصبانیت انسان را راحت می‌کند
توانایی کشتن افراد	نشان دادن اینکه فرد می‌تواند کارهایی را که می‌خواهد انجام دهد
صدمات و آسیب‌های رانندگی	

منبع: برگرفته از اوربرگ و رابینز^۲، ۱۹۸۱

^۱ . Horn

^۲ . Urberg & Robbins

تفاوت‌های بین فرهنگی

سیلبریزین، نواک و شانپفلاک (۱۹۹۴)، تفاوت‌های فرهنگی موجود در سیگار کشیدن نوجوانان آلمانی و لهستانی را مطالعه کردند. بنابر شواهد و مدارک آنها، نوجوانان و جوانان لهستانی کمتر از جوانان آلمانی سیگار می‌کشند. در میان هر دو گروه، دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستانی بالای شهر، کمتر از دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستانی پایین شهر سیگار می‌کشند. همچنین آنها دریافتند که بهترین پیش‌بینی‌کننده رفتار سیگار کشیدن برای هر دو گروه فرهنگی، میزان عزت نفس آنان است و این عامل اهمیت فوق‌العاده‌ای در زمان‌های مختلف برای هر دو گروه فرهنگی دارد. در نمونه آلمانی، عزت نفس در نوجوانی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و مصرف سیگار بیشتر بود.

مصرف سایر مواد مخدر و داروها

صاحب‌نظران معتقدند مصرف داروهایی نظیر کوکائین، هروئین و ماری‌جوانا، بسیار کمتر از مصرف الکل و کشیدن سیگار است (سویشر^۱، ۱۹۹۱). استفاده از داروهایی نظیر کوکائین، به دلیل تأثیرات شدید روانی اجتماعی و روان‌شناختی، بسیار خطرناک است. مصرف طولانی‌مدت این ماده منجر به واکنش‌های پارانویاگونه، حالات شیدایی - افسردگی شدید یا حالات ترس می‌شود (سولیوان و تامپسون^۲، ۱۹۹۴). مصرف هروئین ضربان قلب را سرعت می‌بخشد، اما استفاده درون‌وریدی از آن خطر ابتلا به ویروس و عفونت ایدز را پیش می‌آورد.

نوجوانان کمتر از ماری‌جوانا استفاده می‌کنند تا سیگار. در مطالعه‌ای که در آمریکا صورت گرفت، مشاهده شد که ۳۳ تا ۵۰ درصد بزرگسالان در طول عمر خود لااقل یک‌بار ماری‌جوانا کشیده‌اند. محققان گزارش کرده‌اند که مصرف ماری‌جوانا نسبت به اواسط دهه ۱۹۷۰، کاهش یافته است.

نوجوانانی که الکل یا سیگار مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض خطر مصرف ماری‌جوانا قرار دارند. پیش‌بینی‌کننده‌های نگرشی و رفتاری، از جمله عوامل مهمی‌اند که مصرف ماری‌جوانا را در هر دو جنس پیش‌بینی می‌کنند. استفاده دوستان از داروها، مواد مخدر و روان‌گردان، عامل اثرگذار مهمی برای هر دو جنس محسوب می‌شود. با این حال، در پسران، درگیری در فعالیت‌های بزهکارانه و اعتقاد به اینکه مصرف ماری‌جوانا ضرری ندارد نیز پیش‌بینی‌کننده‌هایی برای تصمیم‌گیری نوجوان برای مصرف داروها به‌شمار می‌روند. نوجوانانی که ماری‌جوانا مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض

^۱ . Swisher

^۲ . Sullivan & Thompson

خطر شکست تحصیلی و ترک تحصیل قرار دارند. این نوجوانان تمایلات مذهبی ضعیفی داشته و بیشتر به اعمال بزهکارانه گرایش دارند و پرخاشگرترند (کندل، ۱۹۸۲). به نظر می‌رسد که مصرف هروئین در جوانان بسیار کم باشد. برای مثال، در آمریکا فقط هفت دهم درصد (۰/۷ درصد) نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله گزارش کرده‌اند که از داروهای روان‌گردانی نظیر هروئین استفاده می‌کنند (سولیوان و تامپسون، ۱۹۹۴). با این حال امروزه استفاده از داروهای محرک و نیروزا در میان نوجوانان بسیار رایج شده است. در ادامه به معرفی بعضی از این داروها و مواد محرک و آثار منفی آنها خواهیم پرداخت.

شیشه (متامفتامین)

متامفتامین ماده محرک بسیار اعتیادآوری است که بشدت بر سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز و نخاع اثر می‌گذارد. متامفتامین را می‌توان به شیوه‌های مختلفی مصرف کرد؛ شکل تدخینی (دود کردن) آن را شیشه^۱ می‌گویند. شکل ظاهری آن به صورت پودر سفید و شفافی است که بو ندارد و مزه آن تلخ است و به سادگی در آب یا مشروبات الکلی حل می‌شود. به لحاظ شیمیایی ساختار آن شباهت زیادی به آمفتامین دارد، اما تأثیرات آن بر سیستم اعصاب مرکزی بسیار قوی است. همانند آمفتامین موجب افزایش فعالیت و تحریک، کاهش اشتها و احساس شادابی می‌شود. آثار این ماده بین ۶ تا ۸ ساعت طول می‌کشد. بعد از سرخوشی شدید اولیه (Rush)، حالت تحریک‌پذیری پیش می‌آید که در برخی افراد ممکن است به رفتارهای پرخاشگرانه منجر شود.

متامفتامین به شکل تدخینی، کشیدن در بینی، خوراکی و تزریقی مصرف می‌شود. این ماده ممکن است به تغییرات خلقی منجر شود که البته به روش مصرف بستگی دارد. بلافاصله پس از دود کردن یا تزریق آن در رگ، افراد مصرف‌کننده حالت سرخوشی و نشگی شدیدی را به مدت چند دقیقه تجربه می‌کنند که به اعتقاد آنان حالت بسیار لذت‌بخشی است. کشیدن در بینی یا خوردن آن سبب حالت سرخوشی خفیف‌تری می‌شود.

آثار کوتاه‌مدت مصرف متامفتامین چیست؟

این ماده محرک، بسیار قوی است و حتی مصرف مقادیر کم آن می‌تواند سبب بیدار ماندن (بی‌خوابی)، افزایش فعالیت و کاهش اشتها شود. به دنبال تدخین یا تزریق این ماده، حالت کوتاه و

^۱ . glass

شدیدی از سرخوشی عمیق به وجود می‌آید، اما مصرف آن به صورت خوراکی یا کشیدن در بینی حالت خوشی بلندمدتی را به وجود می‌آورد که ممکن است تا نیمی از روز ادامه یابد. اما باید بدانید که هر دو وضعیت (سرخوشی کوتاه‌مدت و سرخوشی طولانی)، ناشی از رها شدن و افزایش بسیار زیاد یک ماده شیمیایی و انتقال‌دهنده امواج عصبی در مغز است که دوپامین نام دارد. به‌طور خلاصه آثار کوتاه مدت مصرف این ماده عبارتند از:

- ۱- افزایش دامنه توجه و کاهش خستگی؛
- ۲- افزایش فعالیت؛
- ۳- کاهش اشتها؛
- ۴- سرخوشی و نشگی؛
- ۵- تنفس تند؛
- ۶- افزایش شدید دمای بدن؛
- ۷- پرحرفی؛
- ۸- افزایش انرژی؛
- ۹- تهوع و استفراغ؛
- ۱۰- خشمگین شدن؛
- ۱۱- اضطراب و تنش؛
- ۱۲- اختلال قضاوت؛
- ۱۳- تند شدن، کند شدن یا بی‌نظمی ضربان قلب؛
- ۱۴- ضعف عضلانی؛
- ۱۵- تشنج؛
- ۱۶- کاهش یا افزایش فشار خون.

آثار بلندمدت مصرف متامفتامین چیست؟

اولین اثر بلندمدت مصرف متامفتامین، وابستگی و اعتیاد است، به گونه‌ای که فرد مصرف‌کننده اجباری درونی برای مصرف مکرر متامفتامین در خود احساس می‌کند که ممکن است با تغییراتی در اعمال مغز، نیز بافت ملکولی آن، همراه باشد. علاوه بر وابستگی، سایر عوارض بلندمدت متامفتامین شامل رفتار پرخاشگرانه، اضطراب، اغتشاش و آشفتگی ذهنی و بی‌خوابی است. علاوه بر این، فرد مصرف‌کننده، ممکن است رفتارهایی حاکی از جنون (روان‌پریشی) از خود نشان دهد؛ نظیر سوءظن و بدگمانی شدید و توهمات شنوایی، بی‌نظمی و اختلال در خلق و بروز توهم (برای مثال احساس

حرکت حشرات روی پوست). بدگمانی و سوءظن فرد مصرف‌کننده در مواقعی ممکن است به اقدام به خودکشی بینجامد.

مصرف بلندمدت آن می‌تواند سبب ایجاد حالت "تحمل" شود، یعنی دیگر حالات سرخوشی با مقدار کم ماده به وجود نمی‌آید و مصرف‌کننده برای دستیابی مجدد به آن حالات یا تشدید آنها، مقادیر مصرف ماده را افزایش می‌دهد یا دفعات مصرف را اضافه می‌کند و در نهایت، ممکن است روش مصرف را تغییر دهد. آثار بلندمدت مصرف متامفتامین عبارتند از:

۱- وابستگی و حالات جنون (روان‌پریشی) ناشی از اعتیاد با علائم زیر:

- سوءظن و بدگمانی؛

- توهم؛

- بی‌نظمی در اختلال خلق؛

- فعالیت‌های حرکتی بیش از اندازه و تکراری.

۲- سکتۀ مغزی

۳- کاهش وزن

قطع مصرف متامفتامین در فرد وابسته، عوارض و نشانه‌های خاصی را به وجود می‌آورد، از جمله افسردگی، اضطراب، خستگی، سوءظن، پرخاشگری و اشتیاق شدید به مصرف مجدد ماده.

عوارض جسمی ناشی از مصرف متامفتامین چیست؟

مصرف این ماده می‌تواند سبب بروز مشکلات متعددی شود که عبارتند از: افزایش ضربان قلب، ضربان نامنظم قلب، افزایش فشار خون و صدمه دیدن رگ‌های مغزی ناشی از سکتۀ مغزی، افزایش دمای بدن و تشنچ، که با مصرف مقادیر زیاد این ماده به وجود می‌آید و اگر بلافاصله درمان نشود، ممکن است به مرگ منجر شود.

مصرف بلندمدت و مزمن متامفتامین سبب تورم پردۀ محافظ قلب می‌شود و در کسانی که آن را تزریق می‌کنند، سبب آسیب رگ‌های خونی و آبنسۀ پوست می‌گردد. مصرف‌کنندگان این ماده در مواردی نیز دچار دوره‌هایی از پرخاشگری، اغتشاش فکری و بی‌خوابی می‌شوند. آنهایی نیز که به این ماده وابسته می‌شوند، دچار اختلالات جدی در روابط اجتماعی و شغلی خود می‌شوند. علائم جنون و روان‌پریشی در مواردی حتی پس از ماه‌ها یا سال‌ها عدم مصرف این ماده ادامه پیدا می‌کند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف این ماده در دوران بارداری سبب بروز مشکلات جنینی، افزایش احتمال زایمان زودرس و تغییر در الگوهای رفتاری دوران نوزادی نظیر رفلکس‌های غیرعادی و

تحریک پذیری بیش از حد می شود. در عین حال مصرف این ماده در دوران بارداری سبب بدشکلی و تغییر شکل اندام ها در جنین می گردد.

ارتباط مصرف متامفتامین و هیپاتیت B و C

افزایش احتمال ابتلا به ویروس HIV و هیپاتیت B و C از پیامدهای افزایش مصرف متامفتامین است، بویژه در افرادی که متامفتامین را تزریق یا از سرنگ مشترک استفاده می کنند. تحقیقات نشان می دهد که مصرف متامفتامین و سایر مواد محرک در کوتاه مدت، برخلاف تریاک، سبب افزایش میل جنسی می شود، ولی تداوم مصرف آن به کاهش میل جنسی بویژه در مردان منجر می شود. در عین حال مصرف این ماده و نیز رفتارهای جنسی پرخطر احتمال ابتلا به ویروس HIV و بیماری ایدز را افزایش می دهد (پیام مشاور، ۱۳۸۵).

هروئین فشرده (کریستال یا کراک)

اخیراً نام ماده جدیدی در رسانه ها به میان آمده است که کریستال یا کراک نام دارد. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد، این ماده همان هروئین است که به شکلی خالص تر و بلورمانند درآمده و در بازار خرید و فروش می شود. روش مصرف این نوع هروئین، تدخین و دود کردن است. این ماده فوق العاده اعتیادآور است و قدرت اعتیادی آن چند برابر از هروئین معمولی (که به صورت پودر است) بیشتر است.

کریستال شکل خالص هروئین است، از این رو، آثار آن همانند پودر هروئین ولی شدیدتر است. شدت این حالت بستگی به مقدار کریستال مصرف شده و سرعت انتقال آن به مغز دارد. در واقع یکی از دلایل اعتیادآور بسیار زیاد هروئین و کریستال این است که خیلی زود به مغز می رسند. بیشتر کسانی که کریستال مصرف می کنند، در ابتدا احساس سرخوشی و نشگی می کنند، همراه با این سرخوشی، بدن فرد گرم تر و دهان خشک می شود و فرد در دست ها و پاها خود احساس سنگینی می کند. در مواقعی نیز فرد مصرف کننده، دچار حالت تهوع و استفراغ و بی قراری شدید می شود. بعد از این حالات اولیه ممکن است تا چند ساعت حالت سرگیجه پیش آید. در این وضعیت تمامی اعمال مغز تحت تأثیر آثار این ماده قرار می گیرد و دچار نابسامانی می شود، حرکات قلب کند شده و تنفس در مواردی آنچنان آهسته می شود که به مرگ می انجامد.

آثار بلندمدت مصرف کریستال

اولین اثر مصرف مداوم کریستال، اعتیاد و وابستگی به آن است. اعتیاد، بیماری مزمن و عودکننده‌ای است که با اجبار درونی برای یافتن مواد و تغییرات سلولی / شیمیایی و مولکولی مغز همراه است. کریستال در عین حال سبب به وجود آمدن تحمل و وابستگی جسمی بسیار شدیدی می‌شود که در نتیجه آن فرد به مصرف اجباری و مجدد آن باز می‌گردد. همانند اعتیاد به هروئین، در این حالت، فرد زمان و انرژی بیشتری را صرف به دست آوردن این ماده می‌کند. بدیهی است با بروز اعتیاد، هدف اصلی زندگی فرد مصرف‌کننده به دست آوردن و مصرف مواد خواهد بود. درواقع کریستال به معنای واقعی کلمه سبب بروز تغییرات بارز در مغز و رفتار می‌شود. وقتی که وابستگی جسمی به کریستال به وجود می‌آید، بدن فرد به حضور این ماده در بدن عادت می‌کند؛ به گونه‌ای که اگر مصرف آن به یک باره قطع شود، علائم محرومیت بروز می‌کند. این علائم اغلب چند ساعت پس از آخرین مصرف نمایان می‌شوند و شایع‌ترین آنها عبارتند از:

- بی‌قراری؛
- درد استخوان و عضلات؛
- بی‌خوابی؛
- اسهال؛
- استفراغ؛
- حرکات غیرارادی در پاها.

تا مدت‌ها تصور بر این بود که وابستگی و اعتیاد جسمی، علائم محرومیت و تلاش فرد برای رهایی و کاهش این علائم، علت اصلی اعتیاد است، اما در حال حاضر روشن شده که این مسئله تنها دلیل نیست، چراکه در موارد متعددی ثابت شده است که اشتیاق فرد برای مصرف دوباره و عود مصرف، ممکن است هفته‌ها و ماه‌ها در پی از بین رفتن علائم ترک به وجود آید. همین نکته در مورد کریستال نیز صدق می‌کند. در واقع کریستال نیز همانند هروئین نه تنها (مغز) فرد را به خود وابسته می‌کند، بلکه با وابسته کردن روان فرد، در وی میلی دائمی برای مصرف پدید می‌آورد.

قرص‌های ریتالین

قرص ریتالین (متیل فندایت)

قرص‌های ریتالین در اصل برای درمان یکی از انواع اختلالات روانی دوران کودکی به نام "بیش‌فعالی همراه با نقص توجه" به کار می‌رود. گاه نیز برای درمان بیماران مبتلا به "حمله خواب"

تجویز می‌شود، ولی در سال‌های اخیر مصرف خودسرانه این دارو در کشور ما رو به افزایش گذاشته است و عدم آگاهی از آثار و ویژگی‌های این قرص نگران‌کننده است. هم‌اکنون گزارش‌های متعددی وجود دارد که برخی از افراد برای بیدار ماندن در شب‌های امتحان به جای مصرف چای و قهوه از قرص‌های ریتالین استفاده می‌کنند. شواهد متعدد حاکی از آن است که این افراد از این قرص‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند چندین ساعت متوالی بیدار بمانند و به شکل غیرمعمولی تمرکز خود را در مدت طولانی حفظ کنند.

آثار مصرف ریتالین

چون ریتالین دارویی است که پزشکان تجویز می‌کنند، مصرف‌کنندگان آن را بی‌خطر و فاقد "بدنامی" مواد مخدر می‌دانند، درحالی‌که عوارض مصرف خودسرانه این قرص‌ها می‌تواند در حد مواد دیگر نظیر کوکائین و آمفتامین باشد. شایع‌ترین عوارض مصرف خودسرانه قرص‌های ریتالین عبارتند از:

- عصبی شدن و بی‌خوابی؛
- حالت تهوع و استفراغ؛
- احساس سرگیجه و سردرد؛
- تغییرات ضربان قلب و فشار خون (که اغلب به صورت افزایش است، ولی در مواردی نیز به شکل کاهش دیده می‌شود)؛
- خارش و جوش‌های پوست؛
- دردهای شکمی، کاهش وزن و مشکلات معده؛
- مصرف دائمی و اعتیاد(وابستگی)؛
- بروز حالت‌های روان‌پریشی(جنون) و علائم وابستگی به ریتالین؛
- بروز افسردگی پس از قطع مصرف.

عوارض مصرف مقادیر زیاد ریتالین

- از دست دادن اشتها و سوء تغذیه؛
- لرزش و پرش عضلات؛
- تب، تشنج و سردرد؛

- نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس که در مواردی ممکن است به شکل خطرناکی ادامه پیدا کند؛
- تکرار حرکات و اعمال بی هدف؛
- بروز حالت‌های پارانوئید (سوءظن)، توهم و هذیان؛
- احساس حرکت و جنبش حشرات در زیر پوست؛
- مرگ (تاکنون در چند مورد، سوءمصرف ریتالین به مرگ منجر شده است) (پیام مشاور، ۱۳۸۵).

آثار منفی سوءمصرف حشیش

- ۸۰ درصد کسانی که به مواد مخدر دیگر وابستگی دارند، سابقه مصرف حشیش، بویژه در نوجوانی و جوانی، داشته‌اند.
- مهارت‌های محاسبه، تمرکز، حافظه و یادگیری ۲۴ تا ۴۸ ساعت در دانشجویانی که حشیش و ماری‌جوانا مصرف می‌کنند، مختل باقی می‌ماند.
- مصرف یک سیگاری حشیش در ۱۰ نفر به طور تصادفی، منجر به وابستگی حداقل یک نفر آنان تا پایان عمر می‌شود.
- حشیش اعتیادآور است.
- ترک مصرف حشیش همانند قطع مصرف الکل و داروهای خواب‌آور و تریاک و هروئین با بی‌قراری و اضطراب، بی‌اشتهایی، لرزش و تنش عضلانی همراه است.
- مصرف حشیش با احتمال ایجاد بیماری روانی شدید در حد جنون ماندگار همراه است.
- اضمحلال شناختی با مصرف طولانی مدت حشیش، تا سال‌ها بعد از قطع کامل مصرف، باقی می‌ماند.
- مصرف درازمدت حشیش موجب ایجاد اختلال بی‌انگیزگی مزمن می‌شود.
- مصرف حشیش موجب افزایش ضربان قلب، افت فشار خون، قرمزی چشم‌ها، احساس گرسنگی زیاد و خشکی دهان می‌شود.
- مصرف حشیش موجب کاهش تمرکز، توجه و قدرت شناختی می‌شود.
- مصرف حشیش به از بین رفتن هماهنگی بدن، حواس و رفتار حرکتی منجر می‌شود.

- مصرف حشیش موجب ناتوانی در انجام دستورات پیچیده، کاهش بازداری اجتماعی در رفتار، سرخوشی کاذب، اضطراب شدید و حملات هراس ناگهانی همراه با احساس ترس و بدگمانی و مرگ ناگهانی می‌شود.
- مصرف هر سیگار حشیش، از نظر خطر ایجاد سرطان ریه و دیگر مشکلات ریوی با مصرف ۶-۸ سیگار معمولی برابری می‌کند.
- مصرف درازمدت حشیش موجب کاهش اندازه بیضه، هورمون مردانه و تعداد اسپرم در آقایان و افزایش خطر ناباروری و قاعدگی نامنظم و تغییرات هورمونی در خانم‌ها شده و در نتیجه به کاهش توانایی جنسی در هر دو جنس منجر می‌شود.
- مصرف درازمدت حشیش موجب تخریب قشر مغز بخصوص قسمت جلو پیشانی و در نتیجه اختلال در هماهنگی‌های ذهنی، عاطفی و رفتاری می‌شود.

آثار منفی سوء مصرف اکستاسی (X)

- به علت تولید غیرقانونی قرص‌های اکستاسی، بیشتر آنها از نظر میزان ماده مؤثر و وجود ترکیبات آلاینده و همراه، غیرقابل پیش‌بینی‌اند.
- موارد متعدد مرگ ناگهانی، فقط با مصرف یک قرص X، گزارش شده است.
- وابستگی به اکستاسی هم جسمانی و هم روانی است.
- احتمال ایجاد جنون پایدار، حتی در افراد کاملاً سالم با مصرف اکستاسی به اثبات رسیده است.
- مصرف‌کنندگان X، اذعان داشته‌اند برای رسیدن به یک تا چند ساعت احساس شادی، ۶ روز دیگر هفته را با افسردگی کلنچار رفته‌اند.
- اکستاسی در بدن اثر دوگانه دارد، یعنی هم شبیه به مواد محرک موجب تحریک بیش از حد سیستم‌های مختلف بدن و مغز می‌شود و هم مانند مواد توهم‌زا مثل LSD فرد را با ایجاد توهم و هذیان دچار جنون آنی می‌کند.
- اکستاسی در بدن به موادی تبدیل می‌شود که به نابودی سلول‌های مغزی می‌انجامند.
- مصرف اکستاسی به نرون‌های مغز آسیب می‌رساند و موجب خونریزی در داخل مغز، افزایش ضربان قلب و فشارخون و نارسایی‌های کلیه و کبدی و افزایش شدید درجه حرارت بدن می‌شود.

- مصرف اکستاسی به افسردگی، اضطراب فراگیر، گمگشتگی، رفتارهای پرخطرانه و سوءظن در دوران مصرف، یا هفته‌ها پس از مصرف، می‌انجامد (پیام مشاور، ۱۳۸۵).

قضایات‌های اجتماعی در مورد مصرف مواد

نوجوانان معتقدند که مصرف منظم داروهای نظیر کوکائین و ماری‌جوانا، بسیار آسیب‌رسان‌تر از مصرف منظم الکل است و آثار زیانبار این مواد اگر فقط یک یا دو مرتبه مصرف شوند، به نسبت کمتر است. ۶۸ درصد نوجوانان اظهار داشتند که بیشتر دوستان آنها الکل و ۸/۲ درصد آنان اعلام کردند که دوستانشان ماری‌جوانا مصرف می‌کنند؛ این مقدار برای مصرف کوکائین برابر با ۶/۲ درصد گزارش شده است (سویشر، ۱۹۹۱).

هر چه نوجوان داروی بیشتری مصرف کند، احتمال اینکه دیدگاه مثبت‌تری در مورد مصرف دارو داشته باشد، بیشتر بوده و فکر می‌کند مصرف دارو بی‌ضرر است. در مطالعه‌ای، از دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان خواسته شد تا اطلاعاتی در مورد مصرف داروهای مختلف توسط خودشان در اختیار محققان قرار دهند، سپس دیدگاه خود را درباره تأثیرات ادراک‌شده مصرف دارو بیان کنند. محققان دریافتند آزمودنی‌هایی که کمتر دارو مصرف می‌کردند، مصرف دارو را بسیار نادرست‌تر از نوجوانانی می‌دانستند که بارها دارو مصرف می‌کردند. به علاوه نوجوانانی که زیاد از مواد و داروها مصرف می‌کردند، بیشتر از آنهایی که کمتر دارو مصرف می‌کردند، به این رفتارها به منزله مسائل و موضوعات شخصی نگاه می‌کردند. در مقابل، نوجوانانی که کمتر از داروها استفاده می‌کردند، به والدین خود و مسئولان به عنوان افرادی نگاه می‌کردند که برای کنترل، اصلاح و تنظیم رفتار آنان، حق و قدرت قانونی دارند. بنابراین برای نوجوانانی که زیاد از داروها استفاده می‌کردند، چنین رفتارهایی جنبه شخصی و خصوصی داشتند و خودشان در مورد آنها تصمیم می‌گرفتند (نوسی^۱ و همکاران، ۱۹۹۱؛ به نقل از هیون، ۱۹۹۶).

نشانه رفتار مشکل‌آفرین

آیا نوجوانانی که از مواد تحریک‌کننده و محرک استفاده می‌کنند، در سایر اشکال غیرقابل قبول رفتار نیز مشارکت بیشتری دارند؟ به نظر جسور، دوناوان و کاستا^۲ (۱۹۸۸)، یک عامل منفرد کلی در انجام بیشتر رفتارهای مشکل‌آفرین نوجوانان نقش دارد. این صاحب‌نظران اظهار کرده‌اند رفتارهایی

^۱ . Nucci

^۲ . Jessor, Donovan & Costa

نظیر مصرف مواد تحریک‌کننده، مشکلات مشروب‌خواری، بزهکاری و تجاوزهای جنسی، اشکال مختلف رفتار مشکل‌آفرین‌اند.

ارتباط بین مصرف مواد مخدر و اقدام به فعالیت‌های جنسی بویژه انجام رفتارهای جنسی مشکل‌آفرین و خطرناک، بسیار مهم است. درحالی‌که نتایج پژوهش‌ها نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت بین مصرف مواد مخدر و انجام رفتارهای جنسی خطرآفرین است، اما تعیین علت در اینجا بسیار مشکل است و به‌سختی می‌توان گفت که مصرف مواد مخدر دلیل انجام فعالیت‌های جنسی خطرناک است، زیرا احتمال دارد که هم مصرف مواد مخدر و هم رفتارهای جنسی خطرناک نوجوان مربوط به گروهی از متغیرهای شخصی و اجتماعی دیگری باشد که مدنظر قرار نگرفته‌اند (برای مثال اعتیاد والدین). در این زمینه، رشاد و کاستنر^۱ (۲۰۰۴) با استفاده از داده‌های یک طرح مطالعه طولی ملی که در مورد سلامت نوجوانان صورت گرفته بود، دریافتند که مصرف مواد مخدر علت اقدام به فعالیت‌های جنسی خطرناک در نوجوانان بویژه نوجوانان دختر است.

در یک مطالعه طولی در آمریکا، نوجوانان از دوره راهنمایی تا دبیرستان مورد مطالعه قرار گرفتند. شواهد نشان داد که رفتارهای مشکل‌آفرین به‌طور معناداری با یکدیگر مرتبط‌اند و می‌توان آنها را توسط یک عامل تأثیرگذار کلی و مشترک که نویسنده آن را غیرمتعارف بودن معرفی کرده است، تبیین کرد (دونوان و جسور، ۱۹۸۵).

به‌نظر می‌رسد که برخی رفتارها بیشتر از سایر رفتارها به‌عنوان غیرمتعارف تعیین می‌شوند. این رفتارها به ترتیب اهمیت عبارتند از:

- دفعات نوشیدن مشروب؛

- مصرف ماری‌جوانا؛

- انحرافات کلی؛

- تجارب جنسی.

بنابر نظریه رفتار مشکل‌آفرین، اغلب روابط بین سه حوزه، یعنی نظام شخصیتی، نظام محیطی ادراک‌شده و نظام رفتاری، برای تبیین رفتارهای مشکل‌آفرین کفایت می‌کند. براساس این نظریه، رفتار تابعی از تعامل بین شخص و محیط است. دو دلیل برای این نگرش ارائه شده است؛ اولاً، عوامل آشکارکننده مشروب‌خواری در سال‌های نوجوانی، نظیر توانایی استقلال یافتن از والدین، پدیده‌ای تحولی و طبیعی است؛ ثانیاً اعتقاد بر این است که مشروب‌خواری باید توسط بافت اجتماعی یا محیطی که در آن رخ می‌دهد، تعریف شود.

^۱ . Rashad & Kastner

فارو و فرنچ^۱ (۱۹۸۶) با مصاحبه با ۹۱ نوجوان بزهکار، دریافتند بین مصرف مواد توسط نوجوانان و والدین آنها و انجام رفتارهای بزهکارانه و جرم‌آفرین آنان در آینده رابطه تنگاتنگی وجود دارد.

چارچوب‌ها و دیدگاه‌های نظری

در حال حاضر، به‌طور کامل اثبات شده که فرایندهای روان‌شناختی مختلفی، مراحل مختلف رفتار اعتیاد به داروها و مواد مخدر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این بخش دو مرحله زیر برای مصرف داروها و مواد مخدر مورد بحث قرار می‌گیرند؛ شروع مصرف دارو و ادامه مصرف دارو.

شروع مصرف دارو و مواد

در این قسمت، مطالعات تحقیقی‌ای مطرح می‌شوند که فرایند شروع مصرف مواد را در نوجوانان بررسی کرده‌اند. این تحقیقات را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد؛ یکی عوامل ژنتیکی و دیگری عوامل روانی اجتماعی خاص.

زمینه‌های ژنتیکی

بحث اصلی در این مورد این است که بعضی نوجوانان زمینه‌های ژنتیکی برای مصرف مواد دارند، با این حال، بعضی صاحب‌نظران معتقدند وراثت و ویژگی‌های ژنتیکی با عوامل محیطی خاصی در تعامل قرار می‌گیرند و منجر به مصرف مواد می‌شوند. محققان به‌منظور بررسی این علل مختلف به مطالعه دوقلوهای همسان، خواهر و برادرهای ناتنی و فرزندخوانده‌ها می‌پردازند.

بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده بر روی دوقلوهای همسان و غیرهمسان، نشان‌دهنده تأثیر قدرتمند عوامل ژنتیکی بر الکلیسم‌اند. مروری بر تحقیقات انجام‌شده طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۷، نشان می‌دهد که هماهنگی در مصرف الکل در دوقلوهای همسان، بسیار بیشتر از دوقلوهای ناهمسان است (هیون، ۱۹۹۶).

در مرور دیگری که بر ادبیات صورت گرفت، نتایج پژوهش‌های انجام‌شده بر روی ۱۶,۰۰۰ دوقلوی پسر که از نظر میزان شیوع و هماهنگی در الکلیسم، روان‌پریشی ناشی از الکل، سیروز کبدی و مشکلات لوزالمعده، طبقه‌بندی شده بودند، بررسی شد. میزان هماهنگی در تمام اختلالات مذکور

^۱ . Farrow & French

به غیر از مشکلات لوزالمعده‌ای در تمام دوقلوهای یکسان دو برابر دوقلوهای ناهمسان بود. این یافته‌ها نشان‌دهنده تأثیر قدرتمند عوامل ژنتیکی است. مطالعات انجام‌شده روی خواهر و برادرهای ناتنی و فرزندخوانده‌ها که روش خوبی برای جداکردن تأثیرات ژنتیکی و محیطی است، نیز نشان‌دهنده نقش مهم عوامل ژنتیکی در مصرف الکل و الکلیسم است (ادیتیان جی و مورای^۱، ۱۹۹۹). به‌نظر می‌رسد بین افراد الکلی و غیرالکلی تفاوت‌های فیزیولوژیکی وجود داشته باشد. برای مثال، بعضی محققان گزارش کرده‌اند کودکان والدین الکلی در مقایسه با کودکان گروه کنترل، دارای سطح تحمل اولیه‌ای برای اتانول هستند و ریتم آلفای آنها در EEG^۲ کمتر است. پسران پدران الکلی نیز عملکرد کلامی و ذهنی کمتری را نشان می‌دهند و تفاوت‌های عصب روان‌شناختی دیگری با پسران پدران غیرالکلی دارند. به‌طور خلاصه، شواهد نشان می‌دهد که ممکن است عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیکی (وراثت) زمینه‌ساز مصرف مواد در بعضی از نوجوانان باشند (هیون، ۱۹۹۶).

پیش‌بینی‌کننده‌های روانی اجتماعی

عوامل روانی اجتماعی مختلفی در شروع مصرف مواد مخدر و داروها نقش دارند. این عوامل عبارتند از: مصرف مواد توسط همسالان و والدین، آسیب‌های اجتماعی والدین، عزت نفس پایین، تنیدگی‌ها و فقدان تأیید اجتماعی (گرین، ۱۹۷۹؛ مارلات^۳ و همکاران، ۱۹۸۸).

پژوهش‌های بسیاری تأثیر مصرف مواد توسط والدین و همسالان را در نوجوانان بررسی کرده‌اند. کندل (۱۹۹۰)، دریافت که نقش مصرف مواد توسط دوستان نوجوان بسته به این است که نوجوان عضو فعالی از گروه همسالان خود باشد یا نه. نوجوانانی که دوستانشان سیگار نمی‌کشند یا ماری‌جوانا مصرف نمی‌کنند، باورها و نگرش‌های مشابهی در مورد استفاده از مواد و داروها و کیفیت تعامل با والدین دارند. در هر حال، نوجوانانی که فعالانه با گروه همسالان در تعامل‌اند و دوستانی دارند که ماری‌جوانا می‌کشند، از ماری‌جوانا و دیگر داروهای تحریک‌کننده بیشتر استفاده می‌کنند تا نوجوانانی که دوستانشان کمتر ماری‌جوانا مصرف می‌کنند. پسران نوجوانی که دوستان آنها ماری‌جوانا می‌کشند، خطرهای سلامتی مرتبط با مصرف ماری‌جوانا را بسیار ناچیز می‌دانند و به آن توجهی نمی‌کنند و این کار را به‌منزله نوعی سازوکار مقابله‌ای به‌کار می‌گیرند. درحالی‌که مصرف ماری‌جوانا در دختران نوجوان، نشانه استقلال، بلوغ و خودمختاری است. اگر والدین نوجوانان از مواد مخدر و داروها استفاده کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که آنها نیز این کار را انجام دهند، این مواد عبارتند

^۱ . Adityanjee & Murray

^۲ . Electroence phalography (EEG)

^۳ . Marlatt

از: سیگار، باربیتورات‌ها و الکل. نظریه‌پردازان یادگیری معتقدند این کار از طریق الگودهی یا سرمشق‌گیری از والدین آموخته می‌شود. از طرفی مشاهده شده اختلالات روانی والدینی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، قابل انتقال به کودکان آنان است. کلارک^۱ و همکاران (۲۰۰۴) خطر انتقال آسیب‌های روانی والدین مبتلا به اختلال مصرف مواد به کودکان آنها را مورد مطالعه قرار دادند. آنان بدین منظور ۱۱۶۷ کودک و نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله (۶۲ درصد پسر و ۳۸ درصد دختر) متعلق به ۶۱۳ خانواده را انتخاب کردند و مورد مطالعه قرار دادند. شایان ذکر است که والدین ۲۹۴ خانواده کاملاً معنادار و دارای اختلالات روانی و ۳۱۹ خانواده فاقد اعتیاد و اختلالات روانی بودند. نتایج نشان داد که کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده‌های معنادار به مواد مخدر، در سطح بالایی مبتلا به اختلالات سلوکی، اختلال بیش‌فعالی همراه با نقص توجه، افسردگی و اضطراب بودند. این محققان نتیجه گرفتند که این نتایج نشان‌دهنده قابلیت انتقال اختلالات روانی از والدین معنادار به کودکان آنهاست. یافته‌های پژوهشی منتشر شده در گزارش معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی (۱۳۷۵) نشان می‌دهند که ۷۲ درصد از معتادان استان مرکزی متولد شهر و ۲۸ درصد آنان متولد روستا بوده‌اند، درحالی‌که ۸۳ درصد این معتادان در شهر سکونت داشته‌اند. از نظر میزان تحصیلات نیز ۸ درصد آنان بی‌سواد، ۳۸ درصد آنان در مقطع ابتدایی، ۲۵ درصد در مقطع راهنمایی و ۲۸ درصد در مقطع متوسطه و ۲ درصد در مقطع تحصیلات عالی بوده‌اند. همچنین مشاهده شد که ۲۸ درصد این معتادان، در خانواده‌هایی زندگی می‌کردند که لااقل یکی از اعضای خانواده آنان معنادار بوده است.

در گزارش فیروزآبادی (۱۳۷۵) نیز سنین افراد معتاد چنین آمده است: ۳۳/۸ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۷/۵ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۷/۵ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۲/۵ درصد ۶۰ سال و بالاتر گزارش شده است. همچنین براساس این بررسی ۷۶/۲۵ درصد متأهل و ۲۱/۲۵ درصد مجرد بودند و ۲/۵ درصد آنها از همسر خود جدا شده بودند. در این گزارش سن شروع مصرف نیز قابل توجه است، ۴۰ درصد معتادان، سن آغاز مصرف را بین ۳۱ تا ۴۰ سالگی و مابقی سن شروع مصرف مواد را در دوران نوجوانی و جوانی گزارش کرده‌اند.

بنابر گزارش رفیعان (۱۳۷۵) که ۴۰۰ معتاد بستری در مرکز بازپروری یزد را مورد بررسی جمعیت‌شناختی قرار داده است، ۵۷/۴ درصد از این افراد، حداقل یک معتاد در خانواده خود داشته‌اند. نکته مهم‌تر اینکه ۸۲ درصد معتادان درباره مضرات اعتیاد و مصرف مواد بی‌اطلاع بوده‌اند. با این حال

^۱ . Clark

هنوز مطالعه جامعی درخصوص بررسی همه‌گیرشناسی اعتیاد در کشور ما انجام نشده است (بهرامی احسان، ۱۳۸۳).

ستاری و اعظمی (۱۳۸۳) در پژوهشی میزان گرایش به مصرف مواد مخدر را در افراد بالای ۱۰ سال در استان اردبیل مورد بررسی قرار دادند. آزمودنی‌ها شامل ۵۹۸ نفر از افراد ۱۰ سال به بالای این استان بودند که در قالب ۱۵۰ خانوار برآورد شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان گرایش به اعتیاد در گروه‌هایی از قبیل بیکاران، بیسوادان، روستائیان، حاشیه‌نشینان شهرها و خانواده‌های دارای مصرف مواد بالا است.

آمار و ارقام گزارش شده توسط معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان مرکزی (۱۳۷۵) درمورد معتادان اعزام شده و یا خودمعرف به مراکز بازپروری ایران، نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد معتادان در بخش خصوصی و فقط ۸/۶ درصد آنان در بخش دولتی شاغل بوده‌اند و از آنجا که رقابت در بخش خصوصی شدیدتر بوده و متعاقب آن موفقیت و دستاوردها نیز بیشتر است، چه بسا افرادی که از صحنه رقابت حذف شده‌اند، به مواد مخدر گرایش یافته‌اند.

در تحقیق صدیق سروستانی (۱۳۷۵) مشاهده شد که بیشتر نمونه‌های مورد بررسی، قبل از مصرف تریاک یا هروئین سیگاری بوده‌اند. زرگر (۱۳۷۸) مشاهده کرد که مصرف سیگار بین تمام معتادان زندانی رایج است. براتوند (۱۳۷۸) با مطالعه کودکان خیابانی شهرستان اهواز دریافت که ۹۰ درصد یک نمونه ۴۳ نفره از این کودکان سیگاری بودند. شایان ذکر است که میانگین سن این کودکان ۱۲/۵ سال بود و هیچ‌کدام از آنها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند.

بشارت (۱۳۷۹) به بررسی نقش متغیرهای خانوادگی در پدیدآیی اختلالات مصرف مواد پرداخته است. یافته‌های او نشان می‌دهد که بین فزون حمایت‌گری مادران و حرمت خود فرزندان آنان رابطه مثبت و معنادار و بین فزون حمایت‌گری مادران و سن اختلال مصرف مواد فرزندان آنان (سن شروع و سن معتاد شدن) همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین مشاهده شد فراتر از آنچه به عنوان نقش مؤثر متغیرهای خانوادگی اعم از جنبه‌های مربوط به مواد در رفتار والدین (نوع مصرف مواد در والدین، نگرش والدین درمورد مواد و غیره) و جنبه‌های غیرمرتبط با مواد در رفتار والدین و خانواده (مدیریت ضعیف، تعارض خانوادگی، پیوندهای ناپایدار و غیره) بر اختلالات مصرف مواد مطرح شده است، این متغیرها از زاویه‌های دیگر نیز بر پدیدآیی و شکل‌گیری اختلالات مصرف مواد تأثیر می‌گذارند. عزت نفس کاذب و خودبزرگ‌پنداری، خواه محصول فزون‌حمایت‌گری مادر باشد، خواه نتیجه نگرش‌ها و انتظارات خانوادگی و اجتماعی برخاسته از توانمندی‌های اقتصادی و

موقعیت‌های اجتماعی خانواده، یکی از ساز و کارهای اصلی پدیدآیی اختلالات مصرف مواد محسوب می‌شود.

بروک^۱ و بروک (۱۹۹۰)، متغیرهای تعیین‌کننده مصرف مواد و داروها را مطرح کرده‌اند که عبارتند از:

عوامل کودکی

شخصیت کودک و

عوامل خانوادگی.

شخصیت والدین و مصرف مواد توسط آنها

متعارف بودن؛

کنترل هیجانات؛

مصرف مواد توسط والدین؛

عملکردهای درون‌روانی.

هماهنگی زوجین

شخصیت نوجوان

متعارف بودن؛

کنترل هیجانات؛

روابط خواهر و برادرها؛

روابط درون شخصی؛

عملکردهای درون‌روانی؛

روابط والد - نوجوان؛

دلبستگی دوجانبه.

نتایج پژوهش موسوی (۱۳۸۳) در مورد ویژگی‌های کمی و کیفی عملکرد خانواده در نوجوانان معتاد نشان داد که حضور پدر در خانواده‌های دارای نوجوان معتاد از نظر فیزیکی و عاطفی بسیار کم‌رنگ و قوانین انضباطی نامناسب و کنترل نامطلوب است. میزان همبستگی در این خانواده‌ها ضعیف و درگیری بین پدر و مادر و نوجوان معتاد زیاد است.

در پژوهشی حیدرنیا و چرخیان (۱۳۸۵) کیفیت رابطه والد-فرزندی را در نوجوانان معتاد و عادی شهر تهران مقایسه کردند. آنان بدین منظور ۳۰ نوجوان معتاد مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد

^۱ . Brook

تهران و ۳۰ نوجوان غیرمعتاد را با رعایت همتاسازی از بین دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران انتخاب کرده و مورد مطالعه قرار دادند. آن‌ها دریافتند که کیفیت رابطه والد-فرزندی (پدر-فرزند و مادر-فرزند) در نوجوانان عادی در کلیه ابعاد بهتر از نوجوانان معتاد بود. همچنین مشاهده شد که در نوجوانان معتاد کیفیت رابطه با مادر به گونه معناداری بهتر از کیفیت رابطه با پدران بود.

صولتی، نیک فرجام و دریس (۱۳۸۳) ۷۲۴ نفر از بیماران مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی کلینیک ویژه بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد را به صورت تصادفی در طول یک سال انتخاب و مورد مطالعه قرار دادند که ۴۹/۴ درصد از این افراد اظهار کردند که لااقل یکی از اعضای خانواده آنان دارای سوءمصرف یا وابستگی به مواد بوده و این مسئله در بروز یا عود بیماری آن‌ها نقش اساسی داشته است. از این گروه ۶۶/۵ درصد زنان و ۳۲/۲ درصد مردان وجود سوء مصرف یا وابستگی به مواد را در همسر و فرزند خود و ۳۳/۵ درصد زنان و ۲۷/۷ درصد مردان چنین مسئله‌ای را در خانواده خود گزارش کردند. همچنین رابطه معناداری میان سوء مصرف و وابستگی به مواد در همسر و فرزند و خانواده بیمار با متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و شغل به دست آمد. نتایج پژوهش دیگری نشان داد که احتمال این که همسر، فرزند یا خانواده فرد مبتلا به افسردگی، دارای سوء مصرف یا وابستگی به مواد باشند دو برابر فردی است که مبتلا به سایر اختلالات روانی است. اکثر این بیماران اشاره کردند که اختلال روانی آن‌ها منبث از درگیری اعضای خانواده (همسر، فرزند، پدر، مادر و خواهر و برادر) با مواد مخدر است.

نظام همسالان

همان‌طور که مشاهده می‌شود، عوامل روانی اجتماعی مختلفی نظیر عوامل بیولوژیکی، بین فردی، درون فردی و فرهنگی اجتماعی در مصرف مواد نقش دارند. با این حال، در مورد یک فرد خاص، برخی عوامل تأثیر بیشتری از سایر عوامل دارند و ممکن است برخی از حوزه‌ها در برخی از مراحل مصرف مواد مهم‌تر باشند.

بروک و بروک (۱۹۹۰)، نشان دادند همسالان تأثیر زیادی در تعداد دفعات مصرف داروها و مواد مخدر دارند، اما به احتمال زیاد خانواده و عوامل شخصیتی، مرحله استفاده از مواد مخدر را توسط فرد تعیین می‌کنند. بنابراین عوامل خانوادگی و عامل همسالان، اثر متقابلی در تعیین مصرف مواد توسط نوجوان دارند.

پیل گریم، آبی و کرشاو^۱ (۲۰۰۴)، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم میزان پیوستگی خانوادگی را در مادران و نوجوانان بر نگرش نوجوانان نسبت به مصرف مواد مخدر بررسی کردند. ۲۲۵ نوجوان و مادران آنها، آزمودنی‌های این پژوهش را تشکیل می‌دادند. نتایج نشان داد که پیوستگی خانوادگی بیشتر در دوره راهنمایی و دبیرستان به‌طور مستقیم با دارا بودن نگرش منفی در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان مرتبط است. عواملی که اثر پیوستگی خانوادگی را بر نگرش منفی نسبت به مصرف مواد واسطه‌گری می‌کردند، شامل دلبستگی به همسالان و آموزشگاه، انجام فعالیت‌های مذهبی توسط افراد خانواده و نگرش مادران به مصرف مواد توسط کودکان بود.

روابط بین خواهران و برادران، بویژه روابط با خواهر و برادرهای بزرگ‌تر، نقش مهمی در مصرف مواد مخدر توسط فرد دارد. برای مثال، برادرهای کوچک‌تر ممکن است در رفتار خود از برادران بزرگ‌تر الگو و سرمشق بگیرند.

آیا نقش عوامل درون‌فردی در تعیین مصرف مواد توسط فرد بیشتر از نقش عوامل بین‌فردی است؟ فلانری^۲ و همکاران (۱۹۹۴) دریافتند که هم در دختران و هم در پسران اسپانیایی و روسی، عوامل بین‌فردی در مقایسه با عوامل درون‌فردی پیش‌بینی‌کننده مهم‌تری برای مصرف مواد و داروها به‌شمار می‌روند. داشتن دوستان بیشتر و صمیمی‌تر و نداشتن دوستان صمیمی که مواد مخدر مصرف کنند و تأثیرپذیری از همسالان، از عوامل بسیار مهم و کلیدی در این زمینه‌اند.

باید توجه داشت که استفاده افراطی نوجوانان از مواد مخدر، اثرهای منفی شدیدی بر سلامت آنان به‌جای می‌گذارد. نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که تعداد بسیار کمی از نوجوانان به طرف استفاده از مواد خطرناکی چون کوکائین و هروئین می‌روند، زیرا این مواد خطرناک آثار جدی و شدیدی بر سلامت نوجوانان داشته و با بزهکاری، قتل، فحشا و تجاوز جنسی در نوجوانان رابطه قدرتمندی دارد. همچنین دیده شده که استفاده از ماری‌جوانا، زمینه را برای استفاده از کوکائین و هروئین فراهم می‌کند و یکی از پیش‌بینی‌کننده‌های مهم برای مصرف هروئین به‌شمار می‌رود. با این حال، عوامل روانی - اجتماعی و بیولوژیکی زیادی در استفاده و روی آوردن به مواد مخدر نقش دارند، از جمله عوامل شخصیتی مانند میزان عزت‌نفس، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی مانند فقر.

^۱ . Pilgrim, Abbey & Kershaw

^۲ . Flannery

عوامل زیست‌شناختی و شخصیتی

در سال‌های اخیر موضوعی که بسیار مورد توجه قرار گرفته این است که آیا نشانه‌های زیست‌شناختی‌ای وجود دارند که بتوانند افراد الکلی را از افراد غیرالکلی جدا کنند. بعضی معتقدند افراد الکلی در مقایسه با افراد غیرالکلی فعالیت پلاکت کمتری در مونوآمین اکسیداز^۱ خود دارند (مزیچ^۲ و همکاران، ۱۹۹۴). در واقع، فعالیت مونوآمین اکسیداز با صفات شخصیتی خاصی مرتبط است (مانند هیجان‌طلبی) که ممکن است نشان‌دهنده این واقعیت باشد که عوامل زیست‌شناختی در رابطه بین مصرف الکل و شخصیت نقش دارند.

طی پژوهش‌هایی، فعالیت MAO در دختران مصرف‌کننده الکل و گروه کنترل مقایسه شد. در این مطالعات، تفاوت در صفات شخصیتی مانند خوش‌بینی، صمیمیت و نزدیکی اجتماعی، واکنش به تنش، اجتناب از آزار و اذیت، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، پرخاشگری و انزوا نیز بررسی شد. نتایج این مطالعات نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه نوجوان از نظر فعالیت MAO وجود نداشت. اگرچه فعالیت MAO به خودی خود نمی‌تواند مصرف الکل را در این نمونه تبیین کند، با این حال، فعالیت MAO می‌تواند در ترکیب با صفات شخصیتی خاصی منجر به مصرف الکل شود، صفاتی چون خلق و خوی عاطفی پیچیده (مزیچ و همکاران، ۱۹۹۴).

در پژوهشی قریشی‌زاده و ترابی (۱۳۸۱) عوامل مؤثر در وابستگی به مواد مخدر را در ۲۰۰ نفر از معتادان مرد مراجعه‌کننده به مرکز خودمعرفی شهر تبریز بررسی کردند. یافته‌ها نشان داد که ۴۶ درصد مراجعه‌کنندگان در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال، ۶۵ درصد در سطح زیر دیپلم و ۷۸ درصد متأهل بودند. رایج‌ترین ماده مصرفی، تریاک (در ۸۰ درصد موارد) بود. در مورد علل گرایش و شروع مصرف، شایع‌ترین علت، فشار دوستان و معاشرت با دوستان ناباب (۲۸ درصد)، پس از آن به ترتیب لذت‌جویی و مصرف تفننی (۲۶ درصد)، فرار از درد و ناراحتی جسمی (۱۹ درصد) و فشار روانی و مشکلات زندگی (۱۳ درصد) گزارش شد. عوامل مؤثر در تداوم سوء مصرف عبارت بودند از احساس وابستگی (۲۰ درصد)، ناتوانی در تحمل علائم ترک (۲۸ درصد)، آثار نشگی (۱۵/۵ درصد)، رفع اضطراب و ناراحتی (۱۲/۵ درصد)، ایجاد اعتماد به نفس (۱۱ درصد) و ایجاد تمرکز، توانایی فکر و کار کردن (۱۳ درصد). عوامل مؤثر در مصرف دوباره پس از دوره‌های قطع شامل ناراحتی روانی ناشی از ترک (۴۵ درصد)، طردشدگی از سوی خانواده (۱۰ درصد)، نقش دوستان در مصرف مجدد (۲۲ درصد)، احساس تنهایی و طردشدگی از سوی اجتماع (۸/۵ درصد)، بیکاری (۶

^۱ . Monoamine Oxidase (MAO)

^۲ . Mezzich

درصد) و افسردگی (۸/۵ درصد) بود. این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل گوناگون زیستی، روانی و اجتماعی در شکل‌گیری مراحل مختلف پدیده اعتیاد از جمله شروع و تداوم مصرف مواد دخالت دارند.

ادامه یافتن مصرف مواد

در این بخش به‌طور مختصر به مطالعاتی اشاره می‌شود که رابطه بین مصرف مواد و عوامل اجتماعی روانی خاصی را ارزیابی کرده‌اند. همپوشی‌های زیادی بین نظریه‌های شروع مصرف مواد و ادامه مصرف مواد وجود دارد.

تأثیر مواد مخدر و داروهای روان‌گردان

می‌دانیم که افراد نسبت به یک داروی خاص تحمل دارویی پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر، سلول‌های عصبی درون مغز، به‌مرور زمان به حضور یک دارو سازگار می‌شوند و در نتیجه اجازه عملکرد طبیعی را می‌دهند. به این موضوع تحمل دارویی گفته می‌شود. با کنار گذاشتن مصرف دارو یا کاهش آن، عملکرد و کارکرد مغز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به نیاز به مصرف دارو می‌انجامد. برای مثال، کوکائین با سرعت توسط کبد سوخت‌وساز شده و به کاهش افسردگی منجر می‌شود و این با افت سطح کوکائین خون رابطه دارد. در نتیجه، مصرف‌کننده برای اینکه باز هم افسردگی خود را تسکین دهد، به طرف کوکائین کشیده می‌شود.

بعضی نوجوانان مواد را به دلیل ویژگی‌های بهبوددهنده خلق مصرف می‌کنند و ادامه می‌دهند. داروهای توهم‌زایی چون LSD، اثرهای هیجانی و روان‌شناختی شگفت‌انگیز و مخصوص به خود دارد که ممکن است تداوم مصرف این داروها را تبیین کند. LSD منجر به توهم‌های دیداری و شنیداری و تحریف‌های زمانی می‌شود. بعضی از این حالت‌ها به صورت «افزایش هشیاری» تجربه می‌شوند و ممکن است فرد را برای ادامه مصرف دارو تشویق کنند. LSD ممکن است سبب تغییرهای خلقی نیز بشود که فرد را به وجد می‌آورد و شاد می‌کند، اگرچه ممکن است تأثیرهای بسیار ترسناکی هم داشته باشد و منجر به افسردگی شود. بنابراین در بسیاری موارد وقتی داروها اثری «مثبت» یا پاداش‌دهنده برای مصرف‌کننده دارند، رفتار مصرف دارو از طریق فرایندهای شرطی‌سازی کلاسیک تداوم می‌یابد. درواقع، حالت وجدآور و شادی‌انگیز یا بهبود درخلق به منزله محرکی عمل می‌کند که نوجوان را همچنان به طرف مصرف مواد می‌کشاند (پیام مشاور، ۱۳۸۵).

عوامل روانی اجتماعی

عوامل شخصیتی و نگرشی نیز با مصرف مواد رابطه دارند. این عوامل شامل انگیزه‌های شخصی، عزت نفس اندک، تکانشی بودن، هیجان‌طلبی، نگرش‌های منفی نسبت به نمادهای قدرت، افسردگی زیاد، تعهد و مسئولیت‌پذیری کم و نافرمانی هستند.

انگیزه‌های شخصی برای تبیین اینکه چرا بعضی به مصرف مواد ادامه می‌دهند، بسیار مهم‌اند. برای مثال نوجوانانی که سیگار می‌کشند، دلایل روشنی برای این کار دارند. در مطالعه‌ای مشاهده شد نوجوانانی که سیگار می‌کشند، تمایل دارند از نظر اجتماعی پذیرفته شوند (من احساس اطمینان می‌کنم؛ دوستانم سیگار می‌کشند؛ این کار به من اجازه می‌دهد احساس کنم جزئی از گروه آنان هستم) یا این کار سبب شادی و خوشحالی آنان می‌شود، (این کار مرا آرام می‌کند) یا اعتیاد پیدا کرده‌اند و این کار برای آنها به صورت نیاز و عادت درآمده است (فهمیدم که ترک کردن بسیار سخت است) (هو^۱، ۱۹۹۴).

این انگیزه‌ها برای کشیدن سیگار همان‌گونه که هو عنوان می‌کند، رابطه نزدیکی با عوامل انتظاری تعریف شده توسط مارلات^۲ و همکاران (۱۹۸۸) دارند. نویسندگان اخیر معتقدند افراد باورها یا انتظاراتی دارند مبنی بر اینکه داروهای خاص اثرهای رفتاری و خلقی خاصی دارند که سبب مطلوب بودن آنها می‌شوند. صاحب‌نظران مذکور دو نوع از انتظارات را مشخص کرده‌اند؛ یکی انتظارات پیامد و دیگری باور به خود - کارآمدی. بنابراین ممکن است نوجوانی مشروب‌خواری کند، زیرا اعتقاد دارد این کار به او کمک می‌کند تا احساس اطمینان بیشتری کند.

نوجوانان انتظارات خاصی درباره اثرهای نوشیدن مشروب و الکل دارند و به نظر می‌رسد چنین انتظاراتی مرتبط با رفتار آنان است. انتظارات پیامد در مورد الکل عبارتند از:

- تغییر مثبت؛
- بهبود رفتار اجتماعی یا بازداری از رفتار اجتماعی؛
- اصلاح توانش‌های شناختی یا حرکتی فرد؛
- بهبود و افزایش میل جنسی؛
- وخیم‌تر شدن کارکردهای شناختی و رفتاری؛
- افزایش سطح برانگیختگی؛
- کاهش تنیدگی و افزایش آرامش.

^۱ . Ho

^۲ . Marlatt

بعضی پژوهش‌ها به بررسی نقش خانواده در تداوم مصرف مواد در نوجوانان پرداخته‌اند. برای مثال مشاهده شده ویژگی‌های پدر همراه با شخصیت نوجوان نقش زیادی در پیش‌بینی مصرف مواد توسط نوجوان دارد. شیوه‌های فرزندپروری در شکل‌دهی رفتار مصرف مواد در نوجوانان اهمیت دارند. در این مورد ماهیت التزام و تعهد بین والدین و نوجوان و همچنین صمیمیت عاطفی و هیجانی و تعهد والدین نقش بسزایی دارند. سبک دلبستگی نیز در پیش‌بینی رفتار مصرف مواد مهم‌تر از عواملی مانند کنترل والدین است (سیرایت^۱ و همکاران، ۱۹۹۱؛ به نقل از هو، ۱۹۹۴).

نوجوانان مصرف‌کننده مواد که برای ترک اعتیاد خود تحت درمان هستند، به‌طور معناداری در زمینه تصورات و ادراکاتشان از خانواده اصلی خود با دیگران تفاوت دارند. آنها به خانواده خود به‌عنوان خانواده‌ای می‌نگرند که مهارت‌های ارتباطی ضعیفی دارند و برای مرزبندی‌های شخصی ارزش زیادی قائل‌اند. از این رو، به‌نظر می‌رسد درون این خانواده‌ها درگیری زیادی وجود داشته باشد. نوجوان در این خانواده‌ها، مورد محافظت شدید و افراطی قرار می‌گیرد. این خانواده‌ها نمی‌توانند هیجانات خود را به‌صورت رضایت‌بخشی بیان کنند و فاقد گرمی و صمیمیت عاطفی‌اند.

درمان اعتیاد به مواد و الکل

امروزه درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل اهمیت روزافزونی پیدا کرده، از این رو رویکردهای مختلفی برای درمان سوء مصرف مواد طراحی و تدوین شده‌اند. این برنامه‌های درمانی دامنه‌ای از برنامه‌های کمک‌رسانی به دانش‌آموزان در مدرسه و کلینیک‌ها یا مراکز مشاوره وابسته به مدرسه تا برنامه‌های درمان جمعی و بیمارستان‌های شبانه‌روزی دارد. هدف این بخش مرور بر پیوستار خدمات قابل دستیابی و نتایج تحقیقات انجام‌شده برای درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکلیسم است.

برنامه‌های کمک‌رسانی به دانش‌آموزان

اگرچه این برنامه‌ها رایج‌ترین برنامه‌های مدرسه‌مدارند، اما به خوبی مورد ارزشیابی قرار نگرفته‌اند. این برنامه‌ها بر ارائه مداخله‌های اولیه به دانش‌آموزانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، تأکید دارند. این مداخله‌ها شامل راهبردهای درمانی مانند فراهم ساختن حمایت اجتماعی و افزایش مهارت‌ها و ظرفیت‌های فرد برای مقابله با دامنه‌ای از مشکلات زندگی است. وجه مشترک مهم این برنامه، درگیر کردن همسالانی است که اغلب نقش فعالی در این برنامه‌ها دارند. نقش همسالان شامل مدیریت و حل بحران، تسهیل‌کننده گروه‌های کوچک و عامل‌های ارجاع‌دهنده است. به‌طور معمول در

^۱. Searight

این برنامه‌ها از بزرگسالان هم به عنوان مشاور و تسهیل‌کننده استفاده می‌شود. این برنامه‌ها شامل فعالیت‌هایی مانند مشاوره گروهی برای نوجوانان دارای والدین مشکل‌دار، مشاوره فردی برای دانش‌آموزانی که الکل یا مواد مصرف می‌کنند، مشاوره فردی و گروهی برای نوجوانانی که پیشرفت تحصیلی ضعیفی دارند و در معرض خطر مصرف مواد قرار دارند و آموزش خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازهای فرزندانشان است. مطالعات زیادی در مورد کارایی این برنامه‌ها صورت نگرفته، اما نتایج برخی پژوهش‌ها نشان‌دهنده کارایی این برنامه‌هاست (کلاین من^۱ و همکاران، ۱۹۹۲؛ به نقل از دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶).

کلینیک‌ها یا مراکز مشاوره مدارس

درباره مداخله‌های گروهی مانند برنامه‌های همیاری دانش‌آموزان مشکلاتی وجود دارد. نگرانی اصلی این است که احتمالاً در گروه‌درمانی، افرادی که مشکل کمی دارند، در عمل با برقراری ارتباط با افرادی که مشکلات زیادی دارند، به طرف مصرف مواد کشیده شوند. راه‌حل دیگر این مشکل، طراحی راهبردهای خدمات مراقبتی انفرادی است. خدمات اجتماعی مختلفی در مدارس ارائه می‌شوند که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مشکل مصرف مواد را حل کنند.

سازمان‌های اجتماعی، خدماتی را در اختیار مدارس قرار می‌دهند تا به مربیان برای حل مشکلات اجتماعی و سلامت دانش‌آموزان کمک کنند؛ مشکلاتی چون اختلالات قابل انتقال، مصرف مواد، خشونت و افسردگی. این کار نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اجتماعی دارای رابطه متقابلند (آنها با هم رخ می‌دهند) و علل و راه‌های درمانی مشترکی دارند. مراکز مشاوره وابسته به مدارس و دیگر مراکز خدماتی نوجوانان ایجاد شده‌اند تا خدمات اجتماعی و سلامتی جامع، یکپارچه و یک مرحله‌ای را ارائه کنند.

کلینیک‌های وابسته به مدارس به دلایل خاصی راه‌اندازی شده‌اند؛ نخست اینکه گروه نوجوانانی که در محله‌ها و مناطق فقیرنشین و محروم زندگی می‌کنند و به تسهیلات مراقبتی بهداشتی دسترسی کمی دارند، روزبه‌روز زیاد و زیادتر می‌شوند. در این باره بریندیس^۲ و همکاران (۱۹۹۳)، به نقل از دیکلمنت؛ هانسن و پانتون، ۱۹۹۶) مشاهده کردند تعداد نوجوانانی که در فقر به سر می‌برند، از ۱۵ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۱۹ درصد در سال ۱۹۸۶ افزایش یافته‌اند؛ دوم اینکه، شیوع خشونت، بارداری در نوجوانی و مصرف مواد مخدر بسیار گسترده است. در بسیاری از موارد، حل این مشکل

^۱ . Kleinman

^۲ . Brindis

مستلزم مداخله اجتماعی و دارویی است. در پاسخ به این نیازها، دامنه وسیعی از فعالیت‌ها زیر پوشش خدمات بهداشتی و اجتماعی وابسته به مدارس قرار می‌گیرند. این خدمات بسیاری از مشکلات را هدف قرار می‌دهند و شامل ترویج و توسعه تحول توأم با سلامت، پیشگیری از رفتارهای بسیار خطرناک، تشخیص و درمان بیماری‌ها و مداخلات اولیه‌ای برای گستره کاملی از مشکلات پزشکی، بهداشتی و اجتماعی‌اند. الگوهای خدمات اجتماعی وابسته به مدرسه شامل خدماتی می‌شوند که به‌طور مستقیم توسط کارکنان مدرسه، از جمله مشاوران ارائه می‌شوند، همچنین شامل خدماتی که دامنه کاملی از خدمات را توسط سازمان‌های خارج از مدرسه، ارائه می‌کنند. ارائه‌دهندگان این خدمات ممکن است مشاوران، روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، دستیاران پزشکان و پرستاران بهداشت عمومی باشند.

داده‌های پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که مراکز مشاوره وابسته به مدارس منبعی ضروری برای مراقبت‌های بهداشتی و حمایت اجتماعی‌اند (بریندیس و همکاران، ۱۹۹۳). اما تاکنون ارزشیابی دقیقی از میزان کارایی این کلینیک‌ها به‌عمل نیامده است؛ بویژه در زمینه نقش این مراکز در درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکلیسم در نوجوانان. محققان علاقه‌مند به این حوزه باید در مورد نتایج و سازوکارهای این برنامه‌ها، بویژه برنامه‌های خدماتی به مطالعه و تحقیق بپردازند.

برنامه‌های خانوادگی

در سال‌های اخیر محققان به مطالعه درمان اعتیاد با استفاده از برنامه‌هایی علاقه‌مند شده‌اند که والدین در آنها فعالانه درگیر می‌شوند. برای مثال بری (۱۹۸۸)، به نقل از دیکلمنت، هانسن و پانتون، (۱۹۹۶) از برنامه‌هایی که شامل خانواده‌درمانی رفتاری برای تشخیص دانش‌آموزان در معرض خطر زیاد بودند، گزارشی ارائه کرده است. نوجوانانی که در این برنامه‌های خانواده‌درمانی شرکت کرده بودند، در مقایسه با آنهایی که فقط مداخله‌های مبتنی بر مدرسه را دریافت کرده بودند و معلم از راهبردهای تقویت رفتاری برای آنان استفاده کرده بود، نمره‌های تحصیلی بهتری دریافت کردند. همچنین مشاهده شد که نوجوانان شرکت‌کننده در خانواده‌درمانی رفتاری توانسته بودند مقدار مصرف مواد خود را در سطحی ثابت و بدون افزایش نگاه‌دارند، درحالی‌که نوجوانان گروه کنترل مقدار مصرف مواد خود را طی این دوره افزایش داده بودند. مطالعات موردی هم نشان‌دهنده تأثیر خانواده‌درمانی در کاهش مصرف مواد است. در این مطالعات به والدین آموزش می‌دهند با مشکلاتی که سبب افزایش تمایل نوجوانان به مصرف مواد می‌شود و با بحران‌های مختلف با استفاده از روش حل مسئله برخورد کنند.

رویکردهای جدیدتر خانواده‌درمانی، بر آموزش مهارت‌های شناختی، شناخت باورهای غیرمنطقی و انتظارات نادرست و جایگزینی آنها با افکار و انتظارات واقع‌گرایانه و منطقی به همراه استفاده از فنون رفتاری مانند استفاده از تقویت‌کننده‌های مثبت تأکید دارند. این رویکرد به خانواده‌درمانی شناختی - رفتاری مشهور است که استفاده از آن برای مبارزه با اعتیاد نوجوانان نیازمند تحقیق و شناخت بیشتری است (خوانندگان علاقه‌مند به رویکردهای جدید خانواده‌درمانی در درمان اعتیاد نوجوانان می‌توانند به کتاب خانواده‌درمانی شناختی - رفتاری اختلالات کودکان و نوجوانان، تألیف خدایاری فرد و عابدینی (زیرچاپ) رجوع کنند).

برنامه‌های دوازده مرحله‌ای

بسیاری از رویکردهای درمانی از راهبردهای درمانی ویژه بزرگسالان برای نوجوانان نیز استفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین این رویکردها، برنامه‌های دوازده مرحله‌ای است که بعد از برنامه‌های ناشناس‌های الکلی و ناشناس‌های مصرف‌کننده مواد طراحی شده است. دو بُعد مهم این برنامه، یکی مربوط به فلسفه دارابودن ۱۲ مرحله و دیگری مربوط به شکل ملاقات است که شامل راهبرد کلی برای حمایت اجتماعی است.

فلسفه برنامه مبتنی بر درمان الگوی رفتاری به عنوان یک اختلال بوده و بر این باور است که اگر اختلال بدون درمان رها شود، شدیدتر می‌شود. این برنامه‌ها مستلزم این هستند که به فرد معتاد اجازه داده شود احساس کند قدرت کنترل استفاده از مواد مخدر را دارد. به علاوه، برنامه مستلزم این است که فرد شرکت‌کننده در آن تعهد دهد که هرگز بار دیگر به مصرف مواد روی نخواهد آورد. بخشی از این رویکرد اعتقاد به این ایده است که فرد معتاد می‌تواند خودش را در جهت نزدیک شدن به قدرت برتر سوق دهد. این قدرت برتر خداوند است، اما در این برنامه‌ها به هیچ مذهب خاصی تأکید نمی‌شود.

اعتقاد مهم دیگر این برنامه‌ها این است که فرد معتاد در درون گروه همیاری مورد نیاز خود را پیدا خواهد کرد. در این برنامه‌ها آزاد بودن از قید هرگونه دارو یا ماده‌ای، به وضوح از هر رابطه شخصی مهم‌تر است. به دلیل عدم اطمینان از بازگشت مصرف مواد و به دلیل فقدان برگشت‌پذیری شخصی، فرض می‌شود که میزان تهدید بازگشت ثابت است. برنامه‌های دوازده مرحله‌ای به‌طور معمول برای بیان این مفهوم از شعار «روزی روزگاری» استفاده می‌کنند. در نهایت، باور قدرتمندی مبنی بر این موضوع وجود دارد که فقط افرادی می‌توانند به معتادان کمک کنند که خودشان بهبود یافته و اعتیاد را ترک کرده‌اند.

افرادی که وارد برنامه‌های دوازده‌مرحله‌ای می‌شوند، یک همدست یا شریک کاری را برای راهنمایی خود برای طی مراحل به‌منظور رسیدن به بهبود انتخاب می‌کنند. این همدست فردی است که خود پیش از این، این مراحل را پشت سر گذاشته و در حال حاضر پاک است و از مصرف مواد پرهیز می‌کند. این همدست تا زمانی که فرد جدید پاک شود و به‌طور کامل ترک کند و راه درست زندگی را در پیش گیرد، با او کار می‌کند. با این حال، تأثیر برنامه‌های دوازده‌مرحله‌ای حتی برای بزرگسالان معتاد به مواد مخدر مورد ارزشیابی قرار نگرفته است. انتظار می‌رود میزان تأثیر این برنامه‌ها از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. البته برای تجویز این برنامه‌ها برای تمام نوجوانان باید تا حدودی محتاط بود. در چنین موقعیت‌هایی بر بازبینی و نظارت دقیق بر نوجوانان بسیار تأکید می‌شود.

درمان شبانه‌روزی

در بعضی برنامه‌ها باید نوجوان معتاد به مواد مخدر از خانواده خود و محیط زندگی روزانه‌اش جدا شود و در محلی که دارای تسهیلات درمانی خاصی است، به‌طور شبانه‌روزی سکونت کند. بیشتر این برنامه‌ها برای نوجوانان و جوانان طراحی شده‌اند. دو نوع رایج از این برنامه‌ها وجود دارد؛ نخستین مورد، بیمارستان یا مرکز تسهیلات درمانی است که در وهله اول شروع به سم‌زدایی می‌کند و سپس برای فرد جلسات درمانی انفرادی یا گروهی تدارک می‌بیند. در این نوع برنامه‌ها، تأکید زیادی به آموزش برای ترک اعتیاد می‌شود. به‌دلیل پرهزینه‌بودن این برنامه‌ها، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا این برنامه‌ها در آینده هم تداوم خواهند داشت یا نه؛ دومین نوع برنامه، به «جامعه‌درمانی» مشهور است. به‌طور معمول، هدف این برنامه جامعه‌پذیری مجدد و کامل فرد است. در این برنامه توجه کمی به موضوع‌های روان‌شناختی خاص مصرف مواد می‌شود، ولی در عوض فرد فرایندی را طی می‌کند تا بتواند مهارت‌های شخصی و اجتماعی لازم برای کار کردن به‌عنوان یک فرد طبیعی جامعه را کسب کند. این برنامه شامل نظارت و بازرسی شدیدی است و اعطای آزادی فقط زمانی امکان‌پذیر است که فرد رفتارهای همراه با مسئولیت و تعهد از خود نشان بدهد. جوامع درمانی ممکن است فقط افرادی را بپذیرند که در زمان معرفی شدن پاک‌اند و از مواد مخدر استفاده نمی‌کنند. کارایی و تأثیر این برنامه‌ها تا حدودی ارزیابی شده است. در مطالعه‌ای که بدین منظور انجام شد، اطلاعات به‌دست آمده نشان‌دهنده تأثیر خاصی نبودند (هستر و میلر^۱، ۱۹۸۸).

^۱ . Hester & Miller

چگونه از مصرف مواد جلوگیری کنیم؟

بسیاری از نوجوان‌ها، ممکن است گاه از طرف دوستانشان برای مصرف مواد مخدر تحت فشار قرار بگیرند. در این وضعیت، آنها باید تصمیم بگیرند که از این مواد استفاده کنند یا نه. اگر چه اتخاذ این تصمیم با آنهاست، اما شما حتماً باید پیشاپیش کاری کنید که آنها از خطر واقعی داروهای روان‌گردان حتی در حد امتحان کردن، اطلاع پیدا کنند. بله، اگر چه این داروها به‌ظاهر می‌توانند راهی برای گریز از فشارهای دوره نوجوانی باشند، اما هر کسی باید مشکلات اجتناب‌ناپذیر دوره رشد را تجربه کند تا بتواند فردی بالغ، رشدیافته و مسئول شود و مواد مخدر، مانع این تجربه نشوند. داروها از طریق ایجاد مسائل مختلف، از انزوای اجتماعی گرفته تا کاهش انگیزه، فرایند رشد را حتی از آنچه هست، مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌کنند. به طور کلی، آنچه اهمیت دارد، این است که قبل از آنکه داروها مشکلی ایجاد کنند، کاری کنید. از طریق اقدام‌های زیر این احتمال را افزایش می‌دهید که وقتی به نوجوان شما دارو تعارف شود، او بگوید "نه".

- به‌طور مرتب در مورد مسائل مرتبط با زندگی نوجوان‌ها با او صحبت کنید؛ از جمله مسائل مربوط به مواد مخدر، و اینکه نوجوان چگونه می‌تواند به شکلی صحیح در میان دوستانش محبوبیت پیدا کند. حقایق مربوط به خطرهای داروها را به او بگویید و به او یاد دهید که خودش به‌طور مستقل تصمیم بگیرد و کاری نداشته باشد که دوستانش چه می‌گویند، یا چه می‌کنند. بگذارید بداند شما در مورد داروها چه عقیده و احساسی دارید.
- به او یادآوری کنید راه‌های متعددی برای کنار آمدن با عواطف و احساسات وجود دارد، بدون آنکه گرایش به داروها در آن جایی داشته باشد. مهم‌تر از همه، شرایطی فراهم کنید که او بداند شما همیشه در زمان بروز مشکلات، آماده‌اید به او کمک کنید.
- از هر فرصتی که پیش می‌آید استفاده کنید تا اعتماد به نفس او را افزایش دهید، او را برای کارهایی که انجام می‌دهد، تشویق کنید و از عیب‌جویی بیش از حد پرهیز کنید.
- او را تشویق کنید که در فعالیت‌های لذت‌بخش و سالم و بی‌خطر شرکت کند. این کار او را از استفاده از داروها به منظور رفع خستگی برحذر خواهد داشت. بگذارید او بفهمد که می‌توان شاد و سرخوش بود و به شادمانی دست یافت، بدون اینکه از داروها استفاده کرد.
- بگذارید نوجوان شما بداند اگر از داروها استفاده کند، او را از بعضی امتیازهای ارزشمند، از قبیل استفاده از اتومبیل خانواده محروم خواهید کرد.

- اگر نوجوان شما در سن رانندگی است، با اصرار تأکید کنید که هرگز نباید بعد از نوشیدن الکل رانندگی کند، حتی اگر مقدار خیلی کمی هم مصرف کرده باشد، زیرا حتی نوشیدن کم هم می‌تواند مهارت رانندگی او را مختل کند. بعضی از والدین سیاست آزادی تلفن کردن به خانه را در پیش می‌گیرند، به این معنا که اگر نوجوانشان بیرون از خانه از الکل استفاده کند، می‌تواند با خانه تماس بگیرد تا دنبال او بروند، بدون ترس از اینکه در آن شب عقوبتی منتظرش باشد و روز بعد والدین در مورد این مسئله با او بحث و گفت‌وگو خواهند کرد.
- نوجوان شما نه تنها باید از خطرهایی که مواد مخدر برای سلامتی او ایجاد می‌کند آگاه باشد، بلکه باید از عواقب قانونی دستگیر شدن همراه مواد مخدر هم مطلع باشد.
- خود شما، با محدود کردن استفاده از الکل و مواد مخدر، الگوی مناسبی برای او باشید. اگر به دلیل مشکل طبی، دارو مصرف می‌کنید، لازم است که این مسئله را به نوجوانتان توضیح بدهید. اگر در خانه الکل می‌نوشید، حد اعتدال را رعایت کنید و به نوجوان خود توضیح دهید که از الکل به عنوان راهی برای کنار آمدن با مشکلات استفاده نمی‌کنید.

چگونه باید مصرف دارو را ترک کرد؟

اگر فهمیدید که نوجوانتان به داروها یا الکل معتاد است، ممکن است پذیرش این مسئله برای شما مشکل باشد. تعدادی از پدر و مادرها، حتی وقتی که نشانه‌ها، شدت نشان‌دهنده وجود این مسئله‌اند، آنها را انکار می‌کنند و نادیده می‌گیرند و این وضعیت اغلب مدت‌ها ادامه می‌یابد. اما تشخیص فوری اعتیاد، ضرورت دارد. از هر چهار نفری که به مراحل پیشرفته اعتیاد می‌رسند، یعنی به طور فعال در جست‌وجوی مواد برمی‌آیند و گرفتار آنها می‌شوند، سه نفر هرگز بهبودی کامل و موفقیت‌آمیزی پیدا نمی‌کنند. بنابراین، مشورت و درمان به موقع حیاتی است.

سخنرانی‌های محکم و کوبنده، فایده چندانی نخواهد داشت. به جای آن سعی کنید بفهمید چرا نوجوانتان از داروها استفاده می‌کند. با کمک همدیگر تلاش کنید تا راهی بیابید که بتواند به شکل سازنده‌ای بر مشکلات غلبه کند و عشق و حمایت خود را متوجه او کنید و اگر فقط گاهی از مواد استفاده می‌کند، دوره‌ای را به‌طور آزمایشی در نظر بگیرید، برای مثال دو هفته یا یک ماه. در این مدت، او قبول کند از مواد پرهیز کند و شما قبول کنید که در حل موقعیت‌های خاص و دشوار زندگی به او کمک کنید. اگر او در مرحله پیشرفته‌تر اعتیاد باشد، مشکل خود و حتی درگیر شدن با

این مواد غیرقانونی را بشدت انکار خواهد کرد، اما اگر علائم هشداردهنده‌ای را که ذکر شد در او می‌بینید، باید علت زمینه‌ای آن را پیدا کرده و به او کمک کنید.

حتماً از روان‌شناس و روان‌پزشک راهنمایی بگیرید، تشخیص اعتیاد اغلب نیازی به آزمون‌های تشخیصی مواد مخدر (از طریق آزمایش ادرار) ندارد، اما ممکن است روان‌شناس و روان‌پزشک پیشنهاد بدهند که نوجوان شما را مصاحبه کنند و ببینند آیا اعتیاد، مشکلات جسمی برای او به وجود آورده است یا نه، سپس ممکن است نوجوانتان را به سمت برنامه‌های ترک اعتیاد یا مشاورانی که در این زمینه کمک می‌کنند، ارجاع دهند.

اگرچه در این فصل به‌طور عمده، در مورد الکل و اعتیاد به سایر داروها بحث شده است، اما سیگار هم به همان اندازه اهمیت دارد. براساس پژوهشی که انجام شده است، ۲۱ درصد دانش‌آموزان سال‌های آخر دبیرستان روزانه سیگار می‌کشند (گریدانوس، ترجمه فروشانی و مطهری، ۱۳۸۳).

نوجوان شما با وجود استفاده گسترده از سیگار، احتمالاً تمام مطالب ضروری را در مورد خطرهای سیگار می‌داند. در رسانه‌ها و روی هر پاکت سیگار، به وضوح گفته می‌شود که سیگار کشیدن به بیماری‌های قلبی و سرطان ریه منجر می‌شود. سیگار غیرقابل اجتناب‌ترین دلیل مرگ در جامعه است. هر سال حدود ۳۵۰ هزار فرد بالغ، بر اثر سیگار کشیدن دچار مرگ زودهنگام می‌شوند. اما ممکن است نوجوان شما نداند که گذشته از بیماری‌های مزمن و اغلب کشنده (حتی در خلال نوجوانی)، فرد سیگاری ممکن است مبتلا به سرفه مزمن، عفونت ریه‌ها، کوتاهی نفس و تنفس صدادار (ویزدار) شود. همچنین، بیماری‌های ریوی که از قبل وجود داشته‌اند، از قبیل آسم، ممکن است بدتر شوند. همچنین، سیگار کشیدن ممکن است مشکلاتی برای زنان حامله به وجود بیاورد، از قبیل سقط ناگهانی، رشد کم جنین یا حتی مرگ جنین. شواهد و مدارک بسیار زیادی برای اثبات تمامی مواردی که ذکر شد، در دسترس است.

اعتیاد جسمی به تنباکو، مشکل بزرگ دیگر برای کسانی است که سیگار می‌کشند. غلبه بر این اعتیاد بسیار مشکل است. علاوه بر آن، سیگار کشیدن آثار سویی بر زیبایی افراد دارد، از قبیل رنگ زرد دندان‌ها و بوی بد دهان. با وجود این همه مطلب منفی در مورد سیگار، عجیب است که چرا مردم باز هم سیگار می‌کشند؛ البته به استثنای جنبه اعتیادآور سیگار، که توجیه‌کننده تداوم مصرف افراد است.

اگرچه سیگار عمده توجه ما را به خود جلب می‌کند، اما از شکل‌های بدون دود تنباکو، نباید غافل شد که شامل انفیه (تنباکویی که به صورت ریز خرده شده است) یا تنباکوی جویدنی (یا برگ) است. مصرف کردن این مواد، هم تنفس را بدبو و هم دندان‌ها را رنگی می‌کند. جوانان به گونه‌ای

فزاینده از آنها استفاده می‌کنند. هر دو این مواد ممکن است موجب اعتیاد به نیکوتین شوند، به پوشش دهان و گلو صدمه بزنند و بدتر از اینها، ممکن است به سرطان دهان و گلو و همچنین، بیماری‌های لته منجر شوند. از این رو این مواد هم مانند سیگار، خطری جدی برای سلامتی انسان محسوب می‌شوند.

آگهی‌های بازرگانی در روزنامه و مجله‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، افراد جوان خوش‌اندami را به تصویر می‌کشند که اغلب توسط افراد جذابی از جنس مخالف احاطه شده‌اند، و می‌توانند نقش فریب‌دهنده‌ای داشته باشند و نوجوانان را متقاعد کنند که استفاده از تنباکو، نه تنها قابل قبول، بلکه نشانه‌ی مد و جذاب بودن است. رفتار والدین هم می‌تواند همین اثر را داشته باشد؛ اگر شما سیگار بکشید، واقع‌بینانه نیست از نوجوانتان انتظار داشته باشید این کار را نکند. در حقیقت، نوجوانانی که در خانواده‌شان سیگار کشیده می‌شود، دو برابر بیشتر از دیگران، احتمال دارد سیگار بکشند. پس اگر می‌خواهید به نوجوانتان لطفی کنید، همین الان زمان مناسبی برای ترک سیگار به شمار می‌رود، تا نوجوانتان را متقاعد کنید که او هم همین کار را کند.

میزان تأثیر خودتان را بر نوجوان از نظر مصرف سیگار، مواد مخدر و سایر جنبه‌های زندگی دست کم نگیرید. شما می‌توانید نیروی وادارکننده باشید. در مورد مواد مخدر و داروهای محرک، بعضی از نوجوان‌ها به واقعیت گوش کرده‌اند. بیشتر دانش‌آموزان سال‌های آخر دبیرستان، عقیده دارند سیگار کشیدن موجب می‌شود نوجوان بی‌ثبات به نظر برسد، نه جذاب. بنابراین باوجود اینکه به نظر می‌رسد دنیای نوجوان‌ها دور از استرس است، سعی خودتان را بکنید. به عنوان والد، می‌توانید تأثیر خیلی مهمی بر انتخاب‌های نوجوانتان داشته باشید و اگر دارای ثبات باشید، پیام شما منتقل خواهد شد. اگر اعتیاد به مواد خانواده شما را گرفتار کرده، کمک‌هایی در دسترس است. متخصصان گوناگون مراقبت‌های بهداشتی در این زمینه مهارت و تخصص دارند.

خلاصه

در حال حاضر، تعداد زیادی از نوجوانان، موادی نظیر سیگار، الکل، تریاک، ماری‌جوانا، کوکائین و هروئین را آزمایش و تجربه می‌کنند. تعداد زیادی از نوجوانان معاصر، در طول زندگی‌شان حداقل یک بار سیگار کشیده یا مشروب خورده‌اند. مصرف این مواد تأثیرات زیانباری را برای آنان به دنبال دارد؛ از جمله اینکه آسیب‌های جدی به سلامت جسمی و روانی آنان وارد می‌سازد. در این باره، اعتقاد بر این است که استفاده از ماری‌جوانا زمینه‌ساز مصرف سایر مواد خطرناک نظیر کوکائین و هروئین است.

نظریه‌های مختلفی برای تبیین شروع و ادامه مصرف مواد در نوجوانان مطرح شده‌اند. این نظریه‌ها، همگی بر نقش عوامل زیست‌شناختی، روان‌شناختی، تفاوت‌های فردی و تأثیرات اجتماعی تأکید دارند. مهم‌ترین عامل اجتماعی، گروه همسالان است. از طرفی، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که حمایت، گرمی، صمیمیت و انسجام خانوادگی، میزان روی آوردن نوجوانان به مصرف مواد را کاهش می‌دهند. خانواده‌هایی که فاقد روابط مثبت عاطفی و کلامی‌اند، زمینه را برای روی آوردن نوجوانان به مواد مخدر و الکل فراهم می‌کنند.

درمان اعتیاد به مواد در نوجوانان، به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. نتایج تحقیقات موجود نشان می‌دهند که کلیه اشکال مختلف درمانی، ظرفیت‌هایی را برای درمان مؤثر دارند. بهترین روش‌های درمانی، به‌طور معمول روش‌های مختلفی از رویکردهای مختلف را ترکیب می‌کنند و به‌کار می‌گیرند.

پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

- ۱) با توجه به نقش عوامل مختلف زیستی، روانی و اجتماعی در شروع و تداوم مصرف مواد، چه عواملی می‌توانند در پیشگیری از مصرف مواد نقش محافظت‌کننده داشته باشند؟
- ۲) به نظر شما سبک‌های والدینی چگونه می‌توانند بر شروع و تداوم مصرف مواد در نوجوانان تأثیر بگذارند؟

فصل هفتم

بزهکاری

بزهکاری^۱، اصطلاحی است که به دامنه‌ای از اعمال ضداجتماعی که توسط نوجوانان انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود. بزهکاری شامل اعمال مختلفی است که در نوجوانی صورت می‌گیرد، از جمله سرقت، دزدی، تجاوز جنسی، مصرف داروها و مواد، تخریب اموال عمومی و مشروب‌خواری. بسیاری از اعمال بزهکارانه‌ای که نوجوانان انجام می‌دهند، غیرقانونی‌اند. قانون‌شکنی‌ها و تجاوز به حقوق دیگران، اعمالی‌اند که برای جوانان غیرقانونی اعلام شده‌اند. مشروب‌خواری، فرار از مدرسه و خانه، جزء این اعمال به شمار می‌روند. از نظر و دیدگاه رفتاری، اگر به بزهکاری به‌منزله ویژگی کلی که جوانان کم و بیش در آن درگیر می‌شوند نگریسته شود، قابل درک‌تر خواهد بود. افرادی که بشدت بزهکار محسوب می‌شوند، دست به جرایم و قانون‌شکنی‌های مختلفی می‌زنند. در این فصل، به‌طور خلاصه به شرح ماهیت، میزان شیوع، درمان و پیشگیری از رفتار بزهکاری پرداخته خواهد شد.

خطرهای بزهکاری

بزهکاری، هم برای جامعه و هم برای افرادی که درگیر آن می‌شوند، خطرهایی را به‌دنبال دارد. یکی از این خطرهای پناهگاهی شدن به اشکال مختلف در نهادها و سازمان‌های امن و تسهیلات اجتماعی نظیر مراکز بازداشتگاهی، مدارس کارآموزی و آموزشی، پناهگاه‌ها، خوابگاه‌ها و مراکز تشخیصی و زندان‌هاست. بعضی جوانان به این دلیل ساکن پناهگاه‌ها می‌شوند که قبلاً مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند یا با دیگران درگیر شده‌اند، اما بیشتر آنها به‌دلیل جرایم و قانون‌شکنی‌های مختلف دستگیر و نگهداری می‌شوند. هزینه این تسهیلات، به‌طور کلی در حدود ۲/۸ بلیون دلار در سال ۱۹۸۹ برآورد شده است. به این هزینه‌ها باید هزینه زندان‌ها و هزینه‌هایی را که صرف نگهداری نوجوانان و جوانان بزهکار در کانون‌های اصلاح و تربیت می‌شود نیز افزود. هزینه‌هایی که نیروی انتظامی و پلیس متحمل می‌شود نیز چشمگیر است. البته تمام هزینه‌های پلیس صرف جرایم مربوط به نوجوانان نمی‌شود، بلکه نوجوانان بیشتر از سایر اقشار جامعه دست به قانون‌شکنی می‌زنند. از این رو بخش اعظم هزینه‌های نیروی پلیس صرف آنان می‌شود.

^۱ . delinquency

هزینه‌های مالی ناشی از خشونت‌ها، هزینه‌های دارویی و پزشکی مربوط به صدمات و آسیب‌های جسمی و ابتلا به آسیب‌های روان‌شناختی که کیفیت زندگی این نوجوانان بزهکار را کاهش می‌دهد و از مولد بودن آنان می‌کاهد نیز بسیار چشمگیر است (ماجیور^۱ و همکاران ۱۹۹۳). لینگرن^۲ (۱۹۸۸) معتقد است افرادی که در محله‌هایی زندگی می‌کنند که میزان جرم و جنایت زیاد است، به‌طور مستقیم مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند، بلکه به‌طور غیرمستقیم تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند. به‌علاوه بزهکاری، سلامت روانی و جسمانی افراد بزهکار را به مخاطره می‌اندازد، زیرا این افراد علاوه بر اینکه در خلاف و قانون‌شکنی درگیر می‌شوند، به خشونت‌های جرم‌انگیز نیز دست می‌زنند. به‌طور کلی، جوانان ۱۲ تا ۱۹ ساله در معرض خشونت‌های شخصی بیشتری قرار دارند تا جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله. پژوهش‌های جرم‌شناسی نیز نشان داده‌اند افرادی که در سبک‌های زندگی توأم با خلاف درگیر می‌شوند، احتمال بیشتری وجود دارد که در جرایمی نظیر قتل و آدم‌کشی و تجاوزات درگیر شوند (کندی و بارون^۳، ۱۹۹۳). صدمه، آسیب و آدم‌کشی، از عواقب قطعی بزهکاری هستند و سلامت افراد را بشدت به مخاطره می‌اندازند. جوانان بزهکار در معرض خطر دستگیری، توقیف و زندانی شدن قرار دارند و ممکن است دچار دامنه‌ای از مشکلات نظیر شرمساری، طرد یا مورد تبعیض واقع شدن از طرف والدین، معلمان، دوستان و کارفرمایان گردند و این منجر به کاهش میزان پیشرفت و دستاوردهای زندگی آنان می‌شود.

شیوع و میزان بروز بزهکاری

شیوع بزهکاری برابر است با تعدادی از نوجوانان جامعه که طی دوره زمانی خاصی در رفتارهای بزهکارانه درگیر می‌شوند (در طول دوران زندگی، یک سال، یک ماه و غیره). میزان بروز بزهکاری عبارت است از تعداد قانون‌شکنی‌های انجام‌شده توسط نوجوانان طی دوره زمانی خاص. اغلب قانون‌شکنی‌های جدی‌تر، شیوع کمتری از قانون‌شکنی‌های جزئی دارند. مطالعات انجام‌شده با استفاده از خودگزارش‌دهی نیز نشان داده‌اند که جرایم جدی‌تر شیوع کمتری دارند. مطالعه‌ای که در سال ۱۹۷۶ در مورد نمونه‌ای تصادفی از نوجوانان ۱۱ تا ۱۷ ساله انجام شد، نشان داد ۷۶ درصد پسران نوجوان طی یک سال گذشته در بعضی از بزهکاری‌های کلی درگیر بوده‌اند،

^۱ . Maguire

^۲ . Lindgren

^۳ . Kennedy & Baron

درحالی که فقط ۲۹ درصد پسران نوجوان گزارش کردند که دست به اعمال بزهکارانه فهرست شده در پرسشنامه نزده‌اند (الیوت، هایزینگا و منارد^۱، ۱۹۸۹).

در ایران آمار محکومان قضایی در سال ۱۳۶۲ نشان می‌دهد که از مجموع ۳۳۵۰۸ مورد، ۱۳۶۵۲ مورد آن یعنی بیش از یک سوم در سنین ۱۵ سالگی تا ۲۴ سالگی بوده‌اند. گزارش اداره بهداشت مدارس از دانش‌آموزانی که اختلالات عاطفی و روانی داشته‌اند، حاکی از این است که بزهکاری‌ها رقم بیشتری را به خود اختصاص داده است (مرکز آمار ایران، ۱۳۶۲).

بزهکاری و ویژگی‌های جمعیت‌شناسی اجتماعی

سن و جنسیت، از همبسته‌های مهم قانون‌شکنی و بزهکاری به‌شمار می‌روند. اگرچه ممکن است روابط بین این عوامل و خلافکاری تا حدودی وابسته به نوع قانون‌شکنی باشد، اما واقعیت این است که نوجوانان، بویژه پسران، بشدت در جرایم درگیر می‌شوند. میزان قانون‌شکنی تا حدودی در افراد ساکن در شهرها و نواحی صنعتی بیشتر است.

سن

آمار ملی آمریکا در سال ۱۹۹۲، نشان می‌دهد که میزان توقیف شدن به‌دلیل قانون‌شکنی در افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله در بالاترین سطح است و در ۱۶ سالگی به اوج خود می‌رسد (اداره فدرال مطالعات و بررسی‌ها، ۱۹۹۳). آمارهای مربوط به قانون‌شکنی‌های توأم با جرایم نشان می‌دهد که میزان قانون‌شکنی در سال‌های اول نوجوانی افزایش می‌یابد (۱۵ تا ۱۷ سالگی)، در سال‌های آخر نوجوانی در سطح متوسطی باقی می‌ماند و پس از آن کاهش می‌یابد، این پدیده هم در مورد دختران و هم در مورد پسران صدق می‌کند (فارینگتون^۲، ۱۹۸۷).

جنسیت

پسران گروه‌های سنی مختلف قانون‌شکنی می‌کنند و بیشتر این قانون‌شکنی‌ها توأم با جرایم‌اند. مطالعه‌ای که روی پسران و دخترانی که در سال ۱۹۵۸ در فیلادلفیا به‌دنیا آمده بودند انجام گرفت، نشان داد ۳۳ درصد پسران و ۱۴ درصد دختران قبل از ۱۸ سالگی حداقل یک‌بار توسط پلیس دستگیر

^۱ . Elliot, Huizinga & Menard

^۲ . Farrington

می‌شوند (ترسی، ولفگانگ و فیچلو^۱، ۱۹۸۵). میزان تفاوت‌های جنسی تا حدودی وابسته به عواملی نظیر نوع قانون‌شکنی، سن و نژاد است. احتمالاً میزان بروز جرایم جدی‌تری مانند دزدی و سرقت در پسران در بیشترین حد خود است. از این‌رو میزان توقیف دختران برابر با ۲۴ درصد کل توقیف‌هاست و میزان دستگیری به دلیل قانون‌شکنی‌هایی مانند سرقت، جعل اسناد و مدارک، خیلی کمتر و برابر با ۷ درصد از کل توقیف‌هاست. به نظر می‌رسد میزان این جرایم در پسران در سال‌های نوجوانی و سال‌های اولیه بزرگسالی در بیشترین حد است (اداره فدرال مطالعات^۲، ۱۹۹۳).

پژوهش جعفری و همکاران (۱۳۸۵) از جمله پژوهش‌های داخلی است که به بررسی عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با بزهکاری پرداخته است. محققان با استفاده از یک طرح مقطعی تعداد ۵۰ دختر بزهکار محکوم شده در دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که سن متوسط این دختران ۱۶/۲ سال بوده و ۹۱/۸ درصد آنان مجرد بودند، سطح سواد ۶۰ درصد از آنان در مقطع راهنمایی بوده، ۲ درصد از آنان بیسواد بودند، ۲۴ درصد از پدران آن‌ها و ۲۲ درصد از مادران آن‌ها بی‌سواد بودند. ۵۸ درصد از این نوجوانان دختر از خانواده خود جدا زندگی می‌کردند که شایع‌ترین علل این موضوع طلاق و جدایی والدین (۳۰ درصد) و ترک خانواده (۱۴ درصد) بود. شایع‌ترین نوع بزهکاری در این نوجوانان به ترتیب عبارت بود از: منکرات (۶۴ درصد)، سرقت (۱۰ درصد)، مواد مخدر (۱۰ درصد)، قتل (۲ درصد) و جرایم متعدد (۸ درصد). ۸۳/۵ درصد این دختران سیگار می‌کشیدند، ۵۳ درصدشان سابقه‌دار بوده و ۳۶ درصدشان در خانواده‌شان سابقه بزهکاری وجود داشته است که در ۵۵/۵ درصد موارد پدر، ۱۱/۱ درصد موارد مادر و ۳۳/۳ درصد موارد برادر یا خواهر فرد سابقه بزهکاری داشته است. همچنین در ۳۶ درصد موارد یکی از افراد خانواده اعتیاد داشته است و در ۲۶ درصد موارد افراد خانواده از بیماری جسمانی رنج می‌بردند. این دختران نوجوان بزهکار در ۴۲ درصد موارد داشتن دوستان ناباب و در ۳۸ درصد موارد خانواده را علت اصلی انحراف خود ذکر کردند.

سکونت در شهرهای بزرگ و صنعتی

محل اقامت، یکی از همبسته‌های مهم دیگر بزهکاری است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که میزان قربانی‌های ناشی از قتل و خودکشی ناشی از جرایم مختلف در شهرهای بزرگ، بویژه در پایتخت، بیشتر از حومه شهرها و شهرهای کوچک است (باستیان^۳، ۱۹۹۳). مطالعه ملی جوانان نشان می‌دهد

^۱ . Tracy, Wolfgang & Figlio

^۲ . Federal Bureau of Investigation

^۳ . Bastian

که ساکنان شهرها بیشتر دست به جرایم می‌زنند. در سال ۱۹۷۶، نمونه‌ای متشکل از ۲۶/۴ درصد جوانان شهری و ۱۵/۹ درصد جوانان روستایی پرسشنامه‌هایی را در مورد قانون‌شکنی‌های که طی سال قبل داشتند، پر کردند. نتایج نشان داد که میزان قانون‌شکنی در نوجوانان شهری سالیانه ۶/۹ درصد و در نوجوانان روستایی ۳/۲ درصد بود. رابطه بین سکونت در شهر و بزهکاری توسط داده‌هایی که از اداره پلیس به دست می‌آیند نیز تأیید شده است.

روندهای زمانی

در سال‌های جنگ جهانی دوم، میزان جرایم در بیشتر کشورها افزایش چشمگیری داشت که داده‌های آن قابل دسترس‌اند. بررسی و مطالعه تاریخی روندهای جرایم نشان می‌دهد که میزان جرایم در کشورهای صنعتی به صورت منحنی U شکل است که در سال‌های دهه ۱۸۰۰ و اوایل دهه ۱۹۰۰ کاهش و در سال‌های بعد افزایش یافته است (لان^۱، ۱۹۹۲). آمارهای اداری و داده‌های مربوط به قربانی‌ها، نشان می‌دهد که سطح جرایم در سال‌های دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسیده است. افزایش کلی در میزان جرایم از اواسط قرن نوزدهم به بعد تا حد زیادی به تغییر ساختار سنتی جامعه نسبت داده می‌شود.

پیشگیری

از نظر سنتی، پیشگیری به صورت فعالیت‌هایی تعریف می‌شود که منجر به توقف، کاهش یا ثابت ماندن میزان ارتکاب به جرم و رفتارهای بزهکارانه می‌شود. درمان نیز عبارت است از فعالیت‌هایی که به کاهش فراوانی و شدت رفتارهای بزهکارانه‌ای که تاکنون انجام می‌گرفته است، کمک می‌کند. تمایز قائل شدن بین پیشگیری از بزهکار شدن فرد و کاهش رفتارهای بزهکارانه در میان بزهکاران به صورت ایده‌آل بسیار ظریف، دقیق و مشکل است. از این رو بهتر است هر تلاشی را که برای جلوگیری از ازدیاد و فراوانی و شدت بزهکاری در طول پیوستار بزهکاری صورت می‌گیرد، پیشگیری از بزهکاری بنامیم. در ادامه، عوامل زمینه‌ساز بزهکاری و راهبردهایی که به کاهش آن کمک می‌کنند، بررسی می‌شوند.

^۱ . Lane

عوامل زمینه‌ساز بزهکاری

اعمالی که در پیشگیری از بزهکاری مؤثرند، احتمالاً به‌طور مستقیم تجارب، ویژگی‌ها، باورها، نگرش‌ها و رفتارهایی را که علت بزهکاری به‌شمار می‌روند، تحت تأثیر قرار می‌دهند. عوامل زیادی با بزهکاری رابطه دارند، مانند ویژگی‌های جامعه و محیط مدرسه و عوامل فردی نظیر فرایندهای خانوادگی، تجارب مرتبط با مدرسه و تحصیلات و نگرش‌ها و تجارب گروه همسالان، ارزش‌های شخصی، نگرش‌ها و باورهای فرد و عوامل اجتماعی نظیر رفتار جرم‌آفرین از نظر قانون و هنجارهای اجتماعی، داشتن فرصت‌هایی برای دست زدن به فعالیت‌های جرم‌آفرین، عدم سازمان‌یافتگی اجتماعی، عوامل تحصیلی شامل فقدان وضوح، دقت و همگونی در قواعد مربوط به روش‌های تشویق، عوامل مرتبط با خانواده شامل والدین مجرم، سخت‌گیری‌های افراطی، سبک‌های انضباطی ناهمگون، سهل‌انگاری والدین، روابط ضعیف، دعوا، آزار و اذیت، بحث و مجادله، سطوح پایین دلبستگی، نگرش‌ها و تجارب مرتبط با مدرسه شامل عملکرد تحصیلی ضعیف، دلبستگی کم به مدرسه و تعهد کم به درس و مدرسه. تجارب مرتبط با همسالان شامل طرد شدن از طرف همسالان، مواجهه و ارتباط با همسالان بزهکار و عوامل فردی شامل رفتارهای مشکل‌آفرین اخیر، تکانشی بودن یا سطوح پایین کنترل خود، نگرش‌های طغیان‌گرایانه، باور داشتن به مطلوبیت تخلف از قانون و سطوح پایینی از مهارت‌ها و توانش‌های اجتماعی نظیر مدنظر قرار ندادن پیامدهای احتمالی اعمال و عدم ارائه راه‌حل‌های جانشین برای مشکلات، ناتوانی در مدنظر قرار دادن دیدگاه دیگران و عدم تعبیر و تفسیر نشانه‌های اجتماعی به‌طور صحیح و درست است.

تمام این عوامل علت بزهکاری نیستند. برخی از آنها ممکن است پیامدهای بزهکاری و بعضی هم از همبسته‌های مهم آن باشند. برای مثال، ممکن است نگرش فرد به رفتارهای خلاف قانون بخشی از فرایند دلیل‌تراشی باشد که بعد از اقدام به جرم راه‌اندازی می‌شود و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. یا اینکه ممکن است نوجوانانی که نمی‌توانند خود را کنترل کنند، هرگز نتوانند در مدرسه و تحصیل موفق باشند، در نتیجه بخواهند توانایی و مهارت خود را با پرداختن به جرم و کارهای خلاف به دیگران ثابت کنند، از این‌رو بیشتر در جرایم درگیر می‌شوند. بدین‌ترتیب رابطه بین عملکرد تحصیلی و بزهکاری را می‌توان براساس میزان کنترلی که نوجوان بر خود دارد، تبیین کرد.

عزت نفس پایین

نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد افرادی که کمتر می‌توانند خود را کنترل کنند (صفات و ویژگی‌هایی نظیر لجبازی، کنترل کم بر تکانه‌ها و پرخاشگری)، بیشتر در معرض خطر رفتارهای

مشکل آفرین بعدی از جمله بزهکاری قرار دارند. این ویژگی‌ها چه در سال‌های اولیه کودکی یعنی ۳ یا ۴ سالگی اندازه‌گیری و سنجیده شوند (بلوک، بلوک و کیز^۱، ۱۹۹۸)، چه در سال اول دبستان، چه در سال‌های کودکی میانی یعنی در ۷ تا ۱۱ سالگی (شدلر و بلاک^۲، ۱۹۹۰)، چه در سال‌های اولیه نوجوانی یعنی کلاس سوم راهنمایی یا اول دبیرستان (اسمیت و فوگ^۳، ۱۹۷۸) و چه در اواخر نوجوانی یعنی کلاس سوم دبیرستان (کانجر و میلر^۴، ۱۹۶۶)، پیش‌بینی‌کننده خوبی برای رفتارهای مشکل آفرین بعدی هستند. در واقع، براساس ویژگی‌های شخصیتی، می‌توان دامنه وسیعی از رفتارهای مشکل آفرین را پیش‌بینی کرد (مانند سوء مصرف دارویی، بزهکاری، ترک تحصیل، عملکردهای ضعیف و مشکلات سلامت روانی).

این گروه از ویژگی‌های شخصیتی اغلب نشان‌دهنده مهارت‌ها و توانش‌های کم اجتماعی‌اند. برای مثال، ممکن است افراد با سطوح کنترل ضعیف، کنترل تکانه‌های خود را خیلی سخت بدانند، اما روش‌های غیرقابل قبول اجتماعی برای آنان بسیار آسان باشد و به راحتی به آن عمل کنند. این افراد نمی‌توانند بر فعالیت‌های هدفمندی نظیر فعالیت‌هایی که برای عملکرد موفق در مدرسه ضرورت دارند، متمرکز شوند. این رفتارهای غیرماهرانه احتمال طرد شدن از طرف همسالان و قضاوت منفی از سوی معلم را افزایش می‌دهند (داج^۵ و همکاران، ۱۹۸۶).

کامرانی فکور، رسول‌زاده طباطبایی و اللهیاری (۱۳۸۲)، خصوصیات روان‌شناختی دختران و زنان ویژه و دختران و زنان عادی را مقایسه کردند. بدین منظور ۶۰ نفر از دختران و زنان بزهکار و روسپی ۱۵ تا ۳۵ ساله‌ای را که در مراکز بازپروری زنان آسیب‌دیده اجتماعی سازمانی بهزیستی و زندان اوین نگهداری شدند، انتخاب کرده و آنها را از نظر میزان هیجان‌طلبی، هوش، حرمت خود و هویت با ۶۰ دختر و زن عادی که در شهر تهران سکونت داشتند، مقایسه کردند. نتایج نشان داد زنان ویژه به‌طور معناداری در مقیاس هیجان‌خواهی و خرده‌مقیاس‌های آن از جمله تجربه‌طلبی، بازدارندگی و ملال‌پذیری نمره‌های بهتری را در مقایسه با زنان عادی به دست آوردند. همچنین زنان ویژه در مقایسه با زنان عادی به‌طور معناداری در آزمون‌های هوش و حرمت خود نمره‌های کمتری را کسب کردند.

^۱. Block, Block & Keyes

^۲. Shedler & Block

^۳. Smith & Fogg

^۴. Conger & Miller

^۵. Dodge

عملکردهای خانوادگی

اعمال و رفتارهای والدین و تعاملات خانوادگی افراد با رفتارهای بزهکارانه ارتباط دارد (گلاک^۱ و گلاک، ۱۹۸۶). مرور پیش‌بینی‌کننده‌های مهم بزهکاری در نوجوانان پسر، نشان داد که اعمال، رفتار و عملکردهای خانوادگی، مهم‌ترین و اولین پیش‌بینی‌کننده بزهکاری در آنان است. عناصر مهم رفتارهای خانوادگی عبارتند از عدم تجانس و ناهمگونی، سهل‌انگاری، دعوا، درگیری و مشاجره، رفتارهای انضباطی بسیار تنبیه‌کننده و توأم با سخت‌گیری، تعاملات خانوادگی توأم با سردی، بی‌محبتی و طرد کردن، فقدان ارتباط با فرزندان، منفعل بودن و عدم آگاهی والدین از روابط فرزندان با همسالان خود، عدم نظارت والدین بر فعالیت‌های اوقات فراغت نوجوانان و تنبیه جسمانی و فیزیکی. شواهد نشان می‌دهند که این ویژگی‌ها نه تنها پیش‌بینی‌کننده خوبی برای شروع و تداوم رفتارهای بزهکارانه‌اند، حتی می‌توانند انواع مختلف و اشکال متفاوت رفتارهای بزهکارانه را پیش‌بینی کنند؛ اشکال مختلف بزهکاری شامل جرایم پرخاشگرانه، جرایم خاص و استفاده از مواد مخدر و داروهایست.

پژوهش شهریاری احمدی (۱۳۸۳) از جمله پژوهش‌های داخلی است که تأثیر ساختار خانواده را بر میزان تمایل نوجوانان به بزهکاری مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای مربوط به ساختار خانواده شامل خانواده تک‌والدی - دو‌والدی و ناسازگار - والدین ازدواج مجدد کرده بود. نتایج نشان داد در دو گروه دختران و پسران تفاوت معناداری بین نوجوانان در خانواده‌های با ساختار ناسازگار و خانواده‌های عادی و خانواده‌های ناسازگار با خانواده‌هایی که والدین ازدواج مجدد کرده‌اند از نظر تمایل به بزهکاری مشاهده شد، اما جنسیت در میزان گرایش به بزهکاری تأثیر معناداری نداشت.

سامنیگو و گنزالس^۲ (۲۰۰۳)، به بررسی اثر وضعیت فرهنگ‌پذیری نوجوانان بر رفتارهای بزهکارانه آنان پرداختند. آنان ۲۱۴ دختر و پسر نوجوان دبیرستانی (۹۳ پسر و ۱۲۱ دختر) آمریکایی مکزیکی‌تبار را با میانگین سن ۱۵ سال، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که ۴ متغیر واسطه‌گر از جمله تعارضات خانوادگی، بازیابی و نظارت مادرانه، انضباط ناهمگون و ناهماهنگ، درگیری‌های منفی با همسالان، اثر وضعیت فرهنگ‌پذیری را بر رفتارهای بزهکارانه میانجی‌گری می‌کنند.

وگا^۳ و همکاران (۱۹۹۵) دریافتند نوجوانان آمریکای لاتین که فرهنگ‌پذیری بیشتری دارند، بیشتر در معرض خطر انجام رفتارهای بزهکارانه قرار دارند تا آنهایی که فرهنگ‌پذیری کمتری دارند. این

^۱ . Glueck

^۲ . Samaniego & Gonzales

^۳ . Vega

یافته‌ها نشان می‌دهند که علاوه بر متغیرهای مذکور، میزان فرهنگ‌پذیری نوجوانان نیز در رفتارهای بزهکارانه آنان نقش دارد.

آمار محکومان قضایی در کشورمان نشان می‌دهد که از مجموع ۵۲۰۱۳ بزه در سال ۱۳۷۷، به‌طور کلی ۲۱۳۱۸ مورد آن یعنی در حدود نیمی از آن در سنین ۱۵ تا ۲۴ سالگی اتفاق افتاده است. همچنین گزارش اداره بهداشت مدارس از دانش‌آموزانی که اختلالات رفتاری داشته‌اند، حاکی از این است که بزهکاری‌ها رقم بیشتری را به خود اختصاص داده است. جدول ۷-۱ اختلال رفتاری را در دانش‌آموزان دبیرستانی نشان می‌دهد (به نقل از احمدی، ۱۳۸۲).

جدول ۷-۱. فراوانی و نوع اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

نوع اختلال	فراوانی
بی‌قراری و اضطراب	۶۱۵۸
ولگردی	۲۶۲۱
پرخاشگری و حالت‌های تهاجمی	۵۲۱۸
فرار از مدرسه	۴۷۸۳
دزدی	۳۰۲۸
افسردگی	۸۲۲۲

یافته‌های جدول ۷-۱ نشان می‌دهد که بیش از دو سوم دانش‌آموزن مراجعه‌کننده به بی‌قراری و بزهکاری‌هایی از قبیل ولگردی، پرخاشگری، فرار از مدرسه و دزدی مبتلا هستند. تحقیق در مورد ۹۶ نوجوان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت تهران، نشان داد که بیشترین مورد بزهکاری در سنین ۱۵ تا ۱۷ سالگی رخ داده است (انجمن اولیاء و مربیان، ۱۳۶۱).

جدول ۲-۷. درصد و نوع بزهکاری‌های مختلف در قانون اصلاح و تربیت تهران

سن	درصد
۱۰-۱۴	۲۸
۱۵-۱۷	۶۶
۱۸-۲۰	۶
نوع بزه	درصد
سرقت	۵۱
لواط	۳۴
ضرب و جرح	۱۵

همان‌گونه که در جدول ۲-۷ مشاهده می‌شود، بیشتر بزهکاری‌ها مربوط به سنین ۱۵ تا ۱۷ سال یا سنین نوجوانی است. احتمالاً بزهکاری‌ها در نوجوانان به این علت است که آنها نیرو و انرژی فوق‌العاده‌ای دارند که به دلیل مشکلات شخصی، خانوادگی یا اجتماعی نمی‌توانند از این انرژی و نیروی خود در جهت صحیح استفاده کنند. حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف متفاوت است، اما در قانون اصلاح و تربیت تهران حداقل سن بزهکاری برابر با ۱۰ سال است. نوع بزهکاری نیز در جوامع مختلف متفاوت است، همان‌گونه که در جدول ۲-۷ مشاهده می‌شود، سرقت، لواط و ضرب و جرح از جمله بزه‌هایی است که در نوجوانان ساکن در قانون اصلاح و تربیت تهران مشاهده شده است.

اولین محیطی که زمینه بزهکاری را در فرد ایجاد می‌کند، خانواده است. اغلب بزهکاران از خانواده‌های آشفته و از هم پاشیده‌اند. مطالعه‌ای که روی کودکان بزهکار ساکن در قانون اصلاح و تربیت تهران در سال ۱۳۶۱ انجام شد، نشان داد که یک سوم پدران و یک دهم مادران این کودکان بزهکار دارای شخصیت ضداجتماعی یا مبتلا به الکلیسم بودند. یافته‌های این مطالعه را در جدول ۳-۷ مشاهده می‌کنید.

جدول ۳-۷. فراوانی مشکلات خانوادگی در کودکان و نوجوانان بزهکار ساکن در کانون اصلاح و تربیت تهران

نوع اختلال	فراوانی
عدم تفاهم و درگیری والدین	۳۰
سختگیری و عصبانیت پدر	۳۵
کتک زدن کودکان	۶۵
اعتیاد والدین	۲۷
عدم محبت و حمایت	۵۰
طلاق یا فوت والدین	۳۰

چنانکه در جدول ۳-۷ مشاهده می‌شود، یک سوم از خانواده‌های بزهکاران با یکدیگر درگیری داشته‌اند، حدود دو سوم آنان از تنبیهات بدنی استفاده می‌کرده‌اند، یک دوم آنان به فرزندان خود محبت نمی‌کرده‌اند، و در حدود یک سوم آنان مبتلا به اعتیاد بوده‌اند. این یافته‌ها نشان‌دهنده اهمیت و نقش شیوه‌های فرزندپروری در شکل‌گیری بزهکاری کودکان و نوجوانان است.

دوستان و همسالان بزهکار نقش مهمی در بزهکاری نوجوانان دارند. در سوال از بزهکاران کانون اصلاح و تربیت تهران در این باره که از چه کسی بزه را فرا گرفته‌اند، به نقش دوستان و همسالان اشاره شده است. نتایج این مطالعه را در جدول ۴-۷ مشاهده می‌کنید (کانون اصلاح و تربیت تهران، ۱۳۶۱).

جدول ۴-۷. فراوانی نقش افراد در بزهکاری نوجوانان

نوع اختلال	فراوانی
دوستان و همسالان بزهکار	۴۴
خود شخص	۲۹
اقوام	۴
اتفاقی و بدون تقصیر	۲۳

همان‌طورکه در جدول ۴-۷ مشاهده می‌شود، دوستان و همسالان بزهکار بیشترین نقش را در انجام رفتارهای بزهکارانه نوجوانان داشته‌اند.

عملکردهای تحصیلی و نگرش به مدرسه

شکست تحصیلی، یکی از بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های مشخص‌شده برای الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر، رفتار بزهکارانه، حاملگی نوجوانان، مردود شدن و اخراج از مدرسه است (گریسام و شپارد^۱، ۱۹۸۹). تعهد کم به قراردادها و قوانین اجتماعی و عدم دلبستگی به افراد سازگار از نظر اجتماعی و فرااجتماعی نیز می‌تواند بزهکاری را پیش‌بینی کند. دلبستگی کم به مدرسه، اغلب از طریق عدم علاقه به مدرسه یا افرادی که در مدرسه‌اند، مشخص می‌شود. از سوی دیگر، تعهد کم به مدرسه، اغلب با تلاش اندک برای انجام تکالیف مدرسه و عدم حضور یا حضور کم در مدرسه و کلاس درس مشخص می‌شود.

اگرچه در مطالعات طولی رابطه عوامل مربوط به مدرسه با بزهکاری بعدی افراد اثبات شده، اما برخی از شواهد نشان می‌دهند که در تفسیر این ارتباط به‌عنوان رابطه علت و معلولی و به‌صورت علی باید محتاط بود. عملکرد تحصیلی تحت تأثیر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان قرار می‌گیرد، همچنین عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مهارت‌های اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اغلب درجه‌بندی معلم‌ها و همسالان از مشکلات رفتاری کنونی فرد، عملکرد تحصیلی و مشکلات بعدی رفتاری او را پیش‌بینی می‌کنند (اسپیواک و سیانسی^۲، ۱۹۸۷).

ارتباط با همسالان بزهکار

به احتمال زیاد، کودکانی که همسالانشان در فعالیت‌های بزهکارانه درگیر می‌شوند، دست به رفتارهای بزهکارانه می‌زنند. تبیین‌های نظریه یادگیری اجتماعی در مورد داشتن رابطه با همسالان بزهکار، نشان می‌دهد که همسالان بزهکار، یکدیگر را از طریق اصول یادگیری شرطی تحت تأثیر قرار می‌دهند (اکرز^۳ و همکاران، ۱۹۷۹). همسالان بزهکار الگوهای رفتاری‌ای را برای یکدیگر به‌منظور تقلید فراهم کرده و با پاداش دادن و عدم تنبیه این رفتارها آنها را تقویت می‌کنند. به‌علاوه، افراد موضوعات ارزشی رفتاری خوب یا بد را (هنجارها، نگرش‌ها، سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌ها) از طریق ارتباط با گروه یاد می‌گیرند. هرچه افراد رفتاری را بیشتر به‌عنوان رفتار خوب یا لاقبل رفتار معقول، منطقی و موجه تعریف کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که به آن رفتار عمل کنند.

اغلب افراد بزهکار در گذشته مورد بی‌مهری همسالان خود واقع شده‌اند. به‌درستی معلوم نیست که آیا طردشدن از طرف همسالان منجر به بزهکاری می‌شود یا اینکه بزهکاری منجر به طرد شدن از

^۱ . Grissom & Shepard

^۲ . Spivak & Cianci

^۳ . Akers

سوی همسالان می‌گردد. با این حال، برخی شواهد نشان می‌دهند که جوانان بزهکار خود را با نشان دادن رفتارها و شخصیت پرخاشگرانه در گروه دوستان جای می‌دهند.

برخی صاحب‌نظران اعتقاد دارند که طردشدن از گروه‌های یکپارچه اجتماعی ممکن است موجب محروم شدن کودکان طردشده از فرصت‌های مناسب برای یادگیری و برقراری تعاملات اجتماعی مثبت با همسالانی که رفتارهای سازش‌یافته و سالمی دارند، شود. از این رو کودکان طردشده از طرف همسالان که در مهارت اجتماعی کاستی‌هایی دارند، ممکن است رفتارهای سازش‌نیافته بیشتری را با برقراری ارتباط با کودکان طردشده دیگر بیاموزند و این رفتارهای سازش‌نیافته ممکن است با برقراری ارتباط با سایر کودکان پرخاشگر تقویت شوند (کوپراسمیت، کوی و داج^۱، ۱۹۹۰).

وایسنر و سیلبرینسن^۲ (۲۰۰۳)، طی مطالعه‌ای طولی که بر روی ۳۱۸ نوجوان آلمانی ۱۴ ساله انجام دادند، دریافتند که دارا بودن دوستان با انحرافات و تخلفات زیاد، همدلی ضعیف بین والدین و نوجوانان، پیشرفت تحصیلی ضعیف و کنترل و نظارت کم والدین، از جمله عوامل مهمی‌اند که با بزهکاری این نوجوانان رابطه تنگاتنگی دارند.

محدودیت‌ها و قیدوبندهای محیطی

ویژگی‌های محیطی، مانع بروز رفتارهای بزهکاری می‌شوند یا آن را افزایش می‌دهند. در بعضی محیط‌ها، نوجوانان فرصت‌های محدودی برای درگیر شدن در رفتارهای نامطلوب دارند و در برخی محیط‌ها، هنجارهای واضح، روشن و بدون ابهامی وجود دارند که رفتارهای معینی را ممنوع می‌کنند و جوانان کمتر دست به رفتارهای نامطلوب می‌زنند.

در سطح فردی، افرادی که مواد و داروهای روان‌گردان را به سادگی در جامعه یا محیط مدرسه به‌دست می‌آورند، بیشتر از مواد مخدر استفاده می‌کنند و بیشتر به سراغ آن می‌روند. در سطح کلان و در سطح اجتماعی، فراوان بودن و قابلیت دسترسی ساده به اسلحه در یک شهر با میزان قتل و آدم‌کشی به‌طور مثبت ارتباط دارد (مک دوال^۳، ۱۹۹۱).

ویژگی‌های کلاس درس و محیط مدرسه (برای مثال رسالت‌ها و اهداف تحصیلی قوی، ابهام‌زدایی از هنجارهای رفتاری، قابلیت پیش‌بینی، همگونی و تناسب در به‌کارگیری پیامدهایی برای رفتارهای نادرست و جو حمایت عاطفی و هیجانی)، به‌طور مستقیم رفتارهای مشکل‌آفرینی را که اولین بار در مدرسه اتفاق می‌افتند (نه رفتارهای بزهکارانه جدی‌تر را که ابتدا خارج از مدرسه رخ

^۱ . Kupersmidt, Coie & Dodge

^۲ . Wiesner & Silbereisen

^۳ . Mc Dowall

می‌دهند)، تحت تأثیر قرار می‌دهند (سازمان اصلاحات و پژوهش‌های آموزشی^۱، ۱۹۹۳b). با این حال، احتمال اینکه محیط‌های کلاس و مدرسه به‌طور غیرمستقیمی بزهکاری را با تحت تأثیر قرار دادن ویژگی‌های فردی افراد و تجارب مدرسه‌ای که بزهکاری را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهند، تشویق کند، وجود دارد.

به‌طور کلی، مطالعات پژوهشی انجام‌شده در مورد علل بزهکاری، نشان داده‌اند که تدابیر مؤثر پیشگیری‌کننده، رفتارهای بین‌فردی سازش‌یافته را افزایش می‌دهند، عملکردهای خانوادگی را اصلاح می‌کنند، عملکرد تحصیلی را بهبود می‌بخشند، نگرش‌های مطلوب و مساعدی در مورد قوانین و مقررات ایجاد می‌کنند و رابطه با همسالان بزهکار را کاهش می‌دهند. محیط‌هایی که عواقب رفتارهای فرااجتماعی را از طریق وضع هنجارها و انتظارات دقیق و بدون ابهام نشان می‌دهند نیز موجب کاهش بزهکاری می‌شوند. این مسئله موجب محدود کردن فرصت‌های فرد برای درگیر شدن در رفتارهای نادرست می‌شود و رفتارهای نادرست را به‌صورت همگونی خاموش می‌کند.

درمان

اگرچه در مورد نقش مهم درمان در زندگی مجرمان و خلافکاران بزرگسالی که محکومیت خود را گذرانده‌اند، بحث‌های زیادی وجود دارد، اما بر نقش درمان‌های مختلف در اصلاح رفتارهای جوانان بزهکار و مجرم تأکید زیادی شده است، زیرا نوجوانان و جوانان کمتر در سبک زندگی خلاف غرق شده‌اند و ظرفیت بیشتری دارند که عضو مفیدی در جامعه شوند. راهبردهای خلاصه‌شده در زیر، از جمله شیوه‌های درمانی پیشنهادی برای نوجوانان خلافکار و مجرم می‌باشند.

موقعیت‌های درمانی: در درمان مؤسسه‌ای برخلاف درمان مبتنی بر جامعه (جامعه‌مدار)، خدمات درمانی وابسته به مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهایی نظیر مدارس و آموزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بازداشتگاهی، کانون‌های اصلاح و تربیت و پادگان آموزشی است و در آنجا ارائه می‌شود. چنین خدماتی از نظر نوع (برای مثال درمان انفرادی یا گروهی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، آموزش تحصیلی یا شغلی) و رویکرد نظری که درمان بر آن مبتنی است، بسیار متفاوت‌اند. چند تحقیق محدود در مورد ارزیابی کارایی درمان اصلاحی سازمانی یا مؤسسه‌ای وجود دارد. ایزو و راس^۲ (۱۹۹۰؛ به نقل از دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶)، فراتحلیلی را روی ۴۶ مطالعه انجام دادند. آنها دریافتند که موقعیت‌های درمانی، متغیر مهمی در کارایی یک برنامه به‌شمار می‌روند و کارآمدترین و

^۱ . office of educational research and improvements

^۲ . Izzo & Ross

مؤثرترین برنامه‌های درمانی در موقعیت‌های اجتماعی انجام شده‌اند تا در موقعیت‌های مؤسسه‌ای و سازمانی.

وایت‌هد و لاب^۱ (۱۹۸۹) نیز پنجاه مطالعه موجود در مجلات تخصصی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۴ را بررسی و پنج رویکرد مختلف درمانی مختلف را از نظر کارایی در کاهش تکرار جرم و خلاف با یکدیگر مقایسه کردند؛ تغییر مسیر و تغییر جهت بدون سیستم، تغییر مسیر و تغییر جهت با سیستم، اصلاحات اجتماعی و جمعی (شامل آزادی مشروط و مجازات تعلیقی)، برنامه‌های درمانی مؤسسه‌ای، سازمانی و شبانه‌روزی و برنامه‌های جدید و خاص (نظیر ترساندن مستقیم و توأم با صراحت فرد مجرم و محدود کردن ظاهری). این محققان دریافتند که هیچ‌یک از برنامه‌های درمانی مذکور اثر و نتایج مثبت و مؤثری نداشتند، اما در عین حال تأثیر مثبت برنامه‌های درمانی مؤسسه‌ای، سازمانی و شبانه‌روزی کمتر از برنامه‌های اصلاحات اجتماعی بود.

به‌طور کلی، برنامه‌های درمانی انجام‌شده در موقعیت‌های اجتماع - مدار (یا مبتنی بر اجتماع)، تأثیرات مثبت‌تری را در مقایسه با موقعیت‌های سازمانی، مؤسسه‌ای و شبانه‌روزی داشتند. در واقع، به‌نظر می‌رسد موقعیت‌های مؤسسه‌ای و شبانه‌روزی تأثیرات مثبت بعضی از درمان‌ها را کاهش و اثر منفی سایر درمان‌ها را افزایش می‌دهند (اندریوز^۲ و همکاران، ۲۰۰۴).

یک شکل نسبتاً جدید از درمان مؤسسه‌ای و سازمانی که مورد توافق همگان است، «پادگان آموزشی» یا «ضربه حبس» نامیده می‌شود. این اردوگاه‌ها، اغلب برای دختران نوجوانی طراحی شده‌اند که مرتکب جرم‌های بدون خشونت شده و از آموزش‌های پادگان‌های نظامی ارتش، الگوگیری کرده‌اند. در این اردوگاه‌ها، بر تعلیمات نظامی و تشریفات ارتشی، آموزش‌های جسمانی و کار سخت تأکید می‌شود. علاوه بر محورهای اساسی در آموزش به سبک نظامی، این برنامه‌ها از نظر ابعادی نظیر میزان برنامه‌های بازپروری، شدت نظارت و کنترل پس از آزاد شدن و نوع خدمات مربوط به مراقبت‌های بعدی، با آموزش‌های نظامی متفاوت‌اند. مطالعات انجام‌شده روی اردوگاه‌های آموزشی نشان داده‌اند که این برنامه‌ها داروی همه دردها نیستند، به‌طوری‌که نتایج برخی تحقیقات نشان داده‌اند این برنامه‌ها اثری بر تکرار جرم در آینده توسط افراد مجرم ندارند، بلکه در مقایسه با سایر درمان‌های مؤسسه‌ای و سازمانی، در کاهش میزان جرم در زندان‌ها، راه‌حل کم‌هزینه‌تری به‌شمار می‌روند.

درمان‌های مبتنی بر اجتماع، در محیط‌های اجتماعی جمعی (اماکن اجتماعی) ارائه می‌شوند. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های روزانه (غیرشبانه‌روزی) و خدمات شبانه‌روزی می‌باشند که در مکان‌های عمومی ارائه می‌شوند و در کل کوچک‌ترند و امنیت کمتری از مؤسسه‌ها و سازمان‌ها دارند. در

^۱ . Whitehead & Lab

^۲ . Andrews

سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها مسئولان جامعه برای غیرمؤسسه‌ای و غیرسازمانی کردن نوجوانان مجرم تحت فشار قرار گرفتند، در نتیجه درمان‌های اجتماع - مدار رشد فزاینده‌ای پیدا کردند. صاحب‌نظران این حوزه امیدوارند که برنامه‌های درمانی اجتماع - مدار محیطی هدایت‌کننده‌تری برای درمان ایجاد کنند و مشکلاتی را که درمان‌های مؤسسه‌ای و سازمانی دارند، نداشته باشند.

دامنه این برنامه‌ها می‌تواند شامل نظارت حداقل بر نوجوانان تا سکونت آنان در مکان‌های شبانه‌روزی باشد. سکونت در مکان‌های شبانه‌روزی در واقع از نظر جو حاکم بر آن و دسترسی به جامعه، کاملاً مانند مکان‌های مؤسسه‌ای و سازمانی است. بعضی از انواع رایج و شایع درمان‌های اجتماع‌مدار عبارتند از: درمان با استفاده از آزادی مشروط افتراقی، روش‌های مشاوره‌ای تعاملات گروهی هدایت‌شده، مراقبت‌های پرورشگاهی، خانه‌های گروهی و مراکز شبانه‌روزی نوجوانان.

باور اساسی درمان‌های اجتماع‌مدار این است که درمان نوجوانان در محیط مؤسسه‌ای منجر به انتقال مهارت‌های آموخته‌شده در مؤسسه به محیط‌های واقعی زندگی نمی‌شود. به‌طور معمول در برنامه‌های اجتماع‌مدار، نوجوان را یا در خانه یا در محیط‌هایی مانند خانه نگهداری می‌کنند تا سازگاری خود را به‌دست آورد و در نتیجه احتمال تکرار جرم توسط او کاهش پیدا کند. این برنامه‌ها برای اجتناب از فرستادن نوجوانان به مراکز اصلاح و بازپروری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فراتحلیل‌های انجام‌شده روی این برنامه‌ها، به‌منظور بررسی میزان کارایی آنها در کاهش بزهکاری و ارتکاب جرم، نه تنها به مطالعه تکرار جرم توسط نوجوانان مجرم پرداخته‌اند، بلکه نتایج رفتاری (نظیر عملکرد تحصیلی و رفتار اجتماعی) و پیامدهای نگرشی و شناختی (مثل اندازه‌های شناختی و عزت نفس) را بررسی کرده‌اند. این فراتحلیل‌ها نشان داده‌اند، اگرچه تأثیر برنامه‌های اجتماع‌مدار در تمام موارد مذکور مثبت است، اما این تأثیرات از نظر آماری معنادار نبوده‌اند (اندریوز و همکاران، ۲۰۰۴).

به‌طور کلی، اگرچه برنامه‌های اجتماع - مدار در کاهش هزینه درمان نوجوانان بزهکار و مجرم نقش دارند، اما به‌طورمعمول شامل نظارت‌های شدیدی که در برنامه‌های مؤسسه‌ای اعمال می‌شوند، نیستند، از این‌رو احتمال تکرار جرم را افزایش می‌دهند.

شیوه‌های درمانی

بیشتر درمان‌ها را می‌توان هم در موقعیت‌های مؤسسه‌ای و سازمانی و هم در موقعیت‌های اجتماع‌مدار به‌کار برد. اگرچه موقعیت درمان یکی از مهم‌ترین علل کارایی و تأثیر یک درمان خاص است، اما پرداختن به کارایی و تأثیر شیوه‌های درمانی مختلف، ارزشمندتر است. به‌طور کلی، شیوه‌های درمانی شامل موارد زیر است: روان‌پویشی، رفتاری (شامل راهبردهایی نظیر مدیریت وابستگی)، شناختی - رفتاری (آموزش تعاملات گروهی هدایت‌شده، فرهنگ مثبت همسالان)، مهارت‌های زندگی (شامل درمان‌های طراحی‌شده برای بهبود و افزایش مهارت‌هایی مربوط به کارکردهای موفق روزمره‌ای نظیر آموزش درباره مصرف الکل و مواد و تجربه تحصیلی، شغلی و خارج از خانه) و سایر درمان‌ها (شامل موسیقی‌درمانی، درمان با مولتی‌ویتامین و مهارت‌های غیرافتراقی). در ادامه خلاصه‌ای از این درمان‌ها مطرح می‌شوند.

کارایی رویکردهای مختلف درمانی

درمان روان‌پویشی

درمان روان‌پویشی، یکی از اشکال رایج درمان بویژه در موقعیت‌های شبانه‌روزی است، اما کارایی آن برای نوجوانان و جوانانی که مرتکب جرم شده‌اند، اثبات نشده است. نتایج بعضی مطالعات نشان داده‌اند که گروه‌درمانی و درمان انفرادی در موقعیت‌های شبانه‌روزی اثر کمی بر کاهش تکرار جرم توسط نوجوانان خلافکار دارد (مولوی^۱ و همکاران، ۱۹۹۳؛ به نقل از دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶). نتایج بعضی مطالعات نیز نشان‌دهنده نقش مؤثر درمان روان‌پویشی در کاهش تکرار جرم هم در موقعیت‌های مؤسسه‌ای و هم در موقعیت‌های اجتماعی است (دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶). به‌طور کلی، به‌نظر می‌رسد که روان‌درمانگری انفرادی نمی‌تواند تکرار جرم را کاهش دهد، زیرا هدف آن ایجاد تغییرات شناختی کلی و عمومی نظیر دستیابی به درکی جدید از علت‌های رفتار و ایجاد زمینه برای روابط گرم و حمایت‌کننده است. به عبارت دیگر، هدف‌های درمانی مبهم و دوپهلو و الگوهای درمانی غیردقیق، در طولانی‌مدت موجب می‌شود که مراجع نتواند در رفتارهای مطلوب درگیر شود.

به‌نظر می‌رسد درمان‌هایی با ساختار کمتر و غیرمتمرکزتر نظیر مشاوره و راهنمایی، کارایی کمتری در مقایسه با درمان‌های دارای ساختار بیشتر و متمرکزتر دارند. در این مورد لیپسی^۲ (۱۹۹۲) اعتقاد

^۱. Mulvey

^۲. Lipsey

دارد درمان‌هایی که بر موضوعات زندگی واقعی که در حال حاضر وجود دارند تأکید می‌کنند، ممکن است کارایی بیشتری در کاهش تکرار جرم داشته باشند. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد خانواده‌درمانی در کاهش جرم تأثیر بسزایی داشته باشد. الگوی خانواده‌درمانی کارکردی که شامل قراردادهای رفتاری و روش‌های ارتباطی است، برای کاهش تکرار جرم و خلاف در میان بزهکاران، کارایی و تأثیر زیادی دارد. با این حال، نتایج برخی تحقیقات نشان داده‌اند که خانواده‌درمانی رفتاری هیچ تأثیری در کاهش جرم در افراد مجرم و بزهکار ندارد (گیسمار و وود^۱، ۱۹۸۵؛ به نقل از دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶).

کارهای موردی و مشاوره‌های انفرادی، از جمله برنامه‌های درمانی انفرادی به‌شمار می‌روند. درمان‌های موردی که برای هر فرد به‌صورت منحصر به فرد و خاصی طراحی می‌شوند، در کاهش تکرار جرم تأثیر بیشتری دارند تا درمان‌ها و کارهای موردی که در همه موقعیت‌ها کاربرد دارند.

رویکردهای شناختی - رفتاری

همان‌گونه که در بخش پیشگیری اشاره شد، درمان‌های دارای جهت‌گیری‌های شناختی - رفتاری که متمرکز بر نواقص موجود در مهارت‌های شناختی‌اند، بیشترین موفقیت را در کاهش تکرار جرم داشته‌اند. این برنامه‌ها را در وهله اول می‌توان به جهت‌گیری‌های رفتاری و جهت‌گیری‌های شناختی تقسیم کرد.

الگوی خانواده آموزشی، در درجه اول، رویکرد درمانی رفتاری است که در موقعیت‌هایی نظیر خانه‌های گروهی شبانه‌روزی اجتماعی به‌کار گرفته می‌شود. در خانه‌های خانواده آموزشی، یک زوج یا زن و شوهر آموزش‌دیده با شش نوجوان بزهکار زندگی می‌کنند. این والدین نظام رفتاری سیستماتیکی را که متشکل از امتیازها و پاداش‌هایی است که رفتار نوجوان را هدایت می‌کند، به نوجوانان بزهکار آموزش می‌دهند. ارزشیابی این الگو نشان می‌دهد که این الگو رفتارهای بزهکارانه را تا زمانی که نوجوان در برنامه شرکت می‌کند، کاهش می‌دهد. با این حال، برنامه‌هایی که شامل مؤلفه‌های شناختی‌اند (نظیر بعضی از عناصر و مؤلفه‌هایی که تفکر مجرم را هدف قرار می‌دهند، از جمله آموزش حل مسئله، آموزش مهارت‌های گفت‌وگو، آموزش مهارت‌های بین‌فردی، درمان منطقی - هیجانی، ایفای نقش و سرمشق‌دهی یا اصلاحات رفتاری شناختی)، دو برابر برنامه‌هایی که فاقد این مؤلفه‌های شناختی‌اند، کارایی و تأثیر دارند. در این زمینه، گوردون و آربوثنات^۲ (۱۹۸۷؛ به نقل از

^۱ . Geismar & Wood

^۲ . Gordon & Arbuthnot

دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶) معتقدند اگرچه توانش‌های شناختی برای دیدن مسائل و قضایا از دیدگاه دیگران در کاهش رفتار ضداجتماعی نقش بسزایی دارند، توانش‌های عاطفی نظیر توانایی همدلی و درک هیجان‌های افراد دیگر نیز اهمیت دارد. البته نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه بسیار متفاوت‌اند. بعضی از این تحقیقات نشان داده‌اند که شناخت - رفتار درمانگری انفرادی کارآمدترین شیوه برای کاهش تکرار جرم در بزهکاران است (گرت^۱؛ به نقل از دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶). در این باره، فراتحلیلی که وایت‌هد و لب (۱۹۸۹) روی مداخلات رفتاری انجام دادند، نشان داد که رفتاردرمانی نه تنها تأثیری در کاهش تکرار جرم ندارد، بلکه تأثیرات منفی نیز دارد.

برنامه‌های تحصیلی، شغلی و مهارت‌های زندگی

نتایج فراتحلیل گرت (۱۹۸۵)، نشان‌دهنده تأثیر مثبت برنامه‌های تحصیلی است. در یکی از این برنامه‌ها، برای تقویت دستیابی به اهداف تحصیلی، از شیوه‌های اصلاح رفتار استفاده شد. نوجوانان شرکت‌کننده در این برنامه هنگام انجام موفقیت‌آمیز مؤلفه‌ها و عناصر موجود در برنامه، با دریافت نمره تشویق می‌شدند. نوجوانان در آزمون‌های استاندارد سرعت بهبود یافتند و در مدت یک سال تکرار جرم در آنان کاهش پیدا کرد.

هدف برنامه‌های توسعه مهارت‌های شغلی، آموزش مسئولیت‌پذیری و دارا بودن هدف در زندگی به نوجوانان مجرم است. این برنامه‌ها به جوانان کمک می‌کنند تا با انجام و اتمام کارها و پروژه‌ها، احساس مسئولیت و کفایت کنند و اغلب با شرکت منظم نوجوان در مدرسه همراه می‌شوند. تأثیر و کارایی این برنامه‌ها در کاهش تکرار جرم هنوز مشخص نیست.

یک نوع متفاوت از برنامه‌های مهارت‌های زندگی، درمان با استفاده از تجربه هوای آزاد است. این برنامه شامل روش‌هایی نظیر برنامه‌های اردوهای طبیعی است. این برنامه‌ها از سختی‌ها، فشارهای طبیعی و موقعیت‌های طبیعی استفاده می‌کنند تا رشد و تحول و مشارکت گروهی را تشویق کنند. صاحب‌نظران معتقدند که برنامه‌های تجربه هوای آزاد تأثیر زیادی در کاهش تکرار جرم در نوجوانان مجرم دارند. هیچ ارزشیابی جامع و دقیقی از کارایی این برنامه‌ها صورت نگرفته است.

اگر بخواهیم به یک نتیجه‌گیری کلی در مورد پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه دست بزنیم باید بگوییم که تحقیقات انجام‌شده در مورد کارایی برنامه‌های درمانی همانند پژوهش‌های انجام‌شده در مورد روش‌های کارایی پیشگیری نشان می‌دهند که اگرچه این درمان‌ها میزان جرم و بزهکاری را کاهش می‌دهند، اما تأثیر آنها هنوز به سطح بهینه نرسیده است. به طور معمول رویکردهای شناختی -

^۱ . Garrett

رفتاری در مقایسه با سایر رویکردهای درمانی، در کاهش تکرار جرم کارایی بیشتری دارند. چه این درمان‌ها در موقعیت‌های مؤسسه‌ای و سازمانی به‌کار گرفته شوند و چه در موقعیت‌های اجتماع‌مدار، همگی ضعف‌های مشترکی دارند، از جمله اینکه برنامه درمانی نمی‌تواند تغییرات طولانی‌مدتی را در نوجوانان مجرم به‌وجود آورد، بویژه بعد از اتمام برنامه درمانی و این نشان‌دهنده نیاز به درمان‌های پیگیری و پس‌مراقبتی است. به‌نظر می‌رسد که طرح درمانی و قوت و انسجامی که این طرح درمانی هنگام اجرا دارد، مهم‌ترین عامل در تأثیر و کارایی آن است. هرچه طرح درمانی قوت و انسجام بیشتری داشته باشد، کارایی آن نیز بیشتر است.

خلاصه

بزهکاری در نوجوانان دامنه بسیار وسیعی دارد و شامل سرقت، دزدی، تجاوز جنسی، مصرف مواد، مشروب‌خواری و تخریب اموال عمومی است. بزهکاری خطرهای زیادی را برای فرد بزهکار و جامعه دربردارد و از یک طرف منجر به صرف هزینه‌های هنگفت برای دستگیری و زندانی کردن و نگاهداری نوجوانان بزهکار در مؤسسه‌هایی نظیر کانون‌های اصلاح و تربیت می‌شود و از طرفی، منجر به بروز آسیب‌ها و صدمات جدی جسمی و روانی در فرد بزهکار و سایر افراد جامعه می‌شود. اغلب میزان شیوع بزهکاری در پسران نوجوان بیشتر از دختران نوجوان و در مراکز شهری بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک است. عوامل مختلفی موجب رشد الگوهای رفتار بزهکارانه می‌شوند، از جمله عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و آموزشی. برای درمان بزهکاری از رویکردهای مدرسه‌مدار، اجتماع‌مدار و مؤسسه‌مدار استفاده می‌شود و روش‌های درمانی مطرح برای بزهکاری شامل درمان روان‌پویشی، رفتاری و شناختی رفتاری به‌صورت فردی، گروهی و خانوادگی است. به‌نظر می‌رسد شناخت - رفتار درمانی فردی مؤثرترین روش برای کاهش تکرار در نوجوانان باشد.

به‌منظور افزایش کارایی و تأثیر برنامه‌های پیشگیری و درمانی برای بزهکاران، باید به چند نکته توجه داشت:

۱. توسعه و اصلاح طرح‌های مربوط به راهبردهای درمانی و پیشگیری؛
۲. افزایش تناسب، دقت و جدیت در ارزشیابی این برنامه‌ها؛
۳. افزایش قوت، صحت و دقت در کاربرد این برنامه‌ها.

برنامه را می‌توان با تأکید بیشتر بر عوامل علی احتمالی مطرح‌شده در بخش پیشگیری و افزایش دوره زمانی و جدیت آن کارآمدتر کرد. این موضوع که تحقیقات انجام‌شده در مورد عوامل علی

ایجادکننده بزهکاری، مطابق با نتایج فراتحلیل‌های انجام‌شده روی مطالعات مربوط به کارایی و تأثیر پیشگیری و درمان بزهکاری است، بسیار امیدوارکننده است. نتایج فراتحلیل‌های انجام‌شده در مورد برنامه‌های درمانی، نشان داده‌اند که کارایی مداخله‌های بلندمدت، از جمله روش‌های درمانی ساختاریافته و متمرکز، بیشتر از رویکردهای مهارت‌مدار و رفتاری و درمان‌های چندوجهی است. تحقیقات انجام‌شده در مورد علل و ریشه‌های بزهکاری نشان‌دهنده اهمیت و نقش کمبودها و کاستی‌های موجود در مهارت‌های شناختی و رفتاری و چندعلیتی‌بودن بزهکاری است. ارزشیابی‌های صورت‌گرفته از برنامه‌های پیشگیری با استفاده از بهبود و اصلاح کمبودهای موجود در مهارت‌های شناختی و رفتاری نشان داده‌اند که این رویکردها در میان روش‌های مختلف، متقاعدکننده‌ترین و در موقعیت‌های مختلفی نظیر خانواده، مدرسه و تسهیلات شبانه‌روزی، کاربرد بیشتری دارند.

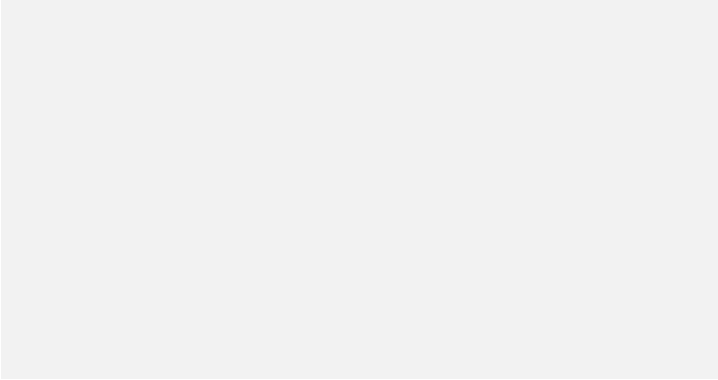
برنامه‌های تکمیلی نیز باید برای از بین بردن علل بزهکاری طراحی و خدمات ممتد و مداومی برای حل مشکلات مرتبط با علل بزهکاری ارائه شود. چنین برنامه‌هایی باید شامل مؤلفه برنامه‌ریزی مبتنی بر مدرسه با هدف آموزش مهارت‌های شناختی خودمدیریتی، مؤلفه جو حاکم بر مدرسه با هدف افزایش وضوح و میزان همگونی قوانین و مقررات مدرسه و مؤلفه مهارت‌های والدینی با هدف افزایش نظارت و کنترل و ارائه نظم و انضباط توسط والدین باشد.

متأسفانه برنامه‌های موجود برای پیشگیری و درمان بزهکاری کوتاه‌مدت بوده و چندبُعدی نیستند. شاید ضروری‌ترین کار برای توسعه و اصلاح کارایی برنامه‌های پیشگیری و درمان بزهکاری، مربوط به قوت، دقت و جدیت در به‌کارگیری فعالیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی است. ایده‌آل‌ترین طرح‌های درمانی و پیشگیری نیز در اجرای تمام مراحل شکست می‌خورند و به‌طور ناقص انجام می‌شوند.

مشکل کیفیت ضعیف اجرای برنامه‌های طراحی‌شده، بیشتر مربوط به فرهنگ سازمانی و سازمان‌های مجری این طرح‌هاست. برای مثال روحیه و اخلاقیات معلمان، مشارکت اجرایی آنان و روابط موجود در مدرسه، از جمله فرهنگ‌های تأثیرگذار در برنامه‌های مدرسه‌مدارند. در واقع، در مدارس به وجود ساختارهای تصمیم‌گیری نیاز داریم که درگیری معلم را در برنامه‌ریزی‌ها و اقدام برای حل مشکل افزایش دهند و قواعد واضح آموزشی وضع کنند، ساختارهای کاملاً روشن پاداش‌دهی داشته باشند و نقش‌ها را به‌طور واضحی تعریف کنند.

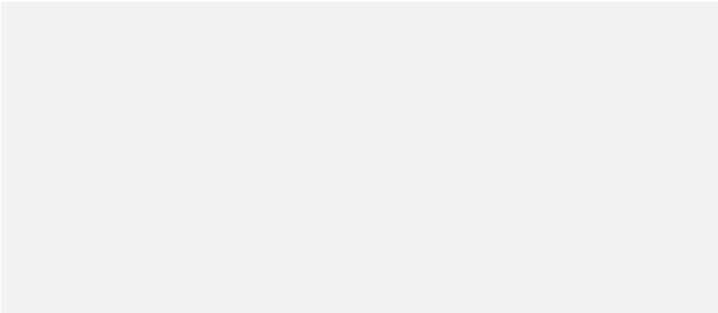
پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

- ۱) به نظر شما فقر به عنوان یکی از همبسته‌های مهم بزهکاری چگونه بر شکل‌گیری و تداوم رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان تأثیر می‌گذارد؟
- ۲) نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری چیست؟



فصل هشتم

خسونت در نوجوانان



امروزه بحث‌های مربوط به خشونت بسیار ذهن ما را به خود مشغول کرده است، داغ‌ترین بحث روزنامه‌ها، تلویزیون و گفت‌وگوهای روزمره‌ای که با یکدیگر داریم، درباره خشونت‌هایی است که در جامعه صورت می‌گیرد، اما چرا؟ اگرچه خشونت مشکل بیشتر جوامع صنعتی و توسعه‌یافته است، اما از آنجا که خشونت انواع و اقسام زیادی دارد، ارائه تعریف دقیقی از آن مشکل است. در این فصل، خشونت به عنوان اقدام رفتاری تعریف می‌شود که منجر به بروز صدمات و آسیب‌های جسمانی کم و بیش شدیدی می‌گردد. اگرچه بیشتر رفتارهای خشونت‌بار منجر به بروز صدمات نسبتاً جزئی‌ای می‌شوند، اما اختلالات و ناتوانی‌های طولانی‌مدت و مرگ و میر نیز از پیامدهای فراوان آن به‌شمار می‌روند. در واقع، بیماری‌های عفونی و خشونت، دو علت مهم مرگ و میرند که بارها در تاریخ بشر به آنها اشاره شده است.

خودکشی و قتل که دو عامل مهم از پنج عامل اصلی مرگ و میر در جهان به‌شمار می‌آیند، اعمال خشونت‌بار هستند، به‌طوری‌که این دو نوع خشونت علت اصلی مرگ نوجوانان دختر بویژه دختران سیاه‌پوست است. شواهد نشان می‌دهند که این خشونت‌ها در آمریکا بیش از سایر کشورهای توسعه‌یافته است.

قبل از بحث در مورد خشونت نوجوانان در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، مرور مختصری بر مطالبی که در این فصل ارائه خواهد شد، خواهیم داشت. ما به پیامدهای جدی خشونت از جمله قتل و جرایم خشونت‌بار دیگر آگاهی داریم؛ پیامدهایی نظیر تجاوز جنسی توأم با خشونت، ضرب و شتم، سرقت، قتل عام و قتل عمد (ایرلز، کایرنز و مرسی^۱، ۲۰۰۳).

تجارب نشان می‌دهند گروه‌هایی که بیشتر در معرض خطر درگیری در خشونت و قربانی مشکلات ناشی از آن شدن قرار دارند، یا متعلق به جایگاه اجتماعی - اقتصادی پایین‌اند یا در شهرهای بزرگ و مرکز کشورها ساکن‌اند یا به گروه‌های اقلیت یا جنس مذکر تعلق دارند.

مصرف افراطی الکل، حتی بیش از سایر داروها و مواد غیرمجاز و غیرقانونی، از همبسته‌های خشونت است. به‌علاوه حمل اسلحه‌های کمری مثل تپانچه و هفت‌تیر نقش زیادی در افزایش شدت

^۱ . Earls, Cairns & Mercy

صدمات ناشی از خشونت دارد. با این حال، بسیاری از مسائل را در مورد خشونت نمی‌دانیم؛ مسائلی نظیر اینکه خانواده‌های امروزی از نظر ساختار و کارکرد چه تغییری پیدا کرده‌اند؟ وضعیت سازمان‌های اجتماعی و محلات مختلف شهرها چگونه است؟ طی قرون و اعصار گذشته چگونه نژادگرایی با فرهنگ خاصی ترکیب شده و منجر به بروز سطوح بالایی از خشونت شده است؟ مشاهده خشونت در رسانه‌های گروهی نظیر تلویزیون، چقدر در بروز رفتارهای خشونت‌بار سهم است؟ و اینکه چگونه می‌توان از خشونت پیشگیری کرد و آن را کاهش داد؟

خشونت موضوع مهمی در نزد دولتمردان است. به دلیل افزایش خشونت در مراکز کنترل و پیشگیری از اختلالات، در دهه قبل برنامه‌هایی برای مطالعه همه‌گیرشناسی خشونت شروع شده که هم‌اکنون به عنوان یک واحد اجرایی علمی رشد لازم را پیدا کرده است. یکی از ارکان مهم این برنامه‌ها، طراحی مداخله‌هایی برای کنترل میزان خشونت در بافت‌های اجتماعی مختلف است.

خشونت را نمی‌توان فقط به عنوان رفتار مشکل‌آفرین فردی یا مشکل اجتماعی در نظر گرفت. خشونت مرتبط با کل جامعه و ساختار اقتصادی آن، جامعه خاص نوجوانان و محیط‌های خانوادگی آنان و سلامت روانی خاص آنان است. برای مثال، حادثه خشونت‌بار پاکدشت را در نظر بگیرید، (در این حادثه که در سال ۱۳۸۴ رخ داد جوانی به نام بیجه پس از دزدیدن کودکان و تجاوز به آن‌ها، آنان را به طرز فجیعی به قتل می‌رساند، از جمله این که جسد آنان را در کوره‌های آجرپزی می‌انداخت تا آثاری از آنان باقی نماند). این حادثه فقط ناشی از عدم سلامت روانی عاملان آن نبود، بلکه بافت اجتماعی و حتی موقعیت فیزیکی - جغرافیایی منطقه‌ای که این حادثه تکان‌دهنده در آن رخ داد نیز در وقوع این حادثه خشونت‌آفرین نقش داشت. از این رو با صراحت می‌توان نتیجه گرفت که پیشگیری یا مداخله نمی‌تواند فقط در سطح اصلاح رفتار افراد صورت گیرد، بلکه باید در جهت حل مسائل گسترده‌تر اجتماعی باشد.

در این فصل به بررسی موضوعاتی نظیر شناخت خشونت و اقدام‌های لازم برای پیشگیری از آن می‌پردازیم. دانش ما درباره خشونت بسیار وسیع است. داده‌های مربوط به همه‌گیرشناسی خشونت به ما کمک می‌کند تا هم نوجوانان و هم سایر اقشار جامعه را که در معرض خطر رفتارهای خشونت‌بار قرار دارند، تشخیص دهیم. این کار را می‌توان با درک جامعه و رفتارهای مشکل‌آفرین نوجوانان آن جامعه به صورت یک کل انجام داد. در واقع، قدرت ما تحت تأثیر میزان دانش و شناخت ما از خشونت قرار دارد و ضعف ما مربوط به نظریه‌هایی است که به عنوان پلی بین دانش و عمل ماست. فقدان نظریه‌های سنجیده در مورد علت خشونت، با افزایش مداخله‌های پیشگیرانه رابطه دارد. اگرچه بعضی از نظریه‌های موجود تا حدودی علت خشونت را بررسی کرده‌اند، اما بسیاری از آنها در

تبیین علت دامنه وسیع متغیرهای سهم در خشونت و روابط متقابلی که بین این متغیرها وجود دارد، ناتواناند.

در این زمینه با دو مشکل مواجه‌ایم؛ اول اینکه نظریه‌هایی که بر مؤلفه‌های فردی خشونت تأکید می‌کنند، منجر به بروز مداخله‌هایی می‌شوند که علل مهم محیطی را نادیده می‌گیرند، در نتیجه برای بیشتر افراد جامعه که در معرض خطر خشونت قرار دارند، نامناسب‌اند، زیرا نقش محیط را در نظر نگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را به روشنی تعریف نکرده‌اند.

باوجود شکافی که بین دانش و عمل ما وجود دارد، در این فصل سعی شده اطلاعات خوبی دربارهٔ هنر پیشگیری و درمان رفتارهای خشونت‌بار در اختیار خوانندگان قرار گیرد. متأسفانه مداخله‌های موجود دچار فروپاشی شده‌اند، زیرا بیشتر مداخله‌ها با نظریه‌ها مرتبط نیستند و اغلب بر مجازات، تنبیه و جدا کردن افراد از جامعه تأکید دارند.

هنگام به‌کارگیری درمان، بهتر است بر یک رویکرد رفتاری ظریف تأکید کرد که هم فرد، هم رفتار و هم محیط را هدف قرار می‌دهد.

در راستای افزایش روزافزون میزان خشونت در جوامع، هم دست‌اندرکاران جامعه و هم متخصصان و دست‌اندرکاران حوزه سلامت، برای مداخله در خشونت جوانان بسیج شده‌اند. این بسیج عمومی در حوزه سلامتی، پزشکی، تعلیم و تربیت و مذهب و رسانه‌های گروهی انعکاس پیدا کرده است. از این رو تأکید زیادی بر ترویج و توسعه مداخله‌های پیشگیرانه می‌شود.

همه‌گیرشناسی خشونت

داده‌های مربوط به خشونت، با اهداف مختلفی شامل علل همه‌گیرشناختی، مراقبت‌های بهداشتی عمومی، تشخیص گروه‌های در معرض خطر و خطرآفرین و تشخیص عوامل خطرآفرین، جمع‌آوری می‌شوند (روزنبرگ و فنلی^۱، ۲۰۰۱).

اگرچه داده‌های جمع‌آوری‌شده و سیستم‌های نظارتی و مراقبتی اطلاعاتی را دربارهٔ خشونت و مرگ‌های خشونت‌بار فراهم کرده‌اند، اما تمام این سیستم‌های مراقبتی مشکلات مشترکی دارند. خشونت گزارش‌شده با میزان رخداد واقعی آن بسیار تفاوت دارد. برای مثال، ممکن است تعداد تجاوزهای جنسی توأم با خشونت که گزارش می‌شوند، تا حد زیادی به بافت اجتماعی - تاریخی که این خشونت‌ها در آن رخ می‌دهند، وابسته باشد و این بافت نیز احتمالاً با تعریفی که از تجاوز جنسی صورت می‌گیرد، مرتبط است (برای مثال تعریف شامل تجاوزهای جنسی به غریبه‌ها یا افراد آشنا

^۱ . Rosenberg & Fenley

باشد). داده‌های مربوط به خشونت و مرگ‌های خشونت‌بار ممکن است غیردقیق باشند، زیرا این داده‌ها تا حد زیادی به سیاست‌های حاکم بر جامعه وابسته‌اند. در بسیاری از کشورها، مرگ‌های خشونت‌بار و فجیع مرتبط با تصمیمات سیاسی و گاهی بدون سوابق پزشکی و دارویی‌اند (ایرلز و همکاران، ۱۹۸۹). از طرفی، اطلاعات و داده‌های ملی تا حدودی می‌توانند گمراه‌کننده باشند و علت آن مربوط به روش‌های متفاوت گزارش‌دهی است. برای مثال، در آمریکا داده‌های ملی در مورد نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۹۸۰ و داده‌های ملی در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله و جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله در سال ۱۹۹۰، به‌طور جداگانه گزارش شدند. این داده‌ها نشان می‌دهند که تعداد قتل‌ها در پسران سفیدپوست بیشتر از دختران سفیدپوست و در پسران سیاه‌پوست دو برابر پسران سفیدپوست است. همچنین تعداد قتل‌ها در پسران سیاه‌پوست دو برابر دختران سیاه‌پوست و در دختران سیاه‌پوست دو برابر این تعداد در دختران سفیدپوست است.

تغییر در نرخ خشونت در آمریکا تنها موضوع مهم نیست، بلکه موضوع مهم این است که نرخ خشونت در آمریکا نسبت به سایر کشورها چگونه است. واقعیت این است که نرخ قتل در میان نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله آمریکایی، بیش از نرخ قتل در ۲۱ کشور توسعه‌یافته دیگر جهان است (پروترو - استیث^۱، ۲۰۰۳).

داده‌های ملی در مورد نرخ مرگ و میر نوجوانان، فقط منبع کسب اطلاعات در مورد خشونت در نوجوانان نیست، آنچه نوجوانان خودشان درباره رفتارهای خشونت‌آفرین می‌گویند نیز بسیار مفید است. در سال ۱۹۸۴، محققان و صاحب‌نظران این حوزه گروهی متشکل از ۲۷۸۷ جوان را که در محلات فقیرنشین به کلینیک‌های روانی عمومی رجوع کرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه در اصل برای ارزشیابی کلینیک‌های ده شهر طراحی شده بود. در این برنامه‌ها تعداد زیادی از نوجوانان برای مصاحبه‌های رو در رو در سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۴ و ۱۹۸۷-۱۹۸۶ انتخاب شدند. ۷۰ درصد نوجوانان مورد مصاحبه غیرسفیدپوست و دختر بودند. میانگین سن آنها در سال ۱۹۸۴ برابر با ۱۶ سال و ۲ ماه بود و در دامنه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال قرار داشتند.

مصاحبه‌ها درباره چند حوزه روان‌شناختی بود، از جمله موضوعات جمعیت‌شناختی، نشانگان سلامت روانی و جسمانی، مشکلات رفتاری، رفتارهای جرم‌آفرین، ساختار خانوادگی و پویایی‌های خانوادگی، رفتارهای جنسی و مصرف مواد. بدین ترتیب اطلاعات زیادی در مورد اعمال خشونت‌آمیزی که نوجوانان مرتکب شده بودند و اعمال خشونت‌آمیزی که در مورد آنها اعمال شده بود، به‌دست آمد. در این تحقیق عمل خشونت‌آمیز به‌عنوان عملی تعریف شد که همراه با درگیری

^۱. Prothrow - Stith

فیزیکی و جسمانی، صدمه، کتک‌کاری و تلاش برای صدمه رساندن به شخص دیگر یا حیوانات است.

درصد زیادی از نوجوانان گزارش کردند که در دوره نوجوانی خود یک عمل خشونت‌آمیز انجام داده‌اند. در نمونه مورد مطالعه، بیش از ۸۵ درصد پسران (هم سفیدپوست و هم سیاه‌پوست) گزارش کردند که دست به عمل خشونت‌آمیز زده‌اند.

تشخیص عوامل خطر آفرین

یکی از اهداف جمع‌آوری داده‌های همه‌گیرشناسی در مورد خشونت، تشخیص علل و عواملی است که فرد را در معرض خطر درگیر شدن در رفتار خشونت‌بار قرار می‌دهند. دانش ما در این زمینه بسیار غنی است و کمک می‌کند تا همبسته‌های خشونت بویژه در مورد قتل شناسایی شود.

نژاد و جایگاه اجتماعی - اقتصادی

تشخیص تفاوت‌های اجتماعی از نظر میزان خشونت در جایگاه‌های اجتماعی - اقتصادی مختلف و نژادهای گوناگون، کار مشکلی است. شواهد نشان می‌دهند که وضعیت اجتماعی - اقتصادی و نژادی (اقلیتی)، نقش مهمی در خشونت دارند. افراد متعلق به گروه‌های اقلیت، بیشتر در معرض خطر مرگ و صدمات ناشی از رفتارهای خشونت‌بار قرار دارند (گزارش‌های بهداشت عمومی^۱، a ۱۹۹۱).

نژادپرستی و فقر که خود دو شکل از خشونت‌های اجتماعی‌اند، از جمله عوامل مهم و مؤثر در خشونت افراد شناخته شده‌اند. شاید به این دلیل که فقر به معنای تعلق به گروه‌های اقلیت است و گروه‌های اقلیت به اندازه گروه‌های دیگر به تشکیلات قضایی و جرم‌شناسی دسترسی ندارند، فاقد تعلیم و تربیت و آموزش مناسب و سیستم‌های مراقبت بهداشتی‌اند و ممکن است از نظر اقتصادی و اجتماعی وضعیت خوبی نداشته باشند (گزارش‌های بهداشت عمومی، b ۱۹۹۱).

نژاد و وضعیت اجتماعی - اقتصادی، هم با خشونت‌هایی که منجر به قتل می‌شوند و هم با سایر خشونت‌هایی که منجر به مرگ نمی‌شوند و نیز با خودکشی رابطه دارند. در واقع، گزارش‌های سری بهداشتی ملی در مورد سلامت سیاه‌پوست‌ها و گروه‌های اقلیت در آمریکا، نشان می‌دهند که خیلی از قربانی‌های قتل و آدم‌کشی‌ها قبلاً خودشان دست به سایر خشونت‌های جدی زده‌اند (سیلورمن^۱ و همکاران، ۲۰۰۴).

^۱ . public health reports

^۱ . Silverman

اجتماع

شواهد نشان می‌دهد جامعه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند، نقش بسیار مهمی در خطر اقدام به رفتارهای خشونت‌بار دارد. جالب است که بدانید نوعی تفاوت جغرافیایی در میزان ارتکاب به قتل در نوجوانان وجود دارد. در پنج ایالت آمریکا میزان قتل و آدم‌کشی توسط نوجوانان پسر سیاه‌پوست برابر با ۱۰۰ نفر در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر است. این پنج شهر به اضافه شهر واشنگتن بیش از نیمی از قتل‌ها را در پسران ۱۵ تا ۲۴ ساله آمریکایی به خود اختصاص می‌دهند (راپر^۱، ۱۹۹۱).

باید بدانیم که این تفاوت‌ها مربوط به مشخصه‌های اجتماعی - محله‌ای است که تأثیر بسزایی در مشارکت در جرم و بزهکاری دارند.

تفاوت‌های اجتماعی از نظر میزان خشونت احتمالاً به بافت اجتماعی بزرگ‌تری وابسته‌اند که خشونت در آن رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد رفتارهای خشونت‌آمیز با دامنه‌ای از عوامل اقتصادی، محیطی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و پرورشی و رفتاری رابطه داشته باشند (بلونی^۲ و همکاران، ۱۹۹۱). از جمله مسائل اجتماعی مرتبط با خشونت، می‌توان به باندهای تبهکاری، بیکاری و اشتغال ناقص و کاذب، دسترسی به داروها و مواد غیرقانونی و دسترسی به اسلحه‌های پیچیده در جامعه اشاره کرد (ایرلز، ۱۹۹۱ b). برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با خشونت مربوط به توزیع درآمد و منابع است. همچنین ممکن است خشونت و درگیری در جامعه در درون خانواده‌ها و بین خانواده‌ها، در درون گروه‌های کوچک و بین گروه‌های کوچک رخ دهد. به علاوه، میزان تحمل رفتارهای خشونت‌آمیز ممکن است چنین خشونت‌هایی را تشویق کند.

خانواده

محیط خانوادگی، نقش مهمی در اقدام به قتل توسط نوجوانان دارد. به نظر می‌رسد نوجوانانی که دست به قتل می‌زنند، پرخاشگری را در دوران کودکی خود و با زندگی در خانواده‌هایی که در جرم‌های خشونت‌بار درگیر می‌شوند و تجربه کودک‌آزاری دارند، یاد می‌گیرند (زاگر^۳ و همکاران، ۲۰۰۲). مطالعه‌ای که در مورد محکومان به قتل انجام گرفته، نشان می‌دهد دو سوم آنها در کودکی خود خشونت‌های فجیع، مداوم و بی‌رحمانه‌ای را تجربه کرده‌اند (ماسن^۱، ۱۹۹۱). از این رو تصور

^۱. Roper

^۲. Belloni

^۳. Zagar

^۱. Mason

می‌شود رفتارهای خشونت‌آمیز ریشه در آزار و اذیت جسمی و فیزیکی، مشاهده خشونت در خانواده و جامعه در دوران اولیه کودکی داشته باشد.

دست‌رسی به اسلحه

مطالعه ادبیات موجود درباره ارتکاب جرم و خشونت، نشان می‌دهد که علت افزایش میزان قتل و آدم‌کشی بویژه در پسران نوجوان سیاه‌پوست، مربوط به دست‌رسی به اسلحه گرم است (کوک^۱ و همکاران، ۲۰۰۱). برای نشان‌دادن وخامت مشکل، بد نیست بدانید در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، تعداد افرادی که در آمریکا در اثر صدمات ناشی از شلیک با اسلحه‌های گرم به قتل رسیده و جان خود را از دست داده‌اند، بیشتر از افرادی است که در جنگ ویتنام که بیشتر از ۸ سال طول کشید، کشته شدند (روزنبرگ و فنلی، ۲۰۰۱). با وجود این، بسیار مشکل است که بتوان رابطه بین اسلحه گرم و قتل را به‌طور دقیق نشان داد. نتایج بعضی مطالعات نشان می‌دهند که ممنوع کردن حمل اسلحه‌های کمری با میزان قتل ارتباطی ندارد، اما با میزان خودکشی رابطه دارد، نتایج بعضی پژوهش‌ها هم نشان می‌دهند که داشتن اسلحه‌های شخصی با میزان قتل رابطه زیادی دارد (لستر^۲، ۱۹۸۸).

جالب است بدانید اگر نوجوانان و جوانان نشانه‌های مشکلات روحی و روانی نظیر افسردگی، اقدام به خودکشی، سوء‌مصرف مواد و نشانگان تنیدگی پس‌ضربه‌ای را تجربه کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که با دیگران با خشونت رفتار کنند.

نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند که وجود عوامل مذکور در محیط زندگی نوجوانان، در میزان خشونت آنان نقش دارد (ریس و راث^۳، ۱۹۹۳). شرایط اولیه خانوادگی و مشکلات سلامت روانی، به‌طور معناداری با اقدام‌های خشونت‌آمیز در دوره نوجوانی رابطه دارد. اطلاعات جدول ۸-۱، نشان می‌دهد که بدون توجه به نژاد و جنسیت پرورش‌یافتن کودکان در موقعیت‌های خانوادگی ازهم‌پاشیده (طلاق یا جدایی والدین یا مرگ زودهنگام والدین)، مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرارگرفتن در دوران کودکی و ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری‌های حاد روانی، احتمال خشونت‌طلبی را در نوجوانان افزایش می‌دهد.

تنیدگی‌ها و استرس‌های مزمن و ثابت و داشتن تجارب و وقایع آسیب‌زا (نظیر دیدن مرگ سایر افراد)، با اقدام به خشونت رابطه دارد. رفتار خشونت‌بار نیز با قتل‌های عمدی که در محل زندگی افراد رخ می‌دهد و میزان بیکاری در محله و منطقه زندگی رابطه دارد (روزنبرگ و فنلی، ۲۰۰۱).

^۱. Cook

^۲. Lester

^۳. Reiss & Roth

جدول ۸-۱. خشونت‌های انجام‌شده توسط نوجوانان محله‌های فقیرنشین. همبسته‌های شخصی و محیطی به‌دست آمده از رگرسیون خطی با کنترل تفاوت‌های نژادی و جنسی

متغیر	فراوانی (f)	مجدور همبستگی (r^2)
همبسته‌های شخصی		
نشانگان افسردگی	۱۱۳/۴	۰/۰۴
نشانگان خودکشی	۹۳	۰/۰۳
نشانگان سوءمصرف مواد	۱۹۲/۷	۰/۰۶
نشانگان تنیدگی پس‌ضربی	۵۹/۸	۰/۰۳
همبسته‌های محیطی		
بیماری‌های روانی خانوادگی	۵۶/۳	۰/۰۲
عدم ثبات خانوادگی	۴/۵	۰/۰۰۱
کودک‌آزاری	۲۸	۰/۰۴
وقایع آسیب‌زا	۷۷/۲	۰/۰۲
وقایع تنش‌زا	۱۶۹/۲	۰/۰۵
قتل یکی از همسایه‌ها	۲۵/۲	۰/۰۱
میزان بیکاری	۲۱/۴	۰/۰۱

منبع: برگرفته از دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶

عوامل خطرآفرین

عوامل خطرآفرین ممکن است هم علت خشونت و هم معلول آن باشند. در مورد علل خشونت، اظهارنظرهای زیادی شده است. بعضی اعتقاد دارند که رفتار خشونت‌آمیز غریزی و تمایل به خشونت ذاتی است (دیلالا و گاتزمن^۱، ۲۰۰۳)، بعضی هم سخت مخالف این اعتقادند و به نقش عوامل بیولوژیکی در بروز خشونت اعتقاد دارند (مندیک، برنان و کندل^۲، ۱۹۸۸). اگرچه عوامل زیادی در اقدام به رفتارهای خشونت‌آمیز سهیم‌اند، اما جداسازی نقش نسبی عوامل خطرآفرین بیولوژیکی، روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی، بسیار مشکل است. این موضوع که رفتارهای پرخاشگرانه در طول دوران زندگی چگونه رشد و تحول می‌یابند، و خشونت چگونه از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد، هنوز مشخص نیست (ایرلز، ۱۹۹۱ a).

^۱ . Dilalla & Gottesman

^۲ . Mendick, Brennan & Kandel

براساس ادبیات تحقیق، در هر برنامه‌ریزی‌ای که برای مداخله به‌منظور کاهش خشونت صورت می‌گیرد، باید عوامل زیر را مدنظر قرار داد: اول اینکه باید به تفاوت‌های فردی توجه کرد. ممکن است این تفاوت‌ها از همان ابتدا و آغاز تولد وجود داشته باشند. با این حال، به‌نظر می‌رسد که ویژگی‌های بیولوژیکی (زیست‌شناختی) و روان‌شناختی ریشه این مشکل‌اند و هنگام طراحی مداخله‌های درمانی به دست فراموشی سپرده می‌شوند (ایرلز و تانری^۱، ۱۹۸۹).

یکی از حوزه‌هایی که رابطه تنگاتنگی با خشونت دارد و عامل مهم و بالقوه مداخله به‌شمار می‌رود، رفتارها و اعمال والدینی ضعیف است، اعمالی نظیر الگودهی رفتار خشونت‌آمیز، رفتارهای انضباطی تنبیه‌کننده و کودک‌آزاری. یافته‌ها نشان می‌دهند نوجوانانی که درگیر خشونت و بزهکاری می‌شوند، مشکلاتی را در مدرسه داشته‌اند که نشان‌دهنده تأثیر عوامل موجود در مدرسه و نقش علی این رفتارها در خشونت است که باید هنگام به‌کارگیری مداخلات درمانی به آنها توجه شود. با وجود این، نمی‌توان گفت که تجارب ضعیف تحصیلی و شکست تحصیلی تنها علت لازم و کافی خشونت است (ایرلز و تانری، ۱۹۸۹). احتمالاً هم مشکلات تحصیلی و هم خشونت، نشانه‌ای از مشکلات ریشه‌ای‌تر می‌باشند. در ادبیات مربوط به خشونت، به نقش همسالان و ارتباطی که با خشونت دارد، تأکید شده است. نوجوانانی که دست به رفتارهای خشونت‌بار می‌زنند، به احتمال زیاد متعلق به جوامع خشن و خشونت‌طلب‌اند، با نوجوانان خشونت‌طلب ارتباط بیشتری دارند و عضو گروه‌ها و باندهای تبهکارند (ایرلز، کایرنز و مرسی، ۲۰۰۳).

درک علل خشونت، مستلزم آگاهی از تفاوت موجود بین آن دسته از نوجوانانی است که گاهی دست به رفتارهای فجیع و خشونت‌بار می‌زنند و پس از مدتی از این کار دست می‌کشند و آن دسته از نوجوانانی که شغل آنها جرم‌آفرین است، با خشونت ممتد و مکرر مشخص می‌شوند. البته الگوهای شغلی و حرفه‌های جرم‌آفرین، هنوز مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته‌اند. از این‌رو هنوز راهی برای پیش‌بینی میزان خطرناک بودن فرد ویژه‌ای وجود ندارد. درنهایت اینکه، اگرچه ممکن است اجتماع تأثیر بسیار زیادی روی فرد داشته باشد، اما هنوز مشخص نیست که چگونه اجتماع همراه با دنیاهای دیگر شخصی افراد در شکل‌گیری خشونت نقش خواهد داشت. به‌همین دلیل، تا مشخص نشدن این مسئله، نمی‌توان هیچ مداخله پیشگیرانه‌ای را طراحی کرد و به‌کار گرفت.

^۱. Tonry

نظریه‌های عوامل خطر آفرین

نظریه‌های قابل کاربرد فعلی برای رفتار خشونت‌آمیز، اغلب همان نظریه‌های رفتار ضداجتماعی یا رفتار خطر آفرین‌اند. این نظریه‌ها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: نظریه‌هایی که بر شخص و انگیزش شخصی تأکید دارند، نظریه‌هایی که هم بر بعد فردی و هم بعد محیطی تأکید دارند و نظریه‌هایی که بر محیط و کنترل محیطی تأکید دارند. بعضی از نظریه‌هایی که بر شخص تأکید دارند، معتقدند خشونت و جرم‌آفرینی نتیجه تأثیر متقابل آمال و آرزوهای افراد و انتظارات کم آنهاست (اوتینگ و بیوویس^۱، ۱۹۸۷). با وجود این، بعضی هم بر ابعاد ژنتیکی، بیولوژیکی و شیمیایی رفتار خشونت‌آمیز تأکید می‌کنند (دیلالا و گاتزمن، ۲۰۰۳).

رویکردهای محیطی بر نقش شرایط یا فرایندهای اجتماعی که کنترل‌های رسمی و غیررسمی اجتماعی را تضعیف می‌کنند، تأکید دارند (جانیس و من^۲، ۱۹۷۷). جسور و جسور (۱۹۷۷)، شکست نظام قراردادهای متعارف در خانواده، مدرسه و اجتماع را عامل مؤثری در شکل‌گیری رفتارهای خشونت‌بار می‌دانند. بعضی نظریه‌پردازان هم معتقدند که خشونت و جرم‌آفرینی راهبردهایی برای حفظ و بقای افراد محروم طبقات پایین جامعه‌اند (لایبو^۳، ۱۹۶۷). بعضی هم به نقش محیط اجتماعی مقاوم و شکیب و قابلیت دستیابی به الگوهای رفتاری منحرف اعتقاد دارند (دمبو^۴ و همکاران، ۱۹۸۶). گارتنر^۵ (۱۹۹۰)، در نظریه اختلال و بی‌سازمانی بر اختلال‌ها و بی‌نظمی‌های حاکم بر محلات جرم‌آفرین تأکید می‌کند.

بعضی از رویکردها بر شخص و محیط تأکید می‌کنند. براساس نظریه شناختی اجتماعی، تعیین‌کننده‌های شخصی نظیر عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیکی همراه با عوامل محیطی تعیین‌کننده‌هایی هستند که بر تمام کنش‌های فرد تأثیر می‌گذارند و منجر به شکل‌گیری رفتارهای خشونت‌بار می‌شوند. به عبارت دیگر، فرد، محیط و رفتار، در تعامل متقابل با یکدیگرند (بندورا^۶، ۱۹۸۶). با این حال، بندورا اعتقاد دارد که تأکید اصلی بر شخص و شناخت‌های اوست.

نظریه و الگوی فرهنگی اجتماعی (رودریکس و زایاس^۷، ۱۹۹۱)، بر نقش عواملی نظیر مفهوم خود، قراردادها و تعهدات، محیط ضد اجتماعی، محرومیت و فرهنگ‌پذیری تأکید دارد. بر این

^۱. Oetting & Beauvais

^۲. Janis & Mann

^۳. Liebow

^۴. Dembo

^۵. Gartner

^۶. Bandura

^۷. Rodriguez & Zayas

اساس، با اینکه در این نظریه به مهارت‌ها و انگیزش فرد توجهی نشده، ولی برای گروه‌های اقلیت و مهاجران قابل کاربرد است.

رویکرد و الگوی فرصت بر شخص از بعد انگیزشی و بر محیط از بعد کنترل‌هایی که اعمال می‌کند و بر فرصت‌هایی که موجب بروز فعالیت‌های خشونت‌آمیز می‌گردد، تأکید می‌کند (فیلا و لافری^۱، ۱۹۸۸). در این الگو، محرومیت، درآمد کم، تبعیض و محیطی که سطح تحمل بالایی برای خشونت دارد، منجر به بروز مشکلات شخصی نظیر تعهد کمتر، ایجاد انحرافات قوی‌تر و تضاد بیشتر بین آمال و آرزوها و انتظارات فرد می‌گردد. بدین ترتیب ترکیبی از محرومیت و تحمل، مدل علی را برای رشد و توسعه رفتار خشونت‌آمیز ایجاد می‌کند.

رویکرد شخص و محیط، الگوی تحولی را (ایرلز، ۱۹۹۱ b) به الگوهای مذکور اضافه می‌کند. در این الگو، بر وجود زنجیره‌ای از وقایع و تجاربی که احتمالاً در دوره پیش از تولد شروع می‌شوند و تا دهه دوم زندگی ادامه می‌یابند و بر روی هم انباشته می‌شوند، تأکید می‌شود. این نظریه علاوه بر تأکید بر عواملی که سایر نظریه‌ها مطرح می‌کنند، بر نقش عوامل زیست‌شناختی نظیر خلق و خو نیز تأکید دارد.

بعضی از این زنجیره‌های وقایع و تجارب با نظریه‌هایی که بر نقش محیط تأکید دارند، همپوشی دارند (نظیر انگیزش اجتماعی، کنترل اجتماعی و فرصت‌های اجتماعی). مدل تحولی سعی دارد از اصول نظریه‌هایی نظیر نظریه دلبستگی، نظریه خلق و خو، نظریه کنترل اجتماعی، نظریه شبکه‌ای و نظریه اختلالات اجتماعی نیز استفاده کند. رویکرد تحولی، تلاش دارد رفتارهای خشونت‌آمیز را به صورت تعامل بین فرد و جامعه تبیین کند. با وجود این، رویکرد تحولی به قدری جامع، فراگیر و گسترده است که در معرض این خطر قرار دارد که نتوان به آن عمل کرد یا آن را مورد مطالعه قرار داد.

پیشگیری

به هنگام بحث در مورد پیشگیری، بر یکی از دو سطح زیر تأکید می‌شود؛ پیشگیری اولیه و پیشگیری ثانویه. پیشگیری اولیه به منظور جلوگیری از شروع مشکلات خاص طرح‌ریزی می‌شود (OTA^۲، ۱۹۹۱). این پیشگیری شامل درک علل اختلال و توانایی تغییر و اصلاح آن است. درحالی‌که

^۱ . Fiala & Lafree

^۲ Office of Technology Assessment (OTA)

پیشگیری ثانویه به منظور جلوگیری از ازدیاد، رشد و توسعه مشکل و کاهش آن یا پیشگیری از عودت مشکل، صورت می‌گیرد.

تعداد برنامه‌های موفق که با استفاده از دانش موجود درباره علل و همبسته‌های خشونت به منظور مداخله روی خشونت طراحی شده‌اند، بسیار اندک است (ویلسون - بریور^۱ و همکاران، ۱۹۹۱). از طرفی، بیشتر برنامه‌های پیشگیرانه از نظر میزان تأثیرشان بر کاهش خشونت مورد ارزشیابی قرار نگرفته‌اند. از این رو به جای طراحی برنامه‌های پیشگیرانه خاص، باید به مطالعه و تحقیق درباره پیشگیری از خشونت پردازیم. در این زمینه مرکز کنترل اختلالات خدمات سلامت عمومی و مرکز سلامت اقلیت‌ها در آمریکا، اقدام به برقراری همایش نوجوانان، خشونت و جوامع اقلیت کرده و سازمانی را مسئول پیشگیری از خشونت کرده است (گزارش‌های سلامت عمومی^۲، a، ۱۹۹۱). نتیجه برگزاری این همایش این بود که محققان و صاحب‌نظران این حوزه دریافتند که دانش آنها درباره پیشگیری به روشی هماهنگ و منسجم به دست نیامده است، از این رو برای توسعه برنامه‌های دیگر در زمینه پیشگیری خشونت مفید نیستند. به همین دلیل، به جای طراحی برنامه‌های پیشگیرانه، باید به ارزشیابی و بازشناسی برنامه‌های موجود و نبود خدمات قابل دست‌یابی پردازیم.

برنامه‌های دولتی بر جهت فعالیت‌های پیشگیری از خشونت تأثیر می‌گذارند. در گذشته پیشگیری و درمان خشونت در حد زیادی در دست پلیس، دادگاه‌ها و سیستم کیفری بود. اما امروزه، خشونت در قلمرو و حوزه سلامت عمومی قرار گرفته است (روزنبرگ و فنلی، ۲۰۰۱). برای مثال کنگره آمریکا سازمان ملی سلامت عمومی را مسئول پیشگیری از خشونت و ترویج سلامت جسمی و روانی و کاهش میزان خشونت در کل جامعه کرده است (OTA، ۱۹۹۱). این سازمان موجب افزایش چاپ کتاب‌ها و مقالات در زمینه سلامت عمومی شده است و پیوسته همایش‌هایی را برای کاهش قتل و مرگ و میرهای مرتبط با اسلحه برگزار می‌کند.

از نظر تاریخی، حوزه‌های مختلف مرتبط با پیشگیری از خشونت به طور جداگانه‌ای عمل می‌کنند. به طور کلی، تلاش‌های مربوط به پیشگیری از خشونت در حوزه وظایف تشکیلات قضایی کیفری، مراکز سلامتی، آموزش و پرورش و جامعه است.

^۱ . Wilson - Brewer

^۲ . public hearth reports

بخش تشکیلات قضایی کیفری و جنایی^۱

بسیاری از مداخله‌های مؤثر که کاربرد گسترده‌ای در پیشگیری از خشونت دارند، شامل پیشگیری ثانویه از طریق بخش تشکیلات قضایی و کیفری است. به‌طور سنتی، نوجوانان و جوانان خشونت‌طلب یا از طریق دستگیری و زندانی شدن یا توسط مؤسسه‌های نگهداری خاص از سایر افراد جامعه جدا می‌شوند. رویکرد تشکیلات قضایی کیفری به جرم و خشونت برای ممانعت از اقدام به جرم و سلب صلاحیت از مجرمین مورد حمایت زیادی واقع شده است (روزنبرگ و فنلی، ۲۰۰۱). با این حال، باوجود استفاده فراوانی که در سالیان متمادی از این رویکرد شده، این رویکرد هرگز در حل جرم و خشونت‌های نوجوانان و جوانان مؤثر نبوده است (رامیگ^۲، ۱۹۷۸). به‌طوری‌که میزان اعتیاد به ارتکاب جرم در نوجوانان ساکن در مؤسسه‌های نگهداری از جوانان بسیار زیاد است (اسکارپیتی و استفنسون^۳، ۱۹۷۱). افزایش خشونت در جوامع نیز نشان می‌دهد این رویکرد در پیشگیری و کاهش جرم و خشونت موفق نیست. افزایش خشونت در جوامع مختلف نشان می‌دهد که اگرچه زندانی کردن ممکن است در مورد برخی افراد مؤثر باشد، اما در سطح جامعه کارایی ندارد، زیرا فرد خاصی که به رفتارهای خشونت‌آمیز دست زده است، با مؤسسه‌ای شدن از جامعه جدا می‌شود، ولی سایر افراد خشونت‌طلب در جامعه می‌مانند، در نتیجه نرخ کلی خشونت و جرم همچنان در جامعه روند افزایشی خواهد داشت (مایر^۴ و همکاران، ۱۹۸۶). برای مثال، انجمن کارنگی در آمریکا، به معرفی برنامه پیشگیری از خشونت توسط بخش تشکیلات قضایی کیفری پرداخته که دارای مؤلفه‌های ارزشیابی مفیدی است (ویلسون - بریور و همکاران، ۱۹۹۱). متأسفانه در این برنامه رفتار خشونت‌آمیز به‌عنوان یک نتیجه یا پیامد اندازه‌گیری نشد. اگرچه به‌نظر می‌رسد، مؤسسه‌ای کردن به‌عنوان یک مداخله پیشگیرانه شکست خورده است، اما رویکرد تشکیلات قضایی کیفری تا حدودی با خشونت کمتر رابطه دارد. این رویکرد مبتنی بر محدود کردن دستیابی به ابزارها و وسایل خشونت است و بر ایجاد محدودیت‌های محلی برای فروش و نگهداری اسلحه و طولانی‌کردن مدت محکومیت در مواردی که هنگام جرم از اسلحه استفاده شده است، تأکید دارد (کوک^۵ و همکاران، ۲۰۰۱).

مشاهده شده که زندانی کردن افراد خشونت‌طلب به تنهایی منجر به بروز نتایج ناامیدکننده‌ای در بخش تشکیلات قضایی کیفری می‌شود و زمانی نتایج مثبتی خواهد داشت که با افزایش محدودیت

^۱ . criminal justice sector

^۲ . Romig

^۳ . Scarpitti & Stephenson

^۴ . Mayer

^۵ . Cook

برای دسترسی به اسلحه، افزایش امنیت و ایمنی در جامعه، محلات و خانه‌ها، سخت‌گیری در مورد قاچاق غیرقانونی اسلحه‌های گرم و افزایش قدرت پلیس همراه باشد.

بخش سلامتی

به‌تازگی خشونت در حوزه و قلمرو خدمات سلامتی قرار گرفته است. ازاین‌رو، بسیاری از مقالات چاپ‌شده در مورد خشونت، حاوی توصیه‌های شدید و گسترده‌ای در مورد مداخلات پیشگیرانه‌اند، ولی مقالات اندکی این توصیه‌ها را به‌کار گرفته یا مورد ارزشیابی قرار داده‌اند. بنابراین، قراردادن پیشگیری از خشونت در قلمرو و حوزه سلامت، فقط جنبه توصیه‌ای دارد. در واقع، جای‌دادن مداخلات پیشگیرانه در حوزه سلامت، در وهله اول مستلزم شناسایی نوجوانان خشونت‌طلب و به‌کارگیری نیروهای متخصص برای درمان آنان هم از نظر پزشکی و هم از نظر روان‌پزشکی است. این کار مستلزم کاهش محدودیت‌های مالی مراقبت بهداشتی مربوط به خشونت است. برای اینکه خدمات سلامتی در مداخله در خشونت مؤثر باشد، باید تشکیلات قضایی و جنایی و عرصه‌های آموزشی و پرورشی به‌صورت یک شبکه درآید. از طریق شبکه کارکنان سلامت می‌توان برنامه‌های استخدای را برای نوجوانان در معرض خطر زیاد طراحی کرد و توسعه داد، برنامه‌های پیشگیری از سوءمصرف مواد و الکل را گسترش داد، مهارت‌های حل تعارضات و کنترل خشم را آموزش داد، به خانواده‌ها شیوه‌های درست پرورش کودک و زندگی خانوادگی را آموزش و خانواده‌ها را مورد حمایت قرار داد (روزنبرگ و فنلی، ۲۰۰۱).

بخش آموزشی

بیشتر برنامه‌های پیشگیری از خشونت، در مدرسه و خارج از بخش تشکیلات قضایی کفیری صورت می‌گیرند (بوراج^۱ و همکاران، ۱۹۹۱). این برنامه‌های پیشگیری که در مدارس ارائه می‌شوند، بر موارد مختلفی تأکید می‌کنند. بعضی برنامه‌ها بر خشونت، برخی به آموزش در مورد عوامل خطرآفرین یا در مورد حل تعارض تأکید دارند، بسیاری از آنها برنامه‌های آموزش مهارت‌های مولد در زندگی‌اند که فقط بر رفتارهای مقدماتی یا مهارت‌هایی تأکید دارند که تصور می‌شود با خشونت‌های بعدی رابطه دارند (ویلسون - بریور و همکاران، ۱۹۹۱). تعداد بسیار کمی از آنها هم یک رویکرد کل‌گرا دارند و عوامل پیچیده‌ای را که مرتبط با خشونت‌اند، در نظر می‌گیرند، عواملی نظیر پیشرفت تحصیلی ضعیف، مصرف مواد و غیره.

^۱ . Boruch

به طور معمول برنامه‌های پیشگیرانه در مدرسه شامل ترکیبی از آموزش مهارت‌های زندگی، مشاوره و راهنمایی، آموزش همسالان و آموزش‌های پیشگیرانه مختلف‌اند (بوراج و همکاران، ۱۹۹۱). فرض اساسی این برنامه‌ها این است که خشونت، رفتار آموخته شده‌ای است که می‌توان آن را تغییر داد و از آن پیشگیری کرد (بلونی^۱ و همکاران، ۱۹۹۱). تمام این برنامه‌ها بیشتر اوقات، جوانان متعلق به خانواده‌هایی را که دارای بدکارکردی هستند، هدف قرار می‌دهند. در حال حاضر، این برنامه‌ها، بر مدیریت خشم، پرورش عزت نفس و پذیرفتن مسئولیت تأکید دارند. ممکن است این برنامه‌ها شامل مشاوره، آکادمی‌هایی برای نوجوانان متعهد یا برنامه‌هایی نظیر خدمات ملی نوجوانان باشد (کایرنز و همکاران، ۱۹۹۱). بیشتر این برنامه‌ها مبتنی بر اصول نظریه شناختی اجتماعی‌اند (لوچمن، ۱۹۹۲).

آموزش مهارت‌های زندگی اغلب بر نگرش‌های غیرخشونت‌طلب، مهارت‌های حل مسائل بین‌فردی و آموزش مهارت‌های اجتماعی تأکید دارند. این برنامه‌ها برای کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی طراحی شده‌اند و پیامدها و نتایج آنها از نظر کاهش در پرخاشگری اندازه‌گیری شده است (لوچمن^۲، ۱۹۹۲). داده‌ها نشان‌دهنده تأثیر محدود الگوهای رفتاری در موقعیت‌های مدرسه‌ای است. با این حال، اطلاعاتی درباره چگونگی کاهش پرخاشگری در موقعیت‌های آموزشگاهی اولیه‌ای که احتمالاً به خشونت در کل جامعه تبدیل خواهند شد، وجود ندارد (ویلسون - بریور و همکاران، ۱۹۹۱). برنامه‌هایی هم به منظور کمک به والدین برای کاهش رفتارهای ضد اجتماعی کودکان قبل از دوران بلوغ طراحی و تدوین شده‌اند. این برنامه‌ها در کاهش رفتار ضد اجتماعی مؤثر بوده‌اند، اما چند مشکل دارند؛ یکی اینکه، رفتار خشونت‌آمیز کودکانی که والدینشان از این برنامه‌ها استفاده کرده‌اند، در نوجوانی و جوانی اندازه‌گیری نشده است؛ دوم اینکه والدین بسیاری از نوجوانان و جوانان خشونت‌طلب به مشارکت در چنین برنامه‌هایی علاقه‌مند نیستند.

با وجود فقدان داده‌ها و اطلاعات دقیق در مورد مداخله‌های پیشگیری‌کننده در نظام آموزشی ما و سایر کشورها، گنجینه عظیمی از تجارب و شواهد داستان‌گونه و حکایتی وجود دارد. این شواهد بیانگر تأثیرات فوری و مثبت برخی از تدابیر پیشگیری‌کننده روی رفتارهایی هستند که مرتبط با خشونت تشخیص داده می‌شوند (لوچمن، ۱۹۹۲).

از آنجا که شرکت در مدرسه برای همه افراد اجباری است، طراحی مداخله‌های آموزشی توسط متخصصان و دست‌اندرکاران جامعه، فرصتی است که می‌تواند هر نوجوانی را در برنامه‌های

^۱ . Belloni

^۲ . Lochman

پیشگیری‌کننده درگیر کند. احتمال اینکه یک نوجوان از رجوع به مراکز مراقبتی بهداشتی خودداری کند و از درگیر شدن در نظام تشکیلات قضایی کیفری بپرهیزد، بسیار زیاد است، اما این نوجوان نمی‌تواند از درگیر شدن در نظام آموزشی و تعلیم و تربیت خودداری کند. از این رو، بخش آموزش و پرورش بهترین وسیله برای مداخله‌های پیشگیری‌کننده در خشونت است که تمام نوجوانان به‌اجبار به آن دسترسی دارند.

در پژوهشی بازرگان، صادقی و لواسانی (۱۳۸۲) وضعیت خشونت کلامی را در مدارس راهنمایی شهر تهران بررسی کردند. آزمودنی‌های پژوهش آنان را ۴۹۸ دانش‌آموز دختر و پسر و ۴۳ نفر از معلمان زن و مرد تشکیل می‌دادند. یافته‌ها نشان داد که خشونت کلامی در مدارس شهر تهران بسیار رایج است. این دانش‌آموزان فضای آموزشی نامناسب، ارتباطات نامطلوب در مدرسه و حجم زیاد کتاب‌های درسی را علت خشونت کلامی خود گزارش کردند، در حالی که معلمان آنها بیشتر بر عوامل خارج از مدرسه تأکید داشتند.

بخش اجتماعی

به دلیل رابطه مشخصی که بین خشونت و محیط اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، بخش اجتماعی می‌تواند با تأکید بر کاهش میزان پذیرش فرهنگی خشونت و خشونت اجتماعی مربوط به تبعیض‌های جنسی، قومی و نژادی و حمایت از الگوهای نقش‌گیری مثبت مردانه، تأثیر زیادی در کاهش جرم و خشونت داشته باشد (روزنبرگ و فنلی، ۲۰۰۱).

نقش بخش اجتماعی در کاهش خشونت، بر این فرض مبتنی است که نابرابری در توزیع منابع، درآمد، عدالت، تحمل و شکیبایی، نقش بسیار زیادی در بروز رفتار خشونت‌آمیز و افزایش خشونت‌طلبی دارد، بویژه اگر این موارد با احساس بی‌قدرتی و فقدان کنترل همراه شوند. به دلیل اینکه بین خشونت و داشتن جایگاه اقلیتی در جامعه رابطه وجود دارد، بسیاری از برنامه‌های پیشگیری‌کننده برای جوامع اقلیت طراحی شده‌اند، اما به نظر می‌رسد از آنجا که امروزه خشونت در تمام جوامع گسترش پیدا کرده است، باید این برنامه‌ها توسعه پیدا کنند، به‌طوری‌که بتوانند به تمام اقشار جامعه ارائه شوند.

پیشگیری جمعی و عمومی، همیشه با توصیه برای برنامه‌ریزی دقیق، ایجاد مشارکت عمومی، توسعه منابع، درگیر کردن تمام مشارکت‌کنندگان، تعیین هدف، روی آوردن به مشکل از ابعاد و جوانب مختلف، پرورش کارکنان خوب و ارزشیابی برنامه‌های تدوین شده شروع می‌شود. متأسفانه اطلاعات ما درباره چگونگی تأثیر برنامه‌های جمعی بسیار اندک است.

به‌طور خلاصه، تمام گروه‌هایی که با پیشگیری از خشونت سر و کار دارند، به نیاز برای هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی خدمات مختلف تأکید دارند. همه توافق دارند که سازمان‌ها و تشکیلات مختلف دست‌اندرکار پیشگیری از خشونت، به برقراری ارتباط بهتر و تماس بیشتر با یکدیگر نیازمندند و رسانه‌های گروهی باید در مداخله‌های پیشگیری‌کننده مشارکت فعالی داشته باشند. پیشگیری از خشونت، از وظایف مهم حوزه‌های سلامت عمومی، مراقبت‌های بهداشتی، سلامت روانی، تشکیلات قضایی، جنایی و کیفری، خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیت و رسانه‌های جمعی است. تمام نظام‌هایی که بر نوجوانان و جوانان تأثیر مستقیمی دارند، نظیر خانواده، جامعه، تعلیم و تربیت و سازمان‌های استعدادی، باید در راهبردهای مربوط به مداخله‌های پیشگیری‌کننده از خشونت شرکت کنند و برای این کار خطیر بسیج شوند. خشونت، ناشی از عوامل بسیار پیچیده اقتصادی، محیطی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و پرورشی و رفتاری است. بنابراین، مداخله‌های پیشگیری‌کننده باید این پیچیدگی را با هماهنگ‌سازی خدمات و کانون‌های پاسخ‌دهی منعکس کنند و نشان دهند.

براساس این موارد، اولین مرحله در به‌کارگیری مداخله‌های پیشگیری‌کننده، طراحی مشارکت‌ها و همکاری‌های کاری مؤثر میان حوزه‌های مختلف عمومی در بخش‌های خصوصی و عمومی است.

درمان

رویکردهای درمانی به خشونت، افرادی را که در معرض خطر اقدام به خشونت قرار دارند، هدف قرار می‌دهند، یعنی افرادی که تاکنون خشونت‌طلب بوده‌اند یا جوامعی که سطح خشونت در آنها بسیار بالاست.

این رویکردهای درمانی شامل همان مؤلفه‌هایی هستند که در برنامه‌های پیشگیری برای نوجوانان در معرض خطر، مطرح شد. این مؤلفه‌ها عبارتند از:

- آموزش مدیریت خشم و حل تعارضات؛
- مشاوره همسالان؛
- آموزش مشارکت شغلی یا اردوگاه‌های دارای سبک نظامی؛
- اشاعه برنامه‌های طراحی‌شده برای ترویج عزت نفس، کنترل خطرهای سلامتی و مشارکت در خشونت؛
- خدمات مشاوره و راهنمایی؛
- تغییر رویه از محاکم قضایی جوانان به خدمات عمومی؛

• مشاوره‌های روان‌شناختی (کایرنز و همکاران، ۱۹۹۱).

رویکردهای درمانی انفرادی مطرح‌شده، شامل سه رویکرد درمانی مختلف روان‌شناختی‌اند: رویکرد روان‌پویشی، رویکرد انسان‌گرایی و رویکرد اصلاح رفتار. پیش‌فرض و مفهوم هر سه رویکرد، این است که رفتار خشونت‌آمیز با برخی فقدان‌ها در فرد مرتبط است و چنانچه این فقدان‌ها جبران شوند، رفتار مؤثر و سالم در فرد شکل خواهد گرفت (گلدشتاین^۱، ۱۹۸۶). متأسفانه، بعضی از مطالعاتی که در مورد این رویکردها انجام گرفته، نشان داده‌اند که هیچ‌یک از این رویکردها تأثیر و کارایی چشمگیری در کاهش جرم و خشونت نداشته‌اند (کازدین^۲، ۱۹۸۷؛ ویلسون - بریور و همکاران، ۱۹۹۱). با وجود این، بعضی صاحب‌نظران معتقدند که در کل، نتایج مطالعات ارزشیابی مکرری که در مورد رویکردهای مختلف روان‌شناختی صورت گرفته، از کارایی رویکردهای یادگیری اجتماعی و رفتاری حمایت می‌کنند (مایر^۳ و همکاران، ۱۹۸۶؛ رندر، اسنلمن و دیویدسون^۴، ۱۹۸۲).

در رویکرد یادگیری اجتماعی، فنون حل تعارض، مدیریت و کنترل خشم و آموزش مهارت برای کمک به افرادی که فاقد این مهارت‌ها هستند و نه نیازمند درمان، به‌کار گرفته می‌شوند. تأکید اصلی، بر آموزش این مهارت‌ها به افراد است که منجر به شکل‌گیری تعاملات رضایت‌بخش و مؤثر بدون اعمال خشونت می‌شود. نتایج مطالعات نشان داده‌اند که نوجوانان و جوانان پرخاشگر و خشونت‌طلب طی این برنامه‌های درمانی دامن‌های از مهارت‌های روانی اجتماعی کلی را می‌آموزند، از جمله مهارت‌های بین‌فردی، مدیریت پرخاشگری و خشم و کنترل هیجانات (گلدشتاین، ۱۹۸۶).

این رویکرد تا وقتی ریشه‌های رفتار خشونت‌آمیز یا به‌عبارت دیگر خشونت‌ها و آزار و اذیت خانوادگی وجود دارند، کارایی کمی دارد. اگرچه آموزش چنین مهارت‌هایی در سطح وسیعی توسط محققان مختلف و به شیوه‌های متفاوتی مورد ارزشیابی قرار گرفته است و تحقیقات از کارایی کوتاه‌مدت این آموزش‌ها حمایت می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد که نقص اساسی و مهم یا مشکل اصلی این رویکرد، عدم قابلیت انتقال مهارت‌های آموخته‌شده از جلسات درمانی به موقعیت‌های واقعی زندگی باشد؛ بویژه اگر محیط زندگی فرد، مملو از خشونت باشد.

اجرای برنامه‌های درمانی مبتنی بر این رویکرد در سه شهر مختلف آمریکا نشان‌دهنده کارایی نسبی رویکرد یادگیری اجتماعی است. در شهر جورجیا برنامه‌ای اجرا شد که طی آن به نوجوانان دبیرستانی سفیدپوست و سیاه‌پوست آمریکایی آموزش لازم برای کاهش خشونت زیاد داده شد

^۱ . Goldstein

^۲ . Kazdin

^۳ . Mayer

^۴ . Render, Snellman & Davidson

(جنکینز^۱، ۱۹۹۱)؛ دیگری در شهر کانزاس که بخش سلامت آن شهر این برنامه را اجرا کرد و طی آن در پنج جلسه ۲ ساعته به نوجوانان خشونت طلب حل تعارض و کنترل خشم را آموزش داد (میتچل^۲، ۱۹۹۱)؛ سومین شهر بوستون بود که بخش سلامت آن شهر برنامه‌ای را برای ترویج سلامتی در بین نوجوانان روستایی ارائه کرد که شامل آموزش و امداد بود. بعد آموزشی برنامه از پیشگیری از خشونت در دبیرستان‌ها حمایت می‌کرد. در این برنامه، از آموزش مهارت‌های حل تعارض، ارائه اطلاعات درباره خشونت، قتل و آدم‌کشی استفاده و سعی شد که محیط‌های کلاسی فاقد خشونت ایجاد شود (پروتو - استیث، ۲۰۰۳).

پژوهش‌های انجام شده در مورد خدمات سلامت روانی، نشان می‌دهند که بیشتر این خدمات به جای آنکه اعمال خشونت‌آمیز را هدف قرار دهند، رفتارهای واسطه‌ای را هدف قرار می‌دهند. بعضی از رفتارهایی که مورد هدف واقع شده‌اند، مصرف الکل، مواد مخدر و رفتارهای مرتبط با گروه‌های تبهکاری است (اوستوس^۳، ۱۹۹۱). درمان مصرف الکل و مواد و پیشگیری از خشونت با هم ارتباط دارند.

مداخله در سطح جامعه

بعضی رویکردها فقط فرد را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه جامعه را نیز هدف قرار می‌دهند. همان‌طور که در بخش همه‌گیرشناسی ذکر شد، نوجوانانی که در جامعه با خشونت بیشتری مواجه می‌شوند، به احتمال بیشتری در رفتارهای خشونت‌آمیز درگیر می‌گردند. به علاوه، احتمال بیشتری وجود دارد که جوامع فقیرتر سطح بالاتری از خشونت داشته باشند. برنامه‌های درمانی برای جوامعی که در سطح بالایی در این خشونت‌ها درگیرند، عبارتند از:

- تلاش‌های مداخله‌ای در سطح خیابان؛
- بسیج کردن اعضای جامعه؛
- برنامه‌های آموزشگاهی؛
- برنامه‌های جایگزینی شغلی؛
- برنامه‌های بازپروری؛
- هماهنگ‌سازی برنامه‌های سلامت روان، مصرف مواد و خدمات اجتماعی؛
- تدارک و تهیه الگوهای مثبت نقش؛

¹ . Jenkins

² . Mitchel

³ . Ostos

- مداخلات خانوادگی؛
- پروژه‌های محلی؛
- آموزش شغلی و افزایش سطح تحصیلات (گرین^۱، ۱۹۹۳).

بسیاری از افراد خشونت‌طلب، برای مفید بودن در جامعه، مشکل دارند، به‌همین دلیل، به رویکرد متفاوتی برای استفاده از خدمات سلامت روانی نیازمندند. در درمان این افراد، تغییرات زیر الزامی است:

- افزایش خدمات سلامت روانی محلی؛
- افزایش بودجه‌های خدمات سلامت روانی؛
- آموزش و تربیت متخصصان سلامت روانی؛
- افزایش تحقیقات.

یک رویکرد اجتماعی مهم، جداسازی جوانان و نوجوانان خشونت‌طلب از جامعه با درمان‌های شبانه‌روزی و زندانی کردن است. برخلاف زندانی کردن، هدف درمان‌های شبانه‌روزی، تدارک اسکان شبانه‌روزی توأم با درمان انفرادی است. متأسفانه، بسیاری از خدمات شبانه‌روزی، فاقد صلاحیت و تجهیزات لازم برای نوجوانان و جوانان خشونت‌طلب‌اند. ممکن است رفتارهای توأم با خشونت این نوجوانان، منابع انسانی، کارکنان و محیط مؤسسه‌های شبانه‌روزی را که برای افراد غیرخشونت‌طلب طراحی شده‌اند، به مخاطره بیندازد و آنان را در معرض خطر قرار دهد. به‌طور معمول کارکنان این مؤسسه‌ها در اداره و درمان رفتار جوانان خشونت‌طلب در موقعیت‌های مؤسسه‌ای مشکل دارند. به همین دلایل، برنامه‌های کمی برای پذیرش جوانان خشونت‌طلب طراحی شده‌اند، بنابراین اغلب از یک برنامه به سایر برنامه‌ها انتقال داده می‌شوند و تا سنین بزرگسالی در زندان می‌مانند و عمر آنان تلف می‌شود (آگی^۲، ۱۹۸۶).

به‌طور خلاصه، رویکردهای درمانی برای خشونت، همان مشکلات اساسی را که رویکردهای پیشگیری دارند، دربردارند. این مشکلات شامل عدم پاسخگویی اساسی و مسئولیت اجتماعی و فقدان هماهنگی بین خدمات است. به‌طور معمول عدم پاسخگویی، مسئولیت و هماهنگی با کمبود بودجه‌های لازم برای درمان همراه می‌شود و موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.

^۱ . Greene

^۲ . Agee

نحوه برخورد با نوجوانانی که شاهد مرگ ناشی از خشونت یکی از نزدیکان خود بوده‌اند

گاه مشاهده مرگ خشونت‌بار یکی از نزدیکان، مشکلات شدید روان‌شناختی‌ای نظیر افسردگی، ترس و اختلال تنیدگی پس‌ضربه‌ای در جوانان و نوجوانان ایجاد می‌کند. معلمان، کارکنان مدرسه و سایر نزدیکان فرد، می‌توانند به این نوجوانان کمک کنند تا به‌طور مطلوبی با مرگ ناشی از خشونت نزدیکانشان سازگار شوند. پیشنهادهای زیر، روش‌هایی برای مورد حمایت قراردادن نوجوانان پس از مشاهده مرگ توأم با خشونت است. این توصیه‌ها می‌تواند به مشاوران و روان‌شناسان بالینی نیز در درمان این نوجوانان کمک کند.

داشتن طرح یا برنامه. خط‌مشی‌ها و برنامه‌های پاسخ‌دهی به بحران را مطالعه کنید، سپس با والدین، معلمان، مدیران یا کارکنان مدرسه ملاقاتی داشته باشید و نیاز فردی را که شاهد مرگ خشونت‌بار بوده است، با آنها در میان بگذارید.

ایجاد امنیت. اگر امنیت نوجوان به مخاطره افتاده باشد، با او درباره نگرانی‌هایش و کار با دیگران صحبت کنید و تا آنجا که ممکن است، در او احساس امنیت ایجاد کنید.

ارجاع دادن. نوجوانانی را که واکنش‌های شدیدی نسبت به مشاور از خود نشان می‌دهند، به سایر مراکز درمانی ارجاع دهید.

صحبت کردن. فرصت‌هایی را برای نوجوان ایجاد کنید تا در مورد حادثه صحبت کند. به‌خاطر داشته باشید که ممکن است نوجوان نیاز به بحث در مورد حادثه و نگرانی‌ها و ناراحتی‌های ناشی از آن که در آینده با آن مواجه خواهد شد، داشته باشد.

آموزش‌دهی به نوجوان. هنگام بحث با نوجوان، از مربی و متخصص سلامت روانی کمک بگیرید تا واکنش‌های رایج به حوادث آسیب‌زا را برای او شرح داده و به او آموزش دهد که چگونه با این مرگ توأم با خشونت سازگار شود و واکنش نشان دهد.

حفظ ساختار فعالیت‌ها و محدودیت‌های رفتاری. در صورت نیاز، به‌طور موقت از اصول نظریه یادگیری استفاده کنید، اصولی نظیر تقویت و خاموشی.

پاسخ‌دهی به‌صورت قابل اعتماد. اگر پاسخ پرسش‌های نوجوان را درباره خشونت یا مرگ ناشی از آن نمی‌دانید، از او بخواهید تا فرصتی به شما بدهد تا بعداً به پرسش‌های او پاسخ دهید.

تسهیل بیان افکار و احساسات. به نوجوان اجازه دهید تا بداند که داشتن افکار و احساسات مربوط به مرگ توأم با خشونت طبیعی است و از او بخواهید تا افکار و احساساتش را بیان کند.

الگودهی بیان مناسب افکار و احساسات. فعالیت‌هایی را طرح‌ریزی کنید، مانند نوشتن زندگی‌نامه شخصی، گفتن شعر، دعا و نیایش و راز و نیاز با خداوند که منجر به ایجاد امیدواری و آرامش در نوجوان می‌شود.

آموزش به والدین. اطلاعاتی را درباره روش‌هایی که می‌توان به نوجوان پس از مشاهده مرگ توأم با خشونت کمک کرد، به والدین بدهید.

جست‌وجوی حمایت از دیگران. در صورت نیاز، از متخصصان سلامت روانی، روحانیان و رهبران دینی، پزشک‌ها یا دوستانتان درباره واکنش‌های درست به حادثه کمک بگیرید (سالوم^۱، ۲۰۰۴).

در این فصل، از نقد و انتقاد برنامه‌های موجود پرهیز شد، اما در مورد نقد برنامه‌ها فقط یک موضوع مانده که بیان آن تا حدی مشکل است. از این رو ابتدا فرض را بر این می‌گذاریم که منابع، بودجه و قدرت نامحدودی در اختیار داریم. حال با این فرض چه باید کرد؟ ادبیات تحقیق و تجارب قبلی، نشان می‌دهد که باید از مداخله‌های چندوجهی استفاده کنیم. صاحب‌نظران این حوزه مداخله سه‌قسمتی را پیشنهاد کرده‌اند (جدول ۸-۲). یک قسمت آن متمرکز بر پیشگیری در سطح شخصی، قسمتی متمرکز بر پیشگیری در سطح اجتماعی و بخشی متمرکز بر پس‌مداخله^۲ است.

^۱ . Salloum

^۲ . postvention

جدول ۸-۲. مداخله سه بخشی در خشونت

شخصی

۱. آموزش مهارت‌های بین فردی و درون فردی

الف) حل مسئله

ب) کنترل خشم

۲. تغییر شناخت

الف) تعیین هدف

ب) آموزش شغلی

۳. درمان اعتیاد به مواد

اجتماعی

۱. غیرقابل قبول بودن خشونت

۲. عدم دسترسی به اسلحه

۳. افزایش فرصت‌ها

پس مداخله

۱. ریشه کن کردن و از بین بردن خشونت خانوادگی

۲. ریشه کن کردن و از بین بردن خشونت در جامعه

۳. هدف قرار دادن مجرمان اولیه

منبع: برگرفته از دیکلمنت، هانسن و پانتون، ۱۹۹۶

پیشگیری در سطح شخصی

مؤثرترین روش برای درمان رفتار خشونت آمیز در سطح فردی چیست؟ یکی از روش‌ها، آموزش مهارت است. به نظر می‌سد مهارت‌های حل مسئله و کنترل خشم در بسیاری از نوجوانانی که دست به اعمال خشونت بار می‌زنند، وجود ندارد. تجارب مختلف نشان داده‌اند که آموزش این مهارت‌ها امکان‌پذیر و مؤثر است، بویژه در سنین کم.

یکی دیگر از مداخله‌های مؤثر شخصی، تغییر شناخت‌ها از طریق تعیین هدف و آموزش شغلی و حرفه‌ای است. بسیاری از نوجوانانی که دست به اعمال خشونت آمیز می‌زنند، به آینده کمتر می‌اندیشند و هدف خاصی ندارند. آنها نمی‌توانند خود را با احترام، عزت و به‌طور مفیدی مشغول کنند. بنابراین، یک مداخله در سطح شخصی شامل تأثیرگذاری بر ادراک نوجوانان از خود، آینده و برنامه‌ریزی برای آماده شدن برای آینده است. از نظر اقتصادی، این کار راحت‌تر از سایر کارهاست.

علاوه بر تأثیرگذاری بر این ادراکات و تصورات نوجوانان از فرصت‌های موجود، باید بر آمادگی‌ای که نوجوانان پیدا می‌کنند تا از فرصت‌های موجود بهره ببرند نیز تأثیر بگذاریم. سومین مداخله مؤثر شخصی، درمان اعتیاد است. تعداد زیادی از رفتارهای خشونت‌آمیزی که در دنیا رخ می‌دهند، با اعتیاد به الکل و مواد ارتباط دارند که در واقع مشکل را دوجندان می‌کنند، ترک اعتیاد و رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر مشکل خشونت‌طلبی را شدت می‌بخشد. یکی از مشکلات مربوط به مداخله‌های سطح شخصی، این است که جوانان خشونت‌طلب ممکن است متعلق به محیط‌های مشکل‌آفرین باشند. ممکن است والدین آنها در زندان باشند یا به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشته باشند یا متعلق به خانواده‌هایی باشند که مملو از مشکل و خشونت هستند. ممکن است این افراد فاقد غذای کافی، سرپناه، سرپرست و مدرسه باشند. این فهرست همچنان افزایش می‌یابد، مگر اینکه مداخله در سطح شخصی شامل مدنظر قرار دادن محیط نوجوانان، توسعه مهارت‌ها، تعیین هدف و تأثیر بر ادراک، تصورات و عزت نفس آنان باشد.

پیشگیری در سطح اجتماعی

دومین قسمت از مداخله‌های ایده‌آل، به‌طور مستقیم با جهان اجتماعی نوجوانان سر و کار دارد. در سطح وسیع‌تر اجتماعی غیرقابل قبول بودن رفتارهای خشونت‌آمیز در رسانه‌ها و خیابان‌ها بسیار مهم است. موضوع مهم، ایجاد توازن و تعادل در سانسور اطلاعات مربوط به جرایم، قتل‌ها و خشونت‌ها و تأثیر منفی آنها، ایجاد انگیزه برای عبرت گرفتن در رسانه‌ها، رفاه اجتماعی و آزادی فردی است. بعضی از مسائل در مورد مصرف سیگار بدین ترتیب حل شده است. چرا حالا نتوانیم این کار را در مورد غیرقابل قبول بودن خشونت انجام دهیم؟ مبارزه با مصرف سیگار در ابتدا از طریق رسانه‌ها و سپس قابل قبول نبودن اجتماعی آن صورت گرفت و در نتیجه، مشکل تا حدودی برطرف شد و مصرف سیگار از نظر اجتماعی غیرقابل قبول شد. این رویکرد را می‌توان در مورد خشونت نیز در پیش گرفت.

دومین مداخله اجتماعی، عدم دسترسی به اسلحه است. زمانی که یک نوجوان خشمگین و خشونت‌طلب اسلحه حمل می‌کند، احتمال دارد دست به قتل و کشتار دیگران بزند، یا به افراد دیگر صدمه برساند. در جاهایی که دسترسی به اسلحه وجود ندارد، میزان قتل و آدم‌کشی کم است. کاهش کشتارهای ناشی از خشونت، به اندازه کاهش تعداد اعمال خشونت‌آمیز مهم است.

سومین مداخله مهم اجتماعی، حول فرصت‌ها می‌چرخد. باید فرصت‌های مثبت را برای فعالیت‌هایی که احتمال خشونت را کاهش می‌دهند، افزایش داد. این فرصت‌های مثبت مربوط به

افزایش احتمال واقعی داشتن مشاغل سودآور و تعلیم و تربیت و تحصیلات کافی است. ممکن است این فرصت‌ها برای جوانان غیرقابل دست‌یابی یا محدود باشند. برنامه‌های مشاوره‌ای مخصوص جنسیت و قومیت و الگوهای نقش را نیز نباید نادیده گرفت. این برنامه‌ها باید برای نوجوانان، حمایت‌های آموزشی، مالی و اجتماعی فراهم کنند.

در مناطقی که خشونت زیاد است، رایج‌ترین شغل‌ها و فرصت‌های شغلی شامل خرید و فروش مواد و وسایل غیرمجاز توسط باندها و گروه‌های تبهکاری است که این مسئله موجب گسترش تبهکاری، درگیری‌های خیابانی و محلی و باندهازی و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز می‌شود.

به‌طورمعمول خشونت در مواقع بیکاری و زمانی که فرد در حال گذراندن وقت خود بدون هدف و مشغول وقت‌گذرانی است، رخ می‌دهد؛ یعنی زمانی که گروه‌های جوانان بدون هیچ سرپرست یا ناظری دور هم جمع می‌شوند. تاکنون برنامه‌های زیادی سعی کرده‌اند فرصت‌های سازنده‌ای را برای پرکردن اوقات فراغت و بیکاری نوجوانان ایجاد کنند که بدون شک مؤثر بوده است ولی ارزشیابی درستی از آنها صورت نگرفته است.

پس‌مداخله

قسمت سوم از مداخله‌های مربوط به خشونت، شامل پیگیری یا پس‌مداخله است. هدف این برنامه‌ها این است نوجوانانی که در گذشته دست به خشونت زده‌اند، بتوانند رفتارهای خشونت‌آمیز را فراموش کرده و هرگز تکرار نکنند. قبل از اینکه خشونت به‌شکل الگوی رفتاری در نوجوان درآید، باید متوقف شود. احتمال زیادی وجود دارد که نوجوانان و جوانان در ابتدا در خانواده با خشونت مواجه شده باشند و خشونت را در خانواده یاد گرفته باشند. امروزه نوجوانان در خانواده‌ها خشونت‌های زیادی را تحمل می‌کنند. تا زمانی که زوج‌ها و والدین از درگیرشدن در رفتار خشونت‌آمیز نپرهیزند و استفاده از اشکال انضباطی خشونت‌آمیز را متوقف نکنند، جامعه‌پذیری خشونت‌آمیز در کودکان همچنان ادامه خواهد یافت. همچنین نیاز به متوقف کردن ترویج خشونت در جامعه وجود دارد. خشونت‌های پلیس، یک واقعیت قابل قبول در زندگی روزانه هر فردی است. بسیاری از مدارس هنوز هم از روش‌های تنبیهی استفاده می‌کنند. قهرمانان ورزشی در حین بازی‌های ورزشی، خشونت به خرج می‌دهند، قابل قبول بودن هر نوع خشونتی میزان بروز خشونت در آینده را افزایش می‌دهد. درنهایت، لازم است که عمل افراد مجرم در مراحل اولیه متوقف شود؛ البته نه با زندانی کردن آنان، بلکه با آموزش مهارت‌های شغلی مطلوب و مناسب به آنان. وقتی این افراد شغل سالم و مولدی داشته باشند، مجبور نیستند دست به خشونت بزنند. واقعیت این است که این رویکرد

سه‌قسمتی هرگز به‌طور کامل به‌کار گرفته نمی‌شود، زیرا بسیار وقت‌گیر، پرهزینه و مشکل است و حتی جنبه سیاسی دارد. به همین دلیل، در ابتدای بحث گفتیم با فرض اینکه منابع، بودجه‌ها و قدرت ما نامحدود باشد، کدام نوع از مداخله‌ها تناسب دارند. با این حال، صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که دو رویکرد زیر بسیار اهمیت دارند:

غیرقابل قبول بودن خشونت در اجتماع از طریق رسانه‌ها و افزایش فرصت‌هایی برای زندگی مثبت در آینده و تصور اینکه این فرصت‌ها وجود دارند.

بی‌شک یکی از وقایع مهم و جالب طی سال‌های آینده، این است که چگونه جامعه برای اقدام علیه خشونت‌طلبی بسیج خواهد شد. در این فصل اشاره کردیم که خشونت در جوامع امروزی مانند یک غده سرطانی در حال رشد است و همه دست‌اندرکاران جامعه وظیفه دارند که برای حل آن بسیج و هماهنگ شوند.

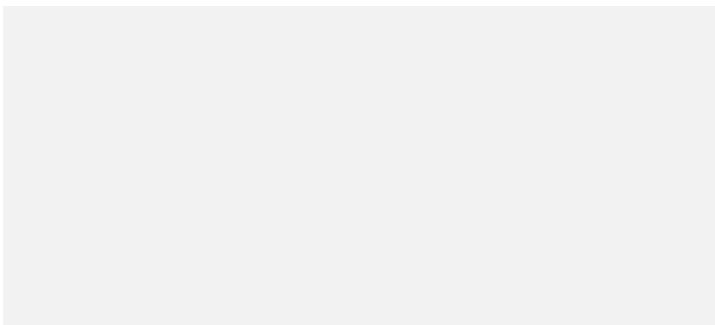
خلاصه

در این فصل اشاره شد که امروزه خشونت در بیشتر جوامع به موضوع مهمی مبدل شده، اما به دلیل تنوع زیاد در رفتارهای خشونت‌آمیز، ارائه تعریف دقیقی از آن تا حدودی مشکل است. با این حال، خشونت به رفتارهایی اطلاق می‌شود که صدمات و آسیب‌های جسمانی شدیدی به افراد دیگر یا خود فرد وارد می‌سازند. خشونت، رفتاری است که هم بعد فردی دارد و هم بعد اجتماعی. اغلب میزان خشونت در شهرها و مراکز بزرگ و پرجمعیت و صنعتی، زیادتر از شهرهای کوچک است و در محلات فقیرنشین رواج بیشتری دارد.

یکی از همبسته‌های مهم رفتارهای خشونت‌آمیز و جرم‌آفرین، نظام و ساختار خانوادگی است. البته دسترسی به اسلحه، بویژه سلاح‌های گرم نیز از جمله همبسته‌های مهم خشونت است. به‌طور کلی، عوامل خطرآفرین سه دسته‌اند: شخصی، اجتماعی و خانوادگی. یکی از موضوعات مهم در این حوزه، پیشگیری از خشونت است. به‌طور کلی، خدمات پیشگیری در حیطه وظایف تشکیلات قضایی کیفری، مراکز سلامتی، آموزش و پرورش و کل جامعه است. مهم‌ترین رویکردهای درمانی به خشونت عبارتند از رویکردهای روان‌پویشی، انسان‌گرایی و اصلاح رفتار. نتایج تحقیقات از رویکردهای درمانی مبتنی بر نظریه‌های یادگیری اجتماعی و رفتاری حمایت می‌کنند.

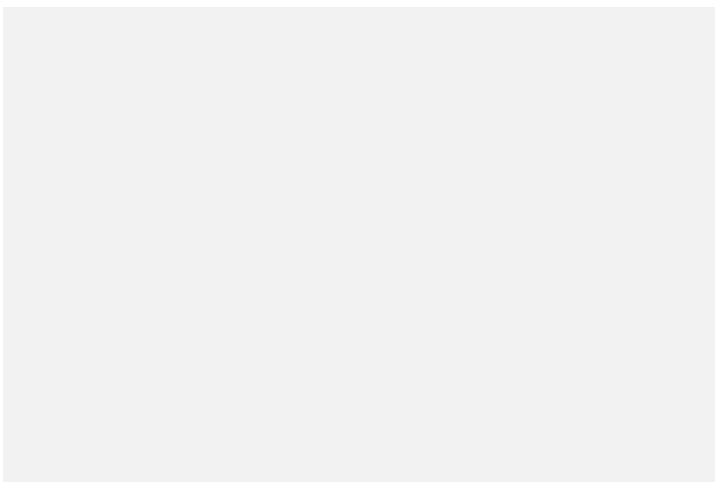
پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

- ۱) رسانه‌های گروهی چه نقشی در ترویج یا پیشگیری از خشونت در جامعه دارند؟
- ۲) به نظر شما کدام یک از عوامل زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی نقش مهم‌تری در شکل‌گیری و تداوم رفتارهای خشونت‌آمیز در نوجوانان دارند؟



فصل نهم

نوجوانان فراری و بی خانمان



تعداد نوجوانان و جوانانی که از خانه فرار می‌کنند یا توسط والدینشان از خانه بیرون انداخته شده و بی‌خانمان و بی‌سرپناه می‌شوند، روبه افزایش است و مشکل بسیار مهمی است که جوامع بزرگ و صنعتی با آن مواجه‌اند. بسیاری از این نوجوانان یا خانه را ترک کرده‌اند یا از طرف خانواده‌های خود که دارای بدکارکردی بوده یا آزاردهنده‌اند، طرد شده و به اجبار بیرون رانده شده‌اند و ناچارند در خیابان زندگی کنند. این زندگی خیابانی عواقب بسیار منفی و وخیمی در پی دارد، از جمله فقر و تنگدستی، مصرف مواد، مورد ضرب و شتم واقع شدن، در معرض تجاوز جنسی قرار گرفتن، حاملگی، صدمه دیدن یا بیماری، ابتلا به عفونت ایدز، مشکلات روان‌شناختی و هیجانی و خودکشی پیامدهای زندگی خیابانی است. علاوه بر این، شانس آنها برای طی دوره نوجوانی توأم با سلامت، مولد و بارآور، توسط خطرهای مختلف تهدیدکننده سلامت که با آن مواجه می‌شوند، کاهش می‌یابد. این افراد اغلب فرصت‌های خود را برای استفاده از تعلیم و تربیت و مشغول شدن به کار از دست می‌دهند. طی سال‌های گذشته محققان گسترش و شیوع این مشکلات را اثبات کرده و نشان داده‌اند.

فرار دختران از خانه در ایران به منزله یکی از مشکلات حاد روز مطرح است. این دختران، خیابان‌ها را به عنوان راهی برای فرار از مشکلات انتخاب می‌کنند و تبدیل به آواره‌های طرد شده جامعه می‌شوند و برای زنده ماندن راه‌های مختلفی را جست‌وجو می‌کنند. ترمینال‌های اتوبوس اولین محل توقف این دختران است. در اطراف این ترمینال‌ها اماکن و خرابه‌های زیادی وجود دارد که برای این دختران آسیب‌پذیر، بسیار خطرناک است؛ اماکنی که در آن توزیع و مصرف مواد مخدر و فحشا در حال افزایش است و طبیعی است که این دختران تازه‌وارد که جایی برای اقامت ندارند، جذب چنین اماکنی شوند (بازیاری میمن‌دی، رسول زاده طباطبایی و آزاد فلاح، ۱۳۸۲). براین اساس، این فصل به بررسی گسترش و جریان بی‌خانمان شدن، بررسی و روشن کردن وضعیت سلامت نوجوانان بی‌خانمان، تعیین عوامل خطرآفرین و راهبردهای بالقوه برای پیشگیری از عواقب بی‌خانمانی، تشریح الگویی برای نوجوانان بی‌خانمان و تعیین مرزبندی‌های ساختاری برای به‌کارگیری خدمات بهداشت روان برای این نوجوانان می‌پردازد.

همه‌گیرشناسی بی‌خانمانی

برآوردهای انجام‌شده از تعداد نوجوانان بی‌خانمان

اگرچه در آمریکا نیز بسیاری از نوجوانان بی‌خانمان‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که بی‌خانمانی در درجهٔ اول یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه باشد (رابرتسون^۱، ۱۹۹۱b). برآوردهای محافظه‌کارانه‌ای که از این مشکل به‌عمل آمده، نشان داده که ۱۰۰ میلیون نوجوان در کل جهان بی‌خانمان و بی‌سرپناه‌اند (یونیسف^۲، ۱۹۸۹). مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اولین تعیین‌کننده‌های بی‌خانمانی هستند. در آفریقا، بسیاری از نوجوانان بی‌سرپناه‌اند، زیرا والدین آنها در اثر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با ایدز مرده‌اند. در کاکارا و تانزانیا، ۲۲,۰۰۰ کودک در اثر شیوع ایدز، یتیم شده‌اند (راتایوگا^۳، ۱۹۹۲). سازمان بین‌الملل در آمریکا پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۱۵، ایدز به یتیم شدن ۱۶ میلیون کودک در آفریقا منجر خواهد شد (راتایوگا، ۱۹۹۲). با این حال، همیشه فقر شدید با از هم پاشیده‌شدن خانواده‌ها رابطه داشته و از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های بی‌خانمانی بوده است. برای مثال، در برزیل، دوسوم جمعیت ۱۴۰ میلیونی این کشور، زیر خط فقرند (میرز^۴، ۱۹۸۹). بسیاری از کودکان برزیلی برای ترک خانه‌های خود زیر فشار قرار می‌گیرند، زیرا والدینشان نمی‌توانند از آنها حمایت کنند. در این کشور، همانند سایر کشورهای در حال توسعه، بی‌خانمانی یکی از روش‌های زندگی کردن است تا وضعیت موقتی.

در آمریکا هیچ پژوهش جامعی در مورد تعداد نوجوانان بی‌خانمان صورت نگرفته است. در سال ۱۹۷۵، برآورد شد که بین ۵۱۹,۰۰۰ تا ۶۳۵,۰۰۰ نوجوان بی‌خانمان در آمریکا وجود دارد (برن، هایزینگا و الیوت^۵، ۱۹۷۹). در سال ۱۹۸۷ در حدود ۳۳۰,۰۰۰ نوجوان بی‌سرپرست در آمریکا وجود داشته است (رابرتسون، ۱۹۹۱ b). با توجه به این ارقام، به‌نظر می‌رسد که بی‌خانمانی در میان نوجوانان، روبه افزایش است. از طرفی، میزان گستردگی این مشکل به سختی قابل برآورد است. یتس^۶ (۱۹۸۸) معتقد است برآورد دقیق تعداد نوجوانان بی‌خانمان به‌دلیل اینکه هیچ راه خاصی برای این کار وجود ندارد، غیرممکن است و اغلب تعداد نوجوانان بی‌خانمانی که از سازمان‌های دولتی تقاضای کمک می‌کنند، کم برآورد می‌شود.

^۱. Robertson

^۲. United Nations Children's Fund (UNICEF)

^۳. Rutayuga

^۴. Meyers

^۵. Brennen, Huizinga & Elliot

^۶. Yates

تعریف بی خانمانی

تعریف بی خانمانی و روش های کنونی برای طبقه بندی نوجوانان بی سرپناه، ارائه راهبردهای مؤثر برای حل مشکلات سلامت فیزیکی و روانی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. نظام های طبقه بندی زیادی برای طبقه بندی نوجوانان بی خانمان صورت گرفته است. بوکی^۱ (۱۹۸۷)، نوجوانان بی خانمان را شامل نوجوانانی می داند که سرپناه ندارند، از خانه فرار کرده اند، از خانه بیرون انداخته شده و قربانی شده اند. با این حال، این مقوله ها را نمی توان به عنوان مقوله های محض و مطلق در نظر گرفت. اغلب نوجوان بی سرپناه در چند مورد از مقوله های بالا جای می گیرد نه فقط در یکی از این مقوله ها. برای مثال، یک نوجوان بی خانمان می تواند از خانه فرار کرده باشد و در عین حال مورد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی نیز قرار گرفته باشد. شبکه جهانی فرار و سازمان نوجوانان^۲ (۱۹۸۵)، نوجوانان "فراری" را از نوجوانان "بی خانمان" بر اساس اینکه نوجوانان فراری، فرار و ترک خانه را ترجیح می دهند ولی نوجوانان بی خانمان از خانه و کاشانه خود بیرون انداخته می شوند، متمایز کرده است.

در حرکت بین المللی سیاسی نوجوانان بی خانمان، بین کودکان "خیابانی"^۳ و کودکانی که "در خیابان"^۴ هستند، تمایز قائل شده اند (بوند، جیمینز و مازین^۵، ۱۹۹۲). کودکان "خیابانی"، کودکانی هستند که از سنین خیلی کم کار می کنند و بزرگتری دارند که بر آنها نظارت و بازرسی نزدیک دارد، اما کودکان "در خیابان"، از دلبستگی به بزرگترهای آشنا مستقل و رها هستند. این نوجوانان به طور معمول بدون اجازه دیگران در گوشه ای با یکدیگر جمع می شوند یا به صورت جمعی زندگی کرده و اغلب نیازهای اساسی یکدیگر را برآورده می کنند. در این فصل، به تمام نوجوانانی که حداقل دو شب را در سرپناه خارج از خانه می گذرانند یا در خیابان ها به عنوان افراد بی خانمان زندگی می کنند، بی خانمان اطلاق می شود و سعی خواهد شد که مشکلات آنان بررسی شود.

ویژگی های نوجوانان بی خانمان

شرایط خاصی از زندگی با افزایش خطر بی خانمانی مرتبط اند. ممکن است والدین بسیار جوان، بخش بزرگی از نوجوانان بی خانمان را تشکیل دهند (رابرتسون، ۱۹۹۱ a). برای مثال، در سال ۱۹۸۵ برآورد شده که یک سوم کل ۲۱,۰۰۰ نوجوان بی خانمان در ایلینویز، مادران نوجوان یا دختران

^۱ . Bucy

^۲ . hational network of runaway and youth servieces

^۳ . on the street

^۴ . of the street

^۵ . Bond , Jiminez & Mazin

نوجوانی بودند که حامله بوده و در شرف مادر شدن بودند (همنز و لوک^۱، ۱۹۸۸). توبر^۲ (۲۰۰۱) دریافت که در حدود ۱۱/۳ درصد خانواده‌های موجود در پناهگاه‌ها در نیویورک (N=۷۷)، والدین نوجوان بودند. در زمینه‌یابی دیگری، توبر (۲۰۰۳) دریافت که سن ۴ درصد والدین بی‌خانمانی که در هتل مارتینیک در یک شهر پناهگاهی زندگی می‌کردند، زیر ۲۱ سال بود.

نیمرخ جمعیت‌شناختی نوجوانان بی‌خانمان در اقشار مختلف جامعه متفاوت است. برآورد شده که در آمریکا نیمرخ قومیتی نوجوانان بی‌سرپناه نشان‌دهنده جمعیت‌شناسی اجتماعی کل آن جامعه است (اداره کل سرشماری^۳، ۱۹۸۹). براساس برخی گزارش‌ها، احتمال فرار از خانه در نوجوانان دختر و پسر یکسان است (باردن^۴، ۲۰۰۰). با این حال، سایر مطالعات نشان داده‌اند که تعداد زنان پناهگاهی بیشتر است (رابرتسون، ۱۹۹۱ b). نوجوانانی که در “خیابان‌ها” زندگی می‌کنند، به احتمال زیاد پسرند و سن آنان بیشتر از آنهایی است که در “پناهگاه‌ها” زندگی می‌کنند (GAO, ۱۹۸۹). در حدود ۵۰ درصد نوجوانانی که از خانه فرار می‌کنند، در پرورشگاه‌ها بزرگ می‌شوند و از محله‌های فقیرنشین فرار کرده‌اند، به طوری که ۱۲ درصد آنهایی که در پرورشگاه بودند، درست قبل از سکونت در پناهگاه‌ها این کار را کرده‌اند (GAO, ۱۹۸۹). برای اینکه یک نوجوان در پناهگاه سکونت کند، سن او باید بین ۱۲ تا ۱۷ سال باشد و نوجوانان در ۱۸ سالگی به سیستم‌های پناهگاهی ارجاع داده می‌شوند.

بنابر نتایج پژوهش‌های صورت گرفته، نوجوانان بی‌خانمان در شهر خود می‌مانند، اما خیلی از آنان به مناطق شهری بزرگ‌تر مهاجرت می‌کنند. بیش از ۹۰ درصد نوجوانان بی‌سرپناه در نیویورک از نواحی اطراف آن شهر هستند (شافر و کاتون^۵، ۱۹۸۴). با این حال، کندی (۱۹۹۱) گزارش کرده ۷۸ درصد نوجوانانی که در مرکز پرورش نوجوانان خیابانی شهر سانفرانسیسکو زندگی می‌کنند، از اهالی مناطق و شهرهای دیگرند، در واقع ۳۸ درصد آنان از خارج کالیفرنیا آمده‌اند. بسیاری از نوجوانان دختر و پسر همجنس‌خواه، دوجنسیتی یا مشکوک به این موارد، جذب شهر سانفرانسیسکو می‌شوند، زیرا این شهر به شهر همجنس‌خواهان معروف است (روترا - بارس و همکاران، ۱۹۹۴).

نتایج مطالعه حسینیان (۱۳۸۳) در مورد خصوصیات جمعیت‌شناختی و خانوادگی ۱۰۰ نوجوان فراری دختر و پسر در شهر تهران نیز نشان می‌دهد که میزان تحصیلات این نوجوانان و والدین آن‌ها پایین بوده، والدین اکثر آن‌ها دچار سوءمصرف مواد هستند، این نوجوانان متعلق به جایگاه اجتماعی -

^۱. Hemmens & Luecke

^۲. Towber

^۳. General Accounting Office (GAO)

^۴. Barden

^۵. Shaffer & Caton

اقتصادی پایین هستند، وضعیت خانوادگی نابسامانی دارند و تعداد افراد خانواده آنان زیاد بوده است. به طوری که ۶۱ درصد این نوجوانان دارای تحصیلات راهنمایی بوده و ۸۷ درصد آنها متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین هستند و ۴۰ درصد آنها والدینشان از یکدیگر طلاق گرفته‌اند و ۴۴ درصد آنها دارای پدران معتاد به مواد مخدر و ۴۷ درصد آنها دارای مادران معتاد به مواد مخدر بودند.

عواملی که موجب بی‌خانمانی نوجوانان می‌شوند

نوجوانان بی‌خانمان، وقایع تنش‌زای زیادی را تجربه و گزارش می‌کنند و در عین حال فاقد خانواده حمایت‌کننده و کارآمد می‌باشند؛ این دو عامل شایع‌ترین عوامل مرتبط با بی‌خانمانی‌اند (روترا - بورس، ۲۰۰۳).

سعیدی (۱۳۷۲) در پژوهشی علل فرار نوجوانان از خانه را بررسی کرد. او دریافت که نوجوانان فراری بیشتر متعلق به خانواده‌هایی هستند که در آنها تنیدگی‌های زیادی وجود دارد. این تنیدگی‌ها شامل بدرفتاری با فرزندان، سوءرفتار جنسی در خانواده، فقر، رفتارهای خشونت‌آمیز، تعارضات خانوادگی، ضربه‌های عاطفی، طرد شدن از سوی والدین، تنبیهات و کیفرهای سخت، طلاق والدین و در کل وجود محیط نامساعد و تنش‌زاست. این محقق نابسامانی خانواده، سردی روابط عاطفی والدین، متارکه و طلاق، وجود ناپدری و نامادری، فقر فرهنگی و اقتصادی و اعتیاد را از مهم‌ترین عوامل برانگیزاننده تمایل به فرار در نوجوانان گزارش کرده است، به طوری که صد درصد (۱۰۰٪) نوجوانان فراری وضعیت خانواده را آشفته و نابسامان توصیف کردند.

تقوی و هاشمی (۱۳۸۳) نیز با استفاده از روشی کیفی عوامل مؤثر در فرار دختران از خانه را در شهر شیراز مورد بررسی قرار دادند. آزمودنی‌های پژوهش ۱۷ دختر فراری بودند که در فاصله اردیبهشت تا تیر ماه سال ۱۳۸۱ به مرکز مداخله در بحران شهر شیراز ارجاع داده شده بودند. نتایج پژوهش نشان داد:

- دامنه سنی آزمودنی‌ها بین ۱۲ تا ۲۹ سال بود و سن ۷۰ درصد آنها زیر ۲۰ سال بود.
- میزان تحصیلات آزمودنی‌ها حداکثر دیپلم بوده و ۶۰ درصد آنها دارای تحصیلات راهنمایی یا کمتر و ۸۲ درصد آنها اظهار کردند که تحصیلات خود را نیمه تمام رها کردند.
- ۷۷ درصد پدران و ۷۱ درصد مادران آنها بیسواد بوده و بقیه والدین از تحصیلات بسیاری پایینی برخوردار بودند.
- ۷۱ درصد آزمودنی با یکی از والدین خود زندگی می‌کردند.

- ۵۳ درصد از سرپرست خانواده آزمودنی‌ها بیکار و فاقد درآمد اقتصادی مشخص بودند.

- ۴۱ درصد از آزمودنی‌ها اظهار کردند که حداقل یکی از والدینشان معتاد است.

در پژوهش دیگری ابوالفتحی و همکاران (۱۳۸۵) با استفاده از یک رویکرد کیفی و پدیدارشناختی زنان و دختران فراری ارجاع داده شده به مرکز مداخله در بحران‌های اجتماعی اصفهان را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد محدوده سنی این زنان و دختران بین ۱۳ تا ۳۲ سال و میانگین سن آن‌ها برابر با ۱۸/۶ سال بود. ۶۰ درصد آنان سابقه فرار از منزل داشته و ۹۰ درصد آنان دارای افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی قبل از فرار از منزل بودند. ۷۰ درصد آن‌ها بیکار بوده و سرپرستان آن‌ها دارای مشاغلی چون کارگری، کشاورزی و عدم شغل ثابت بودند. براساس نتایج مصاحبه ساختار یافته و عمیق انجام شده با آزمودنی‌ها محققان دریافتند که این افراد پس از تجربه حوادثی چون فقر، اعتیاد در خانواده، طلاق، بیکاری، خشونت‌های جسمی و روحی، جنگ و نزاع در درون خانواده، از دست دادن مسکن، شکست در تحصیل و ازدواج ناخواسته دچار احساساتی چون ناتوانی در تصمیم‌گیری، سربار بودن، رسیدن به بن‌بست، سردرگمی، تنهایی، پوچی، فلاکت، بی‌هویتی، بی‌کسی، زندانی بودن، عقاید خودکشی و دیگرکشی شده و این موارد به نوبه خود در آن‌ها آشفتگی روانی ایجاد می‌کند. پس از ورود به مرحله آشفتگی روانی نیز ممکن است اقدام به فرار از خانه با اشکال مختلفی که از لحاظ آگاهی و اخطار دادن قبل از فرار، بُعد مسافت فرار از خانه و زمان فرار متفاوت است، نمایند و پس از فرار معمولاً احساس رضایت و یا رضایت توأم با ندامت داشته ولی پس از مدت اندکی در برآورده کردن نیازهای اولیه و حیاتی با مشکل روبرو شده که منجر به تجربه انواع حوادث پس از فرار همچون خشونت‌های جسمی، جنسی و روحی و حتی استثمار جنسی می‌شوند که تقریباً احتمال بهبودی و بازگشت به خانه و خانواده را غیرممکن می‌کند.

نوجوانانی که در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که دچار بدکارکردی هستند، خاتمه دادن به زندگی در این خانواده‌ها خیلی بهتر و راحت‌تر از تلاش برای حل مشکلاتی است که تقریباً حل آن‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد (بوکی و اوبولنسکی^۱، ۲۰۰۴). از میان تنش‌زاهای خانوادگی، که ۳۰ درصد نوجوانان فراری اظهار کرده‌اند دلیل فرار آنان بوده است، می‌توان به مرگ یا بیکاری اعضای خانواده یا طلاق و جدایی آنان در سه ماه قبل اشاره کرد. ۱۱ درصد این نوجوانان گفته‌اند که والدین آنان بیکار شده و والدین ۲۸ درصد آنان جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند یا طلاق گرفته‌اند. به گزارش شبکه جهانی سازمان جوانان فراری، در حدود ۷۰ درصد نوجوانان فراری ساکن در پناهگاه‌ها به‌صورت اجباری از نظر فیزیکی و جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. نوجوانان فراری علاوه بر

^۱ . Bucy & Obolensky

مشکلات خانوادگی، به مشکلات تحصیلی، مدرسه و همسالان نیز اشاره کرده‌اند. برای مثال، ۳۲ درصد آنان اشاره کرده‌اند که طی سه ماه قبل مدرسه خود را عوض کرده‌اند، ۴۰ درصد آنان مردود شده‌اند، ۴۰ درصد آنان با معلم خاصی مشکل داشته‌اند و ۲۳ درصد آنان از مدرسه اخراج شده‌اند.

بازیاری میمندی، رسول‌زاده طباطبایی و آزاد فلاح (۱۳۸۲) در یک مطالعه پس‌رویدادی به مقایسه عوامل تنش‌زا و شیوه‌های مقابله‌ای دختران فراری و عادی شهر تهران پرداختند. آزمودنی‌های این پژوهش را ۴۵ دختر فراری ۱۵ تا ۲۵ ساله‌ای که در زندان اوین، مراکز نگهداری سازمان بهزیستی (مرکز آصف و ارشاد و مرکز مداخله در بحران منطقه شمال) و کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برند و ۴۵ دختر غیرفراری ۱۵ تا ۲۵ ساله‌ای که در دبیرستان‌های شهر تهران مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. ابزارهای این پژوهش نیز شامل مقیاس رویدادهای زندگی نوجوانان هولمز و راهه و پرسشنامه شیوه‌های مقابله با عوامل تنش‌زای موس و بیلینگز^۱ بود. داده‌های جمعیت‌شناختی این پژوهش نشان داد که دامنه سنی دختران فراری بین ۱۵ تا ۲۴ سال است که در این دامنه، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سالگی بیشترین درصد را (۵۵ درصد) به خود اختصاص داده‌اند. از نظر میزان تحصیلات مشاهده شد که ۴۴ درصد آنان تحصیلات متوسطه، ۳۶ درصد تحصیلات راهنمایی، ۱۳ درصد تحصیلات ابتدایی داشتند و ۴ درصد هم بی‌سواد بودند. ۹۱ درصد این دختران فراری مجرد بودند و ۵۹ درصد آنان سابقه دستگیری، زندان و بازپروری داشتند و ۴۷ درصد آنها سیگار و ۱۸ درصد هم مواد مخدر مصرف می‌کردند. داده‌های توصیفی نشان داد که بالاترین میانگین میزان عوامل تنش‌زا (۳۴/۶) مربوط به گروه دختران فراری است و این میانگین در دختران عادی برابر با ۱۴/۰۴ است. همچنین مشاهده شد که بالاترین فراوانی عوامل تنش‌زا در دختران فراری به ترتیب مربوط به عوامل فرار، ارتکاب به گناه و قطع ارتباط با یک دوست صمیمی است و در دختران عادی به ترتیب مربوط به عوامل تنش‌زای از دست دادن یک شانس یا فرصت خوب، عدم حضور در مدرسه به دلیل بیماری و قهر کردن با خواهر و برادر است. یافته‌ها نشان داد که ۹۳ درصد دختران فراری از شیوه‌های مقابله‌ای هیجان‌مدار و ۷ درصد آنان از شیوه‌های مقابله‌ای مسئله‌مدار استفاده کرده‌اند، درحالی‌که ۷۳ درصد دختران عادی از شیوه مقابله‌ای هیجان‌مدار و ۱۶ درصد آنان از شیوه مقابله‌ای مسئله‌مدار استفاده کرده‌اند. این گزارش‌ها ما را رهنمون می‌کند که فرض کنیم بین وقایع تنش‌زای موجود در خانواده‌ها و زندگی تحصیلی نوجوانان و فرار آنان از خانه رابطه تنگاتنگی وجود دارد.

چاوشی‌فر و رسول‌زاده طباطبایی (۱۳۷۹) به بررسی مقایسه‌ای عوامل تنش‌زا و شیوه‌های رویارویی در نوجوانان مراکز شبانه‌روزی و نوجوانان دارای والدین پرداختند. بدین منظور ۵۰ نوجوان

^۱. Moos & Billings

۱۴ تا ۱۷ ساله ساکن در مراکز شبانه‌روزی و ۵۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله مشغول به تحصیل در مدارس شهر تهران را به صورت تصادفی انتخاب و مطالعه کردند. ۶۶ نفر این آزمودنی‌ها دختر و ۳۴ نفر آنان پسر بودند. نتایج نشان داد که میزان تنیدگی نوجوانان مراکز شبانه‌روزی بیشتر از نوجوانانی که با والدین خود زندگی می‌کردند، بود و هنگام رویارویی با تنیدگی‌ها بیشتر از مقابله‌های هیجان‌مدار استفاده می‌کردند.

عوامل و رفتارهای خطرآفرین نوجوانان بی‌خانمان

نوجوانان بی‌خانمان، اعمال خطرآفرین زیادی را تجربه می‌کنند. استرس و تنش که این نوجوانان تجربه می‌کنند، ناشی از رفتارهای مشکل‌آفرین آنان است و آنها را در معرض نتایج منفی بلندمدتی قرار می‌دهد. با این حال، بسیاری از این رفتارها راهبردهایی هستند که نوجوانان فراری از آنها برای حفظ و بقای خود، در حین زندگی در خیابان‌ها استفاده می‌کنند (برای مثال، روی آوردن به فحشا برای تأمین غذا یا سرپناه).

در بسیاری از موارد، این نوجوانان مشکلاتی را برای ارضای ضروری‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای خود مانند داشتن سرپناه، نیاز به غذا، امنیت و سلامت دارند. پنجاه درصد مشکلاتی که آنها با آن مواجه‌اند، مربوط به تأمین غذا و لباس است (رابرتسون، ۲۰۰۴). خیلی از آنها حتی در تسهیلات عمومی، سرپناهی پیدا نمی‌کنند، زیرا اغلب ظرفیت این تسهیلات عمومی تکمیل شده است. بیشتر این نوجوانان مجبورند در جاهایی زندگی کنند که سکنی گزیدن در آن مکان‌ها از نظر نیروی پلیس غیرقانونی است (گرین بلات^۱ و رابرتسون، ۱۹۹۳). در مطالعه‌ای مشاهده شد که سه ماه قبل از اینکه نوجوانان خیابانی بتوانند جایی را برای زندگی در نیویورک‌سیتی پیدا کنند، بیست درصدشان از نظر فیزیکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، بیست درصدشان از نظر جنسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند، بیست درصدشان مورد سرقت واقع شده بودند یا دست به سرقت زده بودند (توبر، ۲۰۰۳).

بیماری‌های حاد و شدید در نوجوانان فراری، بیشتر دیده می‌شود تا در نوجوانان غیرفراری (یتس^۲ و همکاران، ۱۹۸۸)، به‌طوری‌که در حدود یک پنجم این نوجوانان فراری به بیماری خاص یا آسیب جدی مبتلا هستند (رابرتسون، ۲۰۰۴).

^۱ . Greenblatt

^۲ . Yates

شیوع ویروس و عفونت ایدز، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی را برای نوجوانان بی‌خانمان خاطرنشان می‌کند. در حدود ۴ درصد این نوجوانان به ایدز مبتلا می‌شوند (استریکوف، ناویک و کندی^۱، ۱۹۹۰). برآورد شده که بیش از ۸ درصد این نوجوانان در شهر سانفرانسیسکو مبتلا به ایدز خواهند شد (شالویتز^۲ و همکاران، ۱۹۹۰). این میزان بالای عفونت ایدز در میان نوجوانان بی‌خانمان به دلیل وجود سطح بالایی از ویروس HIV در میان شریک‌های جنسی آنهاست، به طوری که در حدود نیمی از این نوجوانان حداقل یک‌بار انجام رفتارهای خطرآفرین برای ابتلا به ایدز را گزارش کرده‌اند (رابرتسون، ۲۰۰۴). رفتارهای خطرناک جنسی در میان نوجوانان بی‌خانمان بیشتر از نوجوانان دارای سرپناه است، زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که نوجوانان بی‌خانمان برای ادامه زندگی در روابط جنسی درگیر شوند. ۲۰ درصد نوجوانان فراری در لس‌آنجلس برای ادامه زندگی تن به روابط جنسی می‌دهند، در حالی که این میزان برای نوجوانان غیرفراری برابر با ۰/۲ درصد است (یتس و همکاران، ۱۹۸۸). داشتن چندین شریک جنسی به طور همزمان یکی دیگر از مشخصه‌های این گروه از نوجوانان است. در نیویورک سیتی، ۴۷ درصد پسران و ۱۶ درصد دختران فراری، داشتن ۱۰ شریک جنسی از جنس مخالف یا بیشتر را گزارش کرده‌اند. یکی از یافته‌های تکان‌دهنده و هشداردهنده در مورد جوانان فراری، عدم استفاده آنان از کاندوم هنگام برقراری رابطه جنسی است. در حدود ۳۸ درصد از دختران و پسران فراری شهر نیویورک گزارش کرده‌اند که هرگز از کاندوم استفاده نمی‌کنند (روترا - بورس و همکاران، ۱۹۹۲).

علاوه بر ابتلا به ویروس HIV، رفتارهای جنسی نوجوانان فراری آنان را بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مقاربتی جنسی و حاملگی قرار می‌دهد. در حدود ۵۰ تا ۷۱ درصد این نوجوانان خیابانی، ابتلا به یکی از اختلالات مقاربتی را گزارش کرده‌اند (شالویتز و همکاران، ۱۹۹۰). در نیویورک، ۲۵ درصد دختران فراری یک مورد حاملگی را طی سه ماه گذشته (در زمان پژوهش) گزارش کرده‌اند (روترا - بورس و همکاران، ۱۹۹۴).

یکی از مشکلات مرتبط با این رفتارهای خطرآفرین جنسی در این نوجوانان، مصرف زیاد مواد است. بیش از ۵۰ درصد نوجوانان پسر بی‌خانمان لس‌آنجلس بیشتر اوقات یا همیشه هنگام انجام عمل جنسی برای ادامه زندگی خود از مواد استفاده کرده بودند (پنبریج، فریس و مک کانزی^۳، ۱۹۹۲). فرار از خانه در اوایل نوجوانی با مصرف مواد و الکل همبستگی دارد (ویندل^۴، ۱۹۸۹).

^۱. Stricof, Novick & Kennedy

^۲. Shalwitz

^۳. Pennbridge, Freese & MacKenzie

^۴. Windle

نیویورک، ۱۹ درصد دختران و پسران فراری مصرف کوکائین و هروئین، ۴۳ درصد آنان مصرف ماری‌جوانا و ۷۱ درصد مصرف الکل را گزارش کرده‌اند (کوپمن^۱ و همکاران، ۱۹۹۴).

استفاده همزمان از مواد و الکل نیز در این نوجوانان بسیار زیاد است. یک چهارم نوجوانان بی‌خانمان، استفاده همزمان از الکل و مواد را گزارش کردند (آپشار^۲، ۲۰۰۳). نوجوانان بی‌خانمان که مشکل مصرف الکل دارند، در سنین کمتری مصرف الکل را شروع کرده‌اند، اختلالات اجتماعی بیشتری دارند و نسبت به نوجوانان دارای سرپناه، به‌دفعات بیشتری از الکل استفاده می‌کنند (رابرتسون، ۱۹۸۹ a, b). این نوجوانان تاریخچه‌ای از درگیری و زد و خورد دارند، به‌طوری‌که از خانه بیرون انداخته می‌شوند، در نتیجه، سابقه بیشتری در به‌دست آوردن درآمد از راه‌های غیرقانونی دارند.

رابطه بین رویدادهای تنش‌زا و سلامت روانی، به‌طورکامل روشن و اثبات شده است. با توجه به فشارهای روانی و تنیدگی‌هایی که در زندگی این نوجوانان وجود دارد، تعجبی ندارد که آنها در معرض خطر زیادی برای ابتلا به اختلالات روانی قرار گیرند. انگلندر^۳ (۱۹۸۴)، مشاهده کرد دختران فراری به‌طور معناداری عزت نفس کمتری از دختران دیگر دارند و به‌احتمال زیاد صفات نامطلوب اجتماعی را به خود نسبت می‌دهند. این دختران خانواده‌های خود را غیرحمایت‌کننده‌تر از پسران فراری ادراک می‌کنند. اگرچه نوجوانان بی‌خانمان از نظر اهداف، آمال و آرزوهای خود شبیه به نوجوانان دیگرند، اما احتمال بیشتری وجود دارد که احساس تنهایی کنند و تنها بمانند، کمتر در جمع دوستان و همسالان خود قرار گیرند و احساس کنند که هیچ حامی و پشتیبانی ندارند.

پژوهش خرم‌آبادی و طالبیان شریف (۱۳۸۵) از جمله پژوهش‌های داخلی است که به بررسی شیوه‌های حل مسأله، سبک‌های والدینی و منبع مهار در دختران فراری پرداخته است. آزمودنی‌های این پژوهش را ۳۰ دختر فراری ساکن در بهزیستی شهر تهران تشکیل می‌دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که سبک‌های والدینی دختران فراری مستبدانه و منبع کنترل این دختران بیرونی بود و در موقعیت‌های مسأله‌زا از شیوه‌های ناکارآمد حل مسأله استفاده می‌کردند.

در پژوهش دیگری حمیدی (۱۳۸۳) ساخت خانواده، سبک دلبستگی دختران فراری و اثربخشی خانواده درمانی و درمان حمایتی را در تغییر دادن آنها مورد بررسی قرار داد. گروه نمونه این پژوهش شامل ۵۰ نفر از دختران فراری در مجتمع قضایی ارشاد، مرکز مداخله در بحران بهزیستی، خانه ریحانه و کانون اصلاح و تربیت و خانواده‌های آنها بودند. محققان ابتدا ساخت خانواده و

^۱ . Koopman

^۲ . Upshur

^۳ . Englander

سبک دلبستگی این دختران فراری را مورد ارزیابی قرار دادند و سپس ۱۵ نفر از آنان را که دارای سبک دلبستگی ناامن و ساخت خانوادگی ناکارآمد بودند در گروه مداخلات درمانی خانواده درمانی سیستمی به همراه روان‌درمانگری حمایتی (درمان ترکیبی) قرار دادند. این گروه در ۱۰ جلسه درمانی ترکیبی شرکت کردند و سپس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد:

- ساخت خانواده دختران فراری ناکارآمد است و عملکرد آنها در سازه‌های "نقش‌های خانوادگی"، "ابزار عواطف" و "حل مشکل" پایین‌تر از هنجار جامعه است.
- توزیع سبک دلبستگی دختران فراری با جامعه بهنجار تفاوت معناداری دارد. به طوری که درصد سبک‌های دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا در آنها به ترتیب ۲۸ درصد، ۱۰ درصد و ۶۸ درصد می‌باشد.
- سبک دلبستگی دختران فراری با سبک دلبستگی مادرانشان رابطه مثبت و معنادار و با سبک دلبستگی پدرانشان رابطه‌ای مثبت و غیرمعنادار داشت.
- کاربرد خانواده درمانی به همراه درمانگری حمایتی به طور معناداری منجر به بهبود ساخت خانواده دختران فراری و عملکرد آنها در سازه‌های "نقش‌های خانوادگی" ابزار عواطف و "حل مشکل" شده است.

ماندی^۱ و همکاران (۱۹۹۰)، مشاهده کردند ۳۰ درصد نوجوانان بی‌خانمان، مبتلا به علائم روان‌پریشی‌اند. این نوجوانان در سطح بالایی به افسردگی و رفتارهای خودکشی مبتلا دارند. نوجوانان فراری در سطح بالایی مبتلا به اختلالات سلوکی‌اند و همیشه مشکلاتی را با مدرسه و تحصیل دارند. در حدود نیمی از نوجوانان فراری شهر نیویورک، از مدرسه اخراج شده یا ترک تحصیل کرده‌اند یا مردود شده‌اند. آنهایی هم که در مدرسه حضور پیدا می‌کنند، نمره‌های کم و پیشرفت تحصیلی بسیار ناچیزی دارند (رابرتسون، ۲۰۰۴).

زندگی در خیابان، بسیاری از نوجوانان بی‌خانمان را در گروه‌های جرم‌آفرین و مجرم درگیر می‌کند. در نیویورک، ۲۱ درصد نوجوانان فراری طی سه ماه گذشته (در زمان پژوهش) بیشتر وقت خود را در زندان گذرانده‌اند (روت‌رام - بورس و همکاران، ۱۹۹۱). بسیاری از رفتارهایی که سبب می‌شوند نوجوانان بی‌خانمان در جرم درگیر شده و با مراجع قضایی و قانونی درگیر شوند، مربوط به ارضای نیازهای اساسی آنان است (برای مثال دزدیدن پول برای غذا و دزدیدن لباس برای گرم نگاه‌داشتن خود). فراهم کردن کار برای آنها، راه‌حل فوری برای مقابله با مشکل آنان نیست، زیرا سن بسیاری از آنها برای کار کردن هنوز قانونی نیست. در حدود ۴۰ درصد نوجوانان بی‌خانمان گزارش

^۱ . Mundy

کرده‌اند که درآمد آنها از راه‌های غیرقانونی تأمین می‌شود و ۲۰ درصد اظهار داشته‌اند برای به‌دست آوردن غذا و سرپناه به روابط جنسی تن می‌دهند و خودفروشی می‌کنند (رابرتسون، ۲۰۰۴).

کشف نقش‌های اجتماعی، شکل‌گیری هویت و تجربه روابط جنسی، مواد، الکل و سایر رفتارهای خطرناک، از ویژگی‌های بسیاری از نوجوانان است، اما نوجوانان فراری در سطح شدید و خطرناکی دست به این رفتارها می‌زنند و این کار را برای ادامه زندگی فلاکت‌بار خود انجام می‌دهند.

نوجوانان بی‌سرپناه، قربانی جامعه‌ای هستند که نه حمایتی برای آنان فراهم کرده و نه سرپرستی برای توجه به نیازهای آنان در اختیار آنان گذاشته است و آنها را برای ادامه زندگی و رفع نیازهای اولیه و ضروری خود تحت فشار قرار داده است. این قربانی شدن نه تنها عزت نفس آنان را پایین می‌آورد، بلکه ارزش خود آنان و نظرشان در مورد آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از این نوجوانان، زندگی را بی‌معنا، پوچ و زجرآور می‌دانند و معتقدند که باید از شر زندگی خلاص شوند. حتی بعضی از این نوجوانان تلاش دارند تا دیگران را نیز قربانی کنند، بنابراین این نوجوانان هم برای خود و هم برای جامعه خطرناکی را به‌بار می‌آورند.

پژوهش‌های موردی انجام‌شده در مورد نوجوانان بی‌خانمان

درک تجارب نوجوانان خیابانی برای کمک به نوجوانان برای ایجاد الگوهای ثابت زندگی با استفاده از تعاملات مثبت روزانه بسیار کلیدی است. به جای تأکید بر زندگی نوجوان در یک دوره زمانی، شاید بهتر باشد به روندی که وضعیت نوجوانان را در طول زمان شرح می‌دهد، تأکید داشته باشیم. اگرچه ممکن است مسیر زندگی نوجوانان دختر و پسر بی‌خانمان تغییر کند، اما حداقل ۶ گروه از نوجوانان بی‌خانمان وجود دارند که عبارتند از:

۱. آنهایی که والدین خود را در اثر مرگ یا طلاق از دست داده‌اند؛

۲. آنهایی که همجنس‌خواه‌اند؛

۳. نوجوانانی که مشکلات سلامت روانی طولانی‌مدت و پایداری دارند؛

۴. افرادی که توسط خانواده‌هایشان از خانه بیرون انداخته شده‌اند؛

۵. آنهایی که از نظر جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند؛

۶. نوجوانانی که مشکل مصرف مواد دارند.

همان‌گونه که اشاره شد، به‌طور معمول جوانان در چند مورد از این طبقات و مقوله‌ها قرار می‌گیرند، که این موضوع را در مطالعات موردی که در زیر ارائه می‌شود، مشاهده می‌کنید. این مطالعه‌های موردی از نوشته‌هایی استخراج شده‌اند که از سابقه خانوادگی و زندگی ۳۰۰ نوجوان

فراری که طی سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ به دنبال یافتن سرپناهی در نیویورک بوده‌اند، تهیه شده است. این نوجوانان در بدو ورود به پناهگاه ۱۲ تا ۱۷ ساله بوده و بین ۲ تا ۶ سال مورد مطالعه قرار گرفته‌اند (روت‌رام - بورس و همکاران، ۱۹۹۴).

از دست دادن والدین در اثر مرگ یا طلاق

نوجوانانی که در کودکی والدین خود را در اثر مرگ یا طلاق از دست می‌دهند، خانه را در سنین کم ترک می‌کنند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که خانواده‌های آنان موقعیت ثابتی را برای آنها ایجاد کنند. اگر مکان زندگی ثابتی برای این نوجوانان پیدا شود، زندگی آنها نیز تثبیت می‌شود. با این حال، اغلب یک خانه گروهی نیز برای آنان مشکل‌آفرین است. کارکنان این خانه‌های گروهی انتظارات غیرواقع‌گرایانه‌ای در مورد توانایی این نوجوانان برای پایبندی به نظام خانواده دارند، در نتیجه، انتظارات خود را از هر نوجوان به‌طور انفرادی و منحصر به فرد تنظیم نمی‌کنند. بنابراین، مسیرهای زندگی این نوجوانان ممکن است به‌صورت مشکل‌آفرینی ادامه یابد.

سرگذشت زندگی جانیس، نمونه‌ای از این زندگی است. وقتی جانیس ۱۰ ساله بود، مادرش مرد. او در ۱۵ سالگی شروع به پیش‌بینی‌های ناگوار در مورد آینده‌اش کرد. او پس از مرگ مادر با عمه‌اش زندگی می‌کرد، ولی با وجود مراقبت و توجهی که عمه‌اش به او می‌کرد، از مدرسه فرار کرد و پول از او دزدید. جانیس می‌گوید: “من به دنیا آمده‌ام تا او را دیوانه کنم و من هم مثل او دیوانه شوم”. جانیس و عمه‌اش توافق دارند که بهترین کار این است که او را در مدرسه شبانه‌روزی نگهداری کنند.

جانیس در مدرسه متلاطم و ناراحت بود. او مدرسه را دوست داشت، اما تنهایی و نداشتن هم‌صحبت و ملاقات‌کننده او را ناراحت می‌کرد، روزی که احساس خشم شدیدی کرد، به‌طور تکانشی مدرسه را ترک کرده و به طرف نیویورک حرکت می‌کند. سپس اتوبوسی که مربوط به ترمینال مرکزی بزرگ‌تری بود، سوار می‌شود. سپس در آنجا نوجوانانی را در خیابان‌ها می‌بیند که از طریق گوش‌بری و تیغ‌زدن دیگران و تن دادن به روابط جنسی و پرداختن به فحشا و فروش مواد پول درمی‌آورند. او می‌گوید، وقتی به آنجا رفتم، فقط مشاهده کردم و شخصاً دست به انتخاب زدم و تلاش کردم تا با افراد ناباب باشم و تمام این کارها را خودم انجام دادم.

او در این حین شروع به مصرف کوکائین کرده و می‌گوید: “هر کس دیگری هم بود، این کار را می‌کرد، من اولین روزی که کوکائین مصرف کردم، اصلاً اذیت نشدم، من می‌توانستم بروم و تمام شب را به جای خوابیدن از طریق خودفروشی پول دربیآورم. اما به زودی متوجه شدم که حامله شده‌ام و به خود گفتم یا نوزاد یا مواد، و نوزاد را انتخاب کردم”.

جانیس درحالی که حامله بود، شب را در خیابان‌ها می‌خوابید تا اینکه یک مددکار اجتماعی او را به اینجا منتقل کرد. این نقطه شروعی برای یک‌سری از زندگی‌های پناهگاهی او بود؛ از جمله خانه‌های گروهی، پناهگاه‌های فراریان و آپارتمان‌های رفاهی. او در طول دوره نوجوانی‌اش دوبار به دلیل حمله‌های عصبی در بیمارستان بستری شد، او خودش را فردی الکلی توصیف می‌کند، اما تصمیم گرفته از مواد استفاده نکند، اگرچه یک سال سابقه مصرف مواد داشته است.

جانیس، موردی از دختران فراری است که ابتدا بی‌خانمان و بعد یک کودک سازمانی شد و هم‌اکنون تصمیم دارد در امتحانات دبیرستان شرکت کند و می‌خواهد یک تکنیسین دارویی شود، اما در حال حاضر بچه‌های او تمام وقت او را پر کرده‌اند. هردو دختر او مبتلا به آسم و تنگی نفس‌اند و او پیوسته در حال رفت و آمد به بیمارستان است. زندگی او تقریباً تثبیت شده و او خود را خوشبخت می‌داند. او راه درازی را پیش‌رو دارد تا به اهدافش برسد و بسیار شاکر است که نتیجه آزمایش HIV او منفی بوده و رفتارهای جنسی خطرآفرینی که در خیابان‌ها داشته، او را مبتلا به ایدز نکرده است.

نوجوانان همجنس‌خواه

گروه دوم نوجوانانی که خانه را ترک می‌کنند یا از خانه بیرون انداخته می‌شوند، یا دارای تمایلات همجنس‌خواهانه‌اند یا درعمل با همجنس‌های خود روابط جنسی دارند. نوجوانان دختر و پسر همجنس‌خواه، با همسالان خود متفاوت‌اند و اغلب از فاش شدن این مسئله پیش دیگران می‌ترسند، بویژه از فاش شدن این موضوع نزد خانواده ترس زیادی دارند. بویژه اگر خانواده‌های آنان متوجه روابط جنسی آنها با همجنس‌هایشان شوند، آنان را از خانه بیرون می‌کنند (هانتر و اسکاشر^۱، ۱۹۹۰). باب تا سه سالگی در پرورشگاه بوده است. او خوشحال است که اکنون در یک خانواده دوست‌داشتنی زندگی می‌کند که از او و خواهرش نگهداری می‌کنند و زندگی راحت و باثباتی را برای آنها فراهم کرده‌اند. باب در مدرسه عملکرد خوبی داشته و شبکه‌ای از دوستان نزدیک داشته است و این منجر به گذراندن دوران کودکی طبیعی شد. او در حدود ۱۳ سالگی دریافت که تمایلات جنسی او همجنس‌خواهانه است. او به سادگی جذب پسرهای کلاس خود می‌شد و مجلاتی را که حاوی عکس‌هایی از پسران همجنس‌خواه بود، خریداری می‌کرد. بعد شروع به جست‌وجوی مکان‌هایی کرد که احتمالاً افراد همجنس‌باز در آنجا زندگی می‌کردند. اگرچه از نظر جنسی آزمایش نکرده بود، اما احساس می‌کرد که همجنس‌خواه است. وقتی یک خانواده تصمیم گرفتند باب و خواهرش را به فرزندی بپذیرند، باب احساس کرد که بهتر است تمایل جنسی خود را با آنها درمیان

^۱ . Hunter & Schaecher

بگذارد و در ۱۴ سالگی این موضوع را به والدین خود گفت. والدین او بسیار مذهبی بودند و سبک زندگی همجنس‌خواهانه برای آنان اصولاً قابل قبول نبود. باب بلافاصله از خانه طرد شد. او همچنین از مدرسه مذهبی بیرون انداخته شد. خانواده‌اش لباس‌ها، کتاب‌ها و عینک او را به حیاط پرت کردند. باب بی‌خانمان شد و ۲ تا ۳ شب را در خیابان خوابید. او از یک سازمان اجتماعی تشخیص همجنس‌خواهی کمک گرفت و پس از ۳ ماه با یک زوج همجنس‌خواه در پرورشگاهی در شهر دیگر اسکان یافت. او هیچ‌گاه به‌طور خودبه‌خودی تمایل جنسی خود را به همسالانش در مدرسه جدیدش بروز نمی‌دهد و کمتر اجتماعی است.

نوجوانان دارای مشکلات روانی حاد و مزمن

نوجوانانی که سابقه‌ای طولانی مدت از مشکلات روان‌پزشکی و مشکلات سلوکی دارند نیز ممکن است از خانه فرار کنند یا به اجبار از خانه بیرون انداخته شوند. جریان زندگی ویلیام، نشان‌دهنده مسیری است که یک نوجوان مبتلا به مشکلات سلوکی که از خانه بیرون انداخته شده است، طی می‌کند. زمانی که ویلیام ۱۰ ساله بود، شروع به فرار از مدرسه، اذیت و آزار در کلاس درس، دزدی از مغازه‌ها و سیگار کشیدن کرد. مادرش زن تنهایی بود که سه کودک کوچک‌تر دیگر نیز داشت. او به ویلیام گفت که نمی‌تواند او را کنترل کند و روز به روز بیشتر به تنبیه ویلیام می‌پرداخت. همان‌طور که به مشکلات سلوکی ویلیام اضافه می‌شد، مادرش ناامیدتر می‌شد. وقتی او ۱۳ ساله بود، مادرش به او گفت مجبور است خانه را ترک کند. آن شب وقتی برای تقاضای فرصت دیگری به خانه برگشته بود، مادرش قفل‌ها را عوض کرده بود که مبادا ویلیام دزدکی وارد خانه شود.

ویلیام شب اول را خارج از خانه و در خیابان سپری کرد و سپس از نوجوانان شنید که پناهگاه‌هایی برای فراریان وجود دارد. وقتی به او اجازه داده شد، یک سال در آنجا زندگی کرد. در طول این مدت تماس کمی با مادرش داشت. مادرش در جلسات روان‌درمانی اظهار کرد که نمی‌خواهد او را به خانه بازگرداند. او گفت که وقت زیادی صرف کنترل ویلیام کرده است، اما نتوانسته موفق شود. ویلیام بیشتر اوقات خود را در نزدیکی پناهگاه به سر می‌برد و با پسرهای همسایه‌ها پاتوق داشتند و دور هم جمع می‌شدند. در ۱۴ سالگی پلیس از ویلیام خواست که برای پیدا کردن دلال‌ها و فروشندگان مواد به آنها کمک کند، زیرا گفته بود که برای داشتن پول احساس فشار می‌کند. او مدت کوتاهی در مرکز نگهداری جوانان زندگی کرد و سپس به خانه گروهی منتقل شد. ویلیام در این زمان شروع به خرید و فروش مواد کرد و این کار را ادامه داد و در نتیجه از مدرسه اخراج شد. در ۱۷ سالگی، به‌هنگام حمل مواد غیرقانونی، دستگیر و زندانی شد. زندانی شدن

برایش بسیار سخت بود. اگرچه او قد بلند و قوی بود، باز هم چندین مرتبه قربانی خشونت شد و در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

وقتی ویلیام در ۲۰ سالگی از زندان آزاد شد، اگرچه زندگی در خارج از زندان را بسیار دوست داشت، اما دیدگاه بدبینانه‌ای داشت. او می‌گفت برای یک پسر سیاه‌پوست بدون تحصیل فقط دو گزینه وجود دارد: یا پرداختن به کارهای کثیف یا زندگی در خیابان‌ها. ویلیام به دنبال یافتن کاری رفت و شروع به برقراری ارتباط با دختران کرد. او در معرض خطرهای زیادی قرار دارد، از جمله ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و عفونت HIV، پیدا نکردن کار، ابتلا به بیماری‌های روانی مانند افسردگی و افکار خودکشی، درگیری در فروش مواد و غیره. او بیرون انداخته شد تا یک کودک سازمانی، فراری و سپس مجرم شود.

بی‌خانمانی ناشی از بی‌برنامه بودن خانواده

گروه زیادی از نوجوانان بی‌خانمان می‌شوند، زیرا در دوره کودکی و نوجوانی، خانواده آنها فاقد منابع شخصی برای تهیه نیازهای اساسی و اولیه زندگی‌اند (مثل سرپناه، غذا، دارو و لباس). نوجوانان در این خانواده‌ها به‌طور نسنجیده‌ای رها می‌شوند تا این منابع را برای خانواده‌ها یا برای خودشان تهیه کنند. افزایش مشکل خانواده‌های بی‌خانمان در مشکل بی‌خانمانی نوجوانان نقش بسزایی دارد. مورد مربوط به شون یکی از این موارد است:

وقتی مادر شون، آپارتمان محل سکونت خانواده را از دست داد، به پناهگاه بی‌خانمان‌ها منتقل شدند. سیاست پناهگاه نشان داده است که به کودکان کوچک، نه نوجوانان، اجازه زندگی داده می‌شود. کارکنان پناهگاه به شون کرایه قطار زیرزمینی دادند و او را در پناهگاه نوجوانان فراری جای دادند که با قطار زیرزمینی تا آنجا یک ساعت فاصله داشت. شون سعی می‌کرد تماس خود را با خانواده‌اش حفظ کند و انتظار داشت که مادرش به زودی یک آپارتمان پیدا کند. اما تماس بسیار سخت بود، زیرا مادرش تلفن نداشت و پیوسته از پناهگاهی به پناهگاه دیگری منتقل می‌شد. مشاور او پیشنهاد کرد که در خانه گروهی زندگی کند و بدین ترتیب زندگی پناهگاهی شون شروع شد.

شون در ۱۶ سالگی از مدرسه اخراج شد و زندگی را بسیار رنج‌آور و سخت دید. در پناهگاه، او همراه با دوستانش شروع به مصرف هروئین کرد. به‌زودی دریافت که هروئین برای او بسیار مشکل‌آفرین است و متوجه شد که پسرها در پناهگاه برای به‌دست آوردن هروئین تن به روابط جنسی با مردان می‌دهند. او نیز برای تأمین مواد خود دست به این کار زد. در همین حین او شروع به برقراری روابط عاشقانه با یک دختر پناهگاهی کرد. اما چند ماه بعد این دختر حامله شد و حاصل آن

تولد پسری بود. پس از چندی باردیگر آن دختر حامله شد و شون به او کمک کرد تا بچه‌هایشان را بزرگ کنند، تا اینکه دکتر شون پیشنهاد کرد که او آزمایش HIV بدهد و متأسفانه نتیجه آن مثبت بود. همسر شون با شنیدن این موضوع می‌خواست خودکشی کند. این فکر که با مرگ او و شون فرزندان‌شان یتیم و آواره خواهند شد، آزارش می‌داد و حتی بدتر از آن این فکر بود که هر ۴ نفر آنان در اثر ابتلا به ایدز خواهند مرد. او سپس به کمک مشاور توانست آزمایش ایدز بدهد و نتیجه آن هم برای خودش و هم برای فرزندان‌ش منفی بود. با این حال، همیشه افسرده و نگران بود، بویژه در حین برقراری روابط جنسی با شون. با وجود این، با اینکه از راه‌های انتقال ویروس HIV آگاه بود، تمایلی به استفاده از کاندوم نداشت.

آزار و اذیت جنسی

آزار و اذیت جنسی همیشه یکی از عوامل اصلی بی‌خانمانی در میان دختران نوجوان بوده است (بوکی، ۱۹۸۷). برآورد دقیق میزان این مشکل ممکن نیست. برآوردهایی که از تعداد نوجوانان بی‌خانمان شده، نشان می‌دهد هم در دختران و هم در پسرانی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند، میزان فرار از خانه بین ۲۳ تا ۷۰ درصد است (روترا - بارس و همکاران، ۱۹۹۱). به درستی، روشن نیست که میزان جوانان بی‌خانمانی که مورد سوءاستفاده جنسی واقع شده‌اند، زیاده‌تر است یا سایر نوجوانانی که در شرایط تنش‌زا زندگی می‌کنند (مثل آنهایی که همجنس‌خواه‌اند یا در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند). زندگی لاشل نمونه‌ای از داستان زندگی نوجوانانی است که بی‌خانمانی آنها مرتبط با قربانی شدن است.

لاشل می‌گوید، دوران کودکی‌اش مصادف با یک سری حوادث آزاردهنده بوده که یکی پس از دیگری رخ می‌داده است. لاشل وقتی ۱۲ ساله بود، پس از تجربه کردن چیزی که آن را «آخرین سر سوزن یا پرکاه» نامیده، از خانه بیرون انداخته شده است؛ یعنی درست وقتی که لاشل به مادرش گفته که شوهر جدید مادرش از نظر جنسی او را مورد آزار و اذیت قرار داده است، مادرش او را به‌دلیل دروغ‌گویی کتک زده و از خانه بیرون کرده است. لاشل وقتی به پناهگاه فراریان رسیده، بسیار افسرده و خشمگین بوده است. بعدها لاشل و مادرش بارها آشتی می‌کردند و لاشل به خانه بازمی‌گشت. اگرچه ناپدیری لاشل باز هم نسبت به او دید جنسی داشت. لاشل کابوس‌های وحشتناکی درباره این حادثه داشت و احساس ناامنی، عدم اطمینان و نگرانی می‌کرد.

لاشل در طول مدتی که افکار خودکشی داشت، دوره‌هایی از افسردگی را تجربه کرد و دریافت که ترک خانه بسیار مشکل است. او اقدام به خودکشی کرد و در بیمارستان روانی بستری شد و پس

از آن، در مرکز درمان شبانه‌روزی ساکن شد. او در آنجا احساس محدودیت می‌کرد و از طرف مادرش به او پیشنهاد شد که به خانه برگردد، اما امتناع کرد. او در پناهگاه ماند تا اینکه توانست آپارتمانی اجاره کند. در این زمان او حامله شد، درحالی‌که فقط ۱۷ سال داشت. رابطه او با دوست پسرش خشونت‌آمیز شد و دوست پسرش او را برای حامله شدن سرزنش کرد. او تردید داشت که بین این دو کار یکی را انتخاب کند، این کار که نوزاد او پدر داشته باشد و اینکه رابطه خود را با پدر نوزادش قطع کند.

او پس از اینکه فهمید پدر نوزادش، نوزاد را تهدید می‌کند، به آپارتمان مادرش برگشت. وقتی نوزاد او یک ساله بود، وارد کالج شد و دوره دبیرستان را تمام کرد. او امید داشت که برای کودکش یک الگو باشد، به‌طوری‌که کودک او دچار مشکلاتی که او با آنها مواجه شده است، نشود.

حسینیان و خدابخشی کولائی (۱۳۸۳) رابطه بین فرار دختران و سابقه بدرفتاری و خشونت جسمانی و سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی را در ۵۰ دختر فراری با میانگین سنی ۱۶-۲۰ سال ساکن در شهر تهران بررسی کردند. آنها با این دختران فراری مصاحبه‌ای ساختاریافته انجام دادند و دریافتند که ۱۲ درصد از این دختران فراری بی‌سواد، ۲۶ درصدشان دارای تحصیلات ابتدایی، ۵۶ درصدشان دارای تحصیلات راهنمایی و ۶ درصدشان دارای تحصیلات دیپلم بودند. ۸۰ درصد این دختران متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین، ۱۶ درصدشان از طبقات متوسط و ۴ درصد آنان از طبقات بالای جامعه بودند. از این ۵۰ دختر فراری، ۷۸ درصدشان در کودکی مورد بدرفتاری و خشونت جسمانی قرار گرفته بودند و ۳۶ درصدشان در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی واقع شده بودند. یافته‌ها نشان داد که بین آزار و اذیت جسمانی و فرار دختران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوءمصرف مواد

سوءمصرف مواد به‌تنهایی، بندرت دلیل بی‌خانمانی نوجوانان است. در مورد زیر که مربوط به مارتیناست، در ابتدا سوءاستفاده جنسی موجب شده که نوجوان خانه‌اش را ترک کند، اما پس از ترک خانه و بی‌خانمانی فرار از دام اعتیاد برای او مشکل شده است.

داستان زندگی مارتینا، داستان زندگی فرد بی‌خانمانی است که از نظر جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. مارتینا، دختر اسپانیایی ۱۶ ساله‌ای بود که در پناهگاه فراریان در نیویورک زندگی می‌کرد. او درباره ابتلا به ویروس ایدز نگران بود، اما از صحبت کردن در این مورد اجتناب می‌کرد. به‌نظر می‌رسید که ناخشنودی و نگرانی او با آموزشی که در پناهگاه در مورد ایدز دریافت کرده بود،

افزایش می‌یافت، زیرا از رفتارهای خطرآفرین خود در گذشته آگاه شده بود. او اظهار کرده بود که بیشتر اوقات بسیار خسته است و نمی‌خواهد به مدرسه برود.

مارتینا در دوران کودکی از طرف پدرش مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته بود، اما در ۹ سالگی پدرش از او سوءاستفاده جنسی هم کرده بود. او در ۱۰ سالگی حامله شد و نوزاد خود را به پرورشگاه سپرد. او در ۱۳ سالگی می‌خواست به مرکز پرورشگاهی بیاید و در آنجا زندگی کند. اما در ۱۴ سالگی شروع به زندگی در خیابان کرد. او از انواع مواد استفاده می‌کرد. موادی نظیر هروئین و LSD. او می‌گفت که هرگز مواد را ترک نمی‌کند. در ۱۵ سالگی، شروع به خودفروشی کرد و با مرد غریبه‌ای می‌خوابید که مصرف‌کننده مواد با استفاده از تزریق وریدی بود. او درباره زندگی خود بسیار نگران بود، به‌همین دلیل دچار افسردگی شدیدی شد و اقدام به خودکشی کرد و چند ماه در بیمارستان روانی بستری شد. پس از اینکه از بیمارستان مرخص شد، تشویق شد که توسط روان‌شناس در پناهگاه مشاوره شود، اما امتناع کرد. به هنگام مصاحبه، او یک ماه بود که با دوست پسرش آشنا شده بود و می‌گفت که آن پسر واقعاً او را دوست دارد. او هنگام مقاربت با دوست پسر خود از کاندوم استفاده نمی‌کرد، زیرا می‌ترسید آن پسر فکر کند که او در گذشته با مردهای زیادی رابطه جنسی داشته است. پس از قطع رابطه با این پسر که گاهی او را اذیت و تهدید می‌کرد، تصمیم گرفت به دبیرستان برود و مدرک معادل بگیرد.

تمام نوجوانانی که مواد مصرف می‌کنند، با پیامدهای منفی‌ای مواجه نمی‌شوند. با این حال، مورد کارول، مسیر و روند مثبتی را نشان می‌دهد. کارول، زن اسپانیایی ۲۰ ساله و دانشجوی پرستاری است. کارول ۵ سال بی‌خانمان بود و به‌عنوان فاحشه بیشتر اوقات مواد مصرف می‌کرد. با این حال، ۳ سال قبل اعتیادش را ترک کرد و وارد فعالیت سیاسی شد و علیه فروشندگان مواد مخدر فعالیت می‌کرد. او باهوش بود و توانایی کلامی زیاد و اهداف روشن و مشخصی داشت. یک سال قبل از مصاحبه با وی، با وجود رفتارهای خطرآفرینی که در گذشته داشت، نتیجه آزمایش HIV او منفی بود. کارول وارد رشته پرستاری شد و به فعالیت سیاسی خود علیه اعتیاد به مواد ادامه داد. هدف او این بود که با نوجوانان فراری و بی‌خانمان کار کند که از نظر او بسیار نیازمند کمک بودند. کارول به آینده بسیار خوش‌بین بود.

مواردی که به آنها اشاره شد، کاملاً جامع نبودند، با وجود این، داستان زندگی این نوجوانان نشان‌دهنده دامنه، وسعت و تنوع چالش‌های اولیه‌ای است که موجب بی‌خانمان شدن نوجوانان می‌شوند.

خدمات اجتماعی به نوجوانان بی‌خانمان

نیاز به خدمات اجتماعی

ایالت متحده آمریکا، از جمله کشورهایی است که از احکام سازمان ملل در مورد حقوق اساسی کودکان در مورد داشتن غذا، پناهگاه و مراقبت بهداشتی در محیطی امن و سالم تا ۱۸ سالگی حمایت می‌کند (قطعنامه سازمان ملل درباره حقوق کودکان^۱، ۱۹۹۱). با این حال، هیچ تلاش جدی و منسجمی برای رسیدن به این اهداف در این کشور صورت نگرفته است. بین برآوردهایی که از تعداد نوجوانان بی‌خانمان در آمریکا شده و تعداد پناهگاه‌ها، آسایشگاه‌ها و خدمات اجتماعی قابل دست‌یابی برای این نوجوانان، شکاف بزرگی وجود دارد (آکادمی ملی علوم^۲، ۱۹۸۸).

مسئله نگران‌کننده‌تر اینکه، انتقال این نوجوانان به اماکن موجود برای زندگی طولانی‌مدت مشکل است. تعداد مکان‌های اسکان موقتی خیلی بیشتر از تعداد خانه‌های گروهی بلندمدت، ثابت و اماکن پرورشگاهی است. علاوه بر این، سیستم‌های موجود خدمات اجتماعی تصور می‌کنند که بیشتر نوجوانان بی‌سرپناه در ۱۸ سالگی قادرند از خود مراقبت کنند. برای زندگی مستقل برنامه‌های کمی وجود دارد (برای مثال برنامه‌های زندگی انتقالی که از نوجوانان تا ۲۱ سالگی حمایت کمی می‌کنند).

آمارهای به‌دست آمده از شهر نیویورک، نشان‌دهنده فقدان خانه‌های انتقالی ثابت برای نوجوانان است. شافر و کاتون^۳ (۱۹۸۴) برآورد کرده‌اند که در حدود ۹,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ نوجوان بی‌خانمان در نیویورک وجود دارد. براساس برآورد پلیس، در سال ۱۹۸۵ این تعداد در هر سال برابر با ۲۰,۰۰۰ نفر است (شبکه ملی نوجوانان فراری^۴، ۱۹۸۵). بیش از ۸۵ درصد این نوجوانان، هرگز به خانه‌های خود بازنگشته‌اند (روترا - بوریس، کوپمن و ارهاردت^۵، ۱۹۹۱). داده‌های دیگری نشان می‌دهند که حداقل ۳,۰۰۰ نوجوان فراری و بی‌خانمان وجود دارند که برای آنها هیچ مکان ثابتی برای زندگی وجود ندارد. این موضوع فقط منحصر به شهر نیویورک نیست، بلکه مشکلی است که در هر یک از مراکز شهری بزرگ آمریکا وجود دارد، برای مثال در لس‌آنجلس برآورد شده که احتمال بازگشت به خانه فقط در مورد ۱۹ درصد نوجوانان در پناهگاه‌ها وجود دارد (راتمن و دیوید^۱، ۱۹۸۵).

^۱. united nations convention on the rights of the child

^۲. national academy of sciences

^۳. Shaffer & Caton

^۴. national network of runaway youth

^۵. Koopman & Ehrhardt

^۱. Rothman & David

به‌طور کلی، پیوستاری از مراقبت وجود دارد که برای برآورده ساختن نیازهای نوجوانان بی‌خانمان ضروری است. حداقل ۶ نوع خدمات برای نوجوانان بی‌خانمان وجود دارد که باید ادامه پیدا کند و به‌طور ایده‌آل توسعه یابد. این خدمات عبارتند از:

۱. پناهگاه‌های اضطراری کوتاه‌مدت. کنگره آمریکا در سال ۱۹۷۴ به عنوان نتیجه‌ای از اقدام به فرار و بی‌خانمانی نوجوانان، اقدام به ایجاد شبکه ملی برای تأسیس پناهگاه‌های مسکونی کوتاه‌مدت برای نگهداری حدود ۳۰۰,۰۰۰ نوجوان به‌طور سالیانه کرد. درحالی‌که ارائه‌دهندگان خدمات، اظهار کردند که تعداد نوجوانان بی‌خانمان در حال افزایش است، بودجه آنها قطع شد. برای مثال، در یک دوره ۱۲ ماهه در لس آنجلس، ۶۵ درصد از ۴۵۰۰ مورد تقاضای زندگی در پناهگاه، رد شد، زیرا فضای کافی موجود نبود (پنبریج و همکاران، ۱۹۹۰). این کوتاهی و قصور در ارائه خدمات، منجر به انتخاب از میان نوجوانان بی‌سرپناه برای زندگی در پناهگاه‌های اضطراری شد. از این‌رو اغلب هیچ مکان ثابتی برای نوجوانان بی‌سرپناه قابل دسترسی نبود و خیلی از آنان برای مدتی طولانی در پناهگاه‌های اضطراری موقتی زندگی می‌کردند. در پناهگاه‌های موقتی، یک مددکار اجتماعی وجود دارد که تلاش می‌کند تا نوجوان را با خانواده‌اش آشتی دهد، یک پرستار کودک وجود دارد که ۲۴ ساعت در هر شبانه‌روز بر نوجوانان نظارت می‌کند و همچنین کارمندی که سرایدار است (برای مثال یک آشپز). نوجوان در آنجا برنامه روزانه دارد که شامل «ملاقات‌کننده خانگی» است و طی آن تکالیفی را برای تسهیل مکان ثابت و دائمی به او ارائه می‌دهد (مانند رفتن به مدرسه). در گذشته، پناهگاه‌ها به‌صورت سازمان‌هایی بودند که خدمات کامل‌تری را ارائه می‌دادند (مراقبت‌های پزشکی، مراقبت‌های روانی، برنامه‌های شغلی و تحصیلی) (کندی، ۱۹۹۱)، اما امروزه سازمان‌های کمی وجود دارند که خدمات کاملی ارائه می‌کنند.

۲. خدمات درمانی و برنامه‌های منحصر به فرد. تعداد نوجوانان بی‌خانمانی که به خدمات و برنامه‌های خاص نیازمندند، زیاد است. برنامه‌های منحصر به فرد برای نوجوانانی طراحی شده‌اند که در یکی از شرایط زیر قرار دارند: آنهایی که می‌خواهند با ترک اعتیاد کنار بیایند؛ افرادی که در خانه زندگی می‌کنند، اما در معرض خطر بیرون انداختن از خانه قرار دارند؛ نوجوانانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند؛ آنهایی که همجنس‌خواه‌اند؛ افرادی که توسط دوست پسرشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند؛

والدین نوجوان و کم سن و سال؛ آنهایی که به HIV مبتلا هستند؛ نوجوانانی که دست به خودفروشی و فحشا می‌زنند و آنهایی که قربانی خشونت‌ها هستند.

۳. رویکردهای خدمات جامع. هرگاه هدف ارائه خدمات مراقبتی جامع است، حل مشکلات فرد، موضوع اصلی برنامه است. نوجوانان بی‌خانمان نیازهای چندگانه‌ای دارند؛ تشخیص و هماهنگی خدمات مختلف در میان شبکه‌ای از ارائه‌کنندگان خدمات برای موفقیت در ارائه طرح درمانی با نتایج مثبت بسیار کلیدی و مهم است. دو موضوع اساسی در تعریف رویکرد خدمات جامع وجود دارد؛ اول، مفهوم یک رویکرد کل‌گرا به نوجوانان که به معنای ارائه خدمات سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی است. با این حال، بیشتر سازمان‌ها نمی‌توانند تمام نیازهای خدمات اجتماعی را برای یک فرد ارائه کنند. از این رو سازمان‌های مؤثری که تلاش دارند رویکردی کل‌گرا ارائه دهند، باید در درون جامعه به‌طور مناسب شبکه‌بندی و توزیع شوند و بخشی از یک فرایند برنامه‌ریزی اجتماعی باشند که نوع مشکلات را مشخص و موقعیتی را تعیین کنند که فرد متخصص بتواند به بهترین وجه این مشکل را حل کند. ارائه‌دهندگان خدمات به‌راحتی می‌توانند نوجوانان را به مراقبت در سایر جاها ارتباط دهند. دومین معنای اصطلاح «جامع» این است که در مراقبت تداوم وجود داشته باشد و این تداوم تا زمانی که در زندگی نوجوان ثبات ایجاد شود، ادامه خواهد یافت. هر دو رویکرد کل‌گرا و تداوم در مراقبت، در ارزشیابی از مراقبت از نوجوانان بی‌خانمان، اهمیت دارند.

۴. نظام‌های آموزشی و پرورشی خاص. نوجوانانی که سابقه فرار از خانه دارند، به‌طور معمول در مدرسه معمولی مشکلاتی دارند و احتمال زیادی وجود دارد که به آموزش و برنامه‌های آموزشی و پرورشی خاصی نیازمند باشند (روترا - بورس، روزاریو^۱ و کوپمن، ۱۹۹۱). یک مورد از نظام‌های آموزشی طراحی شده برای برآورده کردن نیازهای نوجوانان بی‌خانمان، راه‌اندازی مدرسه در درون پناهگاه‌های اضطراری است (زاکر^۲، ۱۹۹۴). این راه‌حل با پشتیبانی مدارس منطقه‌ای، منجر به ایجاد دبیرستان‌هایی برای نوجوانانی می‌شود که مشکلاتی را در سازگاری با برنامه‌های معمولی و روزانه ساختاریافته در محیط‌های کلاس معمولی دارند. این مدارس اغلب ساختار کمتری دارند، برای فعالیت‌های شغلی و استخدامی امتیاز دارند، قانون پوشیدن لباس راحت‌تری دارند و برای فارغ‌التحصیلی اولیه جداول زمانی با مسیر سریع و تند دارند.

^۱. Rosario

^۲. Zucker

۵. مکان‌های مسکونی ثابت. بسیاری از نوجوانان بی‌خانمان، مکان‌های پرورشی ضعیف و محیط‌های خانوادگی توأم با مشکل را ترک کرده‌اند. برای این نوجوانان، برگشت به خانه امکان‌پذیر نیست. این نوجوانان باید یا در خانه‌های پرورشگاهی، یا در خانه‌های گروهی، ساکن شوند، اما اغلب پیدا کردن چنین جایی برای آنها مشکل است. بویژه پسران و نوجوانانی که سابقه مشکلات سلوکی یا مصرف مواد دارند. اگر افرادی وجود داشته باشند که بتوانند آنها را به فرزندخواندگی قبول کنند، باید مهارت‌های زیادی برای حل مشکل داشته باشند. با این حال، والدین پرورش‌دهنده اغلب آموزش ندیده‌اند تا به‌طور مؤثری با مشکلات چندگانه این نوجوانان دست و پنجه نرم کنند. بنابراین خانه‌های گروهی که کارکنان آن آموزش بهتری دیده‌اند و تجربه بیشتری در مورد این نوجوانان دارند، مکان مطلوبی برای این نوجوانان بی‌خانمان است. با این حال، متأسفانه خیلی از موقعیت‌های خانه‌های گروهی به شکل دیگری می‌توانند مشکل‌آفرین باشند. اگر نوجوان خشونت‌طلب، در خانه گروهی اجازه اسکان بگیرد، اسکان توأم با امنیت سایر نوجوانان پناهگاه را به مخاطره می‌اندازد. این نوجوانان که از محیط‌های خانگی ضعیف فرار کرده‌اند، در فرار از محیط‌های خانه‌های گروهی شک و تردید دارند. باید محدودیت‌های موقعیتی را در مورد نوجوانان دارای مشکل به‌عنوان فرایند تحولی و تکاملی در نظر بگیریم که طی آن نوجوانان و مراقبت‌کنندگان آنها قواعد و انتظارات را با یکدیگر به بحث و گفت‌وگو می‌گذارند. اگر قواعد و مقررات، سخت و غیرقابل‌انعطاف باشند، احتمال اینکه نوجوانان آنان را رعایت کنند، بسیار کم و حتی غیرممکن است. طراحی الگوسازی‌های تحولی پیچیده از قواعد و قاعده‌های رفتاری پناهگاه‌ها مشکل است و به‌کارگیری آنها در زندگی روزمره نوجوانان حتی از آن هم مشکل‌تر است. با این حال، برای پیگیری و ادامه برنامه‌های مؤثر لازم و مورد نیاز است.
۶. انتخاب زندگی مستقل و انتقالی برای جوانان ۱۸ تا ۲۱ ساله. بیشتر نوجوانانی که مشکلات زیادی دارند و در پرورشگاه زندگی می‌کنند، بزرگسالانی می‌شوند که در ۱۸ سالگی کار و محل زندگی ثابتی ندارند. با این حال، اغلب نوجوانان ۱۸ ساله فاقد صلاحیت و شرایط لازم برای استفاده از خدمات اجتماعی محسوب می‌شوند. روان‌شناسان معتقدند خطری در مورد انتقال‌های تحولی خاص وجود دارد. از این‌رو نیاز به خدمات انتقالی به نوجوانان ۱۸ تا ۲۳ ساله که در حال انتقال به دوره بزرگسالی هستند، بسیار مبرم است. خدمات انتقالی اغلب متشکل از یک خانه در محله‌ای

فقیرنشین است که ۸ تا ۱۰ نوجوان در آن زندگی می‌کنند. در این خانه‌ها والدین خاصی وجود دارند که آموزش‌های خاصی برای کار با نوجوانان در معرض خطر دیده‌اند. قواعد توسط ساکنان خانه و بزرگسالانی که بر آنها نظارت دارند، تدوین می‌شود. نوجوانان تا زمانی که در این خانه‌ها زندگی می‌کنند، باید رفتار خوبی داشته باشند و در جهت رسیدن به هدف زندگی مستقل حرکت کنند.

خلاصه

در مروری که در این فصل بر مسئله بی‌خانمانی صورت گرفت، حداقل به پنج راهبرد بالقوه مؤثر برای کاهش تعداد نوجوانان بی‌خانمان و پیامدهای منفی طولانی مدت مرتبط با بی‌خانمانی اشاره شد.

۱. اختصاص هزینه‌ها و بودجه‌های خاصی برای برنامه‌های نوجوانان بی‌خانمان. برنامه‌های نوجوانان بی‌خانمان، اغلب توسط بودجه‌های خاص تأمین می‌شود. بنابراین، هر برنامه‌ای با سایر برنامه‌ها برای دریافت حمایت رقابت می‌کند. برای مثال، پناهگاه‌های کوتاه مدت اضطراری برای دریافت بودجه‌های خاص با ارائه‌کنندگان خدمات برای نوجوانان در موقعیت‌های گردهمایی و اجتماعی (مثل خانه‌های گروهی) و با برنامه‌هایی برای مراقبت طولانی مدت (مثل سلامت روانی) رقابت می‌کنند. ارائه‌دهندگان خدمات برای مرتبط کردن نوجوانان با مکان‌های اسکان ثابت و طولانی مدت تشویق نمی‌شوند. میزان بودجه تعیین شده برای مراکز بحران‌های کوتاه مدت وابسته به تعداد نوجوانانی است که در خیابان زندگی می‌کنند. اگر تعداد نوجوانان بی‌خانمان به دلیل اینکه در پرورشگاه ساکن شوند کاهش یابد، بودجه نگهداری نوجوانان بی‌خانمان هم کم می‌شود. هیچ مشوقی برای پناهگاه‌های بحرانی وجود ندارد تا تعداد نوجوانان زیر پوشش خود را کم کنند. مشوق‌ها مربوط به حفظ تعداد زیاد نوجوانان بی‌خانمان است.

۲. راهبردهای بودجه‌بندی ابتکاری برای خدمات اقتصادی، مالی و اجتماعی مورد نیاز است. برنامه‌های خدمات اجتماعی به‌طور کلی توسط بودجه‌های دولتی و حکومتی تأمین بودجه می‌شوند؛ استان، شهرستان، بخش. نه تنها سطح و نوع بودجه‌ها به‌طور ثابتی تغییر می‌کند، بلکه باورها درباره راهبردهای مداخله‌ای مطلوب نیز تغییر می‌کند. برنامه‌های مداخله‌ای، تجددگرا و نوگرا هستند. به تازگی بودجه برنامه‌های همسالان در اولویت است، بخصوص بودجه مربوط به کنترل HIV در نوجوانان (لونا^۱ و روترام -

^۱. Luna

بورس، ۱۹۹۵). بودجه‌ها به‌طور معمول برای ایجاد برنامه‌های جدید اختصاص می‌یابند نه حفظ برنامه‌های غیر ابتکاری که مراقبت‌های اساسی را فراهم می‌کنند.

۳. تحقیقات طولی در مورد پیامدهای بی‌خانمانی حیاتی و لازم‌اند. مطالعه رابرتسون (b، ۱۹۹۱) در مورد نوجوانان بی‌خانمان نشان می‌دهد که این نوجوانان ممکن است نسل بعدی بزرگسالان بی‌خانمان باشند. به‌منظور متوقف کردن چرخه بی‌خانمانی، بسیار مهم است که مشاهدات سیستماتیک را در مورد مسیر ورود و خروج از بی‌خانمانی به‌کار گیریم. برای توسعه و طراحی مدل‌های مداخله‌ای مثبت، بسیار مهم است که عوامل مرتبط با ایجاد ثبات مثبت در زندگی نوجوانان بی‌سرپناه را تشخیص دهیم. امروزه تحقیقات طولی کمی در این مورد انجام می‌گیرد. باید مطالعات طولی صورت گیرند تا راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات و پیامدهای منفی بی‌خانمانی به‌دست آید.

۱. باید الگوهای درمانی مخصوص نوجوانان طراحی شوند. بسیاری از برنامه‌هایی که برای نوجوانان ارائه می‌شوند، الگوسازی خدمات موجود برای بزرگسالان هستند، بویژه در حوزه مصرف مواد مخدر و درمان اعتیاد. به‌نظر می‌رسد مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان کاملاً متفاوت از بزرگسالان باشد. همچنین خدمات ارائه‌شده نباید فقط برای نوجوانان معتاد باشد، بلکه باید نقش گروه همسالان در مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان نیز مدنظر قرار گیرد. تمام این ویژگی‌ها، احتمالاً کارایی بالقوه برنامه‌های مداخله‌ای برای نوجوانان را کاهش می‌دهد. این برنامه‌ها برای الگوهای مصرف مواد توسط نوجوانان طراحی نشده‌اند. برنامه‌های مداخله‌ای موجود نمی‌توانند موضوعات قانونی و اخلاقی پیچیده‌ای را که در ایجاد خدمات دارویی و اجتماعی برای نوجوانان وجود دارد، حل کنند. این موضوعات باید به‌طور مستقیم توسط شبکه‌های ارائه‌کننده خدمات که تلاش دارند با نوجوانان بی‌خانمان برخورد کنند، مدنظر قرار گیرند.

۲. باید تأکید بر ارزش‌های گروهی و اجتماعی باشد تا حقوق و مسئولیت‌هایی که در مورد کودکان و نوجوانان وجود دارد، شناخته شوند. تقریباً بسیار آسان است که مشارکت‌های خیریه و خیرخواهانه را برای نوجوانان بی‌خانمان جلب کرد. بزرگ‌ترین آژانس موجود برای نوجوانان بی‌سرپناه در آمریکا توسط کلیسای کاتولیک اداره می‌شود که به‌دلیل زیربنای نیکوکاری، مؤسسه نیکوکاری نام‌گذاری شده و در نظر گرفتن نیازهای نوجوانان در دستور جلسات عمومی آن بسیار سخت

است. اغلب کودکان تحت مسئولیت والدین خود هستند؛ گرفتن این حق از والدین بدون تأمل کافی و اثبات مکرر این موضوع که آنها از رعایت حقوق کودکان خود ناتوان‌اند، تقریباً غیرممکن است.

با افزایش تعداد نوجوانان بی‌خانمان، بسیار مهم است که نقش اجتماع را در مورد مسئولیت مشترک نسبت به کودکان دوباره یادآور شویم. فقط با تأکید بر این نکته که تمام کودکان حقوق اساسی‌ای از نظر تأمین غذا، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی و تعلیم و تربیت دارند، قادر خواهیم بود سلامت نسل بعد را تأمین کنیم. با توجه به این مسائل است که ارائه خدمات و درمان برای نوجوانان بی‌خانمان به‌طور بنیادین اصلاح خواهد شد.

پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

- (۱) با توجه به نقش خانواده در فرار دختران، آیا تربیت دینی و مذهبی می‌تواند به عنوان یک عامل پیشگیری‌کننده در فرار دختران از خانه مورد توجه قرار گیرد؟
- (۲) رسانه‌های گروهی چگونه می‌توانند در پیشگیری از فرار دختران از خانه نقش داشته باشند؟

فصل دهم

مشکلات تحصیلی

امروزه گستره وسیعی از رفتارها و نتایج تحصیلی از جمله عقب ماندگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی ضعیف، ترک تحصیل، فرار از مدرسه و مردود شدن در مدرسه، به عنوان خطرهایی که سلامت جدی نوجوانان را تهدید می کنند، مطرح اند و موجب نگرانی والدین، معلمان، متخصصان تعلیم و تربیت و جامعه می شوند؛ این در حالی است که قرن گذشته در کنفرانس کودکان، قرن کودکان نام گذاری شد (بکر^۱، ۱۹۷۴). این مسئله نه تنها منجر به خودآگاهی و هشیاری جوامع و ملل مختلف شده، بلکه موجب شده سیاست های دول مختلف در جهت اصلاح و تغییر، مواظبت، سلامت و آموزش به کودکان سوگیری پیدا کند. بر این اساس، والدین و متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند عدم پیشرفت تحصیلی، عقب ماندگی و شکست تحصیلی، عرصه هایی هستند که برای بهبود آنها شاهد کمترین پتانسیل ها و تلاش ها می باشیم. این مسئله به عنوان خطر بزرگی پیامدهای حادی بویژه از نظر ابتلا به بیماری های جسمانی و روانی، مصرف مواد مخدر، اختلالات رفتاری و بزهکاری و عدم اشتغال و رفتارهای جرم آفرین در جوانی و بزرگسالی خواهد داشت. از این رو ترک تحصیل و پیشرفت تحصیلی ضعیف بخش کوچکی از گستره وسیع رفتارهای خطرآفرین است که منجر به بروز پیامدهای روان پزشکی و روانی اجتماعی شدیدی می شود.

تقریباً از دو دهه قبل مسئله شکست تحصیلی به عنوان رفتار خطرآفرین و بحران ملی مورد توجه بیشتر ملل جهان قرار گرفته است (کمیته ملی تعالی در آموزش و پرورش^۲، ۱۹۸۳). در واقع، شکست تحصیلی، پیشرفت تحصیلی ضعیف و ترک تحصیل، یکی از نگرانی های اصلی جوامع صنعتی به شمار می رود، با این حال، تمام جوامع با تأکید بر توسعه و تحول بهینه توانایی های بالقوه افراد و نیروهای انسانی خود، با این مشکل مواجه شده اند و سعی دارند با سرمایه گذاری روی نیروها و منابع انسانی خود، به مقابله با آن بپردازند.

^۱ . Becker

^۲ . national commission on excellence in education

چرا کودکان مدرسه را طرد یا ترک می کنند

در کتاب سال انجمن بین المللی روان پزشکی کودکان و نوجوانان، شدت و عمق این مشکل برجسته شده و به این پدیده از دیدگاه تجارب معاصر هفت کشور مختلف نگریسته شده است. در ژاپن، اگرچه ۹۲ درصد کودکان ابتدایی وارد دوره دبیرستان شده و فارغ التحصیل می شوند، با وجود این، نگرانی های شدیدی در مورد انتظارات و برنامه ریزی های سختی که از دانش آموزان انتظار می رود و تعداد در حال افزایش جوانانی که نمی توانند یا نمی خواهند از فرصت های آموزشی موجود بهره مند شوند، وجود دارد. از این رو ترک تحصیل سبب شناسی پیچیده ای دارد و با عوامل زیادی مرتبط است که شامل بعد ساختاری نظام آموزشی، تعامل عوامل تحول فردی با عوامل خانوادگی و فرهنگی اجتماعی، نگرانی والدین در مورد آموزش کودکانشان، عدم درگیری و نگرانی ناکافی والدین در مورد اعضای خانواده بویژه تعلیم و تربیت فرزندانشان و عوامل خارجی نظیر فشارهای گروه همسالان و صاحبان قدرت و دست اندرکاران جامعه است (لاست، فرانسیس و استراس^۱، ۱۹۸۹).

در این بافت، نشانه ها و علائم امتناع از مدرسه را می توان به سرویس هایی که شدت تعارضات درونی و بیرونی را در کودکی که بافت خاصی را تجربه می کند افزایش می دهند، نسبت داد. بنابراین برای حل این مشکل، به مداخله ها و روش های درمانی مخصوص به فرد، خانواده و مدرسه نیاز داریم.

در کشور در حال توسعه ای نظیر برزیل که بیشتر افراد جامعه فقیرند، فرصت های کمی برای پیشرفت های اقتصادی وجود دارد. فقط ۲۷ درصد کودکان تا کلاس چهارم ادامه تحصیل می دهند و ۶/۴ درصد نوجوانان تا سال دوم متوسطه درس می خوانند (سلیا^۲، ۱۹۹۰). سلیا اشاره می کند که بعضی از موارد امتناع از مدرسه بویژه در کودکان روستایی، به دلیل ساختار خاص آسیب زا و اجتماعی-سیاسی حاکم بر جامعه برزیل است، مانند عزت نفس ضعیف، عدم امنیت و رفتارهای ضد اجتماعی و همچنین مردود شدن. از این دیدگاه، سبب شناسی تغییرات ساختاری در بافت اجتماعی-فرهنگی مدارس نقش مهمی در مداخله هایی دارد که باید در مدارس صورت گیرد. هدف این مداخله ها باید ایجاد انگیزش پیشرفت تحصیلی و افزایش درگیری تحصیلی دانش آموزان در کلیه پایه ها و مقاطع تحصیلی باشد. در این قسمت به اختصار به مفهوم درگیری تحصیلی و سایر مفاهیم مرتبط با پیشرفت تحصیلی و یادگیری اشاره می شود.

^۱ . Lost, Francis & Strauss

^۲ . Celia

درگیری تحصیلی

اگرچه تعاریف مختلفی از درگیری تحصیلی^۱ شده است، متخصصان تعلیم و تربیت تمایل دارند که درگیری تحصیلی را مساوی با درگیر شدن دانش‌آموزان در تکالیفی نظیر حل مسئله و فعالیت‌هایی بدانند که منجر به توسعه مهارت‌های سطوح بالای شناختی نظیر ارزشیابی، ترکیب و تجزیه و تحلیل در طبقه‌بندی بلوم می‌شود. مرتبط کردن درگیری با هر سطح خاصی از یادگیری^۲ متأسفانه توجه ما را از این واقعیت که یادگیری و درگیری تحصیلی دو مفهوم متفاوت‌اند و هر کدام علل، ویژگی، قوت‌ها و محدودیت‌های خاصی دارند، منحرف می‌سازد. مهم‌تر اینکه توجه ما را از این واقعیت منحرف می‌کند که نه تنها یادگیری حاصل درگیری تحصیلی است، بلکه ممکن است منجر به درگیر شدن در تکالیف و فعالیت‌های تحصیلی شود. با این حال باید توجه داشت که دانش‌آموزان در یادگیری درگیر نمی‌شوند، بلکه در تکالیف، فعالیت‌ها و تجارب درگیر می‌شوند و این مسئله منجر به یادگیری می‌شود. از طرفی اهمیت و نقش یادگیری در مدارس گاه منجر به شکل‌گیری این موضوع نادرست می‌شود که کار مدارس فقط ایجاد یادگیری است. ازاینرو مربیان باید بیاموزند که کار آنها طراحی تکالیفی است که دانش‌آموزان را برای سرمایه‌گذاری تمام منابع و ظرفیت‌های درونی خود از جمله توجه، انرژی و زمان خود تشویق می‌کنند. یادگیری زمانی رخ می‌دهد که دانش‌آموزان تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. برخی از تکالیف و فعالیت‌ها ممکن است سبب شوند که دانش‌آموزان یاد بگیرند ارزشیابی کرده و ترکیب کنند (بالاترین سطوح شناختی در طبقه‌بندی بلوم) و بعضی از تکالیف ممکن است منجر به سطوح پایین یادگیری مانند دانش شوند. بر این اساس به جای آنکه درگیری تحصیلی را از طریق نتایجی که ایجاد می‌کند (برای مثال نوع یا سطح خاص از یادگیری) تعریف کنیم، باید از طریق معنایی که تکالیف و فعالیت‌های طراحی شده توسط معلم برای دانش‌آموزان دارد، تعریف کرد.

در این زمینه اسکالکتی^۳ (۲۰۰۵) معتقد است درگیر شدن دانش‌آموز در تکالیف تحصیلی به این معناست که اولاً تکلیف توجه دانش‌آموز را جلب کرده و تحت فرمان خود در می‌آورد، ثانیاً به دلیل جلب شدن توجه دانش‌آموز، او انرژی خود را برای انجام و اتمام آن تکلیف بسیج کرده و تا پایان آن تکلیف همچنان انرژی خود را حفظ می‌کند، به طوری که متناسب با ملزومات آن تکلیف باشد. معنای دیگر درگیری تحصیلی این است که دانش‌آموز طوری به آن تکلیف یا فعالیت متعهد می‌شود که تمام انرژی و منابع درونی خود را برای انجام آن بسیج می‌کند و خواهد توانست بر تکلیف پافشاری کند،

^۱ . engagement

^۲ . learning

^۳ . Schlechty

حتی اگر با مشکلی مواجه شود و هیچ پاداش بیرونی برای انجام آن تکلیف وجود نداشته باشد. بنابراین برای اندازه‌گیری درگیری تحصیلی در وهله اول باید میزان توجه و تعهد دانش‌آموز را اندازه‌گیری کرد. در واقع دانش‌آموزانی که توجه و تعهد زیادی دارند، در تکالیف درگیر می‌شوند، اما آنهایی که توجه زیادی دارند، اما از نظر تعهد ضعیف‌اند، دانش‌آموزان مطیع^۱ و فرمانبردار هستند. زمانی دانش‌آموزان در تکالیف و فعالیت‌های تحصیلی درگیر می‌شوند که تکالیف برایشان معنا و ارزش ذاتی و درونی داشته باشد. به عبارت دیگر، آنها فکر می‌کنند اگر در فعالیت‌های مربوط به انجام دادن آن تکالیف شرکت کنند، ارزش‌هایشان جامعه عمل خواهد پوشید. از این‌رو مربیان و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت باید تکالیف درسی را طوری طراحی کنند که مبتنی بر انگیزه‌ها و ارزش‌های دانش‌آموزان باشند. زمانی که تکالیف برای دانش‌آموزان معنادار و در راستای ارزش‌های آنان باشند، از انجام آنها لذت می‌برند و هر چه را که معلم، والدین و اجتماع از آنان انتظار دارند یاد بگیرند، یاد می‌گیرند.

درگیری تحصیلی در مقابل اطاعت و فرمانبرداری

درگیری تحصیلی را می‌توان به صورت تعامل بین توجه و تعهد بهتر درک و تعریف کرد. دانش‌آموزانی که درگیر می‌شوند، توجه و تعهد زیادی دارند، زیرا برای انجام تکالیف و فعالیت‌های مربوط به درس ارزش قائل هستند. به بیان دیگر، ممکن است دانش‌آموزان درگیر مسائلی را یاد بگیرند که هیچ ارزش شخصی برای آنها ندارد، چرا که آنها به انجام تکالیف یا فعالیت‌هایی ارزش می‌دهند که منجر به یادگیری بیشتر آنان می‌شود. دانش‌آموزان در هنگام درگیر شدن در تکالیف یا فعالیت‌ها، حتی در غیاب پاداش‌های بیرونی، پایداری و تلاش از خود نشان می‌دهند، درحالی‌که دانش‌آموزان مطیع و فرمانبردار فقط به تکلیف توجه می‌کنند و سطح این توجه در آنان در نوسان است و ممکن است کم شود. برای مثال وعده پاداش بیرونی با ارزش (نمره خوب، تأیید معلم، والدین و اطرافیان، ورود به دانشگاه، فرصت برای بازی در یک تیم ورزشی و غیره) ممکن است موجب صرف انرژی بسیار زیادی شود، اما به درگیر شدن دانش‌آموز منجر نمی‌شود، زیرا چنین پاداش‌هایی فقط وسیله‌ای برای جلب توجه و صرف انرژی ضروری برای انجام تکلیف است، اما به محض حذف شدن پاداش بیرونی، توجه کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود و فرد هیچ انرژی صرف نمی‌کند، زیرا خود تکلیف هیچ ارزش و جاذبه‌ای برای او ندارد. در واقع، توجه توسط پاداش بیرونی ایجاد و جلب می‌شود، اما تعهد فقط از طریق معناها و ارزش‌های شخصی ایجاد می‌شود.

^۱ . compliant

اطاعت و فرمانبرداری دو نوع است؛ تسلیم و اطاعتی که مبتنی بر وعده پاداش بیرونی است و به آن تسلیم یا اطاعت راهبردی^۱ می گویند. در این حالت دانش آموزان برای به دست آوردن پاداش های بیرونی، تکالیف خود را انجام می دهند و ارزش آن پاداش برایشان مهم است. در این حالت تکلیف به خودی خود هیچ ارزشی برای آنان ندارد و به ماهیت تکلیف توجهی ندارند. هنگام تسلیم راهبردی، اگر پاداش به اندازه کافی ارزشمند باشد، می تواند توجه دانش آموز را به خوبی جلب کند، به طوری که یادگیری زیادی صورت می گیرد. در تسلیم راهبردی ممکن است یادگیری حتی در سطح هدف های میانی بلوم (کاربرد و تجزیه و تحلیل) صورت گیرد، با این حال آنچه یادگرفته شده است، زیاد دوام ندارد، پایدار نمی ماند و قابلیت انتقال به سایر موقعیت ها را ندارد. اگر یادگیری در بافتی معنادار و با ارزش از نظر شخصی صورت بگیرد، پایدارتر و قابل انتقال به سایر موقعیت ها است، یعنی همان حالتی که درگیری تحصیلی ایجاد می کند.

باید در نظر داشت که وعده پاداش بیرونی تنها وسیله ایجاد تسلیم و اطاعت در دانش آموزان نیست. تهدید به مجازات یا پیامدها و عواقب نامطلوب و ناخوشایند نیز تا حدی توجه را جلب می کند، اگر چه نمی تواند تعهدی ایجاد کند. در این حالت دانش آموز تا جایی متمرکز بر تکالیف می شود که از تنبیه و عواقب ناخوشایند در امان باشد و اجتناب کند. آنها حداقل وقت و انرژی لازم را صرف می کنند، به طوری که مورد تنبیه واقع نشوند (برای مثال بی توجهی و سرزنش والدین و معلمان). این نوع تسلیم را تسلیم اجباری^۲ می نامند. نام دیگر این اطاعت تسلیم منفعلانه^۳ است (اسکلکتی، ۲۰۰۵). به طور خلاصه درگیری مرتبط با معنا و ارزش شخصی دانش آموزان، تسلیم راهبردی ناشی از میل برای به دست آوردن پاداش و تسلیم اجباری ناشی از تمایل برای اجتناب از تنبیه است.

یادگیری، تسلیم و درگیری

درگیری تحصیلی فقط زمانی که دانش آموزان در تکالیفی درگیر می شوند که منجر به شکل گیری مهارت ها و یادگیری های سطوح بالای شناختی نظیر حل مسئله، ترکیب و ارزشیابی می شود، ایجاد نمی شود، بلکه حتی تکالیفی که موجب ایجاد مهارت ها و یادگیری های سطوح پایین شناختی نظیر دانش و درک و فهم می شوند، دانش آموزان را درگیر می کنند. البته به چند دلیل این یادگیری های سطوح پایین با یادگیری های ناشی از تسلیم و اطاعت تفاوت کیفیتی دارند؛ اولاً در حالت تسلیم یا

^۱ . Strategi Compliance

^۲ . Ritual Compliance

^۳ . Passire

عدم درگیری، میزان پایداری و تنظیم تلاش بسیار پایین است؛ ثانیاً یادگیری ناشی از تسلیم قابل انتقال به سایر بافت‌ها و موقعیت‌ها نیست و پایداری و دوام کمی دارد؛ ثالثاً یادگیری گاهی لازمه یادگیری‌های جدید و پیچیده، یادسپاری، حفظ و کسب دانش است. به عبارت دیگر، گاه انجام تکالیف ارزشمند که منجر به یادگیری‌های پیچیده و سطح بالا می‌شوند، مستلزم حفظ طوطی‌وار مطالب و یادگیری‌های سطح پایین از نوع دانش‌اند. در واقع تفاوت در اینجاست که یادگیری طوطی‌وار ایجاد شده از طریق تسلیم هیچ معنا و ارزشی برای دانش‌آموز ندارد. وقتی چنین باشد، مطالب آموخته‌شده، بسرعت فراموش می‌شوند و قابلیت انتقال به سایر موقعیت‌ها را ندارند.

گاهی دانش‌آموزان نه در فعالیت‌های تحصیلی درگیر می‌شوند و نه تسلیم؛ در این گونه موارد دو گزینه وجود دارد؛ یکی اینکه دانش‌آموز از انجام تکالیف فرار و اجتناب کند و دیگر اینکه کاملاً تکالیف یا فعالیت را طرد کند. اغلب گریز و اجتناب از تکالیف بیشتر در کلاس‌هایی وجود دارد که دانش‌آموزان به جای درگیر شدن به تکالیف به دلیل جاذبه اجتماعی و شخصیتی معلم با معلم درگیر می‌شوند.

انگیزش درونی و بیرونی

مفهوم درگیری تحصیلی با مفهوم انگیزش ارتباط تنگاتنگی دارد. در مبحث انگیزش، بین انگیزش درونی و بیرونی تفاوت وجود دارد. به‌طور معمول اعتقاد بر این است که انگیزش بیرونی وابسته به وجود پاداش‌ها و مشوق‌های بیرونی است، در حالی که انگیزش درونی مستلزم هیچ پاداشی نیست. دانش‌آموزان دارای انگیزش بیرونی فقط برای به‌دست آوردن پاداش یا اجتناب از تنبیه تکالیف خود را انجام می‌دهند (بروکس^۱ و همکاران، ۱۹۹۸؛ به نقل از اسکالکتی، ۲۰۰۵). دانش‌آموزان دارای انگیزش درونی فعالانه در یادگیری درگیر می‌شوند و به دلیل کنجکاوی، علاقه، لذت و یا دستیابی به اهداف با ارزش درونی و شخصی خود تکالیف را انجام می‌دهند، برای شروع یا اتمام تکالیف هیچ نیازی به پاداش و تشویق ندارند و ماهیت چالش‌انگیز تکالیف آنها را برای انجام آن برمی‌انگیزاند. با این حال در هر دو نوع انگیزش دانش‌آموز پاداش می‌یابد. در مورد انگیزش بیرونی، پاداش خارج از تکالیف (برای مثال تأیید معلم)، در انگیزش درونی پاداش درون تکالیف است (دستیابی و ارزش‌های شخصی).

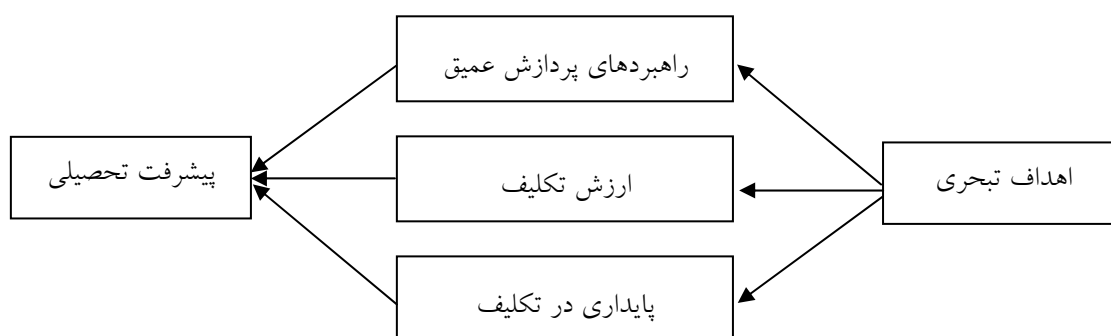
به‌طور کلی پاداش‌ها و تشویق‌ها ممکن است درونی یا بیرونی باشند، اما انگیزه‌ها همیشه درونی‌اند. انگیزه‌ها ممکن است یا ناشی از ارزش‌هایی باشند که اکتساب و درونی شده‌اند یا ناشی از

^۱. Brooks

نیازهای اساسی و فطری نوع انسان باشند. با این حال در هر دو صورت درونی‌اند و اگر با نگرش‌ها، گرایش‌ها و ارزش‌هایی که دانش‌آموز به تکالیف دارد همسو باشند، منجر به درگیری تحصیلی می‌شوند. تکالیفی که به شیوه‌ای طراحی می‌شوند که در دانش‌آموز توجه و تعهد ایجاد می‌کنند، نیازی به پاداش‌های بیرونی ندارند، در نتیجه منجر به تسلیم یا اطاعت نمی‌شوند. اطاعت یا تسلیم در شرایطی شکل می‌گیرد که شرکت در فعالیت‌ها یا انجام تکالیف تحصیلی هیچ ارزش و معنای شخصی برای دانش‌آموز ندارد.

عوامل دیگری نیز وجود دارند که در درگیری تحصیلی دانش‌آموزان نقش دارند. بی‌گمان دانش‌آموزانی که در موقعیت‌های غیر تحصیلی از تبادلات کلامی و نمادهای انتزاعی بیشتر بهره می‌برند، احتمال بیشتری وجود دارد که در تکالیف و فعالیت‌های تحصیلی درگیر شوند تا دانش‌آموزانی که به فرهنگ‌ها و محیط‌هایی تعلق دارند که برای رشد و تحول کلامی و به‌کارگیری نمادهای انتزاعی ارزش کمتری قائل‌اند. یکی از دلایل عدم پیشرفت کودکان خانواده‌های کم درآمد و طبقات پایین اجتماعی مربوط به همین موضوع است. از طرفی، وقتی تکالیف و فعالیت‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان ارزش کمی دارد نیز روش‌هایی برای درگیر کردن آنان در مسائل و موضوعات تحصیلی وجود دارد. برای مثال در مدرسه‌ای که مشارکت و همکاری کامل در میان گروه همسالان موجب می‌شود تبادلات کلامی و ذهنی دانش‌آموزان افزایش یابد، احتمال درگیری تحصیلی بیشتر است تا در کلاس‌ها یا محیط‌های آموزشی که بر رقابت و اهداف فردی تأکید دارند و بر تکالیف مشارکتی تأکید نمی‌شود. متأسفانه نظام‌های آموزشی کنونی طوری طراحی شده‌اند که بیشتر اطاعت و تسلیم را ایجاد می‌کنند تا درگیری در تکالیف تحصیلی، ازاینرو نیازمند اصلاحات عمیق و گسترده‌ای در برنامه‌ها و تکالیف درسی‌اند.

عابدینی (۱۳۸۶) روابط علی میان اهداف پیشرفت، ابعاد مختلف درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را در دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان در دو رشته ریاضی- فیزیک و علوم انسانی مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش نشان داد که در هر دو گروه ریاضی- فیزیک و علوم انسانی اهداف تبحری اثر علی مستقیم و مثبتی بر راهبردهای پردازش عمیق (درگیری شناختی عمیق)، ارزش تکلیف (درگیری عاطفی) و پایداری در تکلیف (درگیری رفتاری) دارند و این متغیرها به نوبه خود اثر علی مستقیم و مثبتی با پیشرفت تحصیلی دارند. این روابط علی را در نمودار زیر مشاهده می‌کنید.



نمودار ۱۱-۱. روابط علی میان اهداف پیشرفت، ابعاد سه گانه درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان در رشته‌های ریاضی-فیزیک و علوم انسانی

تعریف پیشرفت تحصیلی ضعیف و ترک تحصیل

برای یک لحظه، به اصطلاح "پیشرفت تحصیلی ضعیف" توجه کرده و آن را بررسی کنید. این اصطلاح به طور قراردادی به این معناست که عملکرد تحصیلی فرد در موضوعات درسی و تحصیلی پایین‌تر از سطح مورد انتظار و استاندارد باشد. یک آزمون تحصیلی خاص منجر به کسب نمره یا رتبه خاصی می‌شود که عملکرد یا پیشرفت تحصیلی فرد را در آن درس خاص به ما نشان می‌دهد. با این حال، نتیجه این آزمون ممکن است اطلاعات خاصی درباره انتظارات، توانایی یا قابلیت دانش‌آموز برای اکتساب و یادگیری اطلاعات در اختیار ما قرار ندهد.

سازمان آموزش و پرورش آمریکا در کتاب وضعیت و شرایط آموزش و پرورش، به اصطلاح "پیشرفت تحصیلی ضعیف" اشاره‌ای نکرده، اما به جای آن از اصطلاح "پیشرفت تحصیلی"^۲ استفاده کرده است که اطلاعاتی درباره کارآمدی و تبحر دانش‌آموز در حوزه‌های مختلف خواندن، نوشتن، علوم و ریاضیات در اختیار ما قرار می‌دهد (اداره اصلاحات و پژوهش‌های آموزشی و پرورشی^۳، ۱۹۹۳b).

اکنون به اصطلاحات متفاوت و متنوعی که برای توصیف عدم توجه به مدرسه و تحصیل به کار برده می‌شود، توجه کنید. این اصطلاحات شامل گریز از مدرسه، مدرسه‌هراسی، اجتناب از مدرسه، ترک تحصیل، اختلال اضطراب جدایی و مردود شدن است. برگ^۴ (۱۹۹۱) در مروری بر مقالات موجود در زمینه اجتناب از مدرسه، مدرسه‌هراسی و مدرسه‌گریزی، وجه مشخصه و تعاریف این

^۱. under a achievement

^۲. achievement

^۳. office of educational research and improvements

^۴. Berg

اصلاحات را در بافت درمانی، تحولی و تاریخی بررسی کرده است. او اعتقاد دارد در کشورهای صنعتی، در هر لحظه ۱۰ درصد تمام کودکان مدرسه‌رو خارج از مدرسه‌اند و جایگاه اجتماعی - اقتصادی پایین، عدم علاقه والدین به آموزش و پرورش فرزندان و عوامل متنوع دیگر مربوط به مدرسه با اجتناب از مدرسه رابطه دارند.

اصطلاح "مدرسه‌هراسی" نیز به صورت نوعی اختلال و انحراف هیجانی در کودکان شناخته شده است و با اضطراب زیاد دانش‌آموز رابطه دارد و منجر به غیبت جدی از مدرسه می‌شود. برگ (۱۹۹۱)، اشاره کرده که در بریتانیا، اصطلاح‌های "امتناع از مدرسه" یا "ترک تحصیل"، اغلب برای گروهی از مشکلات به کار برده می‌شوند؛ این مشکلات عبارتند از: ۱) کودک با آگاهی والدین در خانه می‌ماند؛ ۲) رفتارهای ضداجتماعی شدیدی در کودک وجود ندارد؛ ۳) والدین تلاش می‌کنند با استدلال و منطق توجه کودک را به مدرسه جلب کرده و در او ایجاد امنیت کنند؛ ۴) هنگامی که کودک مجبور به رفتن به مدرسه می‌شود، نگرانی‌ها و ناراحتی‌های عاطفی از خود نشان می‌دهد.

به تازگی بین مدرسه‌گریزی و امتناع از مدرسه تمایز قائل شده‌اند. مدرسه‌گریزی و غیبت از مدرسه، به صورت ارادی و بدون اطلاع والدین و بدون اجازه آنها صورت می‌گیرد و برآورد شده که ۳ تا ۸ درصد کودکان مدرسه‌رو به این کار دست می‌زنند. این مسئله در کلاس‌های بالاتر رایج‌تر از کلاس‌های پایین‌تر است و در پسران نسبت به دختران، به نسبت ۳ به ۱ است و با شیوه‌های انضباطی سخت و تنبیه‌کننده جایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده، اثرهای منفی گروه همسالان، اختلالات رفتاری و اعمال ضدقانونی در جوانان رابطه دارد (هرساو^۱، ۱۹۸۵).

درباره میزان شیوع امتناع از مدرسه، هرساو (۱۹۸۵) معتقد است که در حدود ۵ درصد کودکانی که از مدرسه رفتن امتناع می‌کنند، اختلالات روان‌پزشکی دارند و با توجه به سن شروع این اختلالات که در حدود ۵ تا ۷ سالگی است، بیشتر این اختلالات مربوط به اضطراب جدایی است، درحالی که در ۱۱ تا ۱۴ سالگی، اختلالات کودکان بیشتر مربوط به حالت‌های افسرده‌خویی است. بین امتناع از مدرسه و اختلال اضطراب جدایی و سایر اختلالات همبود با آن نظیر هراس اجتماعی، هراس ساده، وحشت‌زدگی و اختلالات افسردگی، رابطه وجود دارد و بیشتر این اختلالات مربوط به کارکردهای خانوادگی آسیب‌زاست.

^۱ . Hersov

تفاوت‌های جنسیتی و قومی

اطلاعات مربوط به مردود شدن جوانان دبیرستانی، نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۹۹۱ در آمریکا، ۱۲/۵ درصد جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله از مدرسه اخراج و ۱۷ درصد آنان مردود شده‌اند. با متمایز ساختن آمار مربوط به شکست تحصیلی در سال ۱۹۹۱ در دو جنس، می‌بینیم که میزان افت تحصیلی در پسران ۱۳ درصد و در دختران ۱۹ درصد است. همچنین مشاهده شده درصد دانش‌آموزان دبیرستانی که ترک تحصیل می‌کنند، در خانواده‌های کم‌درآمد بیشتر است، به‌طوری‌که ۱۱ درصد دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌های کم‌درآمد و ۱ درصد دانش‌آموزان خانواده‌های پردرآمد ترک تحصیل کرده‌اند.

نوجوانان توان و استعداد یکسانی برای یادگیری ندارند. برای دسته‌ای از آنان یادگیری ریاضیات مشکل است و به سختی مفاهیم آن را درک می‌کنند. انگیزه نوجوانان برای یادگیری نیز متفاوت است. وقتی انگیزه نوجوان مقبولیت اجتماعی و دست یافتن به مشاغل خاصی باشد، تلاش او برای موفقیت در درس به کسب این اهداف محدود می‌شود. چنانچه انگیزه نوجوان بارور کردن استعداد و کمال شخصی و پرورش روحیه و تتبع و تحقیق باشد، با دقت و عمق بیشتری به یادگیری می‌پردازد. محتوای دروس و کیفیت آموزش به لذت بردن از تحصیل کمک می‌کند. اگر محتوای دروس قابل فهم و جالب باشد، نوجوان را به سمت خود می‌کشد و چنانچه کیفیت آموزش مطلوب نباشد، نوجوان را از درس و مدرسه سرخورده و وازده می‌کند و علاقه‌ای به تحصیل نشان نمی‌دهد. ارزش علم در جامعه نیز موجب انگیزش بیشتر نوجوان به کسب دانش می‌شود. افت تحصیلی از دوره دبستان به دوره راهنمایی و دبیرستان در کشور ما بسیار چشمگیر است. آمار وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ در مورد مردودی کلاس‌های مختلف بیانگر این موضوع است.

جدول ۱-۱۰. میزان مردودی در کلاس‌های مختلف در سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹

کلاس	شرکت‌کنندگان در امتحان	قبولی در خرداد و شهریور	مردودین	درصد قبولی
پنجم ابتدایی	۱۶۷۱۹۶۹	۱۶۳۹۱۰۶	۳۲۸۶۳	۹۸۱۷
اول راهنمایی	۱۶۹۱۳۵۹	۱۵۰۸۱۵۷	۱۸۳۲۰۲	۸۹۱۷
سوم راهنمایی	۱۵۹۳۷۳۲	۱۳۵۶۴۰۳	۲۳۷۳۲۹	۸۵۱۱۱
اول دبیرستان	۱۵۸۳۳۵۶	۱۱۱۱۷۴۵	۴۷۱۶۱۱	۷۰۱۲۱

همان‌گونه که در جدول ۱-۱۰ مشاهده می‌شود، افت تحصیلی در دوره ابتدایی بسیار کم (۱/۳ درصد) و در سال سوم راهنمایی بیش از سال اول راهنمایی بوده است. افت تحصیلی حتی در دوره دبیرستان از دوره راهنمایی نیز بیشتر است (در حدود ۳۰ درصد).

گاهی نقص در نظام آموزشی علت بی‌علاقگی و افت تحصیلی نوجوانان است. تحقیق اداره کل مطالعات برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش در مورد ۷۳۴ دانش‌آموز در مراکز تربیت معلم نشان داد که ۳۷/۵ درصد آنان معتقد بودند دبیرستان‌ها معلومات ناقصی به آنان آموزش می‌دهند و روش‌های تدریس در دبیرستان‌ها روش نادرستی است. نتایج کامل این پژوهش را در جدول ۱۰-۲ مشاهده می‌کنید (انجمن اولیا و مربیان، ۱۳۵۱).

جدول ۱۰-۲. درصد نقایص در دبیرستان‌ها از نظر دانش‌آموزان

درصد	نقایص دبیرستانی که در آن درس خوانده‌ام
۳۴	کمبود وسایل تحصیلی
۱۳	تکرار مطالب زاید و تکراری در کلاس‌ها
۱۲/۵	بی‌علاقگی دبیران و نداشتن حسن رابطه با شاگردان
۹	عدم احاطه دبیران به رشته تخصصی خود
۴	ازدحام در کلاس‌ها

دانش‌آموزان در این تحقیق به معایبی از قبیل کمبود دبیر، نبودن کتابخانه، بی‌توجهی به ورزش و بی‌توجهی به رشته فنی و خانه‌داری نیز اشاره کرده بودند. در پژوهش دیگری که توسط انجمن اولیا و مربیان در سال ۱۳۵۶ صورت گرفت، از ۱۴۹۰ دانش‌آموز دبیرستانی سوال شد که به نظر آنان علت عدم توجه معلمان به وظایف خود چیست. پاسخ‌های آنان در جدول ۱۰-۳ آمده است.

جدول ۱۰-۳. درصد علل عدم توجه معلمان به وظایف خویش از نظر دانش‌آموزان دبیرستانی

درصد	علل ذکر شده توسط دانش‌آموزان
۱۵/۲	عدم مسئولیت
۱۵/۱	ضعف شخصیت و ناموزونی روانی و اخلاقی
۱۳/۱	بی‌سوادی و کم‌تجربگی
۱۰	احتیاجات مالی
۹/۲	ضعف در ایمان و بی‌ایمانی
۸	عدم توجه به نظام آموزشی
۵	بی‌بهره بودن از تربیت اجتماعی و خانوادگی صحیح
۴/۶	ناآشنایی به روش تدریس
۴/۶	ناراحتی‌های خانوادگی
۴/۵	پول‌دوست بودن
۳/۱	محرومیت‌ها و عقده‌های روانی
۰/۵	بی‌علاقه بودن دانش‌آموزان به تحصیل
۱/۸	نامناسب بودن محیط تحصیل
۱/۸	نارضایتی از وضع محیط
۱/۲	سایر اشتغالات معلم
۰/۵	یکنواخت بودن کار

همان‌گونه که در جدول ۱۰-۳ مشاهده می‌شود، دانش‌آموزان بیشتر علل بی‌توجهی معلمان به وظایف خود را مربوط به احساس مسئولیت، ضعف شخصیتی و اخلاقی، بی‌سوادی و کم‌تجربگی، احتیاجات مالی و بی‌ایمانی آنان می‌دانند. طرز رفتار، نحوه تدریس و عدم تسلط معلمان از جمله عواملی است که مورد اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی بوده است. اگرچه تسلط معلم بر درس و روش تدریس او و ارتباط او با شاگردان از عوامل مهم پیشرفت یا شکست دانش‌آموزان در کشور ما بوده است، ولی نباید از نقش عوامل دیگر آموزشی نظیر برنامه درسی، محتوای کتاب‌ها، ساختمان آموزشگاه و شیوه مدیریت آموزشی غافل بود.

متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که به احتمال زیاد افت و شکست تحصیلی کودکان و نوجوانان تا حدودی مربوط به ساعات زیادی است که صرف تماشای تلویزیون می‌کنند. بر این اساس، مرکز

ملی آمار آموزشی و پرورشی^۱ (۱۹۹۳) اقدام به نمونه‌گیری از ساعات تماشای تلویزیون و نمایش‌های تلویزیونی توسط نوجوانان کرده است. بیش از ۹ درصد دانش‌آموزان گزارش کرده‌اند که در شبانه‌روز بیش از ۵ ساعت به تماشای تلویزیون می‌پردازند. همچنین میزان بالاتر تماشای برنامه‌های تلویزیونی با جایگاه اجتماعی - اقتصادی خانوادگی پایین و عملکرد تحصیلی ضعیف دانش‌آموزان ارتباط دارد. علاوه بر عوامل مذکور، شواهد نشان می‌دهند عوامل زمینه‌ساز خانوادگی نظیر تحصیلات کم والدین و انتظارات اندک آنها، به‌طور شدیدی پیشرفت تحصیلی کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (دباریش، پارتسون و کپالدی^۲، ۱۹۹۳؛ به نقل از تامسون و مایکلسون، ۱۹۹۵). همچنین مشاهده شده سبک‌های انضباطی غیرکارآمد، ناهمگون و تنبیه‌کننده، به‌طور فراوان‌تری توسط والدین کودکان دارای پیشرفت تحصیلی پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد و این موضوع با بی‌علاقگی کودکان به تکالیف تحصیلی و مدرسه‌ای همراه و همبسته است.

ارشادی‌منش (۱۳۸۴) رابطه بین شکست‌های تحصیلی را که منجر به گریز از مدرسه می‌شوند و متغیرهای حمایت اجتماعی، نگرش‌های تحصیلی و کمبودهای فزاینده را در ۲۸۰ دانش‌آموز دختر و پسر دارای تجربه موفقیت و شکست در دوره راهنمایی بررسی کرد. یافته‌ها نشان داد تفاوت بین دو گروه دارای تجربه شکست و موفقیت از نظر جنسیتی معنادار نبود. همچنین مشاهده شد که دانش‌آموزان دارای تجربه شکست نسبت به دانش‌آموزان دارای تجربه موفقیت، حمایت عاطفی و اجتماعی کمتری را از والدین و اطرافیان خود دریافت می‌کردند، کمبودهای فزاینده بیشتری را تجربه کرده‌اند و نگرش منفی‌تری به درس و مدرسه و تحصیلات دارند.

رایسی، گارهاردشتاین و کیستنر^۳ (۲۰۰۳)، در مطالعه طولی ۱۰ ساله، ۵۲۴ دانش‌آموز نوجوان ۱۲ تا ۱۶ ساله را مورد مطالعه قرار دادند. آنان دریافتند که مهارت‌های اجتماعی ضعیف، پرخاشگری و انزوای اجتماعی، رابطه منفی و معناداری با پیشرفت تحصیلی این نوجوانان دارد، با این حال، پرخاشگری بهترین پیش‌بینی‌کننده شکست تحصیلی در این نوجوانان بود. همچنین آنها مشاهده کردند که جایگاه اجتماعی - اقتصادی و قومیت نیز پس از پرخاشگری، پیش‌بینی‌کننده‌های خوبی برای شکست تحصیلی در آینده بودند.

بین^۴ و همکاران (۲۰۰۳)، به بررسی نقش حمایت والدین، کنترل و نظارت رفتاری و کنترل روان‌شناختی آنان در پیشرفت تحصیلی و عزت‌نفس نوجوانان آمریکایی آفریقایی‌تبار و اروپایی پرداختند. نتایج نشان داد که رفتار حمایتی مادران آفریقایی از فرزندان نوجوان خود به‌طور مثبتی

^۱ national center for educational statistics

^۲ Debaryshe, Patterson & Kapaldi

^۳ Risi, Gerhardstein & Kistner

^۴ Bean

عزت نفس و پیشرفت تحصیلی را در آنان پیش بینی می کرد، درحالی که در نوجوانان اروپایی، کنترل رفتاری و روان شناختی، از جمله پیش بینی کننده های مهم پیشرفت تحصیلی و عزت نفس بود.

ایزنبرگ، نیومارک و پری^۱ (۲۰۰۳)، با مطالعه ۴۷۴۶ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله که از نظر اجتماعی - اقتصادی با یکدیگر متفاوت بودند، دریافتند نوجوانانی که پیوسته مورد آزار و اذیت همسالان و بدرفتاری آنان قرار می گیرند، نه تنها پیشرفت تحصیلی کمی دارند، بلکه با آموزشگاه و تحصیلات رسمی رابطه خوبی ندارند. به عبارت دیگر، نوجوانانی که بیشتر مورد بدرفتاری همسالان خود واقع می شوند، احساسات منفی تری در مورد تکالیف تحصیلی و مدرسه دارند.

پلگرنیا، گارسیا لینارس و کاسانوا^۲ (۲۰۰۳)، به بررسی رابطه عوامل خانوادگی نظیر میزان پذیرنده بودن والدین و تعارضات و درگیری های خانوادگی با قابلیت ها و لیاقت های تحصیلی نوجوانان پرداختند. آنان دریافتند نوجوانانی که جو خانوادگی آرام تری داشتند و بیشتر مورد پذیرش والدین خود قرار می گرفتند، قابلیت های تحصیلی بهتری داشتند.

مارجوریانکز^۳ (۲۰۰۴) به بررسی نقش عوامل فردی و محیطی در پیشرفت تحصیلی نوجوانان مهاجر پرداخت. او ۱۱۷۵ نوجوان و جوان استرالیایی (۶۰۴ دختر و ۵۷۱ پسر) را با میانگین سنی ۱۸ سال که در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بودند، مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان دهنده اهمیت نسبی جاه طلبی و آمال تحصیلی نوجوانان در تبیین تفاوت های آنان از نظر وضعیت تحصیلی بود. یافته های او بیانگر دو الگو در زمینه رابطه بافت خانوادگی و جاه طلبی و آمال نوجوانان با پیشرفت تحصیلی در آنها بود. اولین الگو (الگوی جاه طلبی تحصیلی - برانگیختگی)، نشان می داد نوجوانانی که جاه طلبی و آمال تحصیلی بیشتری دارند، انگیزش پیشرفت زیادتری دارند، اما در الگوی دوم یا الگوی عملکرد - برانگیختگی، برعکس مشاهده می شود نوجوانانی که عملکرد تحصیلی بهتری دارند، جاه طلبی و آمال تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

پیشگیری

در دیدگاه های سنتی سلامت عمومی، پیشگیری اولیه تلاشی است برای مشخص کردن علل بیولوژیکی اختلال، پیشگیری ثانویه نیز اختلال یا شرایط آسیب شناختی را قبل از اینکه منجر به اختلال و رنج بردن شوند، مشخص و پیشگیری می کند؛ پیشگیری ثالث نیز تلاشی است برای درمان شرایط اختلال آور آشکار و مسلط و پیشگیری از ابتلا به اختلال بیشتر. در حوزه اختلالات

^۱ . Eisenberg, Newmark & Perry

^۲ . Pelegrina, Garcia – Linares & Casanova

^۳ . Marjoribanks

روان‌پزشکی و رفتارهای آسیب‌زای روانی اجتماعی، با شناختی که هم‌اکنون داریم، پیشگیری اولیه از عوامل بیولوژیکی ارثی در سطح پایینی امکان‌پذیر است، درحالی‌که پیشگیری ثالث یا درمان شرایط اختلال هدف اصلی اعمال و کارهای سنتی بالینی است.

پیشگیری ثانویه

وظیفه پیشگیری ثانویه این است که در ابتدای مرحله رشد و شکل‌گیری اختلال مداخله کند، بویژه برای افرادی که از نظر تشخیصی بیشتر در معرض خطر قرار دارند. با تعریف پیشگیری ثانویه، به این شکل که هدف آن عبارت است از پیشگیری از رشد و توسعه رفتارهای مرتبط با شکست تحصیلی قبل از اینکه این رفتارها جزئی از الگوی شخصیتی فرد شوند، پیشگیری هم ضروری است و هم در کاهش میزان نگرانی‌های انسانی و افزایش قابلیت‌های انسانی مفید و مؤثر است. برنامه‌های مداخله‌ای مفید برای پیشگیری از عدم پیشرفت تحصیلی و ترک تحصیل، برنامه‌های آموزشی خاصی‌اند، این برنامه‌ها بیشتر برای دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری، مفید و مؤثرند تا سایر دانش‌آموزان.

مقابله با مشکلات مرتبط با عدم پیشرفت تحصیلی

درمان اختلالات و بدکارکردی‌های بالینی و اختلالات رفتاری مرتبط با عدم پیشرفت تحصیلی و ترک تحصیل، زمانی شروع می‌شود که هیچ مداخله پیشگیری‌کننده‌ای به کار گرفته نشده باشد یا در صورت به‌کارگیری موفق نشده و نتوانسته باشد عوامل محافظت‌کننده را در فرد افزایش دهد، عوامل خطرآفرین را کاهش دهد و از رشد نشانگان رفتاری بالینی پیشگیری کند.

از نظر بسیاری از متخصصان بالینی، هنوز هم در بیشتر اوقات درگیر کردن کودکان و خانواده‌های آنان در فرایند طرح‌ریزی درمانی و تشخیصی، بسیار مشکل است. بسیاری از خانواده‌های دارای مشکل، هنوز هم به کلینیک‌های روان‌پزشکی و یا مراکز مشاوره به منزله جایی نگاه می‌کنند که به فرد برچسب بیماری روانی می‌زنند، بنابراین از مراجعه به آن امتناع می‌کنند، درحالی‌که این مراکز را باید به‌عنوان مکانی در نظر گرفت که از فرد حمایت کرده، او را درک و مشکل او را حل می‌کنند.

یک راه‌حل مفید برای مقابله با این مشکلات، ایجاد و توسعه تیم‌های بررسی دانش‌آموزی است. این تیم‌ها می‌توانند با مشغول کردن نوجوانان دارای مشکل و والدین آنان در کنفرانس‌های مدرسه‌محور، مداخله‌های مبتنی بر مدرسه و شناساندن معلمان و مشاوران مدرسه به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها، فرایند حل مشکلات تحصیلی و مشکلات همبود با آن را تسهیل کنند. این فرایند

رشد و توسعه نگرش‌های حل مسئله، همکاری و مشارکت و همچنین اعتماد و همدلی را در میان شرکت‌کنندگان افزایش می‌دهد و تسهیل می‌کند.

کودکان و نوجوانانی که ترک تحصیل می‌کنند، ممکن است دارای نوعی اضطراب پیچیده بالینی (لاست، فرانسیس و استراس، ۱۹۸۹)، هراس (لاست، فیلیپس و استاتفیلد^۱، ۱۹۸۷)، نشانگان اجتنابی و افسردگی (کی یرنی^۲، ۱۹۹۳) همراه با اختلالاتی در توانایی یادگیری و توانایی‌های زبانی باشند (نایلور^۳ و همکاران، ۱۹۹۴) که ممکن است ناشی از استرس‌های محیطی و خانوادگی باشند. این عوامل تشن‌زا ممکن است رفتار خطرآفرین ترک تحصیل را تشدید و تقویت کنند. اصول درمانی برای مقابله با ترک تحصیل شامل هر نوع تلاش موجه و منطقی برای بازگرداندن هرچه سریع‌تر کودک و نوجوان به مدرسه است. این کار اغلب مستلزم همکاری و مشارکت دقیق دست‌اندرکاران مدرسه و خانواده کودک است. شیوه‌های تغییر رفتار، روان‌درمانگری شناختی - رفتاری و روش‌های مختلف حساسیت‌زدایی و همچنین خانواده درمانی، رویکردهای درمانی رایج مورد استفاده‌اند.

کروز نویی و الدر^۴ (۲۰۰۴) نقش پویایی‌های خانوادگی و روابط حمایتی را در پیشرفت و بهبود تحصیلی نوجوانان بررسی کردند. آنان با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از یک مطالعه طولی ملی که درباره سلامت نوجوانان انجام شده بود، یک سری مدل‌های ساختاری ارائه کردند. آنان دریافتند که نه تنها ارتباط با دوستان با رفتار تحصیلی نوجوانان رابطه مستقیم دارد، بلکه ارتباط با والدین و دریافت حمایت از آنان در نوجوانان آمریکایی و آسیایی، هنگام مواجهه با مشکلات تحصیلی، به‌مثابه عامل محافظت‌کننده عمل می‌کند. این محققان نتیجه گرفتند که بافت تحولی و ساختارهای بزرگ‌تر اجتماعی، نقش متقابل و پیچیده‌ای در وضعیت تحصیلی نوجوانان دارند.

خلاصه

عدم پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی ضعیف و شکست تحصیلی، از رفتارهای مشکل‌زای نوجوانان در مدرسه و آموزشگاه به‌شمار می‌روند. مطالعات جمعیت‌شناختی نشان داده‌اند که در ایالت متحده آمریکا ۱۲/۵ درصد نوجوانان و جوانان ترک تحصیل می‌کنند و فقر و تعلق به گروه‌های اقلیت احتمال ترک تحصیل و عدم ورود به دبیرستان را افزایش می‌دهد. این عوامل مشکل‌ساز و رفتارهای خطرناک مرتبط با آنها، احتمال بروز رفتارهای ضداجتماعی، بزهکاری و گرایش به مواد و جرم و

^۱ . Last, Phillips & Statfeld

^۲ . Kearney

^۳ . Naylor

^۴ . Crosnoe & Elder

زندانی شدن را افزایش می دهند. همچنین موجب می شوند که فرد بیکار بماند، وابستگی های رفاهی پیدا کند و در ادامه زندگی به صورت مستقل شکست بخورد.

این رفتارهای خطرناک ناشی از تعاملات پیچیده تحولی در زمینه های زیستی - ژنتیکی افراد، تجارب تجمعی روانی، اجتماعی و محیطی و سبک های شناختی خاص و ویژگی های شخصیتی است که افراد در مرحله خاصی از تحول در زندگی شان تجربه می کنند. در واقع، بافت های تاریخی فرهنگی خاص و عوامل سازمانی نظام مند روی فرد و فرایندهای روان شناختی او تأثیر سوء می گذارند و منجر به بروز رفتارهای خطرناکی می شوند که احتمال پیامدهای خطرناک را افزایش می دهد.

برای تعیین و مشخص کردن عوامل خطرآفرین تحولی زیستی - ژنتیکی، بافتی و آسیب زایی ژنتیکی و همچنین عامل های محافظت کننده و عوامل بهبوددهنده ای نظیر رفتارهای فرا اجتماعی که ممکن است اثر این عوامل خطرآفرین را کاهش دهند، تحقیقات بیشتری لازم است. بی گمان یک بُعد برجسته در این تحقیقات، تأکید بر نقش مداخلات مستدل و هوشمندانه انسانی در شناسایی و درمان نوجوانان در معرض خطر در موقعیت های تحصیلی، آموزشگاهی و حتی اجتماعی است.

پرسش هایی برای تفکر و اندیشیدن

(۱) به نظر شما چرا در کشور ما افت تحصیلی و ترک تحصیل در مقطع دبیرستان بیش از

سایر مقاطع تحصیلی است؟

(۲) آیا در نظام آموزشی ما بین افت و شکست تحصیلی و جنسیت رابطه ای وجود دارد؟

چرا؟

فصل یازدهم

اختلالات روانی

تعداد زیادی از نوجوانان از بدکارکردی‌ها و ناراحتی‌های هیجانی و روانی رنج می‌برند و مهم‌تر اینکه، گاه این اختلالات و ناراحتی‌ها تا بزرگسالی ادامه می‌یابند و مشکلات حاد و جدی را در سازگاری این افراد ایجاد می‌کنند. سلامت روانی کودکان و نوجوانان، اهمیت خاصی دارد، زیرا کودکان و نوجوانان سرمایه‌های عظیم هر کشوری به‌شمار می‌روند.

تراکم مشکلات خانوادگی و مشکلات اجتماعی از یک طرف و فشارهای روحی و عاطفی دوران بلوغ از سوی دیگر، در نوجوانان نوعی تشویش و نگرانی و عدم پایداری روانی ایجاد می‌کند و اختلالاتی را در شخصیت آنها به‌وجود می‌آورد. بعضی از این اختلالات سطحی و زودگذرند و چند روزی بیشتر دوام ندارند و گذشت زمان در بهبود آنها مؤثر است که اغلب حوادث محیطی ناراحت‌کننده و نیز درگیری با والدین، طردشدن از طرف گروه همسالان و شکست خوردن در موضوعی که موجب پیدایش اضطراب و افسردگی شدید می‌شود، از عوامل آنها به‌شمار می‌روند. بعضی از اختلالات روانی نیز از اختلال‌های عمیق و جدی شخصیت به‌شمار می‌روند که هم علائم بیماری بتدریج آشکار می‌شود و نمی‌توان عامل محیطی خاصی را در پیدایش آنها تشخیص داد و هم درمان و معالجه فرد به زمان طولانی احتیاج دارد و بیمار باید زیر نظر متخصص باشد. در این فصل، به مشکلات و اختلالات روانی این دوره بیشتر پرداخته می‌شود که اهم آنها به قرار زیر است: ترس و اضطراب و اختلال‌های اضطرابی نظیر هراس‌های خاص، هراس اجتماعی، وسواس و وحشت‌زدگی؛ افسردگی؛ اسکیزوفرنیا و خودکشی.

ترس و اضطراب

ترس^۱ و اضطراب^۲، هیجان‌های مهم و بهنجاری هستند که همه افراد در طول زندگی آنها را تجربه می‌کنند. دانشمندان اعتقاد دارند که ترس نقش اساسی و باارزشی در آماده ساختن فرد برای مقابله با خطر و متمرکز کردن توجه و منابع فیزیکی او برای آمادگی برای جنگ یا فرار دارد (بارلو،

^۱ . fear

^۲ . anxiety

(۱۹۸۸). تجربه مکرر موقعیت‌های برانگیزاننده ترس، برای فرد فرصت‌هایی برای یادگیری پاسخ‌های مناسب شناختی و رفتاری برای تسلط بر چنین موقعیت‌هایی ایجاد می‌کند؛ همچنین فرد با تجربه این موقعیت‌ها می‌آموزد که موقعیت‌های تهدیدکننده واقعی را از موقعیت‌های غیرواقعی و نادرست تشخیص دهد. ترس در کودکان، بخش اساسی تحول بهنجار است. اما در بعضی از کودکان و نوجوانان، ترس و اضطراب شدید و طولانی‌مدت ممکن است منجر به ایجاد وقفه در فعالیت‌های روزانه و کیفیت زندگی شود. برخلاف ترس که واکنشی است در مقابل یک هشدار فوری، اضطراب حالت خلقی یا هیجانی است که توسط عواطف منفی با تنش و تنیدگی توأم با این احساس که اتفاق بدی در شرف وقوع است، مشخص می‌شود. نشانگان روان‌شناختی همراه با اضطراب عبارتند از: افزایش ضربان و تپش قلب، کشیدگی عضله و بی‌قراری. اضطراب را می‌توان تا حدودی به‌کمک تفکر چه خواهد شد، مشخص کرد. تفکراتی نظیر اینکه اگر در امتحان شکست بخورم چه خواهد شد؟ یا اگر پدر و مادرم از یکدیگر طلاق بگیرند چه خواهد شد؟ کودکان و نوجوانان ممکن است در مورد عملکرد تحصیلی، روابط اجتماعی، مهارت‌های جسمی و بدنی و موضوعات خانوادگی اضطراب داشته باشند.

اگر فرد با خطری فوری مواجه شود یا درباره موقعیتی تنش‌زا و ناراحت‌کننده نگران باشد، ترس و اضطراب از طریق سه مؤلفه متمایز اما دارای تأثیرات متقابل مشخص می‌شوند؛ مؤلفه روان‌شناختی ترکیبی از واکنش‌های فیزیکی افراد، نظیر احساس پاسخ جنگ یا فرار یا تجربه تنیدگی، اختلال در خواب و عدم تمرکز حواس است؛ مؤلفه شناختی، شامل تمام افکار، تصورات، باورها، تعبیر و تفسیرها و اسنادهایی است که فرد درباره موقعیت و پیامدهای مورد انتظار آن دارد؛ مؤلفه رفتاری شامل واکنش‌های حرکتی است که عبارتند از: اجتناب، فرار و غیره. اغلب در نوجوانان اضطراب با افسردگی و خشم ارتباط دارد (لونینگان^۱ و همکاران، ۱۹۹۴).

روندهای تحولی

نتایج تحقیقات نشان داده‌اند که کودکان و نوجوانان ممکن است ۹ تا ۱۳ نوع از ترس‌ها و نگرانی‌های افراطی را در زمان خاصی از رشد و تحول تجربه کنند. به‌نظر می‌رسد که ترس در کودکان در حدود ۸ سالگی افزایش یابد، زیرا مطابق با سطح تحول شناختی آنان، در این سن توانایی استدلال و در نظر گرفتن پیامدهای منفی ممکن در آینده افزایش می‌یابد. نوجوانان در مقایسه با کودکان ۱۲ ساله، کمتر ترس‌های مرتبط با جدایی و بیشتر ترس‌های مرتبط با نگرانی‌های اجتماعی و

^۱ Lonigan

ارتباطی و عدم کفایت فردی از خود نشان می‌دهند. خلاصه‌ای از ترس‌ها و اضطراب‌های کودکان و نوجوانان در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ۱۱-۱. ترس‌ها و اضطراب‌های مرتبط به سطوح سنی متفاوت در کودکان و نوجوانان

سن	نوع ترس یا اضطراب
۶-۰ ماهگی	صداها، بلند، محرک حسی شدید.
۹-۶ ماهگی	محرک‌های غیرقابل انتظار یا ناگهانی مثل صدای بلند، ترس از غریبه‌ها.
۱ سالگی	جدایی از مادر، صدمه دیدن، توالت، غریبه‌ها.
۲ سالگی	دامنه‌ای از ترس‌های مرتبط با صداها، بلند مثل رعدوبرق، حیوانات، تاریکی، جدایی از مادر یا افرادی که از کودک نگهداری می‌کنند.
۳ سالگی	حیوانات، ماسک‌ها و صورتک‌ها، تنهایی، جدایی از نزدیکان.
۴ سالگی	تاریکی، حیوانات و صداها.
۵ سالگی	حیوانات، افراد بد، تاریکی و جدایی از نزدیکان.
۶ سالگی	هیولا، غول، موجودات ماورای طبیعی، صدمات بدنی، خوابیدن به تنهایی، جدایی از نزدیکان (رفتن به مدرسه).
۸-۷ سالگی	هیولاها، غول‌ها، موجودات غیرطبیعی مثل روح یا آنهایی که در فیلم‌ها و داستان‌ها وجود دارند، وقایع غیرمعمول مانند بمب‌گذاری، جنگ، تنها ماندن، صدمه خوردن.
۱۲-۹ سالگی	آزمون‌ها، امتحانات، گزارش‌های شفاهی، پاسخ دادن با صدای بلند به پرسش‌های معلم و موقعیت‌های تحصیلی مشابه، طرد شدن از طرف همسالان و مردود شدن.
۱۸-۱۳ سالگی	انزوای اجتماعی، شرم، خجالت و دستپاچگی، شکست، عملکردهای تحصیلی، مرگ، صدمه خوردن یا ابتلا به بیماری شدید، حوادث و بلایای طبیعی یا ساخته دست انسان.

منبع: برگرفته از واکر و روبرتس، ۲۰۰۱

تومب و هانت^۱ (۲۰۰۴)، معتقدند موقعیت‌های تحصیلی و آموزشی به دلیل پیچیدگی‌های محیطی، یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های ایجادکننده اضطراب در نوجوانان به‌شمار می‌روند، ازاین‌رو یکی از بهترین موقعیت‌ها برای انجام مداخله‌های پیشگیرانه و درمانی برای اختلالات درونی‌سازی

^۱ . Tomb & Hunter

نظیر اضطراب و افسردگی اند، چراکه به طور معمول اضطراب نوجوانان با حوزه های تحصیلی، برقراری ارتباط، روابط با همسالان و تحول اجتماعی - هیجانی آنها ارتباط دارد.

علائم و نشانه های بالینی ترس و اضطراب

متخصصان سلامت روان دستورالعمل هایی را برای متمایز ساختن واکنش های ترس بهنجار از اضطراب های آسیب رسان مطرح کرده اند. این دستورالعمل ها بر اساس نظام های طبقه بندی روان پزشکی و اطلاعات به دست آمده از مطالعه و بررسی شرایط، زمان و وضعیت آسیب های روانی صورت گرفته است (انجمن روان پزشکان آمریکا، ۲۰۰۰). کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات اضطرابی، در عمل از نظر مدت، محتوا، شدت، فراوانی و علائم و نشانگان اضطرابی با کودکان و نوجوانان بهنجار تفاوت دارند. این تفاوت ها در زیر فهرست شده اند:

- ۱- شدت واکنش ترس متناسب با تقاضاهای عملی یا تهدید ناشی از موقعیت نیست. برای مثال اگر کودکی هنگام رجوع به دکتر جیغ بکشد، بی قراری کند، لگد بزند و توسط چند فرد بزرگسال در مطب نگاه داشته شود، ممکن است به عنوان فرد مبتلا به هراس، مشخص شود.
 - ۲- واکنش ترس با فراوانی زیاد رخ می دهد و با استدلال، توجیه و اطمینان دادن به کودک کنترل نمی شود.
 - ۳- محتوای ترس متمرکز بر موقعیت بی خطر یا محرک بی ضرر است که به کودک صدمه نمی رساند، مانند ترس از مدرسه رفتن، ترس از صداها یا شخصیت های معمولی.
 - ۴- واکنش ترس به صورت خودکار و خود به خودی صورت می گیرد و کودک نمی تواند کنترلی بر آن داشته باشد.
 - ۵- واکنش ترس منجر به فرار یا اجتناب از موقعیت می شود، برای مثال، ممکن است کودکی به دلیل ترس از رعد و برق نتواند در روز بارانی در خانه تنها بماند.
- گاهی ترس نوجوانان غیرمنطقی است. این ترس های غیرمنطقی ممکن است متوجه خصوصیات بدنی باشد و فرد از ابتلا به بیماری خاصی بترسد. بررسی های انجام شده در دانشجویان، دانش آموزان و کارگران جوان کشورمان نشان داد که در بین آنان ترس غیرمنطقی وجود دارد. نتایج یکی از این پژوهش ها (بالایان، ۱۳۷۴) را در جدول ۱۱-۲ مشاهده می کنید.

جدول ۱۱-۲. درصد ترس‌های غیرمنطقی در جوانان

جوانان	سن	درصد ترس‌های غیرمنطقی
دانشجویان	۲۵	۲۷
دانش‌آموزان	۱۳-۱۵	۶۵
دانش‌آموزان	۱۵-۱۸	۳۴
کارگران	۱۳-۱۵	۸۵
کارگران	۱۵-۱۸	۶۱

همان‌گونه که در جدول ۱۱-۲ مشاهده می‌شود، میزان ترس‌های غیرمنطقی در کارگران ۱۳ تا ۱۸ سال و دانش‌آموزان ۱۳ تا ۱۵ سال بیشتر از دانشجویان است.

انواع اساسی و اصلی اختلالات اضطرابی

سن شروع اختلال اضطراب جدایی، براساس DSM-IV-TR قبل از ۱۸ سالگی است. این اختلال توسط اضطراب افراطی و شدیدی که با جدا شدن از خانه یا افرادی که فرد به آنها دلبستگی شدیدی دارد، مثل والدین، مشخص می‌شود. این کودکان می‌ترسند که مبادا واقعه یا حادثه خاصی موجب جداشدن آنها از والدین شود، برای مثال گم شدن در خیابان و غیره. این کودکان بشدت از تنها ماندن ترس دارند و همیشه با والدین خود می‌خوابند. در موارد شدید و حاد، این کودکان، به والدین خود می‌چسبند و از تنها ماندن در هر زمانی امتناع می‌کنند. این اختلال می‌تواند در هر سنی و حتی در نوجوانی بروز کند، اما سن شیوع آن مربوط به دوران قبل از بلوغ است. حالات اختلال اضطراب جدایی با سن تغییر پیدا می‌کند. کودکان کوچک‌تر ممکن است به والدین خود بچسبند، درحالی‌که ممکن است ذهن کودکان بزرگ‌تر برای مدتی طولانی مشغول به افکار مربوط به جدایی شود. به‌طور معمول ترس و نگرانی‌های کودکان ۵ تا ۸ ساله به‌طور شایعی مربوط به ترس از دست دادن محبت دیگران و ترس از مدرسه است. کودکان ۹ تا ۱۲ ساله، اختلالات و آشفتگی‌های هیجانی از خود نشان می‌دهند و نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله دچار مشکلات جسمی می‌شوند و از مدرسه رفتن امتناع می‌کنند.

هراس‌های خاص. برخلاف ترس‌های بهنجار دوران کودکی، هراس‌ها^۱، ترس‌هایی افراطی، شدید و غیرقابل کنترل‌اند که منجر به بروز رفتارهای سازش‌نا یافته می‌شوند (میلر^۲، بارت و هامپ، ۱۹۷۴).

^۱ . phobias

^۲ . Miller

هراس‌های رایج کودکان عبارتند از: ترس شدید از حیوانات، توفان، تاریکی، آمپول و مکان‌های بلند. هراس‌ها در کودکی و نوجوانی و حتی در سال‌های اول کودکی دیده می‌شوند و ناشی از تجربه یک واقعه یا حادثه آسیب‌رسان نیستند. کودکان در مقایسه با بزرگسالان سریع‌تر درمان می‌شوند، اما در تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان این هراس‌ها در طول زمان باقی می‌مانند، به‌طوری‌که منجر به بروز اغتشاش در بسیاری از کارها و عملکردهای روزانه آنان می‌شوند.

هراس اجتماعی. این اختلال با ترس شدید از موقعیت‌های اجتماعی یا موقعیت‌هایی که با ارزیابی از فرد همراهند، موقعیت‌هایی که طی آن کودک با افراد غریبه و ناآشنا مواجه می‌شود یا ممکن است توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد، مشخص می‌شود. افراد دارای هراس اجتماعی، بسیار خودآگاه و هشیارند و احساس شرم دارند و ممکن است فاقد جرأت باشند. کودکان و نوجوانان مبتلا به این هراس، همیشه از شکست اجتماعی و ارزیابی منفی، خجالت، سراسیمگی و دستپاچه شدن ترس دارند. در موارد شدید، ممکن است، لالی انتخابی نیز پیش بیاید (وضعیتی که طی آن کودک از صحبت کردن در خارج از خانه امتناع می‌کند). زمان شروع هراس اجتماعی اغلب مربوط به اوایل نوجوانی یعنی ۱۲ یا ۱۳ سالگی است.

خانواده درمانی یکی از روش‌های مؤثر درمان هراس اجتماعی است. خدایاری فرد و پرنده (۱۳۸۴) گزارشی از دو مورد درمان موفقیت‌آمیز اختلال هراس اجتماعی (یک پسر ۱۸ ساله و یک دختر ۲۰ ساله) با استفاده از روش خانواده درمانگری شناختی- رفتاری ارائه کرده‌اند. فنون مورد استفاده در جلسات روان‌درمانگری خانوادگی شامل آموزش حل مسئله، تنش‌زدایی، مثبت‌نگری و بازسازی شناختی با استفاده از جدول خودبازبینی افکار و رفتارهای غیرمنطقی بوده است.

وسواس

کودکان اغلب رفتارهای وسواسی - اجباری نرمال و بهنجار مرتبط با سن خود را به‌وفور به نمایش می‌گذارند، رفتارهایی نظیر احساس کنترل و تسلط یافتن (مارش و مول^۱، ۱۹۹۸؛ به نقل از واکرو روبرتس^۲، ۲۰۰۱). در بعضی موارد ممکن است کودکان بر نظم و ترتیبی اصرار داشته باشند که همراه با حفظ عادت و آداب خاصی برای زمان خواب است. این نوع آداب و آیین‌های متناسب از نظر تحولی در دوره کودکی اولیه یعنی در ۴ تا ۸ سالگی بروز می‌کنند و برای ترویج و توسعه تسلطیابی و افزایش میزان جامعه‌پذیری آنان مفیدند. در مقابل، رفتارهای وسواسی، اجباری و آیینی

^۱ . March & Mulle

^۲ . Walker & Roberts

که مشخص‌کنندهٔ کودکان دارای اختلال وسواس بی‌اختیاری‌اند، بیشتر در سال‌های بعد شکل می‌گیرند و نشان داده می‌شوند، یعنی در ۱۰ سالگی. این رفتارها بسیار شدید، افراطی، ناتوان‌کننده‌اند و موجب نگرانی شده و منجر به انزوای اجتماعی و وقفه در جامعه‌پذیری کودکان می‌شوند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که پسرها نسبت به دخترها در سنین کمتر به این اختلال مبتلا می‌شوند، یعنی در ۹ سالگی، درحالی‌که در دخترها سن شروع این اختلال در حدود ۱۱ سالگی و سنین قبل از بلوغ است (لئونارد^۱ و همکاران، ۱۹۹۳).

اختلال وسواس بی‌اختیاری در کودکان و نوجوانان از نظر شدت و مجموعهٔ نشانگان خاص آن و مدت زمان پایداری، تفاوت دارد. در برآوردی که از میزان بروز این اختلال در کودکان شده، دیده شده است که ۲ درصد کودکان به این اختلال مبتلا دارند (هالینگزورث^۲ و همکاران، ۱۹۸۰). مطالعهٔ فلامنت^۳ و همکاران (۱۹۸۵) نشان داد ۳۳ درصد دانش‌آموزان دبیرستانی به این اختلال مبتلا هستند. اغلب کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۱۲ ساله، هم وسواس فکری و هم وسواس عملی دارند. وسواس‌های مختلف کودکان و نوجوانان شامل موارد زیر است: وسواس شست‌وشو که شایع‌ترین وسواس عملی در بین کودکان و نوجوانان است (۸۵ درصد)؛ وسواس چک کردن و واریسی‌های مکرر نیز در این سنین بسیار شایع است (در حدود ۵۱ درصد)؛ وسواس کثیفی و آلودگی؛ وسواس آسیب رساندن به خود و افراد دیگری که فرد آنها را دوست دارد و وسواس‌های مذهبی (واکر و روبرتس، ۲۰۰۱). نتایج پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که وسواس بی‌اختیاری سیر طولانی‌مدت و پایداری دارد، در این زمینه تامسون و مایکلسن^۴ (۱۹۹۵) گزارش کرده‌اند که در حدود ۵۰ درصد کودکان و نوجوانانی که مبتلا به این اختلال هستند، تا ۵ سال پس از درمان نشانگان وسواس از خود نشان می‌دهند.

روش‌های درمانی پیشنهادی برای درمان این اختلال در کودکان و نوجوانان شامل درمان روان‌پویشی^۵، رفتاردرمانی، شناخت‌درمانی، شناخت - رفتاردرمانی، خانواده‌درمانی و دارودرمانی است که گاه به‌صورت انفرادی و گاه به‌صورت ترکیبی به‌کار می‌روند.

بارت، هیلی - فارل و مارش^۶ (۲۰۰۴)، کارایی خانواده‌درمانی شناختی - رفتاری انفرادی و خانواده‌درمانی شناختی - رفتاری گروهی را در درمان ۷۷ نوجوان مبتلا به اختلال وسواس بی‌اختیاری مقایسه کردند. آنان این ۷۷ نوجوان را به‌طور تصادفی به سه گروه تقسیم کردند، گروه

^۱. Leonard

^۲. Hollingsworth

^۳. Flament

^۴. Thamsen & Mikkelsen

^۵. psychodynamic

^۶. Barrett, Healy - Farrell & March

خانواده درمانگری شناختی - رفتاری انفرادی، گروه خانواده درمانگری شناختی - رفتاری گروهی و گروه کنترل که اسم آنها در فهرست انتظار نوشته شده بود. کلیه این نوجوانان قبل و بعد از درمان و طی پیگیری ۶ ماهه با استفاده از مصاحبه‌های تشخیصی ارزیابی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو گروه خانواده درمانگری شناختی - رفتاری انفرادی و گروهی پس از شرکت در جلسات درمانی (۱۴ جلسه هر هفته یک‌بار)، بهبود پیدا کردند، درحالی‌که افراد گروه کنترل هیچ تغییر معناداری را در نشانگان و شدت وسواس خود گزارش نکردند. از نظر کارایی هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایشی مشاهده نشد.

خدایاری فرد و عابدینی (۱۳۸۰) طی یک گزارش موردی به مقایسه کارایی شناخت رفتاردرمانی به تنهایی و در ترکیب با دارودرمانی در درمان وسواس بی‌اختیاری نوجوانان پرداختند. آنها دریافتند که شناخت - رفتاردرمانی به تنهایی درمان کارآمدتری برای درمان وسواس فکری - عملی نوجوانان و اختلالات همبود با آن است.

خدایاری فرد و عابدینی (۱۳۸۲) در گزارش موردی دیگری کارایی خانواده درمانی شناختی - رفتاری را در درمان دو کودک و یک نوجوان بررسی کردند و اعتقاد دارند به کارگیری روش‌های شناختی - رفتاری نظیر خودکنترلی با استفاده از خودبازبینی، خودتشویقی و خودتنبیهی، مثبت‌نگری و جایگزینی افکار مثبت و منطقی به جای افکار غیرمنطقی، در موقعیت‌های درمانی خانوادگی تأثیر زیادی در درمان وسواس فکری و عملی در کودکان و نوجوانان دارد.

گلر^۱ و همکاران (۲۰۰۳) با انجام یک فراتحلیل، کارایی دارودرمانی را با استفاده از داروهای بازدارنده انتخابی جذب مجدد سرتونین، نظیر پاروکستین^۲، فلوکستین^۳، فلوواکسامین^۴ و سرترالاین^۵ در درمان اختلال وسواس بی‌اختیاری نوجوانان بررسی کردند. نتایج نشان داد که دارودرمانی کارایی بیشتری در مقایسه با استفاده از دارونما^۶ در درمان این اختلال در نوجوانان دارد. همچنین مشاهده شد که کلومیپرامین تأثیر زیادتری در درمان وسواس دارد تا چهار داروی بازدارنده مذکور.

^۱ . Geller

^۲ . Paroxetine

^۳ . Fluoxetine

^۴ . Fluvoxamine

^۵ . Sertraline

^۶ . Placebo

اختلال وحشت‌زدگی^۱

یکی از بحث‌انگیزترین اختلالات اضطرابی نوجوانان، اختلال وحشت‌زدگی است. افراد مبتلا به این اختلال، دارای احساس‌های درونی به‌صورت نظام جنگ و گریز و ترس‌اند. به‌عبارت دیگر، در افراد مبتلا به اختلال وحشت‌زدگی، تعبیر و تفسیر نادرست از خطر منجر به تپش قلب، نفس نفس زدن، احساس سوزش، نورهای شطرنجی و کشیدگی عضلات می‌شود. تعبیر و تفسیرهای نادرست شناختی، شامل ترس از مرگ، ترس از دیوانه شدن و از دست دادن کنترل است. این افراد اغلب رفتارهای اجتنابی زیادی برای جلوگیری از وقوع حمله‌های وحشت‌زدگی تدارک می‌بینند. در کودکان ممکن است رفتارهای اجتنابی شامل خودداری از رفتن به مدرسه یا سوار شدن به سرویس مدرسه باشد. فرد زمانی مشکوک به داشتن این اختلال است که حداقل در ماه، یک‌بار به حمله وحشت‌زدگی دچار شود و به دنبال آن ترس از حملات بعدی در آینده حداقل به مدت یک ماه یا بیشتر پایدار بماند و نگرانی درباره آثار حمله وحشت‌زدگی و نتایج و پیامدهای آن همچنان تا ماه‌ها وجود داشته باشد، به‌طوری‌که تغییر معناداری در رفتار فرد ایجاد کند (انجمن روان‌پزشکان آمریکا، ۲۰۰۰). حملات وحشت‌زدگی در کودکان نیز رخ می‌دهد (موریو و فولت^۲، ۱۹۹۳). با این حال، حملات وحشت‌زدگی در میان نوجوانان شایع‌تر است. بر این اساس، بعضی اعتقاد دارند که سن شروع این اختلال در نوجوانی است. به‌نظر می‌رسد میزان حملات وحشت‌زدگی با رشد و تحول بلوغ جنسی افزایش می‌یابد. اغلب نشانگان این اختلال در نوجوانان شامل لرزیدن، سست شدن، تکان خوردن، تپش قلب، سرگیجه، تهوع، بریدگی نفس، نفس نفس زدن، عرق کردن، ترس از مردن و از دست دادن کنترل است (کی‌یرنی و همکاران، ۱۹۹۷). دگرسان‌بینی^۳ خود که اصلاً در بین کودکان شایع نیست و عدم شیوع آن احتمالاً مربوط به سطح تحول شناختی کودکان است، در نوجوانان گاهی مشاهده می‌شود.

در مطالعه‌ای خدایاری‌فرد و عابدینی (۱۳۸۴) گزارشی از یک مورد درمان موفقیت‌آمیز اختلال وحشت‌زدگی در دختر دانشجوی ۲۴ ساله با استفاده از فنون مربوط به روان‌شناسی خود و روابط موضوعی ارائه کردند. محققان در این پژوهش با شناخت رابطه دلبستگی ناامن بین آزمودنی و پدرش با استفاده از فن تداعی آزاد و با تأکید بر ناهشیار، تحلیل پدیده انتقال، تقویت "من" و اصل واقعیت‌نگری به درمان آزمودنی پرداختند. شایان ذکر است که آزمودنی پس از شرکت در ۴۷ جلسه

^۱ . Panic disorder

^۲ . Moreau & Follett

^۳ . depersonalization

یک ساعته روان‌درمانگری به‌طور کامل درمان شد و طی پیگیری یک ساله هیچ‌گونه نشانه‌ای از برگشت بیماری در او مشاهده نشد.

درمان اختلالات اضطرابی نوجوانان

مهم‌ترین مداخله‌های درمانی شناخته‌شده برای درمان نوجوانان که مورد حمایت‌های تجربی نیز قرار گرفته‌اند، درمان‌های رفتاری و شناختی رفتاری هستند (آلن‌دیک و کینگ^۱، ۱۹۹۸). از میان مداخلات درمانی رفتاری، حساسیت‌زدایی در موقعیت‌های واقعی زندگی، مواجهه، غرقه‌سازی^۲، غرقه‌سازی تجسمی، شرطی‌سازی کنش‌گر و سرمشق‌دهی (از طریق فیلم‌ها و شرکت در جلسات واقعی)، مهم‌ترین شیوه‌هایی هستند که می‌توان آنها را به تنهایی یا با سایر روش‌ها به‌کار گرفت. شیوه‌های شناختی - رفتاری شامل خودبازبینی، حساسیت‌زدایی تجسمی، تجسم برانگیزنده و آموزش مهارت‌های مقابله‌ای نظیر گفت‌وگو با خود به‌طور مثبت، روش‌های خود - آموزش‌دهی کلامی، توقف افکار، تقویت خود و تنش‌زدایی است (کرونبرگر و میر^۳، زیر چاپ). مداخله‌های رفتاری در وهله اول بر روش‌های مواجهه تأکید دارند که مشغولیت کودک به رفتار اجتنابی را کنترل می‌کنند و پس از آن، بر تقویت رفتارهای مثبت و مخالف با ترس و اضطراب تأکید می‌کنند. مداخله‌های شناختی - رفتاری بر آموزش مشخص کردن نشانه‌های خاص اضطراب نوجوان و سپس به‌کارگیری پاسخ‌های مقابله‌ای رفتاری و شناختی خاص تأکید می‌کنند، ازاین‌رو برای نوجوانان بزرگ‌تر مناسب‌ترند. در این روش‌ها، ادراکات، تصورات، افکار و باورهای نوجوان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و شناخت‌های نادرست، تحریف‌شده و سازش‌نیافته بازسازی می‌شوند. به‌علاوه، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که استفاده از روش خانواده‌درمانی همراه با روش‌های شناختی - رفتاری تأثیر بسزایی در درمان اختلالات اضطرابی دارد (آلن‌دیک و کینگ، ۱۹۹۸؛ خدایاری‌فرد و عابدینی، ۱۳۸۲).

گاه در شرایطی که والدین بیش از حد و به‌صورت افراطی به فرزند خود متکی و وابسته‌اند و او را برای وابستگی افراطی و شدید تقویت می‌کنند، خانواده‌درمانی مورد نیاز است (میر، ۱۹۹۳). ممکن است والدین در چنین شرایطی برای به‌کارگیری توصیه‌های درمانی انگیزه‌ای نداشته باشند و حتی به‌طور آشکاری با آنها مخالفت کنند. در این گونه موارد، نشانگان اجتنابی نوجوان در عمل تأثیر خاصی بر محیط خانواده دارد. در این مواقع، به‌کارگیری خانواده‌درمانی همراه با شیوه‌های شناختی - رفتاری برای حل دقیق مسائل و مشکلات اعضای خانواده و حتی نزدیکان نوجوان ضروری است.

^۱ . Ollendick & King

^۲ . flooding

^۳ . Kronenberger & Meyer

یکی از پرسش‌هایی که ذهن بیشتر والدین دارای نوجوان مبتلا به اختلالات اضطرابی را به خود مشغول می‌کند، این است که آیا دارودرمانی می‌تواند بخشی از فرایند درمان باشد. علاوه بر این، بعضی از والدین هیچ تمایلی به استفاده از دارو برای فرزند خود نشان نمی‌دهند و بیشتر تمایل دارند اختلال فرزند خود را از طریق درمان‌های روان‌شناختی برطرف کنند. به‌طور کلی، تا به امروز، مطالعات تجربی کمی در مورد کارایی داروهای خاص برای درمان نوجوانان مبتلا به اختلالات اضطرابی انجام شده است، البته در مورد اختلال وسواس بی‌اختیاری، استثنا وجود دارد. با این حال، نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حتی در مورد اختلال وسواس بی‌اختیاری به‌کارگیری درمان‌های روان‌شناختی توأم با دارودرمانی تأثیر بیشتری تا دارودرمانی به تنهایی دارد (مارش و همکاران، ۱۹۹۷).

مشکلات حاد روانی

سلامت روانی نوجوانان و جوانان، موضوع بحث‌برانگیزی است که فقط در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و آنها به مطالعه و بررسی موضوعات مرتبط با آن در نوجوانان پرداخته‌اند (کازدین، ۱۹۹۳). در این قسمت ناراحتی‌های مهم روحی و روانی نظیر اسکیزوفرنیا، افسردگی و خودکشی در نوجوانان مطرح می‌شود. افسردگی، اغلب با خودکشی مرتبط است و خودکشی نیز یکی از علل مهم مرگ و میر در میان نوجوانان و جوانان به‌شمار می‌رود، بویژه در میان پسران جوان. اگرچه بخش کوچکی از جامعه بزرگسالان مبتلا به اسکیزوفرنیا هستند، اما این اختلال، اختلالی مخاطره‌انگیز است که می‌تواند ریشه در سال‌های نوجوانی داشته باشد. اسکیزوفرنیا نیز مانند افسردگی با خودکشی رابطه دارد. بنابراین بسیار حیاتی و مهم است که متخصصان و والدین درک کاملی از میزان شیوع، ماهیت و سبب‌شناسی این رفتارها داشته باشند.

اسکیزوفرنیا

اسکیزوفرنیا، اختلالی روان‌پریشی است که در دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی آشکار می‌شود. اسکیزوفرنیا، یک حالت روانی است که در آن افراد از تفکر آشفته رنج می‌برند. برآورد شده، که در حدود ۱ درصد جامعه بزرگسالان از این اختلال رنج می‌برند (ارلنمیر - کیملینگ و کورن بلات^۱، ۱۹۹۱).

^۱ . Erlenmeyer – Kimling & Cornblatt

نشانه‌های بالینی

به‌نظر متخصصان سلامت روان، چندین ویژگی مشخص‌کننده وجود دارند که وجود تعدادی از این ویژگی‌ها برای تشخیص این اختلال ضرورت دارد. دیویسون و نیل^۱ (۱۹۹۴)، نشانگان زیر را برای اسکیزوفرنیا خلاصه کرده‌اند: نشانگان مثبت، گفتار بدون ساختار، توهم‌ها، هذیان‌ها و اختلالات ادراکی و نشانگان منفی، بی‌احساسی یا فقدان انرژی، اختلالات تفکر منفی، ناتوانی در داشتن تجربه خوشایند. این محققان نشانگان مثبت را با عنوان گفتار بدون ساختار شدید که با اختلال تفکر توأم است، شرح داده‌اند. برای مثال، به‌نظر می‌رسد که کلام افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به‌طور کلی بی‌ربط و بدون پیوستگی باشد و هر جمله با جمله قبلی و بعدی ارتباط کمی داشته باشد، همچنین الگوی تفکر، بی‌ارتباط با تفکرات بعدی است. اختلال تفکر موجود در بسیاری از افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا نشان می‌دهد که آنها از هذیان رنج می‌برند. به‌نظر می‌رسد این افراد هیچ درکی از علت و شدت بیماری خود ندارند. بنابراین تمایل دارند واقعیت را به‌صورت نادرستی تعبیر و تفسیر کنند. افراد مبتلا به این اختلال انواع خاصی از هذیان را دارا هستند. برای مثال، بعضی از افراد اسکیزوفرنیایی از تفکر اضافی یا اعتقاد به اینکه افکار عجیب و غریب به ذهن آنها خطور می‌کند، بشدت رنج می‌برند. بعضی از آنها معتقدند که اطرافیان‌شان از افکار آنان اطلاع دارند. حتی برخی از آنها معتقدند دیگران افکار آنها را می‌دزدند. افراد اسکیزوفرنیایی اغلب از اختلال‌های ادراکی رنج می‌برند، اختلالاتی نظیر انواع توهم‌ها. آنها ممکن است اظهار کنند افکار و صداهایی را می‌شنوند و با صاحب آنها مکالمه می‌کنند. نشانگان منفی نیز به‌صورت مشکلات رفتاری مشخص شده‌اند. به بیان دیگر، افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا فاقد انرژی یا انگیزه بوده و بسیار بی‌احساس‌اند. خیلی از آنها نمی‌توانند شادی و خوشحالی را تجربه کنند و بسیاری از آنها از فقدان هیجان رنج می‌برند. علائم و نشانه‌های دیگری که از ویژگی‌های افراد اسکیزوفرنیایی به‌شمار می‌روند عبارتند از انزوا، گوشه‌گیری و عدم تحرک، عواطف نامتناسب و رفتارهای عجیب و غریب و انعطاف‌پذیری موم‌وار.

اسکیزوفرنیا و خودکشی

میزان خودکشی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا در حدود ۱۰ درصد است (وسترمر^۲، ۱۹۹۳). بنابر نتایج به‌دست آمده از مطالعه سوئدی، اقدام به خودکشی در افراد اسکیزوفرنیایی در حدود ۱۰ برابر جامعه کلی و میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی در آنان نیز دو برابر افراد جامعه کلی است. نتایج

^۱ . Davison & Neale

^۲ . Westermeyer

پژوهش‌ها نشان‌دهنده سه نوع نظریه درباره خودکشی در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرنیاست؛ اولاً برخی از افراد اسکیزوفرنیایی انتظارات بسیار زیادی از خودشان دارند، از این رو وقتی نمی‌توانند به این امیدها و انتظارات جامه عمل بپوشانند، دست به خودکشی می‌زنند؛ ثانیاً این افراد بسیار ناامید، غمگین یا افسرده‌اند و این رنج بردن از درماندگی و غمگینی ممکن است آنها را به سمت خودکشی سوق دهد؛ ثالثاً، دوره‌ای که بلافاصله به دنبال تشخیص قرار می‌گیرد، دوره مهمی است، زیرا زمانی است که فرد تشخیص را قبول می‌کند و می‌خواهد با شرایط خود سازگار شود. این دوره حساس و مهم ۶ تا ۸ سال باقی می‌ماند، بنابراین خطر اقدام به خودکشی را در میان نوجوانان مبتلا به اسکیزوفرنیا پیش می‌آورد.

پیشایندها و علل اسکیزوفرنیا

اسکیزوفرنیا، ممکن است معلول عوامل ژنتیکی، زیست - شیمیایی یا تنش‌زا باشد. اگرچه هر کدام از این عوامل به‌طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرند، اما بعضی از این عوامل در پیدایش اسکیزوفرنیا با یکدیگر تعامل دارند (برای مثال تنیدگی‌ها و عوامل زیستی - شیمیایی). مطالعاتی که روی دوقلوها انجام شده، می‌تواند نقش عوامل وراثتی و محیطی را در اختلالات روانی، نظیر اسکیزوفرنیا مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که دوقلوهای همسان ژن‌های یکسانی دارند، تصور می‌رود که شباهت در رفتار و شخصیت آنها مرتبط با تأثیرات ژنتیکی و ارثی باشد. از سوی دیگر، والدین پرورش‌دهنده آنها و کودکانی که توسط والدین آنها پرورش می‌یابند، محیط یکسان و مشابهی را تجربه می‌کنند که اعتقاد بر این است نشان‌دهنده نقش عوامل محیطی در بروز اسکیزوفرنیاست.

بارنس^۱ (۲۰۰۴) رابطه میان نژاد، ابتلا به اسکیزوفرنیا، اختلالات خلقی و رجوع به بیمارستان‌های روان‌پزشکی در نوجوانان را بررسی کرد. بدین منظور ۲۳۱۱ نوجوان را که طی ۸ سال به بیمارستان‌های روانی رجوع کرده بودند، مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که در مقایسه با کل جامعه، نوجوانان آمریکایی آفریقایی تبار (سیاه‌پوست) بیشتر از سایر اقشار جامعه به اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی مبتلا می‌شوند، به‌طوری‌که میزان ابتلا به اسکیزوفرنیا در این نوجوانان ۴ برابر نوجوانان سفیدپوست است. از این رو اعتقاد بر این است که افراد متعلق به قومیت‌ها و خرده‌فرهنگ‌های خاص، به دلیل تحمل شرایط نامساعد محیطی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به ابتلا به اسکیزوفرنیا مستعدتر باشند.

^۱ . Barnes

دارودرمانی و روان‌درمانگری دو رویکرد مهم در درمان اسکیزوفرنیا بخصوص در دوره نوجوانی است. خدایاری فرد (۱۳۸۲) گزارشی از یک مورد درمان موفقیت‌آمیز اختلال اسکیزوفرنیا را با استفاده از فنون شناخت-رفتار درمانگری توأم با دارودرمانی ارائه کرده است. فنون مورد استفاده در این پژوهش شامل تغییر باور از طریق بازسازی شناختی، مثبت‌نگری، آموزش تنش‌زدایی و کاربرد عفو و گذشت بوده و منجر به بهبود نشانگان اسکیزوفرنیا در آزمودنی شده است.

افسردگی

در ادبیات روان‌شناختی، افسردگی، یک اختلال خلقی معرفی شده است (کارسون، باتشر و کلمن^۱، ۱۹۹۸). افسردگی شامل بروز تغییراتی در عواطف و خلق و خوی افراد است که این تغییرات از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در بعضی افراد، تغییرات خلقی ممکن است بسیار شدید، مشخص و قابل توجه باشد.

ماهیت افسردگی

پژوهش‌های انجام‌شده درباره ماهیت افسردگی در بزرگسالان، طبقه‌بندی‌های مختلفی را از این اختلال ارائه می‌کند. باید توجه داشت که افراد از نظر شدت تغییرات در خلق و خو و نشانگان افسردگی با یکدیگر متفاوت‌اند. پیترسن^۲ و همکاران (۱۹۹۳) یک نظام طبقه‌بندی از افسردگی نوجوانان ارائه کرده‌اند که عبارت است از:

- خلق و خوی افسرده؛

- نشانگان افسردگی؛

- افسردگی بالینی.

نوجوانان هنگام دارا بودن خلق افسرده، گزارش می‌کنند که احساس غمگینی و ناامیدی دارند. به‌طور معمول چنین احساس‌هایی توسط منبع بیرونی نظیر گرفتن نمره بد در مدرسه یا از دست دادن رابطه خاص ایجاد می‌شوند. خلق و خوی افسرده ممکن است بسیار کوتاه باشد (مانند یک روز) یا برای یک دوره طولانی مدت (یک هفته، یک ماه و حتی یک سال) ادامه یابد. به‌نظر پیترسن و همکاران (۱۹۹۳)، سایر نشانگان افسردگی اغلب ارتباط زیادی با خلق افسرده دارند و ممکن است شامل ترس، احساس گناه، خشم، اضطراب و انزوای اجتماعی باشند. پژوهشگران اعتقاد دارند که

^۱ . Carson, Butcher & Coleman

^۲ . Petersen

افسردگی اغلب با اضطراب، احساس تنهایی، ترس از انجام کارهای بد و احساس بی‌ارزشی، گناه و عصبی بودن همراه است.

در افسردگی بالینی یک نوجوان باید پنج مورد یا بیشتر از موارد زیر را طی یک دوره دو هفته‌ای تجربه کند:

- خلق افسرده یا خلق تحریک‌پذیر در بیشتر اوقات روز؛
- کاهش علاقه به فعالیت‌های خوشایند و لذت‌بخش؛
- تغییر در وزن یا شاید عدم موفقیت در به‌دست آوردن وزن اضافی ضروری؛
- مشکلاتی در خوابیدن؛
- عدم تحرک، کندی و بی‌فعالیتی روانی - حرکتی؛
- بی‌اشتهایی یا فقدان انرژی؛
- احساس بی‌ارزشی یا احساس گناه افراطی و نابهنجار؛
- از دست دادن تمرکز و عدم توانایی در تصمیم‌گیری؛
- دارا بودن افکار خودکشی مکرر و یا طرح‌هایی برای خودکشی.

عوامل مرتبط با افسردگی

در این بخش، به اختصار بعضی از عوامل روانی - اجتماعی مرتبط با افسردگی نوجوانان بررسی می‌شود. شواهد پژوهشی نشان می‌دهند که دامنه وسیعی از چنین عواملی در افسردگی نوجوانان نقش دارند.

بسیاری از مطالعات به بررسی نقش خانواده در سبب‌شناسی افسردگی نوجوانان پرداخته و دریافته‌اند که رابطه والد - فرزندی و مشکلات مرتبط با آن یا بدکارکردی‌ها و کمبودهای موجود در خانواده از جمله عوامل کلیدی مهم در افسردگی نوجوانان هستند. روابط درون خانوادگی زیر در پیش‌بینی افسردگی نوجوانان مؤثرند: روابط مادر-فرزند، روابط پدر-فرزند، روابط والدین با یکدیگر و روابط خواهر و برادرها با یکدیگر (پویگ - آنتیچ^۱ و همکاران، ۱۹۹۳).

ادراک نوجوان از والدین خود، با میزان افسردگی او رابطه دارد و اعتقاد بر این است که والدین گرم، صمیمی و دارای ارتباط زیاد با فرزندان، در فرزندان خود اطمینان، مهارت و عزت نفس ایجاد می‌کنند. تصور از والدین به‌عنوان افرادی که از فرزندان خود حمایت افراطی و محافظت زیادی

^۱ . Puig - Antich

می‌کنند، با سطوح پایینی از تسلط، مهارت و سطوح بالایی از افسردگی رابطه دارد (آویسون و مک آلپین^۱، ۱۹۹۲).

به نظر می‌رسد که عزت نفس نوجوانان تا حد زیادی به سبک‌های والدینی وابسته باشد و هر دو اینها با هم به عنوان پیشایندهای افسردگی عمل می‌کنند. در مطالعه‌ای مشاهده شد که طردشدن از طرف والدین در مقایسه با عوامل دیگری نظیر تعارضات خانوادگی یا میزان مذهبی بودن خانواده، پیش‌بینی‌کننده بهتری برای افسردگی نوجوانان است (رابرتسون و سیمونز^۲، ۱۹۸۹). بنابراین پویایی‌های خانوادگی می‌تواند از طریق تأثیر بر عزت نفس نوجوانان در افسردگی آنان تأثیر داشته باشد.

بورنز^۳ و همکاران (۲۰۰۴)، میزان و ثبات افسردگی و رابطه آن با عوامل مختلف خطرآفرین در سلامت نوجوانان را بررسی کردند. آنان ۶۴ نوجوان افسرده را انتخاب و مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که رابطه طولی قدرتمندی بین نشانگان افسردگی با چندین عامل رفتاری خطرآفرین مهم از جمله شکست‌های تحصیلی پی‌درپی، فقدان جو خانوادگی حمایت‌کننده، درگیری والدین با یکدیگر، طلاق و جدایی والدین و عزت نفس پایین وجود دارد.

گروهی از پژوهشگران در مطالعه‌ای طولی که بر روی ۳۸۵ نوجوان ۱۴ ساله انجام دادند، تأثیر تعداد زیادی از عوامل روانی - اجتماعی را بر افسردگی در ۱۸ سالگی بررسی کردند (رین هرز^۴ و همکاران، ۱۹۹۳). محققان توانستند تأثیر وقایع دوران کودکی را بر افسردگی نوجوانان ردیابی کنند. آنها دریافتند که هم در پسران و هم در دختران داشتن تصور ضعیف از نقش کودک در خانواده در ۹ سالگی و همچنین ادراک و تصور کودک از خود به عنوان فردی غیراجتماعی، پیش‌بینی‌کننده‌های مهمی از افسردگی در ۱۸ سالگی هستند. در میان دختران، مرگ یکی از والدین، پیش‌بینی مهم افسردگی بود. در مورد پسران، مشکلات سلامتی بعد از تولد با افسردگی در ۱۸ سالگی مرتبط بود، اما در مورد دختران این طور نبود.

سایر محققان به بررسی تأثیر عوامل شناختی بر افسردگی پرداخته‌اند. در این باره، به نظر می‌رسد که خودارزیابی اجتماعی و عزت نفس بسیار مهم‌اند. مطالعه‌ای نشان داد، اگرچه نوجوانان افسرده می‌توانند مشکلات بین فردی را به درستی ارزیابی کنند و قادرند دیدگاه دیگران را در نظر گیرند، اما

^۱ . Avison & Mc Alpine

^۲ . Simons

^۳ . Burns

^۴ . Reinhers

تمایل دارند که راهبردهای ناقص و نادرستی را در مورد مشکلات اجتماعی داشته باشند (مارتونن^۱ و همکاران، ۱۹۹۳).

تندگی نیز با افسردگی ارتباط دارد. نوجوانان در معرض عوامل تنش‌زای مختلفی نظیر تغییرات بیولوژیکی، تغییرات اجتماعی، انتقال از مدرسه، جدایی یا طلاق والدین و انتظارات نقش جنسیتی قرار دارند (گور، آسلتن و کولتن^۲، ۱۹۹۲). فرایندهای خانوادگی و عوامل اجتماعی - اقتصادی می‌توانند نقش ضربه‌گیر را در مقابل تأثیر منفی تندگی‌ها داشته باشند، از این‌رو میزان افسردگی را کاهش دهند.

در زمینه درمان افسردگی در نوجوانان، نتایج پژوهش‌ها نشان‌دهنده کارایی روش‌های مختلف روان‌درمانگری نظیر شناخت‌درمانگری، رفتاردرمانگری، شناخت - رفتار درمانگری، درمان روان‌پوشی و روان‌تحلیل‌گری (گارلند^۳، ۲۰۰۴؛ مافسون^۴، ۲۰۰۴) به تنهایی یا به‌صورت ترکیبی با دارودرمانی است. با این حال، اعتقاد بر این است که استفاده از داروهای ضدافسردگی که برای درمان بزرگسالان به‌کار برده می‌شوند، به‌دلیل آثار جانبی نامطلوبی که دارند، برای افسردگی نوجوانان زیاد مناسب نیستند.

به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از اختلالات روانی در آمریکا^۵ (۲۰۰۴)، برخی از نوجوانانی که به‌دلیل افسردگی شدید به این مراکز رجوع می‌کنند و دارودرمانی می‌شوند، پس از گذشت یک یا چند هفته اقدام به خودکشی می‌کنند، به‌عبارت دیگر، پس از مصرف داروهای ضدافسردگی، میزان خودکشی افزایش می‌یابد. با این حال، گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی^۶ (۲۰۰۳) نشان می‌دهد که میزان خودکشی در بین نوجوانان طی پانزده سال گذشته در ۱۵ کشور دنیا در اثر مصرف داروهای ضدافسردگی در حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است. میزان کاهش در آمریکا برابر با ۲۵ درصد بوده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهند که خودکشی سومین عامل مهم مرگ نوجوانان ۱۲ تا ۱۹ ساله بعد از صدمات ناشی از حوادث رانندگی و قتل است.

گارلند (۲۰۰۴) کارایی داروهای ضدافسردگی را در کودکان و نوجوانان بررسی کرد. او دریافت که علاوه بر عدم کارایی یا کارایی ضعیف داروهای ضدافسردگی بازدارنده انتخابی جذب مجدد سرتونین‌ها (SSRIS) برای نوجوانان، این داروها آثار جانبی نامطلوبی را نیز روی آنها داشته‌اند. این محقق مشاهده کرد که بیش از ۲۵ درصد نوجوانانی که دارودرمانی می‌شوند، تأثیرات جانبی و

^۱. Marttunen

^۲. Gore, Aseltine & Colton

^۳. Garland

^۴. Mufson

^۵. center for disease control and prevention

^۶. national health reports

ناخواسته‌ای نظیر بی‌قراری، اضطراب و تحریک‌پذیری را تجربه می‌کنند. در حدود ۵ درصد نوجوانانی که فلوکستین مصرف می‌کنند، به دلایل آثار جانبی شدید این دارو نظیر ایده‌ها و افکار خودکشی، اقدام به خودکشی، مشکلات سلوکی، بی‌ثباتی هیجانی، خشونت و پرخاشگری، از ادامه مصرف آن خودداری می‌کنند. حتی مشاهده شد که حال ۸ درصد نوجوانانی که به دلیل افسردگی متوسط از پاروکستین استفاده می‌کنند، بدتر شده و در بیمارستان بستری می‌شوند، درحالی‌که نوجوانانی که به دلیل افسردگی متوسط از دارونما استفاده می‌کنند، هرگز در بیمارستان بستری نمی‌شوند. این محقق دریافت که نوجوانان مبتلا به افسردگی شدید و طولانی‌مدت همراه با اضطراب، پس از شرکت در جلسات درمانی غیردارویی، نسبتاً بهبود می‌یابند و پس از آن دارودرمانی می‌شوند. این محقق پیشنهاد می‌کند که روان‌پزشکان هنگام تجویز داروهای ضدافسردگی برای نوجوانان توجه داشته باشند که آثار جانبی داروهای ضدافسردگی با نشانه‌های اختلال افسردگی همپوشی دارند. از این رو ممکن است در این شرایط متخصص به اشتباه دوز و مقدار دارو را برای نوجوانی که تأثیرات جانبی دارو را تجربه می‌کند، افزایش دهد، حتی ممکن است پس از قطع دارو، حالات و نشانه‌های افسردگی در نوجوانان شدت یابد. بنابراین لازم است که متخصصان، والدین و جوانان را آگاه کنند که داروها نمی‌توانند افسردگی را بهبود بخشند، بلکه ممکن است برخی از نشانه‌های افسردگی را کنترل کنند.

کهرازهی، آزاد فلاح و اللهیاری (۱۳۸۲) اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله را در کاهش افسردگی نوجوانان مورد بررسی قرار دادند. آنها ۳۰۰ دانش‌آموز ۱۵ تا ۱۸ ساله را به صورت تصادفی انتخاب کردند و از آنها خواستند که پرسشنامه افسردگی بک را کامل کنند. در مرحله بعد ۳۰ نفر از دانش‌آموزانی که در مقیاس افسردگی بک حداقل نمره ۱۷ را کسب کرده بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و گروه گواه قرار گرفتند. به دانش‌آموزان گروه آزمایشی مهارت‌های حل مسئله آموزش داده شد، ولی به دانش‌آموزان گروه گواه هیچ آموزشی داده نشد. نتایج نشان داد که آزمودنی‌های گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه، کاهش معناداری را در نمره‌های افسردگی خود داشتند.

خدایاری‌فرد و پرند (۱۳۸۴) در مطالعه موردی دختر ۱۷ ساله مبتلا به افسردگی شدید را با استفاده از رویکرد خانواده‌درمانی شناختی-رفتاری و با استفاده از فونونی چون آموزش حل مسئله، خودبازبینی افکار، مثبت‌نگری فردی و خانوادگی و تنش‌زدایی، درمان کردند. طول جلسات درمان خانوادگی در این پژوهش شامل ۷۱ جلسه یک ساعته بود که به صورت هفتگی تشکیل می‌شد.

مافسون (۲۰۰۴)، ۶۳ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله مبتلا به افسردگی را که توسط مراکز مشاوره‌ای مدارس به کلینیک‌های تخصصی درمان افسردگی ارجاع شده بودند، مورد مطالعه قرار داد. این نوجوانان به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند؛ ۳۲ نفر آنان در جلسات ۱۶ هفته‌ای روان‌درمانگری انفرادی و حمایتی و ۳۱ نفر در جلسات ۱۶ هفته‌ای روان‌درمانگری بین‌فردی مبتنی بر آموزشگاه شرکت کردند. نتایج نشان داد، نوجوانانی که در جلسات روان‌درمانگری بین‌فردی مبتنی بر آموزشگاه شرکت کرده بودند، کاهش بیشتری در نشانگان افسردگی داشتند و به‌طور معناداری کارکرد اجتماعی بهتری را دارا بودند تا نوجوانانی که در جلسات روان‌درمانگری انفرادی و حمایتی شرکت کرده بودند.

خودکشی

خودکشی منجر به مرگ بسیاری از نوجوانان می‌شود. گاهی خودکشی ممکن است نتیجه یک عامل تنش‌زای خارجی نظیر مرگ فرد مورد علاقه یا قطع رابطه خاصی باشد. بعضی خودکشی‌ها جنبه تقلیدی دارند و طی آن برخی نوجوانان به تقلید از فرد یا شخصیت مشهوری در یک فیلم دست به خودکشی می‌زنند. با وجود این، برخی از خودکشی‌ها ناشی از تجربه کردن سال‌ها اضطراب و غمگینی روان‌شناختی و احساس درماندگی است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد که برای این نوجوانان، خودکشی تنها راه فرار از موقعیتی است که از نظر آنان سخت و جانکاه است و هیچ راهی برای فرار از آن وجود ندارد.

میزان بروز خودکشی و افکار خودکشی

داده‌های یک مطالعه استرالیایی نشان‌دهنده تعداد زیاد نوجوانانی است که به خودکشی فکر می‌کنند (زابریک^۱ و همکاران، ۱۹۹۵). براساس این مطالعه، در حدود ۱۱/۵ درصد نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله و ۲۳/۵ درصد نوجوانان ۱۵ تا ۱۶ ساله، گاهی یا بیشتر اوقات به خودکشی فکر می‌کنند. یافته‌های مربوط به دو کشور استرالیا و آمریکا، نشان می‌دهند که نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر دست به خودکشی می‌زنند. اما میزان سالانه خودکشی در هر دو کشور کاملاً مشابه است. در سال ۱۹۹۰، میزان خودکشی در دختران استرالیایی ۱۵ تا ۲۴ ساله برابر با ۴ نفر در هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر بوده، درحالی‌که میزان متناظر آن در ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۸۹ برابر با ۴/۲ نفر در هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر است. میزان خودکشی در پسران ۱۵ تا ۲۴ ساله استرالیایی در سال ۱۹۹۰ برابر با

^۱. Zubrick

۲۷ نفر در هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر است، درحالی که این میزان در آمریکا در سال ۱۹۸۹ برابر با ۲۱/۹ است (رایس^۱، ۱۹۹۲).

فیلیپس^۲ (۲۰۰۴) میزان اقدام به خودکشی را در نوجوانان چینی بررسی کرد. نتایج نشان داد که ۵۴ درصد خودکشی‌های صورت گرفته توسط نوجوانان چینی، با خوردن سموم دفع آفات انجام می‌گیرد. او همچنین دریافت ۹۱ درصد نوجوانانی که اقدام به خودکشی کرده بودند، هرگز به مراکز تخصصی سلامت روانی رجوع نکرده بودند. علاوه بر این، خودکشی پنجمین علت مرگ در افراد چینی ۱۴ تا ۳۰ ساله است. این محقق چندین راهبرد زیر را برای پیشگیری از اقدام به خودکشی در نوجوانان مطرح کرده است:

- ۱) محدود کردن توانایی دستیابی به سموم دفع آفات و داروهای کشنده؛
- ۲) توسعه شبکه‌های حمایت اجتماعی برای نوجوانانی که بسیار در معرض خطر اقدام به خودکشی قرار دارند؛
- ۳) به‌کارگیری عملیات ترویج‌دهنده سلامت مبتنی بر سلامت روان و خودکشی؛
- ۴) افزایش توانایی متخصصان و دست‌اندرکاران سلامت نوجوانان با افزایش و توسعه دانش آنها برای بازشناسی و حل مشکلات روان‌پزشکی مرتبط با خودکشی از جمله اختلالات افسردگی؛
- ۵) برنامه‌های سازمانی و منظم برای تشخیص نوجوانانی که در معرض خطر اقدام به خودکشی قرار دارند؛
- ۶) توسعه سرویس‌های حمایت‌کننده و سلامت روان برای افراد در معرض خطر خودکشی هنگام مواجهه با مشکلات.

اقدام به خودکشی

براساس برآوردهای انجام شده، تلاش‌هایی که برای خودکشی صورت می‌گیرد، ۵۰ تا ۲۰۰ برابر خودکشی کامل است (گارلند و زیگلر^۳، ۱۹۹۳). در آمریکا، دختران سه برابر پسران دست به تلاش‌های خودکشی می‌زنند، درحالی که پسران ۴ برابر دختران دست به خودکشی کامل می‌زنند. این برآوردها در استرالیا برای دختران ۱۴ ساله در سال ۱۹۸۵ برابر با ۲۷۰ نفر در هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر و برای پسران برابر با ۷۰ نفر در هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر است (ماسون، ۱۹۹۰).

^۱ . Rice

^۲ . Phillips

^۳ . Zigler

به طور کلی، خودکشی سومین عامل مهمی است که منجر به مرگ نوجوانان و جوانان می شود. تصادفات و حوادث ناشی از آن و قتل، دو عامل مهم مرگ و میر نوجوانان به حساب می آیند. در هر سال در حدود ۱۲ مورد خودکشی در هر ۱۰۰/۰۰۰ نوجوان گزارش می شود. این ۱۲ نفر اغلب ۱۵ تا ۲۴ ساله اند، در هر ۲ ساعت و ۲ دقیقه (۱۲۲ دقیقه) یک فرد زیر ۲۵ سال دست به خودکشی می زند. در سال ۲۰۰۰، به طور کلی ۲۹۳۵۰ نفر دست به خودکشی زده اند که سن ۱۳/۶ درصد آنان زیر ۲۵ سال بوده است. میزان خودکشی در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال ۳۰۰ برابر بیشتر از میزان خودکشی در دهه ۱۹۵۰ است و این میزان خودکشی طی سال های دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ ثابت مانده است. رایج ترین روش خودکشی در میان نوجوانان دختر و پسر و در تمام قومیت ها، استفاده از سلاح های گرم نظیر تپانچه و سلاح های کمری است، که در حدود ۳ مورد از ۵ مورد منجر به خودکشی موفق می شود. نتایج تحقیقات نشان داده که دسترسی آسان به اسلحه، یکی از عوامل مهم افزایش خودکشی در جوانان و نوجوانان است. نسبت خودکشی در مردان نسبت به زنان در سال ۲۰۰۰ در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال برابر با ۳/۷ به ۱ و در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال برابر با ۵ به ۱ و در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال برابر با ۶/۲ به ۱ است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد که بیشتر خودکشی ها در نوجوانان در بعدازظهر و در اوایل شب و در اتاق مخصوصی صورت می گیرد. اقدام قبلی برای خودکشی، مهم ترین عامل خطر آفرین برای اقدام به خودکشی توسط نوجوان است (سالوم^۱، ۲۰۰۴).

فکر خودکشی یا اقدام به آن بیشتر ناشی از احساس افسردگی و وجود خلأ روانی است. متأسفانه آمار خودکشی در بین جوانان کشور ما بیش از سایر سنین بوده است. بررسی ۱۲۲ مورد خودکشی در شهر اصفهان طی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ نشان داده که بیشترین رقم خودکشی مربوط به جوانان بوده است. این آمار نشان می دهد که در سنین ۱۱ تا ۱۹ سالگی ۲۵ نفر و در سنین ۱۹ تا ۲۸ سالگی ۳۱ نفر دست به خودکشی زده اند (مهدی زاده، ۱۳۶۸).

عوامل مرتبط با خودکشی

محققان عوامل زیادی را با خودکشی مرتبط می دانند از جمله، سوء مصرف دارویی و الکلی، تلاش های قبلی برای خودکشی، مشکلات روان شناختی یا داشتن سابقه خانوادگی از رفتار خودکشی، اختلافات و دعوای خانوادگی، سوء استفاده های جنسی، هیجانی، عاطفی و فیزیکی، مشکلات مربوط به مدرسه و همسالان، بیکاری، فقر، بی خانمانی و فقدان رابطه با دیگران (ماسون، ۱۹۹۰).

^۱. Salloum

کوفمن^۱ و همکاران (۲۰۰۴)، خودکشی‌های مرتبط با موضوعات تحصیلی و مدرسه را در آمریکا در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ بررسی کردند. آنان دریافتند که طی این ۵ سال، ۱۲۶ نوجوان ۱۳ تا ۱۸ ساله اقدام به خودکشی کردند. از این ۱۲۶ دانش‌آموز، ۹۸ درصد در خودکشی موفق شده‌اند و از این تعداد، ۸ درصد درست قبل از خودکشی به‌طور عمدی به فرد دیگری صدمه رسانده‌اند، ۷ درصد سابقه تیراندازی به دیگران را داشته‌اند، ۱۴ درصد تا یک سال قبل از اقدام به خودکشی رفتارهای نافرمانی داشته‌اند. هیچ‌یک از این نوجوانان عضو گروه خاصی نبودند و تمام آنها علائم و نشانه‌های خودکشی نظیر دارا بودن افکار خودکشی، ناراحتی از تنیدگی‌های اجتماعی، مصرف مواد و افسردگی را داشتند. تمام این ۱۲۶ مورد خودکشی در مدرسه یا هنگام شرکت در کلاس درس یا در حیات مدرسه صورت گرفته است و به‌طور کلی ۷۸ درصد این نوجوانان، پسر و ۲۲ درصد دختر بودند. ۴۰ درصد فرزندان خانواده‌هایی بودند که والدینشان یا از هم طلاق گرفته بودند یا جدا از هم زندگی می‌کردند، ۳۹ درصد آنان به‌طور هفتگی مشروب می‌خوردند، ۱۸ درصد هنگام خودکشی مست بودند و ۲۱ درصد سابقه جرم‌آفرینی داشتند.

در فنلاند نیز با استفاده از روش کالبدگشایی روان‌شناختی، وقایع مرتبط با خودکشی نوجوانان طی دوره یک‌ساله بررسی شد. یافته‌ها نشان‌دهنده تأثیر عوامل تنش‌زای بین‌فردی به همراه سایر عوامل تنش‌زا بود (مارتونن، آرو و لانکوویست^۲، ۱۹۹۳). عوامل تنش‌زا شامل مشکلات ارتباطی، تعارضات بین‌فردی و تنش‌زاهای کلی و عمومی نظیر مشکلات قانونی و انضباطی، مشکلات تحصیلی، بیکاری، مشکلات مالی و اختلافات خانوادگی و غیره بود. از نظر روان‌شناختی، متمایز کردن نوجوانان متمایل به خودکشی و نوجوانان افسرده بسیار مشکل است. این نتیجه‌گیری براساس مطالعه‌ای که بر روی نوجوانان هلندی انجام گرفت، به‌دست آمد (دی وایلد^۳ و همکاران، ۱۹۹۳). در این مطالعه، صفاتی که وجه مشخصه نوجوانان بهنجار بود، شامل حمایت اجتماعی قوی، پیوستگی و انسجام خانوادگی، نگرش مثبت و امیدواری بود. نوجوانان افسرده و متمایل به خودکشی نیز دارای ویژگی‌هایی نظیر دامنه وسیعی از احساسات و صفات منفی از جمله اضطراب، احساس نابسندگی و عدم کفایت، بی‌اعتمادی به افراد دیگر، عدم انسجام خانوادگی، احساس عدم کنترل بر شرایط و عزت نفس ضعیف بودند. احتمال اقدام به خودکشی در نوجوانان، تابع تعداد عوامل خطرزایی است که با آن مواجه می‌شوند. خودکشی بندرت تابع یک عامل یا واقعه منفرد و خاص است، بلکه ناشی از چندین واقعه آسیب‌زای روانی است.

^۱ . Kaufman

^۲ . Marttunen, Aro & Lonnqvist

^۳ . De Wilde

نوجوانانی که دست به خودکشی می‌زنند، مهارت‌های کمی برای مقابله با مسائل و مشکلات اجتماعی دارند. به نظر می‌رسد این موضوع به تفکرات غیرمنطقی، تحریفات شناختی و سبک اسنادی آنان وابسته باشد. مدارک موجود نشان می‌دهند نوجوانانی که به خودکشی اقدام می‌کنند، در مقایسه با نوجوانان دیگر، به مشکلات اجتماعی به‌گونه‌ای می‌نگرند که منجر به استفاده آنها از راهبردهای تصمیم‌گیری ناقص، نادرست و غیرکارآمد می‌شود، بنابراین این افراد اغلب به راه‌حل‌های ناموفق روی می‌آورند.

کاستله^۱ و همکاران (۲۰۰۴)، به بررسی عوامل خطرآفرین مرتبط با خودکشی در نوجوانان سفیدپوست و سیاه‌پوست پرداختند. نتایج نشان داد که چند عامل یا مؤلفه موجب تمایز خودکشی از مرگ به علت حادثه در نوجوانان می‌شود. این مؤلفه‌ها عبارتند از: دارا بودن افکار خودکشی و مرگ، رفتارهای انزجاری و تهدیدکردن‌های توأم با خشونت. همچنین مشاهده شد که رفتارهای انزجاری و تهدیدهای توأم با خشونت، خطر اقدام به خودکشی را در سفیدپوست‌ها بیشتر از سیاه‌پوست‌ها افزایش می‌دهد.

والویس^۲ (۲۰۰۴) نیز سلامت نوجوانان دبیرستانی، رضایت از زندگی و خودکشی در آنان را بررسی کرد. یافته‌ها نشان داد که دارا بودن سلامت روانی کم طی یک ماه گذشته، سلامت جسمانی ضعیف طی ۳ ماه گذشته، افکار خودکشی زیاد طی یک سال گذشته و برنامه‌ریزی برای اقدام به خودکشی در ۲ سال گذشته، به‌طور معناداری رضایت از زندگی را در نوجوانان کاهش و احتمال اقدام به خودکشی را افزایش می‌دهد.

بسیاری از نوجوانان ممکن است یک یا چند مشکل از مشکلات یا علائم مطرح‌شده در زیر را از خود نشان دهند. علائم فهرست‌شده در زیر در واقع عوامل بالقوه خطرآفرین برای خودکشی در میان نوجوانان هستند. چنانچه این رفتارها در نوجوان یا جوانی مشاهده شوند، توصیه می‌شود که ارزشیابی تخصصی از نوجوان به‌عمل آید (سالوم، ۲۰۰۴):

- وجود اختلالات روان‌شناختی نظیر افسردگی، اختلالات رفتاری مصرف مواد یا الکل، اختلالات سلوکی مانند فرار از خانه و زندانی شدن؛
- نشان دادن حالت یا بیان افکار خودکشی، مرگ، مردن یا زندگی پس از مرگ با حالتی غمگین، افسرده، ناراحت و توأم با احساسات منفی دیگر؛
- رفتار تکانشی پرخاشگرانه، نشان دادن مکرر خشم و غضب؛
- شاهد مرگ ناشی از خودکشی فرد دیگری در گذشته بودن؛

^۱ . Castle

^۲ . Valois

- تنش‌زاهای شدید کنونی (مانند مشکلات جدی جنسی، حاملگی ناخواسته، یا مرگ یکی از عزیزان)؛
- از دست دادن ثبات خانوادگی و درگیری‌های خانوادگی با افراد مهم خانواده.

پیشگیری از خودکشی

راهبردهای مختلفی برای کمک به پیشگیری از خودکشی نوجوانان وجود دارد. این راهبردها شامل مداخله‌های درمانی و برنامه‌های آموزشی است که در زیر به آنها اشاره می‌شود.

مداخله‌های درمانی

بورست و نوام^۱ (۱۹۹۳) در مورد افرادی که اقدام به خودکشی کرده بودند و خود را بشدت سرزنش می‌کردند و حالت دفاعی - خشمگین داشتند، پژوهشی انجام دادند. نتایج نشان داد که این گروه از افراد برای پیشگیری از خودکشی به رویکردهای درمانی مختلفی نیاز دارند. این افراد معتقدند که انواع دفاع‌های توأم با خشم در منحرف کردن افرادی که در اطرافشان هستند، بسیار موفق‌اند، حتی در افرادی که به آنها کمک و یاری می‌رسانند. بسیار حیاتی است که بدانیم این نوجوانان در حین درمان باید آموزش ببینند تا یاد بگیرند که دیدگاه دیگران را در نظر بگیرند. درمان این افراد مستلزم کارهای گروهی و همچنین حمایت از طرف همسالان است، زیرا این افراد به بزرگسالان به‌عنوان نمادهای قدرت توجه می‌کنند.

اقدام‌کنندگان به خودکشی که بشدت خود را سرزنش می‌کنند، نیاز به رویکردهای درمانی دیگری دارند، از جمله بازسازی شناختی. اگرچه آنها هم به حمایت دیگران نیاز دارند. این افراد از این نوع درمان سود بیشتری می‌برند، زیرا به آنان کمک می‌کند تا کمتر احساس تنهایی و خودشرمنده‌سازی داشته باشند.

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های آموزشی مبتنی بر مدرسه برای آموزش به نوجوانان برای شناسایی افرادی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند، مفید و کمک‌کننده است. اهداف این برنامه‌ها عبارتند از: افزایش آگاهی دانش‌آموزان از مشکلات، کمک به آنها برای بازشناسی ابعاد بالینی خودکشی، ارائه اطلاعاتی

^۱ . Borst & Noam

درباره منابع سلامت روانی به دانش‌آموزان و اصلاح و بهبود توانایی‌های مقابله‌ای نوجوانان. در این برنامه‌ها و در جریان آموزش، خودکشی را به منزله یک بیماری مدنظر قرار نمی‌دهند، بلکه به خودکشی به عنوان واکنشی در مقابل تنیدگی‌ها نگریسته می‌شود. بنابراین متخصصان و آموزش‌دهندگان تلاش خواهند کرد تا معنای خودکشی را به عنوان یک بیماری روانی در کارآموزان تغییر دهند و بدین وسیله دانش‌آموزانی را که احتمالاً تمایل به خودکشی دارند، تشویق کنند تا در جست‌وجوی کمک تخصصی و حرفه‌ای برآیند (گارلند و زیگلر، ۱۹۹۳).

خلاصه

امروزه نوجوانی به عنوان دوره انتقالی از زندگی مدنظر قرار می‌گیرد که به سادگی موجب می‌شود نوجوانان در معرض خطر زیادی برای بدکارکردی‌ها و اختلالات روانی قرار گیرند. این اختلالات و مشکلات هیجانی و روانی تأثیرات زیادی در سازگاری بعدی نوجوانان دارد. در این فصل به طور خلاصه ویژگی و وجوه مشخصه ترس، اختلالات اضطرابی، اسکیزوفرنیا، افسردگی و خودکشی بررسی شد. توضیح داده شد که شروع اسکیزوفرنیا ممکن است به سال‌های نوجوانی مربوط باشد و پسران بیشتر از دختران به این اختلال مبتلا می‌شوند. دیدگاه‌های مختلفی درباره علل و سبب‌شناختی این اختلال وجود دارد، بویژه اعتقاد بر این است که اسکیزوفرنیا می‌تواند ریشه‌ها و علل ژنتیکی یا زیست - شیمیایی داشته باشد. وقتی این عوامل در کنار استرس‌های روزمره قرار گیرند، احتمال ابتلا به اسکیزوفرنیا را افزایش می‌دهند. در هر حال، علت این اختلال هر چه باشد، نوجوانان مبتلا به اسکیزوفرنیا و نوجوانانی که تصور می‌شود در معرض خطر ابتلا به آن قرار دارند، به مراقبت‌های بهداشتی، تخصصی و حرفه‌ای فوری نیازمندند. همچنین اشاره شد که افسردگی و خودکشی با یکدیگر رابطه دارند. پژوهش‌ها بیانگر افزایش تعداد نوجوانانی است که در کشورهای مختلف دست به خودکشی می‌زنند. روشن نیست که چرا میزان خودکشی نوجوانان در بعضی کشورها افزایش معناداری دارد و چرا بیشتر این کشورها، کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته‌اند. با وجود این، بسیار مهم است که عوامل مرتبط با خودکشی را تشخیص دهیم و درک کنیم تا بتوانیم راهبردهای پیشگیرانه مناسبی را ارائه کنیم و به کار بگیریم. در این باره باید به راهبردهای مختلف پیشگیری از خودکشی که در دسترس قرار دارند، توجه شود. این راهبردها دامنه‌ای از راهبردهای حرفه‌ای و تخصصی (نظیر مداخله‌های درمانی و برنامه‌های آموزشی) تا درون خط‌مشی‌های سیاسی (نظیر محدودیت دسترسی به اسلحه‌های گرم) دارند.

پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

(۱) به نظر شما ابتلای نوجوانان به مشکلات روانی بیشتر معلول چه عوامل اجتماعی یا علل

شخصی است؟

(۲) متأسفانه افراد جامعه ما به نقش روان‌شناسی و درمان‌های برگرفته از آن در درمان اختلالات

روانی و شخصیتی آگاهی ندارند، به نظر شما چگونه می‌توان در نگرش افراد جامعه

نسبت به درمان‌های روان‌شناختی تغییر ایجاد کرد؟

فصل دوازدهم

آموزش سلامتی

بیماری‌ها و آسیب‌های نوجوانی: نیاز به آموزش

دست‌اندرکاران جامعه، به تازگی با شیوع بحران ایدز، به اهمیت ترویج و آموزش سلامت پی برده‌اند. به دلیل غیرقابل‌علاج بودن و هزینه‌های گزاف مالی درمان این بیماری، دولت‌ها به شعارهای آگاهی‌دهنده و روش‌های دیگری روی آورده‌اند و تلاش دارند تا شهروندان را از فواید انتخاب سبک زندگی سالم، رفتارهای پیشگیری‌کننده و رجوع به پزشک به‌طور منظم یا خودآزمایی در مورد بیماری‌هایی نظیر ایدز آگاه کنند.

آموزش سلامت به نوجوانان بسیار ضرورت دارد. در فصل قبل اشاره شد که نوجوانان به فکر سلامتی خود هستند، اما باید توجه داشت که نوجوانی دوره‌ای حساس از نظر خطرهای تهدیدکننده سلامتی است، زیرا عوامل فردی و محیطی زیادی نوجوانان را برای درگیری در مشکلات خاص یا رفتارهای خطرناک مستعد می‌کند. در این بخش به‌طور مختصر برخی از خطرهایی که نوجوانان با آنها مواجه خواهند بود، بررسی می‌شوند.

براساس برخی مطالعات (اسلاپ^۱، ۱۹۹۱)، عوامل فردی متعددی وجود دارند که رفتارهای خطرآفرین را در میان نوجوانان پیش‌بینی می‌کنند؛ جنسیت، جایگاه اجتماعی - اقتصادی، عملکردهای خانوادگی، تنیدگی‌های اخیر زندگی، استفاده از موادمخدر و مشروبات الکلی. این عوامل در جدول ۱-۱۲ خلاصه شده‌اند. بنابر نظر متخصصان، ترکیبی از این عوامل، ممکن است آسیب‌پذیری نوجوان را از رفتارهای ناسازگار با سلامتی افزایش دهد. بویژه، به‌نظر می‌رسد پسران در مقابل صدمات و رفتارهای خطرناک، آسیب‌پذیرتر و مستعدتر از دختران هستند. از این‌رو دست‌اندرکاران جامعه با استفاده از پیام‌های آموزشی در رسانه‌های جمعی، اقشار مختلف جامعه از جمله نوجوانان را از خطرهایی که سلامت آنها را تهدید می‌کند، آگاه می‌سازند. این پیام‌های آموزشی در مورد عواملی است که در جدول زیر نشان داده شده است.

^۱ . Slap

جدول ۱۲-۱. عوامل فردی پیش‌بینی‌کننده رفتارهای خطرآفرین

۱- جنسیت	احتمال اینکه مردان در اثر صدمات ناشی از حوادث بمیرند، ۲/۵ برابر زنان است. حتی احتمال اینکه مردها دچار سایر صدمات غیرکشنده شوند، بیشتر است. پسرها با خطرهای بیشتری در زمینه تصمیم‌گیری مواجه‌اند.
۲- جایگاه اجتماعی - اقتصادی	میزان مرگ و میر ناشی از حوادث در نواحی فقیرنشین دو برابر نواحی ثروتمندنشین است. تجاوز و حمله در نواحی فقیرنشین بیشتر به چشم می‌خورد. صدمات غیرکشنده در میان کودکان سیاه‌پوست ساکن در محلات فقیرنشین شایع‌تر است.
۳- عملکرد خانواده	خانواده‌هایی که دارای مشکلات پزشکی، بیماری‌های روان‌پزشکی، بیکاری، جابه‌جایی و جدایی فرزندان از والدین‌اند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
۴- تنیدگی‌های اخیر زندگی	تنیدگی مرتبط با خودکشی است.
۵- مشروب و مواد مخدر	انواع خطرها را افزایش می‌دهد، همچنین در روابط با دوستان و خانواده تأثیر می‌گذارد.

منبع: برگرفته از اسلاپ، ۱۹۹۱

راهنمای آموزش سلامتی

عوامل متعددی سلامت نوجوانان را تهدید می‌کنند و آشکار است که روش‌های آگاه کردن نوجوانان از این خطرها، از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از یک عامل خطرآفرین به عامل خطرآفرین دیگر متفاوت است. دست‌اندرکاران سلامتی دامنه‌ای از روش‌های مختلف را برای ترویج سلامتی مطرح می‌کنند. توسل به هشدارهای برانگیزاننده ترس و ارائه اطلاعات حیاتی و ضروری یا استفاده از روش‌های مختلف رفتاری، از جمله این روش‌هاست.

پیام‌های برانگیزاننده ترس

بعضی افراد معتقدند ایجاد ترس زیاد، بی‌نتیجه^۱ است و تأثیر معکوسی دارد و افراد در چنین شرایطی برای موجه جلوه دادن رفتار خطرآفرین خود، خطرهایی را که سلامتشان را تهدید می‌کند، فراموش کرده، انکار می‌کنند و به حداقل می‌رسانند. در هر حال، بیشتر صاحب‌نظران توافق دارند که پیام‌های ایجادکننده ترس و به‌طور کلی، برانگیختن افراد برای کنترل رفتار یا ایجاد تغییر در سبک زندگی‌شان کاملاً مؤثر است. به‌علاوه، به‌نظر می‌رسد پیام‌هایی که بشدت برانگیزاننده ترس هستند، در

^۱ . Counterproductive

تغییر نگرش در مورد سلامت مؤثرترند تا پیام‌هایی که کمتر ترس ایجاد می‌کنند (سارافینو^۱، ۱۹۹۰). اگرچه پیام‌های برانگیزاننده ترس ممکن است نگرش‌های فرد را تغییر دهند، ولی آیا این پیام‌ها رفتار ترویج‌دهنده سلامت را نیز ایجاد می‌کنند. براساس نظر بعضی صاحب‌نظران، تغییر نگرش‌ها به دو روش منجر به تغییر رفتار می‌شود؛ در صورتی که افراد آموزش‌های خاصی را برای عمل به یک رفتار ببینند، احتمال بیشتری وجود دارد که به عمل پیشگیری‌کننده دست بزنند؛ همچنین برنامه‌هایی در تغییر رفتار افراد موفق‌ترند که بر اعتماد به خود آنان تأکید داشته باشند و قبل از آنکه افراد را برای شروع طرح‌ریزی برانگیزانند، به آنها کمک کنند.

ارائه اطلاعات

رسانه‌ها، نقش مهمی در فراهم ساختن اطلاعات مربوط به سلامت دارند. موفقیت رسانه‌ها در افزایش رفتار سالم، بستگی به این دارد که به چه میزان به اصول زیر متکی باشند (ایگر^۲، ۱۹۸۶):

- پیام رسانه باید متناسب با پیام گیرندگان باشد، آیا پیام برای نوجوان گیرنده پیام مناسب است؟ آیا پیام به زبانی که برای نوجوانان قابل فهم باشد ارائه می‌شود؟
- پیام رسانه باید قابل تغییر باشد. نگرش‌های عمومی ثابت نیستند و گاهی ضروری است که پیام تغییر کند، بویژه وقتی گیرنده پیام نوجوانان باشند.
- رسانه باید به صورت انتخابی و حساس مورد استفاده قرار بگیرد.
- منبع پیام باید موثق باشد.
- پیام رسانه باید برانگیزاننده باشد.
- پیام‌های برانگیزاننده ترس باید به دقت به کار روند.
- پیام باید اهداف واقع‌گرایانه داشته باشد.

برخی از ویژگی‌های پیام را که در بالا به آنها اشاره شد، می‌توان به اجزای دیگری تقسیم کرد؛ برای مثال، منبع پیام هم می‌تواند اشاره به اعتبار فرستنده پیام داشته باشد و هم به مطلوبیت و دوست‌داشتنی بودن او، قدرت پیام، کمیت و عوامل جمعیت‌شناختی. بنابراین، یک عامل مهم، میزان اعتقاد و شناختی است که گیرنده پیام از فرستنده پیام دارد. اگر فرستنده پیام جذاب، دارای قابلیت و مهارت اجتماعی و تخصص باشد، احتمال اینکه پیام متقاعدکننده‌تر و موفق‌تر باشد، بیشتر خواهد بود (بارون و بیرن^۳، ۱۹۹۴).

^۱ . Sarafino

^۲ . Egger

^۳ . Baron & Byrne

برای فرستادن پیام از طریق رسانه، می‌توان از یک یا دو راهبرد استفاده کرد؛ یکی از راهبردها، چارچوب تغییر رفتار ارتباطی است. رسانه‌ها به کمک این روش، اطلاعات را به عموم مردمی که برای عمل به آن آزادند یا نه، می‌رسانند. دیده شده که این روش برای تغییر رفتارهایی که مستلزم تلاش زیادی نیستند، مؤثر است؛ رفتارهایی نظیر استفاده از کلاه و کمربندهای ایمنی و غیره. این روش برای تغییر رفتارهای پیچیده‌تری نظیر تلاش برای کاهش وابستگی به مواد مخدر و ترک اعتیاد تأثیر کمتری دارد.

راهبرد دیگر، رویکرد بازاریابی اجتماعی و مبتنی بر راهبردهای بازاریابی تجاری و شامل موارد زیر است:

- جست‌وجو و تحقیق بازار، که شامل اصلاح و توسعه دقت ارتباط در مورد گیرنده پیام هدف (نوجوان) است؛
 - طراحی و توسعه محصول، که شامل پوستره‌های مخصوص و فیلم‌های کوتاه در زمینه تغییر رفتار یا نگرش و مراحلی که باید پشت سر گذاشته شود، است؛
 - مشوق‌های خاص، این مشوق‌ها به افزایش انگیزه برای تغییر رفتار یا نگرش کمک می‌کنند؛
 - حمایت‌های بعدی، که ممکن است شامل جلسات مشاوره‌ای، رویارویی و غیره باشد.
- همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، رویکرد بازاریابی اجتماعی در استفاده از برخی روش‌ها نظیر طراحی و تهیه محصول و حمایت بعدی، با رویکرد اول متفاوت است. بازاریابی اجتماعی، راهبرد نسبتاً پیچیده‌ای است. این روش رویکردی نظام‌دار است که به منظور متقاعد ساختن گیرندگان پیام در این مورد طراحی شده و یک رفتار مناسب (سالم) متناسب‌تر از رفتارهای دیگر (ناسالم) است. راهبرد بازاریابی اجتماعی، رفتار را بیشتر تغییر می‌دهد.
- آخرین روش برای کمک به شکل‌گیری رفتارهای سالم، روش رفتارگرایی است. این روش اصول تغییر رفتار را برای کنترل رفتارهایی که فرض می‌شود سلامت را تهدید می‌کنند، به کار می‌گیرد. درمان‌گرانی که مسئول کمک به نوجوانان برای تغییر رفتارهایشان هستند، از راهبردهای مختلفی استفاده می‌کنند. ممکن است این راهبردها شامل روش فکر کردن درباره موضوعات مرتبط با سلامتی باشد. در خیلی از موارد احتمال ترک رفتارهای خطرآفرین بسیار کم است، مگر اینکه افراد فرایندهای فکری خود را در مورد رفتار تغییر دهند. برای مثال، افراد سیگاری، ممکن است رفتار خود را به شیوه‌های مختلف موجه سازند (جدول ۱۲-۲).

جدول ۱۲-۲. توجیه‌های احتمالی نوجوانان سیگاری برای سیگار کشیدن

۱- من در شرایط تنش‌زای شدیدی قرار دارم و این کار مرا آرام می‌کند.

۲- سیگار به من انرژی می‌دهد و کمک می‌کند تا در کارهایم مؤثرتر و کارآمدتر باشم.

۳- من به‌طور اساسی مصرف سیگار را کاهش داده‌ام.

۴- من از سیگارهای دارای نیکوتین کم، سالم و بی‌ضرر استفاده می‌کنم.

۵- من توان لازم برای رهایی از سیگار را ندارم.

منبع: سارافینو، ۱۹۹۰

گاهی متخصصان، والدین و همسالان، دلیل‌تراشی نوجوانان برای توجیه رفتارشان را مشکل بزرگی می‌دانند، اما بیشتر اوقات، استفاده از استدلال‌های منطقی در بحث‌های متقابل می‌تواند نتایج مثبتی را برای تغییر رفتارهای خطرآفرین به بار آورد. برای مثال، نوجوانی را در نظر بگیرید که اظهار می‌کند قدرت و توان مورد نیاز برای تغییر را ندارد؛ پاسخ‌های احتمالی این نوجوان ممکن است چنین باشد: "مطمئنم که خیلی مشکل است". اما شما به‌عنوان درمانگر ممکن است مجبور شوید روش‌های مختلفی را برای ترک کردن پیشنهاد کنید یا بگویید: "این کار به خودی خود مشکل است، به من اجازه بدهید سعی خودم را برای کمک به شما بکنم".

برخی متخصصان هنگامی که قصد دارند تغییرات رفتاری در نوجوانان ایجاد کنند، به روش‌های تغییر رفتار متوسل می‌شوند. این کار با تغییر روش‌هایی که رفتارها تقویت و تشویق می‌شوند، صورت می‌گیرد. این رفتارگرایان، از اصول شرطی‌سازی کلاسیک و کنش‌گر استفاده می‌کنند. به‌طور خلاصه، رفتارگرایان معتقدند رفتارهایی به سرعت اکتساب و آموخته می‌شوند که تقویت و تشویق شوند و مجازات منجر به خاموشی رفتار می‌شود.

پاولف^۱ (۱۸۴۹-۱۹۳۶، به نقل از میوس^۲، ۱۹۸۸) اولین کسی بود که دریافت بزاق سگ‌ها قبل از اینکه غذا بخورند، ترشح می‌شود. کارهای پاولف بعدها توسط اسکینر در شرطی‌سازی کنشگر گسترش یافت. اسکینر اعتقاد داشت که پیامدهای اعمال یک فرد تعیین‌کننده رفتار اوست؛ یعنی مشوق‌ها و تقویت‌هایی که فرد دریافت می‌کند، رفتار اصلی او را افزایش می‌دهند. اهمیت بحث حاضر در این اعتقاد است که نوجوانان می‌توانند رفتارهای تقویت‌کننده سلامت را با تقویت آن رفتارها یاد بگیرند. برای مثال، ممکن است بعضی نوجوانان برای اینکه بیشتر مورد پذیرش همسالان خود قرار بگیرند، سیگار بکشند. مورد قبول و پذیرش قرار گرفتن و مطلوبیت بیشتر از نظر اجتماعی، به‌عنوان مشوقی که رفتار سیگار کشیدن را افزایش می‌دهد، عمل می‌کند. در برنامه‌های تغییر رفتار که هدف آنها ترک سیگار است، رفتار اغلب با تنبیه همراه می‌شود (مجازات‌ی نظیر تمسخر

^۱ . Pavlov

^۲ . Muuss

و استهزا). مجازات، بعد از رفتار غیرقابل قبول ارائه می‌شود و در کاهش تمایل به انجام رفتار نامطلوب تأثیر دارد.

برخی صاحب‌نظران (لیبرت و اسپایلگر^۱، ۱۹۹۰) معتقدند رفتارگرایان به رفتار انسان به صورت ساده‌سازی شده‌ای می‌نگرند، بدون توجه به این واقعیت که رفتار دارای تعیین‌کننده‌های متفاوتی است. روان‌درمانگران رفتارگرا با تأکید بر مؤلفه‌های محرک - پاسخ، تفاوت‌های فردی، تأثیر عوامل فرهنگی و آزادی و حق انتخاب را فراموش می‌کنند. برای مثال، برخی رفتارهای تهدیدکننده سلامت (نظیر داغ گذاشتن بر بدن) که مربوط به تشریفات مذهبی خاصی‌اند، به فرهنگ وابسته‌اند و از طریق الگوی محرک - پاسخ قابل تبیین نیستند.

سبک‌های اسنادی

مفهوم سبک اسنادی، ارتباط نزدیکی با کنترل تقویت دارد. اولین بار مفهوم سبک اسنادی در متون و منابع روان‌شناختی در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد (آبرامسون، سلینگمن و تیزدال^۲، ۱۹۷۸). سبک اسنادی، براساس تجدیدنظر در الگوی درماندگی آموخته‌شده از افسردگی مطرح شده است. صاحب‌نظران معتقدند به‌طور کلی سه بعد مکان، ثبات و قابلیت کنترل در اسناددهی مهم‌اند. به سبک اسنادی منفی، به‌عنوان طرحواره شناختی منفی اشاره شده و دیده شده است که این نوع سبک اسنادی با دامنه‌ای از پیامدهای سلامتی ارتباط دارد.

پیترسون، سلینگمن و وایلانت^۳ (۱۹۸۸)، با مطالعه بر روی افراد ۳۵ ساله، مشاهده کردند که بین سلامت جسمانی در سال‌های ۳۰ تا ۶۰ سالگی و سبک‌های تبیینی^۴ در سنین ۲۵ سالگی رابطه وجود دارد. این محققان دریافتند مردان جوانی که وقایع منفی را به علل درونی، کلی و ثابت نسبت داده بودند، مشکلات بیشتر سلامتی را در زندگی بعدی خود تجربه کردند. حتی وقتی که سلامت جسمانی و عاطفی کنونی آزمودنی‌ها کنترل شود، باز هم چنین ارتباطی وجود دارد.

این نتایج مهم نشان‌دهنده وجود رابطه بین یک حالت ذهنی (حالت روانی) شناختی خاص و سلامت جسمانی است. در این زمینه دو پرسش بدون پاسخ می‌ماند و احتمالاً در پژوهش‌های بعدی به آنها پاسخ داده خواهد شد؛ اول اینکه، رابطه بین سبک اسنادی و وضعیت سلامت در میان نوجوانان به توجه بیشتر پژوهشگران نیاز دارد. برای مثال، رابطه بین سبک اسنادی و افکار خودکشی

^۱ . Liebert & Spiegler

^۲ . Abramson, Seligman & Teasdale

^۳ . Peterson, Seligman & Vaillant

^۴ . explanatory

یا تصور منفی بدنی چیست؟ ثانیاً، روشن نیست که چرا فقط یک سبک اسنادی منفی منجر به بروز پیامدهای ضعیف سلامت در برخی افراد می‌شود؟

خلاصه

با شیوع بیماری ایدز، توجه متخصصان سلامت روان و دست‌اندرکاران جامعه به نقش آموزش سلامتی به نوجوانان در پیشگیری از انجام رفتارهای خطرناک برای سلامتی جلب شد. یکی از راهبردهای مهم آموزش سلامتی به نوجوانان، ارائه پیام‌های برانگیزاننده ترس از طریق رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های عمومی است. این پیام‌ها باید متناسب با سطح تحولی نوجوانان و واقع‌گرایانه باشند. مفهوم سبک‌های اسنادی نیز ارتباط نزدیکی با سلامت جسمانی دارد.

پرسش‌هایی برای تفکر و اندیشیدن

- (۱) اگر بخواهید یک پیام تلویزیونی برانگیزاننده ترس درمورد خطرهایی که سلامتی نوجوانان را تهدید می‌کند تهیه کنید، بر چه نکاتی تأکید می‌کنید؟
- (۲) به نظر شما سازوکار تأثیرگذاری سبک‌های اسنادی بر سلامت جسمانی و روانی نوجوانان چگونه است؟

فصل سیزدهم

بحث پایانی

و

پیشنهادهای کاربردی

با بررسی و مقایسه شاخص‌های مهم و کلیدی ابتلا به اختلالات مختلف در نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله در کشورهای مختلف دنیا (از جمله مصرف الکل، سیگار، مواد مخدر، داروهای روان‌گردان و نیروزا، صدمات فیزیکی، تهدید و زورگویی، رفتارهای خطرآفرین جنسی و رفتارهای جرم‌آفرین) مشخص می‌شود که خطرهای فراوانی سلامت نوجوانان را تهدید می‌کنند. برای مثال، ایتالیا سومین کشوری است که نوجوانان ۱۳ ساله آن به‌طور هفتگی اقدام به خوردن مشروب می‌کنند، اما در عین حال یکی از پنج کشور جهان است که نوجوانان آن بیش از یک‌بار در هفته مشروب نمی‌خورند. از طرفی، گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که بیش از ۴۰ درصد دختران نوجوان در روسیه و اوکراین سلامت جنسی کم و ضعیفی دارند. سلامت جنسی، یکی از حوزه‌هایی است که تفاوت‌های شدیدی از نظر جنس، سن برقراری رابطه جنسی، اقدام به برقراری رابطه‌های خطرناک جنسی، استفاده از کاندوم در آن در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود. مهم‌تر اینکه به‌تازگی نگرانی‌های زیادی در مورد ابتلای نوجوانان کشورهای مختلف به بیماری‌های مقاربتی جنسی نظیر ویروس ایدز وجود دارد. آمریکا یکی از چهار کشوری است که این خطر نوجوانان آن را بشدت تهدید می‌کند. از طرفی، این مشکلات تأثیر منفی زیادی بر زندگی تحصیلی و اقدام به خودکشی در نوجوانان دارد.

به‌طور کلی، نتایج پژوهش‌ها بیانگر نقش چهار عامل مهم زیر در شکل‌گیری این مشکلات است: جایگاه اجتماعی - اقتصادی، خانواده، همسالان و مدرسه. صاحب‌نظران و متخصصان سلامت روان معتقدند که سلامت نوجوانان و رفتارهای مرتبط با آن باید در بافت مخصوص به آن مطالعه شود و بدون در نظر گرفتن بافتی که نوجوان در آن قرار دارد، نه تنها نمی‌توان این مشکلات را شناسایی کرد، بلکه درمان و اصلاح این مشکلات غیرممکن خواهد بود. برای مثال داشتن ارتباط خوب با والدین رابطه بسیار تنگاتنگی با سلامت نوجوانان دارد یا انجام فعالیت‌های ورزشی و فیزیکی توسط نوجوانان و داشتن تعداد زیادی دوست همسال با عدم ابتلا به اختلالات جسمی و روانی رابطه تنگاتنگی دارد. این یافته‌ها نشان‌دهنده اهمیت خاص محیط و بافت در سلامت و بهزیستی روانی نوجوانان است.

از آنجا که نوجوانی، دوره حساس و خاص و مصادف با تحول شخصیت فرد، به دست آوردن استقلال نسبی او و افزایش انتظارات اوست، به سادگی نمی توان آسیب پذیری ها را شناسایی و رفع کرد، از این رو خطرهایی که نوجوانان را تهدید می کند، خوب درک نشده اند.

متخصصان روان پزشکی و روان شناختی نوجوانان از سال ۱۹۸۰ به بعد، تصمیم گرفتند روان پزشکان و روان شناسان خاصی را برای درمان کودکان و نوجوانان آموزش داده و در بیمارستان ها و کلینیک های روانی بخش های خاصی را به نوجوانان اختصاص دهند و سرویس ها و مراکز مشاوره ای خاص نوجوانان راه اندازی کنند. با این حال، پیشرفت در این حیطه بسیار آرام صورت می گیرد، حتی قرار بر این است که برنامه های خاصی برای ارزیابی وضعیت و مشکلات تحصیلی نوجوانان طراحی و کلینیک هایی در مدارس راه اندازی شوند که هم مشکلات پزشکی و هم مشکلات روانی، اجتماعی و تحصیلی آنان را مورد بررسی قرار دهند.

پرسشی که هنوز بدون پاسخ مانده، این است که چه کسی مسئول سلامت یک نوجوان است؟ خانواده، دست اندرکاران جامعه، متخصصان تعلیم و تربیت، متخصصان پزشکی، روان پزشکی، روان شناختی یا خود نوجوان؟ باید اشاره کرد که در درجه اول، خود فرد و خود نوجوان مسئول سلامت خویش است. بدون مشارکت نوجوان هرگز نمی توان در تعیین و تشخیص مشکل و ارائه راهبردهایی برای حل آن موفق شد. در واقع، آنچه جامعه، مدارس، سیاست گذاران جامعه و بویژه متخصصان سلامت باید آن را فراهم کنند، ارائه اطلاعات به نوجوانان بدون قضاوت ارزشی، آموزش نوجوانان و فراهم کردن و تسهیل دستیابی نوجوانان به مراکز و سرویس های سلامت مخصوص آنهاست. فقط در این صورت نوجوان حق انتخاب واقعی برای زندگی سالم را دارد. با این حال، توصیه های زیر در راستای ارتقا و ترویج سلامت نوجوانان مؤثرند.

توصیه های کلی برای سلامت کودکان و نوجوانان

۱. سلامت روانی نوجوانان باید در چارچوب بوم شناختی مدنظر قرار گیرد که نه فقط شامل سلامت خود نوجوان می شود، بلکه شامل سلامت افراد خانواده او، همسالان او و کل افراد جامعه نیز می شود. پیشنهاد می شود روان پزشکان و روان شناسان متخصص کودک و نوجوان در هفته یک روز در مدارس حضور یابند و برنامه های سلامت روانی جامعی را طراحی کنند و گسترش دهند، بهتر است این برنامه ها بیشتر بر راهبردهای پیشگیری کننده متمرکز باشند؛
۲. لازم است که مراکز مشاوره ای سلامت روانی و جسمانی در مدارس راه اندازی شوند؛

۳. مشکلات روانی کودکان و نوجوانان به‌طور دقیقی توسط متخصصان سلامت روانی آموزشگاه‌ها تشخیص داده شده و درمان شوند؛
۴. روان‌شناسان کودکان و نوجوانان با مدارس همکاری کنند تا بتوانند راهبردها و منابع اجتماعی را که در برنامه‌های سلامت روانی مدارس پیشنهاد می‌شوند، مشخص کنند؛
۵. باید تیم‌های تحقیقاتی خاصی تشکیل شود تا کارایی مراکز سلامت روانی و پزشکی موجود در مدارس را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند؛
۶. مدیران، مسئولان آموزشی و پرورشی و معلمان مدارس، مورد آزمایش‌های روانی (سلامت روان) قرار گیرند؛
۷. بررسی سلامت روان دست‌اندرکاران مدارس به صورت مستمر پیگیری شود؛
۸. برقراری جلسات هفتگی در مدارس با حضور یک متخصص در راستای حل مسائل و آموزش روش‌های ارتباطی بهتر با نوجوانان ایجاد شود؛
۹. ایجاد فضای فعالیت‌های مهارتی- حرفه‌ای در کنار مدارس که موجب افزایش کارایی نوجوان می‌شود.

پیشنهادهای کاربردی

سازگار شدن با نوجوانان در حال تغییر

زندگی با فرزند نوجوان کار ساده‌ای نیست. بسیاری از والدین نمی‌دانند چگونه باید با این فرد دمدمی مزاج و کله‌شقی که در قالب فرزندشان جای گرفته است، کنار بیایند! در همین زمان، آنها به یاد فرایند بزرگ شدن خود می‌افتند. در این حین نوجوان هم ممکن است به دلیل فقدان دوران بچگی خود و روابط سال‌های قبلش غصه‌دار باشد. به هر حال، مسئله مهم این است که بتوانید اوضاع را با دید درستی نگاه کنید. هر قدر هم نوجوانتان پر دردسر باشد، این وضعیت یک مرحله تغییر اجباری محسوب می‌شود. خود شما هم مثل هر فرد بزرگسال دیگری، این مرحله را طی کرده‌اید. سال‌های نوجوانی خود را به خاطر بیاورید: چه قدر طغیان می‌کردید؟ لباس‌هایتان چطور بود؟ آیا والدین شما از آهنگ‌هایی که گوش می‌کردید، گله نمی‌کردند؟ خلاصه کلام، آیا واقعاً، رفتار، تجربیات و شکل روابط شما با این وضعی که نوجوان شما دارد، خیلی متفاوت بود؟ به احتمال زیاد نه، این دوران، وقتی است که افراد باید هویتی برای خود به دست بیاورند، خود را از والدین‌شان جدا کنند و روابط مهمی را در خارج از خانواده شکل بدهند. یکی از مهم‌ترین وظایف شما این است که بگذارید نوجوانتان همین کار را انجام بدهد؛ در این دوره از زندگی شک و تردید درباره مسائل خود و

رودرویی با تجربیات دشوار برای همه، اجتناب‌ناپذیر است. نوجوان باید مستقل بودن را یاد بگیرد. او باید بفهمد بزرگسالی چه شکلی است. پس بگذارید که شروع کند و خود در مورد زندگی‌اش تصمیم بگیرد. با این حال لازم است که محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد کنید. اما در داخل این مرزهای مشخص باید به او کمی میدان بدهید، برایش فضا ایجاد کنید تا بتواند بال‌های خود را باز کرده و حس کند که الان کیست و می‌خواهد در آینده چه کسی باشد. در طی این مسیر، ممکن است او بعضی از توصیه‌های مفید شما را قبول نکند، اما این هم جزئی از رشد او است. خوشبختانه، بسیاری از ارزش‌هایی که شما قبل از نوجوانی به او القا کرده‌اید، پایدار خواهد ماند و احتمالاً در بزرگسالی هم، بخشی از نظام ارزشی او خواهند بود.

در حال حاضر وقتی نوجوان شما اعلام وجود می‌کند، خواه ناخواه تغییراتی در خانواده شما رخ می‌دهد، اما حتی در بدترین شرایط هم نباید بعضی اصول پایه را ندیده بگیرید. این اصول می‌توانند عملکردهای خانواده را در حد امکان، تثبیت کنند. برای مثال:

- حتی اگر عقاید شما با همدیگر در تضاد کامل باشند، گوش دادن به حرف‌های همدیگر را ادامه بدهید.

- "کارهایی" که موجب ناراحتی شما شده‌اند با نوجوانانی که این کارها را انجام داده‌اند، عوضی نگیرید. بله، بارها پیش خواهد آمد که شما از "رفتار" نوجوانتان احساس ناراحتی، خشم و حتی نفرت کنید. همه والدین همین‌طورند. این کاملاً طبیعی است، اما نشانه این نیست که شما دیگر نوجوانتان را دوست ندارید. در حقیقت، عکس این مطلب صادق است، یعنی شما به زندگی او اهمیت می‌دهید و بی‌تفاوت نیستید. اما خشم خودتان را فقط متوجه "رفتار" او نکنید، نه "خود او" به عنوان یک انسان.

- رفتار و ظاهر او هر قدر هم شما را ناراحت کند، دائم از او انتقاد نکنید. از کنار مسائل بی‌اهمیت بگذرید. در مسائل مهم‌تر هم بگذارید بداند که اگر چه شما مخالفید، اما این حق را برای او قائل‌اید که نظر متفاوتی داشته باشد و دنبال مواقعی بگردید که بتوانید صادقانه به او پاداش بدهید.

- به کارهایی که انجام می‌دهد، علاقه نشان دهید. وقتی اختلاف‌نظرها ایجاد می‌شوند، سعی کنید راهی برای مصالحه پیدا کنید، که برای هر دو طرف قابل قبول باشد. در بدترین شرایط، اگر قرار است با موضوعی، موافقت کنید که با آن مخالفید، دست کم می‌دانید وضعیت و عقیده هر کدام از شما چگونه است و چرا.

• سخنرانی نکنید، نق هم ننزید، سعی کنید صحبت‌هایتان در حد مکالمه‌ای منطقی و دوطرفه باقی بماند و مراقب باشید جملاتی از قبیل "وقتی من در سن تو بودم..." را نگویید. می‌توانید مسائل زیادی را پیدا کنید که مورد علاقه هر دو طرف باشد و شما را به هم نزدیک کند.

نوجوان‌ها هر چه هم سعی کنند نیرویشان را متمرکز سازند، هیچ وقت قادر به عملی کردن این کار نخواهند بود. این دوران، زمان سردرگمی آنهاست، ارزش‌ها و حرف‌هایشان مرتب عوض می‌شود. همچنین، در این دوران، نوسان‌های خلق و روحیه کاملاً طبیعی است (نه تنها به دلیل تغییرات هورمونی، بلکه در نتیجه اضطراب‌هایی که در این دوره زندگی خیلی شایع‌اند). این دوره، زمانی است که آنها مرتکب اشتباهاتی خواهند شد، اما از آنها درس خواهند گرفت. در ضمن، به عنوان پدر و مادر، آماده باشید که نوجوانتان شما را هدف مناسبی برای سرزنش‌های خود بداند. شما به کسی تبدیل می‌شوید که مسئول تمام مشکلات اوست، کسی که جلو پیشرفت و رشد او را گرفته و مانع تفریح او شده است و نگذاشته که او با بقیه بچه‌ها جور شود. اگر قبلاً طلاق گرفته‌اید و فرزند شما تماس‌های کمی با والد دیگر داشته است، ممکن است مجبور باشید بار خشم نوجوان را، هم نسبت به خودتان و هم همسر سابقتان، یک جا به دوش بکشید. به هر حال، بیشتر انتقادهای او را به دل نگیرید و نوجوانتان را رها نکنید. در بسیاری اوقات، والدین نوجوان‌ها نتیجه‌گیری می‌کنند که: "انگار هیچ کدام از حرف‌های من روی او اثری ندارد، دیگر اختیار بچه‌ام دست من نیست." اما ناامید نشوید. شما بالغ هستید و تجربه بیشتری دارید، فرزند شما هنوز در حال رشد است. پس به تلاشتان ادامه بدهید. نوجوان‌ها بیشتر از آنچه فکرش را بکنید، در حال دیدن، شنیدن و یاد گرفتن هستند! واقعیت این است که بیشتر افراد، نوجوانی را بدون هیچ نوع عارضه دائمی پشت سر می‌گذارند و سرانجام، بعد از این سال‌های پرتلاطم، عاقبت به خیر خواهند شد.

نوجوانتان در اواخر نوجوانی راحت‌تر می‌تواند وقتش را با شما و در خانه بگذراند. اگر شما رفتاری منصفانه و باثبات با او داشته‌اید، اگر فضا و میدان کافی برای رشد به او داده‌اید، اگر به عشق خودتان نسبت به او (حتی در سخت‌ترین شرایط) ادامه داده‌اید، احتمالاً او با رابطه‌ای محکم با خانواده، نوجوانی را پشت سر خواهد گذاشت و وارد بزرگسالی خواهد شد.

البته طبیعی است که گاهی والدین بسیار نگران می‌شوند، این مسئله اصلاً غیرطبیعی نیست، اما سعی کنید واکنش افراطی نشان ندهید. شما از زمان تولد فرزندتان برای او یک نیروی هدایت‌کننده بوده‌اید و اگر باوجود فشارهای بسیار شدید دوران نوجوانی، باز هم یک پدر یا مادر فعال و دلسوز

باقی بمانید، تأثیر و نفوذ شما از بین نمی‌رود. دوست داشتن یک نفر، به این معنی است که شما حمایت عاطفی خود را ادامه می‌دهید، چه در مواقع خوب و مثبت، و چه در دوره‌های بد و منفی.

غلبه بر مشکلات ارتباطی

آیا می‌توانید با نوجوانتان خوب ارتباط برقرار کنید؟ شما هم مثل خیلی از پدر و مادرهای دیگر، به این سوال با آه و ناله، جواب می‌دهید که: "من اصلاً نمی‌توانم با او ارتباط برقرار کنم" یا ممکن است بگویید: "بعضی وقت‌ها حس می‌کنم، انگار داریم با دو زبان مختلف با هم صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد اصلاً یک کلمه هم از حرف‌های مرا نمی‌فهمد". البته تعجبی ندارد که خیلی از نوجوان‌ها هم، دقیقاً همین احساس را دارند. اگر از آنها هم سوال شود که آیا می‌توانند با والدینشان ارتباط خوبی برقرار کنند، اغلب جواب خواهند داد نه. بیگانه بودن نسل‌ها با همدیگر، تازگی ندارد و احتمالاً از اول تاریخ وجود داشته است. برقرار کردن ارتباط، هیچ وقت کار ساده‌ای نبوده است، خواه بین زن و شوهر باشد، یا رئیس و مرئوس، یا والدین و فرزندان. بویژه در خلال سال‌های بحرانی نوجوانی، این مسئله برای خانواده پیچیده‌تر می‌شود.

از این مسئله فرار نکنید و با آن روبه‌رو شوید؛ بیشتر وقت‌ها زندگی کردن با نوجوان‌ها کار سختی است و سخت‌تر از آن، حرف زدن با آنهاست. بعضی وقت‌ها، آنها آن قدر بحث و جدل می‌کنند که گفت‌وگو به مسابقه جیغ زدن تبدیل می‌شود! در همین زمینه مادر می‌گوید: "اگر خیلی خوش شانس باشم، او با یک ناله و خرخر جواب پرسش‌هایم را می‌دهد و اگر حالش را نداشته باشد، اصلاً حرف نمی‌زند".

از دید نوجوان‌ها نیز اوضاع همین قدر اعصاب خردکن است: "مادرم نمی‌خواهد با من صحبت کند، او می‌خواهد برای من سخنرانی کند". پسر نوجوانی می‌گفت: "من می‌ترسم به مادرم حرفی بزنم، چون وقتی این کار را می‌کنم یک چیزی پیدا می‌کند تا از من انتقاد بکند".

هم والدین و هم نوجوان‌ها، وقتی مملو از ناامیدی می‌شوند، حتی دیگر سعی نمی‌کنند با هم ارتباط برقرار کنند. مادری ممکن است دیگر از نوجوانش نپرسد که در مدرسه او چه خبر بوده است؛ نوجوان هم ممکن است دیگر در مورد مشکلاتش صحبت نکند؛ مادر ممکن است دیگر از دوست‌های نوجوان هیچ پرس و جویی نکند؛ نوجوان هم ممکن است دیگر به مادرش نگوید که کجا می‌رود و کی به خانه برمی‌گردد. با گذشت زمان، دیوار بین آنها غیرقابل نفوذ می‌شود.

در خانواده شما فرقی ندارد که در حال حاضر اوضاع ارتباطی چگونه است، خوب است یا بد، به هر حال شما و نوجوانتان باید سعی کنید اوضاع از اینکه هست، بهتر شود. مجراهای ارتباطی باز، نه

تنها سال‌های نوجوانی را برای همه خانواده لذت‌بخش خواهند کرد، بلکه موجب می‌شوند شما راحت‌تر بتوانید تأثیر مثبتی بر نوجوانتان داشته باشید.

شکستن سدها

بارها به نظر می‌رسد که نوجوان شما، علاقه‌ای ندارد در مورد زندگی‌اش مطلبی را با شما مطرح کند. اگر در مورد نامزدش از او بپرسید که "تو و نامزدت امشب کجا می‌روید؟" خیلی راحت طوری جواب شما را می‌دهد که انگار در محرمانه‌ترین مسئله زندگی‌اش فضولی کرده‌اید. با وجود این، باز هم ناامید نشوید. نوجوان‌ها با وجود مقاومت در برابر مطرح کردن مسائل زندگی خود با شما، به داشتن ارتباط با والدینشان نیاز دارند. هر چند آنها به احتمال این موضوع را انکار می‌کنند، اما به هر حال، خانواده‌ای که در آن رشد می‌کنند، تا زمان نوجوانی و بزرگسالی برایشان مهم باقی می‌ماند و منبع مهمی برای حمایت و راحتی‌شان محسوب می‌شود. البته گاهی هم دلشان می‌خواهد تنهایشان بگذارید، و بعضی مسائل هم هست که می‌خواهند محرمانه نگه‌دارند. اما این مسائل، به این مفهوم نیست که آنها دیگر به پرورش و راهنمایی شما نیاز ندارند. آنها می‌خواهند مطمئن باشند که هنوز هم از آنها مراقبت می‌کنید و هر وقت که به کمک احتیاج دارند، در دسترسشان هستید. همچنین، نیاز دارند که از اشتباهات اجتناب‌ناپذیر و قضاوت‌های غلط‌شان بگذرید. این اشتباهات و قضاوت‌های غلط، بخشی از فرایند یادگیری انسان است. با تجربه یاد خواهید گرفت که نوجوان شما در مورد چه مسائلی دوست دارد صحبت کند و برای چه مسائلی محدودیت قائل است. اغلب، مسائل جنسی یکی از مشکل‌ترین مسائل برای باز کردن بحث است. در خیلی از خانواده‌ها، بیشتر نوجوان‌ها آن را کاملاً شخصی قلمداد می‌کنند و نمی‌خواهند در این زمینه صحبت کنند که آیا از لحاظ جنسی فعال‌اند یا نه. به این خواسته‌های آنها احترام بگذارید، اما از برقرار کردن رابطه ناامید نباشید. شرایطی را فراهم کنید تا او خودش همه چیز را برای شما بازگو کند. مراقب باشید در آن زمان او را سرزنش نکنید بلکه شنونده خوبی باشید. خوب، البته ممکن است ذکر جزئیات زندگی جنسی برای آنها غیرممکن باشد، اما به هر حال، می‌توان در مورد خیلی از مسائل دیگر با آنها رابطه برقرار کرد، از قبیل اینکه: در مدرسه‌شان چه خبر است، میزان اعتیاد در همسن و سال‌های آنان چقدر است، یا مهمانی که آخر هفته قرار است بروند، چگونه است و به خاطر داشته باشید، او دیدگاه و عقاید شما را در مورد مسائل جنسی از طریق سال‌ها رابطه والد و فرزندی، به خوبی می‌داند و از آنها آگاه است.

اغلب لازم نیست که صحبت‌های شما و نوجوانتان از یک مکالمه کوتاه، طولانی‌تر باشد، اما دنبال فرصت‌هایی باشید که بتوانید در مورد احساسات، عواطف، روحیات، سرگرمی‌ها، رفتارها و درست و

غلط بودن مسائل مختلف بحث و گفت‌وگو کنید. به خاطر داشته باشید که فرزند شما بویژه در اوایل نوجوانی، بیشتر پذیرای صحبت‌هایی است که در مورد اکنون و زمان حال باشند، نه مسائلی که نیاز به تفکر آینده‌نگرانه دارند. برای مثال، پسر چهارده ساله‌ای را که سیگار می‌کشد، با این استدلال نمی‌توان قانع کرد که در صورت عدم ترک سیگار، بیست، سی یا چهل سال بعد ممکن است دچار سرطان ریه شود.

خوب، در مواقعی که نوجوانان در مورد هیچ موضوعی صحبت نمی‌کنند، چه باید کرد؟ این مسئله را شخصی تلقی نکنید و به خودتان نگیرید. عمده این بی‌میلی او مربوط به طغیان طبیعی دوره نوجوانی یا میل ذاتی او به استقلال است. او ممکن است تمام چهره‌های مسلط و مقتدرانه موجود در زندگی‌اش را مورد حمله قرار دهد و شما هم راحت‌ترین هدف هستید. یا ممکن است فقط بعد از یک روز پراضطراب و پرفشار به کمی خلوت احتیاج داشته باشد. به گونه‌ای رفتار کنید که او بداند در هر زمانی که خواهان برقراری ارتباط باشد، شما حاضر و آماده‌اید.

شناسایی اضطراب‌ها

این دوران، نه تنها برای نوجوان‌ها دوره تغییر و تحول است، بلکه برای والدین هم دوره پیچیده و مشکلی محسوب می‌شود. بعضی از پدرها و مادرها، مشکل می‌توانند تأیید و اعتراف کنند که پسر یا دخترشان در حال رشد است و دیگر آن بچه کوچکی نیست که چند سال قبل به آنها وابسته بود. مشکل می‌توان با این واقعیت کنار آمد که بچه‌ها بزرگ می‌شوند و آشیانه را ترک می‌کنند.

فشارها و اضطراب‌های دیگری هم وجود دارد. گاهی پدر و مادرها از بعضی رفتارهای نوجوان‌هایشان عصبانی می‌شوند. اگر نوجوانی بگوید که علاقه خاصی به گذراندن وقت با بقیه خانواده ندارد، ممکن است اوقات والدینش تلخ شود. یا وقتی نوجوان‌ها ارزش‌های والدین را رد می‌کنند، یا اسباب آسایشی را که در اختیار دارند، عادی تلقی می‌کنند و دائم چیزهای بیشتری می‌خواهند، باز هم همان وضعیت ممکن است ایجاد شود. وقتی والدین ایمان دارند که بعضی از خواسته‌های خود را سرکوب و قربانی کرده‌اند تا زندگی بقیه خانواده بهتر شود، نوجوانی که به نظر می‌رسد ناشکری می‌کند، می‌تواند موجب خشم و ناراحتی آنها شود.

داشتن احساس‌ها و اضطراب‌هایی از این قبیل، غیرعادی نیست، اما این اضطراب‌ها بی‌تردید می‌توانند در روابط والدین و فرزندان موجب اختلال شوند. این مسائل می‌توانند باعث ایجاد نوعی جنگ سرد در فضای خانه شوند، این وضعیت، برقراری رابطه را تقریباً غیرممکن می‌کند. برای اجتناب از بروز روابطی مملو از دردسر و مشکل، از خود پرسید:

- آیا در مکالمه شما با نوجوانتان جملاتی در جهت انتقاد از او وجود دارد؟ اگر این طور باشد، نوجوانتان را در وضعیت دفاعی و مبارزه جویانه قرار می دهید و احتمال اینکه بتوانید با صحبت کردن، به پیشرفتی واقعی دست پیدا کنید، خیلی کم می شود. انتقاد کردن، بیشتر موجب بروز خشم و عصبانیت در نوجوان ها می شود و آنها را نسبت به ارزشمند بودن خودشان به شک می اندازد. به همین دلیل، مکالمه خود را با جملات منفی شروع نکنید، از قبیل "من از دست این رفتار تو خسته شدم، دیگر باید بنشینیم و در این مورد صحبت کنیم!" در تمام مدت مکالمه، صادق باشید و از انتقاد بیش از حد خودداری کنید. آگاهانه تلاش کنید که در روابط خود با نوجوانتان، مثبت باشید و به خاطر داشته باشید که از "رفتار" انتقاد کنید، نه "خود شخص".
 - آیا برای نوجوانتان سخنرانی های طولانی می کنید، به طوری که او برای جواب دادن فرصت کمی داشته باشد، یا اصلاً فرصتی نداشته باشد؟ لازمه ارتباط خوب، مکالمه دوطرفه است و نوجوان باید احساس کند که برای ابراز عقاید فرصت کافی دارد، حتی اگر شما با آن عقاید موافق نباشید. پس قبل از اینکه منصفانه به حرف های آنها گوش کرده باشید، فوری نظرشان را رد نکنید. نظر خودتان را برایشان تشریح کنید، اما موعظه و سخنرانی نکنید.
 - آیا بعضی وقت ها در گرماگرم مخالفت با نوجوانتان، جیغ و فریاد هم می کشید؟ نعره زدن، در هر رابطه جدی ای، ایجاد اختلال می کند. صدایتان را پایین بیاورید. با این روش نتیجه بهتری به دست می آورید و کار بیشتری انجام می دهید. باید بدانید که در کدام مهارت های ارتباطی به پیشرفت نیاز دارید.
 - آیا هر وقت که خودتان برای صحبت کردن آمادگی و تمایل داشتید، بدون در نظر گرفتن حال و وضع نوجوانتان در آن لحظه، اصرار می کنید که با او صحبت کنید؟ اگر بعضی وقت ها جواب هایی از این قبیل می شنوید که: "الان وقت خوبی برای حرف زدن نیست، من الان دارم برای امتحان تاریخ فردا درس می خوانم"، در این صورت باید در زمان بندی های خود تجدیدنظر کنید.
- اگر خیلی از این مثال های ذکر شده به نظرتان آشنا می آید، ممکن است بخشی از اختلال روابط در خانواده شما، تقصیر شما باشد.

ایجاد بیشترین رابطه

آیا صادقانه سعی می‌کنید بفهمید در ذهن نوجوانتان چه می‌گذرد؟ آیا می‌خواهید وقت صرف کنید که بفهمید او در چه مورد فکر می‌کند؟

اگر واقع‌بین باشید، نمی‌توانید توقع داشته باشید که مسائل مهم زندگی‌تان را خیلی سریع حل کنید. پس باید برای سر و کله زدن با هر مسئله‌ای، وقت کافی بگذارید. هنگام صحبت با نوجوان، خواه پانزده دقیقه طول بکشد یا دو ساعت، آنچه را باعث حواس‌پرتی می‌شوند، از قبیل تلفن و تلویزیون کنار بگذارید. همه توجه خود را بر نوجوان معطوف کنید.

هر چه سعی کنید مکالمه‌تان با نوجوان کوتاه‌تر باشد، نشان می‌دهید که اهمیت کمتری برای او قائل‌اید. برعکس، به نوجوانتان نشان بدهید که او در اولویت اول زندگی شما قرار دارد و شنیدن اخبار شامگاهی یا تلفن‌های مهم کاری اموری هستند که باید بعدها انجام شوند (یا می‌توانید سایر فعالیت‌های اختیاری را نیز به همین ترتیب عقب بیندازید تا به بقیه بچه‌ها و نوجوانتان برسید).

همان‌طور که قبلاً هم پیشنهاد شد، خودتان را مجبور کنید به تمام مطالبی که نوجوان در ذهن دارد، گوش بدهید. نگوئید دارم گوش می‌دهم، درحالی‌که به جای دیگری نگاه می‌کنید. تمام توجه خود را بر نوجوان متمرکز کنید، رودروی او بنشینید و نگذارید چیزهای دیگر حواستان را پرت کند. او ممکن است پرت شدن حواس شما را با بی‌علاقگی و طرد کردن اشتباه بگیرد. در ضمن، نه تنها به لغاتی که می‌گوید حساس و دقیق باشید، بلکه به نشانه‌های غیرکلامی و احساساتش هم توجه کنید. گوش‌تان را باز نگه دارید و نگذارید عقاید و تصورات قبلی‌تان در مطالبی که می‌شنوید مداخله کنند.

در اینجا برای داشتن روابط بهتر، به چند اصل کلی اشاره می‌شود:

- به منظور فهم بهتر دیدگاه‌ها و عقاید نوجوانتان پرسش‌هایی از او بپرسید و سعی کنید علت احساسات فعلی او را بفهمید. در عوض، موقعی که افکار خودتان را برای او توضیح می‌دهید، از او بخواهید صبور باشد.

- روی هر لغتی که به کار می‌برید، دقت کنید، تا سوء تفاهمی ایجاد نشود. نوجوان‌ها برای فرار از قوانین والدین، دنبال روزنه‌ای برای گریز و مفر ممکن می‌گردند. در این شرایط، به جای اینکه آنها را به دلیل این رفتار سرزنش کنید، بهتر است خودتان سعی کنید، حرف‌های کاملاً دقیقی به آنها بزنید. برای مثال اگر می‌خواهید دخترتان بعد از جلسه‌ای که در مدرسه دارد، تا ساعت پنج به خانه برگشته باشد، بهتر است به او یک پیام دقیق را منتقل کنید و برای مثال بگویید "تا ساعت پنج خانه باش". نه اینکه یک جمله کلی بگویید، مثل این جمله: "حتماً قبل از تاریک شدن هوا بیا خانه". در مورد جمله اول

احتمال اشتباه و سردرگمی کمتر است. در ضمن دلیل خوبی هم داشته باشید که چرا ساعت پنج را انتخاب کرده‌اید و این دلیل را برای او توضیح دهید.

- تا حد امکان، دنبال موقعیت‌هایی برای تشویق و تأیید نوجوان باشید. او باید بداند که شما به موفقیت تحصیلی و موفقیتش در امور فوق برنامه، و از همه مهم‌تر، به خود او به عنوان یک انسان، افتخار می‌کنید. نوجوان‌ها حتی در زمان‌هایی که بیشترین سرکشی و طغیان را دارند، نگران هستند که مبدا والدینشان را ناامید یا عصبانی کنند و علت همه اینها این است که می‌ترسند عشق والدینشان را از دست بدهند. در نتیجه، بیشتر کنجکاو‌ها و تجربیات طبیعی خود را مخفیانه انجام می‌دهند تا مبدا توسط بقیه اعضای خانواده که همیشه در کنارشان بوده‌اند، طرد شوند.

- با نوجوان خود به عنوان یک فرد برابر صحبت کنید؛ کسی که عقایدش برای شما ارزش دارد. از صحبت کردن با تکبر و با لحن آمرانه و دستوری خودداری کنید.

- بلند و آهسته بودن صدایتان و شیوه ارتباط برقرار کردنتان را مورد توجه قرار دهید. آیا پرخاشگرانه، طلبکارانه و یا منفعلانه نیست؟ حالت و وضعیت بدن‌تان به چه صورت است؟ بعضی وقت‌ها پیامی که زبان بدن منتقل می‌کند، از لغاتی که به کار می‌برید، قوی‌تر و مؤثرتر است.

- تظاهر نکنید که جواب همه چیز را می‌دانید. اگر در مورد مسئله‌ای حق با شما نبود، واقعیت را بپذیرید. اگر مرتکب اشتباهی شدید، از عذرخواهی کردن نترسید. با عذرخواهی کردن، نه تنها وضعیت و تسلط خودتان را به عنوان یک والد از دست نمی‌دهید، بلکه در واقع، به احتمال زیاد، در این زمینه‌ها بهتر هم می‌شوید.

- نه تنها باید قوانین منصفانه و محدودیت‌های مناسبی ایجاد کند، بلکه در اجرای آنها نیز، باید ثبات و پایداری داشته باشید.

در نهایت، هیچ وقت یادتان نرود که این نوجوان کیست. بله، بعضی وقت‌ها ممکن است حس کنید بچه‌ای که بزرگ کرده بودید، از شما ربوده شده و ناگهان فرد غریبه‌ای در جای او قرار گرفته، که رفتار، حرکات و سر و لباس و آرایش او، برایتان کاملاً بیگانه است. اما به هر حال، در عالم واقعیت، او هنوز هم فرزند نوجوان یا جوان شماست و هنوز هم همان کسی است که دوستش دارید. البته وقتی کج خلق و بداخلاق است، ممکن است مشکل بتوانید نسبت به او احساس محبت کنید. اما حتی در سخت‌ترین لحظات هم، حفظ رابطه‌تان اهمیت دارد. به نوجوانتان بگویید که واقعاً برای او اهمیت قائل‌اید و از او مراقبت می‌کنید. با او تماس بدنی ایجاد کنید، او را لمس کنید؛ اگر اجازه

می‌دهد، بغلش کنید و به تلاش مضاعف خود برای حفظ و تداوم ارتباط، ادامه دهید؛ حتی وقتی حس می‌کنید او در این زمینه هیچ تلاشی نمی‌کند.

چند نکته دیگر برای کمک بیشتر

بعضی کمک‌های اضافی برای شکستن سدهای موجود در روابط، در بیشتر خانواده‌ها می‌تواند مفید باشد. بعضی از کارهایی که نمونه‌هایی از آن در ادامه ذکر می‌شود، می‌توانند مسیر حل بعضی از مشکلات را هموار سازند. این تمرین‌ها به اعضای خانواده کمک می‌کنند تا در بیان مطلبی که می‌خواهند بگویند و فهم احساسی که دیگران واقعاً دارند، مهارت پیدا کنند.

برای کسب بیشترین استفاده از این تمرین‌ها، تمام اعضای خانواده باید موافقت کنند که یک ساعت از وقت خود را برای انجام دادن آن، کنار بگذارند. برای شروع، از جملات و پرسش‌های زیر استفاده کنید. هر کدام از شما، باید جواب خود را بنویسد و بعد، آنها را با صدای بلند بخواند. منصفانه و صادقانه به این پرسش‌ها پاسخ بگویید و هر پاسخی می‌تواند دری برای شروع بحث باشد. به این ترتیب، نه تنها هر کدام از این پاسخ‌ها می‌توانند اطلاعات مهمی را به دیگران منتقل کنند، بلکه این تجربه می‌تواند موجب شود اعضای خانواده ساعت خوش و لذت‌بخشی را در کنار هم بگذرانند.

۱. پنج خصوصیت خانواده‌تان که بیشتر از همه دوست دارید، کدام‌اند؟ پنج خصوصیتی که

دوست ندارید، کدام‌اند؟

۲. این جمله را کامل کنید: "دلم می‌خواهد بقیه اعضای خانواده توجه بیشتری به من کنند، وقتی من".

۳. این جمله را کامل کنید: "اگر کسی می‌خواهد یک ماه پیش خانواده ما زندگی کند، به نظر من قبل از آمدنش باید بداند که ...".

بعضی وقت‌ها شما در مورد موضوعی با همدیگر اختلاف نظر دارید که می‌خواهید حل شود. این مسائل با یک گله از سوی یک نفر مطرح می‌شوند: "تو هیچ وقت خونه نیستی". در چنین مواردی، دستورالعمل‌های مشخصی وجود دارد که در صورت اجرا، می‌توانند به شما کمک کنند تا با کمترین دردسر، به راه حل مناسبی دست پیدا کنید. هر وقت خواستید مشکلی را حل کنید، این پیشنهادها را به خاطر داشته باشید:

- وقت خاصی را تنظیم کنید و جلسه‌ای با همدیگر تشکیل دهید. شرایط را طوری فراهم کنید که هیچ کس مجبور نباشد جلسه را زودتر ترک کند. وقت مناسب می‌تواند عصر هنگام باشد، وقتی که هیچ کس کار خاصی نداشته باشد.

- زمان هر جلسه باید محدود باشد و هر جلسه باید فقط به یک موضوع اختصاص داشته باشد. برای مثال سی دقیقه برای بحث درمورد تعیین ساعت‌های رفت و آمد.
- سعی نکنید در گرماگرم خشم و عصبانیت مسئله‌ای را حل کنید.
- همه باید توافق کنند که حل مشکل به معنی نبرد قدرت نیست که یک نفر برنده و دیگری بازنده باشد.
- همان‌طور که قبلاً هم پیشنهاد شد، همیشه وقتی می‌خواهید مشکلی را مطرح کنید، با ذکر یک نکته مثبت شروع کنید. برای مثال: "اینکه گذاشتی من بدانم، می‌خواهی بروی نشان دهنده احساس مسئولیت توست، اما وقتی به موقع خانه نمی‌آیی، من نگران می‌شوم." این طرز بیان را با یک شروع منفی مقایسه کنید: "تو از اون ساعتی که قبلاً تعیین شده بود، سی دقیقه دیرتر آمدی!" شما با برخورد مثبت خود به شخص موردنظر یادآوری می‌کنید که برای او اهمیت قائل‌اید و باوجود یک مشکل، از رفتارهای مسئولانه او آگاه هستید.
- به جای عام‌نگری و عمومیت دادن، درمورد مسائل بخصوص و معینی صحبت کنید. این مسئله خیلی مهم است، ولی اغلب نادیده گرفته می‌شود. برای مثال، اگر بگویید: "تو این هفته سه بار دیرتر از زمان مقرر به خانه آمدی،" خیلی بهتر است تا بگویید: "تو هیچ وقت به موقع خانه نمی‌آیی."
- از تعمیم دادن بیش از حد، و گفتن "همیشه" یا "هرگز" خودداری کنید.
- احساسات خود را بیان کنید: "وقتی لباس‌هایت را روی زمین می‌اندازی، من خیلی ناراحت می‌شوم." از به کارگیری حدس و گمان درمورد احساس‌های شخص موردنظر خودداری کنید. بگذارید خود او به شما بگوید در چه وضعی است.
- هر وقت که مناسب بود، بپذیرید که بخشی از مشکل تقصیر شما بوده است: "من می‌دانم بیشتر وقت‌هایی که شما دعوا می‌کردید، من طرف خواهرت رو گرفته‌ام، اما از حالا به بعد سعی می‌کنم منصفانه‌تر رفتار کنم. ولی دوست ندارم تو هم خواهرت را کتک بزنی."
- از مطرح کردن مسائل گذشته یا سایر رفتارهای نامناسب بپرهیزید. دوباره می‌گوییم: هر بار، فقط در مورد یک مسئله صحبت کنید.
- در حین بحث، حرف‌های نفر مقابل را بازگویی کنید و ببینید آیا واقعاً توانسته‌اید منظور او را بفهمید یا نه. تلاش کنید بفهمید او چه احساسی دارد، اما از به کار بردن حدس و گمان خودداری ورزید.
- تمام نیرو و احساس خود را بر پیدا کردن راه‌حل متمرکز سازید.

• راه‌حل‌های نهایی، باید مسائل مشخص و معینی باشند و نوشته شوند. دفتری داشته باشید و توافق‌هایی را که کسب کرده‌اید و موضوعاتی را که حل شده‌اند، در آن بنویسید. این مسئله سبب می‌شود که این جلسات و راه‌حل‌های کسب شده، یادتان نرود. بعضی وقت‌ها سدهای محکمی وجود دارند که سال‌های سال مشکلاتی ایجاد می‌کنند و هر چه خانواده‌ها در جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی خود تلاش می‌کنند، باز هم نمی‌توانند آنها را بشکنند. در چنین مواردی باید از مشاور یا روان‌شناس کمک بگیرید. وقتی خانواده با مشکل درگیر است، روان‌شناس ممکن است بتواند همه افراد را جمع کند و مکالمه را در جهت مثبتی پیش ببرد. ممکن است فکر کنید یک مشاور یا روان‌شناس فقط با مسائل پیچیده روانی سروکار دارد، اما همیشه اینطور نیست، او می‌تواند در مورد بیشتر مسائل زندگی نوجوانان، اطلاعات و راهنمایی‌های مناسبی ارائه کند. در صورت نیاز، مشاوران می‌تواند خانواده را برای بهبود الگوهای ارتباطی، به مراکز مشاوره مناسب ارجاع دهد.

وقتی نوجوان به نظم و انضباط نیاز دارد

بیشتر نوجوان‌ها این جمله را شنیده‌اند که: "دوران نوجوانی بهترین سال‌های زندگی است." اما بیشتر والدین، بی‌صبرانه دوست دارند این دوران هر چه زودتر تمام شود! روی هم رفته، زندگی با کسی که اغلب قوانین خانه را زیر پا می‌گذارد، دائم بحث و جدل می‌کند، گاهی به نظر می‌رسد از پنهان‌کاری، شانه خالی کردن از کارها و اوقات تلخی راه انداختن لذت می‌برد، کار ساده‌ای نیست. اگر با موضوعی موافق باشید، نوجوانتان بدون استثنا مخالف است. اگر دوست دارید خانه تمیز باشد، اتاق او همیشه شلخته و نامنظم است. وقتی بعد از ساعت‌های مقرر به خانه می‌آید، از کلاس‌هایش فرار می‌کند، یا حرف‌های نامناسبی به زبان می‌آورد، ممکن است برای به پایان رسیدن دوره نوجوانی او روزشماری کنید.

هر چه بعضی از کارهای نوجوانان ناخوشایند است، باز هم نکته‌ای را که قبلاً گفتیم، به خاطر داشته باشید: این دوران، طبیعی است که در آن، نوجوان‌ها در حال گذر از بچگی به سمت بزرگسالی‌اند؛ می‌خواهند فردیت خود را اثبات کنند و هویت بالغ برای خود کسب کنند. البته این وضعیت طبیعی، حالت‌های مختلفی دارد، عده‌ای این دوره طغیان را آرام‌تر از بقیه طی کرده و برای پدر و مادرشان دردسر کمتری ایجاد می‌کنند. فرقی ندارد نوجوان‌ها استقلال خود را چگونه اعلام کنند؛ در هر حال، طغیان به هر شکلی که باشد، جزئی از رشد و مرحله طبیعی تکامل است.

با وجود اینکه والدین رفتارهای نامناسب نوجوانان خود را پیش‌بینی می‌کنند، باز هم بسیاری از آنها، با این رفتارها برخوردهای نامناسبی دارند، برای مثال، بعضی از والدین، در برابر رفتارهای نوجوان که به نظر آنها قابل قبول نیست، بیش از حد واکنش نشان می‌دهند؛ ممکن است هر ضعف نوجوان را حتی اگر خیلی هم جزئی باشد، به رخ او بکشند. اگر آرایش موی سر نوجوان کمی غیرعادی باشد، صدای ضبط او بلند باشد، یک بعدازظهر با سر به هوایی و بی‌توجهی از خانه بیرون برود، نق بزند که چرا ماشینشان آخرین مدل نیست، ممکن است بعضی از پدرها و مادرها، یک دفعه بشدت عصبانی شوند و بدون درنظر گرفتن کل رفتارهای نوجوان و به دلیل همین مسائل جزئی، قوانین تازه و سفت و سختی برقرار کنند. برعکس، عده دیگری از والدین، رفتار کاملاً متفاوت، اما اشتباه دیگری دارند. آنها هر اشتباه نوجوان را دلیلی بر ضعف مهارت‌های تربیتی خود تلقی می‌کنند. آنها همیشه آرزو داشته‌اند بچه کامل و بی‌عیب و نقصی تربیت کنند و هر رفتار نادرست نوجوان را دال بر نوعی کوتاهی از جانب خود، می‌دانند، بنابراین، وقتی نوجوان مشکلی دارد، احساس گناه می‌کنند و ممکن است با حمایت بیش از حد از نوجوان در برابر مسئله واکنش نشان دهند؛ این کار، بچه را به سمت تداوم وابستگی به پدر و مادر سوق می‌دهد و مشکلات اجتناب‌ناپذیر دوره رشد نوجوان را به تأخیر می‌اندازد. اما رفتارهای بهتری هم وجود دارد. کمال مطلوب این است که پیوسته محیط شادی ایجاد کنید که حد واسطه طرد کردن و حمایت بیش از حد باشد. نوجوان شما در حال گذراندن دوره سختی است. برای او طبیعی است که سرکش باشد و در طی این مسیر، هم او و هم شما، مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. در عین حال که وجود نظم و انضباط و کنترل بر رفتارهایش یک ضرورت است، این نکته را نادیده نگیرید که در نهایت باید کمی آزادی داشته باشد تا خودش با زندگی روبه‌رو شود. پس باید زیرنظر خود، به او کمی میدان بدهید، تا بفهمد بزرگسالی چه شکلی است و بتواند برای خودش تصمیم بگیرد.

ایجاد مقدار کمی محدودیت

- "کجا می‌روی؟"

- "بیرون".

- "با چه کسی می‌روی؟"

- "دوستانم".

- "کی برمی‌گردی؟"

- "بعداً".

بیشتر والدین چنین مکالماتی را با نوجوان‌هایشان داشته‌اند. هیچ اطلاعات تازه‌ای از این مکالمات به دست نمی‌آید و در نهایت، پدر و مادر ناکام و ناامید می‌شوند؛ در این موارد، پدر و مادر از فعالیت‌های نوجوان چیزی دستگیرشان نمی‌شود: نوجوان‌شان چه کار می‌خواهد بکند و کی به خانه برمی‌گردد. البته تحمیل اصول و قوانین به نوجوان‌ها کار ساده‌ای نیست. بعضی از والدین می‌ترسند که اگر بیش از حد برای نوجوان‌هایشان محدودیت قائل شوند؛ به احساسات آنها لطمه بزنند. نوجوان‌ها می‌گویند: "هیچ کدام از پدر و مادرهای دیگر، ساعت رفت و آمد بچه‌هایشان را تعیین نمی‌کنند." و خیلی از پدر و مادرها، در دام چنین ادعاهایی گرفتار می‌شوند. اما، محدودیت لازم است. خوب البته همه درک می‌کنند که برای نوجوان خیلی مهم است با بقیه دوستانش جور باشد و بتواند بیشتر کارهایی را که آنها انجام می‌دهند، انجام دهد، اما این حقیقت را نادیده نگیرید که تا وقتی نوجوان‌ها به ۱۸ سالگی نرسیده‌اند، مسئولیت مستقیم آنها با شماست. همچنین، احتمالاً او هم مثل بیشتر نوجوان‌های دیگر، نمی‌تواند همیشه بهترین تصمیم ممکن را برای مصلحت خود اتخاذ کند. نوجوان‌ها اغلب به صورت هیجانی و بدون خویشتن‌داری رفتار می‌کنند و افکار رویاگونه‌شان سبب می‌شود تمام مشکلاتی را که ممکن است در آینده برایشان بوجود بیاید، نادیده بگیرند. بنابراین، بیشتر مسئولیت بر عهده شماست. اگر احساس می‌کنید درست نیست فرزند پانزده‌ساله‌تان، بعد از ساعت هشت شب بیرون باشد، یا اگر نمی‌خواهید و قتش را با گروه خاصی از دوستانش بگذرانند، این حق و مسئولیت را دارید که تسلط خودتان را اعمال کنید. موضوعاتی را که برایتان مهم‌اند، انتخاب کنید و در مورد آنها، سر حرف خودتان بایستید.

ممکن است واقعاً هم، پسر یا دخترتان دوستانی داشته باشد که اجازه دارند تا ساعاتی دیرتر از ساعت مورد نظر شما، بیرون از خانه باشند، اما این موضوع، به معنی نادرست بودن نظر شما (یا آنها) نیست. روشی که شما برای بزرگ کردن فرزندان‌تان دارید (تا زمانی که ثبات دارد و همراه با عشق است)، برای خانواده شما بهترین روش است؛ هیچ روشی وجود ندارد که برای همه مردم درست، یا برای همه غلط باشد. اما در عین حال محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنید، فراموش نکنید که حفظ احترام دوجانبه بین نسل‌ها اهمیت دارد. در مورد مسائلی که با نوجوان‌تان اختلاف نظر دارید، با او صحبت کنید و به نظر او هم توجه داشته باشید و بدون اینکه داد بزنید یا موعظه کنید، برای او توضیح بدهید که چرا در مورد بعضی مسائل بشدت مخالف یا موافق‌اید. در ضمن، مشخص کنید که در مورد مسئله خاصی، برای او امکان مذاکره و چانه زدن وجود دارد یا نه. اگر نوجوان‌ها احساس کنند که آنها را گول می‌زنید و در مورد مسئله‌ای که واقعاً روی آن اختیاری ندارند، تظاهر می‌کنید که دارای اختیارند، عصبانی می‌شوند.

تصمیم‌ها و قضاوت‌های خود را به صورت واضح و شفاف‌تر برای آنها توضیح دهید. برای مثال، "من فکر می‌کنم برای کسی به سن تو خیلی خطرناکه که بدون همراهی یک فرد بزرگ‌تر، بعد از ساعت هشت شب بیرون باشد. من دوست دارم و نگران سلامتی و ایمنی تو هستم." بگذارید نوجوانان ناامیدی و ناراحتی خود را بیرون بریزد: "شما با من مثل بچه‌ها رفتار می‌کنید." اگر در نهایت نتوانستید به مصالحه قابل قبول دست پیدا کنید، تصمیم نهایی با شماست. ممکن است او از بعضی قوانین خوشش نیاید، اما تا هجده‌سالگی، تصمیم گرفتن به عهده شماست.

هر وقت قانونی برقرار می‌کنید، نوجوانان باید بفهمند که چرا چنین کاری را به او تحمیل کرده‌اید. بعضی از والدین فکر می‌کنند نیازی به این قبیل توضیحات نیست: "این کار را بکن چون من می‌گویم، علتش همین است!" اما در واقع وقتی نوجوانان بفهمند که این قوانین به چه دلیلی وضع شده‌اند، بیشتر احتمال دارد به آنها پایبند باشند. در ضمن این کار موجب می‌شود که خود شما نیز ناچار شوید در مورد این قوانین فکر کنید و برای آنها دلیل داشته باشید!

بگذارید نوجوانان بدانند که در مورد بعضی از قوانین (آنهايي که واقعاً مهم‌اند) هیچ انعطافی وجود ندارد. برای مثال، اگر با رفتن او به مهمانی بچه‌هایی که رفتارهای خطرآفرین دارند، مخالفید، سر حرفتان بایستید و تردید به خود راه ندهید.

اما مسائل دیگر ممکن است این قدر مهم نباشند. ممکن است پسران دلش بخواهد موهایش از حدی که شما ترجیح می‌دهید، بلندتر باشد؛ یا دخترتان لباس شنایی انتخاب کند که به نظر شما مناسب نباشد. در مورد این نوع مسائل (که اهمیت مرگ و زندگی ندارند) می‌توان کمی کوتاه آمد. اینها مسائلی هستند که جای مذاکره و چانه‌زنی دارند. مسائلی که می‌توان بدون درگیری زیاد حلشان کرد، شما کمی عقب می‌کشید و اجازه می‌دهید نوجوانان راه خود را ادامه دهد. به او بگویید: "می‌توانی در این مورد خودت تصمیم بگیری." یا "هر تصمیمی که بگیری من قبول دارم." نوجوانان باید احساس کنند اجازه تصمیم‌گیری در مورد بعضی از مسائل را دارند و همگام با رشد آنها، این اجازه گسترش می‌یابد. همین مسئله بخش مهمی از رشد طبیعی است و والدین بتدریج باید از کنترل کردن نوجوان کم کنند تا نوجوانان بتوانند مقداری استقلال به دست آورند. در ضمن، وقتی در مسائل کم اهمیت‌تر به نوجوانان اختیار ببخشید، احتمال بیشتری وجود دارد که از اصول مهم‌تری مثل مسائل مرتبط با رفتارهای خطرآفرین، پیروی کنند.

در این بخش، مکرر بر اهمیت این مسئله تأکید شد که باید به نوجوانان کمی آزادی داد تا بتوانند برای خود تصمیم بگیرند. در دوره نوجوانی، افراد تجربه خوداتکایی و احساس مسئولیت را شروع می‌کنند. بنابراین، هرچه قدرت انتخاب بیشتری به آنها داده شود، برای تصمیم‌گیری در آینده و

بزرگسالی آماده‌تر خواهند بود (و باید با مسائلی شروع شود که اگر انتخاب نوجوان اشتباه بود، کمترین ضرر را داشته باشد).

نوشتن فهرستی برای اولویت‌بندی اصول مهم، برای بسیاری از والدین کمک‌کننده است. اجرای کدام اصول سرسختانه را اصرار می‌ورزید؟ در مورد کدام اصول می‌توانید کمی کوتاه بیایید؟ در این جریان، به خاطر داشته باشید که اگر با اصرار بخواهید ثابت کنید "اینجا رئیس چه کسی است"، اغلب فایده‌ای در برنخواهد داشت. این کار ممکن است روابط والد و فرزند را به نبرد قدرت بی‌فایده تبدیل کند. حتی ممکن است در مورد بعضی از اصول سفت و سخت هم گاهی بتوان به توافق‌ها و مصالحه‌هایی دست پیدا کرد. فرض کنیم شما برای منزل آمدن شبانه فرزندتان ساعت ۸:۳۰ را تعیین کرده‌اید. خوب، گاهی کوتاه آمدن از این اصل (با توافق و اجازه قبلی) می‌تواند قابل قبول باشد. اگر در مورد خاصی به او اجازه بدهید و قرارتان را به ساعت ۹:۳۰ تغییر دهید، دنیا به آخر نمی‌رسد و با این کار، نوجوان احساس می‌کند نظرهای او برای شما اهمیت دارد و به خواسته‌های او بها می‌دهید. اگر ماشینش خراب شود و به شما تلفن کند، باز هم می‌توانید کمی انعطاف‌پذیری نشان دهید و حتی به او پیشنهاد کنید با ماشین خود، دنبال او می‌روید.

بیشتر نوجوان‌ها این اصول اساسی خانواده را حتی اگر از آنها خوششان نیاید، جدی می‌گیرند؛ بویژه اگر والدین در زندگی خود همیشه مطابق این اصول رفتار کرده باشند، احتمال خیلی زیادی وجود دارد که بیشتر نوجوان‌ها به این اصول پایبند بمانند، حتی اگر همیشه نق بزنند.

با وجود اینکه بعضی وقت‌ها نوجوان‌ها طبیعت سرکشی دارند، باز هم بیشتر از آنچه به نظر می‌آید، به خانواده خود بها می‌دهند. در واقع، وقتی احساس کنند از طرف همسالان خود برای انجام کاری که دلخواهشان نیست، تحت فشارند (مثل شرکت در یک مهمانی که در آنجا الکل مصرف می‌شود)، برایشان مطلوب و مؤدبانه است که به عنوان بهانه، از اصول والدین خود استفاده کنند. وقتی نوجوان‌ها در موقعیتی با مشکل مواجه می‌شوند، به عنوان یک راه‌حل می‌توانند بگویند: "معذرت می‌خواهم، اگر با شما بیایم، بابا و مامانم حسابی دعوایم می‌کنند".

اصول ثابت و استوار، برای زندگی نوجوانان خیلی اهمیت دارند. نوجوان‌هایی که خط‌مشی خاصی ندارند، اغلب احساس سردرگمی، ناامنی و در معرض خطر بودن می‌کنند، یا درگیر موقعیت‌های خطرناکی می‌شوند که از عواقب آن اطلاعی ندارند. جالب اینجاست والدینی که فرزندانشان را کنترل می‌کنند، اغلب از دست آن والدینی که برای بچه‌هایشان محدودیت‌های کمی قائل‌اند و فرزندانشان را سرگردان می‌کنند، عصبانی و ناراحت هستند. بچه‌هایی که کنترل نمی‌شوند، در واقع مورد بی‌مهری واقع شده‌اند، بسیار طغیانگر، سرکش و عصبانی‌اند و می‌توانند سرمشق‌های

بدی برای بقیه بچه‌ها باشند. وقتی نوجوان شما همسن و سال‌های خود را با این همه آزادی می‌بیند، ممکن است از شما به دلیل "سخت‌گیری‌هایتان" گله کند. با وجود این، صبور باشید، عشق بورزید و محدودیت‌هایتان را اعمال کنید.

وقتی نوجوان قوانین را نقض می‌کند

نظم و انضباط یکی از مسئولیت‌های والدین است و بسیاری از پدر و مادرها، در این مورد احساس کمبود می‌کنند. در دوران کودکی فرزندان با تنبیه کردن او به زحمت می‌توانستید نظم و انضباط را محقق سازید، علاوه بر این، بحران‌های آن دوران از مسائل کوچک فراتر نمی‌رفت؛ برای مثال اتاقشان را مرتب نمی‌کردند یا سر ساعت ۸:۳۰ نمی‌خوابیدند. اما در دوره نوجوانی، شرایط خیلی مشکل‌تر می‌شود و این شرایط ممکن است پیامدهایی داشته باشند که تا آخر عمر گریبانگیر او باشند. با وجود این، بچه در هر سنی که باشد، اصول کلی نباید تغییر کنند. اگر شما با دقت و وضوح محدودیت‌هایی را وضع کردید و نوجوان آنها را نقض کرد، این کار باید برایش پیامدی داشته باشد. اگر نوجوان هنوز معنی روابط علت و معلولی را درک نکرده است، دوره نوجوانی وقت مناسبی برای درک این مفهوم است. هر نوجوانی، گاهی مقررات را تا آخرین حد تعیین شده می‌کشاند و بعد هم از این حد می‌گذرد. در این مواقع باید او را جریمه کنید؛ همان‌طور که برای رفتارهای خوب او باید پاداش در نظر بگیرید. اگر از کنار رفتار اشتباه او گذشتید، این پیام را به نوجوان منتقل می‌کنید که می‌تواند از پیامدهای هر کاری، حتی کارهای بدتر از آن هم در امان بماند، و شما واقعاً اهمیتی نمی‌دهید که او چه کار می‌کند.

تنبیه باید چگونه باشد؟ جزییات آن با خودتان است. در بعضی خانواده‌ها، تنبیه، به شکل گرفتن و سلب امتیاز است. برای مثال یک هفته جای نرود یا از دیدن مسابقه فوتبالی که قصد دیدن آن را داشته است، محروم شود. در بعضی خانواده‌های دیگر، جریمه به صورت انجام دادن کارهای اضافی در خانه است، به هر حال، تنبیهی که انتخاب می‌شود، هرگز نباید شکلی از تنبیه بدنی باشد. با بقیه والدین در مورد روش‌های تنبیه آنها صحبت کنید. در واقع، تشکیل جلسه‌های منظم با بقیه والدین فکر مناسبی است (برای مثال در مدارس، مساجد و سایر اماکن اجتماعی) و از این راه می‌توانید مشکلات را با هم بررسی کنید و دنبال راه‌حل‌هایی بگردید.

نوجوان نه تنها قبل از نقض اصول باید بداند که پیامدهای آنها چیست، بلکه باید که از قبل در هنگام تعیین جریمه‌ها، حق اظهار نظر داشته باشد. اگر خود او در انتخاب تنبیه دخالت داشته باشد، به وضوح خواهد دانست اگر رفتار اشتباهی مرتکب شود، چه تنبیهی در انتظارش خواهد بود.

در همه موارد، وقتی تنبیهی را اعمال می‌کنید، ثابت قدم شوید، جز در مواردی که امکان تخفیف وجود دارد (برای مثال، وقتی ماشینش خراب می‌شود). در سایر موارد، وقتی نوجوان قانونی را نقض یا از اصلی تخلف می‌کند، نباید بتواند برای رهایی از جریمه آن وارد بحث و مذاکره شود. در ضمن، وقتی نوجوان رفتار اشتباهی را انجام دهد، باید حتماً متوجه شود که دقیقاً کدام کارش اشتباه بوده است و تأکید کنید که شما فقط از رفتار او ناراحت هستید، اما قصد ندارید بگذارید این ناراحتی از رفتار او، در عشق شما نسبت به او خللی وارد کند. شما نمی‌توانید رفتار او را تأیید کنید، اما باز هم دوستش دارید؛ آن هم بدون هیچ قید و شرطی. بگذارید پرتوهای عشق شما تابنده باشند.

در اینجا دوباره تأکید می‌شود، هرگز از تنبیه بدنی استفاده نکنید، چه برای نوجوانان و چه بچه‌ها در هر سنی که باشند. بیشتر وقت‌ها نوجوانی که توسط یکی از والدینش (برای مثال پدرش) تنبیه می‌شود، احساس شرم و حقارت می‌کند. والدین از این شیوه ایجاد انضباط، اغلب نتیجه معکوس می‌گیرند. این روش، نوجوان را از خانواده دور می‌کند و در آینده، احتمالاً سرکشی و طغیان او بیشتر می‌شود و احتمال ایجاد رابطه خوب و مثبت، چه اکنون و چه در آینده، کمتر خواهد بود.

از پرخاشگری کلامی هم خودداری کنید. نوجوانان را تحقیر نکنید، به یک کار اشتباهش پيله نکنید، و از گفتن عبارات تحقیرآمیز خودداری ورزید، برای مثال: "تو آدم بی‌خود و بی‌عرضه‌ای هستی، هیچ وقت به جایی نمی‌رسی. آخرش هم یک آدم ولگرد و مفت‌خور می‌شوی!"

وقتی اوضاع از کنترل خارج می‌شود

بعضی وقت‌ها نوجوان‌ها به قدری بر ضد خود و اجتماع رفتار می‌کنند که والدین کنترل اوضاع را از دست می‌دهند. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، نوجوان‌ها گاهی به صورت هیجانی و بدون خویشتن‌داری رفتار می‌کنند، بدون اینکه به کاری که انجام می‌دهند و عواقب آن فکر کنند. این مسئله ممکن است مشکلات بزرگی را ایجاد کند. برای مثال، بعضی نوجوان‌ها به مغازه‌ها، دستبردهای کوچک و بزرگی می‌زنند، آن هم نه به دلیل اینکه نمی‌توانند اشیای سرقت شده را خریداری و تهیه کنند، بلکه فقط به این دلیل که خیال می‌کنند می‌توانند این کار را بدون هیچ پیامدی، انجام دهند. یا ممکن است اقدام به وحشی‌گری و خرابکاری کنند، با سنگ پنجره همسایه‌ها را بشکنند و چرخ اتومبیل‌ها را پنچر کنند. حتی بدتر از اینها، گاهی ممکن است مرتکب اعمال خشونت‌باری شوند.

رفتار خارج از کنترل دیگری که این روزها در بین نوجوان‌ها همه‌گیر شده، فرار از خانه است. بسیاری از نوجوان‌های فراری گله می‌کنند که زندگی در خانه به علت وجود والدین معتاد و الکلی، یا آزارهای جسمی یا جنسی از طرف والدین، برای آنها غیرقابل تحمل بوده است. برداشت از فرار در

بقیه آنها، خیلی ساده به صورت نوعی طغیان رؤیایی و شاعرانه بوده است. بسیاری از دخترهایی که از خانه فرار می‌کنند، فکر می‌کنند با خیابان راحت‌تر از واکنش پدر و مادرشان می‌توانند کنار بیایند. عده‌ای خانه را به مدت یک هفته ترک می‌کنند، بعضی‌ها هم سال‌ها و تعدادی نیز، هرگز به خانه برنمی‌گردند.

بسیاری از افراد فراری پیش دوستان خود می‌روند، اما اغلب این حالت موقتی و کوتاه است. در نهایت عده زیادی ممکن است به زندگی در پارک‌ها روی بیاورند و برای تأمین زندگی خود، مجبور می‌شوند برای چند تومان، گدایی کنند، فاحشه شوند، یا برای قاچاقچیان مواد مخدر کار کنند. بعضی‌ها توسط دزدها یا اشاعه‌دهندگان فحشا مورد آزار جسمی و جنسی قرار می‌گیرند و سایرین، به مواد مخدر و یا فعالیت‌های خلاف قانون دیگری مثل جعل چک و دزدی کشیده می‌شوند.

اگر نوجوان شما خانه را ترک کرد، بسرعت برای مشورت با مشاور یا روان‌شناس تماس بگیرید. افراد پلیس و والدین دوستان نوجوانتان (و بعضی وقت‌ها خود دوستان فرزندان) ممکن است بتوانند به شما کمک کنند. وقتی فهمیدید نوجوانتان کجاست، بی‌درنگ امکان مشاوره با افراد متخصص را هم برای فرزندان و هم برای بقیه اعضای خانواده فراهم آورید. نوجوان شما دلیلی برای فرار دارد، این دلیل را شناسایی کنید و اقدام‌های پیشگیرانه مناسبی انجام دهید تا این مسئله دوباره تکرار نشود.

این نوجوان‌های فراری چه کسانی هستند؟ تعداد زیادی از آنها در مدرسه عملکرد ضعیفی دارند؛ با والدینشان ارتباط خوبی ندارند، والدین آنها اغلب آنها را از عشق و توجه محروم کرده‌اند. به نظر می‌رسد در این خانواده‌ها، هیچ کس اهمیت نمی‌دهد این بچه‌ها کجا می‌روند و با چه کسانی وقتشان را می‌گذرانند. در این موارد، واکنش نوجوان‌ها به ناکامی‌هایشان، به صورت پرخاشگری و افزایش فزاینده خشونت و جنگ و دعوا بروز می‌کند. جالب اینجاست که فرار آنها راهی است که سرانجام، توجه والدینشان را به خود جلب می‌کند.

بعضی از نوجوان‌ها به دلیل ساختار شخصیتی‌شان، بیشتر از دیگران طغیانگر و مستعد بزهکاری هستند. آنها در مقایسه با بقیه نوجوان‌ها، با قوانین و اصول والدینشان مقابله بیشتر و طولانی‌تری می‌کنند. اما به هر حال، هر نوجوانی که رفتار خارج از کنترل نشان می‌دهد، حتماً دلیلی برای این کار دارد. ممکن است مشکلات روحی جدی و مهمی داشته باشد. یا احساس کند مورد بی‌مهری و فراموشی واقع شده است و با رفتارهایش سعی می‌کند توجه والدینش را به خودش جلب کند. برای مثال در مواردی که پدر بعد از طلاق، از خانواده جدا می‌شود و هزاران کیلومتر دورتر از خانواده زندگی می‌کند، گاهی فرزند نوجوان تعجب می‌کند که چرا پدرش بعد از اینکه مادرش را طلاق داده، از او هم طلاق گرفته است!

در مواردی که توجه اعضای خانواده بر مسائل دیگری (مانند اعتیاد به الکل در پدر یا افسردگی در مادر) متمرکز است، باز هم ممکن است نوجوان از این طریق درصدد جلب توجه خانواده برآید. یا در بعضی موارد، ممکن است مجموعه‌ای از وضعیت‌های ذکر شده، یک جا وجود داشته باشد. در خانواده‌ای که از ابتدا بنیان محکمی ندارد، درگیری نوجوان با قانون، به هر دلیلی که باشد، ممکن است به از هم پاشیدگی کامل خانواده منجر شود. حتی اگر رفتار ضداجتماعی نوجوان گذرا باشد و این رفتار بعد از رشد نیروهای کنترل‌کننده درونی او از بین برود، باز هم ممکن است صدمات پایدار آن برای همیشه، در روابط اعضای خانواده با همدیگر باقی بماند.

وقتی نوجوانان یک اشتباه جدی را ادامه بدهد، یا حتی بدتر شود، مشاوره با افراد متخصص ضرورت پیدا می‌کند. این کار نشان‌دهنده شکست یا ناتوانی شما به عنوان یک والد نیست، بلکه بیشتر از همه، نشانه شدت نیاز نوجوان شما به کمک است. در این مواقع روان‌شناس می‌تواند به شما کمک کند.

وقتی نوجوانی پیوسته رفتار اشتباهی را تکرار می‌کند، باید بفهمید علت این رفتار چیست و شما برای حل این مشکل چه کار باید بکنید. نوجوانی که با والدین خود ارتباط برقرار نمی‌کند، ممکن است با مشاور باتجربه‌ای که قصد ندارد در مورد نوجوان به داوری بنشیند و برای ایجاد ارتباط و اعتماد با این نوجوان وقت صرف می‌کند، سر صحبت را باز کند. اما نوجوانی که با مشاور هم ارتباط برقرار نمی‌کند، ممکن است دچار مشکلات جدی روحی و روانی باشد و در این صورت، بررسی و درمان روحی و روانی کافی توسط افراد متخصص، برای وی ضروری است.

اعضای خانواده نوجوان هم باید در خانواده‌درمانی شرکت جویند. مشکل فقط مربوط به نوجوان نیست. برای هر کدام از اعضای خانواده مفید خواهد بود که بفهمند سدها و موانع ارتباطی چرا و چگونه ایجاد شدند و اکنون چه کار باید بکنند. مشاور ممکن است آنها را در یادگیری و اجرای بخشی از مهارت‌های ارتباطی خوب، کمک کند. در ضمن، ممکن است لازم باشد که نوجوان شما راه‌های قابل قبول‌تری برای هدایت و کنترل انرژی و خشم خود بیاموزد. ممکن است متوجه شود که با ورزش می‌تواند بخشی از اضطراب درونی خود را تخلیه کند یا امکان دارد یک روش سازمان‌یافته تنش‌زدایی کمک‌کننده باشد.

بی‌گمان مشاوره فقط مخصوص نوجوان‌های خلافکار نیست؛ خانواده‌هایی که همیشه اختلاف و درگیری دارند، می‌توانند از این برنامه استفاده کنند. اگر نوجوان شما افت ناگهانی در نمره‌های مدرسه دارد؛ اگر از مدرسه فرار می‌کند و غایب می‌شود؛ اگر خوابش خیلی زیاد شده است؛ یا اگر رفتارش

یک دفعه تغییر کرده است (بویژه خشم، غمگین بودن درازمدت، گریه کردن‌های مکرر، استفاده از مواد مخدر یا الکل)؛ در این صورت، او و بقیه خانواده به مشاوره با افراد متخصص نیاز دارند.

این افراد متخصص، با تخصص‌های مختلف در دسترس‌اند، از جمله روان‌شناس‌ها، متخصصان خانواده‌درمانی، روان‌شناسان بالینی کودک و نوجوان و حتی مشاوران مدارس و سایر افراد می‌توانند کمک کنند. اگر نفر اولی که به او مراجعه کردید کمکی نکرد، موضوع را با مشاور مدرسه مطرح کنید تا فرد دیگری را به شما معرفی کند. شما به درمانگری نیاز دارید تا تشخیص بدهد نوجوان یا خانواده چه مشکلی دارند و برای بهتر شدن اوضاع چه کار باید کرد.

به خاطر داشته باشید که پیشنهاد مشاوره، حمله و توهین به خانواده شما نیست، بلکه راه مناسبی برای بهتر شدن اوضاع نابسامان است. اگر در مشاوره مشخص شد چه اشتباهی مرتکب شده‌اید، عصبانی نشوید، حالت تدافعی به خود نگیرید و از ادامه مشاوره منصرف نشوید، بلکه به جای آن، باز هم به بررسی موضوع بپردازید. این کار، هر چند ممکن است ناخوشایند و ناراحت‌کننده باشد، اما به رشد و پیشرفت خانواده منجر خواهد شد. نوجوان و بقیه اعضای خانواده را هم تشویق کنید همین نگرش و برخورد را داشته باشند. مشاور لایق و بی‌طرف می‌تواند به همه شما کمک کند تا مشکل موجود را از زوایای مفیدی نگاه کنید، زوایایی که الان ممکن است خودتان متوجه آنها نباشید.

هر چند بزرگ کردن یک نوجوان گاهی ممکن است بسیار مشکل به نظر بیاید، اما باز ناامید نشوید. با آگاهی از اینکه خصوصیات اخلاقی دشوار، در دوره نوجوانی خاص خانواده شما نیست و در همه دنیا همین‌طور است، می‌توانید احساس آرامش و آسودگی بیشتری داشته باشید. برای مثال، اگر نوجوانتان یک لحظه پذیرای شما باشد و بخواهد همه چیز زندگی‌اش را برای شما تعریف کند و زمانی، از شما فاصله بگیرد، ساکت شود و نخواهد حتی به معمولی‌ترین سوال‌های شما جواب بدهد. اصلاً عجیب نیست، اما به خاطر داشته باشید که نوجوانتان همیشه به شما نیاز دارد، حتی در زمانی که سعی می‌کند از شما فاصله بگیرد.

صبور، علاقه‌مند و دلسوز باشید. همیشه عشق و علاقه خود را بروز داده و نشان بدهید. در دسترس باشید و این امکان را ایجاد کنید که نوجوانتان به شما نزدیک شود، با گذشت زمان می‌توانید به نوجوانتان از همیشه نزدیک‌تر و صمیمی‌تر باشید. با او حرف بزنید و برایش شنونده خوبی باشید. زمانی که با شما صحبت می‌کند و حتی از عملکردهای ضعیف و یا از اشتباهات خودش سخن می‌گوید هرگز او را سرزنش نکنید.

منابع و مآخذ

منابع فارسی

ابوالفتحی، یدالله؛ عابدی، حیدرعلی؛ توکلی، خسرو و نصیری، محمود (۱۳۸۵). تعیین سطوح پیشگیری در پدیده فرار از منزل. *مقاله ارائه شده در دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران*. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

احمد، احمد (۱۳۸۲). *روان‌شناسی نوجوانان و جوانان: شخصیتی، رفتاری، تحصیلی، شغلی، بزهکاری و اعتیاد*. اصفهان: انتشارات مشعل.

احمدخانی‌ها، حمیدرضا، ترکمن‌نژاد، شریف و حسینی مقدم، محمد مهدی (۱۳۸۱). همه‌گیرشناسی افسردگی و سوءاستفاده جنسی در کودکان خیابانی. *فصلنامه اندیشه و رفتار* ۲۹، شماره ۱، ص ۲۰-۱۴.

اسلامی، احمدعلی (۱۳۷۶). بررسی نگرش افراد نسبت به مذهبی بودن و رابطه آن با افسردگی در دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان‌های اسلام‌شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقاتی بهداشتی.

ارشادی‌منش، سودابه (۱۳۸۴). مقایسه دانش‌آموزان دارای تجربه شکست و تجربه موفقیت براساس متغیرهای حمایت اجتماعی، نگرش تحصیلی و کمبودهای فزاینده. *مجله علوم روان‌شناختی*، دوره چهارم، شماره ۱۵، ص ۲۳۴-۲۲۰.

آزاد فلاح، پرویز؛ دادستان، پریخ؛ اژه‌ای، جواد و مؤذنی، سیدمحمد (۱۳۷۸). تنیدگی (استرس)، فعالیت مغزی/ رفتاری و تغییرات ایمونوگلوبولین ترشحی A. *مجله روان‌شناسی*، سال سوم، شماره ۱، ص ۲۲-۳.

آمار وزارت آموزش و پرورش (۸۱-۱۳۸۰). تهران: معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش.

انجمن اولیا و مربیان (۱۳۵۱). بررسی چند تحقیق درباره مسایل نوجوانان. شماره ۵، ص ۳۲-۳۵.

انجمن اولیا و مربیان (۱۳۵۶). پژوهش‌هایی درباره نسل جوان. شماره ۵، ص ۲۸-۳۱.

انجمن اولیا و مربیان (۱۳۶۱). واحد پژوهش‌های تربیتی، تحقیق در کانون اصلاح و تربیت تهران.

باباپور خیرالدین، جلیل؛ رسول‌زاده طباطبایی، سید کاظم؛ اژه‌ای، جواد و فتحی آشتیانی، علی (۱۳۸۲). بررسی رابطه بین شیوه‌های حل مسئله و سلامت روان‌شناختی دانشجویان. *مجله روان‌شناسی*، سال هفتم، شماره ۱، ص ۱۶-۳.

بازرگان، زهرا، صادقی، ناهید و لواسانی، غلامعلی (۱۳۸۲). بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران؛ مقایسه نظرات دانش‌آموزان و معلمان. *مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال سی و سوم، شماره ۱، ص ۲۸-۱*.

بازیاری میمندی، مهتاب؛ رسول‌زاده طباطبایی، کاظم و آزاد فلاح، پرویز (۱۳۸۲). بررسی مقایسه‌ای عوامل تنش‌زا و شیوه‌های مقابله با آن در دختران فراری و عادی شهر تهران. *مجله روان‌شناسی، سال هفتم، شماره ۴، ص ۳۹۷-۳۸۷*.

بشارت، محمدعلی (۱۳۷۹). بررسی نقش متغیرهای خانوادگی در پدیدآیی اختلالات مصرف مواد. *مجموعه مقالات اعتیاد و جوانان، تهران: دانشگاه علم و صنعت*.

براتوند، محمود (۱۳۷۸). *کودک خیابانی یک معضل اجتماعی*. اداره کل زندان‌های استان خوزستان. بواله‌ری، جعفر؛ احسان‌منش، مجتبی و کریمی کیسمی، عیسی (۱۳۷۹). بررسی رابطه عوامل تنش‌زا، میزان توکل به خدا و نشانگان تنیدگی در دانشجویان پزشکی. *مجله اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره ۱، ص ۳۴-۲۵*.

بهرامی احسان، هادی (۱۳۸۳). *اعتیاد و فرایند پیشگیری*. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

بهرامی مشعوف، عباس (۱۳۷۳). بررسی رابطه بین عبادت و سلامت روان. *تهران: دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد*.

پیام مشاور (۱۳۸۵). شادی و عوامل مؤثر بر آن. *شماره ۴۷، ص ۲-۱*. تقوی، محمدرضا و هاشمی، لادن (۱۳۸۳). بررسی عوامل مؤثر در فرار دختران از خانه، مطالعه موردی در شهر شیراز با استفاده از روش کیفی. *مقاله ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران*. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

ستاری، بهزاد و اعظمی، احد (۱۳۸۳). بررسی میزان گرایش به اعتیاد افراد بالای ده سال خانواده‌های استان اردبیل در سال ۱۳۸۲. *مقاله ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران*. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

سمندری، ناهید (۱۳۷۳). بررسی نظر دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در مورد ابعاد اخلاقی - خانوادگی بیماری ایدز و نقش آن در پیشگیری از این بیماری. *مقاله ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران*. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

شهریاری احمدی، منصوره (۱۳۸۳). بررسی تأثیر ساختار خانواده بر میزان تمایل نوجوانان نسبت به بزهکاری. مقاله ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

جعفری، فرهاد؛ اعظمی، فاطمه؛ امین زاده، ملیحه و نصرالهی، زینب (۱۳۸۵). بررسی بزهکاری و عوامل مؤثر بر آن در دختران نوجوان. مقاله ارائه شده در دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

چاوشی‌فر، جلال و رسول‌زاده طباطبایی، کاظم (۱۳۷۹). بررسی مقایسه‌ای عوامل تنش‌زا و شیوه‌های رویارویی در نوجوانان مراکز شبانه‌روزی و نوجوانان دارای والدین. مجله روان‌شناسی، سال چهارم، شماره ۲. ص ۱۸۴-۱۶۹.

حسینیان، سیمین و خدابخشی کولائی، آناهیتا (۱۳۸۳). بررسی رابطه بین فرار دختران و سابقه بدرفتاری و خشونت جسمانی و سوء استفاده جنسی در دوران کودکی آنان. مجله علوم روان‌شناختی، دوره سوم، شماره ۱۰، ص ۱۳۵-۱۲۳.

حسینیان، سیمین (۱۳۸۳). بررسی خصوصیات دموگرافیک نوجوانان فراری و خانواده‌های آن‌ها به منظور پیشگیری از رفتار فرار. مقاله ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

حمیدی، فریده (۱۳۸۳). بررسی سبک دلبستگی، ساخت خانواده در دختران فراری و اثربخشی خانواده درمانی و روان‌درمانگری حمایتی در تغییر آن‌ها. مقاله ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

حیدرنیا، احمد و چرخیان، امیر (۱۳۸۵). بررسی کیفیت رابطه ولی-فرزند نوجوانان دارای اعتیاد و نوجوانان عادی شهر تهران. مقاله ارائه شده در دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

خدایاری‌فرد، محمد (۱۳۸۲). کارایی روش‌های شناخت-رفتار درمانگری توأم با دارودرمانی در درمان اسکیزوفرنی (مطالعه موردی). مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال سی و سوم، شماره ۱، ص ۷۷-۱۰۲.

خدایاری‌فرد، محمد (۱۳۸۵). مسایل نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات انجمن و اولیا و مربیان.

خدایاری‌فرد، محمد و پرند، اکرم (۱۳۸۵). تأثیر خانواده‌درمانی با تأکید بر رویکرد شناختی-رفتاری در درمان هراس اجتماعی نوجوانان (مطالعه موردی). مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی. شماره ۲، ص ۱۴۰-۱۲۱.

خدایاری فرد، محمد و پرند، اکرم (۱۳۸۴). خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری در اختلال افسردگی نوجوانی: مطالعه موردی. پژوهش‌های روان‌شناختی، دوره هشتم، شماره‌های ۳ و ۴، ص، ۸۳-۶۲.

خدایاری فرد، محمد و رحیمی‌نژاد، عباس (۱۳۸۵). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه‌های شهر تهران. گزارش نهایی طرح پژوهشی اجراشده در بنیاد شهید انقلاب اسلامی و دانشگاه تهران. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.

خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، محمد؛ و شکوهی یکتا، محسن (۱۳۸۰). رابطه عوامل تنش‌زا و نشانگان تنیدگی با راه‌های مقابله در جوانان. تهران: گزارش نهایی طرح پژوهشی اجرا شده زیر نظر دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (۱۳۸۴). گزارشی از یک مورد درمان روان‌پویشی اختلال وحشت‌زدگی با گرایش روابط موضوعی و روان‌شناسی خود. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، شماره ۲، ص، ۶۱-۳۹.

خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (۱۳۸۲). کاربرد خانواده درمانگری مبتنی بر فنون شناختی - رفتاری در سه تک بررسی وسواس - بی‌اختیاری. مجله علوم روان‌شناختی، دوره دوم، شماره ۶، ۱۲۴-۱۰۱.

خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (زیر چاپ). خانواده‌درمانی شناختی - رفتاری اختلالات کودکان و نوجوانان.

خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (۱۳۸۰). مقایسه کارایی روش‌های شناخت - رفتار درمانگری و شناخت رفتار درمانگری توأم با دارودرمانی، در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال سی و یکم، شماره ۱، ۱۷۹-۱۴۵.

خرم‌آبادی، راضیه و طالبیان شریف، جعفر (۱۳۸۵). شیوه‌های حل مسئله، سبک‌های والدینی و منبع مهار در دختران فراری. مقاله ارائه شده در دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.

رفعیان، احمد (۱۳۷۵). بررسی دموگرافیک معتادین بستری شده در مرکز بازپروری یزد. یزد: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

زرگر، یدالله (۱۳۷۸). زمینه‌یابی و برآوردی از میزان اعتیاد بین کارکنان صنایع استان خوزستان. ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان.

- سعیدی، محمد (۱۳۷۲). بررسی علل فرار نوجوانان از خانه. *پایان‌نامه کارشناسی ارشد*. تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
- قریشی‌زاده، محمدعلی و ترابی، کتابون (۱۳۸۱). بررسی عوامل مؤثر در وابستگی به مواد مخدر در مراجعه‌کنندگان به مرکز خود معرف تبریز. *فصلنامه اندیشه و رفتار* ۲۹، شماره ۱، ص ۲۸-۲۱.
- صدیق سروستانی، رحمت‌الله (۱۳۷۵). بررسی وضعیت اجتماعی خانواده‌های ساکن منطقه ۱۵ شهر تهران. تهران: مرکز آموزش سازمان زندان‌ها.
- صولتی، کمال؛ نیک‌فرجام، مسعود و دریس، فاطمه (۱۳۸۳). بررسی رابطه سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر با اختلالات روانی اعضای خانواده مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره کلینیک ویژه بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد در سال ۱۳۸۰. *مقاله ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران*. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.
- ظهره‌وند، راضیه (۱۳۷۵). بررسی تحولی ملاک‌ها و کیفیت دوستی با روش‌های مقابله با فشارهای روانی در نزد کودکان و نوجوانان دختر. *پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی*. تهران: دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
- عابدینی، یاسمین (۱۳۸۶). نقش درگیری تحصیلی و اهداف پیشرفت در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان: مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دو رشته ریاضی- فیزیک و علوم انسانی. *رساله دکتری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران*.
- عابدینی، یاسمین (۱۳۸۲). رابطه موفقیت تحصیلی، راه‌های مقابله با تنیدگی و جایگاه اجتماعی- اقتصادی در نوجوانان دختر. *مجله روان‌شناسی، سال هفتم، شماره ۱، ص ۲۹-۱۷*.
- علمی، محمود (۱۳۸۵). انحرافات جنسی نوجوانان و ارتباط آن با محیط خانواده. *مقاله ارائه شده در دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران*. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.
- فقیهی، علی نقی (۱۳۸۴). *بهداشت و سلامت روان در آینه علم و دین*. قم: انتشارات حیات سبز.
- فیروزآبادی، علی (۱۳۷۵). بررسی عوامل مؤثر در روی‌آوری فرد وابسته به مصرف مجدد ماده مخدر سمnan. *دانشگاه علوم پزشکی سمnan*.
- فلاح‌تی خشک‌ناب، مسعود (۱۳۷۷). بررسی نقطه نظرات دین اسلام درمورد پیشگیری از بیماری‌های جنسی با تأکید بر نقش خانواده. *مقاله ارائه شده در مجموعه مقالات ارائه‌شده در اولین همایش نقش دین در بهداشت روان*. قم: دفتر نشریه نوید اسلام.

کامرانی فکور، شهربانو؛ رسولزاده طباطبایی، کاظم و اللهیاری، عباسعلی (۱۳۸۲). بررسی مقایسه‌ای خصوصیات روان‌شناختی زنان ویژه با زنان عادی. *مجله روان‌شناسی، سال هفتم، شماره ۳*، ص ۲۶۹-۲۵۳.

کهرازهی، فرهاد؛ آزاد فلاح، پرویز و اللهیاری، پرویز (۱۳۸۲). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله در کاهش افسردگی دانش‌آموزان. *مجله روان‌شناسی، سال هفتم، شماره ۲*، ص ۱۴۲-۱۲۷.

گریدانوس، دونالد. ای. *مراقبت از نوجوانان*. ترجمه پوریا صرامی فروشانی و بزرگمهر مطهری (۱۳۸۳)، تهران: انتشارات رشد.

محفوظی، محمود و جان بزرگی، مسعود (۱۳۷۷). *ماهنامه روان‌شناسی امروز، سال اول، شماره ۴*.

مرکز آمار ایران (۱۳۷۷). *سالنامه آماری کشور*.

مرکز آمار ایران (۱۳۶۲). *سالنامه آماری کشور*.

مهدی‌زاده، محمد (۱۳۶۸). *مجله علمی دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، سال چهارم، شماره ۱۵*، ص ۳۳-۴۷.

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان مرکزی (۱۳۷۵). *بررسی علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در استان مرکزی*.

موسوی، اشرف السادات (۱۳۸۳). بررسی کیفی - کمی عملکرد خانواده معتادان نوجوان. *مقاله ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران*. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.

هومن، عباس (۱۳۷۶). پژوهش در زمینه سطوح و انواع استرس و راهبردهای مقابله با آن در دانشجویان. *تهران: مؤسسه تحقیقات تربیتی*. گزارش نهایی طرح خاتمه یافته.

منابع لاتین

- Abramson, L., Seligman, M., & Teasdale, J. (1978). Learned Helplessness in human: Critique and reformulation. *Journal of Abnormal Psychology*, 87, 49-74.
- Acklin, M.W., Brown, E. C., & Manuger, P.A. (1983). The role of religious values in coping with cancer. *Journal of Religion and Health*, 22(4), 201-209.
- Adityanjee, S. , & Murray, R. (1999). The role of genetic predisposition in alcoholism. In I, Glass (Eds.) , *The international hand book of addiction behavior*, London: Routledge.
- Agee, V. L. (1986). Institutional treatment programs for the violent juvenile. In S. J. Apter & A. P. Goldstein (Eds.), *Youth violence: Programs and prospects* (pp. 75-88). New York: Pergamon Press.

- Akers, R. L., Krohn, M. D., Lanza-Kaduce, L., & Radosevich, M. (1979). Social learning and deviant behavior: A specific test of a general theory. *American Sociological Review* , 44, 636-655.
- Altshuler, J., & Ruble, D. (1989). Developmental changes in children's awareness of strategies for coping with uncontrollable stress. *Child Development* , 60, 1337-1349.
- American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Text Revision* , (4th edn.), Washington, D.C.: American Psychiatric Association.
- Andrews, D. A., Zinger, I., Hodge, R. D., & Bonta, J. (2004). Does correctional treatment work? A meta-analysis. *Criminology* , 28, 369-404.
- Attie, I., & Brooks-Gunn, I. (1989). Development of eating problems in adolescent girls: A longitudinal study, *Developmental Psychology*, 25, 70-79.
- Avison, W., & McAlpine, D. (1992). Gender differences in symptoms of depression among adolescents. *Journal of Health and Social Behavior* , 33, 77-96.
- Baker, S., Thalberg, S., & Morrison, D. (1988). Parents' behavioural norms as predictors of adolescent sexual activity and contraceptive use. *Adolescence*, 23 , 265-282.
- Bancroft, J. (1994). Homosexual orientation: The search for a biological basis. *British Journal of Psychiatry* , 64, 437-440.
- Band, E., & Weisz, I. (1988). How to feel better when it feels bad: Children's perspectives on coping with everyday stress, *Developmental Psychology* , 24, 247-253.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Barden, J. C. (2000). Strife in families swells tide of homeless youths. *The New York Times*, pp. A1, B8.
- Barling, N., & Moore, S. (1990). Adolescents attitudes towards AIDS precautions and intention to use condoms. *Psychological Reports* , 67, 883-890.
- Barlow, D. H. (1988). *Anxiety and its disorders*. New York: Guilford Press.
- Barnes, A. (2004). Race, Schizophrenia and admission to state Psychiatric hospitals. *Administration and policy in mental Health* , 31(3), 241-242.
- Baron, R., & Byrne, D. (1994). *Social psychology: Understanding human interaction*. Boston: Allyn and Bacon.
- Barrett, P., Healy- Farrell, L., & March, J.S. (2004). cognitive - behavioral family treatment of childhood obsessive - Compulsive disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent psychiatry* , 43(1), 46-48.
- Bastian, L. D. (1993). *Criminal victimization 1992* . Washington, DC: Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice.
- Bean, R., Bush, K.R., McKenry, P.C., & Wilson, M. (2003). the impact of parental support, behavioral control, and psychological control on the academic achievement of adolescents. *Journal of Adolescent Research* , 18(5), 523-525.
- Becker, M. (1974). The health belief model and sex role behavior. *Health Education Monographs* , 2, 409-419.
- Belloni, J., Blumenthal, D., Bracy, P., Braithwaite, R., Cohen, S., Goodman, R. H., Green, L. W., Hausman, A. J., Ketto, C., Kreuter, M. W., Sterling, E. E., Walter, J., & Wilson-Brewer, R. (1991). Application of principles of community intervention. *Public Health Reports*, 106, 244-247.

- Benthin, A., Slovic, P., & Severson, H. (1993). A psychometric study of adolescent risk perception. *Journal of Adolescence*, 16, 153-168.
- Berg, H. (1991). *Beyond The relaxation response*. New York: Berkely Books.
- Bergin, A. E. (1991). Values and religious issues in psychotherapy and mental health. *American Psychologist*, 46, 3, 4-403.
- Beyth-Marom, R., Austin, L., Fischhoff, B., Palmgren, C., & Jacobs-Quadrel, M. (1993). Perceived consequences of risky behaviors: Adults and adolescents. *Developmental Psychology* 29: 549-563.
- Bezner, A. T. & Steinhardt, M. (1997). The conceptualization and measurement of perceived wellness. Integrating balance across and within dimensions. *American Journal of Health Promotion*, 23, 208-218.
- Block, J., Block, J. H., & Keyes, S. (1988). Longitudinally foretelling drug usage in adolescence: Early Childhood personality and environmental precursors. *Child Development*, 59, 336-355.
- Bond, L. S., Jiminez, M. V., & Mazin, R. (1992). Street kinds and AIDS. *AIDS Education and Prevention*, (Fall Suppl.), 14-23.
- Borst, S., & Noam, G. (1993). Developmental psychopathology in suicidal and nonsuicidal adolescent girls. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 32, 501-508.
- Boruch, B., Coleman, D., Doria-Ortiz, C., Girouard, S., Goodman, A., Hudson, L., Kraus, J., Maseru, N., Prothow-Sith, D., Rugg, D. L., Stark, E., Stephens, R. D., & Sterling-Scott, R. (1991). Violence prevention strategies targeted at the general population of minority youth. *Public Health Reports*, 106, 247-250.
- Brennen, T., Huizinga, D., & Elliot, D. S. (1979). *The social psychology of runaways*. Lexington, MA: Lexington Books.
- Brindis, C., Morales, S. S., McCarter, V., & wolfe, A. L. (1993). *An evaluation study of school-based Clinics in California*. Sanfrancisco: University of California.
- Brook, D., & Brook, J. (1990). The etiology and consequences of adolescent drug use. in R. Watson (Ed.), *Drug and alcohol abuse prevention*, Clifton, N.J.: Humana Press.
- Brooks-Gunn, J., & Furstenberg, F. (1989). Adolescent sexual behavior. *American Psychologist*, 44, 249-257.
- Brunswick, A. (1991). Health and substance use in adolescence: Ethnic and gender perspectives, in R. Lerner, A. Petersen and I. Brooks-Gunn (Eds.), *Encyclopedia of Adolescence*, 1, New York: Garland Press.
- Bucy, J. (1987). Prepared statement of June Bucy, Executive Director, the National Network of Runaway and Youth Services, Washington, DC. In *The crisis in homelessness: Effects on children and families*. Hearing before the Select Committee on Children, Youth, and Families, House of Representatives. Washington, DC: U. S. Government Printing Office.
- Bucy, J., & Obolensky, N. (2004). Runaways and homeless youths. In M. J. Rotheram – Bours, J. Bradley, & N. Obolensky (Eds.), *Planning to live: Evaluating and treating suicidal teens in community settings* (pp. 333 – 353). Tulsa: university of Oklahoma Press.
- Burbach, D., & Peterson, L. (1986). Children's concepts of physical illness: A review and critique of the cognitive-developmental literature, *Health Psychology*, 5, 307-325.

- Burns, J., Cottrell, L., Perkins, K., & Pack, R. (2004). Depressive symptoms and health Risk among rural adolescents. *Pediatrics* , 113(5), 1313-1321.
- Cahn, K., Chamberlain, B., Old Dog Cross, P., Daro, D., Eron, L. D., Froehlke, R. G., Galter, J. L., Guerra, F. A., Hammett, M., Hill, H., Ostos, T., Parron, D., Saltzman, L., Slaby, R. G., Sorenson, S. B., Vince, C. J., & Widom, C. S. (1991). Interventions in early childhood. *Public Health Reports*, 106, 258-263.
- Cairns, R., Coleman-Miller, B., Greenwood, P., Hewitt, W. W., Jenkins, E., Jenkins, R., Maccannon, G., Mitchell, M., Napper, D., Reiss, A. J., Sciammarella, E., Valdivia, S. D., & Warren, R. C. (1991). Violence prevention strategies directed toward high-risk minority youths. *Public Health Reports*, 106, 250-254.
- Campbell, J. (1975). Illness is a point of view: The development of children's concepts of illness. *Child Development*, 46, 92-100.
- Carson, R., Butcher, J., & Coleman, I. (1988). *Abnormal psychology and modern life* (8th edn.), Glenview, Ill.: Scott, Foresman & Co.
- Castle, K., Duberstein, P.R., Meldrum, S., Conner, K.R., & Conwell, Y. (2004). *American Journal of Psychiatry* , 161(3), 452-454.
- Celia, S. (1990). School refusal and school problems in Brazil. In C. Chiland, & J. G. Young (Eds.), *Why children reject school: Views from seven countries* (pp. 152-159). New Haven: Yale University Press.
- Center for Disease Control and prevention. (2004). tragic teen suicides inspire idea that invites more. *USA Today* , 21, 226-228.
- Centers for Disease Control. (1992). *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 41, 1-33.
- Choquet, M., & Manfredi, R. (1992). Sexual intercourse, contraception, and risktaking behavior among unselected French adolescents aged 11-20 years. *Journal of Adolescent Health*, 13 , 623-403.
- Ciordon, S., & Gilgun, J. (1987). Adolescent sexuality, in V. Van Hasselt and M. Hersen (Eds.). *Handbook of adolescent psychology* , New York: Oxford.
- Clarck, D., Cornelius, J., Wood, D.S., & Vanguko, M. (2004). Psychopathology Risk transsion in children of parents with substance use disorder. *The American Journal of psychiatry* , 161(4), 658-691.
- Cohen, R., Brownell, K., & Felix, M. (1990). Age and sex differences in health habits and beliefs of schoolchildren. *Health Psychology*, 9, 208-224.
- Coleman, I. (1992). Current views of the adolescent process. in J. Coleman (Ed.). *The school years - Current issues in the socialization of young people* (2nd edn). London: Routledge.
- Collip, P.H. (1969). The effecacy of prayer: Atriple blind study. *Medical Times*, 97, 201-209.
- Compas, B. (1987). Coping with stress during childhood and adolescence. *Psychological Bulletin*, 101 , 393-403.
- Conger, J. J., & Miller, W. C. (1966). *Personality, Social class, and delinquency*. New York: Wiley.
- Cook, P., Juarez, P., Lee, R., Loftin, C., Marshall, O. A., Maurrain, W. A., Roth, J. A., Ryan, J., Smith, G. K., Spivak, H., Teret, S. P., Walker, M., & Wintermute, G. J. (2001). Weapons and minority youth violence. *Public Health Reports*, 106, 254-258.
- Crawford, J., Turtle, A., & Kippax, S. (1990). Student-favoured strategies for AIDS avoidance, *Australian Journal of Psychology*, 42, 123-137.

- Crosnoe, R., & Elder, G.H. (2004). family dynamics, Supportive relationship, and Educational during adolescence. *Journal of Family Issues* , 25(5), 571-600.
- Davison, G., & Neale, I. (1994). *Abnormal Psychology* (4th edn.), New York: John Wiley & Sons.
- De Wilde, E., Kienhorst, I., Diekstra, R., & Wolters, W. (1993). The specificity of psychological characteristics of adolescent suicide attempters. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 32 , 51-59.
- Deisher, R., & Rogers, W. (1991). The medical care of street youth. *Journal of Adolescent Health*, 12, 500-503.
- Dembo, R., Blount, W. R., Schmeidler, J., & Burgos, W. (1986). Perceived environmental drug use risk and the correlates of drug use and non-use among inner-city youths: The motivated actor. *International Journal of the Addictions*, 21, 977-1000.
- Department of Employment, Education & Training (1991). 1989 *Australian Youth Survey-First results*, Canberra: Australian Government Publishing Service.
- Diclemente, R. J., Hansen, W. B., & Ponton, L. E. (1996). *Handbook of Adolescent Health Risk Behavior*, Plenum Press: New York and London.
- Dielman, T., Leech, S., Becker, M., Rosenstock, I., Horvath, W., & Radius, S. (1980). Dimensions of children's health beliefs. *Health Education Quarterly*, 7, 219-238.
- Dilalla, L. F., & Gottesman, I. (2003). Biological and genetic contributors to violence-Widoms untold tale. *Psychological Bulletin*, 109 (1), 125-129.
- Dodge, K. A., Pettit, G.S., McClaskey, C.L., & Brown, M. M. (1986). Social competence in children. *Monographs of the Society for Research in Child Development* , 51(2, Serial No. 213).
- Donahue, J.M., & Benson, H, (1995). Religious and well-being of adolescents. *Journal of Social Issues*, 51(2), 145-160.
- Donovan, J., & Jessor, R. (1985). Structure of problem behavior in adolescence and young adulthood. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 53 , 890-904.
- D'Zurilla, T. J.; Sheedy, C. F. (1992). The relations between social problem solving ability and subsequent level of academic competence in college students. *Cognitive Therapy and Research*, 16, 5/589-599.
- Earls, F. (1991a). Not fear, nor quarantine, but science: Preparation for a decade of research to advance knowledge about causes and control of violence in youths. *Journal of Adolescent Health*, 12, 619-629.
- Earls, F. (1991b). A developmental approach to understanding and controlling violence. In H. E. Fitzgerald, B, M. Leister & M. W. Yoguray (Eds.), *Theory and research in behavioral pediatrics* (Vol. 5, pp. 61-87). New York: Plenum Press.
- Earls, F., & Robins, L. N., Stiffman, A. R., & Powell, J. (1989). Comprehensive health care for high-risk adolescents: An evaluation study. *American Journal of Public Health*, 79, 999-1005.
- Earls, F., & Tonry, M. (1989). *Program on human development and criminal behavior: Proposed research agenda*. Submitted to John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Harvard University Mimeograph.
- Earls, F., Cairns, R., & Mercy, J. (2003). The control of violence and the promotion of nonviolence in adolescents. In S. Millstein, A. Petersen, & E. Nightengale (Eds.), *Adolescent Health Promotion* (pp. 285-304). New York: Oxford University Press.
- Edlin, G. & Golanty, E.; Brown, K. M. (1999). *Health and wellness*. Jones and Bartlett publisher, international barb house, Barb Mews, London W6, 7PA, UK.

- Egger, G. (1986). Health Promotion, in N. King and A. Remenyi (Eds.), *Health care: A behavioral approach*, Sydney: Grune & Stratton.
- Eisenbery, M. E., Neumark, D., & Perry, CL. (2003). peer harrassment, school competence and academic achievement. *The Journal of School Health* , 73(8), 311-315.
- Elkind, D. (1967). Egocentrism in adolescence. *Child Development*, 38, 1025-1034.
- Elliott, D. S., Huizinga, D., & Menard, S. (1989). *Multiple problem youth Delinquency, substance use, and mental health problems* . Berlin: Springer-Verlag.
- Elliot, T. R.; Shewchuk, R. M. & Richar, J. S. (1999). Caregiver social problem solving abilities and family member adjustment to recent-onset physical disability. *Rehabilitation psychology*, 44, 104-123.
- Erasmus, R. V. (1977). Advances in understanding happiness. *Revue quebecoise de psychologie*, 18, 29-79.
- Engel, G. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196, 129-136.
- Englander, S. W. (1984). Some self – reported correlates of runaway behavior in adolescent females. *Journal of Consulting & Clinical Psychology*, 52, 484 – 485.
- Erikson, E. (1968). *Identity: Youth and crisis* , New York: W.W. Norton & Co.
- Erlenmeyer- Kimling, L., & Cornblatt, B. (1991). Schizophrenia in adolescence and young adulthood, antecedents predictors of. in R. Lerner, A. Petersen and I. Brooks-Gunn (Eds.), *Encyclopedia of adolescence* , Vol. 2, New York: Garland Press.
- Fairburn, C.G., Harrison, P.J., Kotler, L.A., & Walsh, B.T. (2003). *Eating Disorder Lancet* , 361, 407-416.
- Farrington, D.P. (1987). Epidemiology. In H. C. Quay (Ed.), *Handbook of juveniled elinquency* , (pp. 33-61). New York: Wiley.
- Farrington, D.P. (1992). Explaining the beginning, progress, and ending of antisocial behavior from birth to adulthood. In J. McCord (Ed.), *Advances in criminological theory* : Vol. 3. Facts, *frameworks, Am forecasts*. New Brunswick Transaction Publishers.
- Farrow, J.A., & French, J. (1986). The drug abuse- delinquency connection Revisited. *Adolescence* , 21(84), 951-953.
- Federal Bureau of Investigation. (1993a). *Age-specific arrest rates and race-specific arrest rates for selected offenses* . 1965-1992. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- Fiala, R., & Lafree, G. (1988). Cross-national determinants of child homicide. *American Socilolgical Review*, 53, 432-435.
- Flament, M., Rapoport, J., Berg, C., Sceery, W., Kilts, C., Mellstrom, B., & Linnoila, M. (1985). Clomipramine treatment of childhood obsessive – compulsive disorder. *Archive of General Psychiatry*, 42, 977-983.
- Flannery, D., Vazsonyi, A. Torquati, J., & Fridrich, A. (1994). Ethnic and gender differences in risk for early adolescent substance use. *Journal of Youth and Adolescence*, 23 , 195-213.
- Fromme, K., & Rivet. K. (1994). Young adults coping style as a predictor of their alchol use and response to daily events. *Journal OF Youth and Adolescence*, 23 , 85-97.

- Frydenberg, E., & Lewis, R. (1993). Boys play sports and girls turn to others: Age gender and ethnicity as determinants of coping. *Journal of Adolescence*, 16 , 253-266.
- Garcia - Garau, E. (2004). Adolescent boys and girls show different predispositions for eating disorders. *Women's Health Weekly* , 6, 22-94.
- Garfinkel, P., & Garner, D. (1982). *Anorexia nervosa: A multidimensional perspective* , New York: Brunner/ Maze.
- Garland, A., & Zigler, E. (1993). Adolescent suicide prevention: Current research and social policy implications. *American Psychology*. st, 48, 169-182.
- Garland, E. J. (2004). antidepressant treatment in children and adolescents. *Canadian Medical Association Journal* , 17 (4), 489-491.
- Garnets, L., & Kimnel, D. (1991). Lesbian and gay male dimensions in the psychological study of human diversity, in J. Goodchilds (Ed.), *Psychological perspectives on human diversity in America: Master lectures* , Washington, D.C.: American Psychological Association.
- Garret, C. J. (1985). Effects of residential treatment on delinquents: A meta-analysis. *The Journal of Research in Crime*, 22, 287-308.
- Gartner, R. (1990). The victims of homicide: A Temporal and cross - national comparison. *American Sociological Review*, 55, 92-106.
- Geller, D. A., Biederman, J., Stewart, S. E., Mullin, B., Mrtin, A., & Spencer, T. (2003). which SSRI? A meta analysis of pharmacotherapy Trialsin pediatric obsessive - compulsive disorder. *American Journal of Psychiatry* , 160(11), 1919-1921.
- General Accounting Office. (1989). *Homelessness: Homeless and runaway youth receiving services at federally funded shelters*. Washington, DC: Author.
- Gilchrist, L. D. , & Schinke, S. P.(1983). Coping with contraception: Cognitive and behavioral methods with adolescents . *Cognitive Therapy Research*, 7 , 379-388.
- Glueck, S., & Glueck, E. T. (1968). *Delinquents and non-delinquents in perspective*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gochman, D. (1971). Some correlates of children' s health beliefs and potential health behavior *Journal of Health and Social Behavior*, 12, 148-154.
- Gochman, D. (1988). Health behavior: Plural perspectives, in D. Gochman (Ed.), *Health behavior: Emerging research perspectives*, New York: Plenum Press.
- Goldstein, A. P. (1986). Psychological skill training and the aggressive adolescent. In S. J. Apter & A. P. Goldstein (Eds.), *Youth violence: Programs and prospects* (pp. 89-119). New York: Pergamon Press.
- Gordon, D. (1990). Formal operating thinking. *American Journal of orthopsychiatry*, 60, 346-356.
- Gordon, S., & Gligun, J. (1987). Adolescent sexuality, in V. Van Hasselt and M. Hersen (Eds.) *Handbook of adolescent psychology*, NewYork: Oxford.
- Gore, S., Aseltine, R., & Colton, M. (1992). Social structure, life stress and depressive symptoms in a high school - aged population. *Journal of Health and Social Behavior*, 33 , 97-113.
- Grange, D.L., Loeb, K.L., Orman, S.V., & Jellar, C. (2004). Bulimia nervosa in adolescent Medicine, 158(5), 478-485.
- Greenblatt, M., & Robertson, M. J. (1993). Life – styles, adaptive strategies, and sexual behaviors of homeless adolescents. *Hospital and Community Psychiatry*, 44 (12), 1177 – 1180.

- Greene, J. (1979). Overview of adolescent drug use, in G. Beschner and A. Friedman (Eds.), *Youth drug abuse: Problems, issues, and Treatment*, Lexington, K. Y.: Lexington Books.
- Greene, M. B. (1993). Chronic exposure to violence and poverty: Interventions that work for youth. *Crime and Delinquency*, 39, 106-124.
- Grissom, J. B., & Shepard, L.A. (1989). Repeating and dropping out of school. In L. A. Shepard & M. L. Smith (Eds.), *Flunking grades: Research and policies on retention*. New York: Falmer Press.
- Gross, R. T., Duke, P. M. (1980). The effect of early versus late physical maturation on adolescent behavior. *Pediatric Clinics of North America*, 27, 71-77.
- Hardy, J. B. (1991). Pregnancy and its outcome. In W. R. Hendee (Ed.), *The health of adolescents* (pp. 250 – 281). San Francisco: Jossey – Bass.
- Hauscr, S., & Bowlds, M. (1990). Stress, coping, and adaptation, in S. Feldman and G. Elliott (Eds.), *At the threshold: The developing adolescent*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Heatherton, T., & Baumeister, R. (1991). Binge eating as escape from selfa reness. *Psychological Bulletin*, 108, 86-110.
- Heaven, P.C.L. (1996). *Adolescent Health: the role of individual differences*. Rutledge: London and New York.
- Hermon, D. A. & Hazler, R. J. (1999). Adherence to a wellness model and perceptions of psychological well-being. *Journal of counseling and development*, 77, 3, 339-343.
- Heins, H. C., Nance, N. W., Mc Carthy, B. J., & Efird, C. M. (2004). A randomized trial of nurse – midwifery prenatal care to reduce low birth weight. *Obstetrics and Gynecology*, 75, 341 – 345.
- Hemmens, K. C., Luecke, M. R. (1988). *Sheltering homeless youths : A guide to Illinois Law and programs*, Chicago : The Chicago Law Enforcement Sru dy Group.
- Hendick, T. H., & King, N.J. (1998). Emprically supported treatments for children with phobic disorders. *Journal of Clinical child Psychology*, 27, 156-167.
- Henshaw, S. K. (1992). Abortion trends in 1987 and 1988: Age and race. *Family Planning Perspectives*, 24, 85 – 87.
- Hersov, L. (1985). School avoidance. In M. Rutter & L. Hersov (Eds.), *child and adolescent psychiatry: Modern approaches* (pp. 382-389). Oxford: Blackwell Scientific Publication.
- Hester, R. K., Miller, W. R. (1988). Empirical guidance for optimal client-treatment matching. *Adolescent Drug Abuse Journal*, 77, 27-38.
- Hill, D., White, V., Pain, M., & Gardner, G. (1990). Tobacco and alcohol use among Australian secondary schoolchildren in 1987. *Medical Journal of Australia*, 152, 124-130.
- Hill, D., Willcox, S., Gardner, G., & Houston, J. (1987). Tobacco and alcohol use among Australian Secondary schoolchildren. *Medical Journal of Australia*, 146, 125-130.
- Ho, R. (1994). Cigarette advertising and health warnings. *Australian Psychologist*, 29, 49-56.
- Hodgson, C., Feldman, W., Corber, S., & Quinn, A. (2003). Adolescent health needs II: Utilization of health care by adolescents. *Adolescence*, 21, 383-390.

- Hollingsworth, C. E., Tanguary, P. E., Grossman, L., & Pabst, P. (1980). Long – term outcome of obsessive – compulsive disorder in childhood. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 19, 134-144.
- Horn, K., Dingo, G., Kalsekar, L., Massey, C.J., & McGloin, T. (2004). *prevention Science*, 5(2), 113-115.
- Hunter, J., & Schaecher, R. (1990). Teenage suicide: Lesbian and gay youth. In M. J. Rotheram – Borus, J. Bradley, & N. Obolensky (Eds.), *Planning to Live: Evaluating and treating suicidal teens in community settings* (pp. 297 – 316). Tulsa: University of Oklahoma Press.
- Irwin, C. and Millstein, S. (1991). Risk – taking behaviors during adolescence, in R. Lerner, A. Petersen and J. Brooks – Gunn (Eds.), *Encyclopedia of adolescence*, Vol. 1, New York: Garland Press.
- Irwin, C., & Orr, D. (1991). Health research in adolescence, future directions of in R. Lerner, A. Petersen and J. Brooks-Gunn (Eds.), *Encyclopedia of adolescence*, Vol. 1, New York: Garland Press.
- Janis, L. W., & Mann, L. (1977). *Decision making: A psychological analysis of conflict, choice and commitment*, New York: Free Press.
- Jenkins, R. S.(1991). New way of fighting. *Public Health Reports*, 106, 240.
- Jessor, R. (1984). Adolescent development and behavioral health, in J. Matarazzo, S. Weiss, J. Herd, N. Miller and S. Weiss (Eds.), *Behavioral health: A handbook of health enhancement and disease prevention*, New York: John Wiley & Sons.
- Jessor, R. (1984). Adolescent development and behavioral health, in J. Matarazzo, S. Weiss, J. Herd, N. Miller and S. Weiss (Eds.), *Behavioral health: A handbook of health enhancement and disease prevention*, New York: John Wiley & Sons.
- Jessor, R., & Jessor, S. L. (1977). *Problem behavior and psycho – social development: A longitudinal study of youth*, New York: Academic Press.
- Jessor, R., Donovan, J., & Costa, F. (1991). *Beyond adolescence: Problem behavior and young adult development*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Johnson, C., & Flach, A. (1985). Family characteristics of 105 patients with bulimia. *American Journal of Psychiatry*, 142, 1321-1324.
- Jones, J., Bennett, S., Olmsted, M.P., Lawson, M.L., & Rodin, G. (2001). disordered eating attitude and behaviors in teenaged girls. *CMAJ*, 165, 547-552.
- Kandel, D. (1982). Epidemiological and psychosocial perspectives on adolescent drug use. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 21, 328-347.
- Kandel, D. (1990). on processes of peer influences in adolescent drug use: A developmental perspective, in R. Muuss (Ed.), *Adolescent behavior and society* (4th edn.), New York: McGraw- Hill.
- Kandel, D. B., Yamaguchi, K., & Chen, K. (1992). Stages of progression in drug involvement from adolescence to adulthood: Further evidence for the gateway theory. *Journal of Studies on Alcohol*, 53, 447-457.
- Kandel, D. (1975). Stages in adolescent involvement in drug use, *Science*, 190, 912-914.
- Katchadourian, H. (1990). Sexuality, in S. Feldman and G. Elliott (Eds.), *At the threshold: The developing adolescent*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Kaufman, J. (2004). school associated suicides in united states, 1994-1999. *Morbidity and Mortality weekly Report*, 53(23), 479-481.

- Kaufman, J., Birmaher, B., Brent, D., Rao, U., Flynn, C., Moreci, P., Williamson, D., & Ruan, N. (2004). Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School - Age Children – Present and Lifetime version (K-SADS-PL): Initial reliability and validity data. *Journal of the American Academy of child and Adolescent Psychiatry*, 36, 980-988.
- Kazdin, A. (1993). Adolescent mental health: Prevention and treatment programs. *American Psychologist*, 48 , 127-141.
- Kazdin, A. E. (1987). Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions. *Psychological Bulletin*, 102, 187 - 203.
- Kearney, C. A. (1993). Depression and school refusal behavior: A review with comments on classification and treatment. *Journal of school psychology*, 31, 267-279.
- Kearney, C. A., Albano, A. M., Eisen, A. R., Allan, W. D., & Barlow, D. H. (1997). The phenomenology of panic disorder in youngsters: An empirical study of a clinic sample. *Journal of Anxiety Disorders*, 11, 49-62.
- Keitner, G., & Miller, I. (1990). Family functioning and major depression: An overview. *American Journal of Psychiatry*, 147 , 1128-1137.
- Kelly, L., Stevens – Simon, C., Singer, D., & Cox, A. (1994). Why pregnant adolescents say they didn't use contraceptives prior to conception. *Journal of Adolescent Health*, 15, 78.
- Kennedy, L. W., & Baron, S. W. (1993). Routine activities and a subculture of violence: A study of violence on the street. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 30(1) , 88-112.
- Kennedy, M. R. (1991). Homeless and runaway youth mental issues: No access to the system. *Journal of Adolescent Health*, 12 (7), 576 – 579.
- Kiapiawa, L. (2004). Health workers in Uganda need training to help teens with sexual health issues. *Women's Health weekly* , 10, 11-13.
- Kirby, D. (1992). School – based programs to reduce sexual risk – taking behavior. *Journal of School Health*, 62, 280-287.
- Koopman, C, Rosario, M., & Rotheram – Borus, M. J. (1994). Alcohol and drug use and sexual behaviors placing runaways at risk for HIV infection. *Addictive Behaviors*, 19, 95-103.
- Kozma, A.; Stones, S. & Stones, M. J. (2000). Stability in components and predictors of subjective well-bing (SWB): Implications for SWB Structure. *Advances in quality of life theory and research*, 13-30.
- Kronenberger, W. G., & Meyer, R. G. (in press). *The child clinicalss handbook* (2 nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Kupersmidt, J. B., Coie, J. D., & Dodge, K. A. (1990). The role of poor peer relationships in the development of disorder, In S. A. Asher & J. D. Coie (Eds.), *Peer rejection in childhood* (pp. 274-305). London: Cambridge University Press.
- Lane, R. (1992). Urban police and crime in nineteenth- century America. In M. Tonry & N. Morris (Eds.), *Modern policing* , (pp. 1-50). Chicago: University of Chicago Press.
- Larson, R., & Asmussen, L. (1991). Anger, worry, and hurt in early adolescence: An enlarging world of negative emotions, in M. Colten & S. Gore (Eds.), *Adolescent stress: Causes and consequences* , New York: Aldine de Gruyter.

- Last, C. G., Francis, G., & Strauss, C. C. (1989). Assessing fears in anxiety – disordered children with the Revised Fear survey schedule for children (FSSC-R). *Journal of Clinical Child Psychology*, 18, 137-141.
- Last, C. G., Phillips, J. E., & Statfeld, A. (1987). Childhood anxiety disorders in mothers and their children. *Child Psychiatry and Human Development*, 18, 103-112.
- Lau, R. (1988). Beliefs about control and health behavior, in D. Gochman (Ed.), *Health behavior: Emerging research perspectives*, New York: Plenum Press.
- Lau, R., Quadrel, M., & Hartman, K. (1990). Development and change of young adults preventive health beliefs and behavior: Influence from parents and peers. *Journal of Health and Social Behavior*, 31, 240-259.
- Leland, N., & Barth, R. (1992). Gender differences in knowledge, intentions, and behaviors concerning pregnancy and sexually transmitted disease prevention among adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 13, 589-599.
- Leonard, H. L., Swedo, S. E., Lenane, M. C., Rettew, D. C., Hamburger, S. D., Bartko, J. J., & Rapoport, J. L. (1993). A 2- to 7- year follow – up study of 54 obsessivecompulsive children and adolescents. *Archives of General Psychiatry*, 50, 429-439.
- Lester, D. (1988). Gun control, gun ownership, and suicide prevention. *Suicide and life Threatening Behavior*, 18, 176-180.
- Liebert, R., & Spiegler, M. (1990). *Personality: Strategies and issues*, Pacific Grove: Brooks/Cole.
- Liebow, E. (1967). *Tally's Corner: A study of Negro street corner men*. Boston: Little, Brown.
- Lindgren, S. A. (1988). The cost of Justice. In *Report to the Nation on Crime and Justice* (2 nd ed.) (pp. 113-127). Washington, DC: Bureau of Justice Statistics, U. S. Department of Justice.
- Link, B. G., Susser, E., Stueve, A., Phelan, J., Moore, R. E., & Struening, E. (1994). Lifetime and five – year prevalence of homelessness in the United States. *American Journal of Public Health*, 84 (12), 1907-1912.
- Lipsey, M. W. (1992). Juvenile delinquency treatment: A meta-analysis. In t. D. Cooke, H. Cooper, D. S., Covorly (Eds.), *Meta analysis for explanation* (pp. 83-127). Beverly Hills: Sage.
- Lochman, J. F. (1992). Cognitive-behavioral intervention with aggressive boys: Three – year follow – up and preventive effects. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 60, 426 - 432.
- Lonigan, C. J., Carey, M. P., & Finch, A. J. (1994). Anxiety and depression in children and adolescents: Negative affectivity and the utility of self – report. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 62, 1000 -1008.
- Low, C.A., & Handal, P.J. (1995). The relationship between religion and adjustment to college. *Journal of College Student Development*, 39(5), 406-412.
- Luna, G. (1991). Street youth: Adaptation and survival in the AIDS decade. *Journal of Adolescent Health*, 12, 511-514.
- Luna, G. C. (1987). HIV and homeless youth. *Focus: A Review of AIDS Research*, 2 - 10.
- Luna, G. C. (1991). Street youth: Adaptation and survival in the AIDS decade. *Journal of Adolescent Health*, 12, 511-514.
- Luna, G. C., & Rotheram – Borus M. J. (1995). *The limitation of empowerment programs for young people living with HIV*. Manuscript submitted for publication.

- Maguire, K., Pastore, A. L., & Flanagan, J. J. (1993). *Sourcebook of criminal justice statistics 1992*. Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- March, J. S., Parker, J., Sullivan, K., Stallings, P., & Conners, K. (1997). The Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC): Factor structure, reliability, and Validity. *Journal of the American Academy of child and Adolescent Psychiatry*, 36, 554-565.
- Marjoribanks, K. (2004). Immigrant Adolescents, individual and environment influences on young adolescent, Educational Attainment. *Journal of Comparative Family Studies*, 35(3), 485-498.
- Marlatt, G., Baer, J., Donovan, D. and Kivlahan, D. (1988). Addictive behaviors: Etiology and treatment, *Annual Review of Psychology*, 39, 223-252.
- Marttunen, M., Aro, H., & Lonnqvist, I. (1993). Precipitant stressors in adolescent suicide. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 32, 1178-1183.
- Mason, G. (1990). *Youth suicide in Australia: Prevention strategies*, Canberra: Government Printer.
- Mason, J. O. (1991). Prevention of violence: A public health commitment. *Public Health Reports*, 106, 265 – 268.
- Mayer, J. P., Gensheimer, L. K., Davidson, W. S., & Gottschalk, R. (1986). Social learning treatment within juvenile justice: A meta – analysis of impact in the natural environment. In S. J. Apter & A. P. Goldstein (Eds.), *Youth violence: programs and prospects* (pp. 24-38). New York: Pergamon Press.
- McDowall, D. (1991). Firearm availability and homicide rates in Detroit, 1951-1986. *Social Forces*, 69(4), 1085-1101.
- McKernan McKay, M., Chasse, K.T., piakoff, R., & McKinney, L.D. (2004). family level impact of the champ family program to reduce youth HIV risk. *Family process*, 43(1), 79-94.
- Mechanic, D. (1991). Adolescents at risk: new directions. *Journal of Adolescent Health*, 12, 638-643.
- Mendick, S. A., Brennan, P., & Kandel, E. (1988). Predisposition to violence. *Aggressive Behavior*, 14, 25 – 33.
- Meyer, R. G. (1993). *The clinicians handbook* (3 rd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Meyers, H. (1989). Poverty and bias: Enemies in Brazil AIDS fight. *American Medical News*, 32 (9), 33-35.
- Mezzich, A., Tarter, R., Moss, H., & Kirisci, L. (1994). Platelet monoamine oxidase activity and personality in adolescent female substance abusers. *Personality and Individual Differences*, 16, 417-424.
- Millan, G., & Ross, M. (1987). AIDS and gay youth: Attitudes and lifestyle modifications in young male homosexuals. *Community Health Studies*, 11, 50-53.
- Miller, B. C. (2003). Families, science, and values: Alternative views of parenting effects and adolescent pregnancy. *Journal of Marriage and the Family*, 55, 7 – 21.
- Miller, B., & Dyk, P. (1993). Sexuality, in P. Tolan and B. Cohler (Eds.), *handbook of clinical research and practice with adolescents*, New York: John Wiley & Sons.
- Miller, L. C., Barret, C. L., & Hampe, E. (1974). Phobias of childhood in a prescientific era. In A. Davids (Ed.), *Child personality and psychopathology: Current topics* (pp. 89-174). New York: Wiley.

- Millstein, S. (1991). Health beliefs, in R. Lerner, A. Petersen and J. Brooks-Gunn (Eds.), *Encyclopedia of adolescence*, Vol. 1. New York: Garland Press.
- Millstein, S., & Irwin, C. (1987). Concepts of health and illness: Different constructs or variations on a theme. *Health Psychology*, 6, 515-524.
- Millstein, S., & Litt, I. (1990). Adolescent health, in S. Feldman and G. Elliott (Eds.), *At the threshold: The developing adolescent*, Cambridge, Massachusetts Harvard University Press.
- Minuchin, S., Rosman, B., & Barker, L. (1980). Psychosomatic families: *Anorexia nervosa in context*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mitchel, J., & Eckert, E. (1987). Scope and significance of eating disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55, 628-634.
- Mitchell, J. and Eckert, E. (1987). Scope and significance of eating disorders, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55, 628-634.
- Mitchell, M. (1991). The Kansas city Project. *Public Health Reports*, 106, 237.
- Moore, S., & Rosenthal, D. (1993). *Adolescent sexuality*, London: Rutledge.
- Moreau, D., & Follett, C. (1993). Panic disorder in children and adolescents. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 2, 581-602.
- Mrch, J. S., Mulle, K., & Herbert, L. B. (1997). Family Therapy: Concepts and methods. *Journal of American Child Psychiatry*, 33, 333-341.
- Mufson, L. (2004). New York state Psychiatric institute, School-based interpersonal psychotherapy effective for depressed adolescents. *Biotech week*, 30, 404-406.
- Mundy, P., Robertson, M., Robertson, J., & Greenblatt, M. (1990). The prevalence of psychotic symptoms in homeless adolescents. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 29 (5), 724-731.
- Muuss, R. (1986). *Adolescent eating disorder: Bulimia*, *Adolescence*, 21, 257-267.
- Muuss, R. (1988). *Theories of adolescence* (5 th edn.), New York: Random House.
- Muyinda, H. (2004). HIV - AIDS prevention, Sengas can effectively teach HIV prevention behavior to ugandan girls. *Virus weekly*, 3, 35-37.
- National Academy of Sciences, Institute of Medicine, Committee on Health Care for Homeless people. (1988). *Homelessness, health, and human needs*, Washington, DC: National Academy Press.
- National Center for Education Statistics, Office of Educational Research and Improvement. (1993). *Youth indicators: Trends in the wellbeing of American youth*. U. S. Department of Education. Washington, DC. U. S. Government Printing office.
- National Commission on Excellence in Education. (1983). *A nation at risk: The imperative for education reform*, Washington, DC: U. S. Government Printing Office.
- National Network of Runaway and Youth Services, Inc. (1985). *To whom do they belong?*, Washington, DC: Author.
- National Network of Runaway and Youth services, Inc. (1985). *To whom do they belong?*, Washington, DC: Author.
- Naylor, M. W., Staskowski, M., Kenney, M. C., & King, C. A. (1994). Language disorders and learning disabilities in school – refusing adolescents. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 33 (9), 1331-1337.
- Newcomb, M., Huba, G., & Bentler, P. (1986). Desirability of various life change events among adolescents: Effects of exposure, sex, age, and ethnicity. *Journal of Research in Personality*, 20, 207-227.

- Noller, P., & Callan, V. (1991). *The adolescent in the family*, London: Routledge.
- Obesity, K., Fitness, J., & Wellness week, K. (2004). Eating disorder, New guideline to standardize care for eating disorder. *Atlanta* , 28, 18-20.
- Oetting, E. R., & Beauvais, F. (1987). Common elements in drug abuse: Peer clusters and other psychological factors. *Journal of Drug Issues*, 17 (1 & 2), 133 – 151.
- Office of Educational Research and Improvment. (1993 b). *The condition of education*. U. S. Department of Education, Washington, DC: U. S. Government Printing Office.
- Ollendick, T. H., & King, N.J. (1998). Emprically supported treatments forchildren with phobic disorders. *Journal of Clinical Child Psychology*, 27, 156-167.
- Ostos, T. (1991). Alternatives to gang membership: The Paramount plan. *Public Health Reports*, 106, 241.
- Oswald, H., & Pforr, P. (1992). Sexuality and AIDS: Attitudes and behaviors of adolescents in East and West Berlin. *Journal of Adolescence*, 15 , 373-392.
- Pelegrina, S., Garcia - Linares, M.C., & Casanova, P.F. (2003). Who can better predict the adolescent's academic competence?. *Journal of Adolescence* , 26(6), 651-653.
- Pennbridge, J. N., Freese, T. E., & MacKenzie, R. G. (1992). High – risk behaviors among male street youth in Hollywood, California. *AIDS Education & Prevention*, (Fall Suppl.), 24-33.
- Pennbridge, J. N., Yates, G. L., David, T. G., & MacKenzie, R. G. (1990). Runaway and homeless youth in Los Angeles County, California. *Journal of Adolescent Health Care*, 11 (2), 159-165.
- Petersen, A., Compas, B., Brooks-Gunn, J., Stemmler, M., Ey, S., & Grant, K. (1993). Depression in adolescents. *American Psychologist*, 48 , 155-168.
- Peterson, C., Seligman, M., & Valiant, G. (1988). Pessimistic explanatory style is a risk factor for physical illness: A thirty-five-year longitudinal study. *Journal of Personality & Social Psychology*, 55, 23-27.
- Phillips, G. Yang. (2004). Suicide and attempted suicide - china, 1990-2002. *Morbidity and Mortality Weekly Report* , 53(22), 481-485.
- Pilgrim, C., Abbey, A., & Kershaw, T. (2004). the direct and indirect effects of mother's and adolescents, family cohesion on adolescents, attitude toward substance use. *Journal of Primary Prevention* , 24(3), 263-265.
- Pleck, I., Sonenstein, F., & Ku, L. (1991). Adolescent males Condom use: Relationships between perceived costs-benefits and consistency. *Journal of Marriage and the Family*, 53 , 733-745.
- Polit, D. F. (1989). Effects of a comprehensive program for teenage parents: Five years after project redirection. *Family Planning Perspectives*, 21, 164 – 169.
- Prothrow – Stith, D. (2003). Boston's violence Prevention Project. *Public Health Repots*, 106 , 237 – 239.
- Public Health Reports*. (1991 a). Background of the forum, 106, 237 – 239.
- Public Health reports*. (1991 b). The necessity of social change in preventing violence, 106, 227 – 277.
- Puig- Antich, I., Kaufman, J., Ryan, N., Williamson, D., Dahli, R., Lukens, E., Todak, G., Ambrosini, P., Rabinovich, H., & Nelson, B. (1993). The psychological functioning and family environment of depressed adolescents. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 32 , 244-253.
- Quadrel, M., Fischhoff, B., & Davis, W. (1993). Adolescent (in) vulnerability. *American Psychologist*, 48, 102-116.

- Rashad, I., & Kastner, R. (2004). teenage sex, drug and alcohol use: problems identifying the cause of risky behaviors. *Journal of Health Economics*, 23(3), 493-495.
- Redner, R., Snellman, L., & Davidson, W. S. (1982). A review of behavioral methods in the treatment of delinquency. In R. J. Morris & T. Kratochwill (Eds.), *Practice of therapy with children: A textbook of methods* (pp.193 – 220). New York: Pergamon Press.
- Reinherz, H., Giaconia, R., Pakiz, B., Silverman, A., & Lefkowitz, E. (1993). Psychosocial risks for major depression in late adolescence: A longitudinal community study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 32, 1155-1163.
- Reiss, A. J., Jr., & Roth, J. A. (1993). *Understanding and preventing violence*, Washington, DC: National Academy Press.
- Rice, F. (1992). *The adolescent: Development, relationships, and culture* (7th edn.), Boston: Allyn & Bacon.
- Risi, S., Gerhardstein, R., & Kistner, J. (2003). children's classroom Peer relationships and subsequent educational outcomes. *Journal of Clinical child and Adolescent Psychology*, 32 (3), 351-352.
- Robertson, J. J. (1991 a). Homeless women with children: The role of alcohol and other drug abuse. *American Psychologist*, 46 (11), 1198-1204.
- Robertson, J., & Simons, R. (1989). Family factors, self-esteem, and adolescent depression. *Journal of Marriage and the Family*, 51, 125-138.
- Robertson, J., & Simons, R. (1989). Family factors, self-esteem, and adolescent depression. *Journal of Marriage and the family*, 51, 125-138.
- Robertson, M. J. (1989 a). Alcohol use and abuse among homeless adolescents in Hollywood. *Contemporary Drug Problems*, 16, 415-452.
- Robertson, M. J. (1989 b). *Homeless youth in Hollywood: Patterns of alcohol use*. A report to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Berkeley, CA: Alcohol Research Group.
- Robertson, M. J. (1991 b). Homeless youth: An overview of recent literature. In J. H. Kryder - Coe, L. M. Salamon, & J. M. Molnar (Eds.), *Homeless children and youth* (pp. 33-68). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Robertson, M. J. (1992). The prevalence of mental disorder among homeless people. In R. I. Jahiel (Ed.), *Homelessness: A prevention oriented approach* (pp. 57-86). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Robertson, M. J. (2004, August 11). *Characteristics and circumstances of homeless adolescents in Hollywood*. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Boston.
- Rodriguez, O., & Zayas, L. H. (1991). Hispanic adolescents and antisocial behavior: Sociocultural factors and treatment implications. In A. R. Stiffman & L. E. Davis (Eds.), *Ethnic issues in adolescent mental health* (pp. 147 – 171). Beverly Hills: Sage Publications.
- Romig, V. A. (1978). *Justice for our children*, Lexington, MA: Health.
- Roper, W. L. (1991). Prevention of minority youth violence must begin despite risks and imperfect understanding. *Public Health Reports*, 106, 229 – 231.
- Ropers, R., & Boyer, R. (1987). Perceived health status among the new urban homeless. *Social Science & Medicine*, 24, 669-678.
- Rosenberg, M. L., & Fenley, M. A. (Eds.), (2001). *Violence in America: A public health approach*. London: Oxford University Press.

- Roth, S., & Cohen, L. (1986). Approach, avoidance, and coping with stress. *American Psychologist*, 41, 813-819.
- Rotheram – Borus, M. J., & McDermott, R. (1995). Mental health needs of homeless youths. In N. Alessi (Ed.), *The basic handbook of child and adolescent psychiatry*. New York: Wiley.
- Rotheram – Borus, M. J., Koopman, C., & Ehrhardt, A. A. (1991). Homeless youths and HIV infection. *American Psychologist*, 46 (11), 1188-1197.
- Rotheram – Borus, M. J., Luna, G. C., Marotta, T., & Kelly, H. (1994). Going nowhere fast: Methamphetamine use and HIV infection. In R. Battjes, Z. Sloboda, & W. Grace (Eds.), *The context of HIV risk among drug users and their sexual partners* (National Institute on Drug Abuse Monograph No. 143, pp. 155-183). Rockville, MD: U. S. Department of Health and Human Services.
- Rotheram – Borus, M. J., Meyer – Bahlburg, H. F. L., Koopman, C., Rosario, M., Exner, T. M., Henderson, R., Matthieu, M., & Gruen, R. (1992). Lifetime sexual behaviors among runaway males and females. *The Journal of Sex Research*, 29, (1), 15-29.
- Rotheram – Borus, M. J., Rosario, M., & Koopman, C. (1991). Minority youths at high risk: Gay males and runaways. In S. Gore & M. E. Colton (Eds.), *Adolescent stress: Courses and consequences* (p. 181-200). New York: Aldine de Gruyter.
- Rotheram – Borus, M. J. (2003). Suicidal behavior and risk factors among runaway youths. *American Journal of psychiatry*, 150, 103-107.
- Rothman, J., & David, T. (1985). *Status offenders in Los Angeles County: Focus on runaway and homeless youth: A study and policy recommendations*. School of Social Welfare, University of California at Los Angeles.
- Rutayuga, J. B. K. (1992). Assistance to AIDS orphans within the family / kinship system and local institutions: A program for East Africa. *AIDS Education and Prevention: HIV and Street Youth*, (Fall Suppl.), 57-68.
- Salloum, A. (2004). *Group work with adolescents after violent death: A manual for practitioners*. New York and Hove: Brunner – Routledge, Taylor & Francis Group.
- Samaniego, R.Y., & Gonzales, N.A. (2003). Multiple mediators of the effects of acculturation status on delinquency for mexican American adolescents. *American Journal of Community Psychology*, 27(2), 189-212.
- Santrock, J. (1990). *Life span development* (4 th edn.), Dubuque, Iowa: W. C. Brown.
- Sarafino, E. (1990). *Health psychology: biop psychosocial interactions*, New York: John Wiley & Sons.
- Sarrel, L., & Sarrel, P. (1981). Sexual unfolding. *Journal of Adolescent Health Care*, 2, 93-99.
- Scarpitti, F., & Stephenson, R. M. (1971). Juvenile court dispositions. *Crime and Delinquency*, 17, 142 – 151.
- Schlechty, P. C. (2005). *Creating create schools: Six critical system at the heart of educational innovation*. Sanfrancisco: Jhon Wiley and sons.
- Schludermann, E.H., & Schludermann, S.M. (2000). *Adjustment Scale, technical report* (winnipeg, M. B, Department of psychology, universit of manitobal).
- Schubiner, H., Scott, R., & Tzelepis, A. (2004). Exposure to violence among inner-city youth. *Journal of Adolescent Health*, 14, 214-219.
- Scott, M., Parthasarathy, S., Kohn, C., & Hinman, A. (2004). Adolescents with substance diagnoses in an HMO. *Mental Health Service Research*, 6(1), 47-49.

- Services. (1990). *Healthy People 2000: National Health promotion and disease Prevention objectives*. Washington DC: U. S. Government Printing Office.
- Shaffer, D., & Caton, C. (1984). *Runaway and homeless youth in New York City*. A report to the Ittleson Foundation. New York: Division of Child Psychiatry, New York State Psychiatric Institute and Columbia University College of Physicians and Surgeons.
- Shalwitz, J. C., Goulrat, M., Dunnigan, K., & Flannery, D. (1990, June). *Prevalence of sexually transmitted diseases (STD) and HIV in a homeless youth medical clinic in San Francisco*. Presentation at the Sixth Annual International Conference on AIDS, San Francisco, CA.
- Shaw, H. (2004). Eating disorder, Common eating pathology patterns encompass most ethnic groups. *Women's Health weekly*, 13, 55-57.
- Shedler, J., & Block, J. (1990). Adolescent drug use and psychological health: A longitudinal inquiry. *American Psychologist*, 45, 612-630.
- Shulman, S. (1993). Close relationships and coping behavior in adolescence. *Journal of Adolescence*, 16, 267-283.
- Silbereisen, R., Noack, P., & Schonpflug, U. (1994). Comparative analyses of beliefs, leisure contexts, and substance use in West Berlin and Warsaw, in R. Silbereisen & E. Todt (Eds.), *Adolescence in context: The interplay of family, school, peers, and work in adjustment*, New York: Springer - Verlag.
- Silverman, M. M., Lalley, T. L., Rosenberg, M. L., Smith, J. C., Parron, D., & Jacobs, J. (2004). Control of stress and violent behavior : Mid – course review of the 1990 health objectives. *Public Health Reports*, 103, 38 – 48.
- Slap, G. (1991). Injury during adolescence, risk factors for, in R. Lerner, A. Petersen and J. Brooks-Gunn (Eds.), *Encyclopedia of adolescence*, Vol. 1, New York: Garland Press.
- Small, S., Silverberg, S., & Kerns, D. (1993). Adolescents perceptions of the costs and benefits of engaging in health-compromising behaviors. *Journal of Youth and Adolescence*, 22, 73-87.
- Smith, G. W., & Fogg, C. P. (1978). Psychological predictors of early use, late use and non-use of marijuana among teenage students. In D. Kandel (Ed.), *Longitudinal research on drug use: Empirical findings and methodological issues* (pp. 101-113). Washington, DC: Hemisphere- Wiley.
- Sobal, J. (1987). Health concerns of young adolescents. *Adolescence*, 22, 739-750.
- Spivack, G., & Cianci, N. (1987). High-risk early behavior pattern and later delinquency. In J. D. Burchard & S. N. Burchard (Eds.), *Prevention of delinquent behavior* (pp. 44-47). Beverly Hills: Sage.
- Spivak, G., & Cianci, N. (1987). High – risk early behavior pattern and later delinquency. In J. D. Burchard & S. N. Burchard (Eds.), *Prevention of delinquent behavior* (pp. 44-74). Beverly Hills: sage.
- Stevens – Simon, C., & Reichert, S. (1994). Child sexual abuse and adolescent pregnancy. *Archives of Pediatric Adolescent Medicine*, 148, 23 – 27.
- Stevens _ Simon, C., Wallis, J., & Allen _ Davis, J. (1995). Which teen mothers choose Norplant?. *Journal of Adolescent Health*, in press.
- Stevens, S.J. (2004). Addiction Medicinc, Study finds greater severity in substance abuse in adolescent females. *Atlanta*, 3, 32-34.
- Stricof, R., Novick, L. F., & Kennedy, J. (1990, June). *HIV – 1 seroprevalence in facilities for runaway and homeless adolescents in four states: Florida, Texas,*

- Louisiana, and New York. Paper presented at the Fourth Annual International Conference on AIDS, San Francisco, CA.
- Strober, M. and Humphrey, L. (1987). Familial contributions to the etiology and course of anorexia nervosa and bulimia, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55, 654-659.
- Sullivan, T., & Thompson, K. (1994). *Introduction to social problems* (3rd edn.). New York: Macmillan.
- Swahn, M.H., Simon, T. R., Hamming, B.J., & Guerrero, J.L. (2004). Alcohol - Consumption behaviors and risk for physical fighting among adolescent drinkers. *Addictive Behaviors*, 29(5), 959-964.
- Swisher, J. (1991). Stimulants, in R. Lerner, A. Petersen & Brooks - Gunn (Eds.), *Encyclopedia of adolescence*, Vol. 2. New York: Garland Press.
- Taylor, S. (1991). *Health psychology* (2nd edn.). New York: McGraw- Hill.
- Thomsen, P., & Mikkelsen, H. (1995). Course of OCD in children and adolescents. *Journal of the American Academy of child and Adolescent Psychiatry*, 34 (11), 1432-1440.
- Thomsen, P., & Mikkelsen, H. (1995). Course of OCD in children and adolescents. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 34 (11), 1432-1440.
- Tomb, M., & Hunter, L. (2004). prevention of anxiety in children and Adolescents in a school setting. *Children and Adolescent and schools*, 26(2), 87-105.
- Towber, R. I. (2001). *Characteristics of homeless families: December, 1985*. New York: Human Resources Administration, Office of Program Evaluation. Unpublished manuscript.
- Towber, R. I. (2003). *Summary of findings of a one – day survey of homeless families housed at the Martinique Hotel and Forbell Street Shelter*. New York: Human Resources Administration, Office of Program Evaluation.
- Tracy, P. E., Wolfgang, M. E., & Figlio, R. M. (1985). *Delinquency in two birth cohorts: Executive summary*, Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, U.S. Department of Justice.
- Turtle, A., Ford, B., Habgood, R., Grant, M., Bekiaris, J., Constantinou, C., Macek, M., & Polyzoidis, H. (1989). AIDS-related beliefs and behaviours of Australian university students. *Medical Journal of Australia*, 150, 371-376.
- U. S. Congress, Office of Technology Assessment. (1991). Background and the effectiveness of selected prevention and treatment. *Adolescent health services* (Vol. II, OTA – H- 466). Washington, DC: U. S. Government Printing Office.
- U. S. Department of Health and Human Services. (1989). Prepared for the office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation Systemetrics / Mc Graw – Hill. *A partial listing of problems facing American children, youth and families*, Lexington, MA: Author.
- Uggen, CH., & Blackstone, A. (2004). working teens increasingly victims of sexual harassment. *Women's Health weekly*, 10, 12-14.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (1989). Annual report, New York: Author.
- United Nations Convention on the Rights of the Child: unofficial summary of articles. (1991). *American Psychologist*, 46, 50-52.
- Upshur, C. C. (2003). Research Report: The Bridge, Inc., Independent Living Demonstration. *In Amendments to the Foster Care and Adoption Assistance program*. Hearing before the Subcommittee on Public Assistance and

- Unemployment Compensation of the Committee on Ways and Means, House of Representatives, Ninety – Ninth Congress (September 19, 1985) (Serial 99-54). Washington, DC.
- Urberg, K., & Robbins, R. (1981). Adolescent perceptions of the costs and benefits associated with cigarette smoking: Sex differences and peer influences. *Journal of Youth and Adolescence* , 10, 353-361.
- Valois, R. F. (2004). Adolescent Health, Life satisfaction and suicide among highschool adolescent. *Medical letter on the CDC & FDA* , 8, 9-10.
- Vaughn, A.A., & Roesch, S.C. (2003). Psychological and phsical health correlates of coping in minority adolescents. *Journal of Health Psychology*, 8(6), 671-683.
- Vega, W.A., Houry, E.L., Zimmerman, R.S., Gil, A.G., & Warheit, G.J. (1995). Cultural conflicts and problem behavior of latino adolescents. *Journal of Community Psychology* , 23, 167-179.
- Vincent, M. L., Clearie, A. F., & Schluchter, M. D. (1987). Reducing adolescent pregnancy through school and community – based education. *Journal of the American Mecidal Association*, 257, 3382 – 3386.
- Walker. C.E., & Roberts, M. C. (2001). *Handbook of Clinical Psychology, Third Edition* . John Wiley & Sons, INC. New York.
- Weekly, V. (2004). To prevent AIDS. *New York Times* , 25, 24-26.
- Wentis, W.L. (1995). The relationship between religion and mental health. *Journal of Social Issues*, 15. 33-48.
- Werner, M., & Greene, J. (1992). Problem drinking among college freshmen. *Journal of Adolescent Health* , 13, 487-492.
- Westermeyer, J. (1993). Schizophrenia, in P. Tolan & B. Cohler (Eds.), *Handbook of clinical research and practice with adolescents* , New York: John Wiley & Sons.
- Whitehead, J. T., & Lab, S. P. (1989). A meta-analysis of juvenile correctional treatment. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 26, 276-295.
- Wiesner, M., & Silbereisen, R.K. (2003). Trajectories of deliquent behavior in adolescent and corolations. *Journal of Adolescence* , 26(6), 735-737.
- Wilks, I., Callan, V., & Forsyth, S. (1985). Cross-cultural perspectives on teenage attitudes to alcohol. *International Journal of the Addictions* , 20, 547-561.
- Wilks, J., & Callan, V. (1990). Adolescents and alcohol , in P. Heaven & V. Callan (Eds.), *Adolescence: An Australian perspective*, Sydney: Harcourt Brace Jovanovich.
- Wilson – Brewer, R., Cohen, S., O' Donnell, L., & Goodman, I. (1991). *Violence prevention for young adolescents: A survey of the state of the art*, Washington, DC: Carnegie Council.
- Windle, M. (1989). Substance use and abuse among adolescent runaways: A four – year follow – up study. *Journal of Youth and Adolescence*, 18, 331-334.
- Wissing, M. P. & Fourie, A. (2000). *Spirituality as a component of psychological well being*. 27th international congress of psychology, 23-28 July, Stockholm, Sweden.
- World Health organization. (2003). *national study of adolescent suicidc* .
- Wu, T. F.; Custer, R. L. & Dyrenfurth, M. J. (1996). Technological and personal problem solving styles: Is there a difference? *Journal of Technology Education*, 7.2.
- Yamaguchi, K., & Kandel, D. (1984). Patterns of drug use from adolescence to young adulthood: III. Predictors of progression. *American Journal of Public Health* , 74, 673-681.
- Yates, G. L. (1988, December). *The service delivery system for runaway / homeless youth in Los Angeles County*. Paper presented at the Olive View Medical Center

- Research Conference on Homeless Adolescents: A Population in Crisis. Sylmar, CA.
- Yates, G., MacKenzie, R., Pennbridge, J., & Cohen, E. (1988). A risk profile comparison of runaway and no runaway youth. *American Journal of Public Health*, 78, 820-821.
- Zagar, R., Arbit, J., Sylvies, R., Busch, K. G., & Hughes, J. R. (2002). Homicidal adolescents: A replication. *Psychological Reports*, 67, 1235 – 1242.
- Zeitlin, H., & Swadi, H. (1991). Adolescence: The genesis of addiction, in I. Glass (Ed.), *The international handbook of addiction behavior*, London: Rutledge.
- Zimet, G., Bunch, D., Anglin, T., Lazebnik, R., Williams, P. and Krowchuk, D. (1992). Relationship of AIDS- related attitudes to sexual behavior changes in adolescents, *Journal of Adolescent Health*, 13, 493-498.
- Zubrick, S., Silburn, S., Garton, A., Burton, P., Dalhy, R., Carlton, I., Shepherd, C., & Lawrence, D. (1995). *Western Australian child health survey: Developing health and well- being in the nineties*. Perth, Western Australia: Australian Bureau of Statistics and the Institute for Child Health Research.
- Zucker, J. (Executive Producer). (1994, December 18). *Today Show*. New York: National Broadcasting Corporation,.

فهرست اعلام

الف

اسکاکس	آبرامسون
اسکلکتی	ابوالفتحی
اسلاپ	آبی
اسلامی	آپشار
آسلتین	آتیہ
اسلوویک	احسان منش
اسمال	احمد
اسمیت	احمدخانی‌ها
اشتین هارت	احمدی
اعظمی	ادلین
اکرت	ادیتیان جی
آکلین	آربوثنات
اکرز	اراسموس
آگی	آزاد فلاح
آلتشولر	استونز
آلن دیک	ارشادی منش
اندریوز	ارلنمیر - کیملینگ
انگل	ارہاردت
انگلاندر	آرو
اوبسیتی	اریکسون
اوبولنسکی	اسپایلگر
اوتینگ	اسپیواک
اور	استراس
اوربرگ	استروبر
اوستوس	استریکوف
اوسوالد	استففسون
اوگن	استیفمن
آویسون	استیونز - سیمون
ایرلز	اسکات
ایروین	اسکارپیتی
آیزنبرگ	
ایزو	

ایگر	بروکس
الدر	بروکس گان
الکاینند	برگین
اللهیاری	بری
الیانت	بزنر
الیوت	بریندیس
الیوت	بکر
	بلاک
ب	بک
باباپور خیرالدین	بلک استون
باتشر	بلونی
بارت	بتتین
بارث	بنسون
باردن	بندورا
بارلو	بوراج
بارلینگ	بورباش
بارنس	بوالهری
بارون	بورست
بازرگان	بورنز
بازیاری میمندی	بوکی
باستیان	بولدز
باند	بوند
بانکرافت	بهرامی
بایر	بهرامی احسان
بایومیستر	بیت - ماروم
بشارت	بیرن
براتوند	بیکر
براون	بیلینگز
برگ	بین
برنان	بیووایس
برنن	
بروانل	پ
بروک	پارتسون

پانتون	ث
پاولف	ثالبرگ
پرکینز	
پرند	ج
پروترو - استیت	جان بزرگی
پری	جانسون
پفور	جانیس
پک	جسور
پلک	جعفری
پلگرنیا	جنکینز
پنبریج	جونیز
پولیت	جیمینز
پویگ - آنتیچ	
پیترسون	چ
پیل گرایم	چاوشی فر
	چرخیان
	چوکویت
ت	
تارتل	ح
تامپسون	حسینی مقدم
تامسون	حسینیان
تانری	حمیدی
ترابی	حیدرنیا
ترسی	
ترکمن نژاد	خ
تزلیس	خدابخشی کولائی
تقوی	خدایاری فرد
توبر	خرم آبادی
توکیلی خمینی	
توماس	د
تومب	داج
تیزدال	دان
تیلور	دباریش
	دریس

دزورپلا	رسول زاده طباطبایی
دمبو	رشاد
دوک	رندر
دوناوان	روبرتس
دوناھو	روتراام - بورس
دی وایلد	روزاریو
دیشر	روزمن
دیکلمنت	روزنبرگ
دیالالا	روزنتال
دیلمن	روش
دیوید	رفیعیان
دیویدسون	ریچرت
دیویسون	ریس

ز

ر

راین هرز	زابریک
رابرتسون	زابین
رابل	زاگر
راینز	زاگر
راپر	زایاس
راپرس	زایمت
راتایوگا	زرگر
راتمن	زیتلین
راث	زیگلر

س

راجرز	
رادری گاز	
راس	سارافینو
رامیگ	سارجینت
رایس	سارل
رایسی	سالوم
رایف	سامنیگو
رایننی	سانتروک
رحیمی نژاد	ستاتفیلد

صادقی	سلیا
صولتی	ستاری
ط	سلیگمن
طالبیان شریف	سمندری
ظ	سوادی
ظهروه‌وند	سواهن
ع	سوبال
عابدینی	سورسون
علمی	سولیوان
غ	سعیدی
غباری بناب	سویشر
ف	سویتمن
فارو	سیانسی
فایربورن	سیرایت
فرانسیس	سیلبری زین
فرایدنبرگ	سیلبرینسن
فرخ	سیلوربرگ
فرنچ	سیلورمن
فرومه	سیمونز
فریس	ش
فرینگتون	شابیز
فقیهی	شافر
فلاحتی خشک‌ناب	شالویتز
فلامنت	شانپفلاک
فلانری	شپارد
فلچ	شدلر
فلیکس	شکوهی یکتا
فنلی	شلودرمن
فورستنبرگ	شولمن
	شهریاری احمدی
	ص

فوری	کرور
فوگ	کروز نویی
فولت	کریمی کیسمی
فیتنس	کسیدی
فیجلو	کلارک
فیروز آبادی	کلاین من
فیشر	کلایور
فیلا	کلمن
فیلیپس	کلی
ق	کمپاس
قریشی زاده	کمپیل
ک	کندل
کاتچادورین	کندی
کاتون	کوادرل
کارسون	کوپراسمیت
کازدین	کوپمن
کاس	کورن بلات
کاسانوا	کوزما
کاستا	کوفمن
کاستله	کوک
کاستنر	کولتن
کالان	کولپ
کامرانی فکور	کوهن
کانجر	کوی
کپالدی	کهرازهی
کراس	کی یرنی
کرافورد	کیاپیوا
کرانبرگر	کیپاکس
کرشاو	کیتنر
کرنز	کیستنر
کرنی	کیمنل
	کینگ

لاست	گ
لافری	گاتزمن
لانکویست	گارتنر
لایبو	گارسیا - گرو
لاین	گارسیالینارس
لستر	گارفینکل
لو	گارلند
لواسانی	گارتس
لوئیس	گارنر
لوچمن	گارهاردشتاین
لونا	گرانج
لونینگان	گرت
لی لاند	گروس
لیبرت	گریدانوس
لیپی	گریسام
لیت	گرین
لیندگرن	گرین بلات
لینک	گلاک
م	گلدشتاین
ماجیور	گلر
مارتونن	گنزاس
مارجوریبانکز	گور
مارش	گوردون
مارلات	گوשمن
مازین	گولانتی
ماسن	گیسمار
ماسون	گیلکان
مافسون	ل
مانفردی	لانگ
مایر	لئونارد
مایکلسون	لاب
محفوظی	لارسن

مرسی	ن
مزید	ناویک
مک آلپین	نایلور
مک درموت	نزو
مک دوال	نواک
مک کانزی	نوام
مک کرنان	نوسی
مک کی	نولر
مکانیک	نیک فرجام
من	نیل
منارد	نیوکامب
مندى	نیومارک
مندیک	
مور	و
مورای	والر
موریسون	والویس
موریو	وایت هد
موس	وایسنر
موسوی	وایوگن
مول	وردویون
مولوی	ورنر
مویندا	وستر میر
میتچل	وگا
منیوگر	ولفگانگ
مهدی زاده	ولنس ویک
میر	ونتیس
میرز	وو
میلان	وود
میلر	ویچستروم
میلشتین	ویسنز
مینوچین	ویسینگ
میوس	ویکلی
	ویلسون - بریور

ویلکز	همنز
ویلکس	هنشاو
وین سنت	هو
ویندل	هورن
	هومن
هـ	هیثرتون
هاجون	هیل
هارتمن	هیلی فارل
هاردی	هیمن
هاسر	هینز
هاشمی	هیون
هالینگزورث	
هامفری	ی
هانان	یاماگوشی
هانتز	یتس
هانسن	یونیسف
هاندال	
هایزینگا	
هرساو	
هرمن	
هزلر	
هستر	

فهرست موضوعی

الف

- ابتلای نوجوانان به عفونت ایدز: به اختلالات
 جنسی نوجوانان رجوع کنید
 اعمال جنسی: به اختلالات جنسی رجوع کنید
 ابعاد سلامتی
 انزوا
 آکنه و جوش صورت
 الگوهای اجتماعی
 استقلال
 ارزش‌های والدین
 ارزش‌های همسالان
 ادراک از خطر در نوجوانان
 الکلیسم: به مواد مخدر رجوع کنید.
 اصول تغییر رفتار
 اصول شرطی‌سازی کلاسیک و کنش‌گر
 الگوی درماندگی آموخته‌شده
 الگوهای دوستی
 افسردگی: به مشکلات شخصیتی و روانی رجوع
 کنید
 ادراک قابلیت کنترل
 اختلالات خوردن
 استفراغ کردن
 از دست دادن کنترل
 احساس درماندگی
 استفاده از کاندوم
 احساس گناه
 استمنا
 ارزش‌های شخصی و مذهبی
 اولین رابطه و عمل جنسی
 استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی
 الگوهای مصرف مواد مخدر
 اولین تجربه نوشیدن الکل
 الگودهی و سرمشق‌گیری
 ارتباط با همسالان بزه‌کار
 اصول یادگیری شرطی
 اردوگاه‌های کار
 ایفای نقش
 ارتباط نژاد و جایگاه اجتماعی - اقتصادی با
 خشونت
 الگوی فرهنگی - اجتماعی خشونت
 ایجاد فرصت‌های تحصیلی و شغلی
 ارتباط فقدان جوّ حمایت‌کننده خانوادگی با فرار
 ابتلا به ویروس ایدز و فرار از خانه
 ابتلا به بیماری‌های مقاربتی در نوجوانان بی‌خانمان
 اختلالات سلوکی در نوجوانان بی‌خانمان
 ارائه خدمات درمانی و برنامه‌های منحصر به فرد
 اختلالات شخصیتی و روانی
 اضطراب جدایی
 انواع اساسی اختلالات اضطرابی
 اختلال وحشت‌زدگی
 اسکیزوفرنیا
 اسکیزوفرنیا و خودکشی
 افسردگی
 اختلال خلقی
 اقدام به خودکشی
 آموزش سلامتی
 آموزش جرأت‌ورزی
 آزار و اذیت جنسی
 آموزش حل مسئله
 آموزش مدیریت خشم و حل تعارضات: به
 خشونت در نوجوانان رجوع کنید

ب

بیماری

بعد فیزیکی سلامتی

بعد زیست‌شناختی سلامتی

بعد اجتماعی سلامتی

بعد روان‌شناختی سلامتی

باورهای سلامتی

بیگانگی

بازاریابی اجتماعی

بالغ شدن

بی‌اشتهایی عصبی

بدکارکردی‌های خانوادگی

بازبینی و نظارت بر پرخوری

بیماری‌های قابل انتقال مقاربتی

برنامه‌های آموزش شغلی

برنامه‌ریزی‌های شغلی

برنامه‌های مبتنی بر اجتماع برای پیشگیری از

حاملگی

بحران هویت

بیمارستان‌های شبانه‌روزی

برنامه‌های مدرسه‌مدار

برنامه‌های دوازده مرحله‌ای برای ترک اعتیاد

بزهکاری

برنامه‌های اجتماع‌مدار

برنامه‌های تحصیلی و شغلی و مهارت‌های

زندگی

بیرون انداخته شدن از خانه

برنامه‌های آموزشی مبتنی بر مدرسه برای

پیشگیری از خودکشی

بحث پایانی

بیماری مسری

پ

پیام‌های برانگیزاننده ترس

پذیرفته شدن از طرف همسالان

پر خاشگری

پر خوری عصبی

پادتن‌ها

پیشگیری اولیه از حاملگی نوجوانان

پیش‌بینی‌کننده‌های روانی اجتماعی مصرف مواد

و الکلی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری از خشونت

پیشگیری از خشونت در سطح شخصی

پیشگیری از خشونت در سطح اجتماعی

پس‌مداخله در خشونت

پناهگاه‌های اضطراری کوتاه‌مدت

پیشرفت تحصیلی پایین

پیشگیری از شکست تحصیلی

پیشگیری ثانویه از شکست تحصیلی

پیشایندها و علل اسکیزوفرنیا

پیشگیری از خودکشی

ت

تعریف سلامتی

تغذیه

تاریخچه اجتماعی

تمایلات همجنس‌خواهانه

تمایلات خودکشی: به اختلالات روانی رجوع

شود

تنیدگی‌های اخیر زندگی

تغییر رفتار و نگرش

تقویت و تشویق

تنیدگی‌های دوره نوجوانی

تفکر انتزاعی

- تغییرات فیزیولوژیکی
تنش‌های خانوادگی
تفاوت‌های جنسی از نظر هیجان‌های منفی
تعارضات خانوادگی
تعارضات والد - فرزندی
تفاوت‌های جنسیتی
تصویر منفی بدنی
تمایل به لاغری
تفاوت‌های قومیتی
تصور بدنی ضعیف
تعارضات پنهان
تنش‌زدایی
تحول جنسی
تظاهرات جنسی
تغییر جنسیت
تجربه عمل جنسی
تجارب جنسی اولیه
تشخیص و درمان ایدز
تعدد شریک جنسی
ترک تحصیل: به مشکلات تحصیلی رجوع کنید
تأثیرات تحولی مربوط به حاملگی
تأثیرات اجتماعی
تأثیرات هیجانی
تشخیص حاملگی
تریاک
ترک اعتیاد
تفاوت‌های بین فرهنگی در مصرف مواد و الکل
تجاوز جنسی
تحمل دارویی
تکانشی بودن
تعهد کم به مدرسه
تجاوزات جنسی خشونت‌آمیز
تشخیص عوامل خطرآفرین مربوط به خشونت
- تعریف نوجوانان بی‌خانمان
تجربه وقایع تنش‌زا در نوجوانان بی‌خانمان
تعدد شریک جنسی در نوجوانان بی‌خانمان
ترک تحصیل
تفاوت‌های جنسیتی و قومیتی در شکست تحصیلی
تیم‌های بررسی دانش‌آموزی
ترس و اضطراب
ترس از تاریکی و حیوانات
ترس از موجودات غیرطبیعی
ترس شدید از توفان، تاریکی و آمپول
ترس از مورد ارزیابی قرار گرفتن
توهم
تنیدگی و افسردگی
تفاوت‌های جنسیتی در میزان خودکشی
توصیه‌های کلی برای سلامت کودکان و نوجوانان
- ج**
جامعه‌پذیری
جامعه‌پذیری خانوادگی
جرم: به خشونت رجوع کنید
جو خانوادگی
جو عاطفی گرم و صمیمانه
جرم و جنایت توأم با خشونت
- چ**
چاقی و اضافه وزن: به اختلالات خوردن رجوع کنید
چرا کودکان مدرسه را ترک می‌کنند
- ح**
حاملگی و باردار شدن: به حاملگی رجوع کنید

داروهای روان‌گردان: به مصرف مواد رجوع کنید

دوره نوجوانی

درگیری فیزیکی

داروهای ضد یبوست

درمان اختلالات خوردن

درمان شناختی - رفتاری

دگرجنس‌خواه

داروهای تزریقی

داروهای آنتی‌ریتروویرال

درمان حاملگی نوجوانان

داروهای تحریک‌کننده

دوقلوهای همسان و غیرهمسان

دلبستگی به همسالان

داروهای توهّم‌زا نظیر LSD

درمان اعتیاد به مواد

درمان‌های شبانه‌روزی ترک اعتیاد

دستگیر شدن

درمان بزهکاری

درمان‌های مؤسسه‌ای

درمان‌های روان‌پوشی

درمان‌های انفرادی

دسترسی به اسلحه و خشونت

درمان خشونت

درمان‌های اجتماع‌مدار: به خشونت در نوجوانان

رجوع کنید

درمان‌های شبانه‌روزی: به خشونت در نوجوانان

رجوع کنید

درگیری در جرایم و خلافکاری و بی‌خانمانی

درمان مشکلات مرتبط با عدم پیشرفت تحصیلی

دارودرمانی وسواس

درمان اختلالات اضطرابی

داروهای ضد افسردگی

داشتن افکار خودکشی

حاملگی ناخواسته: به حاملگی رجوع شود

حمل اسلحه: به خشونت رجوع کنید

حاملگی زودرس

حاملگی نوجوانان

حاملگی‌های مکرر

حشیش

حمایت و کنترل والدین و پیشرفت تحصیلی

خ

خواب

خودکشی: به اختلالات شخصیتی و روانی

رجوع کنید

خودمیان‌بینی‌ها

خطرهای سلامتی در نوجوانان بی‌خانمان: به

فرار و بی‌خانمانی رجوع کنید

خشونت‌های جنسی

خانواده‌های مستبد

خودمختاری

خودبازبینی و خودکنترلی

خودانگیزی جنسی

خانواده‌درمانی اعتیاد در نوجوانان

خطرهای بزهکاری

خانه‌های شبانه‌روزی گروهی

خشونت در نوجوانان

خانواده و خشونت

خدمات اجتماعی برای نوجوانان بی‌خانمان

خدمات جامع

خانواده‌های کم درآمد و ترک تحصیل فرزندان

خانواده‌درمانی شناختی رفتاری وسواس

خودکشی

د

دوره‌های آسیب‌پذیری

ر

رفتارهای خطرآفرین برای سلامتی

رفتارهای مشکل آفرین

رفتارهای انحرافی

رفتارهای ناسازگار با سلامتی

راهبردهای آموزش سلامتی

رسانه‌های گروهی

رویدادهای تنش‌زا

رابطه نوجوان - والدین

روابط بین فردی و اجتماعی

روندهای تحولی در مقابله با تنیدگی

روابط همسالان

رفتارهای جبرانی

رژیم غذایی

روان‌درمانگری

راهبردهای جنسی سالم

روابط جنسی سالم

رابطه جنسی بدون محافظ

رفتارهای خطرناک از نظر جنسی

رشد فیزیولوژیکی و روانی اجتماعی

رفتارهای ضد اجتماعی

رفتارهای غیرمتعارف

روندهای زمانی در بزهکاری

رفتارهای انضباطی تنبیه‌کننده

رفتارهای اجتماعی و فرااجتماعی

رویکردهای شناختی - رفتاری

رفتارهای خطرآفرین نوجوانان فراری

رفتارهای خطرناک جنسی

روندهای تحولی ترس و اضطراب

روش‌های تغییر و اصلاح رفتار و ترک تحصیل

ز

زخم‌های آلت تناسلی

زایمان زودرس

زمینه‌های ژنتیکی مصرف مواد

زندانی شدن

س

سلامتی نوجوانان

سبک‌های اسنادی

سیر تحولی باورهای سلامتی

سبک والدینی

سرزنش خود

سطح بازداری ایمنی

سقط جنین

سقط جنینی‌های عمدی و انتخابی

سیگار کشیدن

سلامت روانی

سن شروع مصرف الکل

سرطان‌زا بودن سیگار

سکونت در شهرهای بزرگ

سکونت در محل‌های غیرقانونی

ساختار نظام آموزشی

سوء مصرف مواد و بی‌خانمانی

سبک والدینی و افسردگی

ش

شادی

شبکه و ترکیب خانوادگی

شبکه حمایت اجتماعی

شبکه حمایت خانوادگی

شکاف بین نگرش و رفتار جنسی

شیوع بزهکاری

شاهدان مرگ‌های ناشی از خشونت

شکست تحصیلی

شناخت - رفتار درمانی و سواس

شناخت - رفتار درمانی افسردگی

ص

صدمات و آسیب‌های ورزشی

ض

ضد افسردگی‌ها: به اختلالات شخصیتی و روانی
رجوع کنید

ط

طرد شدن از طرف همسالان
طبقه اجتماعی
طلاق والدین و بی‌خانمانی

ع

عوامل اقتصادی - اجتماعی
عوامل روان‌شناختی اجتماعی
عزت نفس
عوامل تنش‌زا: به تنیدگی و مقابله با آن رجوع
کنید

عزت نفس

علل درونی

علل بیرونی

علل با ثبات

عوامل تنش‌زای هنجاری و غیرهنجاری

علائق جنسی

عوامل مرتبط با مشکلات خوردن

عفونت HIV

عفونت‌های قابل انتقال جنسی

عدم استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی

عوامل زمینه‌ساز بزهکاری

عدم تحمل خشونت

عواملی که موجب بی‌خانمانی نوجوانان می‌شود

عوامل تحولی مؤثر در پیشرفت تحصیلی

علائم و نشانه‌های اضطراب بالینی

عوامل وراثتی اسکیزوفرنیا

عوامل محیطی اسکیزوفرنیا

عوامل مرتبط با افسردگی

عزت نفس و افسردگی

عوامل مرتبط با خودکشی

عوامل تنش‌زای بین‌فردی و خودکشی

علائم و نشانه‌های خودکشی در نوجوانان

ف

فرضیه عدم آسیب‌پذیری
فقر

فنون شناختی - رفتاری

فعالیت جنسی

فراورده‌های خونی

فیزیولوژی رفتار جنسی

فرزندخواندگی

فعالیت‌های بزهکارانه: به بزهکاری رجوع کنید

فرهنگ‌پذیری نوجوانان

فرار از خانه

ق

قتل و آدم‌کشی

قضاوت‌های اجتماعی در مورد مصرف مواد

ک

کودکان خانواده‌های مهاجر

کشانده‌های جنسی

کنترل میل جنسی

کیسه جنینی

کوکائین

کلینیک‌های سلامتی مدارس

کاهش بزهکاری و ارتکاب به جرم

- کاهش دسترسی به اسلحه
 کودک‌آزاری
 کودکان خیابانی
- گ**
 گروه‌های اقلیت
 گیرندگان پیام
 گروه‌های مذهبی
 گروه‌درمانی
- م**
 مکان کنترل
 مفهوم‌سازی سلامتی
 مهارت‌های زبانی و کلامی
 منابع باورهای سلامتی
 مشروب‌خواری: به مصرف مواد و الکل رجوع کنید
 مصرف سیگار: به مصرف مواد رجوع کنید
 مدارس خصوصی
 محلات فقیرنشین
 مهاجرت
 منبع پیام
 محرک - پاسخ
 مشاجره‌های روزانه
 مقابله با تنیدگی
 مکانیسم‌های مقابله‌ای
 مقابله اولیه - ثانویه
 مقابله مسئله‌مدار
 مقابله هیجان‌مدار
 مقابله غیرکارآمد
 مقابله اجتنابی
 مقابله‌های مذهبی
 مکان کنترل درونی
- مکان کنترل بیرونی
 مهارت‌های مقابله‌ای
 ملاک‌های تشخیصی بی‌اشتهایی عصبی
 مشکلات جنسی
 مکانیسم‌های هورمونی
 مقدار لیمپوسیت CD4
 محلات محروم
 مراقبت‌های لازم قبل از زایمان
 مشکلات روانی اجتماعی رایج در مادران
 نوجوان
 مصرف مواد مخدر
 مورفین
 معتاد شدن
 میل به حادثه‌جویی
 ماری جوانا
 مصرف الکل
 مضرات مصرف سیگار
 مصرف سایر مواد مخدر
 میزان فعالیت مونوآمین اکسیداز یا MAO
 میزان بروز بزهکاری
 محدودیت‌های محیطی
 موقعیت‌های درمانی اجتماع مدار
 مهارت‌های زندگی
 مهارت‌های گفت‌وگو
 مهارت‌های بین‌فردی
 مهارت‌های حل مسائل بین‌فردی
 مهاجرت به شهرهای بزرگ
 مشکلات تحصیلی و فرار
 مصرف مواد و الکل در نوجوانان فراری
 مطالعات موردی انجام‌شده در مورد نوجوانان
 بی‌خانمان
 مشکلات روانی مزمن و بی‌خانمانی
 مکان‌های مسکونی ثابت برای بی‌خانمان‌ها

مشکلات تحصیلی	نقش تشکیلات قضایی، کیفری و جنایی در
مدرسه‌هراسی	کاهش خشونت
مدرسه‌گریزی	نقش آموزش و پرورش در کاهش خشونت
مردود شدن	نقش اجتماع در کاهش خشونت
مشکلات حاد روانی	نوجوانان فراری و بی‌خانمان
میزان بروز خودکشی و افکار خودکشی	نوجوانان خیابانی
مصرف مواد و الکل و خودکشی	نظام‌های آموزشی و پرورشی خاص نوجوانان
مداخله‌های درمانی برای خودکشی	بی‌خانمان
ن	
نوجوانی	نشانه‌های بالینی اسکیزوفرنیا
نقش‌های اجتماعی	نشانگان منفی
نگرانی‌های سلامتی	نشانگان مثبت
نظام رفتاری	نشانگان افسردگی
نوجوانان خیابانی: به نوجوانان فراری و	نقش خانواده در سبب‌شناسی افسردگی
بی‌خانمان رجوع کنید	و
نیازهای جنسی	وقایع مثبت و منفی زندگی: به تنیدگی و مقابله
نخستین قاعدگی	با آن رجوع کنید
نشانه‌های تنیدگی	ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مادران نوجوان
نقش روابط نزدیک	وابستگی جسمی و روانی
نقش فرهنگ	ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بزهکاری با سن و
نوجوانان سیاه‌پوست	جنسیت
نوجوان سفیدپوست	ویژگی‌های نوجوانان بی‌خانمان
نمونه‌های مثبت	وسواس
نوزادان کم وزن و نارس	وسواس فکری
نرخ کلی زایمان نوجوانان	وسواس عملی
نوشابه‌های الکلی سخت	ه
نوجوانان آمریکایی و استرالیایی	همسالان
نشانه‌های رفتار مشکل‌آفرین	هویت شخصی
نگرش‌های منفی نسبت به نمادهای قدرت	همبسته‌های تنیدگی نوجوانان
ناشناس‌های الکلی	هویت‌یابی جنسیتی
نگرش به مدرسه	هویت همجنس‌خواه
نظریه‌های عوامل خطر آفرین در مورد خشونت	همه‌گیرشناسی

هویت معتاد	همبسته‌های شخصی خشونت
هروئین	همبسته‌های محیطی خشونت
هیجان‌طلبی	همه‌گیرشناسی فرار و بی‌خانمانی
هزینه‌های نگهداری از نوجوانان بزه‌کار	همجنس‌خواهی و بی‌خانمانی
هزینه‌های نیروی پلیس	هراس‌های خاص
هزینه‌های پزشکی و دارویی	هراس اجتماعی
همه‌گیرشناسی خشونت	هذیان

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

Abortion	سقط جنین
Abstract thinking	تفکر انتزاعی
Academic achievement	پیشرفت تحصیلی
Academic failure	شکست تحصیلی
Addiction	اعتیاد
Adolescence	نوجوانی
Aggression	پرخاشگری
Alcohol drinking	مشروب‌خواری، نوشیدن مشروب
Alcoholism	الکلیسم
Alienation	بیگانگی
Anorexia nervosa	بی‌اشتهایی عصبی
Antidepressant drug	داروی ضد افسردگی
Antisocial behavior	رفتار ضد اجتماعی
Anxiety	اضطراب
Assertive training	جرأت‌آموزی
Attributional style	سبک‌های اسنادی
Authoritarian family	خانواده مستبد
Authoritative family	خانواده مقتدر
Behavior modification	اصلاح رفتار
Behavior system	نظام رفتاری
Bulimia nervosa	پرخوری عصبی
Cannabis	حشیش
Children on the street	کودکان خیابانی
Cigarette smoking	سیگار کشیدن
Classical conditioning	شرطی‌سازی کلاسیک
Cocaine	کوکائین

Cognitive – behavior family therapy	خانواده درمانی شناختی – رفتاری
Cognitive – behavior therapy	شناخت – رفتار درمانگری
Conduct disorder	اختلال سلوکی
Conflict	تعارض
Coping skills	مهارت های مقابله ای
Coping style	سبک های مقابله ای
Crime	جرم
Delinquency	بزهکاری
Delusion	هذیان
Depression	افسردگی
Deviant behavior	رفتار انحرافی
Diagnosis	تشخیص
Divorce	طلاق
Drug abuse	سوء مصرف دارویی
Drug dependence	وابستگی دارویی
Eating disorders	اختلالات خوردن
Egocentrism	خود میان بینی
Encouragement	تشویق
Family disfunction	بدکارکردی خانواده
Family socialization	جامعه پذیری خانوادگی
Family support network	شبکه حمایت خانوادگی
Fear	ترس
Foster child	فرزندخوانده
Gender identity	هویت جنسیتی
Agoraphobia	هراس از مکان های باز
Group therapy	گروه درمانی
Guilt feeling	احساس گناه

Happieness	شادی
Hallucination	توهم
Hallucinogenic drugs	داروهای توهم‌زا
Health	سلامتی
Health beliefs	باورهای سلامتی
Heroin	هروئین
Homelessness	بی‌خانمانی
Homicide	قتل، آدم‌کشی
Homosexuality	همجنس‌خواهی
Illness	بیماری
Impulsivity	تکانشی بودن
Independence	استقلال
Injection	تزریق
Internal focus of control	مکان کنترل درونی
Interpersonal skills	مهارت‌های بین‌فردی
Isolation	انزوا
Learning helplessness	درماندگی آموخته‌شده
Locus of control	مکان کنترل
Mass media	رسانه‌های گروهی
Mental disorder	اختلال روانی
Migration	مهاجرت
Minority group	گروه اقلیت
Monitoring	نظارت، بازبینی
Mood disorder	اختلال خلقی
Normative	هنجاری
Nutrition	تغذیه
Obsession	وسواس

Obsessive – compulsive disorder	اختلال وسواس بی‌اختیاری
Operant conditioning	شرطی‌سازی کنش‌گر
Opium	تریاک
Overweight	چاق
Panic	وحشت‌زدگی
Parental values	ارزش‌های والدینی
Parenting style	سبک والدینی
Peer	همسالان
Peer acception	پذیرش همسالان
Peer rejection	طرد همسالان
Peer relationship	رابطه همسالان
Pregnancy	حاملگی
Personal identity	هویت شخصی
Personality	شخصیت
Positive life events	وقایع مثبت زندگی
Poverty	فقر
Problem – solving	حل مسئله
Problem behaviors	رفتارهای مشکل‌آفرین
Psychodynamics	روان‌پوشی
Psychotherapy	روان‌درمانگری
Psychotropic drugs	داروهای روان‌گردان
Reinforcement	تقویت
Relaxation	تنش‌زدایی
Religious coping	مقابله مذهبی
Role playing	ایفای نقش
Runaway	فرار
Schizophrenia	اسکیزوفرنیا

School drop out	ترک تحصیل
School phobia	مدرسه‌هراسی
School truancy	مدرسه‌گریزی
Self - control	کنترل خود
Self - esteem	عزت نفس
Self – monitoring	خود باز بینی
Self – recrimination	سرزنش خود
Seperatoion anxiety disorder	اختلال اضطراب جدایی
Sex reversal	تغییر جنسیت
Sex role	نقش جنسیتی
Sexism	تبعیض جنسی
Sexual abuse	آزار و اذیت جنسی (سوءاستفاده جنسی)
Sexual intercourse	آمیزش جنسی
Sexual problems	مشکلات جنسی
Sexual promiscuity	بی‌بند و باری جنسی
Sexual violence	خشونت جنسی
Sexually transmitted diseases	بیماری‌های مقاربتی مسری
Shelter	پناهگاه
Sleep	خواب
Social roles	نقش‌های اجتماعی
Social status	جایگاه اجتماعی
Socializaton	جامعه‌پذیری
Socioeconomic factors	عوامل اجتماعی اقتصادی
Specific phobia	هراس خاص
Sports injuries	صدمه‌های ورزشی
Stereotype	تصور قالبی
Stress	تنیدگی

Stress symptoms	نشانه‌های تنیدگی
Stressors	عوامل تنش‌زا
Suicide	خودکشی
Suicide ideas	افکار خودکشی
Tolerance	تحمل
Verbal skills	مهارت‌های کلامی
Violence	خشونت
Vulnerability	آسیب‌پذیری